Доморацкий В. А.
Медицинская сексология и психотерапия сексуальных расстройств



УДК 159.9
ББК88
Д66

Серия издается совместно
с Профессиональной Психотерапевтической Лигой

Научный редактор серии - проф. В.В. Макаров.
Менеджер серии - В. Потапова

Доморацкий В. А.
Медицинская сексология и психотерапия сексуаль-
Д66 ных расстройств. - М.: Академический Проект; Куль-
тура, 2009. - 470 с. - (Психотерапевтические технологии).

ISBN 978-5-8291-1064-2 (Академический Проект)
ISBN 978-5-902767-44-2 (Культура)

В книге с современных позиций рассматриваются различные аспекты человеческой сексуальности; сексуальные дисгармонии; половые расстройства, вошедшие в пятую главу Международной классификации

болезней 10-го пересмотра, а также принципы их диагностики и лечения. Приведены основные группы лекарственных препаратов, используемые в сексологической практике. Представлена авторская модель интегративной психотерапии сексуальных дисфункций у мужчин. Дано систематизированное описание целого ряда психотерапевтических методик для прицельной коррекции основных психологических механизмов мужских половых дисфункций. Изложены методы психотерапии, которые применяют в лечении наиболее распространенных сексуальных дисфункций у женщин. Освещены вопросы коррекции нарушений межличностных и сексуальных отношений в паре. В приложение вошли сексологические опросники и клинические иллюстрации (случаи из практики автора).

Книга предназначена в первую очередь для сексологов, психотерапевтов, психиатров, клинических психологов, но может быть интересна и другим специалистам.

УДК 159.9
ББК 88

© Доморацкий В.А., 2008
© Оригинал-макет, оформление.

ISBN 978-5-8291-1064-2 Академический Проект. 2009
ISBN 978-5-902767-44-2 © Культура, 2009

Введение

Половая жизнь принадлежит к наиболее значимым аспектам человеческого существования. Сексуальная функция у людей имеет две основные цели: прокреативную и рекреативную. Прокреативная цель заключается в продолжении человеческого рода, в способности к деторождению. Рекреативная сторона половой функции связана с чувственным наслаждением, глубокой удовлетворенностью совместным общением в процессе специфических сексуальных взаимоотношений, основанных на чувстве любви и физическом влечении партнеров. Каждый психически здоровый человек мечтает о любви и счастье, продлении своего рода и нуждается в сексе. Сексуальную потребность как проявление стремления мужчины и женщины друг к другу можно считать витальной. Причем сексуальность - это не только физиологическое явление, связанное с удовлетворением полового инстинкта. Сексуальные отношения позволяют познать себя через общение с противоположным полом, что является выражением присущей человеку потребности в самоактуализации (Л.И. Козловская, 2001). Таким образом, половая жизнь неразрывно связана с наиболее важными аспектами человеческого бытия.

Неудовлетворенные сексуальные потребности - источник сильнейших фрустраций для многих людей. По мнению руководителя Федерального центра медицинской сексологии и сексопатологии, профессора Н.Д. Кибрика (1999), «снижение половой функции у зрелого мужчины, равно как и сексуальное фиаско у молодого человека только что вступившего в брак, воспринимается как крушение надежд на счастливую жизнь, как потенциальную угрозу распада семьи или невозможность ее создания... Сексуальные расстройства и дисгармонии, сопровождаясь выраженной и часто пролонгированной аффективной реакцией, способствуют формированию пессимистической оценки личностной перспективы. Это приводит к возникновению кризиса в

семейной и интимно-личностной сферах, а при условии неразрешенности ситуации и остроты реакции к формированию суицидального поведения». В современном обществе переходного периода социологи выделяют драму двух поколений: компетентных «отцов», ставших ненужными в новых рыночных условиях, и малоопытных «детей», потерявших социальные ориентации в стихии финансовых потрясений. Для тех и других нарушение семейно-сексуальных отношений нередко является «последней каплей», разрушающей способность противостоять хроническому стрессу (С.Т. Агарков, 2003). Поэтому эффективное устранение проблем, нарушающих полноценное сексуальное функционирование человека, является важной и весьма благодарной задачей. Автор выражает надежду, что данная работа внесет определенный вклад в ее решение.

Глава 1. Сексуальность человека

1.1. Половой диморфизм

Раздельнополость - глобальный феномен сексуальности человека. Половой диморфизм проявляется в широком спектре морфофизиологических и поведенческих различий между мужчиной и женщиной, но его сущность - в особенностях процесса размножения. Половое размножение обеспечивает наиболее прогрессивный в эволюционном ряду вид воспроизводства. Происходит быстрое возникновение новых генетических комбинаций, которые существенно облегчают их носителям приспособление к меняющимся условиям среды, причем самцы и самки выполняют в этом процессе разные функции. Согласно теории В.А. Геодакяна (1983), процесс самовоспроизводства любой биологической системы включает в себя две противоположные тенденции: наследственность и изменчивость. Наследственность - консервативный фактор, который стремится сохранить у потомства все родительские признаки в неизменном виде. Изменчивость - качество, благодаря которому у каждого следующего поколения для приспособления к меняющейся жизни возникают новые признаки, т. е. происходит эволюционирование человека. Причем особи женского пола образуют своего рода «золотые кладовые» наследственности, обеспечивая неизменность потомства от поколения к поколению. Напротив, особи мужского пола - передовой отряд популяции, принимающий на себя столкновение с экстремальными ситуациями, новыми условиями существования, в результате чего возникают новые генетические тенденции. Таким образом, в процессе филогенеза, т. е. исторического развития человеческой популяции, мужской пол играет основную роль в ее изменении, а женский - в сохранении. Теория Геодакяна хорошо объясняет некоторые факты естественно-

го полового отбора, например, повышенную смертность среди мужских особей, на которых приходится максимум внешних воздействий, в силу чего они гораздо чаще становятся жертвами неудачных «экспериментов» природы и самого человека. Г.С. Васильченко (1977), суммируя многочисленные данные, отмечает, что первичное соотношение полов на уровне зиготы (оплодотворенной яйцеклетки) составляет 1,2 - 1,7 (120 - 170 плодов мужского пола на 100 женского), а вторичное (при рождении) - 1,03 - 1,07. Мужской плод более уязвим уже в первом триместре беременности. Третичное соотношение полов, напротив, меняется в сторону женщин, поскольку среди мужчин выше смертность от врожденных пороков и различных заболеваний.

Американский сексолог Д. Мани (1955) выделил ряд закономерностей половой дифференцировки, которые он представил в виде следующих принципов.

Принцип дифференцировки и развития означает, что развитие организма одновременно является процессом его дифференцировки, в ходе которого первоначально бипотенциальный зародыш становится особью мужского либо женского пола. Этот принцип направлен против представлений о линейной эволюции, согласно которым в ходе развития реализуется лишь один - единственный набор возможностей, заложенный в эмбрионе. Он также опровергает теории, согласно которым половая и сексуальная идентичность индивида определяется преимущественно особенностями среды и воспитания.

Принцип стадиальной (последовательной) дифференцировки: процесс индивидуального развития имеет свои закономерные этапы, где каждая последующая дифференцировка основывается на предыдущей (генетический диморфизм половых хромосом предшествует дифференцировке гонад, которая в свою очередь определяет гормональный пол зародыша, и т. д.).

Принцип критических периодов подчеркивает, что каждому этапу половой дифференцировки соответствует определенный период развития, когда организм наиболее чувствителен к специфическим воздействиям. Если критический период по какой-либо причине пропущен, то последствия обычно необратимы.

6

Так, дифференцировка зародышевых гонад, которая управляется половыми хромосомами, происходит нормально только в тех случаях, когда генетический код, записанный в хромосомах, может полностью проявиться в отведенный для этого критический период (6-7 неделя внутриутробного развития). Нарушения генетического кода могут уже на этом этапе изменить весь процесс половой дифференцировки.

Принцип Адама (дополнительности маскулинной дифференцировки) означает, что природа в первую очередь заботится о создании женской особи. Поэтому на всех критических стадиях развития, если организм не получает дополнительных сигналов или команд, дифференцировка автоматически идет по женскому типу. Чтобы на свет появился мужчина, на разных стадиях развития плода необходимо подавить исходное феминнное начало. Вначале это Н-У-антиген, который помогает превращению зародышевых половых желез в яички. Они в свою очередь начинают производить тестостерон, обеспечивающий преобразование вольфовых протоков во внутренние половые органы мужчины. Кроме того, особый SRY-ген активирует яички зародыша на выработку антимюллерова гормона, который подавляет превращение мюллеровых протоков в женские половые органы. Поскольку для создания мужской особи природе требуются дополнительные усилия, она чаще делает при этом ошибки, т. е. мужской путь развития более уязвим в отношении изменений и воздействий окружающей среды. Известно, например, что отставание в умственном развитии, проблемы в обучении, некоторые формы патологии речи и девиаций сексуального поведения встречаются у мужчин достоверно чаще, чем у женщин. Кроме того, это - еще одно из объяснений повышенной смертности мужчин и их восприимчивости к целому ряду заболеваний.

Половым диморфизмом объясняют более высокую адаптивность (пластичность) женских особей, их лучшую обучаемость, воспитуемость, конформность. Мужчин же отличают находчивость, сообразительность, изобретательность. Поэтому задачи, которые ставятся впервые, но в их решении основные требования предъявляются к новизне, а не к безупречности выполнения, больше по плечу мужчинам, тогда как со знакомыми задачами, требующими ми-

нимум новизны, но максимум совершенства, лучше справляются женщины. Половые различия проявляются также в полодиморфическом (полоролевом) поведении. Хорошо известно, что мальчики, как правило, более подвижны, драчливы, менее ласковы, чаще участвуют в силовых соревнователь-ных играх, из игрушек предпочитают конструкторы, машинки, оружие и т. д. В то же время девочки более спокойны, любят играть в куклы, семью, охотнее помогают матери по хозяйству, ухаживают за младшими детьми и т. д. В последующем полоролевые различия сохраняются. Мужчины выбирают профессиональную деятельность чаще связанную с техникой, абстрактными понятиями, карьерой, престижем, высокими заработками. Они более рацио-нальны в своих поступках, не склонны к сентиментальности. Женщины гораздо чаще нуждаются в удовлетворении эмоциональных потребностей: нежности, любви, уважении и др. Однако было бы неправильно связывать формирование поведения людей исключительно с биологическими различиями между мужчинами и женщинами. Например, закономерности общественного разделения труда и связанные с ними психологические особенности полов историчны и отнюдь не вытекают из особенностей их психофизиологии. М. Мид на протяжении длительного времени исследовала жизнь трех племен в Новой Гвинее и убедительно показала, что в каждом из них мужчины и женщины исполняли совершенно различные роли, порой диаметрально противоположные общепринятым стереотипам. По-видимому, половые роли складываются не только и не столько вследствие биологических различий мужчин и женщин, сколько на основе культурных и социальных особенностей эпохи и общества.

Современная биология констатирует наличие половых различий на всех уровнях развития и функционирования организма. Вместе с тем было бы большим упрощением разделять все свойства человека на две полярные категории: мужские или женские. Наряду с взаимоисключающими свойствами (один и тот же субъект не может в норме иметь и мужские и женские гениталии) существует множество бисексуальных качеств, присущих лицам обоего пола. Это верно как для соматических, так и поведенческих свойств, которые далеко не всегда совпадают. Понятие

8

«половой диморфизм» поначалу не различало генетическую, гормональную, морфологическую, поведенческую, психологическую дифференцировку индивидов, поскольку предполагалось, что все эти измерения совпадают и определяются одними и теми же причинами. До сих пор по телосложению индивида пытаются определить его сексуальные предпочтения. Однако половые различия в психике могут не совпадать с морфологическими признаками. Также не следует абсолютизировать психологические особенности носителей того или иного пола. Половой диморфизм допускает и даже предполагает многообразие индивидуально-психологических вариантов мужского и женского характера и стиля жизни.

1.2. Формирование либидо

Энергетическое обеспечение полового влечения (либидо) осуществляют глубокие структуры головного мозга (лимбический комплекс, зрительные бугры, гипоталамус, гипофиз) и эндокринные железы. С деятельностью этих биологических структур связаны пробуждение и развертывание полового влечения, наличие и степень выраженности всех сексуальных проявлений, особая обостренность сексуальных переживаний человека. Зрелое половое влечение характеризуется селективностью (избирательностью) в выборе объекта влечения и предпочитаемых форм сексуального поведения. К нарушениям формирования либидо могут приводить как патогенные воздействия на эмбриональной фазе, так и (в значительно большей степени) влияния негативных психологических и микросоциальных факторов на ранних этапах психосексуального развития человека.

Согласно концепции З. Фрейда, либидо составляет источник всей психической энергии индивида, а всякое эмоциональное и телесное удовлетворение он называл сексуальным. В соответствии с преимущественной локализацией эрогенных зон, стимуляция которых вызывает эротические ощущения в различные периоды психосексуального развития человека, З. Фрейд выделил несколько его фаз. Фактически - это стадии развития либидо. Первая фаза, оральная, охватывает первый год жизни, когда рот является для

младенца основным источником удовольствия (сосание, а затем кусание). Вторая, анальная, фаза (в возрасте от одного года до трех лет) характеризуется повышенным интересом ребенка к дефекации. Контролируя этот процесс, ребенок получает телесное удовольствие и одновременно вырабатывает навыки самоконтроля. Третья, фаллическая, фаза приходится на возраст от трех до пяти лет. Происходит усиление интереса ребенка к гениталиям. На этой фазе мальчик должен преодолеть Эдипов комплекс, а девочка - электры комплекс и чувство зависти к мальчикам из-за отсутствия у нее полового члена. На этой фазе происходит половая идентификация (в норме - завершается формирование правильного полового самосознания ребенка). Четвертая, латентная, фаза продолжается до начала полового созревания. Она характеризуется временным ослаблением сексуальных реакций ребенка и «дремлющим» либидо. С половым созреванием начинается генитальная фаза развития, когда либидо ищет и находит удовлетворение в половой близости. Фрейд высказал мысль, что если нормальному психосексуальному развитию что-то мешает, происходит как бы возврат, регресс к пройденным фазам. Именно в психологической регрессии или фиксации на пройденных этапах психосексуального развития он видел ключ к пониманию девиантной сексуальности.

Итак, будучи тесно связанным с сознанием, либидо претерпевает длительную индивидуальную эволюцию, постепенно усложняясь и приобретая новые качества. В отечественной сексологии выделяют несколько стадий его формирования (Г. С. Васильченко, 1977).

Понятийная стадия целиком связана с формированием у ребенка сознания, лишена чувственной окраски и к сексуальному влечению как таковому отношения не имеет. На этой стадии ребенок осознает, что все окружающие его люди делятся не только на мальчиков и девочек, но и на более емкие категории - мужчин и женщин (мама и папа, бабушки и дедушки, тети и дяди). Усвоив факт раздельнополости, ребенок начинает отождествлять себя с одним из двух полов.

Романтическая стадия у юношей характеризуется фантазиями, в которых они совершаются различные подвиги в честь идеализируемого объекта первой влюбленности, У девочек отчетливо прослеживается стремление нра-

виться, обратить на себя внимание, появляются фантазии, основным содержанием которых является бескорыстная забота о ней со стороны прекрасного и храброго «рыцаря». Попытки разрушить эти иллюзии поучениями со стороны родных или сокращением дистанции со стороны юноши воспринимаются как грязные и оскорбительные. Характерные черты этой стадии - высокий накал чувств с элементами сладостного трагизма и самоотречения, убежденность в уникальности переживаемого: «никто и никогда не любил так как я». Значение этой стадии формирования либидо состоит в возвышении физиологического инстинкта до истинно человеческой любви. В отличие от стремительного развития полового влечения у юношей черты романтичес-кой стадии у девушек могут надолго сохраниться, переплетаясь с эротическими элементами.

Эротическая стадия выражается в стремлении к нежности и ласкам. Эта стадия, длительное время определяющая женскую сексуальность, у юношей достаточно быстро сменяется потребностью в их завершении сексуальной разрядкой. У девушек постепенно появляется волнующий интерес к эротическим ситуациям и стимулам, фантазии приобретают все более чувственный характер, возникает стремление стать объектом ухаживания и эротических ласк со стороны мужчины. Переживания первой влюбленности наполняют эротическую стадию яркими и незабываемыми чувствами и надеждами, многим из которых так и не суждено сбыться.

Сексуальная стадия протекает на фоне инстинктивного влечения к разрядке сексуального напряжения, т. е. специфических эмоций низшего порядка, которые тесно связаны с деятельностью глубинных структур мозга и половых желез. Юношеская гиперсексуальность, возникающая в подростковом возрасте, сопровождается рядом специфических феноменов - интенсивным половым влечением со своеобразной эротизацией психики, неослабевающим любопытством к вопросам секса, частыми спонтанными и адекватными эрекциями с выраженным половым возбуждением, ночными поллюциями, регулярной мастурбацией с яркими сексуальными фантазиями, началом половой жизни, которая характеризуется чередованием сексуальных эксцессов и периодов воздержания. У женщин эта стадия

характеризуется появлением влечения к интимной близости и способности к переживанию оргазма и, нередко, наступает лишь после начала регулярной половой жизни. Бурное пубертатное развитие у женщин может сопровождаться ранним и интенсивным проявлением эротического либидо, но при отсутствии регулярных половых контактов или по крайней мере мастурбации формирование зрелого сексуального влечения обычно запаздывает. По данным А. М. Свядоща (1988), отсутствие сексуального либидо в течение всей жизни наблюдалось у 22,4 % обследованных им женщин. 8 большинстве случаев такая задержка связана с подавлением сексуальности в результате дефектов воспитания или некомпетентности полового партнера.

Стадия зрелой сексуальности характеризуется гармоничным соотношением понятийного, возвышенно-романтического, эротического и сексуально-чувственного элементов со всей системой морально-этических ценностей личности. С достижением зрелости у мужчины формируются механизмы контроля за своим половым поведением, поэтому в противоположность сексуальной стадии, он может успешно подавлять сексуальные тенденции, противоречащие общественным нормам и личностным морально-этическим установкам. Большинству женщин свойственны циклические колебания интенсивности полового влечения, связанные с различными фазами менструального цикла.

1.3. Сексуальные реакции и копулятивный цикл

Сексуальные реакции людей детально изучены У. Мастерсом и В. Джонсон (1966) путем непосредственного лабораторного наблюдения более чем за 10 000 половыми актами группы добровольцев из 700 мужчин и женщин. Итоги исследования показали, что их можно описать в виде цикла, состоящего из четырех фаз, следующих друг за другом: возбуждения, плато, оргазма и разрешения.

1. *Возбуждение.* Женские реакции локально проявляются увлажнением, увеличением клитора в диаметре и в длине; расширением и удлинением влагалища; шейка матки и матка приподнимаются вверх, а половые губы увеличиваются в объеме за счет притока крови, разглаживаются и

слегка раздвигаются. Кроме этого у женщин в 2/3 случаев возникает эрекция сосков, набухает грудь, нарастают мышечный тонус, частота пульса, начинает повышаться артериальное давление; у некоторых женщин появляется «сексуальный румянец».

У мужчин происходит эрекция полового члена, кожа мошонки напрягается и утолщается, яички частично подтягиваются к телу. Может наблюдаться эрекция сосков, нарастает мышечный тонус, увеличиваются частота пульса и артериальное давление.

2. *Плато.* У женщин в связи с усиленным притоком крови возникают изменения окраски малых и больших половых губ (их цвет колеблется от розового до ярко-красного у нерожавших и от алого до темно-вишневого у рожавших), причем малые половые губы могут увеличиваться в 2-3 раза, а клитор отходит к лобковой кости и скрывается за складками губ. Влагалище еще сильнее расширяется и удлиняется, в нижней его трети формируется оргастическая манжетка, благодаря которой входное отверстие влагалища сужается на 30 % и более. Грудные железы увеличиваются в размерах до 1/3 *(в* большей степени у некормивших грудью), набухают соски. У большинства женщин распространяется по телу сексуальный румянец, еще больше нарастают мышечное напряжение, частота дыхания и сердцебиения, заметно возрастает артериальное давление.

У мужчин пенис достигает максимальной эрекции, подтягивается мошонка, яички приподнимаются и увеличиваются в размерах до 50 %, из бульбоуретральных желез выделяется две-три капли мукоидного секрета. Наблюдаются эрекция сосков, нередко сексуальное покраснение кожи живота, передней поверхности грудной клетки, лица и шеи. Растет мышечное напряжение, увеличиваются артериальное давление, частота сердцебиения и дыхания.

3. *Оргазм.* Наивысшая стадия сексуального удовлетворения, которая проявляется у женщин одновременным волнообразным сокращением мускулатуры матки, нижней трети влагалища и сфинктера прямой кишки с интервалами примерно в 0,8 секунды, с последующим снижением силы, длительности и периодичности сокращений. «Мягкий» оргазм может сопровождаться 3-5 сокращениями, тогда как при интенсивном (сильном) оргазме их число достигает

13

10-15. Отсутствуют дальнейшие изменения состояния клитора, половых губ, груди и сосков. Усиливается сексуальный румянец, происходит потеря произвольного контроля над сокращениями мышц. Достигают своего максимума артериальное давление, частота дыхания и сердечных сокращений.

Мужской оргазм отличается от женского наличием двух четко различимых стадий. На первой - происходят сокращения семявыносящих протоков, предстательной железы и семенных пузырьков, что способствует выводу спермы в луковицу мочеиспускательного канала (субъективно возникает ощущение неизбежности эякуляции). На второй стадии оргазма в процесс ритмических сокращений вовлекается уретра и сам половой член, что через несколько секунд приводит к семяизвержению. Спазмы мышц промежности, простаты, семенных протоков и уретры повторяются 3-4 раза с промежутком 0,8 секунды после чего интервалы между сокращениями увеличиваются, а их интенсивность ослабевает. При этом не происходит заметных изменений состояния яичек и мошонки. Максимально увеличиваются артериальное давление, частота сердцебиения и дыхания.

Оргазм продолжается 3 - 15 секунд и сопровождается легким затуманиванием сознания. При ярком оргазме можно говорить о своеобразном «кинестетическом трансе» с фокусировкой внимания на чувственных экстатических переживаниях.

4. *Разрешение.* Фаза сопровождается чувством общего расслабления и благополучия, мышечной релаксацией. У женщин клитор возвращается к обычному положению, теряя эрекцию. Стенки влагалища расслабляются и возвращаются в невозбужденное состояние. Матка опускается в обычное положение, а отверстие шейки матки расширяется на 20-30 минут. Половые губы, грудь и соски возвращаются к своим первоначальным размерам, форме и цвету. Исчезает сексуальный румянец, частота дыхания, пульс и артериальное давление приходят в норму.

Мужчины утрачивают эрекцию пениса, кожа мошонки расслабляется и возвращается к обычной толщине. Яички принимают исходный размер и возвращаются к исходному положению в мошонке. Частота пульса, дыхания и артери-

альное давление приходят в норму. Мужчины на определенное время, которое зависит от их половой конституции и увеличивается с возрастом, утрачивают способность к новому оргазму. Такой рефрактерный период может продолжаться у них от нескольких минут до многих часов. У женщин рефрактерный период как таковой отсутствует, в силу чего они потенциально способны к многократным оргазмам. Фаза разрешения длится 10-15 минут, а если в результате сексуальной стимуляции оргазм не возник - до 6-12 часов.

Копулятивный цикл представляет собой совокупность специфических физиологических процессов, происходящих у каждого из партнеров во время коитуса. Необходимо учитывать социальные и культурные влияния в сексуальных отношениях, но в принципе копулятивный цикл во время мастурбации, петтинга, гомо- или гетеросексуального полового акта различается лишь характером стимуляции гениталий.

Г.С. Васильченко (1977) рассматривает копулятивный цикл с позиций общей теории функциональных систем П.К. Анохина как частный случай таких систем. С целью обеспечения необходимых условий для зачатия и достижения сексуального наслаждения природа объединила в единую функциональную систему ряд самостоятельных систем: психику и нервную систему, эндокринный аппарат, урогенитальный тракт и систему кровообращения. Все они принимают непосредственное участие в целостном обеспечении сексуальной сферы и делают возможным половой акт.

Копулятивный цикл мужчины состоит из пяти последовательных стадий, на каждой из которых последовательно происходят определенные психофизиологические процессы, приближающие главный биологический результат половой активности, - выделение мужского оплодотворяющего начала. Первая, психическая, стадия начинается с осознания желания близости, направленного на конкретный сексуальный объект и заканчивается появлением эрекции. При наличии адекватных условий в процессе общения с потенциальным партнером возникает вторая, эрекционная, стадия, которая заканчивается интроитусом (введением полового члена во влагалище). Третья, фрикционная, стадия

характеризуется постепенным нарастанием возбуждения до определенного предела. Далее следует четвертая, эякуляторная, стадия, сопровождающаяся семяизвержением и оргазмом с последующим резким спадом возбуждения. Пятая, рефрактерная, стадия заключается в абсолютной, а затем относительной половой невозбудимости в течение определенного периода после эякуляции.

У женщин также выделяют пять стадий копулятивного цикла. Первая, психическая, стадия, возникающая на фоне определенной эротической готовности, охватывает период от осознания женщиной желания сексуальной близости до принятия решения о ее осуществлении, причем осознание желания полового акта с конкретным мужчиной обычно происходит под воздействием эротической стимуляции с его стороны (комплементы, прикосновения, поверхностные ласки и т. п.). Вторая, сенсорная, стадия, наступающая вслед за принятием женщиной решения о реализации интимной близости, характеризуется интенсификацией любовных ласк, которые приобретают характер целенаправленной стимуляции эрогенных зон, и охватывает период до интроитуса. Эта фаза характеризуется нарастающим возбуждением, проявляющимся специфическими физиологическими реакциями (любрикапией, расширением верхнего отдела влагалища и т. п.). Третья, фрикционная, стадия охватывает период от интроитуса до наступления у женщины оргазма. Четвертая, стадия оргазма, с присущими различным женщинам индивидуальными вариациями продолжается до полной оргастической разрядки. Пятая, резидуальная, стадия отличается от соответствующей у мужчин тем, что в подавляющем большинстве случаев повторная эротическая стимуляция приводит к новому нарастанию полового возбуждения, а сам спад возбуждения у женщин происходит плавно и занимает более продолжительное время.

Основные отличия мужского и женского копулятивного циклов объясняются различной биологической направленностью сексуальности мужчины и женщины. Поскольку главной задачей мужской сексуальности является организация самого копулятивного цикла и «доставка» спермы к месту оплодотворения яйцеклетки, то и весь стиль полового поведения мужчины носит активный, порой агрессивно-наступательный характер, Выполнение конечной биологи-

16

ческой задачи требует сильной мотивации, обязательности всех сексуальных реакций мужчины вплоть до эякуляции, ярким подкреплением которой является оргазм. Стадия невозбудимости после полового акта обеспечивает накопление зрелой спермы и в какой-то мере гарантирует качество оплодотворения, то есть жизнестойкость потомства. Женская сексуальность направлена на осуществление отбора наиболее достойного из многих претендентов (в интересах той же жизнестойкости потомства), поэтому природа наделила ее потенциальной способностью к более частым половым контактам.

Внешние эффекты деятельности функциональной системы, обеспечивающей сексуальные реакции мужчины, можно разделить на пять последовательных стадий; психическую, эрекционную, фрикционную, эякуляторную и рефрактерную. Ответственными за реализацию этих стадий являются определенные анатомо-физиологические комплексы, которые Г. С. Васильченко (1977) назвал составляющими копулятивного цикла. У мужчин их выделяется четыре:

1. *Нейрогуморальная составляющая* связана с деятельностью глубинных структур мозга и эндокринных желез. Она формирует энергетический потенциал полового влечения человека и определяет интенсивность его сексуальных проявлений.

2. *Психическая составляющая* связана с деятельностью головного мозга и психическим функционированием индивида. Создает соответствующий психоэмоциональный настрой на половой акт.

3. *Эрекционная составляющая*, анатомо-физиологическим субстратом которой являются центры и нервные пути эрекционного рефлекса, система кровоснабжения гениталий и сам половой член, приводит к возникновению эрекции при соответствующем настрое.

4. *Эякуляторная составляющая* связана с деятельностью тестикул, простаты, семенных пузырьков, семявыносящих путей, а также нервными центрами и нервными путями эякуляторного рефлекса. Обеспечивает выделение мужского оплодотворяющего секрета.

При сексуальном контакте у мужчины происходит нарастание полового возбуждения, что достигается за счет

последовательного включения в этот процесс каждой из четырех составляющих и суммации их эффектов.

У женщин соответственно выделяют три составляющие копулятивного цикла: нейрогуморальную и психическую, которые в целом соответствуют аналогичным составляющим у мужчин, и генитосегментарную, которая обеспечивает ряд чисто женских сексуальных реакций, включая изменения, происходящие в гениталиях при нарастающем половом возбуждении, и оргастические переживания. Деятельность генитосегментарной составляющей обеспечивают нервные элементы (от рецепторного аппарата гениталий до сексуальных центров головного мозга), а также сами женские половые органы. Если пять стадий копулятивного цикла поочередно сменяют друг друга в процессе нарастаний полового возбуждения, то последнее достигается за счет последовательного вклада в процесс возбуждения каждой из составляющих (четырех - у мужчин или трех - у женщин) и суммации их эффектов.

Эти процессы и обеспечивают нормальное течение полового акта.

1.4. Сексуальное поведение

Общей биологической основой человеческой сексуальности является инстинкт продолжения рода, его конкретные проявления (половое влечение, разделение функций между полами, особенности репродуктивного цикла, ритуал ухаживания, техника полового акта и др.). Наряду с инстинктивной, генетически заданной организму программой нормальное половое поведение обеспечивается посредством научения, через общение со сверстниками, родителями и др. Формирование здоровой сексуальности - сложный, порой противоречивый процесс. Человеку свойственны многообразные заместительные формы секса и сексуальные символы, которыми могут служить Зрительные образы, нагота, интимные предметы одежды и др., В норме они играют вспомогательную роль, провоцируя или усиливая половое влечение, интенсифицируя любовные переживания. Однако в случае устойчивой или исключительной фиксации на них эти дополнительные элементы сексуального репертуара могут приобретать доминирующий характер,

при определенных условиях достигающий патологического уровня.

Одна из главных особенностей человеческой сексуальности состоит в том, что переживания, связанные с удовлетворением половой потребности отделены от ее первоначальной биологической цели - продления рода. Это создало принципиальную возможность гуманизации полового чувства, превращения элементарного полового инстинкта в человеческую любовь, когда взаимоотношения между мужчиной и женщиной служат не только средством продолжения рода и источником чувственного наслаждения, но и дают высочайшее счастье глубокой психологической, душевной близости. У человека в понятие полноценной половой жизни наряду с телесным, генитальным взаимодействием в качестве обязательного компонента входит межличностное, духовное общение. Отсюда вытекает громадное многообразие способов выражения человеческой сексуальности. Выделяют *экстрагениталъные формы* половой жизни: платоническая любовь, поверхностные эротические ласки, танцы, и ее *генитальные формы.* К последним относятся: заместительные (викарные) формы половой активности (поллюции, сновидения эротические, фантазии эротические, маструбация, виртуальный секс, петтинг); суррогатные формы коитуса (наварсадата, коитус между бедер, в преддверье влагалища, в анус и др.); нормативный генитально-гени-тальный половой акт; орогенитальные контакты (минет, кунилингус); сексуальные действия с животными и неодушевленными предметами.

Нормативный половой акт предполагает генитально-генитальный контакт двух индивидуумов с целью получения полового удовлетворения и/или зачатия. И. О. Кон подчеркивает, что речь идет о гетеросексуальном половом акте, т. е. введении мужского полового члена во влагалище. Г. С. Васильченко (1977) наряду с нормативным гетеросексуальным коитусом выделяет его суррогатные формы, к которым он относит:

Вестибулярный коитус, т. е. половой акт проводится в преддверьи влагалища (мужской член располагается между половыми губами женщины). Обычно практикуется в следующих случаях: 1) как способ предотвратить

нарушение девственной плевы и наступление беременности; 2) когда недостаточная эрекция не позволяет осуществить интроитус; 3) если оргазм у женщины наступает исключительно при интенсивном воздействии на клитор и малые половые губы, а вагинальные фрикции ей безразличны или даже неприятны.

Коитус между бедер, коитус между грудей (наварсадата) и подмышечный коитус обычно используют для достижения описанных выше первых двух целей, а также при высокой эрогенной чувствительности у женщины соответственно молочных желез, внутренних поверхностей бедер или подмышечных впадин либо при половом контакте в менструальный период.

Коитус в задний проход (может быть гетеросексуальным и гомосексуальным). Иногда считают, что такой половой акт практикуют преимущественно гомосексуалы. Однако значительное число гетеросексуальных пар применяют анальный секс как весьма возбуждающий вариант полового контакта, способный вызвать оргазм как у мужчин, так и у женщин. Тем не менее многие люди отвергают эту форму коитуса как негигиеничную, неестественную и просто неприятную. Действительно, при стимуляции анальный сфинктер обычно сильно сжимается, поэтому попытки быстрого и энергичного введения полового члена в прямую кишку могут быть весьма болезненными, а порой приводить к травмам. Чтобы свести риск травматизации до минимума анальное отверстие обильно смазывают каким-либо кремом.

По особенностям проведения нормативного коитуса выделяют его следующие варианты: *прерванный коитус*, при котором мужчина, чувствуя приближение эякуляции, с целью предупреждения беременности извлекает половой член из влагалища и семяизвержение происходит вне половых органов женщины; *пролонгированный коитус* (произвольно затягиваемый с целью получения наибольшего удовлетворения); *неполный коитус*, при котором отсутствуют эякуляция и оргазм.

При проведении гетеросексуального коитуса взаимное расположение тел партнеров может меняться в зависимости от индивидуальных предпочтений и взаимных пожеланий.

1.5. Гендер

Гендер - любые психологические или поведенческие свойства, ассоциирующиеся с маскулинностью или фемининностью и предположительно отличающие мужчин от женщин. В более узком смысле термин «гендер» означает «социальный пол», т. е. социально детерминированные роли, идентичности и области деятельности мужчин и женщин, которые зависят не от биологических различий между полами, а от социальной организации общества. Гендер - это своеобразный социальный конструкт, а не природная данность. Гендерная принадлежность предполагает половое самосознание и самоопределение, гендерную идентичность. Гендерная идентичность представляет собой фундаментальное (базисное) чувство своей принадлежности к определенному полу, в результате чего индивид осознает себя мужчиной, женщиной или существом промежуточного (третьего) пола. Гендерная идентичность вырабатывается в результате сложного взаимодействия природных задатков человека и процессов социализации, «кодирования». Причем субъект является активным участником этого процесса, принимая или отвергая предлагаемые ему социальные роли и модели поведения. Возможно «перекодирование» гендерной идентичности, т. е. смена пола. Это происходит в тех случаях, когда индивид категорически не может принять гендерный статус мужчины или женщины, полученный согласно своему анатомическому полу, в результате чего он испытывает постоянный душевный дискомфорт и настаивает на его изменении в соответствии с половым самосознанием (при транссексуализме). Также выделяется гендерная роль (син. половая роль), которая обозначает нормативные предписания и ожидания, предъявляемые обществом (соответствующей культурой) к мужскому или женскому поведению и фактически является критерием оценки маскулинности/фемининности ребенка или взрослого. Многие люди считают гендерные особенности однозначными, тесно связанными с половой принадлежностью. Например, если женщина проявляет пассивность и нежность, то она обнаружит эти качества в любых ролях и ситуациях. Но в жизни все может быть иначе. Мужчины

и женщины взаимодействуют друг с другом в различных социальных ситуациях, исполняя при этом конкретные социальные роли, В разных сферах деятельности, например, в семье и на производстве, характер тендерной дифференциации часто не совпадает. Традиционно считается, что потребность в социальном успехе выше у мужчин, поэтому современные бизнес-леди воспринимаются как нечто новое и беспрецедентное. Но если в прежних исторических условиях честолюбивая женщина, как правило, могла сделать карьеру только опосредованно, например, удачно выйдя замуж, то в наши дни она может самостоятельно добиться высокого социального статуса. Изменения положения женщины в обществе влекут за собой иную мотивацию и характер взаимоотношений полов. Однако не следует отождествлять социальное равенство мужчин и женщин с их одинаковостью и нивелированием тендерных (полоролевых) различий, к чему призывают радикально настроенные представители феминистского движения. Было бы ошибкой полностью игнорировать культурные стереотипы маскулинности и фемининности, поскольку они важны для гармоничных партнерских отношений. Когда мужчина - это мужчина, а женщина - это женщина, они ищут и находят друг в друге то, чего каждому из них не хватает. Если тендерные роли «перепутаны» и в поведении индивида присутствует многое из того, что традиционно соотносится с противоположным полом, он часто оказывается одинок, поскольку не имеет внутренней потребности в близких отношениях с другим человеком.

1.6. Половая конституция

В сексологической практике существует потребность соотнесения интенсивности половой жизни индивида, обратившегося за помощью, не только с его возрастом, но и объективными параметрами, которые определяют его потенциальную сексуальную активность. Благодаря исследованиям Г.С. Васильченко (1970), в отечественной сексологии сформировалось представление о том, что сексуальные проявления конкретного субъекта во многом зависят от

типа его функционально-энергетического реагирования, который обусловлен его конституциональными, биологическими характеристиками.

Половая конституция - совокупность устойчивых биологических свойств организма, сложившихся под влиянием наследственности и условий развития во внутриутробном периоде и раннем детстве. Она определяет индивидуальный уровень сексуальных потребностей, предел половой активности и сопротивляемость половой сферы патогенным воздействиям. Является одним из аспектов общей конституции человека и определяет интенсивность сексуальных проявлений, то есть половой темперамент. От половой конституции зависит индивидуальная устойчивость сексуальной функции к негативным влияниям ряда факторов (сильных стрессов, интоксикаций, ряда заболеваний и др.). Сексуальные расстройства при сильной половой конституции могут возникнуть лишь под влиянием мощных повреждающих факторов, длительно воздействующих на разные звенья обеспечения сексуальной сферы. При низких параметрах половой конституции даже слабое вредное воздействие может послужить толчком к развитию нарушений сексуальной функции. Влиянием половой конституции объясняется отсутствие прямой зависимости между давностью и выраженностью таких заболеваний, как алкогольная зависимость, хронический простатит и др., и наличием или отсутствием сексуальных дисфункций. Определение половой конституции может быть полезно для оценки сексуальных проявлений конкретного человека, разграничения их патологического снижения или повышения и индивидуальной нормы, для разработки гигиенических рекомендаций при выборе режима половой жизни. С этой целью используется шкала векторного определения половой конституции у мужчин, которую разработал и впервые апробировал профессор Г.С. Васильченко (1970). Позднее аналогичная шкала для женщин была предложена его сотрудницей И.Л. Ботневой.

Шкала векторного определения половой конституции мужчин (см. таблицу 1.1) предусматривает учет семи показателей. При ее использовании определяют исходные индексы для каждого из 7 показателей (определение индексов по VI и VII векторам проводится только у мужчин, ведущих регуляр-

ную половую жизнь в течение нескольких лет). Затем вычисляют среднее арифметическое и получают общий (фенотипический) показатель половой конституции обследуемого: 1 (1 - 1,5) - чрезвычайно слабая; 2 (1,6 - 2,5) - очень слабая; 3 (2,6 - 3,5) - слабая; 4 (3,6 - 4,5) - несколько ослабленный вариант средней; 5 (4,6 - 5,5) - средняя; 6 (5,6 - 6,5) - сильный вариант средней; 7 (6,6 - 7,5) - сильная; 8 (7,6 - 8,5) - очень сильная; 9 (8,6 - 9) - чрезвычайно сильная. Все показатели, составляющие шкалу, можно разделить на две различающиеся между собой группы. Первые четыре показателя шкалы (возраст пробуждения либидо, возраст первой эякуляции, трохантерный индекс и характер оволосения лобка) отражают процессы, происходящие в пубертатном периоде, и в дальнейшем они остаются неизменными. Поэтому среднее арифметическое показателей I - IV характеризует *генотипический индекс половой конституции (*$К_г$). Это ее наиболее стабильная часть, которая определяется действием внутренних факторов и характеризующая исходное состояние нейроэндокринного обеспечения половой сферы. Равномерное снижение всех четырех показателей и $К_г < 3,5$ указывают на задержку пубертатного развития. Показатели V-VII - максимальный эксцесс, время вхождения в полосу условно-физиологического ритма (УФР) после женитьбы и абсолютный возраст перехода на УФР (2 - 3 сношения в неделю), хотя и связаны с генотипом, во многом зависят от личностных, партнерских ситуационных факторов. Их среднее арифметическое - *индекс половой активности* ($К_а$) - отражает степень реализации мужчиной конституционально-генетических параметров (энергетического потенциала) собственной сексуальности. Генотип и половая активность мужчины взаимосвязаны. С одной стороны, частота интимных контактов во многом определяется его сексуальным темпераментом (половой конституцией), с другой стороны, уровень половой активности влияет на функциональное состояние половой сферы мужчины. По наблюдениям сексологов, оптимальным для половой функции мужчины является режим наиболее тесного соответствия между половой активностью и его конституциональными возможностями (соотношение индексов $К_а$ / $К_г$ приближается к единице). Менее благоприятным считается режим превышения активности и наиболее неблагоприятным - режим, лежащий ниже уровня конституциональных показателей.

Таблица 1.1.

Шкала векторного определения половой конституции мужчины

Векторы	Конституция								
	слабая			средняя			сильная		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0-1,5	1,6-2,1	2,6-3,1	3,6-4,5	4,6-5,5	5,6-6,5	6,6-7,5	7,6-8,5	8,6-9,0
I. Пробуждение либидо (годы)	17 и позже		15	14	13	12	11	10	9 и раньше
II. Первая эякуляция (годы)	19 и позже	17-18	16	15	14	13	12	11	10 и раньше
III. Трохантерный индекс (ТИ) - отношение роста к длине ноги	< 1,85	1,86-1,89	1,90-1,91	1,92-1,94	1,95-1,96	1,97-1,98	1,99	2,0	>2,0
IV. Оволосение лобка	Редкие пушковые волосы	Горизонталь по женскому типу	Тенденция к горизонтали	По мужскому типу			По мужскому типу с гипертрихозом		
V. Максимальный экспресс, число эякуляций	0	2	3	4	5	6	7	8	9 и больше
VI. Время вхождение в полосу УФР после женитьбы (годы)	-	«Медовый месяц»	1	2-3	4-5	6-10	11-19	20-29	30 и больше
VII. Время вхождение в полосу УФР (абсолютный возраст)	-	До 22	23-26	27-31	32-36	37-40	41-45	46-50	51 и больше

25

Шкала векторного определения половой конституции женщин (см. табл. 1. 2) разработана по аналогии с приведенной выше шкалой для мужчин (И.Л. Ботнева, 1983). Генотип - наиболее стабильная часть половой конституции, не зависящая ни от воспитания, ни от партнера, у женщин определяется по 4 первым показателям: возрасту *менархе к* регулярности менструаций, детородной функции (сроки наступления первой беременности и характеру ее течения), трохантерному индексу, типу оволосения лобка. При определении генотипического показателя ($К_г$) вычисляется средняя арифметическая показателей I - IV шкалы. У женщин некоторые показатели «расплываются» по шкале, например, характер оволосения лобка $А_3Р_3$ занимает 3 графы, поэтому его цифровое значение определяют по графе, которая ближе к другим показателям. Показатель уровня сексуальности определяется по возрасту пробуждения эротического либидо, времени наступления первого оргазма и проценту оргастичности (среднее арифметическое показателей V - VII). Эротическое либидо зависит в основном от состояния нейроэндокринной системы женщины, в частности, функции яичников. Остальные показатели, хотя и определяются гормональным статусом, в большей степени зависят от воспитания, психологических и поведенческих особенностей женщины, ее индивидуального опыта, полового партнера и т. д. Считается, что если показатели генотипа и уровня сексуальности близки, то развитие сексуальности гармоничное, соответствующее половой конституции. Если какой-то один показатель «выбивается» из шкалы или имеется большой разброс между несколькими показателями, то по характеру разброса можно определить предполагаемую патологию. Следует отметить, что в настоящее время среди большинства отечественных сексологов, включая автора шкалы, преобладает мнение о том, что полученные показатели достаточно хорошо отражают биологическую составляющую женской сексуальности и состояние репродуктивной сферы женщины. Вместе с тем, в силу большего влияния различных психологических факторов на женскую сексуальность, параметры шкалы часто не дают адекватного представления об индивидуальном уровне сексуальных потребностей женщины и оптимальной для нее половой активности.

Таблица 1.2.

Шкала векторного определения половой конституции женщины

Векторы		Конституция								
		слабая			средняя			Сильная		Патология и редкие конституциональные варианты
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0-1,5	1,6-2,1	2,6-3,1	3,6-4,5	4,6-5,5	5,6-6,5	6,6-7,5	7,6-8,5	8,6-9,0
I. Менструальная функция	Первая менструация и возрасте (годы)	17 и позже	16	15	14	13	12	11	10	9 и раньше
	Регулярность менструации	Аменорея или единичные редкие менструации	Длительные нарушения цикла без видимых внешних воздействий	Нарушения только при неблагоприятных воз-действиях (психоэмоциональных, сома-тических, медикаментозных)	Эпизодические Кратковременные нарушения при выраженных неблагоприятных воздействиях	Регулярная без патологии				Нарушения менструальной функции
II. Детородная функция	Сроки наступления беременности после	-	10 лет и дольше	3-9 лет	1-2 года	3-6 мес.	1-3 мес.	Даже при контрацепции		-

	начала половой жизни								

27

Продолжение табл. 1.2

	Характер течения беремен-ности		**Не вынашивание, тяжелая патология беременности. Мертворождения**	**Угроза прерывания, патологическое течение, токсикозы беременности**	**Легкопротекающие токсикозы беременности**	**Нормальное течение**				**—**
III. Трохантерный индекс		**1,88**	**1,89-1,93**	**1,94-1,96**	**1,97-1,98**	**1,49**	**2,00**	**2,01-2,02**	**2,03-2,04**	**>2,05**
IV. Характер оволосения		**A0P0**	**A1P1**	**A2P2**	**По женскому типу A3P3**			**Тенденция к мужскому**	**Муж-ское**	**Мужское с гипертрихозом (гирсутиз**
V. Пробуждение эротического либидо (годы)		**> 17**	**15-16**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8 и раньше**

Окончание табл. 1.2

IV. Оргазм	**Первый оргазм**	**В возрасте (годы)**	**-**	**10 лет**	**3-9 лет**	**1-2 года**	**6-11 мес.**	**2-5 мес.**	**1 мес.**	**До начала регулярной половой жизни или при первом коитусе**	**До контакта с партнерами**
	Достижение 50-100 % оргастичности	**Время после начала регулярной половой жизни**	**-**	**40**	**35**	**30**	**25**	**20**	**19**	**18-16**	**15 и раньше**
		В возрасте (годы)	**-**	**10-15 лет**	**5-9 лет**	**3-4 года**	**1-2 года**	**6-11 мес.**	**2-5 мес.**	**1 мес.**	**Сразу с начала половой жизни**
		Время после начала регулярной половой									

29

Примечание: Р - *оволосение лобка, А - повышенное оволосение:* отсутствует (при гормональной недостаточности) - А0Р0; остановилось на пубертатном типе (единичные прямые волосы) - А1Р1; волосы более густые и длинные на центральной части лобка - А2Р2; по женскому типу (лобок и большие половые губы покрыты вьющимися волосами с горизонтальной верхней линией) - А3Р3; при повышенной андрогенной насыщенности - тенденция к мужскому типу оволосения (волосы на белой линии живота распространяются к пупку), иногда с гипертрихозами (гирсутизм). В менопаузе волосы выпрямляются, прореживаются и постепенно почти исчезают.

1.7 Сексуальная норма

Определение критериев сексуальной нормы - достаточно сложная задача вследствие тесного переплетения биологических, социальных и личностных факторов, влияющих на половую жизнь человека, а также многообразия связанных с ней индивидуальных отклонений. Зависимость понятия нормы от комплекса культурных факторов, религиозных убеждений, морально-этических требований, господствующих в отдельных социальных группах или в обществе в целом, приводит как к чрезмерно широкой трактовке сексуальной нормы, так и к неоправданно жесткому ее ограничению, вплоть до полного отрицания самой возможности многообразия сексуального самовыражения личности. Только разработка четких научных критериев сексуальной нормы позволяет провести границу между тем, что следует считать нормальным и здоровым, и тем, что рассматривается как ненормальное, патологическое, а значит, требующее определенной коррекции. Искаженные, неправильные представления о сексуальной норме нередко создают у людей значительные трудности в личной жизни и могут вести к формированию у них сексуальных дисгармоний и дисфункций.

Одним из возможных подходов к изучению этой нормы является нозоцентрический (от патологии к норме), в соответствии с которым вначале определяются границы сексуальной патологии, а все половые проявления, не относящиеся к ней, считаются различными вариантами нормы.

30

По определению польского сексолога З. Старовича (1991), к сексуальной патологии относятся такие сексуальные потребности, а также такое сексуальное поведение, которые затрудняют сексуальное партнерство (как выбор партнера, так и совместную с ним половую жизнь) или приспособление сексуальных предпочтений индивида к морально-культурным нормам поведения и к правовой системе данного общества. Таким образом, сексуальные потребности и действия человека, которые не становятся для него источником указанных затруднений и проблем в половой жизни, должны считаться нормальными.

Немецкий сексолог С. Шнабль (1981) считает, что на понимание нормы в сексологии оказали влияние три основных ее понятия. Первое - норма как некий моральный постулат, этическое требование, то есть своего рода идеальный образец сексуального поведения, предписанный обществом. Такого рода нормы появлялись и сменялись в процессе исторического развития общества, что зависело от господствующих религий или классов, установившихся культурных и моральных норм. Их объявляли абсолютными и «естественными», хотя порой они противоречили элементарному здравому смыслу. Во втором случае норма - средняя величина, выведенная из частотных характеристик тех или иных сексуальных проявлений. При таком подходе нормальными считаются такие сексуальные проявления, которые встречаются у большей части людей, а к ненормальным относят все то, что наблюдается сравнительно редко. Подобный подход до сих пор в значительной мере формирует общественное мнение, способствуя негативной оценке лиц, которые относятся к «сексуальным меньшинствам», то есть удовлетворяют свои половые потребности иначе, чем большинство людей. Попытка определить норму через вычисление некого усредненного показателя, противоречит признанию за человеком права на индивидуальное самовыражение. Третье понимание нормы, в ее медико-психологическом аспекте, не связано ни с критерием ценности, ни со степенью частоты. Нормальное - это все здоровое, необходимое для хорошего физического и психического самочувствия, хорошей социальной адаптации, независимо от того, как часто или редко оно встречается, в какой степени приближается к идеальному.

31

Многие специалисты выделяют партнерскую и индивидуальную сексуальную норму. Критериями партнерской нормы являются: 1) парность; 2) гетеросексуальность; 3) половозрелость партнеров; 4) добровольность связи; 5) стремление к обоюдному наслаждению; 6) отсутствие физического и морального ущерба здоровью партнера и других лиц.

В соответствии с этими критериями к партнерской норме могут быть отнесены все формы сексуальной активности, сексуального поведения и сексуальных действий, которые имели место между двумя зрелыми лицами разного пола, принимаются ими обоими и направлены на обоюдное наслаждение, которое не вредит их здоровью и не нарушает норм общежития. Характер конкретных форм сексуального поведения и действий партнеров не имеет при этом решающего значения, поскольку за человеком признается право поиска собственных, индивидуальных путей к половому удовлетворению. Попытки ограничить человека в выборе сексуальных действий жесткими рамками предписаний и догм, игнорируя его потребности, нередко приводят к неудачам в интимной близости, конфликтам, провоцируют развитие сексуальных нарушений и невротических расстройств. Перечисленные критерии партнерской нормы достаточно условны (например, требование разнополости партнеров). Вместе с тем они позволяют вполне адекватно оценить интимную связь по важнейшим параметрам, характеризующим уровень взаимоотношений между сексуальными партнерами.

Рассматривать границы сексуальной нормы и патологии можно и с позиции значения половой сферы для человека в самом широком ее понимании. При таком подходе к сексуальной норме относится потенциальная способность выполнять все три основные функции сексуальности: биологическую (оплодотворение), психологическую (наслаждение, удовлетворение) и социальную (реализация потребности в межчеловеческих контактах). Затруднения или невозможность реализации человеком любой из этих функций определяют выраженность у него отклонений от нормы в сторону сексуальной патологии.

Поскольку партнерская норма достаточно полно разграничивает сексуальную норму и патологию в психо-

32

логическом и социальном аспектах, выделяют также индивидуальную норму, характеризующую биологический компонент сексуальности. Так, польский сексолог Ю. Годлевский считает, что для взрослого человека нормальными являются такие формы сексуального поведения, которые, во-первых, по непреднамеренным причинам не исключают либо резко не ограничивают возможность осуществления полового акта, способного завершиться зачатием; во-вторых, не характеризуются стойкой тенденцией избегания половых сношений в силу наличия у индивида сексуальных дисфункций или грубых нарушений психосексуального развития. Приведенная индивидуальная норма сформулирована как дополнение к партнерской норме. Необходимо выделить еще два важных критерия индивидуальной нормы: *возрастной* и *конституциональный.* В первом случае необходимо соотносить сексуальные потребности конкретного человека с его возрастом и общим состоянием здоровья. Очевидно, что норма для одного и того же мужчины в 25 и 60 лет будет совершенно различна, поскольку интенсивность сексологических проявлений с возрастом постепенно снижается. Известно, что индивидуальная половая активность мужчин и женщин колеблется в очень широком диапазоне. Например, предельный по интенсивности ритм половой жизни для одного мужчины может вызвать у другого явления сексуальной абстиненции и будет оптимальным для третьего. Такой разброс в уровне сексуальных потребностей людей прежде всего связан с различиями в половой конституции. Поэтому при оценке индивидуальных норм следует исходить из потенциальных сексуальных возможностей данного человека, а не из среднестатистических показателей. В этом случае условно-физиологический ритм половой жизни (2-3 раза в неделю) будет считаться совершенно нормальным в первый год супружества для мужчины 20-30 лет, имеющего слабую половую конституцию, но вряд ли будет соответствовать его индивидуальной сексуальной норме при высоких конституциональных параметрах. Подобные несоответствия реальной сексуальной активности человека, его половой конституции нередко обусловлены сексуальными дисгармониями в супружеской паре и требуют психотерапевтической коррекции.

Индивидуальная и партнерская нормы тесно связаны между собой. Например, сексуальные дисфункции у одного из партнеров часто затрудняют либо делают невозможным половое удовлетворение другого партнера, что постепенно вырабатывает у него негативное отношение к сексуальным контактам с данным человеком, нарушая таким образом критерии партнерской нормы. С другой стороны, абсолютно нормальные сексуальные потребности мужчины и женщины невозможно адекватно реализовать при наличии конфликтных взаимоотношений между партнерами. Однако столь жесткое влияние индивидуальной и партнерской норм друг на друга встречается не всегда. Так, наличие сексуальных дисфункций у одного или обоих партнеров, нарушающих критерии индивидуальной нормы, может оказаться для данной пары вполне приемлемым и не препятствовать гармоничному партнерскому союзу.

Клиническое понимание сексуальной нормы охватывает широкий круг сексуальных действий и форм поведения, которые условно можно подразделить на три категории нормы: оптимальную, принятую и терпимую. К оптимальной норме следует отнести сексуальные действия и формы поведения, которые благодаря своим особенностям наиболее желательны с индивидуальной и социальной точек зрения. Именно по этой причине их можно пропагандировать в виде модели для воспитания. К принятой (признаваемой, приемлемый) норме относятся такие сексуальные действия и формы поведения индивида, которые хотя и не являются оптимальными, не мешают ему налаживать межличностные и сексуальные контакты, поскольку не вызывают у партнера принципиальных возражений. К терпимой (толерантной) норме следует отнести такие сексуальные действия и такое поведение, оценка которых может быть различной с точки зрения нормы или патологии и зависит от личностного, ситуационного и партнерского контекста. Сюда относятся такие формы сексуального поведения, которые ограничивают возможности гармоничного подбора партнера и установления с ним тесных взаимоотношений. Однако эти ограничения не имеют абсолютно патологического характера, поскольку соответствующий (хотя и намного более трудный, чем при оптимальной и принятой нормах) сексуальный выбор может обеспечить гармоничную поло-

вую жизнь партнерской пары. Все три указанные выше категории нормы причисляются к сексуальной норме в клиническом понимании, то есть не требующей какого-либо лечения. Иначе обстоит дело с точки зрения педагогики, в которой нормой считается только оптимальный вариант, в крайнем случае - приемлемый, в то время как сексуальные действия и формы поведения в рамках терпимой нормы могут рассматриваться как нежелательные и выходящие за рамки морально допустимых.

Все приведенные критерии касаются в основном потребности в разрядке сексуального напряжения, тогда как в границы полной, широко понимаемой сексуальной нормы обязательно включается и удовлетворение потребности во в не сексуальных контактах с любимым человеком. Таким образом, сексуальные отношения тем больше приближаются к норме, чем сильнее они укрепляют и гармонизируют связь партнеров. Все это свидетельствует об относительности понятия сексуальной нормы и о необходимости рассматривать ее с учетом всего многообразия отношений между партнерами, а не только через призму их интимного взаимодействия.

1.8. Сексуальность в современном обществе

В настоящее время прослеживается несколько основных тенденций в человеческой сексуальности.

Наблюдается ломка традиционных гендерных стереотипов, проявляющаяся значительным ослаблением поляризации мужских и женских социальных ролей. Тендерное разделение труда утратило прежнюю жесткость и нормативность, а существенная часть социальных ролей перестала дифференцироваться по половому признаку.

Культурные стереотипы маскулинности и фемининности становятся менее жесткими и поляризованными. В них традиционные взгляды тесно переплетаются с новыми. Они более полно учитывают индивидуальные различия и отражают точку зрения обоих полов. Традиционный идеал женственности предполагает сочетание нежности, красоты, мягкости и пассивности, зависимости, что позволяет мужчине чувствовать себя рядом с женщиной сильным и

35

энергичным. Все эти качества продолжают высоко оцениваться мужчинами. Но сегодня, чтобы быть с мужчиной на равных, женщине необходимы острый ум, энергичность и предприимчивость, т. е. те качества, которые раньше считались привилегией мужчин. Меняется и стереотип маскулинности - интеллект мужчины все чаще ставится выше его физической силы, допускаются проявления нежности и душевной тонкости, предполагается, что он может обуздать агрессию и грубые порывы.

Происходят изменения в институте брака и семьи. Причем, вопреки предсказаниям радикалов, привлекательность моногамного брака и семейных отношений не уменьшаются. В 1990 году был проведен опрос жителей 43 развитых стран на предмет значимости для них различных сфер жизни человека: 83 % опрошенных на первое место поставили семью. Несмотря на то, что современные люди терпимее относятся к внебрачным связям, абортам, разводам, проституции, они отнюдь не поддерживают идею отмирания брачного союза. Во многих странах значение семьи скорее возрастает. Согласно социологическим опросам, женатые люди больше удовлетворены своей жизнью, меньше болеют и имеют более высокую продолжительность жизни, чем одинокие. Семейная жизнь с постоянным сексуальным партнером является оптимальной для большинства людей. Все большее значение в браке придается качеству жизни и субъективному благополучию. Поэтому современный брак чаще заключается не по расчету или обязанности, а на основе взаимной любви и психологической интимности. Однако свободный выбор брачного партнера предполагает возможность расторжения брака по психологическим мотивам, что делает его менее устойчивым. На статистику разводов также влияет увеличение общей продолжительности жизни, уменьшение материальной зависимости женщин, уменьшение размеров семьи (многие пары имеют одного ребенка либо бездетны). Растет число одиноко живущих людей. Юридически не оформленное сожительство, которое ранее выполняло функции ограниченного во времени «пробного брака», теперь стало массовым явлением, фактически альтернативной формой брака. Новой экспериментальной формой супружеских отношений являются открытые браки, в которых супруги признают

36

друг за другом право на половые связи на стороне для более полного удовлетворения их сексуальных потребностей. Растет число лиц с установкой на «серийную моногамию», суть которой заключается в том, что субъект одновременно живет только с одним партнером (женой, мужем), но на протяжении жизни он может последовательно вступать в несколько юридически оформленных брачных союзов.

Происходит либерализация морали и крах традиционных антисексуальных установок в культуре. В сексуальности перестают видеть нечто запретное, постыдное и низменное. Реабилитирована эротика, которая находит разнообразное выражение в массовой культуре, будь то кино, литература или изобразительное искусство. Ослабели культурные запреты против наготы, расширились границы речевой пристойности и некоторые слова, недавно считавшиеся непристойными, вошли в широкий оборот. Иногда говорят, что это свидетельствует о падении нравов, но возможность свободно обсуждать ранее закрытые, «постыдные», темы скорее говорит о том, что люди наконец перестали их бояться и могут более свободно обсуждать вопросы, связанные с сексуальностью.

Отмечаются изменения в системе социализации детей и молодежи. Расширение диапазона контактов и совместной деятельности мальчиков и девочек способствует выравниванию традиционных тендерных особенностей, а ослабление внешнего контроля дает молодым людям несравнимо большую свободу в принятии решений, в том числе и в вопросах половой жизни. Более раннее половое созревание, как следствие акселерации, приводит к пробуждению сексуальных интересов подростков задолго до наступления совершеннолетия. Поэтому взрослые вынуждены создавать систему сексуального образования, чтобы научить молодых людей ответственному отношению к их собственной сексуальности.

По мнению И.С. Кона (2004), главная тенденция нашего времени - *отделение сексуального поведения от репродуктивного.* Чтобы осознать этот факт, субъекту достаточно сопоставить, сколько детей он сознательно зачал и произвел на свет с тем, сколько раз в течение жизни и с какой целью он совершал сексуальные действия. В конце XX века было создано множество контрацептивных средств,

которые освобождают людей, вступающих в сексуальный контакт, от страха перед нежелательной беременностью. Искусственное осеменение и генная инженерия сделали возможным «непорочное зачатие». К настоящему времени во всем мире благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) на свет появились свыше 1 млн младенцев.

И.С. Кон (2003) также выделяет и другие общие тенденции в сексуальности, характерные для всех развитых стран:

- более раннее сексуальное созревание и пробуждение эротических чувств у подростков;
- более раннее начало сексуальной жизни (по типу своего сексуального поведения подростки опережают своих сверстников из прежних поколений на 3 - 4 года);
- социальное и моральное принятие добрачной сексуальности и сожительства (да и как может быть иначе, если половое созревание происходит раньше, а возраст вступления в брак в индустриально развитых
странах повышается);
- ослабление «двойного стандарта»;
- признание сексуальной удовлетворенности одним из главных факторов удовлетворенности браком и его прочности;
- ресексуализация женщин, которых викторианская мораль считала вообще асексуальными; современные женщины получают от своей сексуальной жизни значительно больше удовольствия, чем прошлые поколения;
- сужение сферы запретного в культуре и рост общественного интереса к эротике;
- рост терпимости по отношению к необычным вариантным и девиантным формам сексуальности, особенно гомосексуальности;
- увеличение разрыва между поколениями в сексуальных установках, ценностях и поведении - многое из того, что было абсолютно неприемлемо для родителей, дети считают нормальным и естественным.

Группа немецких специалистов под руководством Г. Шмидта провела интервью с 776-ю 30-, 40-, 45- и 60-летними мужчинами и женщинами, проживающими в городах ФРГ (G. Schmidt et al., 2003). Оказалось, что лица обоего пола

ныне заключают брак реже и позже, чем раньше, а их супружеский союз чаще распадается. Из-за частых разводов все больше детей воспитываются без участия одного из родителей. Появились различные формы небрачных союзов. Сегодня «парой» фактически признают любой союз, где двое людей говорят, что они образуют единое целое независимо от семейного статуса и пола партнеров, а «семьей» считается любая пара, имеющая детей, независимо от того женаты ли их родители, воспитываются ли дети в одном или двух домохозяйствах. Выявленные сдвиги исследователи называют «семейной революцией», которая, по их мнению, изменяет общество сильнее, чем предшествовавшая им сексуальная революция 60 - 70-х годов прошлого века.

1.9. Особенности мужской и женской сексуальности

В общественном сознании маскулинность и сексуальность - почти синонимы. «Настоящий мужчина» в привычном понимании - прежде всего хороший самец, его идентичность неотделима от его сексуальности, а сила мужчины обычно ассоциируется с его потенцией. А как обстоит дело на самом деле?

Проведен аналитический обзор 5400 научных статей, посвященных выраженности сексуального влечения, т. е. специфической мотивации, сконцентрированной на сексуальной активности и стремлении к достижению сексуального удовлетворения (R. F. Baumeister, K. R. Catanese, K. D. Vohs, 2003). Установлено, что по большинству показателей (частота сексуальных мыслей, фантазий и спонтанного возбуждения; желаемая частота секса; частота мастурбации; желаемое число сексуальных партнеров; предпочтение секса другим занятиям; активный поиск, а не избегание сексуальных действий; готовность инициировать сексуальные действия; наслаждение разными типами сексуальных практик; готовность жертвовать ресурсами ради секса; положительное отношение к сексуальной активности; распространенность расстройств, связанных с понижением сексуального желания) - мужское влечение значительно сильнее женского. Ряд ученых объясняет этот феномен с позиции эволюционной биологии:

39

если биологическая функция самцов состоит в том, чтобы оплодотворить как можно больше самок, то мужская сексуальность по определению должна быть более сильной и экстенсивной.

Был проведен массовый анкетный опрос более чем 16 000 студентов 52 народов из 10 основных регионом мира (G. Schmidt et al., 2003). Молодых людей спрашивали, скольких сексуальных партнеров они хотели бы иметь вообще и в ближайший месяц, готовы ли они приложить для достижения этой цели определенные усилия и как быстро они готовы согласиться на сексуальное сближение с малознакомым человеком? Оказалось, что независимо от страны, региона, брачного/партнерского статуса и сексуальной ориентации респондентов, мужчины хотят иметь больше сексуальных партнеров, чем женщины (иметь в течение ближайшего месяца больше одного партнера хотели бы свыше 50 % мужчин и меньше 20 % женщин), и мужчины легче идут на сексуальное сближение после кратковременного знакомства. По мнению исследователей, это подтверждает универсальность мужской тяги к сексуальному разнообразию и краткосрочным связям.

Повышенное значение для мужчин сексуальной активности имеет важные социально-психологические последствия. Мужская сексуальность была и остается предметом своеобразного культа. А где культ - там и мифы, а где мифы - там опасения и страхи. Перечислим некоторые типичные для американских мужчин мифы: настоящий мужик проверяется прежде всего в сексе; мужчина всегда заинтересован в сексе и всегда готов к нему; всякое прикосновение сексуально или должно вести к сексу; хороший секс происходит сам собой, без подготовки и разговоров; секс - это твердый член и то, что с ним делают; секс и половой акт - одно и то же; хороший секс обязательно предполагает оргазм; занимаясь сексом, мужчины не должны слушаться женщин; у настоящих мужчин нет сексуальных проблем (B. Zelbergeld, 1992).

Все эти утверждения весьма далеки от истины. «Настоящий мужчина» из легенды обязательно обладает длинным и твердым членом, который является главным признаком мужского достоинства и силы и ассоциируется с высокой потенцией. Счастливым обладателям крупных

40

пенисов приписывают особую физическую силу и высокую сексуальную активность. Среднестатистические размеры эрегированного полового члена европейского мужчины составляют 13 - 16 см. Объективно его размеры для женщин не так уж важны, поскольку женские гениталии весьма пластичны и при достаточном уровне полового возбуждения легко подстраиваются под размеры фаллоса партнера. Не более 5 % женщин могут реально испытывать с этим проблемы. Сексуальное удовлетворение женщин зависит от размера пениса гораздо меньше, чем это принято думать, но все же при прочих равных условиях многие из них действительно предпочитают мужчин с достаточно большим половым членом.

Сексологи иногда шутят, что «мужской прибор - самый ленивый». Только в период юношеской гиперсексуальности (1-18 лет) эрекция у юношей может возникать помногу раз в день, порой в самых неподходящих местах. У взрослых мужчин эрекции возникают реже и становятся более избирательными. Кроме того, эрекция, половое возбуждение и сексуальное желание конкретной женщины - это вовсе не одно и то же. Мужской оргазм может различаться по интенсивности в зависимости от выраженности полового влечения к партнерше. Диапазон оргастических переживаний может колебаться от сброса напряжения и чувственного удовольствия, локализованного преимущественно в половых органах, до экстаза с исчезновением границ пространства и времени.

Современный мужчина порой оказывается пленником стереотипов о собственной силе. Женщина, которая отказывает мужчине, только приобретает уважение. Отказ в интимной близости со стороны мужчины до сих пор воспринимается как свидетельство его несостоятельности либо как личное оскорбление. По мнению И.С. Кона (2004), мужской стиль жизни носит во многом предметно-инструментальный характер. Это распространяется и на сексуальность. В мужском сексуальном сценарии «секс» - не только удовольствие, но и работа, которая обязательно требует успеха, завершения, мужчине необходимо «кончить» самому и «довести» до оргазма партнершу. На первый план при этом часто выдвигаются количественные показатели - число женщин, количество половых актов. Но количество сексу-

альных партнерш и контактов далеко не всегда коррелирует с сексуальной удовлетворенностью. Мужчины склонны к «техницизму» сексуального мышления: они часто озабочены тем, как продлить эрекцию, усилить ощущения во время фрикций и при семяизвержении. Поэтому для мужчины интимная близость - это прежде всего половой акт. Все остальное - предварительные ласки, проявления нежности после окончания коитуса - кажется второстепенным, необязательным.

Вследствие инструментальности и соревновательности своего стиля жизни многие мужчины не доверяют собственным переживаниям и нуждаются в объективном подтверждении своей сексуальной эффективности. Самое весомое подтверждение своих мужских достоинств мужчина получает от женщины. Поэтому так важен для юноши первый сексуальный опыт. Да и взрослые мужчины нередко изменяют женам и заводят внебрачные связи не только из-за жажды разнообразия, но и с целью самоутверждения. Но мужчина, который прежде всего стремится доказать свою силу, невольно превращает половую близость в экзамен, порой проваливая его как раз потому, что он не чувствует себя свободно и раскованно. Не случайно, по-жалуй, самая распространенная сексуальная проблема современного мужчины - «исполнительская тревожность», порождаемая сомнениями в своем «мастерстве» и тревогой перед возможной неудачей при половом акте (чаще из-за отказа эрекции). Напротив, жители некоторых островов Полинезии вообще отрицают саму возможность мужской несостоятельности в нашем понимании. Кстати, поэтому у них не наблюдается случаев психогенных нарушений эрекции.

Традиционная модель сексуального поведения приписывает всю активность, начиная с ухаживаний и заканчивая техникой полового акта, мужчине, оставляя женщине пассивную роль. Строго говоря, этой модели никогда не придерживались все пары, однако отголоски этого стереотипа дошли до наших дней. С одной стороны, женщины нередко ждут от мужчины инициативы, не проявляя активно своих сексуальных желаний. С другой стороны, мужчины порой демонстрируют недоумение и даже раздражение, когда партнерша открыто выражает свои намерения всту-

пить в половой акт. У них возникает страх перед непредсказуемостью и силой сексуального желания женщины, с которым они могут не совладать. Такое несоответствие экспектаций порождает взаимное недовольство и является одной из причин возникновения сексуальной дисгармонии в паре.

Мужской сексуальности также свойственны экстенсивность и меньшая эмоциональная вовлеченность в психологическую интимность. Желание реализовать безличные, не связанные с конкретным сексуальным партнером сексуальные потребности, толкает многих мужчин на случайные связи, которые увеличивают вероятность всевозможных «осечек», а значит и обвинений в мужской слабости. Ведь если партнеров ничего кроме плотского желания не связывает, то невозможность его реализации - хороший повод, чтобы сорвать зло на партнере, выставить его в самом невыгодном свете, тем самым пробуждая у него сомнения в сексуальной состоятельности.

Кратко остановимся на наиболее характерных особенностях женской сексуальности.

Женская сексуальность связана с менструальным циклом. Сексуальная реактивность женщин различна на разных стадиях цикла. Например, наибольший интерес к эротическим фильмам появляется у молодых женщин сразу после окончания менструации, а в первые семь дней второй половины цикла интерес к эротике снижается. Также наблюдаются циклические колебания либидо и способности испытывать оргастические переживания. Уделом примерно половины женщин является предменструальный синдром, который проявляется раздражительностью, эмоциональной и вегетативной лабильностью.

Женская сексуальность отличается большей психологичностъю, результатом чего являются значительные индивидуальные различия в сексуальном поведении женщин и сексуальных переживаниях. Испытывать оргазм и удовлетворение от близости женщине нередко мешают опасения, что она не может положиться на любимого человека или страх потерять его. Директор Института Кинзи Джон Бэнкрофт (2003), опираясь на опрос 987 американских женщин от 20 до 65 лет, утверждает, что женская сексуальность качественно отличается от мужской. Сексуальная неудов-

летворенность женщин зависит не столько от физических (телесных) реакций, таких как возбуждение, любрикация, оргазм, сколько от психологических факторов, включая чувство общего эмоционального благополучия и хорошие отношения с партнером. Некоторые явления, которые мужчины, а вслед за ними и врачи, воспринимают как болезненные расстройства, требующие лечения, для женщин скорее являются проблемами, с которыми они живут и которые решаются не фармакологическими, а психологическими средствами (Банкрофт и др., 2003). Недавно фирма «Pfizer», создатель легендарной «Виагры», окончательно отказалась от дальнейших разработок «женской Виагры» в связи с большой зависимостью женской сексуальности от психосоциальных факторов и бесперспективностью фармакотерапии. Тем не менее в Москве в последнее время ряд фирм стал рекламировать чудодейственные инъекции для женщин, страдающих аноргазмией. Интравагинальное введение препарата в пятно Граффенберга вызывает отек - набухание последнего, что якобы резко повышает оргастичность женщины.

С психологичностью сексуальности женщины связаны следующие моменты.

Ведущую роль в формировании полового поведения женщины играет не сексуальное либидо, т. е. стремление к половому акту, а эротическое, тесно связанное с оценкой личностный качеств партнера. Поэтому женская сексуальность по сравнению с мужской более избирательна.

Сексуальное удовлетворение у женщин менее тесно связано с оргазмом, чему мужчин. При хороших отношениях и глубокой взаимной привязанности супругов женщина вполне может довольствоваться «удовлетворением без оргазма » в течение многих лет. Даже при достаточном сексуальном опыте и пробудившейся оргастичности у большинства женщин часть половых актов завершается без оргазма. Если при этом нет физического дискомфорта и признаков эмоциональной неудовлетворенности, подобные случаи не имеют патологической основы.

Однако одним из негативных последствий бурных сексуальных революций 60-80-х годов прошлого века явилось превращение женского оргазма из удовольствия в утомительную обязанность, абсолютную цель, которой одержимы многочисленные представители обоих полов. Причем

для немалого числа мужчин - это лишь способ почувствовать себя отличным сексуальным партнером, который всегда способен удовлетворить женщину. Прекрасный пол также нередко стремится к достижению оргазма из соображений престижа, поскольку он дает возможность женщине продемонстрировать партнеру свою «сексуальную полноценность» и убедиться в ней самой. Иногда в основе «оргазмоцентрической» установки лежат опасения женщины, что иначе мужчина ее разлюбит и уйдет к другой (особенно при наличии реальной или мнимой соперницы). Так или иначе подобные установки порождают у многих женщин тревожные опасения дурных последствий отсутствия оргазма и желание приложить все усилия, чтобы получит этот «заветный приз».

При консультировании женщин с сексуальными проблемами следует помнить еще о некоторых особенностях женской сексуальности.

Большинство сексуальных дисфункций не препятствуют интимной близости женщины, хотя и мешают получать удовлетворение от нее.

В становлении женской сексуальности отмечается тенденция к застреванию в эротической фазе. Причем у ряда женщин пробуждения сексуального компонента либидо и способности испытывать оргазм вообще не происходит, либо способность достигать оргазма возникает лишь после определенного периода регулярной половой жизни.

Если эрогенные зоны мужчины в основном локализованы в области половых органов, то у женщин экстрагенитальные зоны играют большую роль, а порой доминируют над генитальными в процессе нарастания возбуждения.

В отличие от мужчин, у которых после полового акта возникает рефрактерный период (необходим для накопления зрелых сперматозоидов в эякуляте), у женщин нет периода половой невозбудимости, что потенциально обеспечивает мультиоргастичность (эта возможность реализуется у 14 - 30 % женщин).

Для лучшего понимания психологических аспектов, отличающих мужскую и женскую сексуальность, кратко остановимся на теории сексуальных стратегий американского психолога Д. Басса (1994, 1998). С точки зрения эволюционной психологии все психологические механизмы

человеческой сексуальности возникли путем естественного отбора в процессе эволюции. Эти психологические механизмы обеспечивают сексуальную адаптацию индивида к изменяющимся условиям окружающей среды. В процессе эволюции мужчины и женщины сталкивались с разными адаптивными проблемами, поэтому у них сформировались отличные друг от друга сексуальные стратегии.

Мужчины и женщины выработали стратегический репертуар, который включает в себя как краткосрочные (поиск временного сексуального партнера), так и долгосрочные (поиск постоянного партнера) стратегии. При решении краткосрочных и долгосрочных задач у них возникают разные адаптивные проблемы. Так мужчины уделяют спариванию больше усилий, чем женщины, что связано с существенными различиями в размере минимального родительского вклада у представителей обоих полов. Поэтому мужская краткосрочная сексуальная стратегия предполагает решение четырех адаптивных проблем: 1) определение числа половых партнеров; 2) определение сексуально доступных женщин; 3) определение фертильных женщин; 4) минимизация усилий, необходимых для достижения цели (полового контакта) и родительского вклада.

Несмотря на то, что женщины гораздо меньше выигрывают от краткосрочного спаривания, они могут получить от него ряд адаптивных выгод: 1) материальные ресурсы для себя и своих детей; 2) подстраховку на случай потери постоянного партнера; 3) генетические выгоды от спаривания с более сильным мужчиной.

Стратегия долгосрочного спаривания ставит перед мужчиной другие задачи: 1) определение репродуктивно ценных женщин; 2) обеспечение повышенной вероятности стать отцом; 3) определение женщин с хорошими родительскими навыками.

Женщины, избирающие долгосрочную сексуальную стратегию, решают следующие задачи: 1) определить мужчин, способных добывать ресурсы; 2) определить мужчин, которые обнаруживают готовность вложить эти ресурсы в их и их детей; 3) определить мужчин, желающих вступить в долгосрочные отношения; 4) определить мужчин, готовых защищать их и их детей от внешней агрессии; 5) определить мужчин с хорошими родительскими навыками.

В зависимости от контекста мужчины и женщины используют конкретные сексуальные стратегии или их комбинацию.

1.10. Сексология и сексопатология

Сексология является междисциплинарной наукой, объединяющая ряд отраслей знаний основным признаком - изучение человеческой сексуальности во всех ее аспектах: биологическом; психологическом, социальном, морально-этическом, правовом, педагогическом, этнографическом, антропологическом, гигиеническом, религиозном и медицинском. Поэтому медицинская сексология (сексопатология) - составная часть сексологии как науки и одновременно клиническая дисциплина, которая изучает причины нарушения сексуального здоровья, методы профилактики, диагностики и лечения половых расстройств.

Сексология выделилась из ряда других наук и стала самостоятельной лишь в XX веке, когда возросла потребность в систематизированных знаниях о сексуальном поведении человека. Однако интерес к проблемам пола существовал всегда. Достаточно обратиться к старинным трактатам по сексуальным практикам, дошедшим до наших дней из глубины веков: «Искусство спальни» (Китай), «Кама-сутра» и «Ананга ранга» (Индия), «Искусство любви» (Древняя Греция) и др. В древнейших мифологических, а позже и в философских учениях содержались определенные сведения о природе половых различий, анатомии и физиологии половых органов, эротических ласках и позициях полового акта, зачатии, беременности и родах. Однако древняя эротология, то есть теория и практика искусства любви, имела сильный налет мистицизма и не ставила своей целью глубоко исследовать сексуальность. Только с развитием целого комплекса медико-биологических и социально-психологических наук, после преодоления сопротивления церкви и сексологического ханжества среди большей части населения возникли предпосылки для всесторонней и объективной оценки феномена человеческой сексуальности. Систематическое изучение половой жизни первыми начали врачи, причем, долгое время круг их исследований ограни-

чивался лишь патологическими формами сексуального поведения, а нормальные проявления сексуальности человека оставались без должного внимания.

В числе основоположников современной сексологии следует упомянуть профессора психиатрии Венского университета Рихарда фон Крафт-Эбинга (1840 - 1902). Его труд «Сексуальные психопатии », изданный еще в 1886 году, послужил основой для развития медицинской сексологии. Австрийский врач, родоначальник психоанализа Зигмунд Фрейд (1856 - 1939) первым открыл широким кругам общественности роль сексуальности в жизни человека. Он пришел к выводу, что причиной неврозов служат бессознательные конфликты сексуальной природы. Исследуя психосексуальное развитие ребенка, Фрейд показал влияние его нарушений на психическое здоровье и сексуальность взрослого человека. Свою теорию младенческой сексуальности он развил в книге «Три очерка по теории сексуальности», которая вышла в свет в 1905 году. Во многом именно благодаря трудам Фрейда сексуальность стала серьезно изучаться в медицине и психологии. Немецкий дерматовенеролог Иван Блох (1872 - 1922) изучал историю проституции и «необычное» сексуальное поведение, а в своей книге «Сексуальная жизнь нашего времени и его связь с современной культурой», изданной в 1909 году, впервые в систематизированном виде представил весь комплекс существующих в тот период времени сексологических знаний. Немецкий психиатр Магнус Хиршфельд (1868 - 1935) исследовал сексологические проблемы в социальном, историческом и медицинском аспектах. Он придавал основное значение решению этических и юридических проблем, стремился урегулировать вопросы *проституции* и контроля над рождаемостью. В 1918 году в Берлине Хиршфельд основал и возглавил первый в мире сексологический институт. Английский публицист, издатель и врач Генри Хэвлок Эллис (1859 - 1939) потратил несколько десятилетий на изучение всей доступной в то время информации о сексуальном поведении человека в западном мире и других культурах. В результате с 1886 по 1928 год им было издано семь томов «Исследований по психологии секса». В них признавались многовариантность сексуального поведения и

склонностей, проявляемых людьми, а также обусловленность сексуальной морали

48

культурными и социальными факторами. Работы Эллиса, несомненно, сыграли свою роль в постепенной либерализации сексуальных установок, господствующих в викторианскую эпоху (см. *викторианизм*). Важную роль в развитии сексологии внесли швейцарский невропатолог, психиатр и энтомолог Август Форель (1848-1931), который в 1906 году опубликовал работу «Половой вопрос», а также немецкий психиатр Альберт Молль (1862-1939), обобщивший свои взгляды на сексуальное развитие детей и половое воспитание в труде «Половая жизнь ребенка», изданном в 1908 году. Перу голландского гинеколога Теодора Ван де Вельде (1873 - 1937) принадлежит книга «Идеальный брак», которая впервые была опубликована в 1926 году, пользовалась чрезвычайно большой популярностью и к 1967 году выдержала 77 изданий. Ван де Вельде предложил свою концепцию гармоничного супружества, которая учитывает многообразие факторов, способствующих стабильности брака. В их числе важнейшую роль он отводил повышению сексуальной удовлетворенности супругов. Значительный вклад в развитие современной сексологии внес американский биолог Альфред Кинзи (1894 - 1956), который впервые провел широкомасштабное изучение полового поведения людей (детальному опросу подверглись более чем 16 000 человек). Итогом данного исследования стали труды «Сексуальное поведение мужчины» и «Сексуальное поведение женщины», опубликованные соответственно в 1948 и 1953 годах. Кинзи и его сотрудники убедительно доказали существование огромного диапазона индивидуальных различий в проявлениях сексуальности человека. Американский гинеколог Уильям Мастерс (родился в 1915 г.) вместе со своей сотрудницей Вирджинией Джонсон первыми в лабораторных условиях детально изучили нормальные физиологические реакции мужчины и женщины при половой близости. Подробный отчет об их работе представлен в книге «Сексуальные реакции у человека», изданной в 1966 году. Мастерс и Джонсон разработали оригинальный подход к терапии половых дисфункций, который описали в своей книге «Сексуальная неадекватность у человека». В 1970 году выход в свет этого издания ознаменовал рождение секс-терапии. Исследования

последних десятилетий, проведенные в нейрофизиологии, генетике, эмбриологии, эволюционной био-

логии, эндокринологии, гинекологии, психологии и других научных дисциплинах, позволили значительно обогатить и расширить познания в области дифференциации и взаимоотношений полов, различных аспектов человеческой сексуальности.

Сексопатология (медицинская сексология) - область клинической медицины, изучающая причины возникновения половых расстройств, диагностику, клинику, течение, прогноз нарушений сексуальной сферы, а также вопросы их лечения и профилактики. Базируется на междисципли-нарном (системном) подходе и в выявлении закономерностей развития сексуальной патологии, ее диагностике и лечении опирается на психиатрию, клиническую психологию, психотерапию, урологию, андрологию, гинекологию, эндокриноло-гию, невропатологию, ангиологию.

Г.С. Васильченко (1990) выделил три основных этапа становления сексопатологии. На первом, наивно-механистическом, этапе (конец XIX - начало XX веков) все сексуальные расстройства связывались с заболеваниями мужских или женских половых органов. Второй, энциклопедический, этап в развитии сексопатологии (начало - середина XX века) знаменовал переход на мультидисциплинарные методологические позиции. Его результатом явилось преодоление односторонних взглядов на природу сексуальной патологии и признание многофакторности половых расстройств, которые могут возникать при разнообразных формах психической, неврологической, урологической, гинекологической, эндокринной патологии. Переход к третьему этапу связан с фундаментальными работами отечественных исследователей (В. А. Геодакян, И.С. Кон и др.). На базе общей теории функциональных систем П. К. Анохина и концепции о стадиях и составляющих копулятивного цикла Г.С. Васильченко разработал первую междисциплинарную модель сексопатологии, открывающую ее системный этап. Развивая системную концепцию, В.В. Кришталь выделил четыре аспекта сексуальности человека - социальный, психологический, социально-психологический и медико-биологический - и соответствующие им направления в сексологии и сексопатологии. Системный

подход позволяет выявить роль многочисленных негативных социальных, психологических и биологических факторов в генезе сек-

суальных расстройств и на этой основе разработать наиболее адекватные лечебно-профилактические мероприятия.

Сексопатология, будучи единой дисциплиной, подразделяется на общую и частную. Общая сексопатология изучает основные закономерности соотношения и дифференциации полов, анатомо-физиологические особенности половой сферы и сексуальности, вопросы сексуальной нормы и патологии, формы реализации сексуальных потребностей человека, эпидемиологию и феноменологию половых расстройств, причины и условия развития сексуальной дисгармонии. Частная сексопатология изучает конкретные формы половых расстройств, их этиопатогенез, клинику, разрабатывает методы диагностики профилактики и лечения того или иного заболевания. Важным постулатом современной научной сексопатологии является принцип парности, положенный в основу концепции партнерства и учитывающийся в диагностике и лечении половых расстройств.

Наряду с вышеназванными учеными большой вклад в становление отечественной сексологии и сексопатологии внесли Н.В. Иванов, П.Б. Посвянский, А.М. Свядощ, И.Ф. Юнда, В.И. Здравомыслов, Г.И. Козлов, С.С. Либих, В.М. Маслов, И.Л. Ботнева. В настоящее время на постсоветском пространстве над актуальными проблемами сексологической науки и практики активно работают известные специалисты С.Т. Агарков, Б.Е. Алексеев, Б.М. Ворник, И.И. Горпинченко, В.А. Доморацкий, Н.Д. Кибрик, Г.С. Качарян, А.С. Качарян, А.И. Федорова, Л.М. Щеглов, М.И. Ягубов и др.

51

Глава 2. Сексуальные дисгармонии и дисфункции

2.1. Сексуальные дисгармонии

Сексуальную дисгармонию (дисгамию) можно охарактеризовать как нарушение сексуального взаимодействия в паре, которое вызывает недовольство партнеров существующими интимными отношениями. Возникает в результате недостаточной психологической совместимости или физической привлекательности партнеров, а также отсутствия взаимоприемлемого сексуально-поведенческого стереотипа, обеспечивающего адекватное удовлетворение их половых потребностей.

К. Имелинский (1986) считает, что любые недостатки в физическом и психическом соответствии друг другу способны привести к отрицательной оценке «стиля переживания близости» одним или обоими партнерами. В подобных случаях действия партнера, его мимика, жесты, проявления чувств, половое возбуждение - все это, вместо того чтобы быть сильным эротическим раздражителем для мужчины или женщины, становится эротическим тормозом, способным блокировать половое возбуждение. В результате развивается сексуальная дисгармония, которая проявляется: 1) снижением потребности в половых сношениях с партнером; 2) снижением интенсивности чувственных переживаний во время полового акта, включая утрату прежней остроты оргастических ощущений у мужчин и урежение или полное отсутствие оргазма у женщин; 3) уменьшением сексуальных возможностей при *коитусе* (ослабление эрекции, ускоренная либо затрудненная эякуляция у мужчины, торможение полового возбуждения и любрикации у женщины).

52

О том, что сексуальная дисгармония вызвана недостаточной эротической привлекательностью партнера, сигнализирует тот факт, что в ходе половой близости с ним субъект вынужден создавать в воображении образ другого мужчины или другой женщины, чтобы добиться большей степени полового возбуждения. Особенно часто это случается при наличии «конфликтной любви», которая направлена не на актуального партнера, а другое лицо. Об этом всегда свидетельствуют и ситуации, когда мужчина периодически испытывает сильное половое возбуждение при несексуальных контактах с другими женщинами (во время танца), в то время как со своей партнершей он не может добиться подобного состояния даже в самой интимной ситуации.

По мнению К. Имелинского (1986), даже удачное партнерство (супружество) с течением времени претерпевает определенную динамику. Можно выделить три фазы его развития.

1-я фаза. Если партнеров связывают глубокие чувства и взаимная эротическая привлекательность, любые контакты между ними, в особенности сексуальные, которые на этой фазе могут преобладать над всеми другими видами общения, способствуют возникновению ярких эмоциональных переживаний, субъективно воспринимаемых как чувство влюбленности. Таким образом, сексуальные аспекты партнерских отношений доминируют над несексуальными.

2-я фаза. После завершения периода максимального подъема, связанного с чувственностью (редко продолжается свыше четырех лет, что обусловлено нейрофизиологическими механизмами), наступает некоторое снижение интенсивности эротических эмоций между партнерами. Развивается равновесие между сексуальными и несексуальными аспектами жизни.

3-я фаза. Возникает, когда партнер перестает пробуждать яркое эротическое желание, либо даже начинает вызывать нежелание вступать с ним в интимные контакты. Фаза эротического равнодушия является неизбежным следствием эмоциональных перемен и физических изменений, происходящих

у двух людей при длительной совместной жизни. При этом происходит замещение чувства любви другими положительными или отрицательными чувствами, которые способствуют сохранению брака либо, напротив, его разру-

шению. Темпы такого, во многом естественного, варианта развития сексуальной дисгармонии зависят от удачного или неудачного подбора полового партнера. При выборе, осуществленном по любым мотивам, кроме взаимного сексуального влечения и эротической любви, партнеры начинают совместную жизнь со 2-й или даже 3-й фазы. Таким образом, дисгамия может быть следствием изначально неадекватных для гармоничной интимной жизни установок, типа «стерпится - слюбится», «главное - чтобы меня любили» и т. п. Напротив, удачное партнерство лишь на отдаленных этапах совместной жизни ведет к возникновению сексуальной дисгармонии, которая в данном случае не имеет патологической основы, являясь лишь следствием притупления прежних возбуждающих стимулов и развития эротического равнодушия к партнеру. При этом устойчивые межличностные отношения, основанные на уважении, доверии и взаимопонимании, могут длительно сохраняться, выступая стабилизатором брачного союза, в котором уже нет пылкой любви.

Но даже сильные обоюдные чувства партнеров сами по себе еще не являются гарантией взаимоудовлетворяющих интимных отношений. С.Т. Агарков, Т.Е. Агаркова (1985) считают, что сексуальную гармонию в паре отличают прежде всего умение понимать желания другого и адекватно выражать собственные половые потребности в общении с ним. Гармония в половой жизни зависит от хорошей психологической совместимости пары и взаимной сексуальной адаптации, т. е. их умения приспособить собственные сексуальные потребности друг к другу.

Сексуальные дисгармонии являются результатом сложного взаимодействия внутриличностных, межличностных, поведенческих, физиологических факторов и социальных влияний. В целях систематизации можно выделить следующие варианты дисгармоний (по ведущим механизмам ее развития): 1) социально-психологические; 2) поведенческие

(технические); 3) физиологические; 4) связанные с патологией. Подчеркнем, что в изолированном виде они встречаются нечасто, а в большинстве случаев формирование той или иной сексуальной дисгармонии обусловлено сочетанием различных механизмов и вариантов.

Дисгамии задерживают пробуждение сексуальности у женщин, при уже сформировавшемся половом влечении

тормозят возбуждение и часто препятствуют наступлению оргазма, а в случае длительного течения - снижают либидо. У мужчин наличие дисгармонии в интимной жизни может порождать идеи сексуальной неполноценности, способствуя возникновению психогенных *сексуальных дисфункций,* либо постепенно вызывает утрату эротического интереса к супруге.

Социально-психологические дисгармонии

Социально-психологические факторы во многом определяют устойчивость брака в целом и характер интимных отношений. К развитию сексуальной дисгармонии предрасполагают несоответствие черт характера супругов, их эмоциональная незрелость, инфантильность и зависимость от мнения окружающих, разочарование *в* личностных качествах партнера и нарастающие негативные эмоции по отношению к нему (например, после измены супруга либо появления собственного нового увлечения, при его пьянстве или постоянной занятости на работе и т. п.), невозможность реализации в браке потребности в самоутверждении. Негативную роль играет отсутствие взаимного согласия по вопросам, связанным с рождением детей и их воспитанием, совместным времепровождением, бытовыми условиями и материальным обеспечением семьи, культурным досугом и отдыхом, интимной жизнью в браке, ее регулярностью и разнообразием и т. п. Часто в основе психологической дисгармонии лежит несоответствие между представлениями партнеров об идеальном супружестве и тем, как строятся их реальные отношения в браке. Такое несовпадение идеализирован-ных фантазий на тему брака и жизненных реалий вызывает душевный дискомфорт и порождает сомнения в

правильности выбора супруга или супруги. Лазарус представил целый ряд типичных заблуждений о семейной жизни. Перечислим некоторые из них: «пара должна все делать вместе»; «все спасено, если у нас будет ребенок»; «партнеры не могут иметь тайн друг от друга»; «вот заживем вместе, тогда я сделаю партнера другим»; «кто меня по настоящему любит, тот понимает и без слов»; «противоположности притягиваются»; «конкуренция между партнерами оживля-

ет супружеские отношения»; «вся работа а браке должна по братски делиться поровну» и т. п. Подобные мифы создают в браке нереалистичные ожидания и являются благодатной основой для возникновения супружеских конфликтов, нередко затрагивающих и интимную сферу.

В процессе сексуального общения партнеры должны понять, какое ролевое поведение они ждут друг от друга. В противном случае можно столкнуться с жалобами одного из супругов, что другой в ходе половой близости «делает все не так». С.С. Либих (1990) предложил схематичную классификацию психосексуальных типов мужчин и женщин, которая поясняет один из важных механизмов возникновения гармоничных и дисгармоничных интимных отношений. В соответствии с ней выделяют следующие типы женщин:

1. Женщина-мать. Стремится к опеке своего партнера, увлекается слабыми, больными, неудачниками. Стремится их защитить, «поднять», ободрить, воодушевить, Слабость и несчастья мужчин могут быть сильными сексуальными раздражителями. Даже беспокойство, эмоциональная неустойчивость, капризность партнера нередко являются для такой женщины сексуально возбуждающими и могут входить в структуру ожидаемых от него ласк.
2. Женщина-женщина.

а) Агрессивный тип. Стремится бороться с партнером, поначалу в обычном, а потом и в сексуальном общении. Насмешлива, язвительна, склонна к иронии, любит одерживать верх над мужчиной. В его ласках ожидает покорность, даже приниженность, некоторую растерянность.

б) Пассивно-подчиненный тип. Имеет идеалом «сильного мужчину», хочет подчиниться, «раствориться» в нем, в мечтах фантазирует о

мужчине, который «овладевает ею», в ласках мужчины она предпочитает агрессивность, напор, силу, вплоть до причинения боли.

3. Женщина-дочь. Идеал - мужчина значительно старше женщины, опытный, сильный, причем не столько в сексуальном, сколько в житейском отношении. В его присутствии чувствует себя слабой, «маленькой», в ласках предпочитает «искусство», «зна-

ие, которое выше силы», склонна к психологическим возбуждающим влияниям (речь, музыка и др.). Существуют аналогичные типы мужчин:

3. Мужчина-отец. Пожилой, элегантный, с большим сексуальным опытом и хорошо поставленным голосом, способен увлеченно говорить. В ласках женщина ценит элемент ее «отдачи», слабости, подчиненности, восхищения, «угадывания» его желаний и потребностей. Его изощренные ласки значительно компенсируют, возможно, уже невысокий сексуальный потенциал мужчины.

4. Мужчина-мужчина.

а) Агрессивный тип. Склонен к элементам «насилия», «овладения», в ласках демонстрирует борьбу, ласки грубы, чувственны, суждения безапелляционны, иногда причиняют боль.

б) Пассивно-подчиненный тип. Склонен идеализировать «сильную женщину», в ее внешности и вещах любит символы этой силы, авторитарности, некоторой мужеподобности (спортивная одежда или строгий деловой костюм, высокие сапоги, большие очки, мужская прическа и т. д.). Подчеркивает свою приниженность, зависимость, ищет приказов, наказаний, выговоров от женщины.

5. Мужчина-сын. Несамостоятельный, подчиняемый, иногда неудачливый, болезненный, психически и физически инфантильный и зависимый. Склонен к подражанию другим, может быть капризным, манерным. Ожидает от женщины утешения и по матерински нежных ласк.

Очевидно, что хорошо совместимы, а следовательно, наиболее гармоничны в сексуальном плане, например, мужчина-отец и женщина-дочь

или мужчина агрессивного типа и женщина пассивно-подчиненного типа. В то же время сложно ожидать подлинной гармонии между мужчиной-сыном и женщиной-дочерью либо двумя партнерами агрессивного типа.

В основе нарушений сексуального взаимодействия партнеров может лежать отсутствие элементарных знаний о психофизиологии мужской и женской сексуальности, сек-

суальной норме, ее возрастных колебаниях и т. д. Причем в отличие от дефицита сексологической литературы в советские времена сейчас мы столкнулись с явлением обратного порядка. Книжный рынок буквально переполнен популярными изданиями по технике секса, которые, подчас, формируют у читателя весьма искаженные представления о гармонии интимных отношений. Людям навязываются неадекватные стереотипы, например, два правила хорошего секса (одновременное наступление оргазма у обоих партнеров и обязательная смена клиторального оргазма вагинальным), убеждение, что все мужчины способны проводить половой акт сколь угодно долго, а женщины при каждом коитусе непременно должны испытывать бурную оргастическую разрядку. В результате такого дезинформационного давления, порождающего неадекватные установки в сфере интимных отношений, люди предъявляют чрезмерные требования к собственной сексуальности, порой расценивая ее физиологические колебания, как болезненные, а также неадекватно реагируют на возможные нюансы половой близости с партнером.

Поведенческие (технические) дисгармонии

Их сущность заключается в отсутствии оптимальных для пары форм полового общения, которые давали бы возможность получать партнерам обоюдное удовлетворение от сексуальных контактов. Другими словами - половое поведение супругов не оправдывает взаимных ожиданий. Встречаются в самом начале интимной жизни, при смене сексуального партнера, но возможны и в других случаях, если в паре не принято обсуждать индивидуальные сексуальные предпочтения. Чаще «страдают» женщины, в

силу многочисленных нюансов расположения, реактивности (чувствительности) и последовательности «включения» эрогенных зон, составляющих своего рода индивидуальный «код» возбуждения, который должен учитывать ее сексуальный партнер. Например, мужчины часто путают последовательность ласк, прибегая сразу к глубоким ласкам второго порядка (раздражение клитора и др.), минуя поверхностные ласки первого порядка, в результате чего возбуждение женщины тормозится либо носит неприятный, противоречивый характер.

58

Нередки случаи, когда мужчины вообще не знают индивидуальных особенностей расположения эрогенных зон своей партнерши, что приводит к их неадекватной стимуляции, отнюдь не способствующей нарастанию возбуждения в ходе предварительных ласк и самого коитуса. Иногда действия одного из партнеров, направленные на усиление сексуальных переживаний другого партнера, являются неприемлемыми для него, вызывают отрицательные эмоции и спад полового возбуждения. При половом акте технические дисгармонии проявляются в том, что партнеры используют позиции, при которых практически невозможно достичь оргазма у женщины. Например, у женщины с клиторальным типом оргазма в позиции с высоко поднятыми ногами клитор смещается вверх и назад, что препятствует возникновению оргазма. Еще одна проблема - несоответствие силы, темпа, направления и глубины фрикций ожиданиям женщины; слишком частая смена типа фрикций либо их однообразный характер на протяжении всего коитуса. Ошибкой является и отсутствие взаимных фрикций, т. е. полная пассивность и отстраненность женщины во время полового акта.

К сексуальной дисгармонии нередко приводит «стереотипизация и монотонизация половой жизни», которая формируется у значительного числа лиц мужского пола в возрасте старше 30 - 35 лет. Сексуально здоровые мужчины начинают относительно редко вступать в половые контакты, мотивируя это занятостью и постоянной усталостью. Если близость и происходит, они почти не используют предварительных ласк либо сводят их к однообразным воздействиям. Сам половой акт обычно происходит монотонно, в одной и той же позиции - по шаблону. Никакой заботы о чувственном удовлетворении женщины не проявляется. Такое

формальное исполнение «супружеских обязанностей» не имеет ничего общего с гармоничными интимными отношениями.

Физиологические дисгармонии

К ним относят недоучет конституциональных различий партнеров. В известном смысле сексуальная гармония в паре - это возможность адекватно реализовать присущий каждому из партнеров половой темперамент. В идеале -

сексуальное влечение, физиологические возможности и интенсивность половой жизни субъекта должны примерно совпадать. Однако в реальной жизни во многих супружеских парах происходят разногласия и даже конфликты по поводу частоты половых сношений. Ряд специалистов считает, что коитус должен проводиться только при обоюдном желании, а частота половых актов должна определяться партнером с более низким уровнем сексуального влечения. Однако такая ситуация может вызвать у партнера с более высоким уровнем желания перенапряжение и сильный дискомфорт в связи с необходимостью часто подавлять половое влечение. Сексуальная неудовлетворенность, нередко трансформируется в агрессивные чувства по отношению к партнеру. Однозначного решения данной проблемы не существует. В одних случаях более темпераментный партнер прибегает к мастурбации; в других - «тренирует выдержку и силу воли», максимально переключаясь на несексуальную активность (физкультура, работа на даче и т. п.); в-третьих - не устояв перед соблазном, ищет любовных утех «на стороне». Вместе с тем наиболее адекватным и безболезненным способом разрешения данной проблемы является активное использование партнерами петтинга, что, конечно же, требует определенного уровня взаимоотношений в паре. Когда у женщины возникает сильное желание, она может попытаться возбудить своего партнера, а если он все же окажется не готов к половому акту, то вполне сможет удовлетворить партнершу стимуляцией клитора рукой либо языком. В тех случаях, когда мужчина жаждет близости, а женщина совершенно на нее не настроена, она может просто разрешить себе доставить удовольствие партнеру, лаская половой член рукой либо прибегнув к орально-

генитальной стимуляции. Еще один распространенный вариант физиологической дисгармонии - несоответствие продолжительности полового акта, которую способен обеспечить мужчина, потребностям женщины. Если у мужчины эякуляция раз за разом происходит раньше, чем женщина успевает пол учить оргазм (при условии, что женщина способна к его достижению), это требует соответствующей терапии (при длительности коитуса не превышающей 1 - 2 минут) либо модификации поведения во время близости. Мужчинам рекомендуется увеличить продолжительность предварительных ласк,

включающих прямую стимуляцию области клитора и да во влагалище; периодически прерывать фрикции с одновременным раздражением клитора рукой; если половой акт все же не привел к оргазму у женщины - помочь достичь его в ходе завершающих ласк. Дополнительно могут использовать приемы, которые известны из древних тантрических текстов. Например, для снижения высокого уровня полового возбуждения мужчине рекомендуется произвести несколько сжатий мускулатуры промежности и анального сфинктера, при которых происходит втягивание заднего прохода. Их лучше сочетать с одновременным выполнением нескольких вращательных движений глазными яблоками либо при приближении у мужчины эякуляции - энергичным надавливанием пальца женщины на «особую точку тибетских монахов», расположенную в центре промежности посередине между мошонкой и анусом.

Дисгамии из-за относительного несоответствия размеров мужских и женских гениталий встречаются достаточно редко. Чаще всего жалобы женщины на слишком большие размеры полового члена партнера обусловлены отсутствием у нее достаточного возбуждения к началу коитуса. В этом случае не происходит адекватного увлажнения и увеличения в размерах влагалища, поэтому при интроитусе и фрикциях могут возникать дискомфортные ощущения. В отдельных случаях, когда длина полового члена мужчины в эрегированном состоянии значительно отклоняется от средних показателей (13 - 16 сантиметров), достигая 20-ти сантиметров и более, либо, наоборот, составляя менее 10 сантиметров, глубину проникновения во влагалище можно регулировать подбором

соответствующих позиций для сношения. Явное несоответствие половых органов чаще всего наблюдается при патологических состояниях влагалища (недоразвитие, заращение, рубцы, послеродовые нарушения вульварного мышечного кольца и пр.). В большинстве случаев функциональные возможности влагалища велики и при надлежащей позиции коитуса, соответствующей тренировке и осторожности, партнеры в состоянии достичь обоюдного удовлетворения.

В основе дисгармонии могут лежать различия в индивидуальных биологических ритмах супругов. Люди, относящиеся к «жаворонкам» имеют максимум жизнедеятельности, смещен-

ный на раннее утро, тогда как у «сов» - максимальная физическая и умственная работоспособность приходится на вторую половину дня и ночь. В соответствии с этим у «жаворонков» сексуальная активность выше в утренние часы, а «совы» в это время более пассивны, у них отсутствует потребность в близости. По вечерам «жаворонки» чувствуют себя уставшими, стремятся к отдыху, а «совы», напротив, испытывают наибольшее сексуальное желание, что порождает супружеские конфликты и недовольство друг другом. В большинстве случаев, идя на взаимные уступки, партнерам удается прийти к консенсусу по данному вопросу.

У лиц пожилого возраста дисгармонии связаны с игнорированием возрастных особенностей сексуальности. Так, женщины не хотят учитывать, что для возникновения полноценной эрекции у стареющих мужчин часто требуется интенсификация эротических ласк, включая прямую стимуляцию гениталий. Основная женская проблема в климактерическом периоде и постменопаузе связана с эстрогенной недостаточностью, которая приводит к истончению слизистой влагалища и его сухости даже при наличии полового возбуждения. Поэтому, чтобы при половом акте партнеры не испытывали неприятных ощущений от трения гениталий во время фрикций, необходимо использовать специальные увлажняющие гели.

Дисгармонии, связанные с патологией

Это дисгамии, которые носят вторичный характер и обусловлены имеющимися сексуальными расстройствами. Например, эректильная дисфункция, преждевременная или затрудненная эякуляция у мужчин, фригидность, диспареуния, вагинизм у женщин часто приводят к развитию сексуальной дисгармонии в паре. При хороших межличностных отношениях и широком диапазоне приемлемости супругов нарушения половой функции могут быть в значительной мере компенсированы изменением стереотипа половой близости с активным использованием разнообразных эротических ласк, включая петтинг, что может обеспечить обоюдное сексуальное наслаждение. Однако значительно чаще при нарушениях потенции у мужа в паре возникает

дисгамия, которая приводит к аноргазмии и постепенному снижению либидо у женщины. Сексуальные дисфункции у женщин, препятствуя достижению полового удовлетворения, зачастую формируют у них негативное отношение к сексу, что самым негативным образом сказывается на интимной жизни в супружестве. Поскольку этот вариант нарушения гармонии интимных отношений тесно связан с патологией - его часто относят к проявлениям сексуальной дезадаптации супружеской пары вследствие полового расстройства у одного или обоих партнеров.

Профилактика сексуальных дисгармоний заключается в предоставлении необходимой информации о психофизиологии и психогигиене половой жизни. Большое значение имеет правильное воспитание в детском возрасте, которое позволяет выработать адекватное отношение к проявлениям человеческой сексуальности. Так, интимно выхолощенный стиль поведения родителей тормозит психосексуальное развитие дочери, способствуя возникновению у нее в дальнейшем проблем в партнерских отношениях. Важная роль принадлежит повышению сексуальной культуры населения. Залог сексуальной гармонии - хороший межличностный контакт и взаимопонимание в паре. Это позволяет партнерам открыто обсудить все волнующие их вопросы и произвести «подстройку» сексуальных сценариев с учетом взаимных пожеланий.

У. Мастерс и В. Джонсон (1991) представили перечень рекомендаций, которые могут помочь супругам улучшить их взаимоотношения и достигнуть сексуальной гармонии в браке:

1. *Всегда помните, что хороший секс начинается, когда вы еще одеты.* Речь идет о том, что атмосфера спальни чаще зависит от того, что происходит вне спальни, каковы отношения между партнерами, умеют ли они выразить свои чувства и создать определенное настроение друг у друга.
2. *Стоит потратить время, чтобы подумать о себе как о сексуальном существе.* Одна из проблем, с которой люди часто встречаются, - это отделение секса от остальной жизни. Следует поразмыслить о своих сексуальных предпочтениях, от чего зависит возбуждение, что нравится, а что не нравится и т. п.

63

3. *Следует самому позаботиться о собственной чувственном и сексуальном удовольствии.* В определенной мере мы должны сами отвечать за то, что с нами происходит. Не следует считать, что партнер должен «обеспечить» все нужные ощущения.
4. *Говорите о сексе со своим партнером.* Удивительно, но факт: скрытность и неумение выразить чувства словами наблюдаются повсеместно и у людей, живущих долгие годы вместе. Зачастую это приводит к непониманию того, чего хочет партнер. Ласки, задуманные с самыми благими намерениями, могут не достигнуть цели, не подходить ему. Все это можно легко исправить несколькими словами, прошептав их вовремя. Но не следует проводить критический разбор того, что делает или не делает партнер сразу после близости.
5. *Регулярно проводите свободное время вместе со своим партнером.* Если вам приятно и легко с партнером вне постели, то это важная часть чувственного взаимодействия, которое продолжается и усиливается в сексе.
6. *Не допускайте, чтобы секс превратился в рутину.* Половая неудовлетворенность - это прямое отражение скуки, которая появляется там, где нет творчества в сексуальных отношениях. Секс должен
быть игрой, а не обязанностью, процедурой, рутинным мероприятием.
7. *Фантазия - самое лучшее возбуждающее средство.* С помощью фантазии можно самыми различными путями вызвать возбуждение и внести разнообразие в половую жизнь. Воображение может усилить и

воодушевить секс, если вы можете поделиться с партнером сюжетами и особенностями своих сексуальных фантазий - это замечательно.
8. *Работать над сексом не означает трудиться.* Не всегда «напряженная работа» над сексуальной проблемой приводит к положительному результату. Секс улучшается там, где есть спонтанность и естественность чувств и реакций. Роль аналитика и контролера своих реакций чаще всего ухудшает секс, здесь не может быть планов, процентов выполнения и т, п.

64

9. *Не вносите с собой раздражение в спальню.* К этому простому и ясному совету далеко не все прислушиваются, в результате - либо секс уходит, либо превращается в борьбу за власть и соперничество. Либо конфликт, либо секс. Совмещать эти вещи не стоит.
10. *Хороший секс - это не результат нажатия нужных кнопок.* Нельзя преувеличивать механические аспекты секса за счет эмоциональных. Это не руководство по технике рукопашного боя, где овладение нужным приемом дает ожидаемый эффект.
11. *Сохраните долю романтики в вашей жизни.* Внимание, признательность и нежность выражаются далеко не только в постели. Они украшают всю нашу жизнь.
12. *Не подходите к сексу слишком серьезно.* Серьезность, ответственность, чувство вины и т. п. - это именно то, что убивает секс. Оставьте серьезность для других жизненных ситуаций.
13. *Взгляды на те или иные вопросы секса у партнера могут быть другими.* Единство мнений и взглядов достигается уже в контакте, а не является условием самого общения. Диапазон приемлемости у каждого свой, и резко «ломать» его не следует.
14. *Не надо постоянно ждать, когда бы окажетесь «в настроении»* перед тем, как согласиться на секс. Совершенно естественно удовлетворить потребности партнера, даже если вы сами не чувствуете сексуального настроя. Кроме того, если партнер приглашает вас к

близости, дайте себе шанс войти в интимную ситуацию - это нередко удается.

15. *Помните, что сексуальные проблемы и трудности есть и у многих других людей.* Не нужно считать свои проблемы в интимной жизни уникальными. Все это уже было со многими людьми и еще будет с другими.

16. *Подходите реалистично к своим сексуальным ожиданиям.* Если вы ждете экстаза и неземного блаженства от каждого сексуального контакта, то вы обрекаете себя на неудачу. Нельзя оказаться пленником нереалистических ожиданий. Мы люди, а не

совершенные механизмы, и с нами может случаться всякое в жизни.

Отсутствие сексуальной гармонии в браке может привести к ухудшению супружеских взаимоотношений и способствует формированию психогенных половых дисфункций.

2.2. Мнимые сексуальные расстройства

Неадекватные убеждения и установки в отношении половой жизни ведут не только к развитию сексуальной дисгармонии в паре, но в ряде случаев способствуют возникновению мнимых сексуальных расстройств, т. е. убежденности в наличии нарушений половых функций при отсутствии таковых.

Мужчины нередко, предъявляя чрезмерно высокие требования к собственной сексуальной сфере, ошибочно полагают, что эрекция по желанию должна возникать в любой обстановке при одной только мысли об интимной близости; что половой акт может быть сколь угодно долгим до полного удовлетворения партнерши; что повторение полового сношения возможно уже через короткий промежуток времени и, что главное - все эти способности должны без снижения сохраняться до преклонного возраста.

Подобные неверные представления могут послужить причиной убежденности в половом расстройстве там, где его в действительности нет.

У мужчин различают следующие варианты мнимых сексуальных расстройств: 1) предъявление чрезмерных требований к собственным сексуальным возможностям; 2) приписывание себе воображаемых изъянов (например, убежденность в том, что они «истощили» свою нервную систему бывшей в юношестве мастурбацией); 3) неадекватная личностная реакция на естественные физиологические колебания сексуальности (без учета своего возраста, состояния здоровья, вынужденного воздержания и других причин, влияющих на сексуальную сферу мужчины); 4) неправильное поведение одного или обоих партнеров во время интимной близости вследствие несоответствия диапазонов приемлемости супругов, изъянов техники половых сношений, эротического равнодушия к партнерше, ее пассивности во время коитуса

или демонстрации неприязненного отношения к половому контакту с мужчиной.

У *женщин* мнимые сексуальные расстройства проявляются жалобами на снижение или чрезмерное повышение сексуальности, возникновение ощущений, которые женщина считает патологическими. Выделяют четыре варианта подобных расстройств. Одним из них является неправильная оценка женщиной изменений своих сексуальных проявлений без учета возрастных и конституционных норм сексуальности. Так, жалобы на полное отсутствие оргазма при всех формах сексуальной активности (коитус, петтинг, мастурбация, сновидения эротические) в начале половой жизни являются достаточно распространенным явлением и не требуют специального лечения. Другим поводом для сомнений бывает пробуждение или повышение полового влечения в климактерическом периоде, ошибочно расцениваемое женщиной как гиперсексуальность. Ко второму варианту мнимых сексуальных расстройств относят отсутствие у женщины сексуальной разрядки, если по каким-либо причинам она или партнер отказываются от стимуляции эрогенных зон, вызывающих оргазм. Третий вариант обусловлен неадекватной оценкой женщиной своей сексуальности

вследствие незнания или неприятия оптимальных для нее вариантов возбуждения либо ложных представлений о том, какой должен быть оргазм, который может существенно различаться по форме, глубине и интенсивности переживаний. Последний, четвертый, вариант связан с отсутствием у женщины постоянного сексуального партнера либо неправильным поведением мужчины при близости, а также имеющимися у него половыми расстройствами.

Конечным результатом ошибок и заблуждений, обусловленных сексологической неграмотностью, являются мучительные сомнения в своей эротической привлекательности для партнера и собственных сексуальных возможностях, а подчас и успевшая укорениться уверенность в существовании серьезных половых расстройств. Факторами, предрасполагающими к возникновению мнимых сексуальных расстройств, являются легкое снижение интеллекта или наличие тревожно-мнительных черт характера, что приводит к формированию искаженных представлений

о нормальной половой жизни. Мнимые сексуальные расстройства не относят к патологии. Они представляют собой особые предболезненные состояния, которые при отсутствии своевременной психотерапевтической коррекции в ряде случаев могут приводить к возникновению психогенных половых дисфункций.

2.3. Эпидемиология и систематика расстройств сексуальной функции

Сексуальное здоровье людей в силу высокой личностной значимости не менее важно, чем их физическое здоровье. Эксперты ВОЗ в 1977 году предложили следующее определение: «Сексуальное здоровье - есть комплекс соматических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных аспектов сексуального существования человека, позитивно обогащающих личность, повышающих коммуникабельность человека и его способность к любви». Понятие сексуального здоровья включает в себя три основных элемента: 1)

способность к наслаждению и контролю сексуального и детородного поведения в соответствии с нормами социальной и личной этики; 2) свободу от страха, чувства вины, ложных представлений и других психологических факторов, подавляющих сексуальные реакции и нарушающих сексуальные взаимоотношения; 3) отсутствие органических расстройств, заболеваний и нарушений, мешающих осуществлению сексуальных и детородных функций.

Известный украинский сексолог, профессор В. В. Кришталь (1997) считает, что сексуальное здоровье человека обеспечивается четырьмя факторами - социальным, психологическим, социально-психологическим и биологическим. Его социальное обеспечение определяется отношением общества к сексу, уровнем сексуальной культуры, усвоением людьми сексуальных и общественных норм, выработкой ими адекватных половых потребностей и т. д. Психологическое обеспечение сексуального здоровья определяется ролью индивидуально-психологических особенностей личности, осознаваемых и неосознаваемых психических процессов в развитии сексуальности и ее конкретных проявлениях.

68

Социально - психологическое обеспечение сексуального здоровья обусловлено парным характером сексуальной функции, формированием малой социальной группы (семьи или партнерской пары), сложившимися в обществе представлениями о различии мужских и женских социальных ролей и стереотипов мужественности и женственности. Биологическое обеспечение сексуальности определяют генетические факторы, правильное анатомическое строение и нормальное функционирование органов и систем человеческого организма. Поскольку сексуальное здоровье имеет многомерное обеспечение и определяется целым комплексом взаимодействующих компонентов, для оценки его состояния и коррекции возможных нарушений необходим системный подход, который традиционно используется отечественными сексологами в практической работе.

Эпидемиологические исследования в области сексопатологии сталкиваются с определенными трудностями. Сведения, получаемые как при непосредственном обследовании пациентов, так и поступающие из различных медицинских учреждений недостаточно надежны. Это связано с тем, что, во-первых, больные нередко скрывают имеющиеся у них сексуальные

нарушения, во-вторых, получаемые данные зависят от клинической квалификации и ориентации исследователя, в-третьих, существуют серьезные расхождения в вопросах диагностики среди сексопатологов, принадлежащих к различным школам, а также существенные различия в методах исследований. (В. В. Кришталь, Б.Л. Гульман, 1997). О широкой распространенности сексуальных проблем у лиц обоего пола можно судить, например, по данным одного из наиболее репрезентативных исследований сексуального поведения в США, проведенного в рамках Программы обзора здоровья и социальной жизни (HNSLS). В ходе опроса было установлено, что снижение или отсутствие интереса к половой жизни наблюдается у 16 % мужчин, недостаточная эрекция выявлена у 19 %, а на слишком быстрое наступление эякуляции и оргазма указали 29 % обследованных. В свою очередь 34 % женщин сообщили об отсутствии у них интереса к сексу, у 19 % отмечалось недостаточное увлажнение влагалища при половой близости, почти 25 % женщин указали на неспособность достигать оргазма с партнером, 15 % женщин беспокои-

ли болевые ощущения при коитусе (E. Laumann, J. Garnon, R. Michel, S. Michaels, 1994).

Имеются данные, что только нарушениями эрекции страдают более 10 млн мужчин в США, от 3 до 5 млн мужчин в Германии и около 6 млн мужчин в России. Преждевременная эякуляция наблюдается почти у 10 % молодых людей. Различными формами сексуальных дисфункций (постоянно либо периодически) страдает, по некоторым оценкам, от 15 до 40 % мужчин. Половая холодность и проблемы с оргазмом встречаются примерно у 11- 30 % женщин. В ходе выполнения программы изучения старения мужчин в Штате Массачусетс (MMAS) 1709 мужчин в возрасте от 40 до 70 лет были подвергнуты мультидисциплинарному анкетированию. Из общего количества опрошенных 1290 человек полностью ответили на все вопросы, касающиеся их половой жизни. Были получены следующие данные о распространенности эректилъных дисфункций в среднем и пожилом возрасте: минимальные нарушения эрекции - 17 %; умеренные нарушения - 25 % и полная импотенция - 10 %. (H. Feldman, D. Holdstein, 1994).

Типичным фактом клинической практики является наличие у пациентов нескольких сексологических жалоб одновременно, причем половые дисфункции у них чаще всего обусловлены сложным переплетением различных этиопатогенетических факторов. Целостный подход к изучению многоуровневого обеспечения сексуальной сферы и выявлению ее патологии предлагает системная концепция о стадиях и составляющих копулятивного цикла (Г.С. Васильченко, 1977, 1990). На ее основе Г.С. Васильченко разработал метод структурного анализа половых расстройств. Структурный анализ позволяет выявить патологию каждой из составляющих копулятивного цикла, оценить характер имеющихся нарушений (сексопатологических синдромов) и определить соотношения между ними, т. е. реальный вклад каждого из выявленных синдромов в имеющееся у пациента половое расстройство (Г.С. Васильченко, 1983). Это позволяет дифференцированно подойти к лечению и сосредоточить основные терапевтические усилия на коррекции стержневой патологии, т. е. нарушениях, имеющих наибольшее значение в формировании сексуальной дисфункции. Системный, междисциплинарный подход, которого

придерживается большинство профессионально ориентированных специалистов-сексологов, и структурный анализ половых расстройств являются методологической основой для проведения клинических исследований в области сексопатологии.

С позиций структурного анализа диагностическое заключение должно отражать как основные клинические проявления сексуальной дисфункции, так и уровни поражения функциональных систем (указываются в порядке их значимости все нозологические формы либо клинические синдромы). Дополнительно могут быть отмечены параметры половой конституции пациента, его характерологические особенности, нюансы межличностных и интимных отношений с актуальным партнером и т. п. Такое диагностическое заключение достаточно полно отражает клинические и патогенетические особенности сексуального расстройства у конкретного пациента, что позволяет выработать адекватную для него терапевтическую стратегию.

В настоящее время в России и Белоруссии осуществлен переход на психиатрическую систематику в 10-м пересмотре МКБ, которая содержит диагностические рубрики для сексуальных расстройств.

Принципы выделения основных диагностических категорий половых расстройств в МКБ-10 существенно отличаются от таковых при системно-синдромологическом подходе. Их квалификация строится преимущественно на феноменологических признаках и меньше учитывает этиопатогенетические факторы. Классификация сексуальных дисфункций психогенной этиологии, изложенная в рубриках F52.0 - F52.9, опирается на представления о связи половых расстройств с определенной фазой цикла сексуальных реакций человека. Выделяют 4 такие фазы, следующих друг за другом: 1) влечение (желание); 2) возбуждение; 3) оргазм; 4) разрешение, каждой из которых соответствуют определенные половые дисфункции (H. S. Kaplan, B. J. Sadock, 1994; G. Kelly, 2000). С точки зрения разработчиков МКБ-10 может оказаться возможным выявить несомненную психогенную или органическую этиологию сексуальных дисфункций. Но чаще, определение относительного значения психологических и/или органических факторов затруднено. Поэтому рекомендуется тракто-

вать такие состояния, как смешанной или неопределенной этиологии.

Б.Л. Винокуров (1991) считает, что фактически все сексуальные дисфункции, описанные в разделе Р52, относятся к нарушениям психической составляющей по Г.С. Васильченко, а их главным методом лечения является психотерапия. Отмечается, что в отличие от патогенетической классификации Г.С. Васильченко, опирающейся на мультидисциплинарную концепцию сексопатологии, МКБ-10 содержит попытку изолированного рассмотрения психосексуальных расстройств, причем особый акцент сделан на их неорганическом генезе. С позиций современной сексологии такая попытка вряд ли может считаться обоснованной, хотя она неизбежна в свете желания сохранить сексуальную патологию в главе, посвященной психическим расстройствам. Поэтому можно считать с некоторыми оговорками, что МКБ-10 охватывает лишь часть сексуальных расстройств, а именно те из них, которые в отечественной сексопатологии отнесены к расстройствам

психической составляющей. Основным требованием, содержащимся практически в каждом таксоне, является обязательное исключение органической природы указанных расстройств. Однако нередко это составляет трудновыполнимую задачу, поскольку практически все указанные расстройства носят системный характер, когда психогенные факторы теснейшим образом переплетаются с органическими, что и учитывает патогенетическая классификация (А.А. Ткаченко, Г.Е. Введенский, Н.В. Дворянчиков, 1998). В классификации этих расстройств упоминаются все чаще состояния смешанного или органического генеза. Так, уже в DSM III R произошли терминологические изменения, психосексуальные дис-функции стали называть просто сексуальными, что объяснялось возможностью сложного их генеза - психогенного и биологического одновременно. Еще более радикальное изменение подходов было воплощено в DSM- IV, где были добавлены новые единицы систематики - вторичные сексуальные дисфункции, вызванные как употреблением алкоголя, наркотиков и других токсических веществ, так и «непсихиатрическими медицинскими состояниями», то есть различными соматическими заболеваниями. Это было следствием решения расширить прежнюю секцию органических психических

расстройств и расположить «вторичные по III оси» расстройства в их собственных феноменологических группах. МКБ-10 не последовала этим изменениям, по-прежнему говоря о «сексуальной дисфункции, не связанной с органическими расстройствами или болезнями...». Так или иначе терминологические изменения, за которыми стоят попытки концептуального обновления, происходят с введением каждой следующей классификации (А.А. Ткаченко, 1999). Итак, разделение половых расстройств на органические и неорганические (психогенные) в достаточной степени условно и, учитывая тесное переплетение конституционально-преморбидных (биологических) предпосы-лок, возможных сомато-неврологических нарушений, негативных психологических факторов и невротических механизмов, принимающих участие в развитии сексуальных дисфункций у

мужчин, в большинстве случаев может быть проведено только по выявляемой на момент обследования стержневой (ведущей) патологии систем, обеспечивающих копулятивный цикл. В такой ситуации выделение в МКБ-10 смешанных сексуальных дисфункций вполне оправдано, однако в силу своей полисиндромности и полиэтиологичности к ним может быть отнесена весьма значительная часть нарушений половой сферы. Причем подобный диагноз не дает четкого представления о структуре сексуального расстройства и его патогенетических механизмах. Поэтому при использовании МКБ-10 представляется целесообразным рассматривать половые дисфункции, в развитии которых психогенные факторы имеют преобладающее значение, в рамках диагностических рубрик F52.0 - F52.9, а расстройства преимущественно органического генеза - в соответствующих разделах классификации. Так, васкулогенные эрекционные дисфункции относятся к рубрике N48.4 (импотенция органического происхождения). Для идентификации причины расстройства эрекции может использоваться дополнительный код, как это рекомендует МКБ-10. Например, в случаях атеросклеротического поражения артерий, кровоснабжающих гениталии - I 70.8 (атеросклероз других артерий), при патологическом венозном оттоке из кавернозных тел - I 87.8 (другие уточненные поражения вен). Вторичные невротические нарушения, осложняющие сексуальное расстройство васкулогенной

либо другой органической этиологии могут быть отражены в диагнозе дополнительно, причем в этих случаях половая дисфункция фактически имеет смешанную этиологию.

2.4. Принципы классификации сексуальных дисфункций в МКБ-10

Согласно МКБ-10, сексуальные дисфункции включают различные варианты неспособности субъекта участвовать в половой жизни в

соответствии с его желанием, в том числе: отсутствие интереса; отсутствие удовлетворения; отсутствие физиологических реакций, необходимых для полноценного сексуального контакта (например, эрекции); невозможность контролировать или переживать оргазм. Сексуальные дисфункции могут быть перманентными (существующими с начала половой жизни индивида) и приобретенными (после периода нормальной половой жизни), генерализованными (когда проблемы возникают при всех без исключения половых контактах человека) и избирательными или селективными (в определенных условиях, при каких-то формах стимуляции, с конкретным сексуальным партнером). По механизмам развития они подразделяют на органические (связанные с заболеваниями внутренних органов, эндокринных желез, неврологическими нарушениями и патологией кровоснабжения гениталий), психогенные (обусловленные психологическими проблемами и невротическими симптомами) и смешанные (имеется сочетание органических и психогенных факторов) сексуальные дисфункции.

В настоящее время в цикле сексуальных реакций человека обычно рассматривают четыре последовательных фазы. В отличие от модели У. Мастерса и В. Джонсон, дополнительно выделена фаза желания. Это обусловлено тем, что сексуальное влечение функционально связано с возбуждением и оргазмом, но имеет свои нейрофизиологические особенности. В свою очередь, фазы возбуждения и плато, следующие друг за другом, объединены в одну общую - фазу возбуждения. Каждой из четырех фаз присущи свои половые дисфункции (H. I. Kaplan, B. J. Sadock, 1994).

74

1. **Влечение (желание).** Фаза отличается от остальных физиологических фаз и включает психологические аспекты (мотивацию, побуждения, личностные особенности и установки), тесно связанные с сексуальными желаниями человека. Она характеризуется сексуальными фантазиями и жаждой сексуальной деятельности. В половом влечении особая роль принадлежит энергетическому компоненту, связанному с глубинными структурами мозга и деятельностью эндокринных желез. Именно этот компонент обеспечивает пробуждение полового влечения и во многом определяет его наличие и степень выраженности в дальнейшем. Половые дисфункции, связанные с первой фазой: сниженное сексуальное влечение (гиполибидемия), отсутствие или потеря полового влечения,

отсутствие сексуального удовольствия, отвращение к половым контактам (аверсия); повышенное половое влечение (нимфомания, сатириазис).

2. Возбуждение. Фаза состоит из субъективного ощущения сексуального удовольствия и сопутствующих физиологических изменений гениталий и всего организма. Сексуальные дисфункции, связанные со второй фазой: недостаточность или отсутствие генитальной реакции (расстройства сексуального возбуждения у женщин и эректильная дисфункция у мужчин); с некоторыми оговорками - диспареуния и вагинизм. Диспареуния (боль во время полового акта) может нарушать фазу возбуждения и мешать получать удовольствие от сексуального контакта. Вагинизм делает крайне болезненным или невозможным введение полового члена во влагалище, блокируя фазу возбуждения, которая возникает у женщин только при внекоитальной сексуальной активности.

3. Оргазм. Кульминация сексуального удовольствия. Сексуальные дисфункции, связанные с третьей фазой; оргазмическая дисфункция, проявляющаяся у мужчин затрудненной эякуляцией либо ее отсутствием (анэякуляторным синдромом), у женщин - аноргазмией; преждевременная эякуля-ция у мужчин, при которой нередко снижена острота оргастических переживаний; постэякуляторная боль.

4. Разрешение. Происходит общее расслабление, сопровождающееся чувством удовлетворения. Половые дисфункции, связанные с этой фазой, достаточно редки: пост-

коитальная дисфория (после успешного во всех других аспектах коитуса у некоторых лиц снижается настроение, возникают напряжение, тревога, раздражительность, порой агрессия, им хочется побыстрее освободиться от партнера); посткоитальная головная боль (пульсирующая боль в затылочной или лобной области, которая возникает сразу же после коитуса и может продолжаться несколько часов).

Психогенные половые дисфункции (сексуальные неврозы)

К психогенным сексуальным дисфункциям относят функционально-психогенные половые расстройства, возникшие при непосредственном участии психологических механизмов и проявляющиеся в качественных или количественных нарушениях сексуальных функций мужчин и женщин, не связанных с органической патологией.

Психогенные половые дисфункции отличают:

1) ведущая роль в их развитии психотравмирующих воздействий и других негативных психологических факторов; 2) отсутствие очевидной связи с органическими нарушениями или болезнями; 3) обратимый характер тех или иных расстройств половой функции.

Психогенные сексуальные дисфункции являются результатом системного взаимодействия целого ряда неблагоприятных факторов, способных привести к тем или иным нарушениям сексуальных реакций или снижению либидо у мужчин и женщин. К ним относят различные ситуационные факторы, травмирующие переживания, партнерские проблемы и личностные особенности субъекта.

Ситуационные факторы: отсутствие условий для полного уединения, возможность быть застигнутыми врасплох приходом других лиц (при проживании супругов с родителями, а затем со своими детьми, при попытках совершить коитус в купе поезда, салоне автомобиля, «на лоне природы» и т. п.); страх перед нежелательной беременностью; боязнь заразиться венерическим заболеванием; угроза огласки половой связи при внебрачных контактах; слабо выраженное в данный момент желание близости в связи с физической усталостью, психическим переутомлением или предшествующим стрессом; алкогольное опьянение и др.

76

Травмирующие переживания; болезненные воспоминания о предшествующих сексуальных неудачах, включая недовольство партнера половой близостью; тревожные опасения собственной сексуальной неполноценности и страх быть отвергнутым, если не удастся «ублажить» партнера должным образом; страх утраты эрекции или преждевременной эякуляции у мужчин либо беспокойство в связи с возможностью «остаться без оргазма» у женщин.

Партнерские проблемы: нарушения межличностных отношений, частые конфликты, нарастающие негативные эмоции, взаимное недоверие либо охлаждение партнеров; неадекватное поведение сексуального партнера, который ведет себя агрессивно, насмешливо либо демонстрирует свою

холодность и нежелание близости; различия в сексуальных предпочтениях и дисгармоничное сексуальное взаимодействие партнеров.

Личностные особенности: тревожно-мнительные черты характера; сниженная самооценка, склонность к сознательному самоконтролю во время полового акта; недостижимая в реальности установка на максимальное удовлетворение от каждого сексуального контакта; ошибочные убеждения в отношении половой жизни (в связи с неправильным воспитанием или собственным негативным опытом интимных контактов); неосознанные враждебность к противоположному полу и чувство вины в связи *с* сексуальным удовольствием, а также глубинный страх близости и любовных отношений.

Как правило, в развитии функционально-психогенных нарушений сферы у лиц обоего пола играют роль сразу несколько из вышеуказанных причин. Так, например, наиболее частой формой невротических расстройств, приводящей к сексуальным дисфункциям, в первую очередь нарушениям эрекции, является синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Данный невротический синдром формируется у мужчины после одной или нескольких ситуационно обусловленных неудачных попыток совершить половой акт. Этому часто способствуют мнительность, нерешительность, склонность к всевозможным опасениям, а также другие личностные особенности, предрасполагающие к возникновению тревожных сомнений в своих силах и опасений вновь потерпеть фиаско. Имеют значение и

77

партнерские проблемы, которые сами по себе увеличивают как вероятность неудачи, так и ее негативные последствия. Нередко женщины в насмешливо-иронической форме выражают свое отрицательное отношение к сексуальным затруднениям партнера. Поэтому неудивительно, что каждая последующая близость начинает вызывать у мужчины сильное беспокойство, которое за счет выброса в кровь адреналина, обладающего сосудосуживающим эффектом, препятствует возрастанию генитального кровотока до уровня, необходимого для возникновения устойчивой эрекции. Если же происходят новые срывы - они все больше и больше фиксируют внимание мужчины на своей потенции, усиливая сознательный контроль за ходом интимных контактов и усугубляя ситуацию. Половые сношения утрачивают присущую

им чувственность и спонтанность, превращаясь для мужчины в своеобразный экзамен на предмет сексуальной состоятельности. Это влечет за собой очередные неудачи, которые только подтверждают обоснованность навязчивых страхов сексуального фиаско, замыкая «порочный круг» и приводя к возникновению психогенной эректильной дисфункции. Иногда возникает столь сильный страх перед половой близостью, что мужчина, без какой либо грубой органической патологии сексуальной сферы, может длительное время избегать любых интимных контактов. Наличие синдрома тревожного ожидания неудачи, или коитофобии, предполагает их обязательную нейтрализацию психотерапевтическими методами, поскольку без этого трудно рассчитывать на устойчивое восстановление нормальных генитальных реакций мужчины.

Невротические механизмы тревожного ожидания сексуальной неудачи можно обнаружить и у женщин при аноргазмии, диспареунии, аверсии сексуальной, вагинизме. Здесь меняется характер неудачи (отсутствие оргазма, боли при сношении или др.), но практически всегда присутствует ожидание от близости негативных последствий, иногда настолько выраженных, что это вызывает страх и попытки любыми способами избежать полового акта. При аноргазмии, например, присутствует усиление сознательного контроля за коитусом, которое часто сочетается с попытками произвольно ускорить приближение оргастической разрядки. В одних случаях это может быть обусловлено тре-

вожными опасениями полностью потерять контроль над собой и выглядеть нелепо в момент оргазма; в других - подсознательно присутствует чувство вины и стыда за наслаждение от секса; в-третьих - страх перед возможной беременностью и т. п. Вместе с тем одновременно существует желание испытать оргазм, приложив к этому максимум усилий. Однако любые сознательные вмешательства лишь тормозят непроизвольный оргастический рефлекс, и раз за разом подтверждая наихудшие прогнозы женщины, приводят к формированию тревожного ожидания очередного разочарования от интимной близости. В ряде случаев этому может способствовать сексуальный партнер. Многие мужчины склонны рассматривать женский оргазм как личную победу и свидетельство своей сексуальной изощренности. Порой они

начинают упрекать партнершу в отсутствии оргазма, что заставляет ее беспокоиться перед началом коитуса и толкает на неэффективные сознательные манипуляции, лишь отдаляющие наступление оргазма и усиливающие тревогу и навязчивые мысли по поводу его отсутствия.

Следует отметить, что самые различные половые расстройства могут иметь невротическую природу. К числу психогенных сексуальных дисфункций принадлежит значительная часть случаев снижения полового влечения, аноргазмии, вагинизма, нарушений эрекции, преждевременной эякуляции, отвращения к коитусу и отсутствия удовлетворения от него, диспареунии. Их лечение, как правило, носит сочетанный (комплексный) характер, причем в системе коррекционных мероприятий ведущая роль принадлежит методам психотерапии. К рубрике F52 МКБ-10 относятся все сексуальные расстройства (дисфункции), не обусловленные органическими нарушениями или болезнями, т. е. преимущественно психогенной этиологии.

2.5. Механизмы психологической адаптации к сексуальным дисфункции

Выделяют пять типов защитных механизмов, которые активизируются при психологической переработке проблем в сексуальных отношениях (Ф.В. Василюк, 1984):

79

1. *Энергетический тип* - отнятие энергии от «болезненного объекта»:
а) снижение сексуальных побуждений - угнетение либидо;
б) разрядка энергии - отреагирование;
в) перевод энергии - например, трансформация чувства вины в агрессию, которая выражается, например, в гиперсексуальности при супружеской измене;
г) придание энергии - введение нового мотива, например, внебрачная сексуальная активность жены, как акт мести мужу за дисгармоничные интимные отношения.

2. *Пространственный тип* - изменение содержательного или формально-тонического пространства объекта, вызвавшего психичес-кий дискомфорт:
а) перевод личностного конфликта с партнершей в психосоматическое нарушение (преждевременная эякуляция и т. п.);
б) вытеснение из сознания неприемлемых для личности побуждений или сексуальных эталонов;
в) расширение или ограничение круга партнеров в связи с сексуальным расстройством;
г) закрытие своего внутреннего мира от партнера;
д) вынесение внутреннего конфликта вовне и объяснение его внешними причинами.
3. *Временной тип* - сдвиг во времени как самой проблемы, так и возможного способа ее разрешения:
а) перенос длительного «немого» конфликта с сексуальным партнером в ближайшее время - «раньше все было хорошо, и вот только теперь стало плохо»;
б) отодвигание на будущее возможного полового акта; многократные обещания в ближайшее время обратиться за профессиональной помощью; иллюзорная надежда, что вскоре все проблемы разрешатся сами собой.
4. *Генетический тип* - самостоятельные поиски причин, которые привели к сексуальному расстройству, и попытки их устранения:

а) использование ложных объяснений происхождения половых дисфункций, поддерживающих иллюзию интеллектуального контроля;
б) попытки устранить дисфункцию, исходя из собственных представлений.
5. *Познавательный тип* - уход от адекватной оценки неприятного явления или искажение его смысла:
а) рационализация - обоснование адекватности снижения либидо мужчиной, занятым интенсивным интеллектуальным трудом;

б) изменение личностного смысла расстройства - например, обесценивание женщиной, страдающей аноргазмией, значения оргазма для личной и семейной жизни.

Как указывают В.В. Кришталь и Б.Л. Гульман (1997), психологическая адаптация к сексуальным дисфункциям может достигаться за счет компенсации, псевдокомпенсации и гиперкомпенсации.

При *компенсации* сохранность сексуальных функций на достаточном уровне поддерживается включением дополнительных психических функций. Например, при недостаточной яркости оргастических переживаний у одного из супругов им привлекается воображаемый образ другого партнера, чем достигается полноценный оргазм. При этом действуют адаптивные механизмы фантазии, идеальной идентификации с воображаемым партнером, перцептуальной защиты от актуального партнера, подавление легких аверсионных тенденций к нему, диссоциация личностных и физиологических особенностей партнера, частичная деперсонализация партнера (как отказ ему в полной эротической привлекательности), эгоцентризм с ориентацией на достижение только индивидуального наслаждения и система рационализации собственного поведения.

Многокомпонентное обеспечение сексуальной сферы предопределяет возможность использования самых разнообразных путей для компенсации. Так например, недостаточность эрекции у мужчины может компенсироваться не только путем адекватной техники полового акта, но и за счет личностной идентификации с супругой, интроекции ее внутреннего мира, смещения ценности сексуальных отношений с сугубо физиологического на интимно-лич-ностный

план. Могут участвовать и такие психологические механизмы, как позитивный перенос, идеализация отношений, вызывание симпатии к себе и переопределения сложившейся ситуации, использование эвфемизмов, смягчающих остроту проблемы.

Псевдокомпенсация помогает лишь сохранить отдельные компоненты сексуальной функции или имитировать ее. Для псевдокомпенсации характерно использование защитной маски «сильного в половом отношении мужчины», что прявляется в активном флирте «на людях» или хвастовстве мнимыми многочисленными сексуальными связями. Используется и

механизм образования контрастных реакций по типу уверенного, властного в обращении с женщинами мужчины с одновременной их дискредитацией как аморальных существ, а также демонстрация женоненавистничества и социально отклоняющегося поведения, что позволяет под благовидным предлогом выйти из игры. Псевдокомпенсация всегда малопродуктивна и требует коррекции, поскольку «консервирует» или даже усугубляет имеющиеся сексуальные проблемы.

Гиперкомпенсация заключается в форсировании естественного ритма половой жизни. При этом применяются защитная идентификация с существующими на уровне обыденного сознания сексуальными образцами: владение особо изощренными техниками секса, идеализация своих сексуальных качеств, эгоизм, отрицание реакции партнера, трансформация собственных эмоциональных реакций - например, страха в агрессию. Гиперкомпенсация может выполнять разные адаптивные функции: от искупительной до аутореабилитационной, что особенно затрудняет терапию.

В случае, когда личность смиряется с наличием сексуальной дисфункции, наступает *психическое приспособление (привыкание)* - последний этап психической адаптации, который обеспечивает минимальную сохранность сексуальной функции или состояние личностного равновесия. Привыкание характерно для выраженных сексуальных расстройств, сменяя другие, неудавшиеся виды психологической защиты. Проявляется в обесценивании, а иногда и активной дискредитации половой жизни с подчеркиванием своих достижений в других областях. Наблю-

даются также идеализация партнера с одновременной его (ее) позитивной десексуализацией либо принятие на себя роли человека, нуждающегося в опеке, - слабого, неудачника, больного.

Вышеперечисленные адаптивные тактики практически не встречаются в чистом виде, образуя сочетания, в которых преобладает одна из них.

Психологическая защита у больных с сексуальными дисфункциями может проявляться в активно-оборонительной и пассивно-оборонительной форме (В.В. Кришталь, Б.Л. Гульман, 1997).

Активно-оборонительная защита выражается, например, при импотенции в обвинениях супруги в неправильном сексуальном поведении, упреках по поводу утраты ею сексуальной привлекательности, идеализации прежних половых партнерш. Имеют место фантазии мести, вербальная и поведенческая агрессия, которая может переходить в аутоагрессию. Встречается также активный поиск «истинных» причин дисфункции с помощью популярной литературы, эта информация используется для обоснования своей позиции.

Пассивно-оборонительная защита характеризуется избеганием половых отношений под предлогом потребности в отдыхе. Чувство подавленности из-за фрустрированной половой потребности при этом расценивается как усталость. Отрицается физиологическая и эмоциональная важность секса, не замечается недовольство супруга, его признание и самоуважение вызываются деловым или материальным вкладом в отношения, разделением увлечений, дружеской поддержкой. Как правило, подобная форма защиты вызывает нарастающую сексуальную аверсию у партнера.

Достаточно часто сексуальная дисфункция, особенно на первых этапах ее развития, наблюдается лишь в супружеской паре, нормализуясь во внебрачных отношениях. Возможен и обратный вариант, когда в супружестве у мужчины отсутствуют явные нарушения половой функции, но они возникают при попытках вступить во внебрачную сексуальную связь с новой партнершей. Таким образом, сам парный характер сексуальной функции, ее включенность в интимно-личные отношения ставит перед необходимостью

применять системный подход в попытке понять происхождение половых расстройств и наметить наиболее адекватные пути их коррекции.

2.6. Обследование пациентов с сексуальными расстройствами

Обследование пациентов с сексуальными расстройствами осуществляется в амбулаторных условиях, лишь отдельные методы объективного обследования пациентов сексологического профиля проводят стационарно, например фаллоартериографию. Стандартное сексологическое обследование предусматривает обязательную оценку психического статуса (в частности, выявление психопатологической симптоматики), состояния мочеполовой системы у мужчин или гинекологический статус у женщин; неврологическое и эндокринное обеспечение, а также состояние генитального кровотока у мужчин. Используется карта сексологического обследования по Г.С. Васильченко (1977), куда врач заносит жалобы больного, анамнез полового расстройства, динамику основных проявлений сексуальности, особенности интимных отношений с актуальным сексуальным партнером, объективные данные: сексологическая антропометрия (трохантерный индекс, характер оволосения лобка, определение длины и окружности полового члена, состояния молочных желез и др.), психический, неврологический, гинекологический/урологический статусы. Имеются мужской и женский варианты стандартной карты сексологического обследования, каждый из которых содержит анкету-приложе-ние с соответствующими вопросами для уточнения сексуального анамнеза и анамнеза жизни пациента. По возможности врач проводит беседу с постоян-ным партнером для объективизации полученных сведений. В ходе обследования используются методы диагностики из различных областей медицины (психиатрии, невропатологии, урологии, гинекологии и др.). Для экспресс-оценки состояния половой сферы все впервые обратившиеся за сексологичес-кой помощью пациенты предварительно заполняют опросник «Сексуальная формула мужская» (СФМ) или

«Сексуальная формула женская» (СФЖ), что позволяет врачу ознакомиться с ними уже в начале приема. Далее выясняются жалобы пациента, проводится сбор анамнеза и осуществляются соответствующие диагностические процедуры с целью всесторонней объективной оценки состояния его половой сферы.

Особое внимание уделяется *сбору сексологическою анамнеза,* т. е. получению сведений о жизни пациента и особенностях возникновения у него сексуальной дисфункции. С этой целью врач опрашивает пациента, а также получает необходимую информацию из других источников (половой партнер, родственники, друзья). В отличие от общемедицинского анамнеза, состоящего из анамнеза жизни и анамнеза заболевания, подобное разделение в сексологии носит относительный характер. Это связано с тем, что проявления полового расстройства часто тесно переплетаются с теми или иными жизненными событиями, накладывают отпечаток на судьбу пациента, его психическое состояние и взаимоотношения с партнером. Сексологический анамнез наряду с выяснением традиционных аспектов (наследственность, условия жизни, вредные привычки, профессиональные вредности, перенесенные заболевания) предполагает получение сведений о родительской семье, особенностях общения со сверстниками, успеваемости в школе, интересах и предпочтениях подросткового периода, характерологических особенностях, изменениях социального статуса, стрессовых ситуациях и т. д. Обязательным является изучение условий, при которых у пациента впервые возникла мысль о наличии полового расстройства и его личностной реакции на этот факт, предпринятых действий, включая все случаи обращения за медицинской помощью и эффективность предыдущего лечения. Врач должен установить, в чем конкретно усматривает пациент проявления сексуального расстройства, в каких случаях возникают или усиливаются его симптомы, каковы особенности течения заболевания. Сексологический анамнез включает получение сведений о возрасте пробуждения полового влечения и особенностях его проявлений, о сроках первой эякуляции у мужчин или менархе у женщин, мастурбаторной практике, использовании петтинга, о возрасте и субъективном переживании обстоятельств первого полового акта. Выясняются количество и успешность добрачных половых связей, возраст и

мотивы вступления в брак, характер супружеских отношений, наличие внебрачных половых связей, половая активность в разные периоды жизни, особенности проведения полового акта у данной пары (условия, диапазон

приемлемости, нюансы предварительных и заключительных ласк, предпочитаемые позиции коитуса и его продолжительность, уровень оргастичности у женщин, используемые методы контрацепции). Также необходимо выяснить другие сексуальные проявления: наличие и частоту поллюций у мужчин, эротических сновидений у женщин, периодов полового воздержания и их субъективную переносимость, особенности спонтанных (самопроизвольных) и адекватных эрекций, содержание эротических фантазий и сновидений. Важное место в сексологическом анамнезе занимает оценка личностных и сексуальных особенностей постоянного партнера, степени его осведомленности об интимных переживаниях пациента, реакции на половое расстройство и готовности принять участие в его лечении. Получаемые при сборе анамнеза данные заносятся врачом в специальную карту сексологического обследования и учитываются при постановке диагноза и проведении терапевтических мероприятий.

Кратко рассмотрим основные составляющие сексологического обследования.

Сексологическая антропометрия позволяет получить ряд объективных показателей (трохантерный индекс, тип оволосения лобка, размеры полового члена и яичек у мужчин, диаметр ареола соска у женщин и т. д.), которые имеют значение для оценки половой конституции индивида, характеризуют темпы полового созревания и косвенно отражают функцию половых желез.

Изучение психического состояния больных занимает важнейшее место в сексологическом обследовании. Это связано с исключительной ролью психики как в формировании полового поведения человека, так и в регуляции его сексуальных реакций на всех этапах интимной близости. Значительное число сексологических пациентов обнаруживает те или иные психопатологические расстройства, которые в одних случаях являются непосредственной причиной нарушений половой функции, а в других возникают вторично и существенно осложняют их течение. Для боль-

шинства людей сексуальные дисфункции - источник мучительных переживаний и тревожных опасений из-за возможного ухудшения отношений с половым партнером и угрозы стабильности брака. Утрата

душевного равновесия отрицательно сказывается на общем состоянии человека, часто способствуя усилению симптомов половой дисфункции.

Важную информацию об особенностях личности и психического состояния больного, половой идентификации и психосексуальной ориентации, его отношения к имеющимся сексуальным проблемам, характере партнерского / супружеского взаимодействия может дать психологическое обследование. Для психодиагностики в сексологии чаще всего используются многопрофильный личностный опросник MMPI, 16-факторный опросник Р. Кеттела, репертуарные решетки Г.А. Келли, тест цветовых выборов М. Люшера, многоаспектный квантификационный тест Т. Лири, опросник супружеской удовлетворенности А. Лазаруса, опросник Шмишека, тест Маховера (рисунок человека), рисунок семьи, семантический дифференциал, проективные методики и др.

Оценка неврологического статуса необходима для определения возможной роли в нарушениях половой функции заболеваний, травм и опухолей головного или спинного мозга, а также нарушений проводимости периферических нервных путей, идущих непосредственно к гениталиям. Большее значение имеет для мужчин, поскольку некоторые эректильные дисфункции и расстройства эякуляции связаны с патологическими процессами в нервных структурах, обеспечивающих половую функцию. У женщин неврологическое обследование обычно ограничивается определением чувствительности половых органов и исследованием некоторых рефлексов. При подозрении на патологию глубинных структур мозга их биоэлектрическая активность определяется с помощью электроэнцефалографического исследования. Для исключения органической патологии головного или спинного мозга может потребоваться проведение компьютерной томографии. Основное внимание при рутинном неврологическом обследовании мужчин уделяется области промежности и нижних конечностей. Врач с помощью легких

прикосновении и покалывания иглой оценивает кожную чувствительность, затем неврологическим молоточком исследует сухожильно-надкост-ничные рефлексы и, наконец, рефлексы, вызываемые из области гениталий (мошоночный, анальный, бульбокавернозный). Дополнительно изучаются

нейровегетативные симптомы (дермографизм, реакция зрачков на свет и т. п.). При подозрении на ухудшение нервной проводимости по срамным нервам рекомендуется исследовать вибрационную чувствительность полового члена при помощи биотензиометра; в неясных случаях прибегают к электромиографии мышц промежности, регистрации потенциалов головного мозга на фоне раздражения половых органов. Следует отметить, что неврологические нарушения достаточно редко приводят больных на сексологический прием. Поэтому тщательное неврологическое обследование в основном необходимо мужчинам с жалобами на сексуальные расстройства после перенесенных травм головного и особенно спинного мозга, урологических операций (простатзктомия), при серингомиелии, рассеянном склерозе, миелитах, опухолях спинного мозга, дискогенных радикулитах, алкогольных и диабетических нейропатиях, при переломах костей таза, разрывах уретры, т. е. в тех случаях, когда имеется риск повреждения проводящих путей сексуальных рефлексов.

Исследование урогенитального аппарата проводится у мужчин. При осмотре полового члена выявляют пороки его развития, наличие фимоза, воспаления крайней плоти или головки, выделений из мочеиспускательного канала. Оценивают состояние мошонки, яичек и их придатков, семенных канатиков. Исследование предстательной железы проводят методом ее пальпации через задний проход в коленно-локтевом или лежачем положении обследуемого. Пальцевое исследование простаты заканчивают ее массажем для получения простатического сока. Секрет предстательной железы изучается микроскопически. Целью урологического обследования сексологических пациентов является исключение аномалий развития половых органов, некоторых заболеваний, например болезни Пейрони, воспалительных процессов в простате и уретре, которые могут вести к развитию сексуальных дисфункций.

88

У женщин необходимо оценить *гинекологический статус*. Врач определяет правильность развития наружных половых органов, степень развитости клитора, наличие грубых рубцов после разрыва в родах.

Измеряют расстояние от клитора до наружного отверстия уретры. Некоторые специалисты считают, что если при клиторальном типе оргазма это расстояние превышает 2,5 см, достижение во время полового акта оргазма без дополнительной стимуляции клитора невозможно. Затем исследуют состояние мышц промежности, влагалища, матки и придатков. Таким образом, можно выявить врожденные аномалии развития женских половых органов, деформации и рубцовые изменения генитальных эрогенных зон, которые могут способствовать возникновению сексуальных дисфункций. Определяется чувствительность наружных половых органов и индивидуальное расположение эрогенных зон женщины. При этом целесообразно использовать аппарат для вибромассажа. Обстановка врачебного обследования обычно тормозит специфические сексуальные реакции в момент стимуляции эрогенных зон, однако известно, что участки тела с высокой тактильной чувствительностью, которые сильнее всего реагируют на вибрационное воздействие, обладают и наибольшей эротической чувствительностью. Результаты обследования позволяют сексологу определить влияние состояния половых органов женщины на ее сексуальные проявления, назначить адекватное лечение и дать женщине и ее партнеру конкретные рекомендации о целесообразности тех или иных предварительных ласк и предпочтительных позициях полового акта.

Эндокринологические исследования проводят у пациентов при подозрении на связь сексуальной дисфункции с эндокринными нарушениями. У мужчин наблюдаются снижение полового влечения и ослабление эрекций при гипогонадизме, повышенном содержании в крови гормона гипофиза пролактина, женских половых гормонов, нарушениях функции щитовидной железы и некоторых других расстройствах эндокринной системы. Косвенно о насыщенности организма андрогенами можно судить по выраженности у мужчины вторичных половых признаков: распределению волос на теле и лице, развитию мускулатуры, по местам отложения жировой клетчатки, размерам и

89

плотности предстательной железы и яичек. Информацию о гормональной функции мужских половых желез можно получить путем лабораторного

анализа сока предстательной железы и эякулята. В необходимых случаях исследуют содержание гормонов в крови и моче пациента. Обычно в плазме крови определяют содержание тестостерона, гормонов гипофиза (пролактина, фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов), а в моче - эстрогенов и кетостероидов. При обследовании женщин с фригидностью или гиперсексуальностью желательно определить гормональную функцию яичников. С этой целью применяют метод гистологического исследования влагалищных мазков. К другим методам функциональной диагностики относят лабораторное исследование слизи, полученной из шейки матки, и температурный тест, основанный на ежедневном измерении температуры в прямой кишке в течении 1-3 менструальных циклов. Полученные данные позволяют судить о степени насыщенности эстрогенами и прогестинами в разные фазы менструального цикла. Для более точного исследования состояния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы женщины определяют уровни эстрогенов, кетостероидов и гонадотропинов в моче, а также проводят различные гормональные пробы. Диагностика гормональных отклонений дает ценную информацию для комплексной оценки сексуальной сферы женщины. Например, длительно текущий воспалительные заболевания гениталий нередко сопровождаются снижением гормональной функции яичников, что в свою очередь может привести к ослаблению полового влечения, притуплению ощущений во время фрикций, снижению интенсивности, урежению, а затем и полному исчезновению оргазма.

В сексологическое обследование мужчин входит *оценка кровотока в половом члене*. По современным данным, у пациентов старше 45 лет нарушения кровоснабжения гениталий являются одной из наиболее распространенных причин нарушений эрекции. Наиболее часто их вызывают патологические изменения в артериях, питающих кавернозные тела (обусловлены атеросклерозом, травматическими повреждениями, врожденными аномалиями). Нарушения венозного оттока из кавернозных тел (венозные утечки) встречаются реже. Объективное исследование сосудисто-

го русла полового члена врач начинает с изучения пульса на симметричных тыльных и глубоких пенильных артериях. Определенную информацию дает вычисление пено-брахиального индекса, то есть отношения систолического давления в артериях полового члена к таковому в плечевых артериях. Наиболее эффективный и доступный метод диагностики - ультразвуковая допплерография сосудов пениса. Достоверность результатов исследования значительно возрастает при проведении ультразвукового зондирования сосудов на фоне искусственной активизации кровотока (например, путем введения в одно из кавернозных тел раствора алпрстадила). В диагностически сложных случаях иногда проводят рент ген о контрастные исследования сосудистого русла полового члена (фаллоартериографию, динамическую инфузионную кавернозографию).

Объем сексологического обследования может несколько расширяться или сужаться в зависимости от характера полового расстройства, но в любом случае предполагает определенный минимум исследований для объективной оценки функционального состояния каждой из систем организма, обеспечивающих сексуальную сферу. Все данные, полученные в ходе обследования, заносятся в стандартную карту сексологического обследования. Проанализировав их, врач делает диагностическое заключение и назначает соответствующее лечение.

2.7. Современные подходы к лечению сексуальных дисфункций

Терапия сексуальных дисфункций направлена на нормализацию параметров сексуального функционирования; ликвидацию психопатологической симптоматики; восстановление и/или улучшение партнерских отношений; достижение пациентами приемлемого уровня психологического комфорта и удовлетворяющей их половой активности.

Лечение начинается с сексуальной ресоциализации, т. е. создания необходимых предпосылок для успешного лечения. К таковым относятся: расширение круга общения и возможностей для знакомства и сближения с лицом проти-

воположного пола (при отсутствии сексуального партнера); смягчение супружеских конфликтов до уровня, позволяющего начать восстановительное лечение; вовлечение партнера в лечебный процесс (как минимум его непротиводействие половой активности пациента, в оптимальном варианте - заинтересованное участие в сексуальных контактах); устранение «технических» помех (объединение супружеских постелей, подбор адекватной контрацепции, создание атмосферы уединения и интимности в спальне и т. п.).

Лечение большинства сексуальных дисфункций является комплексным и предполагает сочетанное применение фармакотерапии, психотерапии, физиотерапии, а в некоторых случаях механотерапии (эректоров и вакуумных приспособлений для достижения эрекции) или хирургических вмешательств (например, у больных с грубыми эректильными дисфункциями при неэффективности иных лечебных мероприятий может применяться фадлопроте-зирование).

Фармакотерапия половых дисфункций проводится с учетом этиопатогенеза расстройства и особенностей его течения. Ниже представлена, разработанная нами, рабочая классификация основных групп лекарственных средств, которые применяются в терапии сексуальных дисфункций различного генеза.

1. *Адаптогены и сходные с ними стимулирующие вещества:*

а) *растительного происхождения и продукты пчеловодства:* препараты из женьшеня, аралии манчжурской, левзеи, родиоды розовой, заманихи, элеутерококка, лимонника китайского, цветочной пыльцы, апилак, тентекс-форте, верона;

б) *животного происхождения:* пантокрин, цыгапан, касолин;

в) *комбинированные (животно-растительные):* наньбао, тестис-композитум.

2. *Витамины и поливитаминные комплексы, содержащие макро- и микроэлементы и биоактивные Вещества:* токоферола ацетат, тиамина хлорид, аевит, юникап-Т, супрадин.

3. *Половые гормоны и средства влияющие на гормональное обеспечение половой сферы:*

а) *андрогены и их синтетические аналоги:* тестостерона пропионат, метилтестостерон, тестостерона андекаонат (андриол), местеролон (провирон), тетрастерон (сустанон-250); тестостерона ундекаонат (небидо);
б) *анаболические стероиды:* метандростенолон, нандролона деканоат (ретаболил);
в) *гонадотропины:* хорионический гонадотропин (прегнил, профази);
г) *ингибиторы пролактина;* бромкриптин (парлодел), каберголин (достинекс);
д) *антиандрогены:* ципротерона ацетат (андрокур);
е) *антиэстрогены:* тамоксифена цитрат, кломифенцитрат (клостильбегит);
ж) *эстрогены:* этинилэстрадиол (микрофоллин), эстриол (овестин);
з) *гестагены:* дидрогестерон (дюфастон), линестренол (оргаметрил, эксклютон);
и) *комбинированные гестоген - эстрогённые препараты:* тризистон, фемоден и др.;
к) *комбинированные эстроген - андрогенные препараты:* гинодиан депо.

4. *Вазоактивные препараты:*
а) *общего действия:* пентоксифиллин (трентал), экстракт листьев гингко билоба (танакан), ницерголин (сермион), йохимбин, актовегин;
б) *селективного действия:* папаверина гидрохлорид, алпростадил (каверджект) для интракавернозного введения; ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа для перорального применения: силденафил (виагра), тадалафил (сиалис), варденафил (левитра).
5. *Препараты, стимулирующие центральную и периферическую нервную систему:* стрихнина нитрат, прозерин, дистигмин бромид (убретид).
6. *Метаболиты и ферменты, регулирующие обмен веществ:* милдронат, аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), карнитин, рибоксин, мексидол.
7. *Психотропные препараты:*
а) *транквилизаторы:* тофизопам (грандаксин), алпразолам (ксанакс), мезапам (рудотель), мебикар, фенибут, феназепам, буспирон (буспар);

б) *нейролептики:* тиоридазина гидрохлорид (сонапакс), сульпирид (бетамакс), алимемазин (терален), перициазин (неулептил);
в) *антидепрессанты:* сертрадин (золофт), флувоксамим (феварин); тианептин (коаксил), кломипрамин (анафранид) гиперикум (гелариум), пиразидол;
г) *психостимуляторы:* сиднокарб, сиднафен;
д) *ноотропы:* пиридитол, пикамалон.

8. *Гепатопротекторы:* Лив-52, эссенциале, силибинин (легалон), карсил.
9. *Препараты, действующие в области периферических нервных окончаний:*
а) *местноанестезирующие средства:* аэрозоли и мази на основе лидокаина, тримекаина и т.д.;
б) *местнораздражающие мази:* химколин и т.д.
10. *Препараты, улучшающие функцию простаты:* трианол, простатилен, спеман, спеман форте, простанорм и др.
11. *Вагинальные кремы-любриканты:* услада (безжировая смазка - увлажни-тель с провитамином B_5) и др.

Применяют электролечение (промежностная, ректальная и уретральная электростимуляция с помощью аппаратов «Эндотон-1», «Интратон» и т. п.); воздействие ультразвуком (ультрафонофорез); водолечение (гидромассаж простаты, лечебные микроклизмы); грязелечение в аппликационной и внутриполостной (ректальной, вагинальной) формах; лечебный массаж (пальцевой массаж предстательной железы и семенных пузырьков, пневмомассаж полового члена с помощью локального низкого давления - ЛД-терапия); методы рефлекторного воздействия (хлорэтиловые блокады ромба Михаэлиса по Г. С. Васильченко, акупунктура, аурикулотерапия, традиционный восточный массаж); вибростимуляция эрогенных зон при помощи вибромассажера и др.

Психотерапия играет важную роль в сексологическом лечении. При сексуальных расстройствах, не обусловлен-

ных органическими нарушениями или болезнями (F52), психотерапия может быть единственной формой их коррекции либо использоваться как один из видов комплексного лечения. На сегодняшний день не существует психотерапевтического метода, одинаково эффективно воздействующего на весь спектр психологических проблем сексологических пациентов. Поэтому для коррекции тех или иных сексуальных нарушений в настоящее время чаще всего используются подходы, основанные на систематизированном применении сразу нескольких методов психотерапии в комбинации с иными видами лечения. Например, в России сексологи, широко применяют комбинацию рациональной психотерапии, гипносуггестии, поведенческой секс-терапии, психотерапевтического опосредования лечебных процедур и элементов семейной терапии в сочетании с фармакотерапией и физиотерапией.

При использовании тех или иных методов психотерапевтической коррекции сексуальных расстройств следует учитывать:

1. Оптимальный выбор конкретных форм психотерапии определяется как клиническими проявлениями сексуальной дисфункции, так и их психогенезом, т. е. наличием у пациентов психологических механизмов сексуальной дезадаптации (тревожного ожидания сексуальной неудачи; неадекватных убеждений и установок в отношении половой жизни; глубинных страхов перед проявлениями сексуальности; нарушений межличностных и сексуальных отношений с партнером и др.).
2. В соответствии с вышеуказанным, основными мишенями для психотерапевтического воздействия являются: отдельные симптомы полового расстройства (нарушения эрекции, ускоренная эякуляция, аноргазмия и т. п.); психологические механизмы, участвующие в формировании сексуальных нарушений.
3. Коррекция имеющихся у больных половых расстройств, а также сопутствующих психопатологических нарушений осуществляется при помощи наиболее подходящих по своей терапевтической направленности методов психотерапии и их сочета-

ний, которые в оптимальном варианте должны быть сфокусированы как на сексологической и невротической симптоматике, так и стоящих за ними психологических проблемах пациентов. Конкретные приемы и техники для проведения психотерапии подбираются индивидуально с учетом их терапевтического диапазона и соответствующей подготовки у врача. В частности, методы бихевиоральной терапии эффективно снижают тревогу, являющуюся стержнем психогенных половых дисфункций (систематическая десенсибилизация на фоне мышечной релаксации, тренинг уверенности и т. п.), а также служат для уменьшения супружеских конфликтов и мотивации партнеров к конструктивному взаимодействию («структурированный тренинг общения», «техника позитивных обменов» и др.). Особой разновидностью поведенческой терапии является сексуальная терапия (секс-терапия), которая использует специально разработанные приемы для устранения тех или иных симптомов половых дисфункций (например, техники «сжатие» и «стоп-старт» при ускоренной эякуляции или десенсибилизация с помощью увеличивающихся в размерах расширителей в случаях вагинизма). Для коррекции неадекватных убеждений и логических ошибок в рассуждениях пациентов применяются техники когнитивной психотерапии, основанные на опровержении иррациональных идей.

Гипнотерапия (классический и эриксоновский гипноз), а также техники нейролингвистического программирования (НЛП) эффективны для нейтрализации негативного сексуального опыта, устранение тревожного гиперконтроля за ходом полового акта и обучения ассоциированному восприятию половой близости. Десенсибилизация и переработка движениями глаз (ДПДГ) позволяет пациентам быстро дистанциироваться от психотравмирующих событий прошлого, включая предшествующие сексуальные неудачи, и обеспечить когнитивное переструктурирование информации, отрицательно влияющей на их самооценку и поведение во время интимной близости. Техники семейной и супружеской психотерапии используют в работе супружеской парой для решения следующих задач: прояснение взаимных ожиданий и разногласий, видоизменение характера коммуникаций, сосредоточение супругов на наиболее

значимых проблемах в отношениях и путях их решения, изменение стиля поведения и др.

На завершающем этапе лечения проводится сексуальная реадаптация. Ее целью является оптимизация сексуального взаимодействия с партнером, достижение/восстановление гармонии в интимной жизни и приобретение супружеской парой способности конструктивно разрешать проблемные ситуации в семейно-сексуальных отношениях.

Следует отметить, что проведение мероприятий этапа сексуальной реадаптации возможно лишь при следующих условиях:

1) пациент имеет устойчивые партнерские отношения или состоит в браке;

2) у партнеров/супругов есть обоюдное желание повысить удовлетворенность от совместной половой жизни;

3) партнер согласен участвовать в сексологическом лечении и следовать врачебным рекомендациям относительно его поведения при интимной близости с пациентом.

Сексуальная реадаптация осуществляется после улучшения параметров сексуального функционирования пациента до степени, обеспечивающей возобновление парой регулярных половых контактов. Необходимо уточнить индивидуальные сексуальные предпочтения партнеров с целью совместного планирования и последующей практической реализации оптимальных для них вариантов сексуального взаимодействия. Могут использоваться специальные обучающие видеофильмы. Показана секс-терапия, направленная на повышение физического удовольствия от сексуальных контактов (приемы чувственного фокусирования и др.). На этом этапе также применяют семейную и супружескую психотерапию для обучения партнеров более эффективному межличностному взаимодействию.

Эффективность терапии сексуальных дисфункций достаточно высока. Она может снижаться при отсутствии супруга или постоянного полового партнера либо его явном или скрытом «саботаже» сексологическому лечению, который проявляется уклонением под любыми предлогами от посещения врача-сексолога, а также половой близости с пациентом. Нежелание пациента или его партнера следо-

вать терапевтическим рекомендациям, касающимся частоты половой близости, оптимальной продолжительности эротических ласк и их форм, позиций во время коитуса, также затрудняет восстановление сексуальной функции. Напротив, при наличии чуткого, благожелательно настроенного партнера и обоюдного стремления супругов к более гармоничным интимным отношениям в большинстве случаев возможно не только существенное улучшение сексуальной функции пациента, но и повышение взаимной удовлетворенности половой жизнью в браке.

2.8. Клинические варианты сексуальных дисфункций и их терапия

Психогенные сексуальные дисфункции рассматриваются в МКБ-10 в рубрике F52. Сексуальные расстройства (дисфункции), не обусловленные органическими нарушениями или болезнями. Выделяют следующие их основные варианты:

- отсутствие или потеря полового влечения (F52.0);
- сексуальное отвращение и отсутствие полового удовлетворения (F52.1);
- недостаточность или отсутствие генитальной реакции (F52.2);
- оргазмическая дисфункция (F52.3);
- преждевременная эякуляция (F52.4);
- вагинизм неорганического происхождения (F52.5);
- диспареуния неорганического происхождения (F52.6);
- повышенное половое влечение (F52.7);
- другая сексуальная дисфункция, не обусловленная органическим нарушением или болезнью (F52.8);

сексуальная дисфункция, не обусловленная органическими нарушениями или болезнью, неуточненная (F52.9).

В общих указаниях к рубрике F52. отмечено, что сексуальная реакция представляет собой психосоматический процесс, и в происхождении сексуальных расстройств обычно принимают участие и психологические и соматические факторы. Может оказаться возможным выявить несомненную психогенную или органическую этиологию,

но чаще, особенно при таких проблемах, как отсутствие эрекции или диспареуния, трудно определить относительное значение психологических и/или органических факторов. В таких случаях нарушение следует определять как состояние смешанной или неуточненной этиологии.

Некоторые типы дисфункции (например, отсутствие полового влечения) возникают как у мужчин, так и у женщин. Тем не менее, женщины чаще жалуются на субъективное качество сексуальных переживаний (отсутствие удовлетворения или интереса к половой жизни), а не на отсутствие специфических реакций. Нередки жалобы на оргазмическую дисфункцию, но при расстройстве одного из аспектов женской сексуальной реакции существует вероятность нарушения и остальных. Например, если женщина неспособна к переживанию оргазма, она часто не в состоянии получать удовлетворение от других аспектов физической близости, что способствует значительному снижению ее сексуального влечения. Напротив, мужчины, хотя и жалуются на отсутствие специфических реакций, таких как эрекция или эякуляция, часто сообщают о сохранности полового влечения. Поэтому необходимо тщательно анализировать, что скрывается за предъявляемой жалобой для установления наиболее подходящей диагностической категории.

Определены общие для всех половых дисфункций, не обусловленных органическим расстройством или заболеванием, диагностические критерии, которым должны, помимо специфических, отвечать все частные формы, рассматриваемые в данном разделе.

1. Пациент не в состоянии установить сексуальные отношения так, как он бы этого хотел.
2. Расстройство функции возникает часто, но в некоторых случаях может отсутствовать.
3. Расстройство функции наблюдается в течение по меньшей мере 6 месяцев (на наш взгляд, для постановки сексологического диагноза введение данного критерия малооправдано).
4. Расстройство не соответствует критериям какого-либо психического или органического заболевания.
5. Выделение последнего общего критерия предполагает, что если, например, рекуррентное депрессив-

99

ное расстройство с текущим эпизодом любой тяжести сопровождается снижением полового влечения и ослаблением эрекции (что в данном случае является одним из клинических проявлений депрессии), в диагноз выносится основное, аффективное расстройство. Например: рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод умеренной тяжести с соматическими (сексологическими) симптомами (F32.11).

При рассмотрении каждого из таксонов F52.0-F52.9 вначале приведены клинические описания соответствующих сексуальных дисфункций и их специфические диагностические критерии из МКБ-10, адаптированной для использования в Российской Федерации (1998). Затем следуют наши комментарии, затрагивающие вопросы этиопатогенеза, дифференциального диагноза, клинических особенностей и терапии рассматриваемых половых дисфункций.

F52.0. Отсутствие или потеря полового влечения

Потеря полового влечения является основной проблемой, а не вторичной по отношению к другим сексуальным затруднениям, таким как отсутствие эрекции или диспареуния. Отсутствие полового влечения не исключает сексуального удовлетворения или возбуждения, но делает половую активность менее вероятной.

Диагностические критерии:

1) недостаток или потеря полового влечения выражается в уменьшении сексуальных фантазий, поиска сексуальных стимулов, мыслей о сексуальной стороне жизни, сопровождаемых субъективно приятным эмоциональным оттенком;

2) интерес к осуществлению сексуальной активности с партнерами или к мастурбации без них появляется реже, чем этого можно было ожидать с учетом возраста, ситуации и ранее привычного уровня.

Включаются (относятся к данной рубрике):

- фригидность (алибидемия);
- сниженное сексуальное влечение;
- гипоактивное сексуальное влечение.

Х. Каплан (1987) определяет данное состояние как подавленное сексуальное влечение. У. Мастерс и В. Джонсон (1986) называют его «заторможенное сексуальное желание» (YSD) и выделяют два основных признака потери полового влечения:

1) низкую степень сексуальной активности;

2) отсутствие у субъекта желания проявлять эту активность.

Причем желание включает сексуальные фантазии, проявления внимания к эротическим стимулам и материалам, способность замечать привлекательных потенциальных партнеров, психический и физический дискомфорт (сексуальная абстиненция) при вынужденном отказе от секса.

По данным У. Мастерса и В. Джонсон (1983), отсутствие желания - одна из частых жалоб при обращении супружеских пар, причем это более характерно для женщин (до 35 %), чем для мужчин (до 15 %). Они считают, что отсутствие интереса к половой жизни следует классифицировать как YSD только тогда, когда оно оказывается источником личных проблем или приводит к расстройствам взаимоотношений. Некоторые люди по соображениям субъективного порядка добровольно отказываются от половой жизни, выбирая безбрачие (например, католические священнослужители), что в конечном итоге приводит к полному подавлению у них сексуального влечения. Такой непатологический образ жизни получил название нормальной асексуальности, и в нем нет признаков сексуального расстройства.

Однако достаточно часто сниженное половое влечение может стать серьезной проблемой в супружестве. Так, несоответствие в уровнях сексуального желания у двух партнеров является одной из самых распространенных жалоб, с которыми приходят к сексотерапевтам (J. Beck, 1995).

Х. Каплан (1987) относит к проявлениям отсутствия или потери полового влечения скрытые формы избегания интимных контактов; возникновение негативных представлений, блокирующих сексуальные реакции и переживания; тревогу, связанную с ощущением неполноценности собственных сексуальных действий; отказ от адекватной физической и/или психологической стимуляции во время сексуальных действий; подавление эротических фантазий.

Имеется ряд биологических (органических) нарушений, сопровождающихся снижением или отсутствием полового влечения. У мужчин наиболее часто это связано с гормональной недостаточностью, которая проявляется выраженным снижением уровня тестостерона, а точнее его активного метаболита - 5а-дегидротестостерона в крови.

К причинам андрогенной недостаточности относят первичный (связанный с патологическими изменениями в яичках) и вторичный (обусловленнный патологией гипофиза и гипоталамуса) гипогонадизм; пролактинсекретирующие опухоли гипофиза, которые выявляют более чем у 10 % мужчин с потерей полового влечения, и др.

Гормональная (эстрогенная) недостаточность у женщин при грубой дисфункции яичников или их удалении нередко приводит к выпадению эротического компонента полового влечения (позитивной реакции на эротические стимулы, включая поверхностные ласки), а патология надпочечников, вызывающая снижение уровня андрогенов, может сопровождаться полным отсутствием интереса к половому акту (редуцируется сексуальный компонент либидо). К другим биологическим причинам, часто приводящим к снижению полового влечения у лиц обоего пола, относят токсические влияния (злоупотребление психоактивными веществами, в особенности наркотиками); побочное действие некоторых лекарственных препаратов (например, нейролептиков или ряда транквилизаторов, гипотензивных препаратов, таких как клофелин или резерпин и т. д.); метаболические нарушения при наличии признаков печеночной, почечной либо дыхательной недостаточности; височную эпилепсию.

Психические расстройства, в первую очередь сопровождающиеся депрессивным аффектом, нередко способствуют подавлению полового влечения. По данным У. Мастерс и В. Джонсон (1979), у больных, страдающих депрессией, снижение либидо отмечается в 70 % случаев, а у 33 % наблюдаются различного рода расстройства в течении полового акта.

Основное диагностическое значение для отнесения случаев снижения или потери полового влечения к данной рубрике имеет выявление у пациентов психологических механизмов, тормозящих сексуальное желание, при отсутствии явных биологических причин расстройства.

Отсутствие или потеря сексуального влечения может наблюдаться при целом ряде патологических состояний. К ним относятся шизофрения, височная эпилепсия черепно-мозговые травмы, опухоли, сосудистые заболевания головного мозга, злоупотребление психоактивными веществами (наркотики, алкоголь и др.), депрессивные расстройства. В частности, у больных, страдающих депрессией, снижение либидо отмечается в 70 % случаев. Эндокринные нарушения: у мужчин - первичный (связанный с патологическими изменениями в яичках) и вторичный (обусловленнный патологией гипофиза и гипоталамуса) гипогонадизм, пролактинсекретирующие опухоли гипофиза, кастрация; у женщин - патология надпочечников, яичников, врожденная и приобретенная (например, в климактерическом периоде) гипоталамо-гипофизар-ная недостаточность. Побочное действие ряда лекарственных средств: нейролептиков, транквилизаторов из группы бензодиазепинов, трициклических антидепрессантов, гипотензивных препаратов (клофелин, резерпин и др.). Потеря полового влечения иногда развивается как следствие других сексуальных расстройств. Например, мужчина, длительно страдающий эректильной дисфункцией, на фоне которой у него постепенно угас интерес к сексу, может обнаружить, что прекращение попыток половых контактов помогает ему избежать неприятных последствий сексуальных неудач, тревожных опасений и страхов, новых болезненных ударов по самооценке. В этих случаях алибидемия носит вторичный (невротический) характер и служит своеобразной защитой от душевных потрясений и унижения мужского самолюбия. Аналогичный защитный механизм наблюдается у женщин при длительной сексуальной неудовлетворенности, сопровождающейся аноргазмией. В таких случаях угасание либидо вплоть до алибидемии объясняется отсутствием положительного подкрепления при половых контактах.

Рассматривая психодинамику фригидности, Х. Каплан (1987) отмечает, что у женщины возникает бессознательный конфликт, мешающий ей переживать удовольствие от контакта с мужчиной. Как правило, данная форма расстройства связана не с единичным конфликтом, а проявляется как синдром. К проявлениям этого расстройства относятся страхи или чувство вины, связанные с сексуальными

переживаниями, враждебность по отношению к мужчинам вообще или к конкретному мужчине, страх быть отвергнутой, если она позволит себе «внутренне расслабиться»; беспокойство по поводу «должного» исполнения своих сексуальных действий, чувство стыда по поводу проявлений эротичности и т. д. Специфические механизмы защиты, характерные для фригидных женщин, фактически не позволяют им проявлять свою сексуальную реакцию. Женщины либо избегают получения адекватной стимуляции со стороны мужчины, либо, в том случае, если она не препятствует своему партнеру возбуждать ее, у нее формируется механизм перцептивной защиты, препятствующий получению удовольствия от этого возбуждения. Она, в буквальном смысле, не позволяет себе переживать какие бы то ни было эротические ощущения. Она неосознанно запрещает себе какой бы то ни было сексуальный отклик и не позволяет себе предаваться сексуальным переживаниям.

По мнению К. Штифтера (1999), отсутствие сексуального желания может быть бессознательным выражением проблем в отношениях или внутриличностных напряжений. Есть много бессознательных причин, чтобы при помощи отказа в сексе заставить другого человека в чем-то раскаяться, о чем мы сами часто и не догадываемся. Например, такой причиной может быть разочарование в супруге, что он или она не тот «принц» или «принцесса», какими их считали. Также и партнеры, которые запутались в борьбе за власть, не «хотят» испытывать никакого вожделения к своему «контрагенту». Они не хотят только потому, что этого «хочет » партнер. Еще один мотив - конфликт близости и дистанции. Он существует там, где в отношениях четко не определено, насколько каждый из партнеров может считать допустимой ту степень психической близости и зависимости, не боясь при этом потерять свою автономию, и насколько самостоятельности каждый готов развить до той степени, чтобы у обоих не сложилось впечатление, что они уже больше не пара.

Другие психологические факторы подавления либидо: перенесенная травма сексуального насилия; низкая самооценка, связанная с убежденностью в своей сексуальной непривлекательности (истинной или мнимой); болезненные личностные реакции на критику партнера или расставание с ним; неосознаваемые (вытесненные) гомосексуальные

импульсы, которые тормозят гетеросексуальное влечение; длительное половое воздержание (по любым мотивам); постепенное снижение полового влечения у людей, всецело поглощенных карьерой или бизнесом.

Женщины с отсутствием полового влечения обнаруживают неспособность или низкую способность к сексуальному возбуждению в интимных ситуациях, а если половой акт происходит, то при фрикциях не возникает сладострастных (воллюстических) ощущений из-за низкой чувствительности половых органов и оргазм обычно не достигается. Таким образом, алибидемия в большинстве случаев включает и аноргазмию. Иногда у фригидных женщин могут наступать возбуждение и оргазм вследствие эффективной сексуальной стимуляции, хотя это происходит редко и при отсутствии какой-либо инициативы к близости с их стороны.

Ослабление или утрата полового желания - наиболее обыденный признак распадающейся сексуальной связи. В этих случаях сексуальное «торможение» не носит генерализованного характера и, проявляясь только с определенным половым партнером, может не обнаружить себя в иных интимных ситуациях. Такое избирательное расстройство полового влечения, вызванное недостаточной эротической привлекательностью партнера, равнодушием или отрицательным отношением к нему, является следствием выраженной семейно-сексуальной дисгармонии, поэтому требует уточнения в диагнозе, указывающего на ситуационный (селективный) характер дисфункции.

Обследование пациентов с жалобами на отсутствие полового влечения проводится, как правило, амбулаторно. Включает стандартное сексологическое обследование. При сборе сексологического анамнеза особое внимание следует уделить психосексуальному развитию, наличию отклонений полового влечения (бисексуальное, гомосексуальное и пр.), сексуальному дебюту и последующему опыту интимных контактов, представлениям пациента о сексуальной норме и психофизиологии половой жизни, характеру межличностных и сексуальных взаимоотношений с постоянным сексуальным партнером / супругом либо выяснению причин отсутствия такового.

Дополнительное обследование: использование психодиагностических методов исследования для углубленной

оценки психического состояния и личностных особенностей пациентов; определение 17-КС, эстрогенов в моче; определение ФСГ, ЛГ, пролактина, тестостерона, прогестерона в плазме крови; КТ или МРТ головного мозга; консультация гинеколога для пациентов женского пола или уролога - для лиц мужского пола; консультация эндокринолога; консультация невролога.

Терапия направлена на усиление полового влечения и повышение сексуальной активности. Активизация подавленного полового влечения может осуществляться на биологическом уровне (использование фармакотерапии и физиотерапии) и преимущественно психологическом уровне (психотерапевтическое воздействие).

По показаниям используются следующие группы препаратов:

- антидепрессанты (тианептин, гиперикум, сертралин, флувоксамин);
- транквилизаторы (тофизопам, мезапам, алпразолам, мебикар);
- психостимуляторы (сиднокарб);
- адаптогены (настойки жень-шеня, родиолы розовой, китайского лимонника и т. п.);
- ноотропы (пирацетам, пиридитол);
- средства гормональной коррекции (у мужчин: хорионический гонадотропин, тестостерона пропионат, метилтестостерон, тестостерона андеканоат, местеролон, небидо, сустанон-250; у женщин: котроткие курсы этинилэстрадиола (в первой фазе менструального цикла и метилтестостерона (во второй фазе), иногда - местеролона;
- поливитамины;
- средства, улучшающие кровообращение (ницерголин, пентоксифиллин и др.).

Психотерапия (индивидуальная, парная) направлена на нейтрализацию психогенных факторов подавления либидо, повышение интереса и активности в сексуальной жизни, при необходимости - коррекция представлений о ней. Для решения этих задач используется целый ряд взаимозаменяемых методов психотерапевтического воздействия из арсеналов НЛП, ДПДГ, гештальттерапии, клинического гипноза, телесно-ориентированных практик и др.

Рассмотрим подробнее секс-терапевтическое лечение алибидемии (фригидности) у женщин, разработанное Х. Каплан (1987). Его основная терапевтическая стратегия состоит в обучении женщины адекватно реагировать на сексуальную стимуляцию в то время, как она находится в расслабленном и безмятежном состоянии. Обычно используется следующая последовательность лечения женщин с полной фригидностью: 1) чувственное фокусирование - I; 2) чувственное фокусирование - II; 3) необязывающий коитус; 4) сношение с оргазмом.

Чувственное фокусирование означает, что супруги воздерживаются от полового акта и оргазма в течение нескольких дней или недель. На первом этапе (чувственное фокусирование-I) они занимаются любовными играми и нежными ласками, исключающими прямую стимуляцию гениталий. При этом партеры свободны от обязательств, согласно которым они непременно ждут определенных сексуальных реакций друг от друга. У него нет необходимости иметь эрекцию, а она освобождается от обязанности вызвать ее у своего партнера. Ни ей, ни ему не рекомендуется (терапевт настаивает на этом) достигать оргазма, но при этом им предписывается доставлять друг другу максимум наслаждений. Такая установка позволяет партнерам побороть свои страхи и опасения. При таких обстоятельствах появившееся ощущение радости и наслаждения служит подкреплением и стимулом для адекватного сексуального функционирования. Чувственное фокусирование - II используется после того, как пара успешно справилась с взаимным услаждением, или в том случае, если терапевт посчитал целесообразным обойти первый этап. Партнерам предписываются упражнения генитального услаждения, суть которых состоит в нежной соблазнительной стимуляции половых органов, при этом имеется одно важное условие: возбуждение не должно приводить к достижению оргазма.

У фригидных пациенток могут возникать негативные реакции на упражнения чувственного фокусирования, что необходимо учитывать. Их рекомендуют, если известно, что в добрачный период женщина испытывала достаточную возбудимость в ситуации предварительных ласк и при петтинге. Поначалу эти упражнения следует проводить в

одежде, что позволяет женщине воспринимать их без излишних опасений.

Необязывающий коитус. В оптимальном случае это упражнение выполняется при условии, если женщина проявляла положительную реакцию на упражнения чувственного фокусирования. Но если прикосновения к половым органам вызывают у нее непреодолимое сопротивление, то одним из способов обойти это сопротивление является упражнение не обязывающего коитуса.

Супружеская пара получает установку на взаимные ласки до получения эрекции у мужчины и любрикации у женщины. Если у женщины отсутствует достаточное увлажнение влагалища, мужчине предлагается смазать пенис любрикантом. Затем женщина занимает позу сверху. Она вводит член во влагалище, после чего некоторое время отдыхает, чтобы освоиться с ощущением фаллоса в себе. После этого она делает несколько сжатий лобково-копчиковых мышц, чтобы адаптироваться к ощущениям в вагинальной области. Далее она совершает медленные движения «вверх - вниз» по члену мужчины. Она «забавляется», экспериментирует с различными фрикционными и поступательными движениями. Она движима исключительно собственными ощущениями и не обращает внимания на партнера. С ее стороны требуется определенная доля эгоизма, чтобы оценить и осознать собственные, вагинальные ощущения. Мужчина как бы отдает во временное пользование свой эрегированный член, при этом он всячески поощряет женщину в ее действиях. Если мужчина ощущает приближение у себя оргазма, он предупреждает об этом супругу и пара делает небольшой перерыв. На это время можно оставить член во влагалище. Такой прерванный коитус дает женщине приятное сладострастное ощущение и обостряет ее возбуждение. За время перерыва паре обычно рекомендуют воздержаться от стимуляции. Но иногда мужчина может стимулировать клитор или женщина делает это сама. Упражнение заканчивается, когда она утомлена или достигает оргазма (на этом этапе оргазм возникает крайне редко). Ясно, что для необязывающего коитуса требуется сексологически нормальный партнер-мужчи-на с хорошей потенцией и достаточным контролем эякуляции.

Х. Каплан (1987) описывает различные виды реакций на необязывающий коитус. У женщин: удовольствие и возбуждение, а иногда оргазм; усиление приятных вагинальных ощущений, пробуждение любовных переживаний; но порой негативные проявления в форме анестезии или даже эмоциональных потрясений. Мужчины также по разному реагируют на упражнение. Одни воодушевлены возможностью помочь своей жене, получая от процесса сексуальное удовольствие. Другие - испытывают тревогу и враждебность, поскольку женщина проявляет повышенную активность и эгоцентризм.

При положительных реакциях супруги переходят к регулярному коитусу. Негативные реакции требуют анализа и коррекции. Многие фригидные женщины чрезмерно озабочены удовлетворением своего партнера в ущерб самим себе. Здесь проявляется мазохистская модель поведения в отношении к противоположному полу. В нем заложена глубокая тревога. Женщина не может поверить, что мужчина в состоянии полюбить ее и принять ее такой, как она есть. Она чувствует обязанность постоянно служить, приносить ему удовольствие. Она не может позволить себе расслабиться и принимать наслаждение. Муж, часто неосознанно, заинтересован в этом пассивном поведении жены, и он незаметно способствует его фиксации. Он позволяет ей служить, приносить ему удовольствие и ублажать себя. Такое поведение позволяет глубоко неуверенному в себе мужчине не выставлять наружу собственные проявления тревоги.

Упражнения необязывающего коитуса, в ходе которого женщина направляет свою активность в желаемое для себя русло, игнорируя принцип ублажения мужчины, часто выводят наружу стереотипы мазохистского поведения, поведения, которое служит неосознанным потребностям как мужчины, так и женщины. Поэтому у обоих партнеров может произойти усиление тревоги и активизация механизмов защиты, сдерживающих эту тревогу. Справиться с этими резистентными состояниями помогает повторение заданий и психотерапия, направленная на коррекцию уровня самооценки женщины.

В случаях, когда садомазохистские проявления устойчивы и не поддаются коррекции в ходе краткосрочной психотерапии, Х. Каплан рекомендует использовать «колла-

теральный» способ. Супругам предлагается сохранить все особенности своих взаимоотношений, но при этом следовать сексологическим предписаниям, то есть фактически активно заниматься сексом. Они могут вступать в перебранки, выяснять отношения, если того пожелают, но за пределами спальни.

Страх быть отвергнутой - еще одна типичная причина фригидности. Некоторые женщины способны хорошо диссоциировать сексуальные и аффективные реакции. Они получают наслаждение от половой активности и демонстрируют хороший секс, даже если равнодушны или негативно настроены по отношению к своему партнеру. Но значительно чаще женщины не способны испытывать положительные эмоции от секса в подобных случаях. Причем фригидные женщины часто даже не осознают враждебности или амбивалентности по отношению к своим мужьям. Женщина чувствует себя обманутой, используемой как орудие, совершенно не осознавая своей враждебности, которая, подавляет ее сексуальность в отношениях с мужем. Страх быть отвергнутой можно преодолеть «коллатерально», и женщине порой удается получать удовольствие от секса, несмотря на весьма противоречивое отношение к мужчине. В других случаях проявления враждебности становятся непреодолимым препятствием, и требуется психотерапевтическая помощь. Сходные проблемы возникают в случае чувства вины по поводу сексуального наслаждения.

Оргазм. В случае, когда необязывающий коитус приводит к появлению у женщины эротического отклика, пара получает установку на сношение, направленное на достижение оргазма у обоих партнеров. Однако на начальных этапах терапии нет необходимости форсировать наступление оргазма у фригидных женщин. Поначалу целью терапии должно являться усиление ее сексуальных реакций и пробуждение желания близости. Целенаправленная ориентация на оргазм может затормозить пробуждение сексуальности. Но если фригидность носит вторичный характер, являясь результатом повторяющихся неудачных попыток достичь оргазма, то предписывается выполнение специальных упражнений, направленных на его достижение.

Полезным дополнением к секс-терапии являются упражнения по развитию лонно-копчиковой мускулатуры.

Их предложил А. Кегель, который считал слабость лонно-копчиковой мускулатуры одной из характерных причин женской алибидемии и аноргазмии. Ощущения околовагинальной мускулатуры являются важным источником сладострастных эротических переживаний. Физиологический субстрат женского оргазма включает сокращения луковично-губчатой и лонно-коп-чиковой мускулатуры. Поэтому улучшение тонуса этих мышц способствует более яркому оргазму. Если есть данные, которые указывают на вялость или атрофию указанной мускулатуры, женщине предписывается один или два раза в день проводить упражнения на сокращения лонно-копчиковой мускулатуры. Для идентификации этих мышц пациентке рекомендуется периодически прерывать и продолжать мочеиспускание.

Физиотерапия и рефлексотерапия. Дополнительно могут использоваться: акупунктура и лазеропунктура (тонизируют точки E30; E32; E41; R7; VB25; TR3; RP5; RP10; RP12; VC5; VC15; VG8), аурикулотерапия (основные точки 22, 28, 32, 34, 58), традиционный восточный массаж.

F 52.1. Сексуальное отвращение и отсутствие полового удовлетворения

В отличие от нарушений полового влечения, сопровождающихся утратой интереса или полным безразличием к любым проявлениям интимной жизни, в этой рубрике идет речь о реакциях (субъективно нейтральной либо ярко выраженной негативной) на непосредственное сексуальное взаимодействие.

F 52.10 Сексуальное отвращение

Предстоящая половая связь с партнером вызывает сильные негативные чувства, страх или тревогу, которые достаточны, чтобы привести к уклонению от половой активности.

Диагностические критерии:

1) возможность сексуальных взаимодействий с партнерами вызывает отчетливое отвращение, страх или

тревогу, вынуждающую избегать половой активности. Если половой акт все же происходит, он сопровождается сильными отрицательными эмоциями и неспособностью ощутить удовлетворение;

2) отвращение и избегание не связаны со страхом ожидания сексуальной неудачи (как реакции на предшествующий негативный сексуальный опыт).

Устойчивое или повторяющееся отвращение к сексу с избеганием всех (почти всех) сексуальных контактов через половые органы фактически является тяжелой фобией. У людей, страдающих сексуальным отвращением, возникают иррациональный страх, ужас, связанный с сексуальной активностью и даже мыслями о ней. Страх перед половыми контактами может выражаться в физиологических симптомах (сильное потоотделение, тошнота, понос, серд-цебиение) или же чисто психологически, когда человек просто боится вступать я сексуальную связь. Навязчивый страх пациента усиливается непреодолимым желанием избегать интимных ситуаций, вызывающих у него сильную тревогу и неприятные сексуальные переживания. В одних случаях избегание или отвращение к сексу - изолированный симптом, в других - коитофобия представляет собой одно из проявлений невротических расстройств. Так, по данным Х. Каплан (1987), тревожные расстройства, в том числе атипичные панические состояния, встречаются примерно у 60 % лиц с данной формой сексуальной дисфункции.

Сексуальное отвращение к партнеру является одной из наиболее тяжелых сексуальных дисфункций. Ее распространенность точно неизвестна, поскольку за помощью к специалистам обращается лишь часть партнеров, страдающих сексуальной аверсией. Большинство женщин по мере нарастания данного расстройства начинают всячески избегать интимных отношений с супругом, что ведет к постоянным конфликтам, а в конечном итоге - к разводу. Для обеих сторон ситуация быстро становится трудновыносимой. Лицо, испытывающее отвращение к партнеру, может негативно воспринимать все виды прикосновений. В других случаях чувство отвращения ограничивается лишь сексуальными раздражителями при попытках близости (осязательны-ми, обонятельными, зрительными и т. п.). При выраженной аверсии сильная негативная реакция возникает не

только при непосредственном прикосновении партнера, но даже при одной мысли о таком прикосновении или о самом партнере. Отсюда - раздельные постели, переезд к матери и т. п. Чаще сексуальная аверсия нарастает постепенно. Однако она может возникнуть и внезапно, например, как реакция на раскрывшуюся измену партнера. Резкое возникновение отвращения, а также его периодическое усиление и ослабление обычно наблюдаются у истеричных лиц, которые в такой форме демонстрируют перемены в своем отношении и чувствах к партнеру либо стараются оказать на него психологическое давление.

Складывающаяся ситуация крайне неприятна для партнера, чувствующего, что к нему испытывают отвращение. Обычно мужчины расценивают это как удар по престижу. Одни примиряются с этим, другие стараются «проверяться» с посторонними женщинам, а некоторые силой принуждают партнершу к сожительству, относясь к аверсии как к притворству.

Ощущение женщиной половой аверсии со стороны мужчины наносит сильный удар по ее самооценке, воспринимается как отрицание ее женской привлекательности. Причины обычно ищут в появлении у партнера другой женщины, иногда его обвиняют в гомосексуальных наклонностях. В подобной ситуации женщины, нередко, стремятся найти подтверждение своей привлекательности у других мужчин. Сексуальная аверсия намного чаще отмечается у женщин (10 : 1). Столь большая разница обусловлена причинами аверсии, к которым относятся:

- *нарастающий конфликт между партнерами.* Негативные чувства, которые либо подавляются, либо утаиваются, постепенно начинают давать о себе знать исчезновением интереса к интимной близости. Последующие половые контакты становятся все более затруднительными и неприятными. Вслед за вспышкой аверсии, служащей выражением разрядки подавляемых чувств, наступает полное отвержение партнера;
- *аверсия как реакция на психотравтирующее или неадекватное поведение партнера.* Может возникать остро при измене и обнаружении так называемой двойной жизни. В других случаях она нарастает по-

степенно и связана с образом жизни и уровнем гигиены партнера, вызывающими сильное неприятие. Так, неприятный запах изо рта или от потных ног может послужить мощным детонатором аверсии. В том случае, если партнер не следит за собой, отвращение нарастает, охватывая не только сферу интимных отношений, но и изменяет отношение к нему как к личности. Это один из самых распространенных механизмов, к которым мужчины порой относятся с пренебрежением. Впрочем, некоторые женщины не стесняются заниматься личной гигиеной во время менструации в присутствии мужа, разгуливать по дому в грязном белье, неумытыми и непричесанными. Лица, придающие особое значение физической чистоте, аккуратной внешности, реагируют на партнеров, не оправдывающих их ожидания, сексуальной аверсией. К сожалению бывает так, что в добрачный период человек следит за собой, желая добиться признания я одобрения со стороны объекта обожания, но после свадьбы он начинает думать, что может вести себя дома как заблагорассудится, и перестает соблюдать опрятность;

- *аверсия как последний этап сексуальных дисфункций*. Например, если женщина не испытывает оргазма, то половая жизнь постепенно становится для нее безразличной либо даже неприятной, а при длительно существующей аноргазмии может вызывать отвращение. Случается также, что расстройство, которым страдает партнер (например, преждевременная эякуляция), мешает удовлетворению женщины и порождает у нее нежелание близости. Если мужчина не лечится и ситуация не меняется, к разочарованию присоединяются чувство досады, агрессивность и в конце концов аверсия. В принципе любые сексуальные затруднения при определенных условиях могут привести к аверсии. К таким условиям относятся продолжительность расстройства, его недооценка, отсутствие сотрудничества и диалога между партнерами, уклонение от поисков помощи и т. п.;

- *аверсия как выражение разочарования реалиями брачного союза*. Если от партнера по браку ожида-

лась возможность реализации многих надежд, а по разным причинам этого не произошло, на него возлагают вину за возникшее разочарование, что в итоге может спровоцировать по отношению к нему сексуальную аверсию;

- *аверсия как реакция на предложение партнером неприемлемых форм половых контактов* (анализм, групповой секс и т. п.). Иногда бывает достаточно одного разговора *о* подобных потребностях, чтобы к партнеру родилось отвращение. Чаще оно возникает после попыток склонения к формам близости, лежащим за гранью диапазона приемлемости;

- *сексуальная аверсия как результат неадекватного отношения к сексу из-за неправильного полового воспитания или жестких религиозных установок.* Отмечаются случаи, когда под влиянием соответствующих воспитательных воздействий постепенно усиливается отрицательное отношение к полу, телу, сексу, и сексуальная аверсия может возникнуть уже в самом начале половой жизни с партнером.

Это наиболее часто встречающиеся причины, но на самом деле их значительно больше. Нередко выявление истинных механизмов сексуальной аверсии, скрытых в бессознательном, является весьма непростой задачей.

У. Мастерс и В. Джонсон (1986) отмечают, что в типичных случаях сексуального отвращения частота половых контактов падает до 1-2 раз в год и реже. В супружестве или при длительных партнерских связях расстройство без лечения, как правило, приводит к полному разрыву отношений.

F52.11. Отсутствие сексуального удовлетворения

Возникают нормальные сексуальные реакции и переживается оргазм, но нет адекватного удовольствия. Эта жалоба намного чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

Диагностические критерии:

1) все генитальные реакции (оргазм и/или эякуляция) возникают при сексуальной стимуляции, но не вызывают приятных ощущений или чувства приятного возбуждения;

115

2) в ходе сексуальной активности отсутствуют отчетливые и стойкие признаки тревоги, страха.
Включается: ангедония (сексуальная).
Сексуальная, или оргазмическая, ангедония связана с выпадением психического компонента оргазма, в результате чего субъект не ощущает наслаждения и сексуального удовлетворения, хотя физиологический компонент оргазма сохранен.

Считается, что подобные нарушения являются проявлениями невротических реакций диссоциативного типа, отделяющих аффективный компонент оргазма от сознания. В их основе могут лежать конфликтные партнерские отношения, сексуальные комплексы (бессознательный запрет на чувственное наслаждение) и т. п. Текущие депрессивные эпизоды различной тяжести (Р32, Р33) также приводят к снижению или утрате удовольствия от переживания оргазма.

Обследование проводится, как правило, амбулаторно. Включает стандартное сексологическое обследование. В случае аверсии необходимо провести детальный расспрос о характере партнерских отношений в их длиннике (как межличностных, так и сексуальных) и выяснить возможные причины возникновения отвращения к половой близости. У женщин требуется тщательный сбор акушерско-гинекологического анамнеза для исключения органической природы расстройства - гормонального дисбаланса, воспалительных заболеваний репродуктивной сферы и пр. Мужчинам с жалобами на слабую выраженность переживания оргазма показана консультация уролога с проведением задней уретроскопии для исключения колликулита.

Дополнительные обследования: экспериментально-психологическое исследование; беседа с постоянным партнером для объективизации полученных сведений и коррекции его сексуального поведения; осмотр гинеколога.

Лечение направлено на повышение интереса к половым контактам и усиление остроты сексуальных переживаний пациента. После исключения

органической патологии, которая могла привести к развитию сексуального отвращения или отсутствию сексуального удовлетворения, основной акцент делается на психотерапевтических мероприятиях. Проводится индивидуальная, парная (в т. ч. по-

веденческая секс-терапия) и групповая психотерапия, которая сосредоточена на выявлении и разрешении истинных причин сексуальной аверсии или ангедонии, повышении интереса к сексуальной сфере и активизации половой жизни. Важными элементом психотерапевтической коррекции являются гипнотические техники, направленные на нейтрализацию негативного сексуального опыта {возрастная регрессия и переработка психотравмиругащих ситуаций в интимной жизни), а также усиление позитивно окрашенных сексуальных переживаний (сопровождение в приятном воспоминании). С той же целью вместо гипнотерапии может использоваться метод десенсибилизации и переработки движениями глаз (ДПДГ). В необходимых случаях психотерапия фокусируется на сопутствующих невротических расстройствах.

Фармакотерапия: по показаниям транквилизаторы, антидепрессанты, адаптогены.

F52.2. Недостаточность генитальной реакции

У мужчин основная проблема заключается в расстройстве (дисфункции) эрекции, т. е. затруднениях в наступлении или поддержании эрекции, достаточной для проведения удовлетворительного полового акта. Если в некоторых случаях эрекция возникает нормально, например, при мастурбации, во время сна или с другим партнером, то причина нарушения скорее всего является психогенной. В других случаях правильная диагностика расстройства (дисфункции) эрекции неорганической природы зависит от специальных исследований или реакции на психотерапию.

Диагностические критерии.

У мужчин при попытке сексуального контакта не возникает достаточная для совершения полового акта эрекция, причем нарушение эрекционной функции происходит в одном из следующих вариантов:

а) эрекция возникает на ранних стадиях сексуального контакта, исчезая частично или полностью при попытке совершения полового акта (до наступления эякуляции);

117

б) эрекция возникает лишь вне ситуации полового акта;
в) возникающая эрекция неполная (частичная) и недостаточная для проведения коитуса;
г) эрекция отсутствует полностью.
Включается:
- психогенная импотенция.
Исключается (к данной рубрике не относится):
- импотенция органического происхождения (N48.4).

У женщин основная проблема заключается в сухости влагалища или отсутствии его увлажнения (любрикации). Причина может быть психогенной или органической (например, инфекционной), либо речь идет об эстрогенной дифицитарности (например, после наступления менопаузы). Женщины редко жалуются на первичную вагинальную сухость, если только она не выступает как симптом эстрогенной недостаточности в постменопаузе.

Диагностические критерии;
- нарушение генитальных реакций (отсутствие физиологических признаков полового возбуждения) проявляется в одном из следующих вариантов:
а) любрикация отсутствует во всех соответствующих ситуациях;
б) любрикация может появиться вначале, оказываясь недостаточной для обеспечения субъективно приятных введения полового члена и/ или фрикций;
в) любрикация происходит нормально лишь в некоторых ситуациях (например, с определенным партнером, при мастурбации, вне полового акта).
Включается:
- расстройство полового возбуждения у женщин.

К. Имелинский (1986) относит данный вид нарушений к расстройствам комплекса сексуальной готовности, т. е. физиологического обеспечения готовности женщины к коитусу. При этом недостаточное увлажнение влагалища и расслабление его мышц затрудняют интроитус и весь ход полового акта. Чаще всего расстройства комплекса сексуальной готовности возникают как следствие «неприятия» партнера и отсутствия желания близости с ним либо недостаточного сексуального возбуждения в случаях неадекватной или слишком кратковременной стимуля-

ции со стороны партнера, генерализованного снижения (отсутствия) либидо, а также при неблагоприятной ситуации, вызывающей у женщины различные опасения.

Расстройства комплекса сексуальной готовности в период проведения полового акта проявляются обычно прекращением выделения вагинального секрета, что эквивалентно утрате эрекции у мужчины во время коитальных фрикций до эякуляции. Появляющаяся при этом сухость слизистой оболочки влагалища затрудняет фрикционные движения, которые сопровождаются сильным трением и вызывают болезненные ощущения как у женщины, так и. у мужчины. Это расстройство связано с преобладанием процессов торможения над сексуальным возбуждением. Оно наблюдается в ситуациях, связанных с переживанием страха перед нежелательной беременностью; при затянувшемся коитусе, во время которого женщина, несмотря на свое стремление, так и не достигла оргазма; при неадекватной сексуальной стимуляции со стороны партнера во время полового акта; иногда после произошедшего у женщины оргазма, если мужчина продолжает половое сношение. Частота расстройства генитальной реакции у женщин обычно недооценивается. По данным опроса NHSLS (1994), 19 % женщин отметили у себя проблемы с увлажнением влагалища.

Подавляющее число случаев обращения за сексологической помощью в связи с недостаточностью или отсутствием генитальной реакции приходится на мужчин. Нарушения эрекции - наиболее распространенная мужская сексуальная дисфункция. Частота расстройств эрекции увеличивается с возрастом, составляя 5 - 8 % у молодых мужчин и достигая 75 - 80 % к 80 годам (У. Мастерс, В. Джонсон, 1966, 1979; И. Голдстейн, 1985; К. Штарке, В. Фридрих, 1991 и др.). При изучении старения мужчин в штате Массачусетс (MMAS) 1709 мужчин в возрасте от 40 до 70 лет были подвергнуты мультидисциплинарному анкетированию. Из общего

количества опрошенных 1290 человек полностью ответили на все вопросы, касающиеся их половой жизни. Были получены следующие данные о распространенности эрекционных дисфункций в среднем и пожилом возрасте: минимальные нарушения эрекции - 17 %; умеренные нарушения - 25 % и полная

импотенция - 10 %. (N. Feldman, I. Goldstein, 1994). Причины дисфункций эрекции весьма многочисленны и связаны с нарушениями различных систем, обеспечивающих генитальные реакции (психической сферы, нервной, эндокринной, мочеполовой, сосудистой) или их сочетанием. Органические (биологические) факторы в этиологии эрекционных дисфункций, по различным оценкам, составляют от 20-25 % до 50-60 %, причем их удельный вес заметно возрастает у мужчин старше 40 - 45 лет (И. Голдстейн, 1985; Э. Уэспес, 1989; Г. Каплан, Б. Сэдок, 1996).

I. Органические этиологические факторы эректильных дисфункций:

1. Сосудистая патология:

а) *Артериальная* (поражения в аорто-подвздошной зоне и в бассейне внутренних половых артерий):

- атеросклеротические поражения артерий;
- посттравматические повреждения артерий малого таза (как правило, возникают после перелома костей таза);
- ятрогенные повреждения артерий (при хирургических операциях на органах малого таза, бифуркации аорты, последствия лучевой терапии рака простаты либо прямой кишки;
- врожденные аномалии артериального русла гениталий (дисплазии артерий, артериовенозные фистулы).

б) *Венозная:*

- кавернозно-венозная идиопатическая недостаточность;
- врожденные аномалии венозного оттока;
- приобретенные нетравматические аномалии венозного оттока (например, при болезни Пейрони);
- посттравматическая венозная недостаточность (кавернозо-спонгиозные и артериовенозные фистулы).

в) Сочетанная артериовенозная патология.
2. Неврологическая патология:
а) *Церебральные нарушения* (повреждения лимбической системы и височной области в результате травмы, аневризмы или ангиомы):
- височная эпилепсия, болезнь Паркинсона;
- опухоли и сосудистые поражения головного мозга.

120

б) *Спинномозговые нарушения* (повреждения и травмы спинного мозга):
- поражения ствола мозга в результате БАС, сирингомиелии, рассеянного склероза, позднего нейросифилиса («спинной сухотки»), арахноидита, абсцесса спинного мозга, тромбоза спинальной артерии, грыжи межпозвоночного диска, миелита и опухолей спинного мозга.
в) *Экстраспинальные нарушения* (каудиты, плекситы, невриты, периферические нейропатии при сахарном диабете, опухолевые процессы, вызывающие повреждение нервов, участвующих в механизмах эрекции):
- травматические (при переломах костей таза) и ятрогенные (при урологических операциях и операциях на нижних отделах кишечника), повреждения периферических нервных путей эрекционного рефлекса.

3. Эндокринная патология:
- гипоталамо-гипофизарная недостаточность в результате идиопатических нарушений, общесоматических заболеваний (туберкулез, саркоидоз), травм и кист головного мозга;
- гормонально активные опухоли гипофиза (пролактинсекретирующая аденома);
- гиперэстрогения при эстроген-секретирующих опухолях или проведении противоопухолевой терапии, при алкогольном циррозе печени;
- врожденные тестикулярные нарушения (тестикулярная агенезия, билатеральный крипторхизм, синдром Клайнфелтера);
- приобретенные тестикулярные нарушения (последствия паротитного либо бактериального орхита, травмы яичек);

- возрастная инволюция - вызывает нарушения в системе гипоталамус-гипофиз-тестикулы;
- опухоли надпочечников;
- общие эндокринопатии (сахарный диабет, акромегалия, гипотиреоз, гипертиреоз, гиперкортицизм.

4. Патология мочеполовой системы:
- пороки развития, опухоли и травматические повреждения половых органов;

- заболевания мочеполовых органов (острый и хронический кавернит, болезнь Пейрони и др.);
- фиброз и склероз кавернозной ткани разной этиологии (травмы, ранения, перенесенные воспаления, последствия частых и длительных интракавернозных инъекций);
- заболевания почек с симптомами хронической почечной недостаточности.

5. Токсические влияния:
- злоупотребление алкоголем и прием наркотиков (препараты конопли, опиаты); табакокурение;
- отравления свинцом, гербицидами и т. п.

6. Осложнения фармакотерапии.
Негативно влияют на эректильную функцию:
а) *психотропные препараты:* аминазин, тизерцин, трифтазин, галоперидол, сульпирид, мелипрамин, амитриптилин, кломипрамин, элениум, реланиум, антелепсин, препараты лития и др.;
б) *гипотензивные средства:* клофелин, резерпин, анаприлин, атенолол, каптоприл, антагонисты кальция;
в) *антиаритмические препараты:* ритмодан, амиодарон, пульснорма;
г) *антиандрогены:* ципротерона ацетат, проскар;
д) *диуретики:* спиронолактон, гипотиазид;

е) *ингибиторы синтеза простагландинов:* индометацин, диклофенак, бруфен;
ж) *антигистаминные препараты:* димедрол, пипольфен, супрастин;
з) *блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов желудка:* циметидин, гистак;
и) *прочие препараты:* фенобарбитал, метронидазол, дигоксин, противопаркинсонические средства (артан, тремблекс), церукал, спазмо-литики (баралгин, спазмалгон, букошпаи), кортикостероиды, антибиотики в высоких дозировках при длительных курсах лечения.

II. Психогенные факторы.
1. Ситуационные факторы:
- неблагоприятные условия для проведения полового акта;

- страх перед нежелательной беременностью женщины;
- боязнь заразиться венерическим заболеванием;
- угроза огласки половой связи при внебрачных половых контактах;
- психическое переутомление, алкогольное опьянение.

2. Травмирующие переживания:
- болезненные воспоминания о предшествующих сексуальных неудачах;
- тревожные опасения по поводу своей способности удовлетворить женщину;
- страх перед возможной неудачей при половой близости.

3. Партнерские проблемы:
- нарушения межличностных отношений с партнершей;
- нарастающие негативные эмоции и взаимное недоверие партнеров;
- неадекватное поведение женщины, которая ведет себя агрессивно, насмехается над мужчиной либо всячески демонстрирует свою холодность и нежелание близости.

4. Личностные факторы:
- тревожно-мнительные черты характера;
- сниженная самооценка и повышенная склонность к самоанализу;
- чрезмерная ответственность за успешное осуществление полового акта;

- ошибочные убеждения и установки в отношении половой жизни.

Наиболее постоянной формой невротических расстройств, приводящей к эректильным дисфункциям (недостаточности или отсутствия генитальной реакции по МКБ-10) является синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН). Он содержит на первом этапе превращение возникшей мысли о возможной неудаче при коитусе в действительности, т. е. своеобразную висцерализацию интеллектуальных, логических построений (формируется региональная вегетососудистая дистония, затрудняющая адекватное возрастание кровотока в кавернозных телах до

123

уровня необходимого для возникновения и/или поддержания стабильной эрекции при половой близости). В интимной жизни тревожное ожидание новых срывов может возникнуть после одной или нескольких неудачных попыток коитуса у мужчины, который до этого был вполне здоров в сексуальном отношении, либо этот синдром отягощает структуру полового расстройства, обусловленного другими причинами. Типичный стереотип развития данного расстройства выглядит следующим образом. Ситуационно обусловленные сексуальные неудачи вызывают у неуверенного и тревожного мужчины сомнения в своих силах, приводя к гиперконтролю очередного интимного сближения. Он начинает выступать в роли наблюдателя за своими сексуальными реакциями и действиями, а также поведением партнерши. В результате, мужчина все меньше включается в сексуальную активность, которая утрачивает спонтанность и естественность, необходимые для возникновения и поддержания полового возбуждения и эрекции. Это влечет за собой новые срывы и усиление навязчивых опасений потерпеть очередную неудачу, формируя классический «порочный круг». Беспокойство мужчины по поводу возникших сексуальных затруднений является первичным (пусковым) психологическим фактором, определяющим развитие физиологических проявлений (поведенческих, соматовегета-тивных) эмоционального стресса. Если основной симптом синдрома уревожного ожидания сексуальной неудачи - навязчивое опасение нового срыва - достигает степени уверенности в собственной неполноценности, формируется

коитофобия, резко ограничивающая либо исключающая половые контакты. При длительном течении коитофобии происходит вторичное снижение либидо, а интересы таких мужчин нередко смещаются на другие потребности: переедание, злоупотребление алкоголем, одержимость работой, уход в активную общественную деятельность, возникновение нового хобби или гипертрофия прежних увлечений и т. п., что носит компенсаторный характер.

Наличие у пациента страха перед предстоящими сексуальными контактами требует его обязательной нейтрализации (лучше всего психотерапевтическими методами), поскольку без этого трудно рассчитывать на устойчивое восстановление нормальных сексуальных реакций мужчины.

124

Среди нарушений эрекции органического генеза у мужчин старше *45* лет доминируют *васкулогенные эректилъные дисфункции.*

Рассмотрим динамику развития половых расстройств у мужчин с атеросклеротическими поражениями сосудистого русла гениталий. Наиболее ранним клиническим признаком нарастающего ухудшения кровоснабжения кавернозных тел является постепенное, без видимых причин ослабление и урежение адекватных и параллельно (либо несколько позднее) спонтанных утренних эрекций. На начальной стадии *(компенсации)* нарушений кровоснабжения гениталий достижение полноценной эрекции еще возможно, но требует определенных усилий. Например, интенсификации и удлинения периода ласк, дополнительной тактильной и визуальной стимуляции, особого психологического настроя. Нередко больные переносят интимные встречи на утренние часы, используя более качественные спонтанные эрекции, тогда как в привычное для них время потенция «оставляет желать лучшего» даже при наличии обоюдного стремления к близости. По мере дальнейшего ухудшения кровоснабжения кавернозных тел наступает *стадия субкомпенсации,* когда полноценная эрекция уже не развивается ни при каких обстоятельствах, что все более затрудняет коитус. Поэтому, несмотря на сохранное либидо, половые акты удаются пациентам все реже, существенно укорачивается их продолжительность. Некоторые больные жалуются на чувство похолодания в промежности и/или онемение головки полового члена. Весьма характерно

резкое ослабление эрекции через 20 - 40 секунд после начала копулятивных фрикций, что связано с неблагоприятным перераспределением кровотока в области малого таза при нагрузке на ягодичные и бедренные мышцы во время фрикционных движений. В результате больные часто вынуждены прерывать коитус до эякуляции либо семяизвержение происходит в преддверие влагалища практически без эрекции. На *стадии декомпенсации* васкулогенные эректильные дисфункции носят столь выраженный характер, что вообще исключают возможность вагинального коитуса. Это вынуждает одних больных прибегать к вестибулярному половому акту (в предверьи влагалища), петтингу или мастурбации (без эрекции), а других - практически полностью отказаться от любых форм сексуальной

активности. На этой стадии у многих больных отмечается вторичное снижение полового влечения (В.А. Доморацкий, 1993).

В ряде случаев уже при возникновении первых проявлений недостаточности кровоснабжения гениталий (торпидной, неполной эрекции, ее периодического ослабления во время коитуса и т. п.), упреки женщины и фиксация внимания на собственных сексуальных реакциях приводят к учащению у мужчины срывов из-за отказа эрекции по механизмам тревожного ожидания неудачи, что существенно облегчается дефицитарностью региональной гемодинамики. Присоединение вторичной невротической симптоматики (навязчивых сомнений в своих сексуальных возможностях и опасений новых неудачных попыток, коитофобии), в свою очередь, способствует нарастанию нарушений сексуальных функций (еще большему ослаблению эрекций, укорочению длительности коитуса, урежению ритма половой жизни, а в ряде случаев и снижению либидо) даже при отсутствии грубой патологии генитального кровотока. При более выраженных расстройствах кровоснабжения кавернозных тел, формирование психопатологических нарушений и невротического поведения во время интимной близости практически лишают пару возможностей для компенсации ослабления эрекций изменением привычного стереотипа сексуальных контактов, расширением и удлинением предварительных ласк, подбором наиболее удачного времени и оптимальных позиций для проведения коитуса. В результате больные сводят к минимуму попытки половых актов либо вовсе избегают сексуальных контактов, поскольку

заведомо уверены в их отрицательном результате. Установлено, что даже эффективная коррекция генитального кровотока (с допплерографическим контролем, свидетельствующим об улучшении гем о динамических механизмов эрекции) у большинства этих пациентов не приводит к нормализации половых контактов до тех пор, пока у них сохраняется страх потерпеть фиаско при коитусе. Описанный нами (В.А. Доморацкий, 1993, 2004) вариант течения васулогенных сексуальных дисфункций с присоединением вторичных невротических расстройств свидетельствует о необходимости коррекции имеющихся психопатологических нарушений у пациентов сексологического профиля, что следует учитывать при выработке лечебной тактики.

Схема обследования пациентов с нарушениями эрекции.

Выявление диагностических признаков психогенной эректильной дисфункции;

1. Сохранные спонтанные эрекции во сне и при утреннем пробуждении.
2. Наличие эрекций при мастурбации.
3. Возникновение эрекции при ласках с ее последующим ослаблением при попытке интроитуса.
4. Появление эрекции в ситуациях, провоцирующих сексуальное возбуждение, если мужчина исключает для себя возможность половой близости.
5. Избирательность нарушений эрекции (их ситуационный характер - сексуальные проблемы возникают с конкретной партнершей или только в определенных ситуациях).

Исследование генитального кровотока;

- *Пальпаторное исследование пульсаций пениальных артерий.*
- *Определение пено-брахиального индекса (ПБИ)* - отношения величины систолического артериального давления в плечевой артерии

к систолическому давлению в артериях полового члена. В норме значения ПБИ составляют 0,65 - 1,0, в то время как показатели 0,6 и ниже позволяют предположить наличие патологии артериального русла, кровоснабжающего гениталии. Следует учитывать, что диагностическая ценность ПБИ не превышает 78 %, а в остальных случаях возможно получение как ложноположительных (при спазмировании пенильных артерий), так и ложноотрицательных (при изолированных поражениях внутренних половых артерий) результатов. - *Фармакологическое тестирование путем интракавернозного введения 10 мкг алпростадила (каверджекта).*

При отсутствии васкулогенной эректильной дисфункции наступление полной эрекции происходит через 5 - 10 минут после инъекции препарата, причем эрекция продолжается не менее 30 минут.

О нарушении артериального кровотока свидетельствует неполная эрекция и задержка в ее возникновении более чем на 15 минут.

На возможный патологический венозный отток из кавернозных тел указывает неполная эрекция и ранняя (менее чем за 30 минут) потеря ригидности полового члена.

127

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов полового члена с фармакологической нагрузкой (10 мкг каверджекта). *Вначале в состоянии покоя исследуются индекс периферического сопротивления (К1), индекс пульсации (Р1), максимальная (Vmax), минимальная (Vmin) и средняя (Vmid) системная скорость. Затем аналогичные показатели регистрируются после интракавернозной инъекции 10 мкг каверджекта* в *фазе тумесценции и эрекции. Отсутствие асимметрии кровотока по пенилышм артериям, достижение его пиковой линейной скорости свыше 33 см/сек., при значениях К1 >1,0 и Р1 >5,0 свидетельствуют о сохранности нормальных гемодинамических механизмов эрекции. УЗДГ с фармакологической нагрузкой является высокоинформативным методом исследования, который в 95 % случаев коррелирует с результатами селективной ангиографии половых артерий.*

||
V
патология
||
V

Селективная ангиография генитальных артерий;
динамическая инфузионная кавернозография;
радиоизотопное исследование генитального кровотока.

Неврологическое исследование:

- *Определение сохранности тактильной и болевой чувствительности гениталий, исследование генитальных рефлексов* (наиболее информативно определение бульбокавернозного рефлекса, но его диагностическое значение сохраняется примерно до 50 лет).

- *Оценка вибрационной чувствительности полового члена* с помощью биотензиометра.

||
V
патология
||
V

Электромиография мышц промежности; исследование рефрактерности крестцовых нервов; регистрация вызванных церебральных потенциалов после стимуляции тыльного нерва полового члена; компьютерная томография головного мозга.

128

Исследование мочеполовой и эндокринной систем:

- *Оценка размеров полового члена; состояния кавернозных тел при пальпации; пигментации мошонки, ее тонуса; размеров и консистенции яичек, придатков; пальцевое исследование простаты и анализ ее секрета.*

Симптомами косвенно указывающими на наличие андрогенной недостаточности являются: гипоплазия пениса (в неэрегированном состоянии в норме его длина 9-9,5 см); депигментация, атония мошонки, ее малые размеры и отвислость; изменение размеров яичек (менее 40 мм в длиннике) и их мягко-эластичная консистенция; симптом «серпа» - уплощение и западение верхнего сегмента простаты, а ее нижний сегмент в виде валика как бы окаймляет образующуюся впадину.

Анализ эякулята: косвенные показатели андрогенной насыщенности - объем эякулята (в норме 3,0 - 3,5 мл), уровни содержания фруктозы (в норме 150 - 500 мг % и лимонной кислоты (в норме 300 - 500 мг %).

Гормональная проба Ригони-Гольяни (в наружную поверхность верхней трети предплечья внутрикожно вводят смесь 0,3 мл 1 % тестостерона пропионата и 0,2 мл физиологического раствора). Оценка результатов пробы Ригони-Гольяни проводится через 15-20 минут следующим образом: ярко-красная гиперемия ++++ (зона гиперемии в месте инъекции более 30 мм) - проба резко положительная; яркая гиперемия +++ (зона гиперемии 26 - 29 мм) — положительная проба; неяркая розовая ++ (зона гиперемии 10 - 14 мм) -

сомнительная проба; слабая гиперемия или ее отсутствие - отрицательная проба. Установлено, что резко положительная либо положительная пробы Ригони-Гольяни четко коррелируют с нормальными показателями тестостерона в сыворотке крови, полученными радиоиммунологическим методом (И.И. Горпинченко, А.С. Сегал, и др., 1991).

||
V
патология
||
V

Определение уровня тестостерона (в норме 4,9 ± 0,38 мкг/л), ЛГ (в норме 2,16 ± 0,19 мкг/ л), ФСГ (в норме 2,44 ± 0,26 мкг/л), про-

лактина(в норме 5,2± 1,9 мкг/л), эстраднола (в норме 27,5 ± 0,13 мкг/л) в сыворотке крови, 17-КС в моче (суточная экскреция в норме 6,6 - 23,4 мг, но лишь 30-40 % мочевых кетостероидов тестикулярного происхождения, а 60-70 % продуцируются корой надпочечников).

Визуализация турецкого седла с помощью краниографии; при подозрении на аденому гипофиза - *компьютерная иди ЯМР-томография.*

Обследование женщин с расстройством полового возбуждения предполагает стандартное сексологическое обследование, в ходе которого особое внимание должно уделяться выявлению различных тенденций сексуального влечения (гомосексуальных и пр.) и определению реактивности эрогенных зон. Дополнительно проводится тщательный гинекологический осмотр, показаны гормональные исследования - определение количества и соотношения гормонов ЛГ, ФСГ, пролактина, эстрогенов, прогестерона, тестостерона в крови, а также 17-КС, 17-ОКС в моче, взятие мазков влагалищной флоры с целью исключения воспалительных инфекционных заболеваний.

Лечение ставит целью улучшение качества эрекции до степени достаточной для удовлетворительного полового акта; у женщин - усиление полового возбуждения и любрикации при сексуальном контакте. Предполагает сочетанное использование фармакотерапии, психотерапии, физиотерапии и рефлексотерапии.

Фармакотерапия у мужчин:

- при нарушениях кровоснабжения гениталий - курсовое назначение комбинаций вазоактивных препаратов общего действия (ницерголин, иохимбин, актовегин, экстракт листьев гингко билоба, пентоксифиллин), а также средств селективного действия (силденафил, алпростадил);
- при нарушениях проводящих нервных путей - средства, улучшающие нервно-мышечную проводимость (стрихнина нитрат, прозерин, дистигмин бромид);
- при эндогенных и органических психических расстройствах - терапия основного заболевания;
- при психогенных эректильных дисфункциях - сочетание дневных транквилизаторов (тофизопам, меза-

пам) и a_2 адреноблокаторов (ницерголин, иохимбин); для получения быстрого эффекта возможно одно-, двухкратное применение силденафила (после предварительной психотерапевтической коррекции страха перед коитусом и на фоне психотерапевтического опосредования).

У женщин применяют адаптогены, транквилизаторы, кремы - любриканты, а также повышающие эрогенную чувствительность и реактивность.

При эректильных дисфункциях различного генеза показано курсовое применение локальной декомпрессии полового члена (ЛД), а также рефлексотерапии (акупунктуры). Рекомендуются следующие точки для акупунктуры: R6; R10; R12; F1; F4; F5; УВ34; RP8; RP9; V23; V28; V31; V32; V33; V34; VG1; VG2; VG3; VC1; VC4; VC5; VC6 (при недостаточной эрекции и нормальной продолжительности полового акта обычно используют второй вариант возбуждающего метода). Точки для аурикулотерапии: АР13 (надпочеч-ник); АР22 (железы внутренней секреции); АР28 (гипофиз); АР32 (яичко); АР34 (кора головного мозга); АР51 (симпатическая нервная система); АР55 (точка ЦНС); АР79 (наружные половые органы); АР93 (простата); АР109 (нижняя часть живота). Возможно сочетанное воздействие на корпоральные и аурикулярные точки.

Используются адаптогены (препараты из женьшеня, аралии манчжурской, левзеи, родиолы розовой, заманихи, элеутерококка, лимонника китайского и т. п.), которые наиболее эффективны при снижении потенции на фоне астенического симптомокомплекса.

Психотерапия сосредоточена на устранении тревоги перед коитусом, подавляющей генитальные реакции. С этой целью у лиц обоего пола необходимо: 1) нейтрализовать негативный сексуальный опыт (психотерапевтической переработке в техниках ДПДГ, НЛП или эриксоновского гипноза подвергаются ситуации фиаско либо другие психотравмирующие ситуации, связанные с половой жизнью); 2) выявить и провести последовательное разрушение триггеров (внешних и внутренних стимулов в форме картин, звуков либо мыслей, образов и ощущений), блокирующих нормальное течение сексуальных реакций при половом контакте (используются техника Сандерса, сокращенная

версия ДПДГ, визуализация дискомфортных ощущений в трансе и др.); 3) устранить гиперконтроль пациента за своим поведением и сексуальными реакциями в ситуации интимной близости (используются ассоциирование в переживание, гипнотические техники, активизирующие кинестетический канал восприятия, а также тактика мнимого запрета у мужчин); 4) активизировать внутренние ресурсы через обращение в трансе к позитивному опыту сексуальных отношений в прошлом (либо формирования яркой и притягательной модели подобных отношений, при отсутствии их у субъекта в реальной жизни).

При адекватном отношении партнерши у мужчин с недостаточностью генитальной реакции показано применение секс-терапии в виде пяти последовательных этапов: эротическое наслаждение без эрекции, эрекция без оргазма, экстравагинальный оргазм, интромиссия без оргазма, коитус. Параллельно с мероприятиями по улучшению эрекции проводится психотерапевтическая коррекция нарушенных межличностных и сексуальных отношений в паре.

F52.3 Организмическая дисфункции

Оргазм не возникает или заметно задерживается. Это может иметь ситуационный характер (т. е. возникает лишь в определенных ситуациях), и в таком случае этиология скорее всего является психогенной. В других случаях оргазмическая дисфункция инвариабельна и физические или конституциональные факторы могут быть исключены только на основании положительной реакции на психотерапию. Оргазмическая дисфункция чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин.

Следует отметить, что физиологически в норме у мужчин оргазм тесно связан с семяизвержением. Поэтому в эту подборку необходимо включать также задержки и отсутствие семяизвержения.

Диагностические критерии.

Отсутствие или отставленность оргазма проявляется в одном из следующих вариантов:

1) оргазм не испытывался никогда, ни в какой ситуации;

2) расстройство возникло после какого-то времени нормального сексуального функционирования.

132

У женщин расстройства оргазма (аноргазмия) представляет собой повторяющуюся и устойчивую задержку или отсутствие оргазма после фазы нормального сексуального возбуждения, которую врач находит адекватной по фокусу, интенсивности и длительности. Аноргазмия отмечается: а) во всех ситуациях и с каждым партнером; 6) лишь в определенных ситуациях, тогда как в других способность к оргазму сохранена, например при мастурбации или с определенным партнером.

У мужчин при расстройствах оргазма эякуляция во время полового акта достигается с большим трудом или не достигается вообще.

Выделяют следующие варианты мужской оргазмической дисфункции:

а) эякуляция бывает лишь во сне при поллюциях и никогда в бодрствующем состоянии;

б) эякуляция и оргазм никогда не происходят в присутствии партнерши, но возможны при мастурбации;

в) в присутствии партнерши, но не интравагинально (при орогенитальной или мануально-генитальной стимуляции);

г) эпизодическое отсутствие эякуляции и оргазма при половом акте;

д) избирательное (селективное) отсутствие эякуляции и оргазма с определенной партнершей или в определенной ситуации;

е) затрудненное, требующее больших усилий достижение эякуляции и оргазма при половом акте, который носит затяжной, изнурительный характер.

Включаются:

- ингибированный оргазм мужской (женский);
- психогенная аноргазмия;
- ингибированное семяизвержение у мужчин;
- психогенное анэякуляторное расстройство.

Оргазм - наивысшая степень чувственного наслаждения, кульминация полового акта или других форм сексуальной разрядки (маструбации, петтинга, эротических сновидений и т. д.). Он является результатом интегратив-ного взаимодействия ряда структурно-функциональных образований различного уровня (тазового, спинального,

133

диэнцефального, коркового). В «конструировании» чувственного наслаждения на местном уровне у женщин участвуют клитор, влагалище и матка, а у мужчин - половой член, простата и семенные пузырьки. Однако само переживание оргазма связано прежде всего с деятельностью целого ряда структур головного мозга и психики в целом. Однажды испытав чувство оргазма, индивид стремится к новым и новым повторениям этого экстатического переживания. Любопытно, что сущность своих оргастических переживаний мужчины и женщины описывают практически одинаково. Группа из 70 экспертов не смогла разграничить мужские и женские описания оргазма, из которых были предварительно удалены явные указания на пол испытуемого (E. Procter et al., 1974).

Тем не менее, женский оргазм физиологически и психологически сложнее мужского. Способность к переживанию оргазма у женщин непостоянна и зависит от множества биологических и психологических факторов. Для адекватной оценки оргастичности женщины необходимо учитывать ее психофизиологические особенности, предшествующий сексуальный опыт, способность испытывать оргазм при тех или иных формах стимуляции либо во сне, возраст, гинекологический статус, наличие постоянного и чуткого партнера без сексуальных отклонений и т. п. Так,

аноргазмия в начале половой жизни может быть связана с некоторым запаздыванием психосексуального развития и носит временный характер. У многих женщин отмечаются циклические изменения либидо и оргазма в зависимости от фазы менструального цикла. Например, у негритянок пик сексуального желания и максимальная оргастичность приходятся на период овуляции, т. е. середину цикла; у белых женщин - чаще на период близкий к менструации (за несколько дней до ее начала либо сразу же после окончания).

Н. Шайнесс (1998) выделяет целый ряд психологических факторов, способствующих женской аутентичной (завершенной) оргазмической реакции. Эти же факторы можно определить как решающие для психического здоровья в целом, что подтверждает ведущую роль психологических факторов для нормальной женской сексуальности. Здесь уместно вспомнить высказывание Дж. МакДугалл:

«Не вызывает сомнения, что ведущая "эрогенная зона" человечества расположена в голове». Рассмотрим наиболее важные из них, относящиеся непосредственно к сексуальности.

1. *Успешное психосексуальное развитие.* Здесь можно выделить сознательное признание собственной женственности, развитие догенитальной ступени, своевременное в контексте индивидуального развития

менархе, развитие груди. Другие факторы психосексуальной зрелости женщины связаны с достаточно хорошим отношением к матери и отцу, с адекватной эротической атмосферой в доме родителей, с позитивным сексуальным опытом в период первых интимных отношений, с чувством собственной ценности и сексуальной привлекательностью девушки.

2. *Активный выбор партнера.* Успех женщины главным образом обусловливается тем, что она понимает свою сексуальную активность как нечто, на что она решилась сама.

3. *Вызывающий доверие партнер.* Причем партнер также должен быть уверенным в себе, так как предполагаемая недостаточность партнера неизбежно становится ее недостаточностью. В большинстве случаев

важны еще прочные партнерские отношения, поскольку женская сексуальность полнее всего раскрывается в ситуации романтически окрашенной, стабильной связи с нежным и внимательным партнером.

4. *Возможность непринужденно реагировать на возникшую сексуальную потребность.*

5. *Независимость от нарциссического поведения.* Для аутентичной реакции характерны естественность сексуального поведения и радость самоотдачи. Женщина, наряду с генитальным удовлетворением, стремится к нежности и к особого рода слиянию или идентификации с партнером.

6. *Свобода от чувства вины и страха.* Эти чувства неблагоприятно сказываются на сексуальной реактивности и эмоциональной вовлеченности женщины.

7. *Культурное влияние.* «Сексуальные способности и способы поведения женщины несут на себе печать

культурной установки на сексуальность и мораль, сексуальный кодекс и положение женщины как таковой».

8. *Жизненная реальность «сегодняшнего дня».* По вседневные данности воздействуют на эмоциональный настрой женщины. То же касается и настроения самого партнера. И связь с сексуальностью данного
пункта достаточна высока.

9. *Удовлетворенное желание быть признанном.* У женщины, способной к аутентичной оргазмической реакции, личностное развитие таково, что ей не нужно больше подтверждения своей значимости и она не сомневается в своих сексуальных способностях.

Женщина, активно включенная в сексуальные отношения, в которые она «вступила или намеренно завела, не являясь при этом сторонним наблюдателем и не интеллектуализируя, без навязчивых размышлений о них и не придумывая особых условий, не испытывая тревоги или страха, не "продуцируя" себя нарциссически и не конкурируя с партнером,

начинает испытывать страсть и отваживается реагировать тем способом, который полностью соответствует ее потребности, пока наконец не может больше удерживать себя под контролем - и тогда в своем изменившемся сознании она переживает полное освобождение, штиль после шторма, сопровождающийся порывом благодарности и чувством уважения к партнеру» (Н. Шайнесс, 1998).

3. Старович (1991) к факторам, способствующим достижению женщиной оргазма, относит следующие: оптимальный уровень андрогенов в организме; хорошая реактивность нервной системы; достаточное напряжение мышц промежности в процессе полового акта; мастурбационный опыт; сексуальная инициация в возрасте до 18 лет; продолжительность предварительных ласк свыше 15 минут, длительность коитуса свыше 10 минут, экстравертированность личности; высокий уровень сексуальной образованности и сексуального воображения; удачная чувственная связь с партнером; вынесенный из семейной среды позитивный эталон чувственных взаимоотношений.

Оргазм у женщин различается по следующим характеристикам:

136

1. *По источнику возникновения:*

а) коитальный (в ходе полового акта);

б) экстракоитальный (без полового акта):

- во время сна (чаще при эротических сновидениях);

- при мастурбации;

- в ходе *петтинга*;

- случайный (на высоте эмоциональных переживаний или при сильной общей вибрации).

2. *По локализации:*

а) клиторальный;

б) вагинальный;

в) смешанный;

г) неопределенной локализации.

3. *По течению:*

а) кратковременный (пикообразный);

б) многократный (мультиоргазм);

в) затяжной (волнообразный);
г) стертый (редуцированный).
4. *По интенсивности:*
а) сильный;
б) умеренный;
в) слабый.

У. Мастерс и В. Джонсон пришли к выводу, что отдельного «вагинального» оргазма не существует. В физиологическом аспекте субстратом любого оргазма являются ритмичные сокращения половых органов, более выраженные в нижней трети влагалища, но возникающие также в матке с интервалом 0,8 секунды. Регистрируется от 3 до 15 подобных сокращений, причем яркость оргастических переживаний определяется их интенсивностью и количеством. В последнее десятилетие исследования американских сексологов Уиппла и Комисарюка убедительно показали невозможность локализовать женский оргазм в какой-то определенной точке тела или половых органах. С помощью ядерно-магнитного резонанса они обнаружили практически идентичную картину у неподвижно лежащих женщин, вызывающих оргастические переживания только с помощью воображаемых эротических образов и у тех, кто достигал оргазма путем мастурбация. Но все же в субъективных оценках того, какая именно стимуляция ведет к оргазму, у женщин существуют большие различия. Так, например,

37

среди молодых немок, опрошенных в 70-х годах прошлого века, 30 % считали воздействие на клитор важнейшим условием достижения оргазма, 17 % - стимуляцию влагалища, 4 % - другие участки тела, но самым распространенным был ответ «это бывает по разному» - 45 % (K. Starke, W. Friedrich, 1991).

Рассмотрим основные варианты течения женского оргазма.

Кратковременный (пикообразный) оргазм. Возникает у женщины в результате адекватной по интенсивности и длительности сексуальной стимуляции, которая приводит к резкому, прерывистому нарастанию возбуждения с однократной интенсивной оргастической разрядкой и последующим общим расслаблением. В ряде случаев после пережитого оргазма у них наступает состояние, напоминающее рефрактерный период у мужчин. Поэтому, если у партнера не произошла эякуляция и он продолжает фрикции, половой акт начинает даже тяготить женщину, поскольку мешает ей предаваться уже возникшему чувству расслабления и покоя. У таких женщин

нет потребности в завершающих ласках, а при повторном коитусе (через небольшой промежуток времени) далеко не всегда происходит нарастание полового возбуждения до уровня, способного вызвать новую оргастическую разрядку.

Многократный оргазм. Мультиоргастичные женщины при адекватной сексуальной стимуляции способны испытывать многократные оргазмы, длительно не выходя из фазы возбуждения. В одних случаях женщина испытывает потребность в оргастической серии (до 10 оргазмов и более), причем в ходе полового акта яркость и интенсивность каждого из них слабее, чем при однократном (пикообразном) оргазме. Первые оргазмы такой серии возникают чаще и проявляются ярче, последующие - через все большие промежутки времени и с меньшей интенсивностью, вплоть до полного удовлетворения женщины. В других случаях яркие оргастические разрядки чередуются с менее выраженными оргазмами без какой-либо четкой закономерности и больше связаны с нюансами сексуальной стимуляции и эмоциональным настроем женщины. Если мультиоргасти-ческие потребности адекватно не реализуются, то после коитуса у нее долго остается чувство неотреагированного

возбуждения, нередко перерастающее в телесный и душевный дискомфорт. Сексуальному партнеру такой женщины следует учитывать ее мультиоргастические запросы, которые в зависимости от ситуации могут быть удовлетворены в ходе повторных половых актов или петтинга. Однако даже ярко выраженная мультиоргастичность наблюдается не при каждом половом контакте, поскольку способность испытывать многократный оргазм во многом зависит от физического и психического состояния женщины в момент близости, характера межличностных и сексуальных отношений с партнером.

Затяжной (волнообразный) оргазм. Возникает у женщин из-за очень низких порогов возбудимости вследствие патологии глубинных структур мозга. Такой оргазм легко начинается при любой форме сексуальной стимуляции, включая экстракоитальную, и может длиться до десятков минут. Половое возбуждение без дополнительной стимуляции (или при ее периодическом возобновлении) с интервалами в несколько секунд волнообразно колеблется от фазы плато к оргазму и обратно. Такие, не поддающиеся подсчету оргазмы, не дают полного удовлетворения, поэтому нередко эти женщины предъявляют жалобы на отсутствие сексуальной разрядки. Они отмечают чрезвычайно сильное и длительное половое возбуждение, которое периодически сопровождается подергиваниями мышц промежности и других мышечных групп, ожидая чего-то большего, но именно так чаще всего и проявляется данная форма оргазма. При обследовании женщин с волнообразным оргазмом обычно выявляют признаки органического поражения головного мозга (отдаленные последствия родовой травмы, перенесенной нейроинфекции и т. п.).

Стертый (редуцированный) оргазм. Легко возникает у женщины из-за очень низкого порога оргастического рефлекса еще на этапе предварительных ласк или при первых же фрикциях. Поскольку это происходит очень быстро, а сладострастные ощущения выражены слабо, у таких женщин нередко вообще отсутствует чувство переживания оргазма и они могут предъявлять жалобы на неспособность достигать сексуальной разрядки. Данное состояние может быть расценено как женский аналог наиболее выраженных случаев преждевременной эякуляции у мужчин.

Если первые два варианта оргастической разрядки у женщин относятся к норме, то наличие затяжного или стертого оргазма в ряде случаев требует специальной коррекции.

Следует также иметь в виду, что у женщин наличие или отсутствие оргазма не всегда напрямую коррелирует с удовлетворенностью половым сношением. Есть женщины, которые никогда не испытывали оргазма, но это их совершенно не тяготит и половая жизнь доставляет удовольствие. Обычно таких женщин связывает с партнером сильная эротическая любовь, тесные межличностные отношения либо по крайней мере мужчина вполне удовлетворяет ее многочисленные несексуальные потребности. Кроме того, если сексуальный партнер в состоянии обеспечить женщине достаточную длительность полового акта (свыше 10 - 15 минут) или иной формы сексуальной стимуляции, то в большинстве случаев происходит своеобразное «сенсорное насыщение» и у нее часто возникает удовлетворенность близостью, несмотря на отсутствие разрядки. По данным одного из опросов, около 30 % американских женщин не видят в длительном отсутствии оргазма никакой проблемы и считают свою сексуальную жизнь вполне удовлетворительной и счастливой. Наоборот, в случаях нарушений эмоциональной связи между партнерами женщина может более или менее регулярно достигать оргазма при половом акте, но это не приносит полного сексуального удовлетворения, поскольку она негативно воспринимает все, что связано с конфликтными партнерскими отношениями.

Мужской оргазм носит кратковременный (пикообразный) характер, после которого обычно возникает рефрактерный период. Только у некоторых молодых мужчин период половой невозбудимости практически отсутствует, что позволяет им продолжать половой акт после эякуляции и достигать нового оргазма.

Оргазм у мужчин отличается от женского оргазма наличием двух стадий. На первой стадии происходит сокращение семявыносящих протоков, семенных пузырьков и простаты, а у мужчины возникает ощущение неизбежности эякуляции. На второй стадии оргазма к ним дополнительно присоединяются сокращения уретры и полового члена, вызывая семяизвержение, которое в абсолютном боль-

шинстве случаев сопровождается оргастическими переживаниями. Хотя, как правило, эякуляция и оргазм происходят одновременно, эти процессы не следует смешивать. Оргазм обеспечивает снятие накопленного сексуального напряжения и связан с интенсивными психическими переживаниями. Эякуляция - это выделение семени, которое при некоторых неврологических и психических расстройствах может и не сопровождаться оргазмом. В то же время оргазм без эякуляции часто наблюдается при мастурбации у мальчиков, не достигших половой зрелости и лиц, употребляющих наркотики. Отсутствие семяизвержения при сохранном оргазме возможно при ретроградной эякуляции, когда происходит заброс спермы в мочевой пузырь, а также при малом количестве эякулята в пожилом возрасте. По мнению Г. Келли, для небольшого числа мужчин существует возможность испытывать два оргазма и более, прежде чем произойдет эякуляция. Вероятно, это связано с овладением ими навыками мышечного контроля, которые позволяют ощущать некоторые внутренние сокращения и оргастические переживания, не допуская наступления эякуляции. Последнее обстоятельство также указывает на относительную независимость мужского оргазма и эякуляции.

Оргазническая дисфункция является наиболее частым расстройством половой сферы у женщин. По данным А. Кинзи, не испытывали оргазм 17 % женщин, живущих половой жизнью не менее 5 лет. З.В. Рожановская и А.М. Свядощ установили, что в первые 3 месяца после замужества оргазм испытывали только 22 % женщин, к концу первого года супружества - 42 %, через 5 лет замужества - 72 %, а в сроки свыше 10 лет после начала регулярной половой жизни - 89 %. Причем, впервые оргазм возник у 30 % женщин вскоре после родов, у 11 % - значительно позднее родов, а у 18 % - при смене сексуального партнера.

У женщин различают абсолютную и относительную аноргазмию. Абсолютная - носит тотальный характер, т. е. оргазм не возникает при эротических сновидениях, мастурбации, петтинге или половом акте с любым партнером, а также в иных сексуально-возбуждающих ситуациях. Если женщина способна хотя бы эпизодически достигать оргазма в ходе мастурбации, во сне либо при половой

близости, но он отсутствует при сексуальном контакте с определенным партнером, это - относительная аноргазмия. Кроме того, выделяют первичную аноргазмию - с самого начала половой жизни - и вторичную - развивается после периода, когда женщина испытывала оргазм.

Многие женщины не считают длительное отсутствие оргазма серьезной проблемой. Однако достаточно часто затрудненное и редкое возникновение оргастической разрядки или ее полное отсутствие (при том, что чувство оргазма знакомо женщине, а при половом акте она испытывает возбуждение) приводит к нарастающей неудовлетворенности сексуальной связью и охлаждению к партнеру. Аноргазмия может вызывать у женщины раздражение, тревогу, беспокойство, вплоть до развития невротических расстройств, а в гинекологической сфере - описанный Х. Каплан (1974) синдром застойной гиперемии тазовых органов, который способствует развитию воспалительно-дегенеративных процессов яичников, матки, влагалища и окружающих тканей.

Среди органических причин, способных блокировать возникновение оргазма у женщины, можно выделить следующие: сахарный диабет или заболевания щитовидной железы; различные неврологические нарушения; гормональная недостаточность; патология органов малого таза; токсические влияния (алкоголь, наркотики), прием лекарственных средств, тормозящих оргазм (транквилизаторы, антидепрессанты, гипотензивные препараты) и т. п.

Психогенные формы женской аноргазмии встречаются чаще, чем органические. Выделяют ряд негативных психологических факторов, которые, сочетаясь друг с другом, способны привести к невротическому подавлению оргазма у женщины. Это неадекватная контрацепция и боязнь наступления беременности; неблагоприятные условия для сексуального контакта; ложные и негативные установки до отношению к сексуальной жизни и к мужчинам; страх утраты контроля во время оргазма; тревожное ожидание наступления оргазма; вытесненный в бессознательное травматический сексуальный опыт, который может тормозить чувственность женщины. Существенную роль в возникновении женской аноргазмии играют партнерские проблемы: мужчина не создает женщине благоприятных условий для

переживания оргазма при недостатке у него сексуального опыта, что проявляется в неумении обеспечить эффективную эротическую стимуляцию; если он страдает сексуальной дисфункцией, затрудняющей нормальное проведение коитуса; эгоистическое стремление мужчины добиться собственного удовлетворения при игнорировании потребностей женщины; если в выборе партнера женщина руководствовалась неэротическими мотивами (обеспечение высокого материального достатка, престиж, стремление к абсолютному подчинению себе мужчины, брак по настоянию родных и т. д.); партнерские конфликты, связанные с изменами или алкоголизацией супруга, его постоянной занятостью на работе, высокомерно-пренебрежительным отношением к личности женщины и ее интересам (вызывают у женщины неприязнь к сексуальному партнеру).

При невротическом подавлении оргазма оргазмическая дисфункция у женщин чаще носит вторичный характер, развиваясь после периода относительно нормального сексуального функционирования. В этих случаях половое влечение сохраняется достаточно долго или незначительно снижается, а эрогенные зоны - чувствительны. Женщины отмечают эротические сновидения с оргазмом, возможен мастурбационный оргазм. Расстройство носит относительный характер, избирательно проявляясь с определенным партнером, при отсутствии аноргазмии с другим мужчиной, способным адекватным образом удовлетворить эмоциональные и сексуальные потребности женщины. Эротическая стимуляция приводит к высокому уровню полового возбуждения, но, по словам женщин, «что-то мешает закончить», «что-то не срабатывает» и вместо разрядки она испытывает сексуальную фрустрацию, хотя ранее и была способна к оргазму с этим же партнером. Психогенные факторы, которые привели к исчезновению оргазма, требуют выяснения и соответствующей психотерапевтической коррекции.

М.В. Екимов (1999), наряду с невротическим подавлением оргазма, выделяет и другой вариант женской аноргазмии - обусловленный «неадекватно развитой сексуальностью». В этих случаях женщины жалуются, что почти ничего не чувствуют, не могут возбудиться. Сексуальная фрустрация выражена слабо или вовсе отсутствует. У них

имеется значительное расхождение между индивидуальными предпочтениями и реальным сексом. Это несоответствие может касаться как сексуального сценария, так и механических стимулов. Характер некоторых форм мастурбаторной стимуляции (при ритмичном сжимании бедер, под струей душа) настолько специфичен, что их невозможно воспроизвести при коитусе, поэтому женщина не в состоянии достигнуть с сексуальным партнером привычных ощущений и оргазма. Если женщина не способна испытывать оргазм вообще или не достигает его при сексуальном контакте, считая это серьезной проблемой в личной жизни, требуется помощь сексолога. Оргазм - сложный психовегетативный рефлекс. В норме формирование оргастических навыков происходит самостоятельно, как один из процессов психосексуального развития. Но если механизмы оргазма сами не сформировались либо имеется жесткая фиксация на одной из форм мастурбации (например, под душем), необходимо помочь женщине развить адекватные оргастические навыки. До сих пор окончательно не установлено, почему у некоторых женщин так и не происходит самостоятельного формирования механизмов оргазма. Возможно, определенную роль играет конституционально-биологическая предрасположенность. Вместе с тем секс-терапевтическое лечение, не воздействующее непосредственно на биологические факторы, во многих случаях позволяет женщине научиться достигать оргазма.

Между двумя основными формами аноргазмии есть ряд переходных вариантов. Так, если при невротическом подавлении оргазма ситуация не имеет благополучного исхода, на фоне нарастающего дискомфорта от постоянных сексуальных фрустраций срабатывает психологическая защита и стимулы, которые ранее возбуждали женщину, но не приводили к оргазму, перестают быть таковыми. Женщина начинает «привычным образом» не возбуждаться в тех ситуациях и от тех воздействий, которые прежде действовали возбуждающе, как это бывает при «неадекватно развитой сексуальности».

Стойкое отсутствие оргазма у мужчин встречается нечасто и может быть обусловлено как психологическими, так и органическими причинами. Поскольку оргастические переживания у мужчин тесно связаны с эякуляцией,

абсолютное большинство случаев мужской аноргазмии сопряжено с неспособностью эякулировать при половом контакте и/или мастурбации. Нарушение процесса семяизвержения при сохранном оргазме возможно в случаях ретроградной эякуляции, когда в силу органической патологии происходит заброс спермы в мочевой пузырь, а также вследствие гормональной недостаточности, когда эякулята вырабатывается столь мало, что он наружу не выбрасывается. Органические причины стертого оргазма или его отсутствия у мужчин - повреждение проводящих нервных путей от гениталий до корковых центров, а также колликулит, т. е. воспаление семенного бугорка. По данным У. Мастерса и В. Джонсон, неспособность испытывать оргазм и эякулировать во влагалище с самого начала половой жизни отмечается примерно у двух третей пациентов с жалобами на отсутствие семяизвержения и оргазма при коитусе. Такие психогенные анэякуляторные расстройства обусловлены *задержками психосексуального разбития.* В результате у мужчин формирование сексуального влечения надолго задерживается на эротической стадии, а половую жизнь они начинают значительно позднее других (после 20 - 22 лет). Наибольшее удовольствие при близости им доставляют взаимные ласки, а коитальные фрикции лишь слегка приятны и проводятся в основном для женщины. Мужчина безболезненно для себя может в любое время прервать коитус по просьбе партнерши либо по собственной инициативе. Незавершенные (без эякуляции) половые акты провоцируют ночные поллюции, которые являются единственным источником семяизвержения. Аноргазмия, равно как и полное отсутствие половой жизни, переносятся такими пациентами легко, а основная причина обращения за помощью к специалистам - бесплодие в браке. Психогенное анэякуляторное расстройство может носить относительный характер, когда оно связано с прочной фиксацией на специфических ощущениях при мастурбации либо других видах стимуляции, например орально-генитальной. При этом мужчина способен привычным для него образом достигать эякуляции и оргазма, но при половом акте семяизвержение у него отсутствует либо в более легких случаях требует чрезвычайных усилий. К другим психологическим причинам торможения эякуляции и оргазма у мужчины от-

носят половые контакты с партнершей, которая не вызывает сексуального влечения либо угнетает его эротические эмоции своей холодностью, откровенной демонстрацией нежелания близости. К органическим нарушениям эякуляторного рефлекса относятся спинальные травмы и другие неврологические расстройства, некоторые операции (простатэктомия, симпатэктомия), опухоли гипофиза. Эякуляция и оргазм могут быть блокированы приемом некоторых психотропных препаратов или гипотензивных средств, а также употреблением мужчиной наркотиков.

Обследование. У лиц обоего пола проводится стандартное сексологическое обследование. Особое внимание уделяют сбору сексологического анамнеза (особенности психосексуального развития, сексуальный дебют, последующий опыт, представления о норме, физиологии и психологии половой жизни, выявление латентных тенденций сексуального влечения, выяснение наличия оргазма при других видах стимуляции - мастурбации, петтинге, при эротических сновидениях). У женщин собирают подробный акушерско-гине-кологический анамнез (для исключения органической природы расстройства - гормонального дисбаланса, воспалительных заболеваний и пр.); определяют эрогенные зоны и их реактивность.

Дополнительное обследование: парное психологическое тестирование для выяснения взаимоотношений между партнерами, их ценностных ориентации; консультации гинеколога, невролога.

Терапия аноргазмии. Основной метод лечения первичного анэякуляторного расстройства у мужчин - психотерапия с проведением курса вибростимуляции полового члена до получения эякуляции и оргазма.

У женщин лечение аноргазмии проводится с учетом механизмов ее развития. При психогенных формах и у мужчин, и у женщин основная роль принадлежит методам психотерапевтической коррекции. Выявление органической патологии, затрудняющей возникновение оргазма, предполагает проведение соответствующего лечения. Цель лечения - восстановление или приобретение способности испытывать оргазм при половом акте. При аноргазмии на фоне органической патологии или психического расстройства проводится лечение основного заболевания.

При психогенной (невротической) аноргазмии у женщин индивидуальная и парная психотерапия, направленная на повышение интереса к половой жизни и сексуальной предприимчивости, улучшение межличностных и сексуальных отношений с партнером. Особое значение имеет выявление, переработка и нейтрализация травматического опыта (факт обнаружения измены, травма сексуального насилия, высказывания актуального партнера, оскорбительные для женщины, и т. п.). Нередко успешная переработка ключевых психотравм в трансовой модели (с использованием возрастной регрессии) либо в технике ДПДГ (работа с отдельным травматическим воспоминанием) достаточно быстро приводит к устранению своеобразного функционального кинестетического блока и восстановлению специфической чувствительности эрогенных зон женщины. В необходимых случаях может применяться секс-терапия с использованием чувственного фокусирования, вибростимуляции эрогенных зон и пр.).

У женщин с психогенной аноргазмией вследствие «неадекватно развитой сексуальности» лечебные мероприятия концентрируются на формировании адекватных оргастических навыков. С этой целью используется секс-терапия (см. ниже), техники телесно-ориентированной терапии, приемы биосинтеза. В числе последних техники, направленные на снятие напряжения сильно «зажатых» мышц, работа с прикосновениями и их позитивной интерпретацией, стимуляция паттернов гармоничного дыхания, ведущего к эмоциональному равновесию, работа с контактом глаз, взглядом, голосом, дающая паре опыт невербального выражения эмоций и отношений, укрепляющая взаимопонимание. В отдельных случаях применяют адаптогены, кремы, повышающие эрогенную чувствительность и реактивность, методы рефлексотерапии (акупунктура, аурикулотерапия, традиционный восточный массаж).

Х. Каплан (1987) рекомендует секс-терапию всем женщинам, испытывающим проблемы с достижением оргазма. Следует отметить, что для части из них, включая их мужей, клиторальная самостимуляция является вполне приемлемой формой достижения женщиной удовлетворения, и в подобных случаях вполне можно ограничиться консультацией пары. Но для ряда женщин отсутствие оргазма при

половой близости является результатом подавления оргастической реакции или следствием плохой техники секса. У них секс-терапия может оказаться весьма эффективной.

Секс-терапевтическая стратегия лечения абсолютной (полной) аноргазмии (по Х. Каплан, 1987)

Включает несколько последовательных этапов: 1) достижение оргазма при мастурбации; 2) оргазм в присутствии партнера посредством клиторальной стимуляции; 3) оргазм в ходе сношения; 4) прием «мост».

Основной принцип достижения оргазма заключается в усилении сексуального возбуждения при ослаблении его подавления. Эффективным способом, ослабляющим подавление, является маструбация, которую женщина проводит в одиночку. При этом она не испытывает давления со стороны партнера. В необходимых случаях следует помочь женщине преодолеть чувство вины и стыда по поводу мастурбации.

Женщины, никогда ранее не имевшие оргазма, часто опасаются возможных ощущений и собственных реакций. Им предлагают рассказать о своих фантазиях, связанных с оргазмом: «Что может произойти?», а затем провести их анализ и обсуждение. Наиболее типичные страхи: «Я потеряю контроль над собой», «Я с ума сойду», «Мне это причинит вред... », «Мне это понравится и я стану неразборчивой». Большинство подобных страхов связаны с подавлением и запретами сексуальности. Необходимо их развенчать. Иногда женщина испытывает вину и переживает смешанные чувства по поводу удовольствия и возможного достижения оргазма, который для нее представляется пределом ее успеха (возникает «конфликт успеха). В этих случаях она должна получить заверение в том, что достижение оргазма не приведет к немедленному разрешению всех ее проблем. Лишь после этого ей рекомендуется испытать свой первый оргазм путем мастурбации. Поскольку эротические фантазии способствуют возбуждению и одно-временно отвлекают от тревожных мыслей, пациентку следует активно поощрять к переживанию фантазий во время мастурбации. Иногда женщине рекомендуют приобрести

эротическую литературу или соответствующую видеопродукцию, чтобы проверить, какие картины, способы, ситуации способствуют ее возбуждению. Стимуляция клитора пальцем в сочетании с эротическими фантазиями довольно быстро (как правило, за несколько недель) приводит к оргазму. Если эффект от этой формы стимуляции слабый, предлагается воспользоваться вибратором. Бытовой электромассажер является более мощным и эффективным, чем аппараты фаллической формы на батарейках. Пациентке рекомендуется проводить вибратором вокруг и вблизи области клитора, сосредоточившись на эротических фантазиях. Это необходимо, чтобы «отвлечь себя от того, что обычно отвлекает от оргазма», т. е. отвлечься от привычки самоконтроля в ходе стимуляции и оргазма. В некоторых случаях помогает просмотр во время самой стимуляции эротических картинок или эротических фильмов.

Некоторым женщинам приходится стимулировать себя долгое время, иногда около одного часа, чтобы добиться наступления оргазма. Для них особенно важны поощрение и поддержка терапевта. Имеется несколько приемов, облегчающих наступление оргазма у женщины: попеременное сжатие и расслабление мускулатуры влагалища; энергичные движения тазом и глубокое дыхание на фоне сильного возбуждения. Если интенсивная стимуляция вызывает сильное напряжение, рекомендуется приостановить ее на несколько секунд, а затем возобновить снова. Несколько повторений этого приема «стол-старт» нередко бывают эффективными. Все эти в какой-то степени механические приемы облегчают наступление оргазма, отвлекая женщину от привычных способов его подавлять. Весьма полезным «отвлекающим» фактором являются эротические фантазии.

Оргазм в присутствии партнера. После того, как женщина освоилась с ощущениями от оргазма при мастурбации в одиночку, она должна его добиться в присутствии супруга. Это непросто, поскольку присутствие партнера провоцирует тревогу. Возникает страх неудачи: «Смогу ли я достичь оргазма? А если ему надоест картина однообразной стимуляции? А если другие женщины делают это быстрее?». В достижении целей этого этапа возможны варианты. Один из них заключается в том, что супружеской

паре предлагается делать все как обычно. После того, как мужчина эякулирует сам, он вызывает оргазм партнерши мануально. Она получает установку на переживание тех же фантазий, которые ранее использовала при мастурбации. Женщина проводит сокращения мышц, глубоко дышит, погружаясь в свои любимые фантазии, а мужчина ее возбуждает. Нередко таким способом женщина достигает оргазма. Если женщина слишком отстает по темпу возбуждения от мужчины либо стесняется попросить мужчину о стимуляции клитора, ей рекомендуют самой проводить мастурбацию в присутствии партнера. Некоторые пары достаточно свободны от предрассудков, чтобы принять такое предложение терапевта. Но нередко женщины испытывают чувство смятения и стыда при мысли о мастурбации в присутствии мужа. Но чаще мужья нормально реагируют на это предложение. Более того, вид мастурбирующей жены возбуждает большинство мужчин.

Секс-терапевтическая относительной (неполной) аноргазмии (по Х. Каплан, 1987)

Неспособность переживать оргазм во время коитуса - самая распространенная жалоба женщин. Это объяснимо, поскольку с анатомической точки зрения коитус не является самым удачным способом возбуждения области клитора. Психологически половое сношение следует рассматривать как крайне возбуждающее и эмоционально привлекательное. Однако коитальная стимуляция клитора является менее сильной, чем непосредственное воздействие на него, например при мастурбации. Поэтому женщины с относительно низким порогом оргастического рефлекса могут достигать оргазма исключительно в ходе коитуса (по некоторым данным, в США их около половины). Другим же физиологически требуется более интенсивная, по сравнению с возможностями коитуса, стимуляция клитора. Еще часть женщин имеет психогенные расстройства оргазма. Высокие пороговые характеристики достижения оргазма могут быть вызваны пси-

хологическими запретами и подавленной сексуальностью либо носить конституционально-генетический характер.

В секс-терапии относительной аноргазмии используются приемы чувственное фокусирование I, II и необязы-

вающий коитус. Однако принципиальным моментом решения данной проблемы является возможность достигать оргазма в ходе полового акта. Для этого Х. Каплан предложила специальный *прием «мост»,* который показан женщинам, испытывающим оргазм при клиторальной стимуляции, но не достигающим его во время сношения. Большинство женщин с относительной аноргазмией испытывают оргазм если клиторальное возбуждение не прекращается в то время, как половой член находится во влагалище. Женщины испытывают огромное удовольствие от такого приема, так как ощущение оргазма приобретает особую четкость, если эрегированный член в это время остается во влагалище. Но постоянное использование этого приема может оказаться утомительным для ее мужа. Подобная активность также редко приводит к истинно коитальному оргазму. Сущность приема «мост» заключается в том, чтобы продолжать стимуляцию клитора до момента, предваряющего оргазм, после чего он должен быть «запущен» фрикциоными движениями. Здесь речь идет именно о моменте, предваряющем оргазм, а не о том, который становится «пусковой точкой» самого оргазма. Таким образом, между стимуляцией клитора и собственно коитусом образуется своего рода связующий мост.

Стимуляция клитора может осуществляться как мужчиной, так и самой женщиной в зависимости от ситуации. Обычно во время начальных попыток осуществления приема «мост» женщине предлагают самой заняться стимуляцией клитора. Ее самостимуляция мужчину не утомляет и не отвлекает, женщина при этом имеет больше возможностей для контроля стимуляции и осознания получаемого наслаждения, ей не приходится волноваться за то, партнеру это надоело или у него устала рука. Основное условие в выборе поз, занимаемых партнерами при выполнении приема «мост», - это свободный доступ руки к области клитора.

«Мост» используется только после того, как женщина уже испытала интенсивные вагинальные ощущения от предшествующих упражнений. Имеется два типа (по характеру источника) эротических ощущений, исходящих от влагалища: тактильные и проприоцептивные. Две трети

поверхности стенок влагалища не содержат осязательных волокон: они преимущественно нечувствительны. Одна-

ко область входа во влагалище и еще 1/3 его поверхности особо чувствительны к тактильной стимуляции, способной привести сексуально чувствительную женщину к переживанию оргазма.

Ощущения от сокращения мускулатуры вагинальной области образуют еще одну составляющую эротической чувствительности. Пролонгированный необязывающий коитус в сочетании с упражнениями лонно-копчи-ковой мускулатуры особенно полезны для более четкого восприятия вагинальных ощущений женщинами, у которых эти ощущения были в прошлом заторможены. Изредка эти «обостренные» ощущения, вызванные предшествующими тренировками, приводят к спонтанному переживанию коитального оргазма. Но, как правило, их бывает недостаточно, и тогда рекомендуется «мост». Паре предлагают после предварительных ласк начать половой акт в удобной для «моста» позе (лучше женщина сверху). Рекомендуется совершать неспешные фрикции, чтобы женщина могла сосредоточиться на своих ощущениях, а затем начала бы возбуждать клитор пальцем так, как она это обычно делает наедине с собой. (Установку можно изменить с тем, чтобы возбуждал мужчина или использовался вибратор, который представляет собой весьма эффективное средство достижения оргазма во время коитуса. Недостаток его использования заключается в нежелании некоторых пар использовать это механическое устройство во время сношения.)

Женщина должна сосредоточить свое внимание на возбуждающих фантазиях. Как только она почувствует приближение оргазма, следует немедленно прекратить стимуляцию и резко надвинуться на партнера. Такое прерывание может временно затормозить приближение оргазма. Это нормально. Необходимо повторить все снова. И как только женщина почувствует приближение оргазма, стимуляция прекращается и ей следует снова быстро и резко надвинуться на партнера. Так повторяют несколько раз, пока не наступит оргазм. Если у мужчины эякуляция происходит раньше, пара может повторить «мост» в следующий раз.

Реакции на «мост». Обычной реакцией супружеской пары на успешную реализацию «моста» является расслабление и воодушевление. Ведь нередко женщины с коиталь-

ной аноргазмией чувствуют свою ущербность и неполноценность по сравнению с теми особами, которые достигают оргазма во время сношения. Это во многом связано с тем, что мужчины часто склонны к эмоционально обостренному переживанию аноргазмии своих жен. Так неуверенные в себе мужчины связывают отсутствие оргазма при коитусе с собственными неумелыми действиями или «недостатками» своего пениса. По этой причине так распространено явление имитации оргазма во время полового акта. Некоторые женщины считают, что легче обойтись без оргазма и симулировать его, чем открыто признать клиторальный источник его возникновения.

Прием «мост» эффективен не более чем у половины женщин. Остальные получают хороший способ достижения оргазма с введенным во влагалище половым членом, что доставляет наслаждение обоим партнерам. Эти женщины сохраняют потребность в непосредственной стимуляции клитора во время полового акта до наступления оргазма.

Нередко установка женщины по отношению к коитальному оргазму настолько эмоционально заряжена, что необходима более глубокая проработка. Переживание оргазма приводит к сладострастным ощущениям, независимо от типа оргазма или его источника. При идеальной ситуации супружеские пары не рассматривают внекоитальный оргазм как «менее полноценный». Любящие пары, где у обоих партнеров есть чувство психологической безопасности, приходят к гармоничной и полноценной половой жизни и в том случае, когда женщине требуется предварительная стимуляция клитора для достижения оргазма.

В процессе секс-терапии женщина учится учитывать свои сексуальные потребности и принимает на себя ответственность за собственное половое удовлетворение. Это означает, что если раньше в половом акте женщина действовала в большей мере отвечая на эротические запросы и прихоти супруга, то сейчас она занимает позицию сверху, двигаясь вдоль фаллоса в соответствии с собственными вагинальным ощущениями. Переход женщины от пассивного к активному состоянию может вызывать различные реакции у ее партнера. Любящие и уверенные в себе мужчины, испытывают радость за

партнершу и наслаждаются ее возросшей сексуальной активностью. Другие выражают опасение и неудо-

153

вольствие, поскольку эти изменения в поведении жены могут ассоциироваться со страхом потери контроля и даже со страхом причинения физического вреда действиями супруги. Некоторые мужчины осознают свои страхи и открыто делятся своими опасениями. Другие же не проявляют видимых признаков беспокойства, но внезапно теряют потенцию и интерес к сексу. В целом, если мужчина не испытывает беспокойства по поводу собственных сексуальных возможностей, он позитивно реагирует на происходящие изменения. Также очень важно убедить партнеров, что для успешного разрешения сексуальных затруднений женщины необходимо взаимное признание ее эротических потребностей и желаний. Неспособность мужа признать сексуальную «анатомию» своей супруги могут стать препятствием на пути к полноценной половой активности женщины.

F52.4. Преждевременная эякуляция

Невозможность контролировать эякуляцию в той мере, которая достаточна, чтобы оба партнера получили удовлетворение от полового акта.

Исключаются:

- преждевременное семяизвержение, обусловленное болезнями мужских половых органов (N40 - N51);
- преждевременное семяизвержение, обусловленное органическим поражением головного мозга (F06.82x).

F52.41. Абсолютное ускорение семяизвержения

Критерии диагностики: продолжительность полового акта менее одной минуты (менее 20 фрикций) на фоне регулярной половой жизни.

F52.42. Относительное ускорение семяизвержения

Критерии диагностики: продолжительность полового акта в пределах физиологической нормы (от 1 до 3 минут).

154

Однако этой продолжительности полового акта недостаточно для получения оргастической разрядки партнершей.

F52.49. Ускорение семяизвержения неуточненное

Включается:
- преждевременная эякуляция без дополнительных уточнений (БДУ).

Ускоренная эякуляция является одной из наиболее частых сексуальных проблем мужчин. У. Мастерс и В. Джонсон (1983) полагают, что по крайней мере 15-20 % американцев испытывают трудности при попытках контролировать быструю эякуляцию, однако далеко не каждый из них обращается за помощью к специалистам. Так, согласно данным опроса NHSLS (1994), 30 % мужчин сообщили, что оргазм у них наступает слишком рано. В обследовании К. Штарке и В. Фридриха (1987) из 78 % мужчин в возрасте до 30 лет, которые смогли указать среднюю продолжительность полового акта, у 7 % она была до 1 минуты, у 23 % - до 3 минут, у 40 % - 4 - 10 минут, у 7 % - свыше 10 минут, у 1 % - семяизвержение отсутствовало.

Следует признать, что на сегодняшний день среди исследователей не существует общепринятого определения преждевременной эякуляции. Так, Г. Келли (2000) отмечает, что границы между нормой и патологией здесь не абсолютны и во многом культурально обусловлены. Он приводит такой пример. Если эякуляция у мужчины из Ист-Бей (Меланезия) происходит более чем через 30 секунд после введения полового члена во влагалище, местные жители считают такой половой акт чрезмерно длительным, что воспринимается ими как отклонение от нормы.

Наряду с подходом, представленным в адаптированном варианте МКБ-10, существуют и другие трактовки ускоренного семяизвержения. Например, Ло Пикколо (1978), основываясь на статистических данных обследования 1000 супружеских пар, считает, что лечение показано

мужчинам, у которых половой акт длится менее 4 минут. В 1970 году У. Мастерс и В. Джонсон высказали мнение, что если мужчина эякулирует раньше, чем партнерша успевает достичь

оргазма по крайней мере в 50 % случаев половых сношений между ними, то он страдает преждевременной эякуляцией. Однако впоследствии Мастерс и Джонсон (1991) сами же признали такое определение неудачным. В частности, оно неприменимо к ситуациям, когда женщина вообще редко испытывала оргазм или никогда не имела его во время коитуса. Х. Каплан (1974, 1987) связывает с понятием преждевременного семяизвержения отсутствие произвольного контроля над эякуляторным рефлексом. Она полагает, что в норме мужчина способен научиться длительно переносить высокую степень полового возбуждения без возникновения рефлекторной эякуляции. Однако большинство специалистов считает, что полный произвольный контроль над эякуляцией - скорее исключение, чем правило, поэтому связывать его с нормой весьма проблематично (С. Кратохвил, 1982; У. Мастерс, В. Джонсон, 1983 и др.). В последнее время получила распространение точка зрения, согласно которой к половым расстройствам следует относить случаи, когда обычно уже при минимальной сексуальной стимуляции семяизвержение у мужчины раз за разом наступает раньше, нежели его партнерша успевает получить удовлетворение от коитуса и если он настолько неспособен управлять процессом эякуляции, что один или оба партнера начинают рассматривать это как проблему (G. Grenier, E. Byers, 1997; M. Metz et al., 1997).

Диагностические критерии преждевременного семяизвержения, по версии Американской Психиатрической Ассоциации (АПА), следующие:

а) эякуляция наступает при минимальной сексуальной стимуляции до, в процессе или сразу после пенетрации до того, как этого хотелось бы партнерам;

б) нарушение семяизвержения приводит к проблемам в общении с половым партнером;

в) преждевременное семяизвержение не связано с прямым действием препаратов (например, эффект отмены опиоидов).

Следует отметить, что мужчины нередко испытывают чувство разочарования и неверия в свои силы из-за неспособности контролировать

наступление эякуляции, но поскольку оргазм по-прежнему доставляет им наслаждение, у них может не быть достаточной мотивации для обращения

к врачу с этой проблемой (M. Metz et al., 1997). В наибольшей степени страдают их партнерши, которые только начинают приходить в сексуальное возбуждение, когда у мужчины уже наступает эякуляция и половой акт заканчивается. Постоянные проблемы с преждевременной эякуляцией могут стать причиной конфликтов между сексуальными партнерами и повлечь за собой другие половые расстройства. Женщины, которые испытывают досаду, разочарование и физический дискомфорт из-за частых сексуальных фрустраций, могут потерять интерес к сексу и перестать испытывать возбуждение от него (Г. Келли, 2000). В ряде случаев попытки мужчины сознательно контролировать свое сексуальное возбуждение, чтобы не допустить быстрой эякуляции, настолько отвлекают его от полового акта, что это приводит к потере эрекции. Любые затруднения в возникновении и поддержании эрекции на фоне конфликтных отношений с партнершей легко фиксируются по невротическим механизмам, приводя к возникновению тревожного ожидания сексуальной неудачи, т. е. вторичной психогенной эрекционной дисфункции.

По некоторым оценкам 35 - 40 % мужчин, получавших лечение по поводу сексуальных расстройств, в основном жаловались на преждевременную эякуляцию (Г. Каплан, Б. Сэдок, 1996).

Несомненно, что при прочих равных условиях способность мужчины в достаточной мере регулировать длительность полового акта позволяет ему лучше подстроиться к партнерше и обеспечить удовлетворяющую ее сексуальную стимуляцию. Кроме того, при большей продолжительности полового акта мужчина и сам, как правило, испытывает более яркие и интенсивные оргастические переживания.

Функционально-психогенные причины преждевременной эякуляции:

1. Редкие половые акты, приводящие к сексуальной абстиненции и физиологически обусловленной повышенной возбудимости.

2. Тревога и страх во время полового акта, связанные либо с внешними факторами, либо с беспокойством и озабоченностью мужчины возможным неудовлетворением своей партнерши, а также проблемами супружеских отношений.

157

3. Привычка к быстрому наступлению эякуляции у молодых мужчин из-за неблагоприятных условий для проведения коитуса либо при длительных отношениях с фригидной женой, которая настаивает на быстром окончании коитуса.

4. Интенсивное, возбуждающее эротическое влияние партнерши (ее высокая активность во время коитуса или чрезвычайная сексуальная привлекательность для данного мужчины).

5. Установка на быстрое снятие собственного сексуального напряжения при отсутствии у мужчины желания доставить партнерше удовлетворение и безразличии к ее чувственным переживаниям.

6. Отсутствие осознания приближения эякуляции, которое позволяет мужчине вовремя предпринять какие-либо действия для пролонгации коитуса (связано с индивидуальной сверхчувствительностью симпатической нервной системы).

Органические причины преждевременной эякуляции:

- Заболевания предстательной железы застойного или воспалительного генеза.

- *Вторичная патогенетическая форма преждевременной эякуляции* (по Г.С.Васильченко). Является неврологическим осложнением хронического простата (региональный симпатоз). Основное отличие от чисто урологической патологии - сохранение ускоренной эякуляции после санации предстатель ной железы.

- *Первичная патогенетическая форма преждевременной эякуляции (синдром парацентралъных долек)* - представляет собой первичное поражение корковых центров регуляции урогенитальных автоматизмов в результате действия патогенных факторов в антенатальном периоде, при родовой травме, реже - при черепно-мозговых травмах, фактически речь идет о формировании очень низких порогов возбудимости эякуляторного

рефлекса, в силу чего эякуляция и оргазм у мужчины происходят при минимальной сексуальной стимуляции.

158

Основные диагностические критерии синдрома парацентральпых долек:

1. Первые эякуляции опережают по времени пробуждение либидо, подчас возникая у подростка в не адекватной обстановке (бег, испуг).

2. Наличие дневных поллюций (особенно неадекватных).

3. Частые ночные поллюции и поллюции после 40 лет.

4. Психическая мастурбация, когда эякуляция происходит только за счет эротических фантазий без механической стимуляции.

5. Ускоренная эякуляция с начала половой жизни.

6. Эякуляция уже при поверхностных ласках или попытке интроитуса.

7. Эякуляторная атаксия - повторные половые акты вначале не влияют на их продолжительность, а затем при очередном коитусе внезапно возникает анэякуляция.

8. Энурез в анамнезе, поскольку корковые центры мочеиспускания и эякуляции расположены рядом - в парацентральных дольках.

9. Отсутствие пролонгирующего коитус эффекта при употреблении алкоголя или использовании местно-анестезирующих мазей.

10. Наличие неврологической симптоматики: наиболее типичный признак - *инверсия рефлексогенных зон ахилловых рефлексов*, часто имеются непостоянная анизокория, симптомы орального автоматизма, признаки внутричерепной гипертензии.

Признаки преждевременной эякуляции психогенного генеза:

1. При коитусе сексуальное возбуждение у мужчины вначале нарастает постепенно, затем неожиданно резко усиливается и приводит к эякуляции.

2. Парадоксальная реакция - эякуляция наступает тем скорее, чем дольше мужчина стремится ее задержать.

3. Из-за повышенной нервной возбудимости семяизвержение наступает тем быстрее, чем слабее у мужчины эрекция (в норме чаще бывает наоборот).

4. Избирательность расстройства (с одной партнершей мужчина способен контролировать длительность коитуса, а с другой - нет).

159

5. Эротические сновидения, в которых нередко фигурирует преждевременная эякуляция (пациенты считают их свидетельством тяжести расстройства).

6. Атмосфера спешки и нервозности в ходе полового акта, необходимость быстрого выведения полового члена из влагалища при практике прерванного коитуса, что способствует усилению возбуждения и ускоряет наступление эякуляции, особенно у лиц с неуравновешенной нервной системой.

7. Спонтанные периоды удлинения коитуса (под влиянием ситуационных факторов, отдыха),

8. Наличие тревожно-невротической симптоматики.

9. Удлинение полового акта под влиянием транквилизаторов и алкоголя.

Синдром парацентральных долек классифицируется в адаптированной МКБ-10 как преждевременное семяизвержение, обусловленное органическим поражением головного мозга (F06.82), а ускоренная эякуляция при урогенитальной патологии как преждевременное семяизвержение, обуслов-ленное болезнями мужских половых органов (N40 - N51).

Отметим, что в настоящее время отсутствуют убедительные данные в пользу преобладающей роли как органических (возможно, конституциональных), так и психогенных факторов в патогенезе ускоренной эякуляции. Большинство зарубежных специалистов связывают преждевременное семяизвержение с наличием психологических причин (К. Имелинский, 1986; Х. Каплан, 1987; У. Мастерс и В. Джонсон, 1998 и др.) или указывают на отсутствие достоверных результатов исследований, которые могли бы объяснить, почему некоторым мужчинам трудно контролировать свою эякуляторную реакцию (M. Metz et al., 1997). В последние годы было высказано предположение, что преждевременная

эякуляция может быть вызвана нарушением нейротрансмиссии серотонинэргической 5-hydroxytrptamine (5-HT). Это привело к развитию таргетной терапии для лечения преждевременной эякуляции, которая направлена на изменение системы 5-HT.

Обследование пациентов с преждевременной эякуляцией включает стандартное сексологическое обследование. Анамнез подразумевает выявление детского энуреза. Нев-

рологический осмотр акцентирует внимание на асимметрии иннервации (анизокория, инверсия рефлексогенных зон ахилловых рефлексов). При урологическом обследовании прежде всего необходимо исключить воспалительные процессы урогенитального тракта, в том числе простатит.

Дополнительные обследования: УЗИ простаты, консультации уролога, невролога, краниография, КТ, психодиагностика.

Лечение имеет своей целью восстановление или приобретение способности в достаточной мере контролировать наступление эякуляции в соответствии с партнерской ситуацией. Выбор терапии определяется в соответствии со степенью выраженности дисфункции, а также длительностью расстройства и сопутствующей психопатологической (урологической либо неврологической) симптоматикой. При наличии обострения хронического простатита на начальном этапе лечения проводится санация предстательной железы. На фоне 3 - 4 недельного курса кломипрамина, флувоксамина или сертралина непосредственно перед коитусом используют местно анестезирующие средства (например, орошение нижней части головки пениса аэрозолем 10 % раствора лидокаина. Показана массивная рефлексотерапия от массажа предстательной железы (6-15 процедур через день) и орошения хлорэтилом ромба Михаэлиса (6-12 процедур) до аурикулотерапии (основные точки 22 и 93) и акупунктуры (седатируют точки R3; R26; F8; RP6; V23; V35; VC4; VC5 и др.). Все терапевтические процедуры проводятся на фоне регулярной половой жизни.

Психотерапия направлена на снижение тревоги перед коитусом (гипнотерапия, техники НЛП, ДПДГ), улучшение межличностных и сексуальных отношений в паре (приемы супружеской и сексуальной терапии). Самостоятельно или в комбинации с антидепрессантами группы СИРС могут использоваться специальные секс-терапевтические упражнения (техники «сжатие головки», «стоп-старт»).

F52.5. Вагинизм неэротического происхождения

Спазм окружающих влагалище мышц, вызывающий окклюзию его открытия. Введение полового члена или не-

возможно, или причиняет боль. Вагинизм может быть вторичной реакцией на локально обусловленную боль, в таком случае настоящая рубрика не должна использоваться.

Диагностические критерии.

Вагинизм, т. е. спазм перивагинальной мускулатуры, проявляется в одном из следующих вариантов:

1) нормальная реакция всегда отсутствовала;

2) расстройство появилось после периода относительно нормального сексуального функционирования.

Причем:

а) сексуальные реакции могут протекать нормально при отсутствии попыток проникновения во влагалище;

б) каждая попытка полового сношения ведет к генерализованной тревоге и попыткам воспрепятствовать введению члена, в том числе за счет приведения и сжатия бедер.

Включается:

- психогенный вагинизм.

Исключается:

- вагинизм (органический) (N94.2).

В литературе обычно подчеркивается, что женщины, страдающие вагинизмом, очень часто имели негативный ранний сексуальный опыт. Например, для тех, кому говорили, что первое половое сношение может вызвать сильную боль и кровотечение при наличии неповрежденной девственной плевы, оно может стать мучительным испытанием (Г. Келли, 2000). Среди причин вагинизма указывают сексуальное насилие в прошлом, грубое поведение партнера при попытке дефлорации, страх перед возможной беременностью, строгое религиозное воспитание и т. п. И.Л. Ботнева (1990)

отмечает, что чаще вагинизм возникает при нерешительном, робком и неумелом поведении партнера и определенных чертах характера женщины (мнительность, эмоциональная неустойчивость, обидчивость, тревожность). Нередко у таких женщин в анамнезе прослеживаются различные фобии, в том числе страх боли либо вида крови.

Вагинизм обычно возникает с началом половой жизни. Судорожному сокращению мышц влагалища и тазового дна часто предшествует страх боли при дефлорации, но в отдельных случаях он появляется внезапно и неожиданно в момент дефлорации. Мягкие, тактичные, чувствительные

к переживаниям молодой супруги мужья не настаивают на коитусе, перенося дефлорацию на утро, на следующий день. Но при очередных попытках совершить половой акт все повторяется снова и снова. В ряде случаев вагинизм может прогрессировать, поэтому выделяют три степени его выраженности:

1) спастическая реакция наступает при введении полового члена, пальца либо инструмента при гинекологическом исследовании;

2) реакция наступает при прикосновении к половым органам или ожидании прикосновения к ним;

3) реакция наступает при одном представлении о половом акте или гинекологическом исследовании.

Вагинизм является наиболее частой причиной виргогамии (девственного брака). Интересно, что даже многолетнее отсутствие дефлорации и половых актов в браке в ряде случаев не ухудшает межличностных отношений супругов. При этом сексуальная адаптация пары достигается за счет использования различных вариантов петтинга и орально-генитальных контактов. Женщины с вагинизмом при этом могут испытывать оргазм, а обращаться к врачу их заставляет чувство неполноценности или желание иметь ребенка (И.Л. Ботнева, 1990). Изредка явления вагинизма возникают после периода нормальной половой жизни, если по отношению к женщине было совершено сексуальное насилие либо она испытывает сильные негативные чувства к своему партнеру. Без соответствующего лечения явления вагинизма у женщины могут привести к серьезным супружеским конфликтам, возникновению сексуальных проблем у супруга и разрыву брачных отношений.

Психогенный вагинизм следует дифференцировать от вагинизма органической природы, когда боль при попытке интроитуса, судорожный спазм и оборонительная реакция женщины обусловлены различными гинекологическими заболеваниями (кольпиты, эндометриоз, спаечный

процесс в малом тазу и т. п.), вызывающими резкую болезненность при коитусе.

Обследование:

- стандартное сексологическое обследование;
- гинекологическое обследование (для исключения органической почвы алгии), в которое должны входить

влагалищный осмотр, ультразвуковое исследование органов малого таза, изменение основных размеров акушерского таза, желательно - исследование гормонального фона пациентки (уровень эстрогена, прогестерона, ЛГ, ФСГ, пролактина, тестостерона); - исследование психического статуса пациентки (клинико-психопатологическое исследование, психологическое тестирование - тесты Люшера, MMPI, Лири, Кеттела и пр.); - урологическое, сексологическое и психологическое исследование постоянного партнера пациентки. Лечение направлено на устранение спазма окружающих влагалище мышц и приобретение способности женщины к половому акту. Терапия вагинизма носит парный и комплексный характер. При наличии у пациенток тех или иных психопатологических расстройств применяют антидепрессанты, транквилизаторы или нейролептики.

Пехотерапия: гинносуггестия для устранения страха перед половым актом, нейтрализации негативных воспоминаний о предшествующих болезненных попытках коитуса и усиления эротических переживаний; прогрессивная десенсибилизация, основанная на применении специальных расширителей влагалища увеличивающихся размеров (когда становится возможным безболезненное введение расширителя, имитирующего эрегированный половой орган мужчины, врач санкционирует переход к коитальной активности). Важное место занимает сексуальная реадаптация пары с привлечением на конечных этапах партнера в качестве котерапевта.

F52.6 Дисмреунда неорганического происшдения

Диспареуния (боль во время полового акта) возникает как у мужчин, так и у женщин. Часто она может быть отнесена за счет местной патологии и тогда кодируется соответствующим образом. Однако в некоторых случаях явные причины не обнаруживаются и важными могут быть эмоциональные факторы. Эта категория должна использоваться только в том случае, если нет другой первичной сексуальной дисфункции (например, ванигизма или влагалищной сухости).

164

Диагностические критерии:

1) повторяющаяся или устойчивая боль в гениталиях либо у мужчин, либо у женщины перед, во время или после полового сношения;
2) нарушение не обусловлено исключительно отсутствием нормального увлажнения влагалища (любрикации) или вагинизмом.

Включается:
- психогенная диспареуния.

Исключаются:
- диспареуния (органическая) у женщин (N94.1);
- диспареуния (органическая) у мужчин (Н47-ШО).

Точных сведений о распространенности диспареунии нет, но известно, например, что при хирургических операциях на гениталиях она наступает в 30 % случаев, а среди женщин, которые находятся на лечении в клиниках сексо-терапии и предъявляют жалобы на боли при половом акте, в 30 - 40 % случаев имеет место патология тазовых органов (Г. Каплан; Б. Сэдок, 1994).

По данным опроса NHSLS (1994), болевые ощущения во время сексуальных контактов на протяжении нескольких месяцев или более в предыдущем году отметили у себя 14 % женщин и 3 % мужчин. В США диспареунические жалобы отмечаются у 46 % женщин в возрасте 18 - 45 лет, обращающихся к гинекологам и семейным врачам (D.J. Jamieson, J.F. Steege, 1996). В России пациентки с жалобами на боли, связанные с половым актом,

составляют до 30 % женщин, обращающихся за сексологической помощью (И.Р. Айриянц, 1999). По данным исследователей, у 48 % женщин, отмечающих боли при половом акте, снижается частота и ритм половых контактов и у 33,7 % на этом фоне происходит нарушение взаимоотношений в семье. (A.E. Glatt, S.H. Zinnner, W.M. McCormic, 1990).

Женскую диспареунию чаще всего вызывают различные органические факторы. Любая причина, приводящая к снижению любрикации, может вызвать дискомфорт во время коитуса. Так, сухость слизистой оболочки влагалища вызывают прием антигистаминных препаратов, некоторых транквилизаторов и трициклических антидепрессантов, ряд заболеваний (сахарный диабет, бактериальный вагинит и др.). К другим причинам женской диспареунии относятся:

поражение кожи (волдыри, сыпь, воспаление) вокруг входа во влагалище или на слизистой оболочке вульвы; раздражение или воспалительные заболевания клитора; патология входа во влагалище вследствие рубцов после эпизиотомии; болезненные остатки девственной плевы; повреждения уретры или ануса; патология влагалища в результате инфекционных заболеваний, хирургических рубцов; атрофия стенок влагалища из-за эстрогенной недостаточности или использования химических местных контрацептивов; повреждения связочного аппарата матки; опухоли или воспалительные заболевания органов малого таза (У. Мастерс, В. Джонсон, 1983). Если боли при половом сношении имеют соматическую основу, состояние классифицируется как диспареуния (органическая) у женщин (N94.1). Необходимо учитывать, что первично возникший органический симптом может удерживаться по невротическому механизму вторичной выгоды, которым для женщины является возможность избегать нежелательной половой близости или по крайней мере ограничить ее (С. Кратохвил, 1982).

В основе диспареунии может лежать сильная неприязнь или физическое отвращение к партнеру, который тем не менее настаивает на сексуальных контактах. В этих случаях диспареуния носит вторичный характер, а основным расстройством является сексуальное отвращение (F52.10).

Психогенная диспареуния возможна у женщин, которые подвергались сексуальному насилию, в т. ч. и в детстве. Боль при коитусе может быть результатом эмоционального напряжения и тревоги относительно полового акта, которые заставляют женщину непроизвольно сокращать мышцы влагалища (Г. Каплан, Б. Сэдок, 1994). Обычно в таких случаях имеются

серьезные проблемы во взаимоотношениях с актуальным партнером либо существует интрапсихический конфликт между сексуальным желанием и неприемлемостью его реализации в интимной связи с конкретным мужчиной (например, в ситуации супружеской измены одного или обоих партнеров, которая вызывает у женщины сильное чувство вины).

По мнению К. Имелинского (1986), диспареуния, возникшая при сексуальных контактах с одним партнером, может создать предрасположенность для появления ее и с

другим партнером. Длительная диспареуния является исходным пунктом для развития вторичных невротических реакций и утраты интереса к половой жизни.

А.И. Федорова (2007) разработала клинико-патогенетическую классификацию женской диспареунии. Она выделяет три ее основные формы:

I. ***Органическая диспареуния***, которая обусловлена структурными изменениями мочеполовой сферы и иннервирующей ее системы, вызванными различными патологическими процессами (воспалительными, атрофическими, рубцово-спаечными, эндометриоидными, травматическими и т. д.).

II. ***Психогенная диспареуния***. Она является собственно сексуальной дисфункцией, при которой ведущей причиной болей, связанных с половым актом, является психогенный фактор.

III. ***Смешанная диспареуния*** является следствием сочетания первично развившейся органической диспареунии с различными психогенными факторами, влияющими на восприятие боли, формирование болевого и сексуального поведения и поддерживающими и усиливающими диспареуничес-кие жалобы.

Согласно А.И. Федоровой, психогенная диспареуния, в свою очередь, может быть подразделена на конверсионную и психосоматическую. *Конверсионная психогенная диспареуния* рассматривается ей как психогенное нарушение телесной функции в рамках истерических расстройств. Она имеет смысл непринятия имеющегося полового партнера, самого факта сексуальных отношений или их конкретного существующего стереотипа, воплощенный в болях при половом акте. Психологический конфликт и его следствие (неадекватное восприятие полового акта) часто обусловлены

иррациональными установками в отношении сексуальных аспектов жизни, сформированными в период психосексуального развития. Болевая симптоматика является результатом объективной или субъективной невозможности изменить сложившуюся ситуацию. Следует иметь в виду, что боли служат наиболее психологически и социально приемлемым поводом отказа женщины от нежелательной половой жизни. Это позволяет говорить об определенной «рентности» данной формы диспареунии

167

(А.М. Свядощ, 1974). Болевая симптоматика локализуется чаще в области входа во влагалище или в проекции матки. Поскольку задействованные конверсионные механизмы ограничены лишь чувственно-двигательной сферой и ведут, как правило, к обратимым функциональным расстройствам, морфологические изменения гениталий не выявляются или не соответствуют характеру и локализации болей.

Психосоматическая психогенная диспареуния является неспецифическим, не имеющим символического смысла ответом индивидуума на широкий диапазон стрессоров. Сопутствующие стрессу «негативные» эмоции вызывают нейродинамические изменения в вегетативной нервной системе, в подкорковых структурах головного мозга. Они способны приводить к изменениям проведения чувствительной информации, нарушениям функции внутренних органов (нарушению микроциркуляции, венозному застою и даже дистрофическим процессам в гениталиях). Результатом могут являться болезненные ощущения во время полового акта. Динамика психосоматического процесса обеспечивает устойчивость патологического состояния и при отсутствии адекватной терапии может приводить к постепенной трансформации обратимых функциональных нарушений в гениталиях в стойкие, трудно обратимые структурные изменения, что постулируется теорией патологических устойчивых состояний и матрицы долговременной памяти. Таким образом, возможность развития структурных изменений отличает психосоматическую форму диспареунии от конверсионной. Эта возможность на определенном этапе приближает клинические проявления психосоматической диспареунии к проявлениям органической диспареунии (А.И. Федорова, 2007).

Обе эти формы связаны с психотравмирующими факторами, однако их содержание и характер связи имеют определенные различия. Развитию конверсионной диспареунии в 100 % случаев предшествуют психотравмирую-щие события, ситуации и состояния, объединенные общим внутренним смыслом непринятия имеющихся партнерских и сексуальных отношений, либо женской роли с ее сексуальной атрибутикой. При психосоматической диспареунии преобладают: изменение партнерских отношений (22 %), общее нарушение ситуации, перемены жизненной

обстановки, повышенные нагрузки (19,5 %). В 31,7 % случаев связь диспареунии с какими-либо событиями или переживаниями выявлялась только в процессе психотерапевтической работы (А.И. Федорова, 2007).

Диспареуния редко встречается у мужчин и обычно имеет органическую основу. Так, при болезни Пейрони фиброзные бляшки в белочной оболочке и перегородке кавернозных тел полового члена нередко приводят к его деформации во время эрекции и болезненным ощущениям при коитусе.

Известен весьма редкий вариант диспареунии неорганического происхождения у мужчин - постэякуляторная боль. Данное расстройство вызвано непроизвольным сокращением эякуляторной мускулатуры и ряда других связанных с ней мышц, которое может иметь место как во время семяизвержения, так и сразу же после него. В результате мужчина начинает испытывать после эякуляции острую боль. Обычно она проходит в течение нескольких минут, но может продолжаться и дольше. Мужчины, ис-пытывающие постэякуляторную боль, часто начинают избегать сексуальных контактов. Поскольку сексуальная активность приносит им неприятные, болезненные ощущения, у них могут появиться проблемы с эрекцией или оргазмом (Г. Келли, 2000). Хотя непосредственной причиной боли является мышечный спазм, это расстройство, по-видимому, имеет глубокие психологические корни. Считают, что мужчины, страдающие от постэякуляторной боли, испытывают затаенное чувство вины, касающееся сексуального наслаждения, амбивалентные чувства по поводу своих отношений с партнершей, а также склонны подавлять чувство гнева и раздражения. Подобные внутренние конфликты могут усугублять

беспокойство по поводу болезненных ощущений и привести к тому, что каждая эякуляция будет сопровождаться болью (Х. Каплан, 1993). Постэякуляторную боль следует отличать от болезненной эякуляции, обусловленной воспалением семенного бугорка, находящегося в простатической части мочеиспускательного канала (колликулит).

Обследование. У лиц обоего пола включает стандартное сексологическое обследование. При диагностике диспареунии у женщин необходимо проведение следующих

исследований: тщательный гинекологический осмотр, УЗИ органов малого таза, определение гормонального профиля пациентки (половые гормоны) и бактериологическое исследование влагалищного мазка (с целью исключить органическую основу болевых ощущений); урологическое и сексологическое обследование постоянного партнера пациентки.

Дополнительно проводится экспериментально-психологическое исследование для всесторонней оценки личностных особенностей и характера межличностного взаимодействия с партнером.

Лечение ставит перед собой целью уменьшение либо полное устранение болезненных ощущений при кбитусе и повышение удовлетворения от половой жизни. При выявлении психопатологической симптоматики, а также при наличии устойчивых гениталий проводится фармакотерапия с использованием антидепрессантов (миансерин, флувоксамин, кломипрамин, пиразидол), транквилизаторов (альпразолам, феназепам), нейролептиков (тиоридазина гидрохлорид, сульпирид, алимемазин).

Психотерапия: техники визуализации, направленные на работу с болью и дискомфортом; гипносуггестивная терапия и аутотреннинговые методики, супружеская терапия для улучшения взаимоотношений между партнерами; секс-терапия и др.

А.И. Федорова (2007) предложила дифференцированный подход к выбору психотерапевтического лечения. При *конверсионной диспарунии* она рекомендует интегративную личностно-ориентированную терапию, направ-

леннуя на разрешение ключевых конфликтов, лежащих в основе нарушения сексуальной функции и сексуальную терапию. Поскольку большая часть встречающихся конфликтов является результатом нарушений психосексуального развития, психотерапевтическая работа предполагает их коррекцию. Она проводится в виде информационно-разъяснительных и психотерапевтических бесед, а также путем формирования позитивного опыта при смоделированном прохождении пропущенных или искаженных стадий психосексуального развития, в том числе во время секстерапевтических упражнений. Должен учитываться часто встречающийся позитивный и противоречивый лич-

ностныи смысл диспареунии, определяющий низкую мотивацию к коррекции болезненных сексуальных контактов в связи с их «вторичной выгодой».

Основные цели сексуальной терапии: приобретение позитивного опыта сексуальных контактов, выработка оптимального стереотипа интимных отношений, приносящих удовольствие, обучение партнеров выражению сексуальных чувств и желаний, нахождению приемлемого для обоих компромисса. При первичной диспареунии (с самого начала половой жизни) у молодых женщин с задержками психосексуального развития сексуальная терапия должна носить максимально развернутый характер, включая мероприятия, направленные на ознакомление с функцией и строением гениталий, адаптацию к вагинальному проникновению. У женщин старшей возрастной группы с диспареунией, развившейся на фоне неадекватной сексуальной техники, нарушений полового влечения, оргазмической дисфункции, чаще используются стандартные методики чувственного фокусирования, генитального услаждения, «необязывающего» коитуса (Х.С. Каплан, 1994; И. Кемпер, 1994). В случаях развития диспареунии на фоне абсолютной аноргазмии и связанного с ней неосознанного отказа от половой жизни, не вызывающей приятных ощущений, используется вибротерапия. Она демонстрирует пациенткам их сексуальные возможности и создает мотивацию к терапии.

При *психосоматической диспареунии*, по мнению А.И. Федоровой (2007), ведущая роль принадлежит интегративной личностно-ориентирован-

ной психотерапии, направленной на выявление связи между психическими факторами и диспареуническими болями, на укрепление уверенности в себе, восполнение женской идентичности, получение эмоциональной поддержки и выработку новых способов эмоциональных проявлений, а также включающая в качестве компонентов телесно-ориентированную и сексуальную терапию. В случае выявления патологических изменений в гениталиях лечение проводится при совместном участии сексолога и гинеколога. При проведении психотерапии акцент делается на проблемах раннего детства, определенных аспектах взаимоотношений с родителями, повлиявших на характер психосексуального развития, от-

ношение к телесности, к сексуальным аспектам жизни и коммуникации с мужчинами. В поле внимания удерживают отношение к собственной женственности, к получению удовольствия вообще и в интимных контактах с партнером в частности и т. д. Целью такой работы является обеспечение восполнения развития женской идентичности, постепенное приобретение более конструктивных и гибких форм обращения с собой и партнером, которые лишат диспареуническое поведение его функциональной ценности. Эффективными путями терапевтической поддержки и восстановления контакта женщин, страдающих психосоматической диспаурением со своим телом, трансформации болезненных телесных паттернов, знакомства с новыми способами эмоциональных проявлений являются телесно-ориентированная терапия и сексуальная терапия.

F 52.7. Повышенное половое влечение

Как мужчины, так и женщины иногда могут жаловаться на повышенное половое влечение как на самостоятельную проблему, обычно в юношеском и молодом возрасте. Когда повышенное половое влечение является вторичным по отношению к аффективному расстройству (F30 - F39) или когда оно развивается в течение ранних стадий деменции (F00 - F03), необходимо кодировать основное заболевание.

Следует отметить:

- в случае, если повышенное сексуальное влечение развивается у больного с умственной отсталостью, то основным заболеванием следует считать умственную отсталость (F70.xx - F79.xx).

Включаются:

- нимфомания;
- сатириазис.

По мнению К. Имелинского (1986), определение нормальной степени выраженности сексуального влечения всегда условно. Если человек ведет интенсивную половую жизнь, но при этом «успевает» проявлять высокую творческую, профессиональную, общественную или иную активность, он не может рассматриваться как человек с патологически усиленным либидо. Патологическая гипер-

сексуальность отличается не только количественным увеличением половых контактов, но и качественным изменением поведения, когда удовлетворение высоких сексуальных потребностей становится некой сверхценной идеей, целиком поглощающей индивида в ущерб другим сферам жизни.

Повышенное половое влечение проявляется в настоятельной потребности вступать в очень частые сексуальные контакты и всячески их разнообразить, а также в очень высоких физических возможностях в половой жизни либо сочетанием обоих этих качеств (К. Имелинский, 1986). Чрезмерная выраженность либидо обычно приводит к беспрерывной смене сексуальных партнеров, многократным в течение суток половым актам с ними, сексуальным оргиям, эксцессивной мастурбации.

У мужчин патологическое усиление либидо обозначается как сатириазис, у женщин - как нимфомания.

Считается, что в основе сатириазиса, кроме чрезмерной интенсивности полового влечения, может лежать также чувство собственной неполноценности, неуверенности в своих сексуальных возможностях. Такие мужчины нуждаются в беспрерывном подтверждении своей сексуальной состоятельности. Этот мотив приписывают легендарному соблазнителю Дон Жуану, который постоянно вступал в половые связи с различными женщинами, чтобы убедиться, что его сексуальные возможности не изменились.

Х. Эллис (1965) характеризует нимфоманию как постоянное стремление к сексуальным контактам, причиной которого являются навязчивости или «аутоагрессивные» тенденции. Это приводит к неконтролируемому поведению, вследствие которого женщина легко вступает в половые связи с любым человеком, независимо от его возраста, внешности и даже пола. Абсолютный промискуитет отличает женщину, страдающую нимфоманией, от женщины, проявляющей выраженную сексуальную активность, но с определенным отбором партнеров (своеобразный селективный промискуитет). Сексуальное поведение, в основе которого не лежат навязчивости, можно в значительно большей степени контролировать, что выражается в отборе партнеров (H. Ellis, E. Sagarin, 1965).

Повышенное половое влечение может быть симптомом в рамках психического расстройства или органи-

ческого заболевания, в частности, при маниакальных и гипоманиакальных состояниях, шизофрении, некоторых расстройствах личности (при которых утрачивается эмоционально-волевой контроль, что проявляется повышением интенсивности сексуальной жизни, распущенностью, цинизмом), а также при органических поражениях мозга, гормональных нарушениях, наркотических интоксикациях (кокаин, героин, мескалин) и отравлениях угарным газом (К. Имелинский, 1986).

По мнению И.Л. Ботневой, сексолог сталкивается с проблемой гиперсексуальности у женщины в трех основных случаях:

1) при патологии глубинных структур мозга, в частности гипоталамуса;

2) при эндогенных психических заболеваниях (шизофрения, аффективные психозы, иногда эпилепсия);

3) когда гиперсексуальности как таковой нет, а усиление полового влечения, например в климактерическом периоде, воспринимается женщиной как нечто патологическое.

При синдроме гипоталамической гиперсексуальности наблюдается пароксизмальное повышение либидо. Периодически возникают приступы сильнейшего полового возбуждения со специфическими ощущениями в

области половых органов, повышением чувствительности гениталий к тактильной стимуляции, могут отмечаться чувство жара, учащенные позывы к мочеиспусканию, боли внизу живота и в пояснице. Женщины с синдромом гипоталамической гиперсексуальности мультиоргастичны, причем повторные оргазмы легко возникают у них при любой форме стимуляции, эротических сновидениях и даже под воздействием неадекватных раздражителей (общая вибрация и т. п.). В более тяжелых случаях они испытывают затяжной, волнообразный оргазм, который может длиться до 1 часа и более, но не приносит удовлетворения. Сексуальное возбуждение у таких женщин часто возникает в виде кризов и сопровождается ухудшением общего самочувствия (побледнение или покраснение кожных покровов, головная боль, головокружение, повышение температуры тела). Нарушается сон, поскольку они часто просыпаются от оргазмов с болью внизу живота. Повышенное половое влечение приводит к сексу-

альной расторможенности и многочисленным случайным связям. Многие женщины тяжело переживают невозможность контролировать свое сексуальное поведение, что является дополнительным источником психотравматизации, способствуя развитию депрессивной и астеноипохондрической симптоматики. В некоторых случаях женщины всячески избегают любых ситуаций, провоцирующих сексуальные контакты, поскольку, несмотря на многократные оргазмы, коитус не приводит к сколько-нибудь длительной редукции полового возбуждения.

Синдром гипоталамической гиперсексуальности следует относить к рубрике F07.8 «Другие органические расстройства личности и поведения вследствие заболевания, повреждения или дисфункции головного мозга».

Гипоталамическую гиперсексуальность необходимо отличать от нимфомании при психических заболеваниях. Например, при шизофрении половое возбуждение носит субъективный характер, проявляясь только на психическом уровне, и не сопровождается соответствующими изменениями в гениталиях. Оргазм затруднен или невозможен. Здесь как бы расщеплены биологический и психический компоненты либидо. Влечение носит компульсивный характер, оно толкает на беспорядочные половые связи, которые не дают сексуальной разрядки. Женщины снова и снова меняют

партнеров, надеясь наконец испытать удовлетворение, которое так и не наступает. У них обычно не бывает эротических сновидений, а попытки мастурбации также не приносят полной разрядки. Поскольку нимфомания при шизофрении носит вторичный характер по отношению к основному заболеванию, в диагнозе используются рубрики F20 или F25.

Обследование. Включает стандартное сексологическое обследование. Особое внимание следует обратить на клинико-психопатологическое исследование, гинекологический статус. При подозрении на синдром гипоталамической гиперсексуальности - консультации невролога, эндокринолога, определение уровня гонадотропинов и половых гормонов в сыворотке крови; ЭЭГ-исследование.

Лечение направлено на улучшение общего состояния и снижение до приемлемого уровня патологически повышенного влечения.

Фармакотерапия: психотропные препараты (преимущественно нейролептики), антиандрогены. Психотерапия направлена на коррекцию самооценки, выработку более адекватного отношения к своему состоянию, формирование лечебной перспективы.

F52 8. Другая сексуальная дисфункция, не обусловленная органическим нарушением или болезнью.

Включены половые расстройства, которые не могут быть классифицированы ни в одной из предыдущих категорий сексуальных дисфункций и не относятся к расстройствам половой идентификации (F64), расстройствам сексуального предпочтения (F65) и психологическим и поведенческим расстройствам, связанным с сексуальным развитием и ориентацией по полу (F66).

Так, к рубрике F52.8 относят посткоитальную дисфорию. Это состояние может возникать в фазе разрешения, когда в норме субъект испытывает чувство блаженства, сопровождающееся мышечным и психическим расслаблением. Посткоитальная дисфория проявляется тем, что после успешного во всех других аспектах коитуса у некоторых лиц возникает депрессия, напряжение, тревога, раздражительность и даже психомоторная ажитация. Им часто хочется освободиться от партнера, и они становятся грубыми, а порой агрессивными. Распространенность этого расстройства неизвестна, но оно чаще встречается у мужчин. Предполагается, что причины посткоиталь-ной дисфории связаны с отношением субъекта к сексу в целом и к партнеру в частности. Расстройство иногда наблюдается при нарушении супружеской верности или при половых контактах с проститутками (Г. Каплан, Б. Сэдок, 1994).

Сюда же включают посткоитальные головные боли, компульсивную мастурбацию и т. п. Посткоитальные головные боли характеризуются цефалгией, которая возникает сразу же после коитуса и может продолжаться несколько часов. Ее описывают как пульсирующую по характеру с локализацией в затылочной или лобной об-

ласти. Причины посткоитальной головной боли неизвестны. По всей видимости, она этиологически связана с изменениями тонуса краниальных сосудов, мышечным сокращением (напряжением) или с психогенными моментами (Г. Каплан, Б. Сэдок, 1994).

Обследование. У лиц обоего пола включает стандартное сексологическое обследование. Дополнительно проводится экспериментально-психоло-гическое обследование.

Лечение имеет задачу ослабить или полностью устранить симптомы сексуальной дисфункции и повысить удовлетворенность половой жизнью. Фармакотерапия проводится с учетом характера сексуальных нарушений и выраженности психопатологической симптоматики. Психотерапия направлена на коррекцию основных психологических механизмов, участвующих в формировании половых дисфункций, а также их отдельных проявлений.

F52.9. Сексуальная дисфункция, не обусловленная органическими нарушениями или болезнью

К данному таксону относятся сексуальные расстройства неуточненного характера предположительно психогенного генеза.

2.9. Зависимость от алкоголя (F10…) и сексуальные дисфункции

Синдром зависимости от алкоголя (алкоголизм) - хроническое прогрессирующее заболевание, на развитие и клинические проявления которого влияют генетические, психосоциальные факторы и условия окружающей среды. Алкоголизм проявляется утратой самоконтроля, неудержимой тягой к спиртному, продолжением злоупотребления алкоголем, несмотря на неблагоприятные последствия для здоровья, социального статуса, семейных и супружеских отношений, а также когнитивными нарушениями (от отри-

цания очевидного пристрастия к спиртному вплоть до развития грубых интеллектуально-мнестических расстройств и деградации личности).

Для синдрома зависимости от алкоголя характерно наличие 3-х и более из числа следующих признаков: а) сильная потребность или необходимость в принятии алкоголя; б) нарушение способности контролировать прием алкоголя (начало употребления, его окончание и количество выпиваемого спиртного); в) состояние отмены (алкогольной абстиненции), которое характеризуется комплексом с о мат о-вегетативных и психических нарушений, для облегчения или предупреждения которых субъект прибегает к очередному приему алкоголя; г) развитие толерантности, которая проявляется увеличением количества употребляемого алкоголя, необходимого для достижения состояния опьянения, ранее вызываемого более низкими дозами; д) прогрессирующее забвение прежних интересов в пользу употребления алкоголя, а также увеличение времени, затрачиваемого на приобретение и прием спиртного, или

восстановление после окончания его действия; е) продолжение употребления алкоголя несмотря на очевидные вредные последствия (поражения печени, депрессивные состояния, снижение когнитивных функций и т. п.).

Зависимость от алкоголя чаще всего встречается у мужчин, рано начавших пить, с быстрым развитием толерантности, физической зависимости с формированием состояний отмены, демонстрирующих антисоциальное поведение уже в детстве и юности.

Злоупотребление алкоголем представляет собой чрезвычайно серьезную медико-социальную проблему. Вероятность развития злоупотребления алкоголем в течение жизни достигает 10 - 15 %. Число лиц, страдающих алкоголизмом, составляет в ФРГ около 2 млн человек, в США - свыше 10,5 млн мужчин и женщин, а 7,2 млн американцев систематически злоупотребляют алкоголем, еще не проявляя признаков зависимости. В 2005 году в наркологических учреждениях Беларуси состояло на учете свыше 167 тыс. лиц с алкогольной зависимостью.

От 20 до 40 % всего коечного фонда в больницах стран Европы занято больными алкоголизмом и лицами, состояние которых утяжелилось вследствие злоупотребления спиртными напитками. Средняя продолжительность жиз-

ни больных алкоголизмом сокращается примерно на 10 лет. Наличие в семье психосоматических расстройств, невротизация непьющего супруга с большой частотой встречаются в семьях алкоголиков. У женщин с алкогольной зависимостью, продолжающих употребление спиртных напитков во время беременности, наблюдается алкогольный синдром плода. Дети рождаются с грубыми морфологическими нарушениями: неправильные размеры головы и соотношения головы, тела, конечностей, лицевой и мозговой частей черепа; шарообразные или глубоко посаженные глаза, широкая переносица, утопленное основание носа, недоразвитие челюстных костей и т. д.

Дети злоупотребляющих алкоголем родителей часто страдают врожденной малой мозговой недостаточностью (избыточная подвижность, отсутствие сосредоточенности, стремление к разрушению, агрессивность), у них замедляется или оказывается неудовлетворительным моторное, психическое развитие, овладение практическими навыками. Во всех случаях

при пьянстве родителей дети растут в психотравмирующей обстановке, обнаруживая признаки невротизации (логоневроз, энурез, ночные страхи), расстройства поведения (упрямство, агрессивность, побеги из дома) и эмоций (тревога, депрессия, суицидальные попытки); психическое развитие их нарушено, возникают трудности в обучении и контактах со сверстниками.

Частота половых расстройств у лиц, длительно страдающих алкогольной зависимостью, по различным данным может достигать 55 - 83 %. Среди нарушений половой сферы у мужчин преобладают расстройства эрекции, ускоренная эякуляция, реже - снижение либидо и остроты оргастических ощущений. Сексуальные дисфункции у больных алкоголизмом могут развиваться в результате целого ряда причин: расстройств нейроэндокринной регуляции половой сферы, поражений иннерваторных структур полового члена при алкогольных нейропатиях, гиперэстрогении при алкогольных гепатитах и циррозе печени (происходит усиленная биотрансформация андрогенов в эстрогены), ухудшения взаимоотношений с партнершей, обусловленных деградацией личности, и т. д. При любом клиническом варианте сексуальные расстройства у мужчин, страдающих алкоголизмом, являются результатом сложного взаи-

модействия конституциональных и личностных факторов, особенностей партнерских отношений, сопутствующих заболеваний, негативно влияющих на половую сферу, а также интенсивности и длительности алкогольной интоксикации.

Половые нарушения у больных алкоголизмом женщин в одних случаях являются следствием алкогольной интоксикации и проявляются сексуальной гипо- или гиперфункцией, в других - возникают в результате недостаточной осведомленности в вопросах психогигиены половой жизни и нарастающей социально-психологической дезадаптации.

У большинства женщин на начальном этапе формирования алкогольной зависимости сексуальная функция не претерпевает существенных изменений. В ряде случаев усугубляются уже имеющиеся у них нарушения половой сферы (гиполибидемия, гипооргазмия). Может наблюдаться сексуальная гиперфункция, которая проявляется повышением полового влечения и

чувствительности эрогенных зон, а также мультиоргастичностью (см. оргазм). Основные механизмы развития подобной гиперсексуальности - поражение гипоталамической области в результате хронической алкогольной интоксикации и морально-этическое снижение личности, сопровождающееся сексуальной расторможенностью. Снижение сексуальной функции у женщин на поздних стадиях алкоголизма происходит вследствие нарушений нейроэндокринной и психической ее регуляции и зависит как от длительности и тяжести течения алкоголизма, так и от типа их половой конституции. Нарушения половой функции у женщин развиваются параллельно развитию алкоголизма и чаще всего проявляются алибидемией и/или аноргазмией.

По данным Е. В. Кришталя, у мужей больных алкоголизмом женщин *в* силу парного характера сексуальной функции нередко отмечаются сексуальные расстройства, проявляющиеся в снижении либидо, ухудшении качества эрекций, преждевременном семяизвержении, психологической и сексуальной аверсии, а в 22 % случаев имеет место полный отказ от половой жизни с супругой, которая перестает вызывать какие-либо сексуальные желания, либо у мужчины возникает непреодолимое отвращение к интимным контактам с ней. Впрочем, алкоголизм у мужа (даже при отсутствии выраженных нарушений потенции) также

весьма отрицательно влияет на качество половой жизни в браке, поскольку большинство женщин весьма негативно относится к сексуальной близости с пьяным супругом.

Необходимо отметить, что сексуальная дисфункция у одного из партнеров, его систематическое неправильное поведение в ходе интимной близости приводят к частым сексуальным фрустрациям и нарастанию эмоционального и физического дискомфорта у другого партнера, который последний может снимать, регулярно употребляя спиртное. Некоторые мужчины систематически прибегают к приему алкоголя перед близостью, используя его для удлинения полового акта. В отдельных случаях алкоголь выступает как средство, стимулирующее половую активность (обычно у тревожных, неуверенных в себе лиц). Подобная практика нередко перерастает в злоупотребление спиртными напитками и может привести к

развитию алкогольной зависимости. Возникновение либо усугубление расстройств половой сферы у больных алкоголизмом требует сочетанного лечения как алкогольной зависимости, так и сопутствующих сексуальных дисфункций.

181

Глава 3. Нарушения психосексуального развития

В данной главе рассмотрены особенности психосексуального развития человека в норме и его различные отклонения, в том числе и не относящиеся к патологии (задержки психосексуального развития, ускоренное психосексуальное развитие, трансформация половой роли, сексуальные девиации, гомосексуализм).

В разделе F6 «Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте» МКБ-10 представлены три сексологические рубрики:

- F64. Расстройства половой идентификации.

- F65. Расстройства сексуального предпочтения.

- F66. Психологические и поведенческие расстройства, связанные с сексуальным развитием и ориентацией по полу.

Приведены клинические описания рассматриваемых в рубриках F64-F66 состояний, критерии их диагностики и терапевтические подходы.

3.1. Психосексуальное развитие человека

Психосексуальное развитие - один из аспектов индивидуального психического развития, в процессе которого формируются половое самосознание, половая роль и психосексуальная ориентация человека. Начинается с первых месяцев жизни и полностью завершается к 20-25 годам вступлением индивида в период зрелой сексуальности (началом регулярной половой жизни с постоянным партнером).

Фактически уже в пренатальном периоде (с момента зачатия до рождения) происходит развитие и половая

дифференцировка гонад, гениталий, а также структур мозга, ответственных за половое поведение, агрессивность, материнский инстинкт, и т. д. Нарушения половой дифференцировки структур мозга могут происходить, если в критический период беременности (7 - 32 недели внутриутробной жизни) на плод действуют различные Егатогенные факторы (стрессы у беременной, нарушение маточно-плацентарного кровообращения, прием женщиной таких лекарственных препаратов, как глюкокортикоиды, анаболические стероиды, прогестины, резерпин и др.). Еще в конце 60-х годов прошлого века было установлено, что девочки, родившиеся у матерей, которые для предотвращения выкидыша получали прогестин, отличались высоким интеллектом, по физическому развитию походили на мальчиков, играли в войну, дрались, проявляли независимость и самоуверенность. Вырастая, такие девочки часто становится руководящими работниками, у них слабо

выражен материнский инстинкт, они проявляют агрессивность, бескомпромиссность и неуживчивость в семье. Известно также, что мальчики, родившиеся в блокадном Ленинграде, напротив, отличались мягкостью, покладистостью, домовитостью, любили играть в куклы, что связывают с феминизирующим влиянием стрессов на мужской плод. Таким образом, профилактика нарушений психосексуального развития должна начинаться еще до рождения ребенка, поэтому для беременной матери необходимо создание условий, исключающих вредные воздействия на плод.

Российские сексологи Г.С. Васильченко, В.М. Маслов и И.Л. Ботнева (1983, 1990) выделяют три этапа психосексуального развития (см. табл. 3.1). Первому и второму этапам и стадиям третьего этапа свойственна определенная фазность, которая является одной из закономерностей психосексуального развития. В первой фазе (выработка установки) накапливается и перерабатывается информация: на I и II этапах - о существовании полов, о половой роли, на III этапе - об особенностях полового поведения, его внешних проявлениях и сущности. Первую фазу можно считать завершенной только при наличии внутренней готовности к реализации сформированных тенденций. Во второй фазе (на-

учение и закрепление установки в игровых ситуациях, т. е. «на практике», происходит научение определению половой принадлежности (I этап) и полоролевому поведению (II этап), а на III этапе - реализации полового влечения. В процессе научения апробируются и закрепляются выработанные в первой фазе установки. Социальная изоляция, в первую очередь лишение общения со сверстниками, ведет к искажению сексуального поведения, нарушениям реализации влечения не только у человека, но и у животных.

Таблица 3.1

Психосексуальное развитие человека

Возрастные периоды	Этапы психосексуального развития	Фазы и их основные проявления
С первых месяцев жизни до 2-4 лет (максимум 5 лет)	I этап. Формирование полового самосознания	1-я фаза (выработка установки): осознание собственной половой принадлежности и пола других людей 2-я фаза (научение и закрепление установки): любопытство, направленное на половые признаки, в том числе изучение половых органов
От 2- 5 лет до 7- 10 лет	II этап. Формирование половой роли в соответствии со своим полом	1-я фаза: выработка полоролевых установок 2-я фаза: научение полоролевому поведению в играх

184

От 7-10 лет до 18-20 лет (максимум 25 лет)	III этап. Формирование психосексуальных ориентации, обуславливающих выбор объекта полового влечения и форм его реализации:	
чаще 7-10 лет	1-я стадия - формирование платонического либидо	1-я фаза: обожание, платонические мечты, фантазии 2-я фаза: ухаживания, платоническое общение
чаще 11-15 лет	2-я стадия - формирование эротического либидо	1-я фаза: эротические фантазии 2-я фаза: эротические ласки и игры
чаще 16-20 лет	3-я стадия — формирование сексуального либидо	1-я фаза: сексуальные фантазии 2-я фаза: начало половой жизни, сочетание сексуальных эксцессов с периодами воздержания и мастурбации

I этап. Формирование полового самосознания, т. е. осознание собственной принадлежности к тому или иному полу (1 - 4 года) происходит под влиянием микросоциальной среды, но в значительной мере определяется половой дифференцировкой мозга во внутриутробном периоде. На этом этапе формируются сознание половой принадлежности себя и других людей, уверенность в ее необратимости, после чего любые попытки изменить половое самосознание оказываются безуспешными.

С первых месяцев жизни ребенок постоянно получает подтверждения от родителей, кто он - мальчик или

девочка. Половые различия в игровом поведении детей обнаруживаются примерно с 12-13 месяцев. Девочки чаще просятся на руки к матери, прикасаются к ней, склонны к пассивным играм на одном месте. Мальчики - более активны, непоседливы, избегают длительных родительских ласк. Дети видят членов семьи и одетыми и неодетыми, поэтому к 1-1,5 годам они уже знают (хотя и неосознанно): так выглядит мама, так папа, а так - брат или сестра. В этом же возрасте дети начинают обнажаться и демонстрировать себя окружающим, осматривают и ощупывают свое тело, нередко играют с гениталиями, что обусловлено любознательностью, а не сексуальностью. Именно так они постигают половые различия людей. Если ребенок в возрасте 1 - 4 лет не имел возможности хорошо рассмотреть отличия в строении тела мужчины и женщины, в дальнейшем он постарается восполнить этот пробел, причем чем позже это произойдет (например, в пубертате), тем выше вероятность возникновения отклонений в половом поведении. В норме о завершении этого этапа свидетельствует тот факт, что при определении ребенком пола окружающих он в равной мере учитывает все признаки половой принадлежности (внешний вид, одежда, строение тела и половых органов) и осознание, что он навсегда мальчик или девочка, а когда вырастет, будет мужчиной или женщиной. Возникает половая идентичность - чувство собственного постоянства, тождественности самому себе душевно и телесно.

Первый этап психосексуального развития имеет и другие важные особенности. В первые 2 - 3 года жизни у детей формируется речь, происходит становление самосознания (выделение себя из окружающего мира). Микросоциальная среда в этот период ограничивается близкими родственниками, среди которых особую роль играет мать, и небольшим кругом сверстников. Тесный эмоциональный и тактильный контакт с матерью крайне необходим ребенку с первых месяцев жизни примерно до 3 лет, поскольку он способствует дозреванию глубоких структур мозга, ответственных за половое поведение человека и закладке эрогенных зон, что в дальнейшем имеет значение для становления сексуальности (особенно у женщин). Особая роль здесь принадлежит грудному вскармливанию, которое обеспечивает наиболее тесный телесный контакт между матерью и ребенком. Об-

щение с матерью, развитие привязанности к ней дает ребенку ощущение безопасности и закладывает основы адекватных, доброжелательных отношений с окружающими. В этом возрасте лишение матери приводит к реагированию на незнакомых людей страхом и агрессией, а затем к формальным отношениям с товарищами, неразборчивости в выборе друзей, чрезмерной жестокости. Став взрослыми, эти лица часто не способны испытывать привязанность к другим людям, в том числе к своему половому партнеру. Следует отметить, что отсутствие материнского ухода, при всех своих проблемах и трудностях, не является фатальным для нормального развития ребенка. Многие специалисты считают, что дети со здоровой «почвой» (без органической патологии головного мозга), воспитанные приемными родителями или даже в детском доме, но получившие достаточно ласки и внимания, могут вырасти вполне гармоничными личностями.

Отметим, что, согласно взглядам Пиаже, дети сначала усваивают стандарты социального поведения, благодаря познанию и исполнению определенных правил, и лишь после этого совершают переход от выученной роли к осознанию своей половой принадлежности. Известно, что дети уже в 1 - 1,5 года начинают подражать родителю одного с ними пола и в играх демонстрируют соответствующее поведение (мальчики пытаются завинчивать шурупы отверткой, стучать молотком; девочки - пользоваться губной помадой, пудрой, надевать на голову платок и т. п.). По мнению И.Д. Исаева и Д.Н. Кагана (1986), ребенок вначале переживает себя как представителя пола - эта первичная идентичность связана с половой дифференциацией во внутриутробном периоде и стилем общения с ребенком в младенчестве. Затем уже в соответствии с первичной идентичностью он отождествляет себя с родителем своего пола и имитирует соответствующее поведение. Только после этого у ребенка окончательно формируется половая идентичность. В дальнейшем развитии половая роль и половая идентичность функционируют в системе обратных связей, подкрепляя друг друга.

II этап. Формирование стереотипа полоролевого поведения. На этом этапе (обычно до 9 лет) происходит выбор половой роли, наиболее соответствующей психофизиологическим особенностям ребенка и идеалам маскулин-

ности или фемининности, принятым в той микросоциальной среде, в которой он воспитывается.

Второй этап характеризуется интенсивной социализацией ребенка. В этот период происходит обучение общению со сверстниками, совершенствуются и дифференцируются эмоциональные реакции, формируется характер. Этому возрасту свойственны недостаточное развитие воли и импульсивность поведения, любознательность, доверчивость, подражательность. Развиваются элементы абстрактно-логического мышления. Приобретение личной независимости не означает потери контакта с родителями. Наоборот, родители и их взаимоотношения становятся объектом повышенного внимания и подражания. Они воспринимаются ребенком как модель мужественности и женственности, как образец взаимоотношения полов. Правильное полоролевое поведение родителей во многом определяет формирование адекватной половой роли у ребенка. В общении со сверстниками, в первую очередь в полоролевых «семейных» играх, требующих выполнения определенной роли - жениха, невесты, отца, матери, ребенка и т. д., апробируется и закрепляется выбранная половая роль, отражающая различные аспекты человеческих отношений, в том числе и сексуальных. Такого рода «семейные» игры в зависимости от информированности детей охватывают широкий диапазон полоролевого поведения взрослых: от подражания поведению родителей (чтение отцом газеты в кресле перед телевизором, ведение матерью домашнего хозяйства) до имитации полового акта. С поступлением в школу появляются новые образцы для подражания, возрастает роль общения со сверстниками. На этом этапе типично разделение коллектива школьников по половому признаку. Во многом благодаря этому возрастают требования к проявлениям мужественности или женственности, окончательно фиксируя выбранную половую роль.

III этап. Формирование психосексуальных ориентации. Начинается в 7 - 10 лет, завершаясь к 20-25 годам, вступлением в период зрелой сексуальности, для которого характерна регулярная половая жизнь с постоянным партнером или супругом.

Если первые два этапа психосексуального развития протекают на относительно «спокойном» гормональном

фоне, то на третьем этапе постепенно начинается и достигает максимума функционирование эндокринной системы, и в частности половых желез. Формируются личность, социальное сознание, адекватная оценка своих способностей. Происходит эмансипация от семьи, вырабатывается собственное мировоззрение, развиваются высшие эмоции. При отсутствии взаимопонимания в семье подросток только в неформальной группе сверстников может получить интересующую его информацию, обсудить волнующие его вопросы. Увеличение роли стихийных средовых факторов в сочетании со скрытностью подростков представляет благодатную почву для различного рода нарушений становления сексуальности, чему также способствует отсутствие адекватного полового воспитания.

Специфика этапа - формирование психосексуальных ориентации, которые обусловливают в последующем выбор объекта влечения с его индивидуальными особенностями (половая принадлежность, внешний вид, телосложение, поведение и т. д.), необходимость для реализации влечения определенной ситуации и ряда последовательных действий, иногда составляющих целый ритуал.

Третий этап можно условно разделить на три стадии соответственно формированию платонического, эротического и сексуального либидо. На каждой из них четко прослеживаются две фазы. Так, платоническое либидо проходит первую фазу - «детской» влюбленности, желания духовного общения - и вторую фазу, когда происходит их реализация в ходе совместного приготовления уроков, учебы за одной партой, демонстрации знаков внимания к объекту платонического увлечения. При всей своей внешней эфемерности вторая фаза очень значима, поскольку в ходе ее прохождения формируется умение обращать на себя внимание понравившихся сверстников, знакомиться и общаться с ними. Если на этой фазе формирования либидо не происходит его реализации, то романтическая любовь остается не только безответной, но и незамеченной, а трудности, сомнения и неуверенность в себе перенесутся на более поздние стадии формирования либидо, создавая серьезные проблемы при попытках сближения с потенциальным партнером. При гармоничном развитии в платоническую влюбленность включаются сначала

отдельные элементы эротического фантазирования (желание остаться наедине, стремление к прикосновениям и ласкам), которые постепенно нарастают, расширяется их диапазон, и они занимают все большую часть свободного времени подростка. При переходе от платонической стадии либидо к эротической подростки начинают проявлять возрастающий интерес к интимной стороне взаимоотношений полов, эротической литературе и фильмам, содержащим сцены свиданий, объяснений в любви. Но даже при самых ярких эротических фантазиях переход ко второй фазе этой стадии можно считать состоявшимся только после их практического воплощения в интимных ласках с партнером. На эротической стадии реализация влечения чаще бывает без оргазма на уровне фрустраций сексуальных, что побуждает к расширению круга сексуальных действий и форсирует переход к последней стадии. Могут также практиковаться формы эротической реализации, подкрепляемые оргазмом: петтинг и мастурбация. Однако пока нет реализации сексуального либидо в половом акте (2-я фаза), существует возможность для различных отклонений от нормального психосексуального развития, которые в дальнейшем могут затруднять проведение гетеросексуального коитуса. Поэтому, чем меньше временной разрыв между началом фантазирования и реализацией, тем гармоничнее стадия формирования того или иного компонента влечения; напротив, чем дольше откладывается реализация фантазий и мечтаний, тем более вычурными и труднее выполнимыми они становятся, все больше отрываясь от нормативных половых контактов. В результате повышенной склонности к фантазированию и задержек реализации либидо, обусловленных социальными факторами, женщины более подвержены отклонениям в психосексуальном развитии.

Этапу формирования психосексуальных ориентации в норме свойственны, воспринимаемые взрослыми как ветреность и легкомыслие, смена влюбленностей и идеалов, порой наличие сразу нескольких увлечений. Однако это ни что иное, как нормальные проявления отбора методом проб и ошибок тех признаков, особенностей и нюансов платонических увлечений, эротических предпочтений и сексуальных ориентации, которые в последующем будут

включать механизм «неподвластного разуму» полового влечения. Многообразие такого рода признаков в периоде становления сексуальности в последующем облегчает выбор супруга и достижение с ним гармоничных интимных отношений. Напротив, «любовь с первого класса» либо длящаяся годами безответная любовь чаще является показателем трудностей сексуальной адаптации, что проявляется очень узким, ограниченным индивидуальным выбором, затрудняющим формирование зрелой сексуальности.

Для всех этапов психосексуального развития, а также для каждой стадии III этапа существуют общие закономерности. Первая из них - фазность, рассмотренная выше. Вторая закономерность - изменение соотношения роли биологического и социального в становлении человеческой сексуальности. В процессе психосексуального развития биологическая детерминированность этапа полового самосознания относительно ослабевает при формировании полоролевых установок, когда возрастает относительное значение социальных факторов, и еще более маскируется на этапе становления психосексуальных ориентации, когда гормональный фон определяет лишь интенсивность проявлений сексуальности.

Преемственность и взаимосвязь этапов (стадий), а также их нарушений представляет собой третью закономерность психосексуального развития. На каждом этапе (стадии) становления сексуальности имеются определенные задатки следующего за ним этапа, поэтому выпадение по тем или иным причинам любого из них искажает течение последующих и в итоге становление всей сексуальности.

Разделение психосексуального развития на этапы носит несколько условный характер, так как половое самосознание, половая роль и психосексуальные ориентации тесно взаимосвязаны и представляют собой подвижные структуры, которые могут меняться не только в процессе их формирования, но и в течение всей жизни человека. Однако основы всех компонентов сексуальности закладываются при их становлении. Эти процессы и их последовательность достаточно полно отражены в представленной концепции.

3.2. Нарушения темпов и сроков психосексуального развития

Ретардации психосексуального развития проявляются отставанием сроков становления сексуальности от возраста субъекта. Выделяют три варианта ретардации психосексуального развития.

Соматогенные задержки имеют биологическую основу и связаны с отставанием в половом развитии. Грубые расстройства эндокринной системы могут привести даже к асексуальности, то есть полному выпадению сексуального компонента а психическом развитии личности.

Психогенные задержки вызваны различными нарушениями в становлении психики, включая общее отставание психического развития. Наиболее часто они обусловлены психопатическими аномалиями характера (шизоидное, тревожное, ананкастное расстройства личности и т. д.). Их тормозящее влияние заметно уже на этапе формирования полоролевого поведения, а максимально проявляется при становлении психосексуальных ориентации. Так, робость, застенчивость, нерешительность, впечатлительность, слабость побуждений, свойственные лицам с тревожным (уклоняющимся) или шизоидным расстройствами личности, затрудняют контакты с окружающими (в том числе и сексуальные), а крайняя изменчивость эмоций, способность к яркому фантазированию, недостаток волевых качеств в сочетании с трудностями общения способствуют формированию и закреплению заместительных форм половой активности (например, стойкой регулярной мастурбацией в сочетании с сексуальными фантазиями и просмотром соответствующей видеопродукции).

Социогенные ретардации психосексуального развития чаще всего наблюдаются при гармоничном психофизическом развитии личности, но неправильном половом воспитании. Привитие ребенку мысли, что все, связанное с полом, - постыдное и грязное, ограничения в общении со сверстниками, негативная реакция на любые проявления сексуальности ребенка, воспитание у него отношения к «телесному низу» как к чему-то порочному, непристой-

ному нередко задерживают психосексуальное развитие, формируя у субъекта устойчивые представления о неприличном характере не только половых контактов, но даже мыслей на «постыдную» тему.

Ретардации являются одним из вариантов несвоевременного становления сексуальности, то есть асинхроний психосексуального развития, отражающих дисгармоничность полового созревания. Указанные варианты сексуальных ретардаций относят к простым асинхрониям, которые редко встречаются изолированно. Чаще наблюдаются сочетанные асинхроний, обусловленные воздействием сразу нескольких негативных факторов. Один из наиболее распространенных вариантов сложных асинхроний психо-сексуального развития - совмещение нормального соматического полового созревания с задержкой становления сексуальности.

В детстве задержки психосексуального развития не привлекают особого внимания родителей или педагогов и воспринимаются как показатели благополучного воспитания. Такие дети не проявляют полового любопытства, а полоролевые игры сведены у них к минимуму или вообще отсутствуют. При этом у них происходит правильное становление полового самосознания и формируется адекватная половая роль. Ретардации становятся более заметными в подростковом возрасте, когда затрудняется формирование сексуальной ориентации. В дальнейшем половое влечение как у мужчин, так и у женщин не достигает зрелости, оставаясь на стадиях платонического или эротического либидо. В ряде случаев полоролевые игры «в семью», «дочки-матери», типичные для детей 5 - 7 лет, из-за трудностей общения со сверстниками переносятся на школьные годы. «Недоигравшие» в свое время дети группами и поодиночке продолжают увлеченно играть в куклы, порой даже в старших классах. Вместе с тем эти игры уже качественно отличаются от полоролевых игр дошкольников, поскольку осведомленность в вопросах пола к этому возрасту выше, а гормональный уровень существенно изменяется. Эти игры как бы заполняют «брешь» в становлении сексуальности, формируя ролевые установки. Однако совпадение игр с гормональной активностью может привести к формированию суррогатных форм реализации либидо и иска-

жению направленности полового влечения. Наибольший процент сексуальных ретардаций приходится на этап формирования психосексуальных ориентации. Так, задержки преимущественно на эротической стадии становятся одним из важнейших механизмов возникновения сексуальных девиаций. Неправильное половое воспитание и другие отрицательные влияния микросоциальной среды приводят не только к социогенным ретардациям, но и к нарушениям формирования психики ребенка и подростка в целом.

Обычно женщины значительно больше, чем мужчины, страдают от чрезмерной «бдительности» воспитателей на всех этапах становления сексуальности. У мужчин же, испытывающих серьезные проблемы уже при первых сексуальных контактах, нередко можно выявить своеобразный психологический барьер, затрудняющий интимные отношения с противоположным полом. Как правило, это результат неразвитости платонической и эротической коммуникаций. Отсутствие практических навыков, которые они не смогли получить в процессе становлении сексуальности, значительно затрудняет общение с партнершей еще на платоническом уровне, а гармоничный переход к эротической близости с последующим сексуальным контактом практически невозможен. В результате без истинного сексуального влечения, не умея заранее программировать, а по ходу общения с партнершей корректировать свое поведение, они идут на половую близость, заведомо обреченную на неудачу. Все их попытки, минуя платоническое общение и эротический контакт с партнершей, сразу «перескочить» к сексуальным отношениям принимают утрированный, подчас нелепый характер, отталкивая большинство женщин. В редких случаях с помощью благожелательной партнерши удается преодолеть все трудности подготовительного периода, но сам половой акт нередко заканчивается неудачей, усиливая у мужчин чувство сексуальной неполноценности. Особенно наглядно выраженные задержки психосексуального развития проявляются у мужчин отсутствием эякуляции и оргазма, несмотря на значительную длительность половых актов.

Коррегирующее лечение ретардаций психосексуального развития предусматривает проведение реконструктивной психотерапии, которая включает ряд последовательных мероприятий по формированию у пациентов адекватных

представлений об интимных отношениях и выборе потенциального сексуального партнера, выработки оптимальной модели поведения на всех этапах сближения (от первого знакомства и платонического ухаживания до эротических ласк и полового акта). Адаптивная поведенческая роль закрепляется вначале в воображении (на фоне мышечной релаксации или в гипнотическом состоянии), а затем последовательно реализуется в реальных партнерских отношениях.

Преждевременное психосексуальное развитие - раннее становление сексуальности, опережающее средние возрастные нормы и половое созревание. К его причинам относят врожденное или раннее поражение глубоких структур мозга, проявляющееся снижением порогов оргастического рефлекса, которое способствует быстрому закреплению патогенных влияний социальных факторов (растление и совращение ребенка подростками или взрослыми). Играют роль психические расстройства (шизофрения, начавшаяся в раннем возрасте, расстройства поведения, олигофрения), которые затрудняют коммуникации со сверстниками, способствуя ранней фиксации интереса детей на сексуальной сфере. Реализация различных, часто девиантных форм половой активности в возрасте до 10 лет приводит к их прочной фиксации с формированием выходящего за рамки нормы сексуального стереотипа, который в дальнейшем практически не поддается терапевтической коррекции.

Во всех случаях преждевременного психосексуального развития требуется постоянное индивидуальное наблюдение за ребенком взрослыми. Семейная психотерапия направлена на выработку у родителей адекватного отношения к ребенку и поведения с ним, обеспечение деликатного, но эффективного контроля его контактов со сверстниками. При психических расстройствах и неврологических нарушениях проводится их лечение.

3.3. Нарушение стереотипа полоролевого поведения

Трансформация полоролевого поведения - формирование полового поведения, свойственного другому полу, при правильном половом

самосознании (В.М. Маслов, И.Л. Ботнева, Г.С, Васильченко, 1983, 1990). Половая роль

195

(син. тендерная роль) - модель социального поведения, специфический набор нормативных требований и ожиданий, предъявляемых обществом к лицам мужского или женского пода. Легкие нарушения половой дифференцировки структур мозга в процессе внутриутробного развития являются фоном для основного фактора патогенеза полоролевых нарушений - микросоциальных влияний в раннем детском возрасте. К ним относятся: попытки родителей воспитывать ребенка в «другом поле»; нарушения половых ролей в семье (маскулинное поведение у матери и фемининное у отца); неполные семьи, в которых мать воспитывает сына «по своему образу и подобию»; изоляция девочек от матери или недостаточная материнская Любовь и отсутствие ласки в детстве.

Полоролевые нарушения проявляются уже с 3 - 6 лет: девочки играют в войну, машинки и самолетики, дерутся, охотно надевают мальчишескую одежду, а мальчики растут мягкими, ласковыми, послушными, избегают конфликтов, любят помогать дома по хозяйству, опекают малышей, с удовольствием занимаются музыкой, танцами.

Взрослым женщинам с трансформацией половой роли свойственны негативное отношение к представительницам своего пола, строгая одежда, безразличие к украшениям и косметике, короткая стрижка, выбор мужских профессий, товарищеское отношение к мужчинам, стремление к лидерству и социальному продвижению. Характерно запаздывание интереса к половой жизни (причем влюбленность чаще носит платонический характер), а попытки партнера перейти к интимным ласкам воспринимаются ими как оскорбление. Сексуальная адаптация таких женщин протекает легче со старшими по возрасту и положению мужчинами. Реже у них наблюдается раннее начало половой жизни с беспорядочными связями, которые долго не приносят сексуального удовлетворения. Женщины с трансформацией полоролевого поведения обнаруживают легкие садистические наклонности, которые обычно реализуются ими через моральное унижение партнера.

Феминизированные мужчины достаточно хорошо социально адаптируются. В силу своей мягкости, конформности, домовитости они

находят себя в кулинарном искусстве, моделировании и пошиве одежды и т. п. В браке - избавляют

жену от домашних забот. Однако их пассивность в половой близости может приводить к супружеским конфликтам и даже разрыву отношений.

Мужчины и женщины с трансформацией полоролевого поведения нередко испытывают затруднения в сексуальных отношениях с противоположным полом. Кроме того, полоролевая трансформация в части случаев сочетается с гомосексуальной ориентацией.

Коррегирующее лечение проводится в случаях семейно-сексуальных дисгармоний либо при неудачных попытках наладить партнерские отношения. В этих случаях используется реконструктивная психотерапия с целью исправления искажений этапа формирования полоролевого поведения. При выявлении признаков формирования полоролевых нарушений у детей коррекционные мероприятия направлены на акцентирование половой роли, адекватной генетическому полу и половому самосознанию. Родителям важно использовать позитивное подкрепление любых действий ребенка, которые соответствуют его полу.

Б.Е. Алексеев (2002, 2006) наряду с описанными выше трансформациями полоролевого поведения выделяет его акцентуации, которые характеризуются более сглаженной, частичной инверсией половой роли. Им предложена специальная методика диагностики кроссполовых акцентуаций полоролевого поведения (см. приложение).

Кроссполовая акцентуация полоролевого поведения у женщин. Их внешность наиболее соответствует портрету деловой женщины. Одежда помогает выразить свою телесную идентичность в наиболее желательной форме. Типичен выбор стильного делового костюма или неброской традиционно женской одежды. Не стремится сделать макияж заметным, использование косметики носит нерегулярный характер. Отсутствие макияжа не вызывает дискомфорта. Нехарактерно ношение распущенных волос или притязательных дамских причесок. Могут пользоваться отдельными украшениями, что скорее соответствует определенному регламенту, чем стремлению как-то выделиться. Поскольку полоролевое поведение и половая идентичность могут быть рассогласованы, в ряде случаев маскулинно акцентуированному полоролевому поведению

женщины может сопутствовать традиционная по убранству внешность. Внешность

197

(стиль в одежде, украшениях, косметике) женщин с маскулинной акцентуацией полеролевого поведения в процессе их полоролевой социализации может меняться. Например, от образа унисекса к образу женщины с экстравагантной внешностью. Обычно это обусловлено гиперкомпенсаторными механизмами, направленными на реализацию нормативных установок (привлечение внимания мужчин, создание семьи). В период полового созревания у женщин с кроссполовой акцентуацией несколько чаще, чем у женщин без акцентуаций полоролевого поведения, возникает недовольство своим телом, например, они могут тяготиться менструациями. Появление признаков полового созревания (изменение фигуры, появление молочных желез) не сопровождается позитивным чувством «превращения» в девушку, скорее они вызывают душевный дискомфорт. Эмоциональное принятие своего телесного «Я» происходит с некоторым запозданием. Многие девушки с кроссполовой акцентуацией увлечены спортом, в том числе традиционно мужскими видами. У них наблюдается некоторая задержка психосексуального развития на платонической или эротической стадии этапа формирования психосексуальных ориентации (в фазе формирования установки или частичной реализации). Этому способствуют складывающиеся с детства «товарищеские» отношения с лицами противоположного пола. Общение, долгое время лишенное сексуально-эротической окраски, приводит к тому, что женщины подобного склада плохо распознают ситуации, предполагающие сексуальные притязания со стороны мужчины. Неудивительно, что женщины с акцентуацией полоролевого поведения в подростковом возрасте нередко становятся жертвами сексуального насилия. Общение с мужчинами по сравнению с общением с женщинами воспринимают как более содержательное и интересное, находят множество общих тем, обнаруживают общие с мужчинами подходы к решению многих вопросов. Вместе с тем не избегают общества женщин, обсуждая с ними «женские» темы, которые они не смогли бы обговорить с мужчинами. В отношениях с партнером такие женщины стремятся занимать лидирующее

положение, проявляют повышенную требовательность. Поэтому у них нередко возникает проблема: «Почему от меня уходят мужчины». Они не

замечают того, что подавляют партнера не только постоянными требованиями и взыскательностью, но и своим авторитетом, успешностью на социальном поприще. Взаимоотношения с партнером приобретают конкурентный характер, а негативный душевный осадок, который они оставляют, переносится на сексуальные отношения, разрушая их. В партнерских отношениях с мужчиной адаптация возможна по принципу взаимодополнения, то есть мужчина должен иметь фемининную акцентуацию полоролевого поведения. В этом случае интимные отношения могут складываться вполне удовлетворительно. Однако при наличии дополнительных неблагоприятных факторов такое ролевое соотношение является почвой для развития сексуальных дисгармоний в супружеской паре.

Женщины с маскулинной акцентуацией полоролевого поведения проявляют высокую стеничность, способны постоять за себя и отстоять свои интересы. Их характеризуют деловой стиль и стремление к социальному продвижению. Семья может занимать важное, но не главенствующее место в системе ценностных ориентации.

Кроссполовую акцентуацию полоролевого поведения мужчин отличает от трансролевого поведения сглаженность фемининных черт. Они носят обычную мужскую одежду. Пластика движений более плавная и тонкая, чем это свойственно маскулинному типу мужчин. В их речи чаще звучат слова в уменьшительно-ласкательной форме, они не склонны к использованию ненормативной лексики. Формальное лидерство часто является для них обременительным, требующим усилий. Среди неформальных лидеров они практически не встречаются. В повседневной жизни могут хорошо поддерживать общение как с мужчинами, так и с женщинами, если оно затрагивает формальные вопросы, например профессионального характера. В неформальной же обстановке таким мужчинам легче и интереснее общаться и находиться в женском обществе. Темы, которые любят обсуждать в неформальной мужской компании, для них малоинтересны, поэтому им трудно поддерживать заинтересованный контакт. В решении жизненных

ситуаций избегают открытых конфликтов, склонны применять гибкую тактику (выжидание, отступление, обращение за помощью).

199

Многие мужчины с кроссполовой акцентуацией полоролевого поведения испытывают неуверенность при знакомстве с понравившейся женщиной, особенно на пути приобретения такого опыта. В связи с этим им свойственны тайные, неразделенные влюбленности. Они мечтают о том, чтобы женщина сама проявила инициативу. Преодолеть себя и продемонстрировать свою симпатию для них равносильно отчаянному поступку. В семейной жизни делят с женой домашние обязанности и заботу о детях. В сексуальных отношениях ласковые, внимательные к партнерше. Однако, если женщина ожидает от партнера в интимных отношениях более маскулинного, завоевательного поведения, возможно, включающего легкий садистический компонент, то в этом случае отношения с феминино акцентуированным мужчиной будут приводить к неудовлетворенности и дисгармонии а отношениях (Б.Е. Алексеев, 2006).

Гиперролевое поведение - чрезмерная акцентуация некоторых особенностей половой роли (В.М. Маслов, И.Л. Ботнева, Г.С. Васильченко, 1983, 1990). Его формирование в определенной мере связано с нарушениями процесса половой дифференцировки мозга в пренатальном периоде. В экспериментах на животных установлены заметные половые различия в двигательной активности, уровне агрессивности, материнском инстинкте. Их выраженность определяется чувствительностью глубоких структур мозга к андрогенам или эстрогенам, которая связана с особенностями полосой дифференцировки структур мозга плода. Вместе с тем наиболее важное значение имеют прививаемые нормы микросоциальной среды, например, повсеместно распространенные высокие требования к маскулинному поведению, которое у многих народов традиционно ценится выше подчиненного и зависимого фемининного (страны мусульманского мира). Формированию гиперролевого поведения способствуют и личностные особенности. Гипермаскулинному поведению больше созвучны гипертимные, эмоционально неустойчивые, диссоциальные, отчасти истерические расстройства личности и сходные с ними акцентуации характера, а

гиперфемининному - тревожные, ананкастные, зависимые расстройства личности и акцентуации психастенического, сенситивного, астеноневротического, конформного, реже истероидного типов.

200

Гипермаскулинное поведение проявляется в гипертрофированно мужском типе поведения, стремлении к получению сугубо «мужских» престижных профессий, занятиям чисто «мужскими» видами спорта (бокс, каратэ, хоккей). Характерно подчеркнуто пренебрежительное отношение к женщинам и всем видам «женского» труда. На этапе формирования половой роли гипермаскулинность выражается в повышенной агрессивности, стремлении к неформальному лидерству. В половой жизни ярко выражено эгоистическое стремление к достижению собственного оргазма при игнорировании потребностей женщины в ласках и безразличии к ее сексуальной неудовлетворенности. Для гипермаскулинного полоролевого поведения достаточно характерны садистические элементы, которые не выходят за границы крайних вариантов нормы. Элементы садизма проявляются принуждением к половой близости, грубым овладением женщиной, причинением ей боли. Обычно мужчине вполне достаточно только разыгрывания подобных сцен и его действия носят символический характер. Ведущим является ощущение безграничной власти, чувство господства над партнершей при ее полной покорности. Мужчины с гиперролевым поведением тяжело переживают любое ухудшение половой функции и легко дают невротические реакции даже при ее возрастном физиологическом снижении.

Как компенсаторное, гипермаскулинная поведение нередко встречается у подростков, стремящихся утвердиться как в собственных глазах, так и в глазах сверстников. Такое поведение не всегда выглядит естественным, часто контрастируют возможности и притязания подростка. Нарочитая агрессивность, грубость, готовность в любой момент вступить в драку, курение, употребление психоактивных веществ выступают лишь как средство утверждения в мужской роли. Характерно увлечение единоборствами и другими «мужскими» видами спорта, которые дают возможность наносить соперникам телесные повреждения. Приемы карате,

дзюдо, боксерские навыки они готовы применять на «практике», при любом удобном случае участвуя в драках, жестоких избиениях, которые обычно носят групповой характер. Гипермаскулинные подростки стремятся к лидерству, которое они поддерживают в группе сверстников не столько силой и уверенностью, сколько жестоко-

стью. В большинстве случаев подобное поведение является транзиторным и с возрастом сглаживается. В отдельных случаях оно может приобретать патологический характер, когда садистические элементы уже не носят игровой характер, как это бывает при обычном гиперролевом поведении, а проявляются систематическими издевательствами над животными, младшими детьми или более слабыми сверстниками. Отказ от любой работы по дому и пренебрежение к «женским» чертам характера трансформируются в циничное отношение к женщинам вообще и как к сексуальным партнерам в частности. Примитивно-шаблонный стереотип сексуального поведения сочетается с грубым принуждением к половым контактам, отказ от которыхобычно приводит к избиению партнерши. Если мужчина получает удовлетворение только при унижении партнерши или жестоком обращении с ней, то это говорит о сексуальном садизме, который может быть отнесен к *патологическому гипермаскулинному поведению* и является перверсией (см. далее). Важным фактором формирования патологических форм гипермаскулинного поведения является отсутствие у маленького ребенка тактильного и эмоционального контакта с матерью или другим ухаживающим за ним лицом, к которому в норме должна возникать первая привязанность. Это способствует развитию у детей агрессивного поведения, причем элементы садизма, возникающие в раннем возрасте, в последующем обычно сохраняются, создавая основу для развития перверсного влечения. В наиболее тяжелых случаях садизма половое удовлетворение наступает при нанесении жертве телесных повреждений или даже ее умерщвлении, причем максимальное возбуждение достигается при виде агонии.

Гиперфемининное поведение характеризуется подчеркнутой пассивностью, подчиняемостью, полной самоотдачей, материнским заботливым отношением не только к детям, но и ко всем окружающим,

домовитостью. Повышенная конформность, умение приспособиться к любым особенностям и требованиям партнера, порой достигающие степени гротеска, способность испытывать подлинную радость от того, что живешь его интересами, - все это свойственно гиперфемининному поведению, блестяще описанному А. П. Чеховым в рассказе «Душечка». Женственность,

кокетство, увлечение косметикой, нарядами, украшениями свойственны таким женщинам. В половой жизни все их усилия и устремления направлены на удовлетворение мужчины, порой даже во вред себе. Этих женщин мало волнует отсутствие оргазма, его полностью замещает психологическое удовлетворение от радости, которую она доставляет любимому человеку. Если отсутствие оргазма все же приводит такую женщину на прием к сексологу, то на первом плане стоит не жажда наслаждения, а страх что мужчина не получит с ней полного удовлетворения. Поскольку в нормальном половом акте нередко имеются определенные мазохистские проявления, гиперролевое поведение женщин обычно воспринимается как естественная женственность и особого внимания не привлекает.

Отчетливо выраженные и устойчивые мазохистские элементы в сексуальном поведении женщины представляют собой *патологическое гиперфемининное поведение (мазохизм).* В основе формирования мазохистических тенденций и установок, в отличие от садизма, лежит не отсутствие контакта с матерью, а наоборот, гиперопека и заласканность. Мазохизм проявляется в получении удовольствия при унижении и физических страданиях, доставляемых партнером, и выступает как перверсия. Без подобных действий партнера удовлетворение, как правило, не наступает.

И у мужчин, и у женщин гиперролевое поведение обостряет сексуальные переживания, способствуя более быстрому получению удовлетворения от половой близости. Гиперролевое поведение при сексуальных контактах может сочетаться как с гиперролевым, так и с обычным стилем поведения в остальных сферах жизни. Гиперролевое поведение на фоне трансформации половой роли гораздо чаще ведет к патологическим гиперролевым установкам, т. е. к появлению перверсных элементов: у женщин - садизма, у мужчин - мазохизма.

Гиперролевое поведение обычно не является патологией и расценивается как крайний вариант нормы. Б.Е. Алексеев (2006) выделяет более мягкие варианты усиления половой роли: фемининную акцентуацию полоролевого поведения у женщин и маскулинную акцентуацию полоролевого поведения у мужчин. Являясь частыми вариантами нормы, фемининные и маскулинные, а также кроссполовые акцентуации

203

полоролевого поведения у мужчин и женщин сужают диапазон их адаптационно-приспособительных реакций, что может затруднять создание устойчивых партнерских отношений, а в супружестве приводить к сексуальным дисгармониям и конфликтам, обусловленным неадекватным друг для друга стилем поведения и несоответствием представлений о браке и семейной жизни. Этому также, способствует возникающий у ряда лиц с полоролевыми акцентуациями внутренний конфликт (полоролевой конфликт, по Б. Е. Алексееву), обусловленный несогласованностью полоролевого поведения субъекта и его половой идентичности. Поэтому в ходе проведения психотерапии сексуальных дисгармоний и дисфункций, супружеских дисгармоний следует учитывать индивидуальные особенности (акцентуации) полоролевого поведения каждого из супругов.

Гиперролевое поведение, не выходящее за пределы нормы, специального лечения не требует. Однако при явном несовпадении ролевых установок партнеров необходима их психотерапевтическая коррекция. Попытки изменить поведение партнера с гиперролевым поведенческим стереотипом обычно малоэффективны, поэтому основные терапевтические усилия направляют на адаптацию второго партнера.

Диагностика патологического гиперролевого поведения - садизма и мазохизма, бывает затруднена в связи с недостаточной откровенностью пациентов, сознательно скрывающих перверсные проявления. Для их выявления необходимо тщательно анализировать этапы становления сексуальности, условия и ситуации возникновении первых оргазмов, побуждать подробно описывать эротические сновидения и по возможности получать объективные сведения от партнера. Принципы терапии сексуальных перверсий, к которым относят патологическое в гиперролевом

поведении в виде садизма или мазохизма, изложены далее, в разделе *Расстройства сексуального предпочтения (F65).*

3.4. Феномен гомосексуальности

Гомосексуализм - гомогендерная сексуальная ориентация, характеризующаяся сексуально-эротическим влечением к лицам своего пола. С середины XIX века термин

«гомосексуализм» употребляется для обозначения сексуальной активности, сексуальных связей (а не только полового влечения) между лицами одного пола. Гетеросексуальность - феномен, присущий подавляющему большинству людей. Он лежит в основе деторождения, обеспечивает продление человеческого рода, а следовательно, является биологически целесообразным. Однако во все времена и у всех народностей существовали мужчины и женщины, предпочитающие однополую любовь. Частота гомосексуализма по данным разных авторов варьирует от 1 до 4 % у мужчин и от 1 до 3 % у женщин. Следует отметить, что гомосексуальность - неоднозначное явление, ибо в одних случаях влечение к лицам своего пола может проявляться только в сновидениях и фантазиях, но никогда не реализуется на практике; в других - при определенных обстоятельствах допускаются единичные гомосексуальные контакты; в-третьих - субъект имеет сексуальные отношения с лицами обоих полов, причем они в равной мере привлекательны для него; в-четвертых - гомосексуальные связи являются предпочтительными; в-пятых - сексуальные контакты с лицами того же пола, что и субъект, являются для него единственно возможным источником удовлетворения. Выделяют три основных этапа формирования гомосексуальной ориентации: 1) от первого осознанного интереса к представителю своего пола до первого подозрения о своей гомосексуальности (мужчины - 14,6 лет, женщины - 18,2 года); 2) от первого подозрения о своей гомосексуальности до первого гомосексуального контакта (мужчины - 16,7 лет, женщины - 19,8 лет); 3) от первого гомосексуального контакта до уверенности в своей гомосексуальности и выработки соответствующего стиля жизни (мужчины - 19,0 лет, женщины - 20,7 года). По ролевому поведению различают активных и пассивных

гомосексуалов, исходя из того, что во время половых сношений один из партнеров играет активную (мужскую) роль, а второй - пассивную (женскую). В настоящее время жесткое распределение ролей при гомосексуальных половых контактах встречается крайне редко. Значительно чаще, желая доставить большее удовольствие друг другу, партнеры меняются ролями. При половой близости гомосексуалы практикуют поцелуи и объятия, стимуляцию груди мануально или орально,

взаимную мастурбацию, трение гениталий друг о друга (трибадия у женщин), орально-генитальные ласки (минет, куннилингус), ласки языком анального отверстия (аннилингус), подовое сношение в прямую кишку (мужеложство или педерастия). У гомосексуален число связей в среднем выше, чем у лиц гетеросексуальной ориентации. Многие из них имеют за время половой активности до 100 партнеров и более. В целом диапазон половых контактов гомосексуадов достаточно широк - от длительных моногамных связей (гомосексуальные браки) до группового секса, от анонимных или разовых встреч до романтических ухаживаний и пылкой эротической любви к партнеру. В странах, где уже давно отсутствует социальная дискриминация по признаку сексуальной ориентации, чаще наблюдаются устойчивые связи между гомосексуалами. В некоторых из них (Дания, Норвегия, Швеция и др.) официально разрешено однополое «зарегистрированное партнерство», практически идентичное браку.

Обратимся к истории вопроса. Косвенные доказательства давнего существования в человеческой популяции однополой любви можно найти в Ветхом Завете. Гнев Господа возбудили жители Содома и Гоморры, которые были настолько одержимы голубыми страстями, что чуть не изнасиловали ангелов. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь с неба», показав пример будущим нечестивцам. Святые апостолы Петр и Павел причисляли «мужеложников» к тем «неправедным», кои за грехи свои не будут жить жизнью вечной, ибо Господь проклял их.

Первые упоминания о гомосексуализме обнаружены в папирусах Древнего Египта (2,5 тыс. лет до н. э.). Известно, что гомосексуальные

отношения имели место у первобытных народов Африки, Азии и Америки. Особый культ этих отношений отмечается в Древней Греции, где женский гомосексуализм получил название лесбийской любви, или сафизма, по имени древнегреческой поэтессы Сафо, жившей на острове Лесбос. Древние греки допускали и даже одобряли гомосексуальные отношения между взрослым свободным мужчиной и свободным юношей. Древнеэллинская педерастия была формой сексуальной и социальной инициации. За любовника-ученика мужчина-воин брал на себя ответственность перед обществом. Гордостью Фив был на-

бранный из воинов-любовников и снискавший репутацию непобедимого «священный отряд». Философ Ксенофонт утверждал: «Нет сильнее фаланги, чем та, что состоит из любящих друг Друга воинов!». В Спарте каждый двенадцатилетний мальчик получал в покровители взрослого и опытного воина. Такой союз спартанцы рассматривали как брачный. Если на поле брани юноша проявлял трусость - наказывали его наставника. Спартанские обычаи предписывали расторгнуть гомосексуальный брак сразу после появления волос на теле юноши. В древнегреческом гомосексуальном браке ролевые функции были строго разделены. Юноше принадлежала роль «женщины» (что символизировало его подчиненное положение), а взрослый мужчина всегда выполнял активную роль. Считалось, что «женская» роль не роняла достоинства юноши. Но если за деньги или даже по принуждению взрослый эллин разрешал «войти в себя», он был обречен на несмываемый позор.

Древние римляне превыше всего ценили мужественность. Сожительство Гая Юлия Цезаря с царем Вифинии Никомедом навлекло на будущего римского императора «всеобщее поношение». Причем римляне ругали Цезаря не за гомосексуализм как таковой, а за его «пассивность», роль женщины в голубом альянсе. В Риме периода упадка не имела предела развратность императора Нерона. Мальчика Спора он кастрировал и даже попытался сделать женщиной. Когда из этого ничего не получилось, Нерон решил стать законным мужем евнуха! После свадьбы он ввел Спора в императорский дворец и «жил с ним как с женой». Разведясь со Спором, он «вышел замуж» за бывшего раба Дорифора. Нерон любил экзотические

бисексуальные потехи. Светоний пишет: «В звериной шкуре он выскакивал из клетки, набрасывался на привязанных к столбам мужчин и женщин и, насытив дикую похоть, отдавался Дорифору, крича и вопя, как насилуемая девушка». В период правления Нерона весь Рим поглотила пучина разврата.

Первые юридические законы против гомосексуалов мы находим в кодексе византийского императора Юстиниана и в своде законов Вестготского королевства (VI век). И все-таки в раннем Средневековье их положение было скорее удовлетворительным. Гомосексуализм был широко

распространен среди феодальной знати. Самый известный педераст того времени - английский король Ричард Львиное Сердце.

Поначалу каноническое право не карало слишком строго за гомосексуализм. Пенитенциарий Папы Римского Григория III (VIII век) покаяние за лесбиянство определил сроком в 160 дней, за мужеложство - в один год, а за участие священнослужителя в охоте - в три года. Но уже III Латеранский собор, состоявшийся в 1123 году, установил очень жестокое наказание церковников, уличенных в гомосексуальных связях: вначале их отправляли в монастырь на покаяние, потом - на костер. В 1307 году французский король Филипп IV Красивый произвел по всей Франции внезапный арест членов рыцарского ордена тамплиеров. Он приговорил их к смерти, обвинив в надругательстве над святым Распятием, идолопоклонстве и содомии. В XIV веке горькая участь постигла английского короля-гомосексуала Эдуарда II. Династические соображения заставили его жениться на дочери французского короля Изабелле Валуа. Она вскоре завела себе любовника - весьма амбициозного феодала Мортимера. Коварные любовники организовали против Эдуарда II заговор, обвинили короля в «грехе содомском» и заточили его в замок Бершиц. Впоследствии Эдуард погиб мучительной смертью - по приказанию Мортимера его посадили на раскаленный докрасна железный прут. К началу XV века из-за эпидемий чумы население Европы уменьшилось почти в четыре раза. Власти начали активно бороться против того, что препятствует деторождению, прежде всего против онанизма и гомосексуализма. Например, а XVI веке английский король Генрих VIII,

который был женат шесть раз, что противоречило тогдашним церковным и гражданским законам, объявил мужеложство государственной изменой.

Гуманисты эпохи Возрождения возродили античные традиции телесности. Они воспевали совершенное человеческое тело как идеал красоты. Но до реабилитации «содомского греха» было еще далеко. К концу XVIII века в Европе существовало крайне жестокое, нетерпимое отношение к гомосексуализму, во многих странах за гомосексуальные контакты предусматривалась смертная казнь. В XIX веке в некоторых странах происходит постепенное смягчение законов. Например, кодекс Наполеона призна-

ет гомосексуальный контакт между взрослыми преступлением лишь в тех случаях, когда применяется насилие либо контакты осуществляются публично и оскорбляют общественную мораль. Аналогичное законодательство было введено в Бельгии и Голландии. В других странах, включая царскую Россию, гомосексуализм по-прежнему оставался уголовным преступлением, «неназываемым пороком». С конца XIX века растет волна протестов против уголовного преследования гомосексуалов, многие известные деятели науки, культуры и искусства включаются в это движение. Однако еще в начале прошлого века гомосексуальные контакты были уголовно наказуемыми. Именно за них староанглийский суд приговорил к двум годам тюремного заключения Оскара Уайльда, который впоследствии так и не смог оправиться от остракизма викторианского общества. В тоталитарных странах гомосексуализм преследовался с жестокостью ничуть не меньшей, чем инакомыслие. В гитлеровской Германии наряду с евреями и цыганами физическому уничтожению подлежали и лица с гомосексуальной ориентацией. В марте 1934 года появилось постановление Президиума ЦИК СССР «Об уголовной ответственности за мужеложство», которое установило за него гораздо более жесткие наказания, чем те, которые существовали в дореволюционной России. Статья 121 Уголовного кодекса РСФСР карала мужеложство лишением свободы на срок до пяти лет, причем женский гомосексуализм не являлся уголовно наказуемым. Несмотря на всю абсурдность статьи по ней было осуждено около 60 000 человек.

После Второй мировой войны на формирование общественного мнения и юридического законодательства значительное влияние оказали работы американских исследователей, в частности, впервые было научно доказано, что гомосексуализм - это не болезнь, не извращение, а иная сексуальная ориентация. В 60 - 70-е годы XX века подавляющее большинство стран исключило из уголовного законодательства статьи, преследующие за гомосексуальные контакты. В России это произошло в 1993 году. Американская психиатрическая ассоциация в 1974 году официально признала, что гомосексуализм не является заболеванием или патологическим состоянием. Всемирная организация здравоохранения внесла аналогичные изменения в Меж-

дународную классификацию болезней 10-го пересмотра (1992). В ней указано, что «сама по себе сексуальная ориентация не рассматривается как расстройство». Отмена одиозного диагноза не означает, что все гомосексуалы зо всех отношениях здоровы, и они не могут иметь никаких психических отклонений. Речь идет лишь о том, что сама сексуальная ориентация, подобно полу или расе, больше не считается патологической и не нуждается в обязательном лечении (если субъект испытывает душевные страдания от «аномального», с его точки зрения, полового влечения - ему требуется психотерапевтическая помощь). К началу 80-х годов в США отношение к гомосексуалам становится спокойным и терпимым. Даже сам термин «гомосексуализм» исчезает из речи: они называют себя «геями», «голубыми», «лесбиянками». В прессе пишут о «лицах, практикующих альтернативный образ жизни». Американская перепись 2000 года зафиксировала свыше 600 000 так называемых однополых домохозяйств. Несмотря на то, что большинство американцев продолжают считать гомосексуальную ориентацию «неправильной», 85 % опрошенных службой Гэллапа людей убеждены в том, что геи и лесбиянки должны пользоваться теми же правами, что и другие граждане. Аналогичная ситуация наблюдается в Европе. Первой в 1989 году однополые «зарегистрированные партнерства» узаконила Дания. Ее примеру последовали Норвегия, Швеция, Исландия, Гренландия, Финляндия, Германия. Франция и Бельгия внесли в гражданское

право понятие «пакт гражданской солидарности», который могут заключить между собой «двое взрослых разного пола или одного пола для регулирования их совместной жизни». В 2001 году Нидерланды стали первым в мире государством, предоставившим однополым парам абсолютно такие же права по заключению брака, как и разнополым.

Современная наука не может однозначно ответить на вопрос о происхождении гомосексуальности. Выдвинуто множество различных теорий возникновения гомосексуализма: эндемическая теория Бартона, генетическая, неврогенная, нейроэндокринная Тернера, эндокринная, условно-реф-лекторная, психоаналитическая и др. На Западе широко распространена теория Э. Хукер, согласно которой люди рождаются сексуально индифферентными

и имеют скорее общую сексуальную предрасположенность, чем гомо-, гетеро- или бисексуальные предпочтения. В дальнейшем же сексуальный опыт определяет выбор сексуального объекта.

3. Фрейд считал, что однополая любовь имеет те же психологические истоки, что и разнополая, а именно - врожденная предрасположенность каждого человека к бисексуальности. В обычной обстановке психосексуальное развитие человека определяет его гетеросексуальный выбор. При особых жизненных обстоятельствах (например, неправильное разрешение Эдипова комплекса) нормальное развитие может остановиться на одной из промежуточных стадий и в будущем трансформироваться в гомосексуализм. Считая, что для всех людей без исключения характерны скрытые гомосексуальные наклонности, Фрейд был уверен, что при определенных условиях они могут проявиться в виде гомосексуального поведения в зрелом возрасте. Интересен отрывок из его письма, адресованного матери одного гомосексуала: «Несомненно, гомосексуализм не преимущество, но и стыдиться его незачем. Это не порок, не деградация, не болезнь. Мы считаем его разновидностью сексуального развития. Многие глубоко уважаемые личности прошлого и настоящего были гомосексуалами. Вот имена некоторых из них: Платон, Микеланджело, Леонардо да Винчи и

др. Это великая несправедливость - преследовать гомосексуализм как преступление - и жестокость тоже».

В. Райх (1971) ссылался на результаты исследований Малиновского (1929), проведенные на островах Тробриан в Меланезии, где у местного населения практически не встречались гомосексуальные связи, мастурбация, садизм, фетишизм, эксгибиционизм и неврозы. Райх объяснял это тем, что тробрианцы с малых лет приобретают знания о сексуальности через собственную практику, которая ограничивается лишь существующим в обществе табу, связанном с инцестом. Детям и подросткам там разрешается в собственном темпе, без отягощения чувством стыда и вины свободно исследовать собственную сексуальность и уже с раннего пубертатного возраста разряжать накопленную сексуальную энергию естественным путем через достижение оргазма при коитусе. В таких условиях, по мнению

Райха, формируется естественная, т. е. гетеросексуальная генитальная сексуальность. Человек приобретает оргастическую потенцию и никакие, по терминологии Райха, извращенные (негенитальные или негетеросексуальные) формы половых контактов не могут закрепиться.

Согласно нейроэндокринной теории, гомосексуализм предопределяется нарушениями процесса половой дифференцировки мозга, которые приводят к искажению чувствительности гипоталамуса к гормональным воздействиям. Предложены гипотезы и теории средовой обусловленности: семейная - материнская гиперопека, «перепутанные» половые роли у родителей, негативно воспринимаемые отцы, отрицательный опыт контактов с братьями и позитивный с сестрами, освоенность с мужской наготой и отсутствие таковой в отношении женской наготы и т. п.; профессиональная (богемная артистическая) среда; образа жизни (цыганский табор). Существует гипотеза ситуационной обусловленности и научения (гомосексуальное совращение, гомосексуальные контакты с ровесниками, последствия случайных и транзиторных гомосексуальных контактов). Теория заместительной обусловленности приписывает основную роль в формировании гомосексуального влечения однополым сексуальным контактам в изолированных мужских

коллективах - в местах лишения свободы, в интернатах, в воинских частях и военных учебных заведениях, в монастырях и теологических учебных заведениях и т. п. Выдвинута и гипотеза фантазийной обусловленности гомосексуализма (например, под влиянием порнографии или сопутствующих мастурбации фантазий гомосексуального содержания).

Сексуальные контакты между особями одного пола описаны более чем у 450 видов животных. Но в большинстве случаев однополые контакты в животном мире являются эпизодическими. Исключительно гомосексуальные предпочтения встречаются лишь у некоторых птиц (гусей и пингвинов), а также домашних овец. У японских макак почти все самки являются бисексуальными. Некоторые социобиологи приписывают гомосексуальности адаптивную функцию - она позволяет снизить внутригрупповую напряженность и соперничество. У многих видов животных молодые самцы по достижению половой зрелости далеко не сразу получа-

ют доступ к самкам. Поэтому контакты с представителями своего пола уменьшают у них сексуальное напряжение и агрессивность. Нерепродуктивное поведение отдельных особей оказывается социально альтруистическим, поскольку сами, не производя потомства, они участвуют в добывании еды для своей стаи, защите ее территории, уходе за чужими детенышами (многие стадные животные воспитывают потомство сообща). Гипотеза «гомосексуального альтруизма» применима и к людям, поскольку выживание человеческой популяции зависит не столько от темпов рождаемости, сколько от производства материальных и духовных ценностей. Э. Миллер связывает происхождение гомосексуальности с генетическими факторами, считая ее побочным, но вполне закономерным продуктом эволюции. Среди монозиготных (однояйцевых) пар близнецов совпадение по гомосексуальности составляет 48 - 52 %, а у дизиготных (двуяйцевых) -16 - 22 %. Накапливаются данные о биологических коррелятах гомосексуальности (длина пальцев, строение слухового аппарата, соотношение циклов сна и бодрствования и др.), но они не могут служить ни диагностическими критериями, позволяющими отличить гомо- от гетеросексуала, ни достаточным обоснованием самого феномена

однополой любви. Точно так же ни одна из существующих теорий не объясняет полностью механизм возникновения гомосексуального влечения. Биологическая предрасположенность, даже если она и существует, вряд ли сама по себе является фатальной предопределенностью. Известно, насколько важны среда общения и жизненные обстоятельства для формирования и черт личности, и особенностей сексуального поведения подростков. Юноши и девушки отличаются повышенной впечатлительностью и зависимостью от своей среды общения. Они склонны к имитации образцов поведения (в том числе и сексуального), которые в этой среде приняты. Особенно сильны отрицательные влияния среды в интернате, армии, тюрьме и т. п. Опыт, приобретенный в этих «закрытых сообществах», может повлиять на тех молодых людей, у которых еще не сложился устойчивый стереотип сексуального поведения, и закрепить гомосексуальную форму реализации либидо.

По мнению В.М. Маслова и И.Л. Ботневой, биологические факторы (нарушения дифференциации мозга и гормональные

сдвиги) являются почвой для искажений полового самосознания и полоролевого поведения, обусловленных влиянием микросоциальной среды. По их данным, формирование гомосексуальной ориентации происходит у 30 - 40 % людей с трансформацией половой роли.

К числу важнейших мероприятий по психогигиене пола у детей и подростков, которые способствуют становлению гетеросексуальности, относятся: предупреждение нарушений внутриутробного развития плода, формирование у ребенка половой идентичности, предполагающей единство полового самосознания и ролевого поведения; выявление и медико-психологическая коррекция искажений психосексуального развития на его ранних этапах; правильное полоролевое воспитание, направленное на ознакомление детей с половыми различиями и особенностями маскулинного и фемининного поведения; обучение общению со сверстниками (в том числе гетеросексуальному); предупреждение растления и совращения детей и подростков.

3.5. Сексуальные девиации

К сексуальным девиациям относят различные отклонения от принятых в современном обществе половых предпочтений (в направленности либидо и формах его реализации). Некоторыми специалистами сексуальные девиации определяются, как сексуально-эротические нарушения, при которых *половое возбуждение* или *оргазм* достигается с помощью атипичных или культурно-запрещенных действий. Известный польский сексолог К. Имелинский под сексуальными девиациями понимает нарушения в сфере сексуальных фантазий и форм поведения во взаимоотношениях с реальным или воображаемым партнером.

В зависимости от эпохи и господствующих в той или иной этнической культуре моральных норм и предписаний, одно и то же половое поведение могло быть признано нормальным либо напротив - ненормальным. Поэтому рамки сексуальных девиаций то расширялись, то сужались. Кроме того, менялось отношение общества к сексуальности и отклонениям от сексуальной нормы. Так, до наступления эпохи Средневековья отношение к сексуальным девиациям

было вполне терпимым, а многие из них даже поощрялись. В Средние века всякое отличие от существующих крайне жестких норм полового поведения считалось греховным и преследовалось церковью. В частности, описанные в XVI веке французским врачом А. Паре различные способы сексуального удовлетворения женщин были признаны аморальными, а самому автору чудом удалось спасти свою жизнь. В дальнейшем общественное мнение постепенно смягчалось, возрастала терпимость к сексуальным отклонениям, но вплоть до настоящего времени сохраняется различная степень осуждения и дискриминации лиц с девиантным поведением: от высмеивания до уголовного преследования.

В зависимости от контекста одни и те же сексуальные действия могут рассматриваться в рамках нормального полового поведения или отклонений от такового. Например, орогенитальные контакты, если они укладываются в *диапазон приемлемости* обоих партнеров и являются одной из возможных форм половой близости, расцениваются как вариант нормы. В других случаях те же орогенитальные контакты, если они неприятны одному из

партнеров, следует расценить как отклонение, чреватое опасностью невротизации. Наконец, если путем насилия, с целью морального и физического унижения партнера, его понуждают к регулярному выполнению оральной стимуляции гениталий, речь идет о патологическом девиантном поведении садомазохистского круга.

Развитие научных представлений об аномальном сексуальном поведении привело к попыткам выделения его девиантных (отклоняющихся) и перверсных (патологических) форм. На сегодняшний день в литературе описаны 132 сексуальные девиации. В своем большинстве они не носят болезненного характера. К непатологическим формам сексуальных отклонений относят, например, различные девиантные тенденции, проявляющиеся лишь в мечтах и фантазиях человека, но по тем или иным причинам никогда не реализуемые в реальной жизни. Выделяют также девиантные элементы, которые выполняют роль дополнительных стимулов, усиливающих сексуальное возбуждение индивида при половых, контактах, но не являются для него абсолютно необходимыми для достижения полового наслаждения. В ряде случаев лица с девиантной сексуально-

стью способны с эротической любви, тесным партнерским отношениям и супружеству. Это возможно при наличии таких отклонений в сексуальных потребностях и формах их реализации, которые могут быть вполне допустимы для партнера (эфебофилия, геронтофилия, фетишизм, трансвестизм, элементы садомазохизма). В отличие от девиаций перверсии сексуальные приобретают характер заболевания, имеют своеобразное течение и симптоматику, существенно затрудняют или делают невозможной нормальную половую жизнь. Субъекты, страдающие перверсиями, могут даже заключить брак и поддерживать в супружестве невысокий уровень нормативной сексуальной активности, маскируя свое аномальное половое влечение. Однако они вынуждены вступать в случайные половые связи или совершать акты сексуального насилия, чтобы время от времени реализовывать перверсные импульсы, которые не поддаются волевому контролю.

Сексуальные девиации могут быть классифицированы как отклонения в отношении объекта полового влечения (замещающие нормальный объект):

педофилия, эфебофилия, геронтофилия, зоофилия, фетишизм, нарциссизм и др.) и отклонения в способе реализации влечения (садизм, мазохизм, эксгибиционизм, вуайеризм, фроттеризм и др.). Гомосексуализм, фактически являющийся отклонением по полу объекта влечения, рассматривается большинством зарубежных специалистов как нетипичное сексуальное поведение. Следует признать, что отнесение той или иной девиации к непатологическим формам либо, наоборот, к патологии, во многом условно и обусловлено критерием тяжести состояния, т. е. глубиной социально-психологической дезадаптации субъекта и/или общественно опасным характером реализации его сексуальных потребностей. Так, проявления девиантной сексуальности, которые полностью или частично замещают нормальную половую жизнь, препятствуя установлению партнерских отношений, обезличивают и обесценивают «партнера», низводя его до роли инструмента, необходимого для получения сексуального удовлетворения, причиняют ему моральные и физические страдания, оскорбляют общественную нравственность, являются противоправными и представляют социальную опасность, традиционно относятся к сексуальным перверсиям (пара-

филиям). На сегодняшний день вряд ли имеет смысл расширять рамки парафилий, поскольку термин «сексуальные девиации» не имеет столь негативного, уничижительного значения и достаточно точно передает суть отклоняющегося полового поведения, которое является отражением огромного диапазона индивидуальных различий в проявлениях человеческой сексуальности.

В объяснении механизмов формирования сексуальных девиаций и существует много различных теорий, но ни одна из них полностью не объясняет природу их возникновения. Наиболее обоснована точка зрения о том, что сексуальные девиации представляют собой психологическую регрессию или фиксацию индивида на ранних этапах и стадиях психосексуального развития. Формированию девиантных форм сексуального поведения и переживаний могут способствовать условно-рефлекторные связи, возникающие в период становления сексуальности. При этом не всегда удается четко определить границы нормы и патологии. Если какой-то

раздражитель (часть тела, запах, предметы одежды, музыка) сочетается с сильным половым возбуждением и подкрепляется оргазмом, то в дальнейшем в силу образования прочных ассоциативных связей он сам становится стимулом, усиливающим сексуальное возбуждение при интимной близости. Но если этот же раздражитель становится почти обязательным условием полового удовлетворения, то это уже девиация.

Наличие сексуальной девиации может по разному повлиять на человека. К. Имелинский считает, что существует четыре основных варианта приспособления личности человека к сексуальному отклонению, которые оказывают значимое влияние на его существование.

1. *Признание*. Это - принятие личностью своих сексуальных особенностей, снижающее до минимума возможность возникновения внутренних конфликтов и невротических расстройств. Чаще этот вариант наблюдается при таких девиациях, которые могут быть приемлемы партнером (садомазохистские наклонности, трансвестизм, фетишизм).

2. *Согласие*. Частичное примирение человека с девиацией. Согласие характеризуется противоречивым отношением человека к своим сексуальным особенностям. С одной

стороны, он смиряется и принимает их, с другой - оценивает эти отличия как предосудительные, недостойные. Девиация может проявляться только частично, например только в фантазиях при мастурбации или половом акте с партнером. Другой формой частичного примирения с девиантными склонностями является их удовлетворение только с определенными партнерами или в определенной среде (например, с проститутками), тогда как в других обстоятельствах не допускаются даже их отдельные проявления. Такая двойственность предполагает параллельное существование нормальной и девиантной сексуальности. Всегда существует угроза нарушения этого равновесия, которое может проявиться учащением и усилением отклонений в сексуальном поведении, а также проблемами с потенцией в супружестве, когда девиантные фантазии перестают оказывать стимулирующий эффект при нормативном половом акте.

3. *Защита*. Если преобладает отвержение личностью девиации, возникает внутрипсихический конфликт, который тем острее, чем сильнее аномальное половое влечение и моральное противодействие ему. Так как полностью подавить влечение обычно не удается, отклоняющаяся сексуальность переживается как нечто чуждое личности, противопоставляется всем остальным чертам характера и поведению человека. Поэтому можно встретить садистские наклонности в сексе у человека известного своим добродушием и мягкостью, а эксгибиционистские тенденции у робкого, стыдливого мужчины. Попытки защиты от сексуальной девиации в крайних случаях могут выражаться самоубийством. Подобное трагическое решение проблемы отмечается у людей высоконравственных или верующих, которые не в состоянии примирить свои идеалы и порочное, с их точки зрения, половое влечение.

4. *Вытеснение.* Это полное подавление девиации, вытеснение ее в бессознательную часть психики. Полное подавление девиантных склонностей достигается за счет переключения их в несексуальную социальную активность человека, которая субъективно не осознается как сексуальная. Примером могут послужить дисциплинарные наказания с целью воспитания, которые могут быть мотивированы неосознаваемыми садистскими наклонностями.

Таким образом, по своим проявлениям, степени выраженности и субъективному отношению к ним сексуальные девиации весьма неоднородны и представляют целую гамму вариантов полового поведения, отклоняющихся от социальных, моральных или правовых норм. Одни из них не нуждаются в какой-либо специальной медицинской помощи, другие - требуют психотерапевтического вмешательства в связи с развитием вторичных невротических расстройств как следствия внутрипсихических или межличностных конфликтов, обусловленных аномальными сексуальными предпочтениями индивида.

3.6. Сексуальные перверсии

Сексуальные перверсии (синонимы - половые извращения, парафилии) - это патологические отклонения направленности полового влечения или способов его удовлетворения. Прежде к ним относили все сексуальные девиации, т. е. любые сексуальные потребности и действия человека, которые отличаются от господствующей в обществе модели полового поведения. Они считались болезненными проявлениями психических нарушений и других заболеваний и, кроме того, всячески осуждались с точки зрения морали. Одно из первых определений патологического сексуального поведения принадлежит Р. Крафт-Эбингу, по мнению которого извращением - при существующей у индивида возможности естественного полового удовлетворения - необходимо считать всякое проявление полового инстинкта, не соответствующее целям природы, т. е. размножению. В настоящее время большинство сексологов придерживается мнения, что только часть сексуальных девиаций носит явно патологический характер. Так, К. Имелинский (1986) указывает на два специфических признака парафилии: 1) навязчивое (принудительное) желание реализовывать только перверсные формы сексуальной активности и нарушения в создании тесного партнерского союза; 2) отсутствие жажды наслаждения от близости с половым партнером и подмена ее стремлением к наслаждению от выполнения определенных действий сексуального характера. Таким образом, парафилии исключа-

ют глубокие партнерские связи, поскольку роль партнера сводится к функции обезличенного стимула, сексуального раздражителя, запускающего механизмы удовлетворения аномального полового влечения в типичных для каждого больного ситуациях. Сексуальные контакты лиц, страдающих парафилиями, характеризуются анонимностью и проявлениями промискуитета.

А. А. Ткаченко (1999), обобщая многочисленные исследования, выделяет целый ряд специфических особенностей в сексуальных предпочтениях лиц с парафилиями (в той или иной степени многие из них присущи всей девиантной сексуальности). Партнер для парафильных актов подбирается по наличию каких-то чисто внешних сексуально возбуждающих

символов (в каждом случае сугубо индивидуальных), а его собственные чувства и желания игнорируются. Формальными критериями выбора объекта для парафильных реализаций являются определенный возраст или тип телосложения, особенности одежды, цвет волос, обильная косметика и др. У лиц с парафилиями садомазохистского круга часто отмечается сексуальное возбуждение при виде крови - своей или чужой. Причем они утверждают, что с детства плохо переносили кровь, каждый раз ощущая непонятную взвинченность или слабость. Похожее действие оказывает черный цвет, например сексуальное поведение запускается при виде черных колготок или лосин. Известно, что черная кожа широко используется в садомазохистских практиках. В других случаях сексуальное возбуждение может наступать при виде льющейся мочи, звонком детском смехе. В качестве стимула, запускающего аномальное сексуальное поведение, могут выступать запахи. Например, запах духов и алкоголя, исходивший от жертвы, порождал неумолимое желание совершить изнасилование, а затем нанести ей множество ударов ножом.

В большинстве случаев лица с парафилиями склонны к стереотипному, клишированному сценарию поведения, что проявляется в тенденции каждый раз проводить одни и те же сексуальные действия (однообразное ощупывание половых органов, фелляция, особые ритуалы, предваряющие или даже замещающие коитус) в строго определенной окружающей обстановке (парк, кабина лифта и др.). При этом осуществление стереотипа в полном объеме, равно

как и степень наслаждения, во многом зависят от желаемой эмоциональной и поведенческой реакции партнера, порой весьма жестко обусловленной (испуг, стыд, оцепенение либо сопротивление насильнику).

Сексуальные действия лиц, страдающих парафилиями, часто приобретают самоценный характер, в результате чего процесс исполнения вынашиваемого замысла (начиная с поиска объекта) оказывается важнее и приносит большее наслаждение, чем его логическое завершение. Поэтому не являются редкостью отсутствие эякуляции и оргазма, несмотря на выполнение субъектом достаточно сложного и длительного ритуала, связанного с реализацией аномального полового влечения.

Прослеживается своеобразный возврат на более ранние этапы индивидуального развития. Примером является типичное поведение педофила с разглядыванием и ощупыванием половых органов ребенка: при нормальном психосексуальном развитии такие действия свойственны детям 2 - 4 лет. Манипуляции с жертвами и трупами, их расчленение сходны с играми ребенка, когда он с любопытством разбирает игрушки.

У парафиликов нарушено осознавание себя (субъекта), мотивов своего поведения и окружающей реальности, частью которой является объект их вожделения. Поэтому для них свойственно ощущение непроизвольности или насильственности собственных сексуальных переживаний, отчуждение себя от своих действий и искажение самосознания вплоть до отождествления себя с женщиной (в ощущениях, эмоциях, мышлении) в ситуации полового контакта.

Истинные парафилии являются для субъекта практически единственным источником полового удовлетворения (обычный половой акт если и возможен, то все равно не дает необходимых ему ощущений и полной сексуальной разрядки). Часть из них имеет тенденцию к прогрессированию (учащению и расширению круга перверсных сексуальных действий, постепенному подчинению всей жизни человека удовлетворению аномального полового влечения) - прогрессирующие формы парафилии. Так, единичные акты эксгибиционизма могут постепенно учащаться и в наиболее тяжелых случаях поиск возможностей для совершения эксгибиционистских актов становится смыслом

существования человека с данной перверсией и вытесняет все остальные интересы, грубо нарушая социальные связи. Нарастание частоты перверсных действий нередко сочетается со снижением остроты сексуальных переживаний и одновременным усилением раздражительности, ощущения пустоты, чувства неудовлетворенности, что, в свою очередь, побуждает человека все чаще прибегать к перверсным реализациям, приносящим хотя бы временное облегчение. Сексуальные переживания приобретают характер неодолимой болезненной привычки, постепенно нарастает социальная неприспособленность, изоляция от окружающего мира. Такие лица могут ощущать свою ущербность, внутреннее раздвоение переживаний, после

снятия сексуального напряжения у них нередко появляется чувство отвращения к себе.

Импульсивные формы парафилий проявляются периодическим нарастанием желания патологической сексуальной активности в промежутках между периодами нормального полового поведения. Такой человек временами начинает испытывать сильное беспокойство на фоне усиления сексуального напряжения, которое требует разрядки, достигаемой путем совершения парафильного акта. Больные, страдающие импульсивными формами парафилий, в социальном плане лучше адаптированы, часто имеют семью, не привлекают к себе особого внимания и после совершения насильственных действий сексуального характера долгое время не попадают в поле зрения правоохранительных органов. В связи с высокой вероятностью повторения парафильных реализаций они представляют наибольшую социальную опасность.

Психологические механизмы аномальной сексуальности разнообразны. Считается, что существенная роль в ее развитии принадлежит нарушениям половой идентичности, т. е. осознанной половой принадлежности индивида, с которой соотносятся прочие свойства его самосознания. Результаты исследований свидетельствуют о большей выраженности фемининных психологических черт при парафилиях, а у подавляющего числа сексуальных насильников имеются нарушения полоролевого поведения. Лицам с парафилиями свойственны нарушения эмпатии, т. е. способности идентифицировать и понимать чувства и эмоцио-

нальные реакции других людей. Следствием этого является развитие неконтролируемых влечений, в русле которых другой человек может восприниматься как обезличенное средство для удовлетворения собственных половых потребностей. Дефицит эмпатии приводит к тому, что выражение жертвой боли, страха и других сильных отрицательных эмоций вызывает чувство удовольствия, сексуального возбуждения или гнева, облегчая выполнение парафильного акта, даже если он носит криминальный характер. Снижение способности к сопереживанию сочетается с затруднениями в общении с другими людьми, трудностью в принятии новых форм поведения,

настойчивом следовании строгим ритуалам половых контактов, возникновением тревоги и страха при малейшем отступлении от выработанного поведенческого стереотипа. Характерной особенностью парафилий является регресс к детскому игровому поведению, которое отчетливо прослеживается в сексуальных действиях больных. Причем такие его элементы, как отсутствие регуляции поведения общественными нормами, «зачарованность» выполняемыми действиями с исчезновением к ним критики, потеря ощущения собственной индивидуальности и утрата границы между воображаемым миром и социальной действительностью, позволяют говорить о наличии у лиц, страдающих парафилиями, патологического (аутистического) игрового поведения. Аномальной сексуальности также свойственны «изменения» объекта сексуального влечения (доведение его до определенного эмоционального состояния, например, испуга и удивления при эксгибиционизме) либо «избегание» нормативного объекта и поиск нового ненормативного объекта с определенными характеристиками (полоролевая и личностная незрелость ребенка при педофилии). В целях преодоления внутреннего дискомфорта и оправдания своих поступков (при формах реализации, связанных с грубым нарушением моральных и правовых норм) лица с парафилиями используют психологический механизм деперсонификации, т. е. обезличивание объекта патологического влечения и обесценивание собственных действий по отношению к нему. Это способствует реализации собственных агрессивных импульсов, позволяет преступить морально-этические барьеры, связанные со значимостью и ценностью другого человека как личности.

223

У части больных с парафилиями возникает внутренний конфликт между перверсной сексуальностью и общепринятыми нормами полового поведения, что приводит их к депрессии, попыткам самоубийства, злоупотреблению алкоголем и наркотиками, тяжелым невротическим расстройствам. В других случаях аномальное половое влечение настолько тесно связано с деформированной личностью субъекта, что не вызывает у него серьезных душевных переживаний и чувства вины за содеянное даже после самого тяжкого сексуального насилия.

Причины перверсий до конца не изучены. Считается, что в формировании всех сексуальных отклонений, включая и их патологические, перверсные формы, играет роль множество биологических и социально-психологических факторов. Существуют данные о связи парафилий, в частности, садизма с органическими поражениями мозга вследствие родовой травмы, роста опухоли, перенесенной нейроинфек-ции. Главным образом повреждается лимбическая система, ответственная за агрессивность индивида, в результате чего мозг патологически активируется для передачи сигналов к нападению одновременно с сигналами полового возбуждения. Имеют значение неблагоприятная наследственность; гормональные нарушения; различные искажения психосексуального развития, в том числе обусловленные дефицитом эмоционального и телесного контакта с матерью в первые три года жизни ребенка, неправильным половым воспитанием, изоляцией от сверстников, асоциальным окружением; психические расстройства при шизофрении, эпилепсии (особенно височной локализации), расстройствах личности (тяжелых психопатиях) и т. д. В основе парафилий чаще всего лежит сочетание нескольких факторов, негативно воздействующих на сексуальную сферу человека и препятствующих становлению зрелой сексуальности.

Лечебно-реабилитационная программа строится с учетом выявленной психической патологии, личностных особенностей больных, их социальной адаптации. В комплексном лечении парафилий важнейшая роль принадлежит психотерапевтической коррекции. Психотерапия направлена на ослабление, а затем и устранение патологического сексуального влечения и связанных с ним душевных переживаний, постепенное формирование эстетического восприятия лиц

противоположного пола, этически правильного отношения к ним, отработку и закрепление навыков естественного и непринужденного общения, а на завершающем этапе - развитие адекватного отношения к потенциальному сексуальному партнеру и обучение соответствующим формам полового поведения (см. далее). За рубежом периодически предпринимаются попытки устранения некоторых видов перверсий с помощью хирургических операций на головном мозге. Однако против данного способа лечения существуют

серьезные возражения: необратимость хирургического воздействия на мозговые центры, опасность для жизни и здоровья человека.

Далее последовательно будут рассмотрены все расстройства, обусловленные нарушениями психосексуального развития, представленные в разделе *Расстройства зрелой личности МКБ-10 (F6).*

3.7. Расстройства половой идентификации (F64)

F64.0. Транссексуализм

Ощущение собственной принадлежности к противоположному полу. Желание жить и быть принятым в качестве лица противоположного пола, обычно сочетающееся с чувством неадекватности или дискомфорта от своего анатомического пола и желанием получать гормональное и хирургическое лечение с целью сделать свое тело как можно более соответствующим избранному полу.

Диагностические указания.

Для диагностики данного расстройства необходимо существование стойкой транссексуальной идентификации по крайней мере в течение 2 лет, что не должно быть симптомом другого психического заболевания, такого как шизофрения, или дополнительного признака каких-либо межполовых, генетических или хромосомных аномалий.

Следует отметить:

- как правило, у включенных в эту подрубрику транссексуалов должны наблюдаться расстройства половой идентификации в детском возрасте (F64.21).

Транссексуализм может быть определен как стойкое несоответствие полового самосознания человека его истинному генетическому и гонадному полу. Нормальное анатомическое строение собственного тела и половых органов воспринимается транссексуалами как неправильное и противоестественное, что приводит к сильному психическому дискомфорту и сопровождается настойчивым стремлением изменить свою половую принадлежность. Частота транссексуализма составляет примерно 1 : 100 - 200 тыс. человек. В основе его лежат грубые нарушения формирования

структур мозга, ответственных за половое поведение индивида, что ведет к искажению полового самосознания и ощущению принадлежности к другому полу. Причиной транссексуализма могут быть различные нарушения внутриутробного развития ребенка в результате нервных стрессов у беременной, приема некоторых лекарственных препаратов, недостаточного питания плода и т. д. Выраженность подобных нарушений варьирует в широких пределах, чем объясняется многообразие клинических вариантов транссексуализма. Половое воспитание практически не влияет на становление полового самосознания при ядерном (выраженном) транссексуализме, но оказывает положительное влияние при коррекции его краевых (нерезких) проявлений.

Для транссексуализма характерны нарушения поведения, связанные с ощущением своей принадлежности к другому полу. Так, дети просят называть их именами и хотят носить одежду противоположного пола, мальчики охотно играют с девочками в куклы, девочки дерутся с мальчиками, играют в футбол и прочие мальчишеские игры. Попытки родителей уговорами или наказаниями изменить поведение детей - транссексуалов обычно не достигают цели. Они настойчиво борются за признание окружающими их в том поле, в котором они сами себя ощущают. Особенно резко усиливается стремление утвердиться в принадлежности к другому полу с началом активного функционирования половых желез. Подростки с ужасом отмечают рост гениталий и развитие вторичных половых признаков, противоречащих их самосознанию. Увеличение грудных желез и начало менструаций воспринимается девушками-транссексуалами как катастрофа. Формирующееся в под-

ростковом возрасте половое влечение обычно искажено: у женщин-транссексуалов оно возникает к женщинам, а у мужчин - к мужчинам. Внешне подобное влечение воспринимается как гомосексуальное, но по сути таковым не является. Например, мужчины-транссексуалы в соответствии со своим половым самосознанием расценивают интимные контакты с женщинами как гомосексуальные и на этом основании отвергают их. Напротив, сексуальное

влечение транссексуала к лицам с противоположным генетическим и гонадным полом фактически является гомосексуальным, хотя внешне выглядит как гетеросексуальное.

Половая жизнь большинства транссексуалов сопряжена с серьезными трудностями в выборе сексуального партнера, поскольку обычно предмет ухаживаний решительно противится попыткам установить близкие отношения, расценивая их как гомосексуальные. Примерно четверть из них (чаще мужчины) пытаются вступить в сексуальные контакты с представителями противоположного пола, но разочаровываются после нескольких попыток. Если транссексуалам удается найти постоянного полового партнера одного с ними пола, то рано или поздно у них возникают различные сложности, поскольку окружающие негативно воспринимают такую связь. Но все же сексуальные проблемы не являются для транссексуалов самыми главными в жизни. Все их устремления прежде всего сосредоточены на приведении своего внешнего облика и строения тела в соответствие с половым самосознанием, а также на общественном признании своей принадлежности к другому полу. При этом они не останавливаются перед длительным гормональным лечением и сложными хирургическими вмешательствами. В случаях более легких форм транссексуализма, хотя и имеется психическое чувство иной половой принадлежности, большая часть транссексуалов постепенно адаптируется, находя компенсацию в работе, привычках и поведении, свойственных противоположному полу. Например, женщины выбирают наиболее престижные мужские профессии: летчиков, капитанов дальнего плавания, следователей и т. д., что помогает им не только самоутвердиться, но и на равных вращаться в мужском обществе. Профессия оправдывает их мужские привычки, манеру поведения, стиль одежды. При выраженных

формах транссексуализма полноценная социальная адаптация без смены пола практически невозможна. Решение вопроса о смене паспортного пола является компетенцией специальной комиссии, состоящей из сексологов, психологов, психотерапевтов, психиатров, урологов, юристов. На основании данных комплексного обследования (включая стационарное

психиатрическое) и динамического наблюдения комиссия выдает соответствующее заключение. После определенного периода адаптации к новому паспортному полу возможна хирургическая коррекция половой принадлежности.

F64.1. Трансвестизм двойной роли

Ношение одежды противоположного пола как часть образа жизни с целью получения удовольствия от временного ощущения своей принадлежности к противоположному полу, но без малейшего желания более постоянного изменения пола или связанной с этим его хирургической коррекции. Переодевание не сопровождается возбуждением, что отличает данное расстройство от фетишистского трансвестизма (F65.1).

Включаются:

- нарушения половой идентификации нетранссексуального типа в подростковом возрасте;
- нарушения половой идентификации нетранссексуального типа в зрелом возрасте.

Исключаются:

- дисфорическая ориентация по полу (F66.3x);
- фетишистский трансвестизм (F65.1).

Трансвестизм относится к числу наиболее распространенных сексуальных девиаций. С современной точки зрения трансвестизм - неоднородное явление, поскольку мотивы ношения одежды противоположного пола могут быть совершенно различными.

Выделяют фетишистский трансвестизм, при котором надевание одежды противоположного пола происходит главным образом для достижения сексуального возбуждения. От простого *фетишизма* он отличается тем, что фетишистские предметы или одежда не просто одеваются, но

и используются субъектом для того, чтобы на некоторое время изменить свой облик на свойственный противоположному полу. При этом одевается несколько предметов или полный комплект одежды, включая парик и

косметику. Фетишистский трансвестизм отличается своей четкой связью с сильным половым возбуждением, возникающим, например, у мужчины при надевании женского белья, платья, чулок. Обычно переодевание сочетается с разглядыванием себя в зеркале и *мастурбацией*, причем после достижения оргазма и снижения сексуального возбуждения субъект испытывает сильное желание снять одежду другого пола.

При трансвестизме ношение одежды противоположного пола является частью образа жизни субъекта. Облачение в одежды другого пола используется для получения удовольствия от чувства своей принадлежности к противоположному полу, причем у субъекта никогда не возникает желания постоянной смены пола хирургическим путем, а само переодевание не сопровождается половым возбуждением.

При гомосексуальном трансвестизме женоподобный мужчина-гомосексуал пользуется косметикой, специально переодевается и пытается подражать женским манерам поведения. Однако такая «гомосексуальная королева» в своем перевоплощении выглядит весьма вычурно и является скорее карикатурой на женщину. Основной целью подобного маскарада является желание обратить на себя внимание потенциальных гомосексуальных партнеров.

При транссексуализме мужчины и женщины с детских лет ощущают свою принадлежность к другому полу. Поэтому они считают совершенно естественным постоянное ношение одежды того пола, который соответствует их самоощущению. Наряду с переодеванием транссексуалы всегда стремятся соответствующим образом изменить и свою внешность.

Профилактика трансвестизма заключается в правильном половом воспитании, а также раннем выявлении и медико-психологической коррекции нарушений психосексуального развития на его ранних этапах. В необходимых случаях при трансвестизме проводится психотерапевтическая коррекция.

229

F64.2. Расстройства половой идентификации в детском возрасте

Расстройства, обычно впервые появляющиеся в раннем детстве (и всегда до начала пубертата), характеризующиеся постоянной интенсивной неудовлетворенностью по поводу зарегистрированного пола вместе с настойчивым желанием принадлежать (или убежденностью в принадлежности) к противоположному полу. Это стойкая озабоченность одеждой и/или занятиями, свойственными противоположному полу, и/или отвергание своего собственного пола. Эти расстройства относительно редки и не должны смешиваться с гораздо более часто встречающейся нонконформностью к общепринятому полоролевому поведению. Диагноз предполагает наличие глубокого нарушения чувства принадлежности к мужскому или женскому полу; явно мальчишеского поведения у девочек или девчачьего поведения у мальчика для этого недостаточно. Этот диагноз не может устанавливаться, если индивидуум достиг пубертатного возраста. Поскольку расстройство половой идентификации детского возраста имеет много общих признаков с другими расстройствами идентификации в этом разделе, оно помещено в рубрике F64, а не в F90-F98.

Диагностические указания.

Необходимым диагностическим критерием является наличие постоянного желания принадлежать (или убежденность в принадлежности) к полу, противоположному зарегистрированному, в сочетании с выраженным отказом от поведения, признаков и/или одежды, присущих зарегистриро-ванному полу. Обычно это расстройство проявляется в дошкольном возрасте, но для постановки диагноза необходимо, чтобы оно манифестировало до начала пубертата. У обоих полов может иметь место отвергание анатомических структур, присущих собственному полу; однако такое необычное проявление редко. Характерной особенностью является то, что дети с расстройством половой идентификации отрицают наличие переживаний по этому поводу, хотя они могут быть огорчены конфликтом, связанным с ожиданиями и надеждами своих родителей или сверстников и насмешками над ними и/или отверганием их.

Больше известно о таких расстройствах у мальчиков, чем у девочек. Обычно, начиная с дошкольного возраста и в последующем, мальчики увлечены играми и другими формами

деятельности, традиционно считающимися девчачьими, и часто при переодевании ими может отдаваться предпочтение девичьей или женской одежде. Однако подобное переодевание не вызывает полового возбуждения в отличие от фетишистского трансвестизма у взрослых (F65.1). Мальчики могут

иметь очень сильное желание участвовать в играх и развлечениях девочек; куклы женского пола часто являются их любимыми игрушками; в качестве партнеров своих игр они постоянно выбирают девочек. Общественный остракизм чаще возникает в период обучения ребенка в младших классах школы и достигает максимума в среднем школьном возрасте в связи с унизительными насмешками со стороны других мальчиков. Откровенное женское поведение может уменьшаться в период ранней юности, но катамнестические наблюдения показывают, что в юношеском возрасте и позже у мальчиков с расстройством половой идентификации в 1/3 - 2/3 случаев проявляется гомосексуальная ориентация. Однако очень немногие демонстрируют транссексуализм во взрослой жизни (хотя большинство взрослых с транссексуализмом сообщают, что в детстве у них существовала проблема половой идентичности).

В клинической практике расстройство половой идентификации у девочек наблюдается реже, чем у мальчиков, однако неизвестно, является ли такое соотношение полов истинным. Для постановки диагноза необходимо, чтобы оно манифестировало до начала пубертата. У девочек, как и у мальчиков, обычно рано начинается увлечение поведением, традиционно ассоциирующимся с противоположным полом. Девочки обычно имеют друзей мальчиков и высказывают жадный интерес к спорту, дракам, не интересуются куклами и женскими ролями в построенных на воображении играх, таких как «папа с мамой» или игра в «дом». Девочки обычно не подвергаются социальному остракизму в такой же степени, как мальчики, хотя они могут страдать от насмешек в позднем детстве или в юности. Большинство из них отказывается от преувеличенной настойчивости в мужских видах деятельности и одежде после достижения юношеского возраста, но у некоторых из них сохраняется мужская идентификация и может проявиться гомосексуальная ориентация.

Расстройство половой идентификации может сочетаться с постоянным отверганием анатомических структур пола. У девочек это обычно про-является в виде периодиче-

ских утверждений о том, что у них имеется или вырастет половой член; в отказе мочиться в сидячем положении; или утверждениях о том, что они не хотят, чтобы у них выросли молочные железы или начинались менструации. У

мальчиков это может проявляться периодическими утверждениями о том, что когда они вырастут, то превратятся в женщину; что половой член и яички отвратительны, что они исчезнут и/или что будет лучше, если их не иметь.

Исключаются:

- эгодистоническая ориентация по полу (F66.1);
- расстройство формирования сексуальности (F66.0);
- расстройство психосексуального развития (F66.0).

F64.21 Расстройство половой идентификации в детском возрасте транссексуального типа

F64.22. Расстройство половой идентификации в детском возрасте трансролевого типа

F64.29. Расстройство половой идентификации в детском возрасте неуточненное

Включается:

- расстройство идентификации в детском возрасте БДУ.

F64.8. Другое расстройство половой идентификации

F64.9. Расстройство половой неуточненное

Включаются:

- отклонение от поведения, свойственного данному полу БДУ;
- расстройство половой роли БДУ.

3.8. Расстройства сексуального предпочтения (F65)

Включаются:
- сексуальная девиация;
- парафилии.
Исключаются:
- проблемы, связанные с ориентацией по полу (F66).

Вне зависимости от конкретного типа расстройств сексуального предпочтения (парафилии) общими для всех них являются следующие *диагностические критерии:*

1) повторно возникающие интенсивные сексуальные импульсы и фантазии, связанные с необычными предметами или поведением;

2) эти импульсы в существенной мере определяют или нарушают общий рисунок поведения больного;

3) расстройство проявляется в течение не менее шести месяцев.

F65.0. Фетишизм

Использование какого-либо неодушевленного предмета в качестве стимула для сексуального возбуждения и сексуального удовлетворения. Многие фетиши являются дополнениями к человеческому телу, такие как предметы одежды или обуви. Другая часть характеризуется особым материалом, таким как резина, пластик или кожа. Фетиши могут варьировать в их значимости для индивидуума. В некоторых случаях они просто служат для повышения сексуального возбуждения, достигаемого обычным путем (например, надевая на своего партнера какую-нибудь особую одежду).

Диагностические указания.

Фетишизм может быть диагностирован лишь тогда, когда фетиш служит наиболее значительным источником сексуальной стимуляции или является необходимым для удовлетворительного сексуального ответа.

Фетишистские фантазии встречаются часто, но они не считаются расстройством до тех пор, пока они не приводят к ритуальным действиям, которые являются столь непреодолимыми и неприемлимыми, что препятствуют осу-

ществлению полового акта и вызывают страдания у самого индивидуума.

Фетишизм встречается почти исключительно у мужчин.

F65.1. Фетишистский трансвестизм

Надевание одежды противоположного пола главным образом для достижения сексуального возбуждения.

Диагностические указания.

Это расстройство необходимо дифференцировать от простого фетишизма на основании того, что фетишистские предметы или одежда не только одеваютбя, но и используются таким образом, чтобы сделать внешность субъекта похожей на внешность, свойственную противоположному полу. Обычно одевается больше одного предмета и часто полный комплект одежды, включая парик и косметику. Фетишистский трансвестизм отличается от транссексуального трансвестизма своей четкой связью с сексуальным возбуждением и сильным желанием снять одежду после достижения оргазма и снижения сексуального возбуждения. О фетишистском трансвестизме обычно сообщается как о ранней фазе у транссексуалов, и, вероятно, в этих случаях он представляет собой стадию в развитии транссексуализма.

Включается:

- трансвестистский фетишизм.

F65.2. Эксгибиционизм

Периодическая или постоянная наклонность к демонстрации собственных половых органов незнакомым людям (обычно лицам противоположного пола) или в общественных местах без предложения или намерений более близкого контакта. Обычно, но не всегда, во время демонстрации имеет место половое возбуждение, которое часто сопровождается мастурбацией. Эта наклонность может проявляться только в периоды эмоционального стресса или кризиса, перемежаясь длительными периодами без подобного поведения.

F65.21. Эксгибиционизм, садистический тип

Эксгибиционист получает максимальное удовлетворение, видя страх (испуг) жертвы.

F65.21. Эксгибиционизм, мазохистский тип

Эксгибиционист получает максимальное удовлетворение при агрессивной реакции жертвы.

F65.29. Эксгибиционизм неуточненный

Включается:
- эксгибиционизм БДУ.

F65.3. Вуайеризм

Периодическая или постоянная наклонность наблюдать за людьми, занимающимися сексом или «интимными делами», такими как раздевание. Это обычно приводит к половому возбуждению и мастурбации и осуществляется тайно от наблюдаемой особы.

F65.4. Педофилия

Сексуальное предпочтение детям обычно препубертатного или раннего пубертатного возраста. Одних педофилов привлекают только девочки, других - только мальчики, а третьи интересуются детьми обоего пола.

Педофилия редко встречается у женщин. Контакты между взрослыми и половозрелыми лицами юношеского возраста являются социально неодобряемыми, особенно если их участники одного пола, но они не обязательно связываются с педофилией. Отдельный случай, особенно если виновник сам юношеского возраста, не свидетельствует о наличии постоянной или доминирующей наклонности, необходимой для постановки диагноза. Однако в число педо-

филов включены мужчины, которые, предпочитая взрослых сексуальных партнеров, из-за постоянных фрустраций при установлении соответствующих контактов привычно обращаются к детям в качестве замены. Мужчины,

которые сексуально посягают на собственных детей препубертатного возраста, иногда обращаются также к другим детям и в обоих случаях их поведение определяется как педофилия.

F65.5. Садомазохизм

Предпочтение сексуальной активности, включающей в себя причинение боли или унижения. Если индивидуум предпочитает быть подверженным такого рода стимуляции - это называется мазохизмом, если же он предпочитает быть ее источником - садизмом. Часто индивидуум получает сексуальное удовлетворение как от садистической, так и от мазохистской активности.

Слабые проявления садомазохистской стимуляции обычно применяются для усиления в остальном нормальной сексуальной активности. Эта категория может использоваться лишь а тех случаях, когда садомазохистская активность является наиболее значительным источником сексуальной стимуляции или необходима для сексуального удовлетворения.

Сексуальный садизм часто трудно ограничить от проявлений в сексуальных ситуациях жесткости или гнева, не связанных с половым чувством. Диагноз может легко устанавливаться там, где насилие необходимо для эротического возбуждения.

Включаются:

- мазохизм;
- садизм.

F65.6. Множественные расстройства сексуального предпочтения

Иногда у одного человека наблюдается более одного нарушения сексуального предпочтения без четкого преобладания одного из них. Наиболее часто сочетаются фетишизм, трансвестизм и садомазохизм.

F65.8. Другие расстройства сексуального предпочтения

Может встречаться множество других видов нарушений сексуального предпочтения и сексуальной активности, каждое из которых наблюдается относительно редко. Они включают такие виды, как непристойные телефонные звонки, прикосновения к людям и трение о них в многолюдных общественных местах для сексуальной стимуляции (т. е. фроттеризм), сексуальные действия с животными (зоофилия, содомия); сдавление кровеносных сосудов или удушение для усиления полового возбуждения (синдром сексуальной асфиксии); отдавание предпочтения партнерам с какими-либо особыми анатомическими дефектами, например с ампутированной конечностью (апотемнофилия).

Эротическая практика также является разнообразной, и многие отдельные ее виды встречаются слишком редко, чтобы было целесообразным использовать специальный термин для каждого из них. Глотание мочи, пачкание испражнениями, уколы кожи или сосков могут быть частью поведенческого репертуара при садомазохизме. Часто встречаются различного рода мастурбаторные ритуалы, однако крайние степени такой практики, такие как вставление предметов в прямую кишку или мочеиспускательный канал полового члена либо неполное самоудушение, когда это происходит при обычных сексуальных контактах, относятся к патологии. В данную рубрику также включена некрофилия, т. е. половое влечение к трупам и совершение с ними сексуальных действий.

Включаются:

- фроттеризм (фроттаж);
- некрофилия.

F65.9. Расстройство сексуального предпочтения неуточненное

Включаются:

- парафилия БДУ;
- сексуальная девиация БДУ.

Лечебно-диагностические мероприятия у пациентов с расстройствами сексуального предпочтения включают диагностическое обследование и коррегирующее лечение.

Перечень необходимых обследований:

- подробное анамнестическое обследование, по возможности с получением данных объективного анамнеза, что позволяет проследить динамику психосексуального развития;
- клинико-психопатологическое обследование для выявления/ исключения психической патологии у пациента;
- сексологическое обследование;
- экспериментально-психологическое исследование с применением традиционных и специфических (для определения особенностей сексуальных предпочтений) методик;
- при необходимости дифференциальной диагностики с органической патологией головного мозга - нейрофизиологическое обследование (ЭЭГ, РЭГ, М-ЭХО).

Дифференциальная диагностика проводится среди всей группы расстройств полового предпочтения, она направлена на выявление психопатологической отягощенности и социальной опасности пациентов - Диагностика проводится в первую очередь с группой эндогенных психических заболеваний (шизофрения, эпилепсия, аффективные расстройства), группой расстройств личности и поведения в зрелом возрасте, а также органическими психическими расстройствами и умственной отсталостью.

Цели и ожидаемый результат лечения - ослабление аномального полового влечения и повышение социально-психологической и сексуально-пове-денческой адаптации.

Наиболее адекватным следует считать амбулаторное лечение, не нарушающее привычный ритм жизни больных. Стационарное - при выраженной тяжести состояния, наличии критериев для недобровольной госпитализации. Продолжительность - варьирует в зависимости от тяжести состояния, индивидуальных особенностей пациента от полугода-года до нескольких лет. Лечебно-реабилитационная программа строится с учетом выявленной психической патологии, личностных особенностей больных, их социальной адаптации.

Выделяют следующие *противопоказания к сексологическому лечению:*

- психические заболевания, зависимость от психоактивных веществ; расстройства личности, приводящие к грубым нарушениям социальных связей;
- интеллектуальная недостаточность;
- безволие и пассивность пациента, а также личностная и эмоциональная незрелость с нечетким осознанием своих мотивов и побуждений.

Терапия должна быть комплексной, сочетанной, последовательной.

Комплексное коррегирующее лечение включает ряд последовательных этапов, каждый из которых решает свои задачи.

I этап - коррекция эмоционального фона и закрепление установки на лечение. Важное место при этом занимает нормализация соматических функций, оптимизация режима сна - бодрствования. При астенических явлениях используются ноотропы, адаптогены. Наличие в структуре расстройства сексуального предпочтения психопатологических образований служит основанием для проведения психофармакотерапии. Так, для коррекции аффективных нарушений депрессивного круга применяют амитрипти-лин, мапротилин, кломипрамин, флувоксамин, сертралин. По показаниям применяют транквилизаторы: клоназепам (антилепсин), феназепам, алпразолам (ксанакс) или нейролептики: тиоридазин, перициазин (неулептил), сульпирид, хлорпротиксен, галоперидол и клозапин (лепонекс). Психотерапевтическое лечение включает рациональную психотерапию, гипносуггестию, элементы аутотренинга с использованием модифицированных методик самовнушения.

II этап - ослабление, а затем и устранение патологического сексуального влечения и связанных с ним переживаний. Могут использоваться психотропные препараты. Так, при лечении парафилий с обсессивно-компуль-сивным характером аномального полового влечения (случаи фетишизма, вуайеризма) применяются флуоксетин (прозак), кломипрамин. Связь парафильных реализаций с психомоторными пароксизмами при височной эпилепсии определяет показания к назначению антиконвульсантов, в частности карбамазепина. Психотерапия направлена на последовательное разрушение

паттерна аномального сексуального поведения, который состоит из трех компонентов - мышечного (двигательного), эмоционального и сенсорного. На мышечный компонент воздействуют с помощью телесно-ориентированных техник (например, больному предлагают представить в воображении привычное для него парафильное поведение, но при этом его телу придается неестественная для данной ситуации поза, что влечет развал всего поведенческого паттерна). Приемы гештальттерапии направлены прежде всего на отщепление эмоционального компонента. Техники НЛП и эриксоновского гипноза применяются для трансформации всех модальностей сенсорного компонента парафильного акта. Также проводится психотерапевтическая коррекция личностных нарушений в виде чувства неполноценности, страха перед общением, трудностей социальных контактов. Это необходимое условие для повышения самооценки пациентов и формирования у них чувства уверенности в себе.

III этап - создание своеобразного «социально-психологического вакуума», при котором происходит регресс психического «Я», выражающийся в ощущении собственной бесполости с дезактуализацией половой жизни в рамках снижения актуальности настоящего. Для этой цели чаще всего используются трансовые техники. Затем постепенно формируется адекватное эстетическое восприятие лиц противоположного пола, этически правильное отношение к ним. Пациентам рекомендуют занятия силовыми видами спорта, бальными танцами, с ними проводят тренинги по полоролевому поведению. В состоянии релаксации или гипнотического транса в воображении пациента формируются и закрепляются навыки естественного и непринужденного общения с лицами противоположного пола, которые в дальнейшем отрабатываются в ситуациях реального взаимодействия с ними.

IV этап - формирование и закрепление адекватного эротического отношения к лицам противоположного пола с последующей выработкой и реализацией соответствующих форм сексуального поведения. Используются приемы когнитивной терапии, техники визуализации, гипносуггесия, секс-терапия (чувственное фокусирование). Поощряется постепенный переход к нормативной

сексуальной активности (от эротических ласк и петтинга к половым актам).

У больных без установки на сексологическое лечение, представляющих социальную опасность, для снижения либидо парафилической направленности и упорядочивания их поведения (в том числе и сексуального) используются нейролептики пролонгированного действия - галоперидола деканоат, пипотиазин пальмитат (пипортил Л4). Наиболее эффективно курсовое назначение депонированных форм ципротерона ацетата (андрокур-депо) либо метоксипрогестеронацетата (депо-провера), которые подавляют либидо и снижают общую активность пациентов, а в ряде случаев приводят к утрате сексуальной мотивации.

При отсутствии эффекта показано проведение повторных курсов психотерапии, назначение психотропных препаратов, антиандрогенов, изменение их дозировок. При сохранении расстройств сексуального предпочтения, не представляющих какой-либо социальной опасности, психотерапевтические мероприятия могут быть сфокусированы на устранении внутреннего конфликта, принятии пациентом собственной девиантной сексуальности и улучшение его социально-психологической адаптации.

3.9. Психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым (психосексуальным) развитием и ориентацией по полу (F66)

Примечание: сама по себе ориентация по полу не рассматривается в качестве расстройства. Для регистрации вариантов сексуального развития и ориентации по полу, которые могут обусловливать проблемы для индивидуума, используются следующие пятизначные коды:

- F66.x0 Гетеросексуальный тип.
- F66.x1 Гомосексуальный тип.
- F66.x2 Бисексуальный тип. Используется только при очевидности сексуальной привлекательности обоих полов.

- F66.x8 Другой тип, включая препубертатный.

241

Пациент страдает от сомнений в собственной половой принадлежности или ориентации по полу, что приводит к тревоге или депрессии. Наиболее часто имеет место в юношеском возрасте у лиц, которые не уверены в том, являются ли они гомосексуальными, гетеросексуальными или бисексуальными; или у лиц, которые после периода явно стабильной ориентации по полу, часто со стабильными отношениями, обнаруживают, что их ориентация по полу изменяется.

Включается:
- расстройство формирования сексуальности.

Обследование:
- исследование половой идентификации: тест Маховера (рисунок человека), рисунок семьи, MMPI;
- определение личностных акцентуаций (опросник Шмишека, ПДО);
- клинико-психопатологическое исследование (выявление расстройств тревожного и депрессивного круга).

Лечение - направлено на разрешение сомнений пациентов в своей половой принадлежности либо сексуальной ориентации, повышение их психосексуальной и социальной адаптации. Психокоррегирующее лечение включает применение небольших доз транквилизаторов и антидепрессантов с седативным Действием. На этом фоне проводится рациональная психотерапия, направленная на разъяснение особенностей психосексуального развития и ослабление навязчивых сомнений по поводу собственной сексуальности.

F66.1. Эгодистоническая ориентация по полу

Половая принадлежность или сексуальное предпочтение не вызывают сомнения, однако индивидуум хочет, чтобы они были другими по причине дополнительно имеющихся психологических или поведенческих расстройств и может искать лечение с целью изменить их.

Следует отметить: сюда же относятся случаи, при которых сексуальное предпочтение не вызывает сомнений.

Однако индивидуум, не желая его изменить, готов на хирургическую и/или гормональную коррекцию собственного тела.

Исключается:

- транссексуализм (F64.0).

Обследование:

- исследование половой идентификации (тест Маховера (рисунок человека), рисунок семьи, MMPI);
- исследование особенностей эмоционально-личностной сферы и межличностного взаимодействия (опросники MMPI, Кеттелла, Лири, «семантический дифференциал»);
- клинико-психопатологическое исследование для исключения шизофрении, шизотипических и шизоаффективных расстройств.

Лечение направлено на повышение социально-психологической и сексуальной адаптации пациентов. Включает психотерапию в индивидуальном, парном, семейном и групповом форматах.

Если эго-дистоническая сексуальная ориентация по полу возникла как одно из проявлений психического расстройства - лечение основного заболевания.

F66.2. Расстройство сексуальных отношений

Нарушения половой принадлежности или сексуального предпочтения вызывают трудности в формировании или обеспечении отношений с сексуальным партнером.

Обследование:

- выявление аномалий половой идентификации, исследование характера сексуального влечения (тест Маховера, кех-тест, MMP1);
- исследование эмоционально-личностных особенностей и особенностей межличностных отношений (MMP1, опросники Кеттелла, Лири, рисунок семьи, «семантический дифференциал»);
- клинико-психопатологическое исследование для исключения шизофрении, шизотипических, шизоаффективных расстройств и расстройств личности.

Лечение включает различные формы психотерапии в индивидуальном, парном, семейном и групповом форматах. Его целью является улучшение межличностного и сексуального взаимодействия с партнером и повышение социально - психологической адаптации пациентов.

243

F66.8. Другие расстройства психосексуального развития

F66.9. Расстройства психосексуального развития неучтенное

Глава 4. Фармакотерапия сексуальных расстройств

Лечение большинства сексуальных дисфункций является комплексным и предполагает использование фармакотерапии, которая сочетается с методами психотерапевтической коррекции. Выбор лекарственных средств при нарушениях половой функции определяется причиной расстройства, характером его течения, возрастом пациентов, сопутствующей соматической либо психической патологией. В соответствии с этим медикаментозное лечение может быть этиологическим, патогенетическим или симптоматическим (В.В. Кришталь, Б.Л. Гульман, 1997). Чтобы облегчить специалистам выбор наиболее подходящих лекарственных средств для коррекции тех или иных половых расстройств ниже представлен ряд препаратов из различных фармакологических групп, которые наиболее широко используются в сексологической практике. Приведены их названия, основные характеристики и рекомендации по применению у пациентов сексологического профиля.

4.1. Адаптогены и сходные с ними стимулирующие вещества

А. Средство растительного происхождения и продукты пчеловодства

Корень женьшеня. Химический состав сложен - содержит эфирные масла, пектины, специфические гликозиды (панаксозиды и глизенозиды), сапонины и другие вещества. Издавна применяется в качестве тонизирующе-го средства при гипотонии, переутомлении и астенических

245

состояниях. Является неспецифическим стимулятором половой сферы человека. Усиливает либидо и повышает потенцию у мужчин и способность к переживанию оргазма у женщин. Назначают внутрь (до еды) в виде 10 % спиртовой настойки по 10 - 25 капель 1 - 3 раза в день, либо в капсулах, содержащих по 1 г экстракта корня женьшеня, 1 - 2 раза в день. Курс лечения женьшенем при половых дисфункциях составляет 30 - 40 дней.

Противопоказания: артериальная гипертензия, повышенная нервная возбудимость, бессонница.

Лимонник китайский. Содержит схизандрин, эфирные масла, органические кислоты, углеводы, витамин С и другие вещества. Лечебные препараты готовят из дикорастущей лианы китайского лимонника, причем наиболее выраженным стимулирующим действием обладает 10 % настойка семян растения. Оказывает возбуждающее влияние на ЦНС, стимулирует сердечно - сосудистую систему и дыхание. Улучшает работоспособность при умственном и физическом утомлении. Способствует повышению полового влечения и потенции, а также усилению сперматогенеза. Применяют по 20 - 30 капель 1 - 3 раза в день (до еды) не менее 1 месяца.

Противопоказания: заболевания желудочно - кишечного тракта, нарушения сна, повышенное артериальное давление.

Сапарал. Содержит сумму аммонийных оснований солей тритерпеновых гликозидов, получаемых из корней аралии маньчжурской. Оказывает стимулирующее влияние на ЦНС. Применяют при гипотонии, астении. Как тонизирующее и стимулирующее средство при снижении потенции назначают по 0,05 г (1 таблетка) 2 - 3 раза в день в первой половине дня. Курс лечения 15 - 30 дней. После 1 - 2 недельного перерыва можно проводить повторные курсы по 0,05 - 0,1 г в день в течение 10 - 15 дней.

Противопоказания: эпилепсия, гиперкинезы, гипертония, бессонница.

Тентекс - форте. Препарат, разработанный с использованием рецептов древней индийской медицины, содержит 10 ингредиентов растительного происхождения. Обладает стимулирующим и тонизирующим эффектом. У мужчин повышает либидо и улучшает качество эрекций. Может назначаться для повышения сексуальной ак -

тивности после перенесенных соматических заболеваний, облучения; для поддержания сексуальной активности в пожилом возрасте. Эффективен при снижении потенции у пациентов с алкогольными ремиссиями (в сочетании с гепатопротекторами и поливитаминами). Рекомендуемая дозировка: по 1 таблетке 2 - 3 раза в день, при недостаточном эффекте суточная доза может быть увеличена до 6 таблеток. Курс лечения 30 - 40 дней. В инволюционном периоде тентекс - форте назначают по 1 таблетке дважды в сутки в течение 50 дней. Курс лечения повторяют каждые 6 месяцев. Эффективность препарата усиливается при совместном применении с кремом химколин (см. ниже). *Противопоказания:* артериальная гипертензия, выраженный атеросклероз, хронические заболевания почек и сердечная недостаточность.

Верона - комплексный природный препарат на основе лекарственных трав. Верона стимулирует клетки Лейдига, улучшает сперматогенез. Препарат увеличивает подвижность сперматозоидов, а также объем выделяющейся спермы. Является биостимулятором, повышает умственную активность, устойчивость к стрессам. Оказывает иммуномодулирующее действие. Верона усиливает половое влечение и способствует улучшению качества эрекций. Может применяться при климактерическом синдроме у женщин. Выпускается в капсулах, которые назначают по 1 - 2 дважды в сутки. Капсулы принимают утром перед завтраком и вечером перед сном, запивая молоком. Курс лечения составляет от 4 до 6 недель. Передозировка препарата маловероятна. В единичных случаях возможно возникновение аллергических реакций.

Бука - Бука - натуральная смесь из десяти растений южноафриканского региона. За счет афродизиатического действия (усиления полового влечения, эрекций и обострения сексуальных переживаний) обладает симптоматическим действием при снижении либидо и потенции у мужчин. Усиливает половое влечение, чувствительность эрогенных зон, воллюст и оргазм у женщин. Выпускается в таблетках по 550 мг. Способ применения: по 2 таблетки ежедневно. При разовом использовании рекомендуется принимать по 4 - 5 таблеток вместе с едой за 2 - 3 часа до половой близости.

247

Леветон **-** комбинированный препарат, состоящий из цветочной пыльцы, порошка корней левзеи (содержит фитоэкдистероид - экдистен), витаминов Е и С. Эффективен при астенических состояниях и переутомлении. Стимулирует иммунитет и обладает общеукрепляющим действием у людей пожилого возраста. Усиливает либидо и улучшает качество эрекций. Для повышения потенции особенно эффективен у лиц с алкогольной зависимостью, находящихся в ремиссии. Рекомендуется по 3 - 4 таблетки в день непрерывно на протяжении 20 - 30 дней (до 4 - 5 курсов в год). *Противопоказания:* артериальная гипертензия и бессонница.

Элтон - композиция из порошка корней элеутерококка, витаминов Е, С и цветочной пыльцы. Препарат стимулирует ЦНС, повышает физическую и умственную работоспособность, особенно при астенических состояниях и переутомлении. Способствует регенерации поврежденных тканей, является иммуностимулятором. Усиливает либидо у лиц обоего пола и эрекцию у мужчин, повышает уровень сексуального возбуждения. Применяется по 1 таблетке 3 раза в день в течение 30 дней. В год может быть проведено до 4 курсов лечения препаратом.

Противопоказания: повышенное артериальное давление, нарушения сна.

Апилак - сухое вещество нативного пчелиного маточного молочка (секрета аллотрофических желез рабочих пчел). Маточное молочко содержит микроэлементы, в частности цинк, который играет у человека огромную роль для поддержания нормальной генеративной и сексуальной функций, В нем также представлены витамины, аминокислоты, ферменты, гормоноподобные вещества и биокатализаторы. Маточное молочко способствует более интенсивному обмену веществ, стимулирует синтез гормонов, улучшает физическое самочувствие. Препарат оказывает позитивное влияние на сексуальную активность и качество эрекций у мужчин. К его достоинствам следует отнести возможность применения у лиц, страдающих сердечно - сосудистыми заболеваниями. Апилак назначается сублингвально по 10 мг (1 таблетка) 3 раза в день. Курс лечения в среднем составляет 20 - 25 дней. *Противопоказания:* болезнь Аддисона, идиосинкразия к препарату.

Б. Средства животного происхождения

Пантокрин **-** наиболее распространенный адаптоген животного происхождения. Представляет собой жидкий спиртовой экстракт (на 50 % спирте) из пант (молодых неокостенелых рогов) марала, изюбра и пятнистого оленя. Также выпускается в таблетках по 0,15 г (соответствует 1 мл спиртового экстракта с активностью 30 - 35 %) и в виде раствора для инъекций по 1 и 2 мл. Применяют в качестве тонизирующего средства при переутомлении, астенических состояниях, гипотонии. В ряде случаев приводит к усилению полового влечения у лиц обоего пола и эрекций у мужчин. Эффект от приема пантокрина по 45 капель 2 раза либо по 1 таблетке 2 - 3 раза в день (за полчаса до еды) наблюдается уже через 6 - 8 дней, достигая максимума на 3 - 4 неделе. Препарат вводят подкожно или внутримышечно по 1 - 2 мл в день на протяжении 2 - 3 недель. Существуют данные, что частые повторные введения пантокрина ослабляют и даже полностью угнетают реакцию организма на этот препарат. *Противопоказания:* выраженный атеросклероз, заболевания сердца, нефриты, диарея.

Касолин **-** сложная смесь химических соединений, получаема я из сп ирто в ого экстракта бобровой струи, переэкстрагированного в растительное масло, выпускается в желатиновых капсулах по 0,1 г и 0,2 г. Бобровая струя - мускусоподобный секрет касторовых или препуциальных желез преимущественно самцов бобра речного, содержащий около 40 биологически активных ингредиентов. Касолин оказывает общетонизирующий эффект, стимулирующе воздействует на репродуктивную функцию, может повышать уровень тестостерона в плазме крови, способствует усилению либидо и потенции у мужчин. Рекомендуется применять внутрь по 0,1 - 0,2 г (1 - 2 капсулы) 3 раза в день во время еды в течение 15 - 30 дней.

Противопоказания: органические поражения мочеполовой системы, венерические заболевания и патология надпочечников.

В. Комбинированные средства (животно - растительного прохождения)

Нань - бао - комбинированный препарат, составленный по китайским традиционным рецептам. В состав вхо -

249

дит около 30 трав, а также почки осла, панты, зори, морской конек, эвкоммию. Оказывает мягкий стимулирующий эффект, повышает потенцию, при ускоренной эякуляции может увеличивать продолжительность коитуса, улучшает функциональную активность предстательной железы при хронических простатитах. Применяют у мужчин внутрь 2 раза в день по 3 капсулы (утром и вечером после еды). Курс лечения - 1 месяц. Противопоказания не выявлены.

Тестис - композитум - представляет собой многокомпонентный гомеопатический препарат, состоящий из адаптогенов, микроэлементов, витаминов и ингредиентов из эндокринных желез животных. Оказывает регулирующее воздействие на эндокринный аппарат мужчины, приводя к постепенному усилению либидо, остроты оргастических ощущений и возникновению более качественных эрекций. Эффективен при сексуальных дисфункциях у мужчин в периоде возрастной инволюции. Способствует редукции астенического симптомокомплекса. Выпускается в ампулах для инъекций по 2,2 мл. Препарат вводят подкожно либо внутримышечно 2 раза в неделю на протяжении 5 недель (на курс 10 инъекций). В зависимости от достигнутого эффекта количество инъекций может колебаться от 1 до 3 в неделю. Противопоказания неизвестны.

4.2. Витамины и поливитаминные комплексы, содержащие макро - и микроэлементы и биоактивные вещества

Токоферола ацетат - синтетический препарат витамина Е. Токоферолы содержатся в зеленых частях растений, особенно в молодых ростках злаков, В растительных маслах, в меньших количествах - в яйцах, жире, мясе и молоке. Витамин Е тормозит перекисное окисление липидов, являясь природным антиоксидантом. Он участвует в важнейших процессах тканевого метаболизма, в регуляции функции репродуктивных органов.

Выпускается в виде капсул по 0,05 и 0,1 г, а также в виде 5, 10 или 30 % раствора для внутримышечных инъекций в ампулах по 1 мл соответ -

250

ственно (50, 100 или 300 мг). Используется в комплексном лечении мужчин с нарушениями сперматогенеза и потенции по 150 - 300 мг в сутки в течение 4 - 6 недель. Токоферола ацетат в суточной дозе 600 - 800 мг применяется в лечении болезни Пейрони (особенно на начальной стадии заболевания при наличии болевого синдрома). Необходимо с осторожностью назначать препараты витамина Е у больных с тяжелым кардиосклерозом.

Юникап - Т - комбинированный поливитаминный препарат, содержащий макро - и микроэлементы. Используется для профилактики и лечения гиповитаминоза и дефицита минеральных веществ, в частности в период реконвалес - ценции после продолжительных или тяжело протекающих заболеваний, а также при алкогольной зависимости. Препарат усиливает неспецифическую резистентность организма, повышает общий тонус, позитивно влияет на сексуальную активность (особенно при гиповитаминозах, астенических состояниях любого генеза и алкогольной зависимости). Юникап - Т выпускается в таблетках, которые назначают 1 раз в сутки на протяжении одного - двух месяцев.

4.3. Половые гормоны и средства влияющие на гормональное обеспечение половой сферы

А. Андрогены и их синтетические аналоги

Тестостерона пропионат - синтетический аналог эндогенного андрогена тестостерона. Постоянная выработка тестостерона в мужских половых железах начинается в период полового созревания и продолжается до периода угасания сексуальной функции в глубокой старости. Циркулирующий в крови тестостерон превращается в органах - мишенях в

дегидротестостерон (с помощью фермента 5а - редуктазы), который связывается с рецепторами андрогенов, обеспечивая специфическое действие, присущее мужским половым гормонам. Тестостерона пропионат выпускается в ампулах по 1 мл 1 % или 5 % раствора в масле для внутримышечных инъекций. Его применение у мужчин

способствует повышению либидо, однако на частоту и качество эрекций препарат отчетливо влияет лишь при имеющейся андрогенной недостаточности (содержание тестостерона в плазме крови ниже 5 нг/мл). Неоправданное назначение препаратов мужских половых гормонов является наиболее частой ошибкой в терапии эректильных дисфункций различной этиологии. Напротив, проведение заместительной терапии андрогенами у мужчин, страдающих первичным (тестикулярным) гипогонадизмом, приводит к усилению у них либидо, появлению сексуальных фантазий и желания близости, увеличивает частоту возникновения эрекций и эякуляции, активизирует сперматогенез. Обычно назначают по 1 мл 5 % раствора тестостерона пропионата внутримышечно 2 - 3 раза в неделю в течение 1 - 2 месяцев. Необходимо отметить, что применение у мужчины андрогенов, особенно в высоких дозах, приводит к снижению секреции гипофизарных гонадотропинов, что в свою очередь ведет к угнетению выработки собственного (эндогенного) тестостерона, а также может способствовать развитию гипертрофии простаты. Тестостерона пропионат влияет на водно - электролитный баланс, вызывая задержку в организме натрия и воды. Как и любые другие андрогены, препарат противопоказан при раке предстательной железы и опухолевых процессах печени.

Для повышения реактивности генитальных эрогенных зон тестостерона пропионат иногда применяется у женщин местно. В этом случае его масляный раствор регулярно втирают в область клитора и входа во влагалище (2 - 3 недели). Поскольку препарат практически не всасывается через кожные покровы и слизистые оболочки, он не оказывает на женский организм побочных эффектов, присущих андрогенам, но может усилить специфическую тактильную чувствительность половых органов.

А.М. Свядощ (1987) с целью усиления либидо назначал фригидным женщинам с хорошо развитыми вторичными половыми признаками тестостерона пропионат по 50 мг внутримышечно через день (на курс 4 инъекции).

Тестостерона андеканоат (андриол) - препарат тестостерона, активен при пероральном применении. Действующим веществом является тестостерона андекаонат, который в отличие от чистого тестостерона не подвергает -

ся первичному печеночному метаболизму, распределяясь в лимфатической системе. Андриол выгодно отличается от активных при пероральном использовании С-17 метилированных производных тестостерона (например, метилтестостерона) тем, что не оказывает отрицательного влияния на функцию печени. Препарат применяется для гормоноза - местительной терапии при нарушениях, связанных с дефицитом тестостерона: посткастрационном синдроме; евнухоидизме, гипопитуитаризме, некоторых видах бесплодия, обусловленных нарушением сперматогенеза, половых расстройствах эндокринного генеза.

Рекомендуемая начальная доза составляет 120 - 160 мг/ сутки (3 - 4 капсулы) в течение 2 - 3 недель. Поддерживающая доза - 40 - 80 мг/сутки. В отдельных случаях может вызывать задержку воды и солей в организме, поэтому лечение пациентов с сердечной недостаточностью, нарушениями функции почек, артериальной гипертонией, эпилепсией и мигренью следует проводить под постоянным врачебным контролем.

Местеролон (провирон) - синтетический андроген для приема внутрь. Выпускается в таблетках, содержащих 25 мг местеролона. В отличие от препаратов тестостерона провирон не превращается в соединения, обладающие эстрогенной активностью, и практически не влияет на уровень гонадотропинов в крови. В терапевтических дозах препарат не подавляет синтез собственного тестостерона, а также не оказывает гепатотоксического действия. Для проведения стимулирующей сперматогенез терапии препарат используется в дозе от 75 до 150 мг/сутки в течение 3 - 9 месяцев. Провирон устраняет обусловленные недостатком эндогенных андрогенов снижение либидо и нарушения потенции. Рекомендуемая доза составляет 75 мг/сутки в начале лечения с постепенным ее снижением (через 2 - 4 недели) до 50 - 25 мг/сутки.

Противопоказан больным с раком предстательной железы, а также при имевших место или существующих опухолях печени.

Метилтестостерон - синтетический аналог тестостерона. Выпускается в таблетках по 5 и 10 мг. Для большего эффекта рекомендуется задерживать таблетку метилтестостерона в полости рта под языком до полного

рассасывания. При сублингвальном применении препарата он примерно в 3 - 4 раза уступает по активности тестостерона пропионату, вводимому внутримышечно. У мужчин метилтестостерон назначают по 10 - 20 мг/сутки при снижении либидо и потенции в период возрастной инволюции, а также при первичном гипогонадизме.

У женщин с вторичным снижением или отсутствием полового влечения (например, после родов) для усиления либидо рекомендуются короткие (запускающие) курсы метилтестостерона (по 5 - 10 мг/сутки) во второй фазе менструального цикла. С этой же целью возможно комбинированное применение этинилэстрадиола (микрофоллина) по 0,05 - 0,01 мг/сутки в первую фазу цикла и метилтестостерона по 10 мг/сутки - во вторую фазу на протяжении 1 - 2 менструальных циклов. А.М. Свядощ (1987) для усиления полового влечения и способности переживать оргазм рекомендовал женщинам принимать метилтестостерон в дозе 5 мг 2 - 3 раза в день в течение одного цикла, начиная с первого дня после окончания менструаций и до наступления следующих либо по 5 мг 5 раз в день 4 - 6 дней подряд. Андрогены подлежат немедленной отмене, если у женщины появляется охриплость голоса, растительность на лице, усиливается выпадение волос, возрастает масса тела, нарушается менструальный цикл и резко увеличивается гемоглобин крови.

Иногда метилтестостерон применяют при патологическом климаксе (если имеются противопоказания к назначению эстрогенных препаратов). Рекомендуемая доза - 5 мг 1 - 3 раза вдень.

Возможные осложнения и противопоказания такие же, как при применении тестостерона пропионата.

Тестостерона ундеканоат (небидо). Выпускается в ампулах, каждая из которых содержит 1000 мг действующего вещества в 4 мл раствора для внутримышечных инъекций (250 мг тестостерона ундеканоата в 1 мл). Небидо является первым препаратом для лечения гипогонадизма у мужчин, который применяется 1 раз в 3 месяца. После одной инъекции уровень тестостерона поддерживается в физиологических пределах в течение 3 месяцев без патологических повышений и снижений. Небидо эффективно снижает проявления гипогонадиз -

ма и предотвращает осложнения, связанные с дефицитом тестостерона, такие как: ослабление эрекции и полового влечения, уменьшение мышечной массы и силы, повышенная утомляемость, депрессивные состояния, слабая выраженность вторичных половых признаков, риск возникновения остеопороза. Преимуществом небидо для пациента является быстрое наступление эффекта и длительность действия препарата. Исходя из оптимального сочетания эффективности, физиологического действия и безопасности, небидо в ближайшем будущем имеет все основания, чтобы стать «золотым стандартом» для пролонгированной терапии как при «классическом» гипогонадизме, так и при возрастном дефиците андрогенов. Небидо вводится очень медленно, глубоко в ягодичную мышцу. После введения, тестостерона ундеканоат постепенно высвобождается из депо и расщепляется эстеразами сыворотки крови на тестостерон и ундеканоат. Действие тестостерона ундеканоата на организм идентично действию эндогенного тестостерона. Повышение уровня тестостерона в сыворотке крови по сравнению с исходным отмечается уже на следующий день и достигает физиологических значений через три дня после первой инъекции. Препарат обладает хорошей переносимостью. При длительном применении небидо рекомендуется измерять уровень тестостерона крови 1 раз в год.

Противопоказания: злокачественные опухоли простаты или молочной железы, опухоли печени, повышенная чувствительность (аллергия) на тестостерона ундеканоат или на любой из остальных компонентов препарата.

Б. Анаболические стероиды

Метандростенолон - обладает андрогенной активностью примерно в 100 раз меньшей, чем тестостерона пропионат при примерно одинаковом анаболическом эффекте. Стимулирует синтез белка в организме. Выпускают в таблетках по 5 мг. В эндокринологии применяют при межуточно - гипофизарной недостаточности, хронической недостаточности надпочечников, тиреотоксикозе, в комплексном лечении диабетических ангиопатий, в том числе

с вовлечением генитальных артерий. Снижение либидо и потенции у реконвалесцентов после перенесенных травм, операций, ожогов, соматических заболеваний, а также при затяжных астенических состояниях различного генеза являются показаниями для назначения метандростенолона по 1 таблетке (5 мг) 1 - 2 раза в день в течение 4 - 8 недель. Метандростенолон противопоказан при раке простаты, остром простатите, тяжелых заболеваниях печени.

Нандролона деканоат (ретаболил) - обладает сильным и длительным анаболическим действием. Андрогенные эффекты выражены мало. Стимулирует белковый синтез, способствует фиксации в костях кальция. Клинически его действие проявляется в повышении аппетита, улучшении общего состояния и постепенном увеличении мышечной массы. Выпускается в ампулах по 1 мл 5 % раствора (50 мг) в масле. После инъекции эффект достигает максимума к 7 - му дню и продолжается не менее 3 недель. У лиц пожилого и старческого возраста ретаболил используют для улучшения компенсаторных и адаптационных процессов. Препарат можно применять в комплексном лечении мужчин со снижением либидо и потенции на фоне выраженной астенизации. Назначают внутримышечно по 1 мл 1 раз в 3 - 4 недели. На курс 3 - 4 инъекции. Ретаболил с осторожностью используется при недостаточной функции печени и почек. У больных сахарным диабетом применение ретаболила может уменьшать потребность в инсулине, в связи с чем необходимо тщательно проверять толерантность к глюкозе.

В. Гонадотропины

Хорионический гонадотропин (прегнил, крофази) - активное вещество, которое представляет собой хорионический гонадотропин, получаемый из мочи беременных женщин. У мужчин препарат стимулирует развитие интер - стициальных клеток Лейдига в семенниках и выработку тестостерона. Выпускают в виде сухого вещества для инъекций по 1000,1500, 2000, 5000 МЕ в ампулах в комплекте с растворителем. При гипогонадотропном гипогонадизме у мужчин в целях нормализации уровня тестостерона в сы- воротке крови вводят подкожно или внутримышечно до

4000 МЕ профази еженедельно в течение 3 недель. Для индукции сперматогенеза назначают до 12 000 МЕ хорионического гонадотропина каждую неделю на протяжении 6 - 9 месяцев. При идиопатическом отсутствии или выраженном снижении полового влечения у мужчин иногда используют короткие «триггерные» курсы лечения, где 6 - 8 инъекций тестостерона пропионата (по 1 мл 5 % раствора), осуществляемых через день, чередуются с аналогичным числом инъекций профази (прегнила) по 1500 МЕ, вводимых также через день. Данная комбинация позволяет добиться усиления либидо и максимально ослабить побочные эффекты синтетических андрогенов в виде снижения секреции гипофизарных гонадотропинов и угнетения выработки эндогенного тестостерона. Хорионический гонадотропин может вызывать задержку жидкости в организме и отеки.

У женщин хорионический гонадотропин применяются прежде всего при ановуляторной дисфункции яичников и связанным с ней бесплодием.

Препарат противопоказан при опухолях гипофиза и предстательной железы, а также воспалительных заболеваниях половой сферы.

Г. Ингибиторы секреции пролактина

Бромкриптин (парлодел) - полусинтетическое производное алкалоида спорыньи эргокриптина. Выпускают в таблетках по 2,5 мг и в

капсулах по 5 мг. Стимулируя центральные допаминовые рецепторы, оказывает тормозящее влияние на секрецию гормонов передней доли гипофиза, особенно пролактина и соматотропина. В результате стимуляции допаминергической передачи в нигростриальной системе уменьшает симптомы паркинсонизма. Эффективен при различных расстройствах, обусловленных повышенным уровнем пролактина. У мужчин гиперпролактинемия может проявляться снижением либидо и потенции, гипогонадизмом, галактореей и гинекомастией. В 50 % случаев гиперпролактинемию вызывают пролактинсекретирующие макро - и микроаденомы гипофиза. Другие причины гиперпролактинемии - параселлярная опухоль (менингиома, краниофарингиома), которая сдавливает ножку гипофиза

или гипоталамус, гипотиреоз, патология печени, почек, прием медикаментов, стимулирующих секрецию пролактина. Иногда возникает умеренная, но стойкая пролактинемия неясного происхождения (идиопатическая). У женщин гиперпролактинемия встречается чаще, чем у мужчин, и является причиной 20 - 25 % случаев аменореи. Ее основные симптомы: вторичная аменорея, ановуляторные циклы, галакторея, снижение либидо, слабо выраженные гирсутизм и акне.

При пролактиномах назначают ежедневно по 2,5 - 3,75 мг (по 0,5 таблетки 2 - 3 раза в сутки) с постепенным повышением дозы до терапевтически эффективной. В небольших дозах (1,25 мг/сутки) бромкриптин как стимулятор Д2 - допаминовых рецепторов может применяться для повышения либидо даже при отсутствии стойкой гиперпролактинемии. *Противопоказания:* гипотония, после недавно перенесенного инфаркта миокарда, при нарушениях сердечного ритма; ангиоспазмах, заболеваниях желудочно - кишечного тракта и психических расстройствах.

Каберголин (достинекс) - производное алкалоида спорыньи эрголина. Выпускается в таблетках, содержащих по 0,5 мг каберголина. Является новым селективным агонистом допамина. Его сродство к допаминовым рецепторам в 20 раз выше, чем у бромкриптина. Достинекс - препарат выбора для терапии гиперпролактинемических состояний. Обеспечивая снижение уровня пролактина, он не влияет на концентрацию

других гормонов, в частности гормона роста. Препарат обеспечивает восстановление либидо у мужчин и женщин и потенции у мужчин, обусловленных гипер - пролактинемией.

Режим назначения достинекса.

I этап - подбор оптимальной дозы:

- начальная доза: 0,5 мг в 2 приема (1/2 таб. 2 раза в неделю);
- «титровка» дозы (увеличение недельной дозы на 0,5мг с интервалом в 4 недели) с подбором оптимальной в течение 12 недель под контролем уровня пролактина. Оптимальная доза - минимальная доза, обеспечивающая снижение уровня сывороточного пролактина до нормальных значений при условии хорошей переносимости терапии.

258

II этап - поддержание терапевтической дозы:

- обычно 1 мг/нед. (от 0.5 до 2.0 мг).

Критерии эффективности лечения гиперпролактинемии:

- концентрация пролактина в сыворотке - не выше 20 нг (600 мкМЕ) в 1 мл;
- уменьшение размеров пролактиномы;
- восстановление полового влечения, у мужчин - спонтанных и адекватных эрекций.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость каберголина или других алкалоидов спорыньи; печеночная недостаточность. С осторожностью назначают больным с сердечно - сосудистой патологией, синдромом Рейно, печеночной недостаточностью, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, психическими заболеваниями в анамнезе. Побочные эффекты: ортостатическая гипотензия, тошнота, головная боль, головокружение, боли в животе, диспептические явления.

Ципротерона ацетат (андрокур) - оказывает выраженный антиандрогенный эффект за счет конкурентного ингибирования андрогенных рецепторов. Дозозависимые эффекты препарата: атрофия половых желез, уменьшение оволосения кожных покровов, снижение

сперматогенеза и полового влеченияю. Ципротерона ацетат выпускают в таблетках по 50 мг и в ампулах по 300 мг для внутримышечных инъекций.

У мужчин препарат угнетает либидо без изменения психосексуальной ориентации. Применяется при патологической гиперсексуальности, особенно если повышенное половое влечение направлено на детей, выражается в угрожающих актах насилия или других сексуально мотивированных действиях противоправного характера (эксгибиционизм). Терапия антиандрогенами не устраняет сексуальных парафилий, однако вследствие снижения либидо пациенты становятся более управляемыми, упорядочивается их поведение, облегчается проведение обязательных в этих случаях психокоррекционных и социотерапевтических мероприятий. Предпосылкой к назначению антиандрогенов, как

правило, является осознание пациентом необходимости терапии и добровольное согласие на лечение. Для устранения сексуальной расторможенности и склонности к импульсивным поступкам андрокур назначают в дозе от 100 до 200 мг в сутки в течение 2 - 4 недель или до достижения отчетливого эффекта (снижение либидо, ослабление эрекции и оргазма). Затем дозу постепенно снижают до 75 - 50 - 25 мг в сутки, этого обычно достаточно для длительного поддерживающего лечения. В ряде западных стран для принудительного лечения по приговору суда применяется андрокур - депо по 300 мг (1 ампула) внутримышечно 1 раз в 10 - 14 дней с последующим уменьшением дозы.

Среди побочных эффектов ципротерона ацетата отмечают геникомастию, снижение фертильности, депрессивные состояния. Препарат противопоказан при гепатитах, депрессии, наклонности к тромбоэмболиям.

У женщин, страдающих гирсутизмом, обусловленным поликистозом яичников, ципротерона ацетат применяют в сочетании с этинилэстрадиолом или местранолом, что в течение года уменьшает рост волос и приводит их к обесцвечиванию более чем у 70 % больных. Имеются сведения об эффективном снижении либидо у пациенток с синдромом гипоталамической гиперсексуальности (с этой целью применяют андрокур - депо).

Е. Эстрогены

Этинилэстрадиол (микрофоллин) - по характеру действия сходен с другими эстрогенными препаратами, которые вызывают пролиферацию эндометрия, стимулируют развитие матки и вторичных женских половых признаков (при их недоразвитии), смягчают и устраняют климактерические и посткастрационные расстройства. Микрофоллин выпускают в таблетках по 0,01 и 0,05 мг этинилэстрадиола. В сексологической практике его применяют у фригидных женщин (особенно при явлениях гипооваризма) в первой половине менструального цикла в суточной дозировке 0,01 - 0,05 мг. Возможно его сочетание с метилтестостероном, который назначается во второй половине цикла. Хотя основную роль в сексуальном влечении женщины и ее способно -

сти переживать оргазм играют андрогены, ряд специалистов считает, что эстрогены также способствуют поддержанию полового чувства у женщины (А. М. Свядощ, 1987 и др.).

Эстрогены противопоказаны при фибромиоме, мастопатии, эрозии шейки матки, полипозе, заболеваниях печени и почек, туберкулезе и эпилепсии.

Ж. Гестагены

Медроксипрогестерон (провера) - производное прогестерона. В соответствующих дозах угнетает секрецию гонадотролных гормонов и предотвращает овуляцию. Выпускается в таблетках по 5и 10 мг. Применяют при эндо - метриозе (30 мг/сутки, курс 90 дней), дисфункциональных (ановуляторных) маточных кровотечениях (по 5 - 10 мг/ сутки в течение 10 дней).

В ряде случаев снижает половое влечение у женщин при синдроме гипоталамической гипосексуальности (для этой цели более эффективна депонированная форма медроксипрогестерона - *депо - провера).*

В отдельных случаях депо - провера может применяться для подавления аномального полового влечения у мужчин, страдающих парафилиями. Лечение проводится по следующей схеме: 300 - 400 мг внутримышечно 1 раз в 10 дней - 1 месяц, затем 200 мг 1 раз в 15 дней - 1 месяц, затем 150 мг 1 раз в 15 дней - 2 месяца.

Побочные эффекты: аллергические реакции, тромбоэмболия, тромбофлебит, бессонница, депрессия, головная боль, тошнота, галакторея, повышенная чувствительность молочных желез. Применение препарата во время беременности не рекомендуется.

4.4. Вазоактивные препараты

А. Общего действия

Ницерголин (сермион) - обладает а2 - адреноблоки - рующим, а также активизирующим метаболизм действием.

261

Выпускают в таблетках для приема внутрь, содержащих по 5, 10 или 30 мг ницерголина, а также в виде порошка для инъекций в ампулах по 4 мг действующего вещества в комплекте с растворителем. Препарат уменьшает сопротивление мозговых и легочных артерий, расширяет периферические сосуды. Повышает скорость кровотока в артериях верхних и нижних конечностей. У пациентов с артериальной гипертензией сермион может вызывать постепенное снижение кровяного давления. Препарат применяют при наличии показаний для усиления церебрального кровотока и активизации метаболических процессов мозга, а также для улучшения периферического кровоснабжения. Курс лечения может составлять до 3 - 4 месяцев.

Рекомендуемые терапевтические режимы:

- *лечебный* 30 мг Х 2 раза в день внутрь или в/м по 4 мг *2* раза в день;
- *поддерживающий* 10 мг Х 3 раза в день;
- *профилактический* 5 мг Х 3 раза в день.

В случаях выраженных нарушений кровотока начинают с внутривенного капельного введения препарата в дозе 4 - 8 мг, разведенной в 100 мл физиологического раствора или 5 % раствора глюкозы.

Основным показанием к применению сермиона в сексологической практики являются умеренно выраженные нарушения гемодинамических механизмов эрекции атеросклеротического генеза со следующими клиническими проявлениями: торпидность (замедленное возникновение) эрекции и недостаточная ригидность полового члена, затрудняющие интроекцию; ослабление эрекции во время копулятивных фрикций до эякуляции. В первую очередь препарат показан пациентам с эректильными дисфункциями на фоне артериальной гипертензии, церебрального атеросклероза, облитерирующих заболеваний конечностей.

При эректильных дисфункциях вследствие патологии артериального русла, кровоснабжающего гениталии, сермион применяется в вышеуказанных дозировках, нередко в сочетании с другими вазоактивными препаратами: тренталом, ксантинола никотинатом, актовегином. Следует отметить, что в случаях выраженного атеросклеротического поражения артерий малого таза сосуды могут утратить способность реагировать даже на высокие дозировки со -

судорасширяющих средств. Иногда это приводит к большему ослаблению эрекций у больных при назначении им сермиона и других вазоактивных препаратов, что связано с развитием своеобразного феномена «обкрадывания тазового кровотока», т. е. перераспределением крови через непораженные артерии в пользу нижних конечностей. Сермион противопоказан при повышенной к нему чувствительности.

Йохимбин - блокатор пресинаптических центральных и периферических а2 - адренорецепторов. Повышает двигательную активность. Оказывает антидиуретическое действие. Улучшает периферический кровоток, способствует усилению кровенаполнения пещеристой ткани кавернозных тел за счет некоторого увеличения притока крови по гениталъным артериям. При сексуальной стимуляции йохимбин уменьшает спастические реакции артерий, кровоснабжающих половой член, чем можно объяснить позитивный эффект в ряде случаев психогенных эрекционных дисфункций. В комплексе с другими препаратами показан при сексуальных дисфункциях

инволюционного генеза. Назначают по 5 мг 3 раза в сутки. Курс лечения около одного месяца. Йохимбин может применяться по 1 - 2 таблетки перед предстоящим половым актом. Курение существенно ослабляет действие препарата.

Противопоказания: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, заболевания печени и почек.

Экстракт листьев гингко билоба (танакан) - растительный препарат, который выпускают в таблетках и в растворе для приема внутрь. Одна таблетка содержит 40 мг стандартизированного экстракта из листьев реликтового дерева Гингко билоба, в 1 мл раствора - 40 мг действующего вещества. Препарат улучшает мозговое кровообращение, обладает вазорегулирующим влиянием на всю сосудистую систему (артерии, вены, капилляры). Уменьшает агрегацию эритроцитов и тромбоцитов. Нормализует метаболические процессы, обладает антигипоксическим действием на ткани. Препятствует перекисному окислению липидов клеточных мембран. Оказывает противоотечное действие как на уровне головного мозга, так и на периферии. Влияет на нейромедиаторные системы, усиливая высвобождение из пресинаптических терминалий и ингибируя обратный за -

хват биогенных аминов, чем объясняется определенный антидепрессивный эффект тонакана. Отмечен положительный эффект препарата при периферических нейропатиях. Танакан применяется при дисциркуляторных энцефало - патиях различного генеза, нарушениях периферического кровоснабжения и микроциркуляции. Его назначают по 1 таблетке или 1 мл раствора (40 мг) внутрь 3 раза в сутки во время еды. Средняя продолжительность курса лечения - 3 месяца.

Уменьшая церебрастенические явления, танакан способствует улучшению общего тонуса и может усиливать либидо у мужчины пожилого возраста, а также у лиц, перенесших черепно - мозговую травму либо инсульт. При нарушениях эрекционной функции вследствие атеросклеротического поражения артерий, кровоснабжающих половой член (в том числе при диабетических ангиопатиях и сопутствующих иннерваторных нарушениях генитальной области), препарат используется в

дозе 120 - 160 мг/сутки в течение 2 - 4 месяцев. Наилучший эффект у больных с васкулогенными эрекционными дисфункциями достигается при сочетанном применении танакана, сермиона и различных общетонизирующих средств. Противопоказания к приему танакана не установлены.

Б. Вазоактивные препараты селективного действия

Папаверина гидрохлорид - миотропное спазмолитическое средство. Препарат является ингибитором фермента фосфодиэстеразы и вызывает внутриклеточное накопление цАМФ, способствующее релаксации гладкомышечных волокон органов брюшной полости и периферических сосудов. При интракавернозном введении 2 % раствора папаверина гидрохлорида от 20 до 100 мг (1 - 5 мл) усиливается кровенаполнение пещеристых тел полового члена, что вызывает эрекцию. С 1982 года препарат используется в лечении эректильных дисфункций различного (преимущественно органичес-кого) генеза. Эффективная доза подбирается индивидуально, начиная с 20 мг (1 мл). Такое количество препарата в ряде случаев способно вызвать полноценную эрекцию у больных с

поражениями проводящих нервных путей, например диабетических нейропатиях. Оптимальной является дозировка препарата, которая обеспечивает возникновение полноценной эрекции продолжительностью от 30 до 90 минут. Причем фармакологически индуцированная эрекция сохраняется у мужчин на протяжении этого отрезка времени даже после эякуляции.

В 80-х годах прошлого века препарат широко применялся в терапии эректильных дисфункций у мужчин. Однако вскоре выяснилось, что интракавернозные инъекции папаверина гидрохлорида приводят к многочисленным осложнениям и побочным эффектам, что существенно ограничивает его использование у пациентов, особенно для длительного курсового лечения. Наиболее серьезное осложнение - развитие затяжной эрекции, которая сохраняется свыше 4 часов. В ряде случаев мужчина может добиться ее исчезновения самостоятельно: приняв ванну с прохладной водой

и/или при помощи физической нагрузки на нижние конечности (приседания и т. п.).

Эрекция продолжительностью более 6 часов свидетельствует о *приапизме.* При интракавернозном введении папаверина гидрохлорида вероятность его возникновения составляет 5 - 7 %. Длительно сохраняющийся приапизм приводит к деструктивным изменениям в пещеристых телах полового члена с постепенной заменой гладкой мускулатуры пещеристых тел фиброзной тканью, что в дальнейшем влечет за собой грубые и стойкие нарушения эректильной функции. Основным способом лечения данного осложнения является аспирация сгустков и застойной крови из кавернозных тел при помощи инъекционных игл. При сохраняющейся эрекции дополнительно вводят раствор одного из адреномиметиков: адреналина или норадреналина (0,05 - 0,1 мг), допамина (0,04 - 0,12 мг) интракавернозно, чтобы вызвать сужение артерий, кровоснабжающих половой член.

Приапизм продолжительностью свыше 12 часов может быть купирован применением 10 % метараминала по следующей схеме: 1 мл препарата растворяют в 10 мл физиологического раствора и вводят в кавернозное тело через иглу - бабочку со скоростью 0,75 мл/мин. Максимальная однократная доза метараминала - 3 мл. Как правило, этих действий бывает достаточно для снятия фармакогенного

приапизма. Методы хирургического лечения показаны при безуспешности консервативных мероприятий или в сроки свыше 24 - 36 часов с момента развития приапизма. Чаще всего накладывают анастомоз между кавернозным телом и большой подкожной веной нижней конечности (обычно проводится двухстороннее сафено - кавернозное шунтирование) либо создают анастомоз между кавернозным и спонгиозным телами. После хирургического лечения приапизма примерно в 50 % случаев развивается полная импотенция, причем до настоящего времени не установлено является она следствием операции или осложнением затянувшегося приапизма.

Другие ранние осложнения интракавернозного применения папаверина гидрохлорида - гематомы в месте инъекций, понижение артериального давления из-за выхода сосудорасширяющего препарата в общий кровоток.

Среди поздних осложнений описаны нарушения сердечного ритма, токсические поражения печени и почек. Однако наибольшие проблемы связаны с развитием фиброзов и деформаций кавернозных тел, которые наблюдаются у 16 - 57 % больных при регулярном использовании препарата свыше 12 месяцев (E. Wespes, 1989). Интракавернозное введение противопоказано больным с нарушениями атриовентрикулярной проводимости сердца, заболеваниями крови, болезнью Пейрони.

Алпростадил (каверджект) - синтетический простагландин Е1. Выпускается в виде стерильного порошка алпростадила для интракавернозного введения по 10 и 20 мкг во флаконе в комплекте с растворителем.

Простагландин Е1 (алпростадил) стимулирует аденилатциклазу, что приводит к увеличению цАМФ, которая вызывает расслабление гладкомышечных волокон кавернозных артерий и синусоидов пещеристых тел, обеспечивая развитие эрекции полового члена.

Основные показания к применению алпростадила.

Для диагностики:

1. В качестве интракавернозного теста для скрининг - диагностики нарушений генитального кровотока.
2. В качестве фармакологической нагрузки при ультразвуковой допплерографии сосудов полового члена и фаллоартериографии.

266

Для лечения:

1. Как альтернатива хирургическому лечению при грубых нарушениях кровоснабжения кавернозных тел.
2. Как эффективное средство, обеспечивающее полноценную эрекцию даже при отсутствии полового влечения.
3. С целью коррекции выраженных эректильных дисфункций у больных с коронарной патологией, принимающих нитропрепараты.

Внутрикавернозное введение каверджекта используется в терапии наиболее тяжелых нарушений эректильной функции, в первую очередь при патологии генитального кровотока и поражениях структур, связанных с

иннервацией полового члена. В зависимости от характера расстройства доза препарата, обеспечивающая достаточную для полового акта эрекцию, может составлять от 2,5 до 60 мкг. Подбор эффективной дозировки осуществляют в кабинете врача, начиная с интракавернозной инъекции 5 - 10 мкг алпростадила. Если у пациента возникла полная эрекция, продолжающаяся свыше 2 часов, доза для следующего введения уменьшается в 1,5 - 2 раза, при недостаточной эрекции она увеличивается на 5 мкг. Оптимальной считается наименьшая дозировка препарата, обеспечивающая полноценную эрекцию через 5 - 10 минут после его введения длительностью 30 - 60 минут. Рекомендуемая частота инъекций не превышает одной в день и не более 3 раз в неделю. При хранении в холодильнике в оригинальном флаконе разведенный раствор алпростадила сохраняет свою стабильность 7 суток и в течение этого времени может использоваться повторно. Для проведения длительной терапии в домашних условиях пациентов обучают самостоятельному выполнению инъекций препарата. Непосредственный эффект при использовании каверджекта наблюдается по разным данным в 70 - 94 % случаев (B. Morik et al., 1988; W. Michaelis,1989 и др.). Имеются указания, что, в случаях длительного применения препарата при различных эрекционных дисфункциях органического генеза, около трети пациентов отмечает улучшение качества самостоятельных эрекций, которые начинают возникать и без предварительного введения алпростадила (A. Bucher et al., H. Porst, 1992).

Побочные эффекты отмечаются существенно реже чем при использовании папаверина гидрохлорида. В месте инъ -

екции иногда возникают гематомы. Некоторые больные отмечают болезненные ощущения и жжение в половом члене после введения препарата. Затяжная эрекция и приапизм наблюдаются примерно у 1,3 % пациентов, причем в подавляющем числе случаев они самостоятельно редуцируются. Доля пациентов, потребовавших медицинского вмешательства для устранения приапизма, составляет 0,2 %. При длительном применении каверджекта описаны лишь единичные случаи фиброза кавернозной ткани и искривлений полового члена. Системные побочные эффекты также редки. При использовании препарата в дозах более 20 - 30 мкг иногда снижается артериальное давление, учащается пульс, возможны кратковременные нарушения сердечного ритма.

Противопоказания:

- установленная гиперчувствительность к алпростадилу;
- заболевания крови, предрасполагающие к приапизму (миеломная болезнь, лейкозы, серповидноклеточная анемия);
- анатомические деформации полового члена (например, в результате болезни Пейрони);
- наличие имплантированного в половой член протеза.

Силдепафил (виагра) - первый в мире пероральный препарат, который оказывает прицельное активизирующее воздействие на гемодинамические механизмы эрекции. Выпускается в таблетках для приема внутрь, содержащих соответственно 25, 50 или 100 мг активного вещества силденафила цитрата. Препарат облегчает естественный ответ на половое возбуждение в виде наступления эрекции.

При сексуальной стимуляции в тканях полового члена мужчины происходит высвобождение оксида азота, который активизирует образование цГМФ. Повышение уровня цГМФ ведет к расслаблению гладких мышц кавернозной ткани и усиленному кровенаполнению полового члена. Силденафил является мощным селективным ингибитором фосфодиэстеразы 5 - го типа (ФДЭ5), которая расщепляет цГМФ. Поэтому при наличии у мужчины полового возбуждения препарат, угнетая ФДЭ5, активно усиливает расслабляющий эффект оксида азота на пещеристую ткань, облегчая возникновение полноценной эрекции.

268

Силденафил применяется при эректильных дисфункциях различного генеза (органических, психогенных, смешанных) у мужчин в любом возрасте. Препарат обнаруживает отчетливый клинический эффект в 78 % случаев. Силденафил недостаточно эффективен у мужчин со сниженным половым влечением или его отсутствием, а также при наиболее выраженных нарушениях генитального кровотока. Сильный страх перед возможной сексуальной неудачей в некоторых случаях может блокировать действие препарата, вероятно, из-за нарушений тонуса генитальных артерий и биохимического дисбаланса в кавернозной ткани. Поэтому при наличии у

пациента коитофобии параллельно с назначением виагры должны быть проведены соответствую-щие психотерапевтические мероприятия.

После перорального приема силденафила его действие начинается через 30 - 60 минут и продолжается около 5 часов, облегчая достижение полноценной эрекции. Наряду с усилением эрекции препарат может вызывать повышение яркости сексуальных переживаний и остроты ощущений при оргазме.

Рекомендуется первый прием виагры в дозе 50 мг (1 таблетка) примерно за час до планируемой сексуальной активности. В последующем в зависимости от эффективности и переносимости дозы может быть увеличена до 100 мг или уменьшена до 25 мг. Максимальная частота применения препарата - 1 раз в сутки.

Силденафил можно принимать независимо от приема пищи, хотя ее присутствие в желудке (особенно жирной) может снизить скорость абсорбции. Не отмечено существенного отрицательного взаимодействия виагры с алкоголем, антибиотиками, ант и депрессантами, сахароснижающими и гипо-тензивными препаратами. Среди побочных эффектов отмечаются головная боль, приливы жара к лицу, головокружение, диспептические явления, заложенность носа, легкие и преходящие изменения цветовосприятия и кратковременное нарушение четкости зрения. Частота побочных эффектов возрастает с увеличением дозы препарата.

Противопоказания к применению виагры.

- совместный прием любых форм нитратов. Эти препараты включают нитроглицерин (аэрозоли, мази, пластыри или пасты и таблетки для рассасывания под языком) или любые донаторы окиси азота;

269

- препараты, предназначенные для лечения эректильной дисфункции, не должны применяться у мужчин, которым не рекомендована сексуальная активность (например, пациентам с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как нестабильная стенокардия или тяжелая форма сердечной недостаточности);
- противопоказано применение виагры пациентами с тяжелыми нарушениями функции печени, с гипотензией (кровяное давление < 90/50 mmHg), недавно перенесенным инсультом или инфарктом

миокарда
и наследственными дегенеративными нарушениями сетчатки глаза;
- препарат с особой осторожностью должен использоваться у лиц с анатомической деформацией полового члена (фиброз кавернозных тел, болезнь Пейрони), а также заболеваниями крови, предрасполагающими к приапизму (лейкозы и др.).

Тадалафил (сиалис) является эффективным, обратимым селективным ингибитором фосфодиэстеразы 5 - го типа (ФДЭ5). Выпускается в таблетках, содержащих по 20 мг активного вещества. Когда сексуальное возбуждение вызывает местное высвобождение оксида азота, ингибирование ФДЭ5 тадалофилом ведет к повышению уровня циклического гуанозин монофосфата (цГМФ) в кавернозных телах полового члена. Следствие этого является релаксация гладких мыши, артерий и приток крови к половому члену, что вызывает его эрекцию. Тадалафил не оказывает эффекта в отсутствие сексуального стимулирования. Тадалафил улучшает эрекцию и возможность проведения полового акта. В отличие от силденафила препарат действует в течении 36 часов. При наличии полового возбуждения эффект проявляется уже через 20 минут после приема препарата. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в среднем через 2 часа после приема внутрь. Скорость и степень всасывания препарата не зависит от приема пищи. Препарат применяется для лечения эректильной дисфункции любой этиологии. Эффективность действия составляет от 75 до 85 % - Рекомендованная доза препарата сиалис 20 мг. Побочные действия: головная боль (11 %), диспепсия (7 %), боль в спине, миалгия, заложенность носа, «при -

270

ливы» крови к лицу. Изредка - отек век, боль в глазах, гиперемия конъюнктивы и головокружение.

Варденафил (лебитра) - селективный ингибитор фосфодиэстеразы 5 - го типа (ФДЭ5). Механизм действия аналогичен таковому у силденафила и тадалафила. Выпускается в таблетках по 5, 10 и 20 мг. Варденафил начинает действовать уже через 15 - 25 минут после приема внутрь.

Продолжительность действия препарата составляет от 5 - 6 до 8 - 12 часов. Используется при эректильных дисфункциях любой этиологии. В начале лечения рекомендуемая доза составляет 10 мг, в дальнейшем в зависимости от эффективности и переносимости она может быть увеличена до 20 мг или уменьшена до 5 мг/сутки. Эффективность при длительной терапии достигает 80 %. Прием пищи и алкоголя не влияет на эффективность действия левитры. Головная боль и «приливы», которые являются наиболее частыми побочными эффектами при приеме всех ФДЭ5, наблюдаются более чем у 10 % лиц, принимавших левитру.

В много центровом двойном слепом исследовании - PROVEN (реакция на варденафил пациентов, ранее безуспешно принимавших силденафил) участвовали 463 больных с умеренной и тяжелой эректильной дисфункцией. Больные были рандомизированы на прием плацебо или левитры в дозе 10 мг в течение 4 недель с возможностью продолжения приема препарата в такой же дозе или титрования ее до 5 мг или 20 мг каждые 2 недели на протяжении 12 недель. Анализ полученных результатов показал, что применение левитры привело к статистически и клинически значимому улучшению эректильной функции по сравнению с плацебо у больных, ранее безуспешно принимавших силденафил (G. Carson et al., 2003).

4.5. Препараты стимулирующие центральную и периферическую нервную систему.

Стрихнина нитрат - главный алкалоид семян чибулихи. В медицинской практике применяют 0,1 % раствор стрихнина нитрата в ампулах для инъекций по 1 мл. В терапевтических дозах стрихнин оказывает стимулирующее

271

действие на органы чувств (обостряет зрение, вкус, слух, тактильную чувствительность), возбуждает дыхательный и сосудодвигательные центры, тонизирует скелетную мускулатуру и сердечную мышцу, усиливает процессы обмена.

Действие стрихнина связано с облегчением проведения возбуждения в межнейронных синапсах спинного мозга.

Стрихнин применяется как тонизирующее средство при выраженной астенизации, гипотонии, парезах и параличах, атонии желудка и т. п. Усиление рефлекторной деятельности может оказывать благоприятный эффект при эректильных дисфункциях, обусловленных неврологической патологией, или в структуре затяжных астенических состояний различного генеза. Препарат назначают в виде подкожных инъекций по 1 мл 1 - 2 раза в день. В необходимых случаях доза может быть увеличена до 2 мл (0,002) 2 раза в день. Курс лечения 10 - 15 дней. У женщин применяется для стимуляции рефлекторной деятельности спинномозговых центров, а также обострения тактильной чувствительности (дважды в день по 1 мл подкожно, курс составляет 10 - 14 дней).

В случаях передозировки возможны напряжение лицевых, затылочных и других мышц, затруднение дыхания, тетанические судороги.

Стрихнин противопоказан больным с гипертонической болезнью, бронхиальной астмой, стенокардией, при выраженном атеросклерозе, тиреотоксикозе, заболеваниях печени и почек,склонности к судорожным реакциям.

Прозерин - синтетическое антихолинэстеразное вещество. Выпускается в таблетках по 15 мг и в ампулах по 1 мл 0,05 % раствора (0,5 мг) для инъекций. Препарат облегчает проведение импульсов в холинэргических синапсах ЦНС, улучшает нервно - мышечную проводимость, усиливая процессы возбуждения, повышая тонус гладкой и попереч-нополосатой мускулатуры.

Прозерин применяют при миастении, двигательных и чувствительных расстройствах, связанных с травмами спинного мозга, радикулитами, невритами либо обусловленных последствиями острых нарушений мозгового кровообращения.

При эректильных дисфункциях и вялом истечении семени в момент эякуляции вследствие нарушений путей ин -

272

нервации мужских гениталий прозерин назначают в виде ежедневных подкожных инъекций по 1 мл (на курс 15 - 25 инъекций) или по 1 таблетке (15 мг) 2 раза в день (20 - 30 дней). Для усиления эффекта прозерин нередко сочетают с подкожным введением 1 - 2 мл 0,1 % стрихнина нитрата (курс 10 - 20 инъекций) и приемом тиамина хлорида. В случае необходимости курс лечения повторяют после 3 - 4 недельного перерыва.

При передозировке возможен «холинэргический криз»: гиперсаливация, тошнота, миоз, усиление перистальтики, понос, частое мочеиспускание, мышечные подергивания, развитие общей слабости. Антидотом является атропин. Противопоказан при эпилепсии, гиперкинезах, бронхиальной астме, стенокардии, выраженном атеросклерозе.

Дистигмин бромид (убретид) - антихолинэстеразный препарат с пролонгированным действием. Выпускается в таблетках, содержащих по 5 мг действующего вещества дистигмина бромида, и в виде раствора для инъекций по 1 мл (0,5 и 1 мг) в ампуле. Препарат вызывает аккумуляцию ацетилхолина в синаптической щели, продлевая и усиливая связанные с ним процессы в скелетных мышцах и парасимпатических нервах. Убретид повышает тонус желудочно - кишечного тракта, мочевого пузыря, сфинктеров и мочеточников, вызывает умеренную вазодилатацию и повышение тонуса поперечнополосатых мышц. В сексологической практике препарат можно использовать при расстройствах эрекции, затрудненной либо ускоренной эякуляции, обусловленных частичными нарушениями проводимости спинного мозга, а также при поражениях периферических нервных образований, участвующих в иннервации половых органов, например при диабетических или алкогольных нейропатиях. Убретид вначале назначают по ½ - 1 таблетке (2,5 - 5 мг) 1 раз в сутки. В зависимости от эффекта доза может быть увеличена до 2 таблеток в сутки или уменьшена до I таблетки один раз в 2 - 3 дня. Таблетки принимают натощак утром за 30 минут до завтрака. В тя-желых случаях препарат используют в виде внутримышечных инъекций по 0,5 мг 1 раз в сутки. Продолжительность лечения убретидом 3 - 4 недели. При передозировке препарата отмечают мускариновые (тошнота, рвота, понос, по -

вышение перистальтики, слюноотделения, бронхоспазмы, брадикардия, миоз, потливость) и никотиновые (мышечные спазмы, затруднения при глотании) эффекты. Побочные явления снимаются атропином.

Противопоказания: гипотония, хроническая сердечная недостаточность, недавний инфаркт миокарда, тиреотоксикоз, бронхиальная астма, эпилепсия, миотония, гипертонус кишечника, желчных и мочевых путей, язвенная болезнь желудка.

4.6. Метаболиты и ферменты, регулирующие обмен веществ

Милдронат - структурный аналог гамма у - бутиробетаина - предшественника карнитина. Выпускается в капсулах для приема внутрь по 0,25 г и в виде инъекционного раствора по 5 мл (0,5 г) в ампуле. Препарат улучшает метаболические процессы, повышает работоспособность, уменьшает симптомы психического и физического перенапряжения, оказывает антиишемическое и кардиопротективное действие, регулирует клеточный иммунитет, купирует соматовегетативные расстройства при алкогольном абстинентном синдроме.

Милдронат применяют при физическом и умственном перенапряжении, снижении работоспособности, а также для лечения заболеваний сердечно - сосудистой системы и нарушений мозгового кровообращения.

Учитывая энергезирующее, антистрессорное и вегетостабилизирующее действие милдроната, его используют у мужчин в комплексном лечении нарушений потенции функционально - психогенного характера (на фоне психотерапии), а также при различных эректильных дисфункциях органического генеза. Поскольку милдронат существенно не влияет на артериальное давление, он является одним из немногих препаратов с тонизирующим действием, который может применяться у больных, страдающих гипертонической болезнью. В сексологической практике милдронат назначают внутрь по 0,25 - 0,75 г (1 - 3 капсулы) 2 раза в день на протяжении 3 - 4 недель. Для достижения более отчет -

ливого и быстрого тонизирующего эффекта в начале курса лечения милдронат иногда вводят внутривенно струйно по 0,5 - 1 г (5 - 10 мл) 1 раз в сутки 7 - 10 дней. Препарат малотоксичен и лишь в редких случаях вызывает кожный зуд, диспептические явления, тахикардию, возбуждение, понижение артериального давления. Противопоказания к приему милдроната не описаны.

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) - естественная составная часть тканей организма. Особенно ею богаты мышцы. АТф участвует во многих процессах обмена веществ и рассматривается как один из медиатров нервного возбуждения; усиливает коронарное, церебральное и периферическое кровообращение.

Для медицинского применения выпускается 1 % раствор натрия аденозинтрифосфата для инъекций в ампулах по 1 мл. Препарат применяют в комплексном лечении ишемической болезни сердца, облитерирующего атеросклероза, спазмов периферических сосудов, мышечной дистрофии. Вместе с вазоактивными препаратами АТФ используется в лечении васкулогенных эректильных дисфункций. У пациентов со снижением потенции различного генеза АТФ находит применение в комбинации с адаптогенами. АТФ может оберегать гипофизадреналовую систему от чрезмерного реагирования в стрессовых ситуациях вследствие активации обменных процессов в других тканях (Г.С. Васильченко, 1983). Курс лечения - 20 внутримышечных инъекций по I мл ежедневно. Препарат противопоказан при выраженной гипотонии и свежих инфарктах миокарда.

4.7. Психотропные препараты

А. Транквилизаторы

Алпразолам (ксанакс) - производное триазолобензодиазепина. Оказывает выраженный анксиолитический эффект. Уменьшает беспокойство, чувство тревоги, страха, напряжения. Отмечена антидепрессивная активность препарата, обладает вегетостабилизирующим, миорелаксирующим и умеренным снотворным действием.

Ксанакс выпускается в таблетках, которые содержат по 0,25; 0,5; 1; 2 мг действующего вещества алпразолама. Назначают больным с тревожными и смешанными тревожно - депрессивными состояниями, включая панические расстройства. При психогенных и смешанных сексуальных дисфункциях, сопровождающихся тревожно - депрессивной симптоматикой, алпразолам назначают в небольших дозах (0,5 - 1,0 мг/сутки в 2 - 3 приема) на протяжении 2 - 3 недель в комбинации с методами психотерапии. У мужчин, страдающих преждевременной эякуляцией, алпразолам, снижая тревогу и общую возбудимость, может способствовать удлинению полового акта при его приеме по 0,25 - 0,5 мг за 1 - 2 часа до предполагаемой сексуальной активности.

У женщин алпразолам используют при сексуальной аверсии, вагинизме, диспареунии, тревожных сомнениях и чувстве вины по поводу половой жизни.

Препарат с осторожностью назначают больным с нарушениями функции печени и почек, дыхательной недостаточностью, а также лицам склонным к злоупотреблению транквилизирующими средствами,

Тофизопам (грандаксин) - вызывает анксиолитический эффект без выраженного седативного, миорелаксирующего, противосудорожного действия. Является психовегетативным регулятором. Обладает умеренной стимулирующей активностью, относится к «дневным» транквилизаторам. Выпускается в таблетках, содержащих по 50 мг действующего вещества тофизопама. Применяется при невротических расстройствах и других состояниях, сопровождающихся эмоциональным напряжением, вегетативными нарушениями, умеренно выраженным страхом, пониженной активностью и навязчивыми переживаниями. В сексологической практике тофизопам используют при тревожном ожидании сексуальной неудачи и страхе перед коитусом (обычно в сочетании с методами психотерапевтической коррекции). Препарат назначают внутрь по 50 - 100 мг 1 - 3 раза в сутки. Курс лечение 2 - 4 недели.

Противопоказания: психомоторное возбуждение, глубокая депрессия и декомпенсированная дыхательная недостаточность.

Мезапам - дневной транквилизатор из группы бензодиазепинов. Препарат вызывает отчетливый анксиоли -

тический эффект. Седативное действие выражено слабо. Снижает состояние тревоги, чувство страха, внутреннее напряжение, общее двигательное беспокойство. Стабилизирует физическую активность. Выпускается в таблетках, содержащих по 10 мг действующего вещества медазепама. Применяется при тревожно - невротических расстройствах, психовегетативных жалобах. Пациентам с тревожным ожиданием сексуальной неудачи препарат назначают по 5 - 10 мг (1/2 - 1 таблетке) 2 - 3 раза в день в течение 2 - 3 недель. При психогенных эрекционных дисфункциях для коррекции нейровегетативной регуляции тонуса генитальных артерий мезапам, как и другие транквилизаторы, часто сочетают с приемом а2 - адреноблокаторов (сермион, редергин и т. п.). Может применяться у женщин, испытывающих различного рода тревожные опасения по поводу сексуальных контактов. Препарат с осторожностью назначают больным с тяжелыми нарушениями функции почек или печени.

Б. Нейролептики

Тиоридазина гидрохлорид (сонапакс) - оказывает умеренное антипсихотическое действие, которое сочетается с успокаивающим влиянием с известным стимулирующим компонентом и мягким антидепрессивным эффектом. Выпускается в драже по 10 и 25 мг препарата. Используется при психических и эмоциональных расстройствах, сопровождающихся страхом, тревогой, напряженностью, ипохондрией, навязчивостями, фобиями, сенестопатиями. Амбулаторно для лечения пограничных состояний сонапакс применяют в дозе 30 - 100 мг/сутки. В сексологической практике тиоридазин чаще всего используется у пациентов с преждевременной эякуляцией. Для удлинения коитуса препарат обычно назначают по 20 - 25 мг за 1 - 1,5 часа до половой близости. В целях снижения местной реактивности на головку полового члена перед половым актом дополнительно могут наноситься местноанестезирующие средства. Следует учесть, что сонапакс, как практически любой нейролептик, способен угнетающе влиять на потенцию, поэтому его не следует использовать у мужчин, предъявляю -

277

щих жалобы на ускоренную эякуляцию и слабость эрекции одновременно.

Сонапакс противопоказан при возникновении к нему аллергических реакций, изменениях картины крови после применения других лекарств.

В. Антидепрессанты

Сертралин *(золофт)* - типичный представитель антидепрессантов - селективных ингибиторов реаптейка серо - тонина (СИРС), которые увеличивают нейротрансмиссию 5 - hydroxytrptamine (5 - НТ). Блокадой обратного захвата серотонина пресинаптическими окончаниями нейронов и стимуляцией серотонинергических структур мозга объясняют основное тимоаналептическое действие препаратов данной группы. Считается, что этот же механизм обеспечивает терапевтический эффект СИРС при обсессивно - компульсивных и панических расстройствах, дисморфофобии, синдроме хронической усталости, нервной анорексии и булимии, ипохондрическом расстройстве и разнообразных хронических болевых синдромах, расстройствах привычек и влечений, личностной патологии, которая сопровождается чрезмерной раздражительностью и агрессивностью, включая сексуальное агрессивное поведение.

Важная особенность всех препаратов группы СИРС - практически полное отсутствие прямого воздействия на холинергические, адренергические гистаминергические, серотонинергические, дофаминергические и ГАМК - ергические рецепторы, что существенно снижает риск побочных эффектов или серьезных осложнений при передозировке.

Сертралин выпускается в таблетках по 50 мг и 100 мг. Наряду с отчетливым тимоаналептическим эффектом препарат оказывает анксполитическое, антиобсессивное и вегетостабилизирующее действие. Применяется для лечения депрессий, тревожно - депрессивных состояний, панических и обсессивно - фобических расстройств. Препарат назначают 1 раз в день. Терапевтическая доза составляет от 50 до 200 мг/сутки.

Использование сертралина у сексологических пациентов основано на известном клиническом факте: все пре -

278

параты группы СИРС, существенно не влияя на потенцию, тормозят наступление семяизвержения (в наибольшей степени пароксетин и сертралин). В целях удлинения коитуса у мужчин с преждевременной эякуляцией золофт назначают по 1/2 таблетке (25 мг) 1 раз в сутки во второй половине дня. При отсутствии необходимого эффекта после двух недель приема дозу увеличивают до 1 таблетки (50 мг) в сутки. Длительность терапии составляет около 2 месяцев. Возможно, потенцирование эффекта золофта местным применением 10 % раствора лидокаина в аэрозоле непосредственно перед коитусом. Пациентам также рекомендуется активно использовать приемы древних восточных практик, позволяющие пролонгировать половой акт. (У мужчин с преждевременной эякуляцией в чистом виде они, как правило, малоэффективны.) К таким приемам, например, относятся неоднократное сжатие анальной мускулатуры и повторные круговые движения глазных яблок при резком усилении возбуждения во время коитуса. На фоне употребления золофта, повышающего порог возбудимости эякуляторного центра, эти приемы оказывают дополнительный эффект и, кроме того, выступают в качестве своеобразных «якорей», формируя при регулярных повторениях условно - рефлекторную связь между их выполнением и задержкой эякуляции. После окончания курса лечения золофтом это позволяет многим пациентам успешно использовать указанные приемы для пролонгации коитуса.

У женщин сертралин применяется при диспареунии психогенного генеза, сексуальной аверсии, гениталгиях, алибидемии на фоне депрессивной симптоматики. Средняя суточная дозировка составляет от 25 до 75 мг.

К возможным побочным эффектам при приеме сертралина относят нарушения желудочно - кишечного тракта (тошнота, диарея), снижение аппетита, головную боль, редко потливость и тремор. У пациентов, страдающих тревожными расстройствами, в первые недели приема могут отмечаться усиление тревоги и беспокойства, расстройства сна и другие симптомы гиперактивации. Препарат не рекомендуется применять у больных с нарушениями функции печени и почек.

Дапоксетина гидрохлорид **-** новый селективный ингибитор обратного захвата серотонина с коротким пе-

риодом полураспада. В силу своей фармакокинетики он не обладает выраженным антидепрессивным эффектом, но используется специально для лечения мужчин с преждевременной эякуляцией. Все наиболее известные препараты этой группы (флуоксетин, сертралин, пароксетин) увеличивают интравагинальное латентное время эякуляции (IELT), однако они не достигают пиковых плазменных концентраций даже *в* течение нескольких часов. Это затрудняет их применение как препаратов «по требованию», т. е. в целях удлинения продолжительности полового акта незадолго до его начала. Дапоксетин ингибирует эффект обратного захвата серотонина и достигает максимальной пиковой концентрации в плазме крови всего за 1 час. Начальный период полураспада составляет 1,2 часа, через 24 часа в крови обнаруживается менее 5 % препарата от его максимальной концентрации. Поэтому дапоксетин может использоваться «по требованию», т. е. примерно за 1 час до полового акта. В двойном плацебо контролируемом исследовании, включающем более 2600 пациентов с преждевременной эякуляцией, дапоксетин назначался в дозе 30 мг или 60 мг за 1 - 3 часа до полового контакта. Средний возраст участников составлял 40 лет. О постоянной преждевременной эякуляции (с начала половой жизни) сообщили более 65 % участников, у 35 % участников имела место преждевременная эякуляция после периода нормальных сексуальных отношений (F. Giuliano, 2007). Первым моментом исследования было изучение интравагинального латентного времени эякуляции (IELT), которое было измерено секундомером во время полового акта. Анализ результатов показал статистически значимое дозозависимое увеличение среднего 1E1/Г: 0,9 - 1,75 минут, 0,92 - 2,78 минут и 0,91 - 3,32 для плацебо, дапоксетина 30 мг и дапоксетина 60 мг соответственно. Этот эффект был одинаков для начальной дозы, для последующих применений препарата, причем улучшение сохранялось в течение 12 - недельного периода исследования. Дапоксетин хорошо переносился участниками исследования. Побочные эффекты выражались в виде тошноты и головной боли. В группе, принимающей дапоксетин в дозе 30 мг, 3,7 % пациентов сообщили о тошноте и 5,9 % пациентов сообщили о головной боли. В группе, принимающей дапоксетин в дозе 60 мг, о тошноте сообщили

20,1 % пациентов и о головной боли - 6,8 % пациентов. Прекращение лечения из-за побочных эффектов в группе плацебо, дапоксетин 30 мг и дапоксетин 60 мг было отмечено у 0,9 %, 4 % и 10 % пациентов соответственно.

Тианептин (коаксил) - трициклический антидепрессант, обладающий анксиолитическими и вегетостабилизирующими свойствами. Выпускают в таблетках по 12,5 мг. Механизм действия тианептина связывают с повышением обратного захвата серотонина нейронами головного мозга и гиппокампа. Препарат применяют при нерезко выраженных депрессиях и тревожных состояниях различного генеза, а также у больных алкоголизмом с аффективными нарушениями. Рекомендуемая доза 37,5 мг в сутки (по 1 таблетке 3 раза в день перед едой). Тианептин лишен отрицательного влияния на половую сферу, поэтому без каких - либо ограничений его можно использовать у пациентов с психогенными и смешанными сексуальными дисфункциями.

Прием препарата в суточной дозе 25 - 37,5 мг приводит к ослаблению навязчивых сомнений и тревожных опасений перед возможной неудачей при коитусе. Курс лечения 3 - 4 недели.

Коаксил хорошо переносится, поскольку не оказывает холинолитического действия. Изредка могут отмечаться быстро преходящие боли в эпигастрии, сухость во рту, тошнота, запоры, нарушения сна, головокружение, головная боль, тахикардия, экстрасистолия, мышечные боли.

Препарат не имеет противопоказаний, за исключением одновременного применения ингибиторов МАО и детского возраста пациента (до 15 лет).

Тразодон (триттико) - антидепрессант сложной бициклической структуры с недостаточно ясным механизмом действия. Препарат блокирует обратный нейрональный захват серотонина, а также обладает адренолитическими, антисеротониновыми и некоторыми антигистаминными свойствами. Выпускается в таблетках по 50 мг. Тразодон оказывает умеренное антидепрессивное действие, а также седативный, анксиолитический и в меньшей степени антифобический эффекты. Чаще применяется при неглубоких тревожных депрессиях различного происхождения и дисфорических состояниях органического генеза, психосома –

тических заболеваниях. Рекомендуемые дозы варьируют от 200 до 600 мг в сутки в три приема. Тразодон способен усиливать эрекции, а при его приеме в высоких дозировках у мужчин иногда даже развивается приапизм. Поэтому в небольших дозах (100 - 200 мг/сутки) препарат можно использовать при эректильных дисфункциях различного генеза, сопровождающихся тревожным ожиданием сексуальной неудачи и пониженным настроением. Курс лечения около 1 месяца. Прием тразодона иногда сопровождается побочными эффектами: сонливостью, сухостью во рту, головокружением, утомляемостью, снижением артериального давления, сердечными аритмиями и раздражением желудочно - кишечного тракта. Противопоказан при инфаркте миокарда.

Миансерин (леривон) - антидепрессант тетрациклической структуры с седативным компонентом. Выпускается в таблетках по 30 мг миансерина гидрохлоридз. По антидепрессивной активности эффективность леривона сопоставима с другими современными антидепрессантами. При этом его особенностью является отчетливое анксиолитическое действие, позитивное влияние на сон и анальгезирующее действие при преобладании затяжных болевых синдромов и отсутствии указаний на их органическое происхождение. В сексологической практике чаще применяют при гениталгиях и диспареунии на фоне явной или латентной депрессивной симптоматики (типичные суточные колебания болевой интенсивности, ранние пробуждения, сезонные обострения и т. п.). Препарат назначают с 15 мг на ночь. Обычно терапевтическая доза не превышает 30 - 60 мг/сутки. При наиболее упорных гениталгиях психосоматического генеза миансерин комбинируют с ингибиторами обратного захвата серотонина (флувоксамин, постепенно повышая с 25 мг до 100 - 150 мг/сутки, сертралин - с 12,5 мг до 50 - 100 мг/сутки).

При назначении леривона рекомендуется соблюдать осторожность у больных с заболеваниями сердечнососудистой системы, печеночной и почечной недостаточностью.

В терапевтических дозах леривон в отличие от трициклических антидепрессантов не имеет антихолинергического и кардиотоксического эффектов.

282

Г. Психостимуляторы

Сиднокарб - психостимулирующее средство. Стимулирующий эффект препарата связан с его воздействием на норадренергические и в некоторой степени дофаминергические структуры головного мозга. Выпускается в таблетках по 5 и 10 мг. Применяется при затяжных астенических состояниях различной этиологии. Уменьшает явления алкогольной абстиненции. В сексологической практике сиднокарб используется при снижении либидо, реже - в случаях ухудшения эрекций у мужчин на фоне выраженной астенизации, вялости и апатии. Дозы подбирают индивидуально. Начальная доза - 5 мг в сутки в один прием. При необходимости ее постепенно увеличивают до 15 - 30 мг/сутки, разделив на два приема в первой половине дня. Курс лечения 2 - 3 недели. Сиднокарб не следует назначать возбужденным пациентам и при явлениях раздражительной слабости. Осторожность требуется при выраженном атеросклерозе и гипертонической болезни.

Д. Ноотропы

Пикамилон - ноотропный препарат, сочетающий свойства гамма - аминобутировой и никотиновой кислоты. Препарат улучшает память, увеличивает устойчивость ЦНС к воздействию неблагоприятных факторов. Оказывает некоторое анксиолитическое и психостимулирующее действие, восстанавливает умственную и физическую работоспособность при переутомлении. Улучшает церебральный кровоток, имеет антигипоксический и антиоксидантный эффекты. Выпускается в таблетках по 20 мг и 50 мг. В сексологической практике применяется в комплексном лечении сексуальных дисфункций, развившихся после перенесенных черепно - мозговых травм, ишемического инсульта, нейроинфекции, а также не фоне астенических и астенодепрессивных состояний, обусловленных нервно - психическими заболеваниями. Пикамилон назначают по 20 - 50 мг 2 - 3 раза в сутки. Курс

лечения 1 - 2 месяца. Побочные эффекты наблюдаются редко. Возможны аллергические реакции, тошнота, головная боль и головокружение.

Противопоказания: острые и хронические заболевания почек.

283

4.8. Гепатопротекторы

Эссенциале - комплексный препарат, содержащий «эссенциальные» фосфолипиды (субстанцию EPL) вместе с витаминами. Главное действующее вещество препарата субстанция EPL - основной элемент в структуре клеточной оболочки и органелл гепатоцитов. Эссенциале оказывает нормализующее действие на метаболизм липидов, белков и дезинтоксикационную функцию печени, восстанавливает и сохраняет клеточную структуру печени, тормозит формирование в ней соединительной ткани. Препарат выпускается в капсулах и в виде раствора для инъекций по 5 мл в ампуле. Применяют при гепатитах и циррозе печени, жировой дегенерации печени различной этиологии, лекарственных и алкогольных поражениях печени. Лечение рекомендуется начинать с комбинированного введения эссенциале внутривенно (по 1 - 2 ампулы ежедневно) и внутрь по 2 капсулы 2 раза в день. По мере улучшения состояния печени полностью переходят на пероральный прием препарата по 2 капсулы 2 - 3 раза в сутки во время еды. Курс лечения составляет 3 месяца и при необходимости может быть продолжен или повторен.

Известно, что при выраженных нарушениях функции печени у мужчин может развиваться гипогонадизм и феминизация организма (геникомастия, уменьшение оволосения тела). Отмечаются снижение полового влечения, ослабление эрекций, уменьшение объема эякулята и количества сперматозоидов. В плазме крови падает содержание тестостерона, а уровень пролактина повышается, увеличивается суточная экскреция эстрогенов с мочей. В этих случаях использование препаратов, улучшающий функциональное состояние печени и ускоряющих процесс восстановления гепатоцитов, - обязательный элемент в комплексной терапии сексуальных дисфункций. Как правило, проводят повторные курсы лечения эссенциале или другими гепатопротекторами в сочетании с адаптогенами, поливитаминами и аминокислотами. Эссенциале обычно хорошо переносится. Крайне редко возникают неприятные ощущения в эпигастральной области.

Лив - 52 - комбинированный препарат, изготовляемый из лекарственных растений по рецептам древней индийской медицины. Оказывает гепатостимулирующее, гепатопротективное и холеретическое действие, тонизирует желудочно - кишечный тракт. Лив - 52 выпускается в виде таблеток и каплей для приема внутрь, содержащих 19 растительных ингредиентов. Препарат используется при гепатитах и циррозах печени, хроническом жировом гепатите, а также для профилактики и лечения поражений печени лекарственными препаратами, химическими веществами и алкоголем. Лив - 52 назначают по 2 - 3 таблетки по 3 - 4 раза в день на протяжении 2 - 3 месяцев и более. При нарушениях потенции у больных алкоголизмом, в том числе в периоды алкогольной ремиссии, Лив - 52 применяют в вышеуказанной дозировке вместе с адаптогенами, метаболитами, поливитаминами. Курс лечения 1,5 - 2 месяца. Крайне редко Лив - 52 вызывает аллергические реакции и диспептические явления.

4.9. Препараты, действующие в области периферических нервных окончаний

А. Местноанестезирующие средства

Лидокаин в виде дозированного аэрозоля для местного применения. Содержит 790 доз во флаконе (одна доза - 4,0 мг). Используется у мужчин, страдающих преждевременной эякуляцией, как правило, на фоне приема препаратов центрального действия, повышающих пороги эякуляторного рефлекса (спеман - форте, резерпин, анафранил, золофт и др.). Обычно на головку полового члена в области уздечки за несколько минут до коитуса наносится 1 - 2 дозы аэрозоля лидокаина, что вызывает локальное снижение чувствительности примерно на 15 минут. В ряде случаев это способствует увеличению продолжительности полового акта. При обильном орошении аэрозолем лидокаина всей головки и других участков полового члена тотальное

снижение его чувствительности может тормозить эрекцию или приводить к временному исчезновению

285

сладострастных ощущений при копулятивных фрикциях. Наружное применение лидокаина противопоказано при повышенной чувствительности к препарату.

Б. Местнораздражающие мази

Химколин - сексуальный стимулятор для местного применения. Выпускается в виде крема, содержащего масла лекарственных растений по 10 или 21 г в тубах. Препарат увеличивает кровенаполнение полового члена, способствуя достижению эрекции. При эректильных дисфункциях химколин применяется вместе с препаратом тентекс - форте либо с другими адаптогенами. Обычно крем наносят на половой член и лобковую область, втирая его путем легкого массирования 1 - 2 раза в день в течение месяца. Химколин также используют примерно за 1 час до предстоящей близости, смывая его непосредственно перед коитусом или не делая этого, поскольку крем не оказывает раздражающего воздействия при попадании во влагалище женщины. Допускается местное применение химколина у женщин для повышения чувствительности генитальных эрогенных зон.

4.10. Препараты улучшающие функцию простаты

Спеман - форте - содержит ряд экстрактов растительного происхождения. Выпускается в таблетках по 100 штук в упаковке. Снижает возбудимость центров, регулирующих половые функции у мужчин, улучшает функциональную активность предстательной железы.

Основными показаниями к приему препарата являются преждевременная эякуляция, сперматорея, частые ночные поллюции,

половые дисфункции, обусловленные возрастной инволюцией. При ускоренном семяизвержении спеман - форте назначают по 1 - 2 таблетке 2 - 3 раза в день на протяжении 3 - 4 недель. При сперматорее назначают по 1 - 2 таблетке в день 4 - 6 недель.

Простанорм - жидкий экстракт для приема внутрь. Содержит травы зверобоя и золотарника канадского, корень солодки, корневища с корнями эхиноцеи пурпурной.

286

Препарат обладает простатотропным действием, обусловленным умеренной андрогенной активностью, противовоспалительным, анальгезирующим свойствами, а также способностью улучшать микроциркуляцию тканей предстательной железы, нормализует диурез. Оказывает бактериостатическое действие на грамположительные бактерии (энтерококки, стрептококки и стафилококки).

Применяется при лечении хронического неспецифического простатита внутрь по и чайной ложки (2,5 мл), разведенной в ¼ стакана воды, 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 4 - 6 недель.

4.11. Другие методы коррекции эректильных дисфункций у мужчин

1. Использование эректоров

Эректор - специальная механическая конструкция, которая надевается на член перед половым актом и позволяет осуществить интроитус и последующие фрикции даже при значительном снижении эрекции у мужчины. Существует несколько модификаций механических эректоров. Для успешного использования эректора необходимо максимально точно подобрать его размер. Эректоры обычно применяются у мужчин, страдающих грубыми эректильными дисфункциями (чаще органического генеза), резистентными к проводимому лечению (при сохранности у них либидо и эякуляции). Рекомендуя эректор, необходимо учесть, что многие пациенты и их партнерши весьма негативно относятся к подобному способу коррекции нарушений эрекции. Вместе с тем низкая стоимость приспособления делает его вполне доступным даже для малообеспеченных лиц.

2. Вакуумная терапия эректильных дисфункций

В России первую попытку использовать вакуумную терапию предпринял И. В. Заблудовский, который в 1909 го -

287

ду предложил «пневмомассаж». Впоследствии метод был усовершенствован Р.В. Беледой (1981) и получил название «локальная декомпрессия» (ЛД). Во время сеанса половой член пациента помещают в прозрачную мини - барокамеру из органического стекла, из которой вакуумным насосом АЛИ - 01 откачивают воздух до появления выраженной эрекции и чувства распирания в головке полового члена (соответствует разрежению 0,3 - 0,4 кг/см2), затем разрежение плавно уменьшают, что приводит к ослаблению эрекции. Попеременно чередуя уровень декомпрессии в колбе, проводят своеобразный пневмомассаж полового члена. При этом рабочее разрежение в колбе колеблется от 0,1 до 0,37 кг/см2. Время одной процедуры ЛД устанавливаются врачом индивидуально при их общем количестве до 10 - 12 на курс.

Основные терапевтические механизмы локальной декомпрессии следующие. Артериальная кровь в условиях пониженного барометрического давления более интенсивно насыщает кислородом окружающие ткани. Это благоприятно воздействует на трофику тканей полового члена и способствует активизации кровотока в сосудистом аппарате кавернозных тел. Имеет значение восстановление во время сеансов специфических сексуально окрашенных ощущений, сопровождающих полную эрекцию. Возникая в эрогенных зонах полового члена, они запускают, а затем поддерживают нормальные механизмы сексуального возбуждения. Нервные окончания, раздражаемые приливом к половому члену насыщенной кислородом крови, порождают импульсы, поступающие в сексуальные центры головного мозга. В результате оживляются угасшие нервные связи, улучшается нервная регуляция генитальных сексуальных реакций мужчины. Процедура имеет отчетливый психотерапевтический эффект, поскольку вид эрегированного полового члена создает у больного уверенность в успехе лечения. ЛД широко применяется при эректильных дисфункциях различной этиологии (психогенной, сосудистой, инволюционной и др.). Например, в сочетании с сосудорасширяющими препаратами это - наиболее эффективный физиотерапевтический метод лечения нарушений эрекции у больных с патологией кровоснабжения гениталий. Противопоказаниями к использованию ЛД являются тяжелые психические расстройства,

288

злокачественные опухоли, сердечно - сосудистая недостаточность, некоторые местные заболевания (фимоз, парафимоз, варикозное расширение вен семенного канатика, водянка яичка, пахово - мошоночные грыжи).

За рубежом с 70 - хгодов применяются различные приспособления по созданию разрежения (вакуума) в прозрачной колбе, надетой на половой член, благодаря чему происходит усиление притока крови к кавернозным телам и возникает принудительная эрекция. Затем для ее поддержания на корень эрегированного полового члена надевается специальное резиновое кольцо, которое затрудняет отток крови от кавернозных тел. Вакуумные устройства (E/P System, ErecAid System, VTU System и др.) способны обеспечить эрекцию, достаточную для осуществления коитуса в 80 - 85 % случаев, однако сжимающее основание полового члена эластичное кольцо может изменить характер ощущений во время фрикций и ослабить эякуляцию. Мужчине необходимо помнить, что оставлять стягивающее кольцо на корне полового члена более 30 минут опасно, так как ригидность, полученная при помощи вакуумного приспособления, является причиной венозного застоя всех тканей полового органа. Некоторые пациенты жалуются на чувство онемения, болезненность и изменения цвета эрегированного члена. Использование вакуумных приспособлений исключает спонтанность при интимной близости и может вызывать психологический дискомфорт у одного иди обоих партнеров,

3. Хирургическое лечение

1. *Реваскуляризация кавернозных тел.* При окклюзионных поражениях артериального русла, кровоснабжающего гениталии, применяются различные варианты шунтирования артерий полового члена, обеспечивающие усиление притока крови к пещеристым телам.

2. *Резекция глубокой тыльной вены полового члена.* Выполняется при патологическом венозном оттоке из кавернозных тел.

3. *Иссечение фиброзной бляшки с последующим замещением кожного дефекта* производят при грубых

деформациях полового члена, обусловленных болезнью Пейрони.

4. *Фаллопротезирование.* Используется при наиболее тяжелых эректильных дисфункциях органической генеза, резистентных к другим способам лечения. Применяется несколько типов протезов. Выбор оптимальной конструкции - важное условие для успешной сексуально - психологической реабилитации пациентов и их партнерш в послеоперационном периоде. Имеются различ ные модели полужестких, гибких, мягких и гидравлически; протезов. Наиболее совершенные на сегодняшний день трехкомпонентные гидравлические протезы, которые позволяют достичь почти физиологического состояния расслабления полового члена, а при необходимости получить полноценную имитацию эрекции. К их недостаткам следует отнести техническую сложность имплантации и высокую стоимость трехкомпонентных моделей гидравлически; протезов. По некоторым оценкам, не менее 90 % мужчин подвергшихся эндофаллопротезированию, остались довольны достигнутым результатом, однако со временем. (5 лет и более после операции) этот показатель уменьшается до 48 % (E. Montors et. al., 1993).

Следует подчеркнуть, что восстановление генитального кровотока хирургическим путем, равно как и успешное проведенное эндофаллопротезирование, сами по себе не ведут к автоматическому решению пациентом всех своих сексуальных проблем, многие из которых лежат совершенно в иной плоскости - зафиксированных страхов, навязчивых опасений, комплексов неполноценности, нарушений партнерского взаимодействия и т. п. Поэтому даже самое эффективное хирургическое лечение, обеспечивая лишь механическую сторону половой активности, должно быть подкреплено соответствующими психотерапевтическими мероприятиями, которые направлены на решение главной, конечной цели лечения данного контингента больных - восстановление психологических и физиологических возможностей к выполнению партнерских функций, т. е. их сексуальной реабилитации.

Глава 5. Психотерапия сексуальных дисфункций

5.1. Место психотерапии в сексологическом лечении

Психотерапия играет важную роль в сексологическом лечении. В ряде случаев она является единственной формой терапии сексуальных расстройств либо - используется как форма дополняющего лечения или как один из компонентов комплексного лечения (К. Имелинский, 1986). Половые расстройства в силу большой личностной значимости сексуальной сферы могут привести к различным невротическим нарушениям, депрессии с суицидальными тенденциями, что еще больше повышает значение психотерапии в лечении таких больных (Г.С. Кочарян, 1994). Так, по данным суицидологической службы Москвы, среди лиц, обратившихся за помощью, 26 % составляют пациенты с интимно - личными и сексуальными проблемами (Н.Д. Кибрик, 1999).

В одних случаях, невротические нарушения и психологические проблемы являются основной причиной сексуальных дисфункций, а в других — возникают вторично, на фоне уже имеющихся расстройств половой сферы органического генеза, усугубляют их течение, препятствуя полноценному восстановлению сексуальной активности пациентов даже при эффективном лечении основной патологии. Причем сексуальные нарушения невротической природы являются самой частой формой половых расстройств у мужчин (Х. Каплан,1987; Г.С. Васильченко,1990; З. Старович, 1991 и др.). В связи с этим важнейшее место в сексологическом лечении принадлежит эффективной психотерапевтической коррекции психологических механизмов (травмирующих переживаний и воспоминаний, неадекватных представлений, страхов и т. п.) половых дисфункций.

По мнению Л. Камерон-Бэндлер (1985), коррекция половых расстройств занимает уникальное место в психотерапии. В отличие от других психологических проблем,

относительно которых сам психотерапевт должен интерпретировать достигнутые результаты лечения, успех или неудача в сексуальном функционировании вполне определены. Явные физиологические реакции пациента, его удовлетворенность половой жизнью являются прямой демонстрацией того, достигнуты ли желаемые изменения.

Безусловно, что огромный арсенал психотерапевтических приемов и практик предполагает необходимость выбора наиболее адекватных из них, с учетом специфики сексологической проблематики и тесного взаимовлияния интимной жизни и супружеских отношений в целом.

Различные психотерапевтические школы по-разному объясняют причины половых расстройств и предлагают весьма отличающиеся друг от друга подходы к их коррекции. Так, например, применение классического психоанализа основывается на представлении, что, например, нарушения эрекции являются результатом подсознательных страхов мужчин, связанных с Эдиповым комплексом, в силу чего супруга воспринимается в качестве объекта, с которым должна существовать эмоциональная, но не половая близость (W. Lauman, 1972; J. Bieber, 1974). Сторонники другой психодинамической ориентации полагают, что сексуальные дисфункции у мужчин связаны с общими аспектами межличностных взаимоотношений и рассматриваются как проявления враждебности, направленной на партнершу (D. Hasting, 1971; L. Salzman, 1972). Через призму базового внутреннего конфликта, обусловленного конфронтацией индивида с данностями человеческого существования, экзистенциальная психотерапия в ряде случаев позволяет понять истоки и найти адекватные пути решения сексуальных проблем, подчас являющихся лишь фасадом, за которым скрываются глубинные страхи пациентов перед конечностью бытия, личной свободой и вытекающей из нее ответственностью за свою жизнь, возможным одиночеством и отсутствием самоочевидного смысла жизни. (И. Ялом, 1999). Представители рационально-эмотивной психотерапии (РЭТ) помогают пациентам преодолевать затруднения в интимной сфере путем активной коррекции их иррациональных представлений, нереалистичных убеждений и надежд в отношении половой жизни, уделяя наибольшее внимание эмоциональным и когнитивным проявлениям сексуальных

дисгармоний и улучшению межличностных отношений супругов (А. Эллис, 1985, 1990). Большое распространение получили приемы бихевиоральной (поведенческой) терапии, основанные на тщательном анализе проблематичного сексуального поведения и использовании положительных и отрицательных подкреплений, наиболее подходящих для данного случая (D. Wolpe, 1958, 1982; A. Mathews et al., 1976). Бихевиоральные техники используют как для устранения тревоги, являющейся стержнем любых невротических расстройств, в том числе и в сексуальной сфере (систематическая десенсибилизация на фоне мышечной релаксации, тренинг уверенности и т. п.), так и для уменьшения супружеских конфликтов и мотивации партнеров к конструктивному взаимодействию (структурированный тренинг общения, техника позитивных обменов и др.) (D. Wolpe, 1958; N. Jacobson, G. Margolin, 1979). Для коррекции психогенных сексуальных дисфункций также применяют гештальтподход (F. Perls, 1973); телесно-ориентированные методы психотерапии (W. Reich, 1949; A. Lowen, 1965); гипнотерапию (D. Araoz, 1980; D. Harmond, 1991); нейролингвистическое программирование (L. Cameron-Bandler, 1985); метод десенсибилизации и переработки движениями глаз (V. Wernie, 1993); символдраму или метод кататимного переживания образов (Х. Лейнер, 1996; В. Стюарт, 1998) и др. Следует отметить, что отличительной чертой всех перечисленных подходов является «встроенность» приемов работы с лицами, предъявляющими сексологические жалобы, в определенную модель психотерапии, например психоаналитическую либо бихевиоральную.

Автор мультимодальной психотерапии А. Лазарус (1985, 2001) предлагает опираться в выборе наиболее подходящих для конкретного пациента методов и техник психотерапии на тщательное изучение его BASIC I. D. Это сокращение, составленное из первых букв семи исследуемых модальностей: поведение, аффективные реакции, ощущение, воображение, когнитивные элементы, межличностные отношения, медикаментозное воздействие или иные биологически факторы. Согласно Лазарусу, полноценное лечение любых нарушений, включая сексуальные, заключается в коррекции дезадаптивного и девиантного поведения, неприятных чувств, негативных ощущений, нежелательных

фантазий, дисфункциональных убеждений и биохимического дисбаланса. Мультимодальная терапия предполагает технически эклектичный подход, а использование тех или иных психотерапевтических методов основывается на определении того, «какое и кем проводимое лечение и при каких обстоятельствах окажется наиболее эффективным для этого человека, с этой конкретной проблемой. По мнению А. Лазаруса (1990), такой подход в высокой степени соответствует требованию, выдвинутому М. Эриксоном: «Каждый человек уникален. Поэтому психотерапия должна осуществляться так, чтобы соответствовать потребностям именно этого человека, а не пытаться приспособить индивида к прокрустову ложу той или иной гипотетической теории человеческого существования».

Следует отметить, что, по свидетельствам его учеников, сам М. Эриксон весьма эффективно работал с пациентами, имеющими сексуальные проблемы. Эриксоновский подход к лечению половых дисфункций основан на определении и гибком изменении имеющихся дезадаптивных стереотипов межличностного взаимодействия и/или сексуального поведения одного из партнеров либо супружеской пары. Он базируется на широком использовании многоуровневого (по сути, гипнотического даже без формальной трансовой индукции) метода воздействия. Применяют различные варианты косвенных суггестии, включая сообщения метафорического типа и сложные аналогии, которые позволяют обойти сопротивление, реорганизовать бессознательные процессы и активизировать внутренние ресурсы пациента для улучшения его интимных отношений. Кроме предъявления адекватной информации о психофизиологии сексуальности и помощи супругам в обнаружении всего лучшего в их взаимоотношениях; партнерам даются рекомендации по совместному выполнению специальных упражнений, во многом сходных с приемами из арсенала сексуальной терапии (Д. Зейг, 1990; Д. Хейли, 1991). Характерной чертой эриксоновского подхода также является использование парадоксальных интервенций. Например, в терапии мужчин с психогенным торможением эрекции - наложение «строжайшего» запрета на любую сексуальную активность партнеров, которые при этом должны продолжать спать в одной постели. Или смена «ярлыков», навешиваемых на

супружеские проблемы. Суть этого приема состоит в позитивном переопределении симптома или дисфункционального поведения, которое дает паре возможность по-новому взглянуть на всю ситуацию в целом. Ситуация фиаско в первую брачную ночь может быть переопределена как следствие того ошеломляющего впечатления, которое произвела на мужа красота молодой жены, в результате чего он начал опасаться возможной неудачи, что фактически и произошло (Д. Уикс, Л.Л. Абат, 2002). Применение эриксоновских стратегий и недирективных гипнотических техник в коррекции психогенных нарушений половой сферы и семейно-сексуальных дисгармоний облегчает и существенно ускоряет достижение устойчивых позитивных изменений сексуального взаимодействия партнеров.

В настоящее время преобладающей тенденцией в сексологическом лечении является сочетанное использование различных методов психотерапии, нередко подкрепляемых назначением лекарственных препаратов, физиотерапевтическим воздействием и т. п. Такая интегрированная терапия часто используется в виде специальных лечебных программ, т. е. систематизированного и планового применения нескольких методов психотерапии (вместе со вспомогательными средствами) для устранения соответствующих сексуальных дисфункций или девиаций (К. Имелинский, 1986). Первой из подобных программ была сексуальная терапия, предложенная У. Мастерсом и В. Джонсон (1970) для лечения партнерской пары. Они разработали способы коррекции различных вариантов сексуальных дисфункций с использованием в ходе интимного взаимодействия партнеров специальных технических приемов. В основе модели У. Мастерса и В. Джонсон лежит бихевиоральный подход, а терапевтические усилия направлены на модификацию индивидуальных вариантов сексуального поведения и развитие подлинной, адекватной взаимосвязи между партнерами.

Х. Каплан (1974, 1994) объединила методы Мастерса и Джонсон с принципами психоаналитической терапии. В данном подходе симптомы психогенных сексуальных нарушений рассматриваются как результат непосредственно действующих деструктивных ментальных и эмоциональных процессов и проявлений психологической защиты. Соглас-

но многофакторной модели Х. Каплан (1979), все половые дисфункции имеют непосредственные (поверхностные) причины, например, беспокойство мужчины по поводу «изъянов» своих сексуальных действий, которое тормозит сексуальные рефлексы и/или блокирует эротические переживания. Вместе с тем во многих случаях эти непосредственно действующие факторы связаны с более глубокими проблемами человеческих взаимоотношений. Неосознанные сексуальные конфликты, негативные «сообщения» о сексе, неврозы, корни которых находятся в раннем психосексуальном развитии пациента, образуют глубинную этиологическую структуру в сексологической симптоматике супружеской пары.

По мнению Х. Каплан (1994), основная цель секс-терапии в ее поведенческом аспекте заключается в изменении «непосредственных» причин полового расстройства, ибо до тех пор, пока не устранены постоянно действующие стрессогенные факторы, пациенты сохраняют дисфункциональность, даже если они получили четкое представление о своих глубинных конфликтах, и ощущение вины, связанное с сексуальным удовлетворением. В то же время, если у супружеской пары имеются скрытые конфликты и проблемы во взаимоотношениях, нередко можно наблюдать сопротивление сексотерапевтическому вмешательству, для ослабления которого и требуются сеансы активной психодинамической терапии.

G. Arentewicz, G. Shmidt (1986) предложили несколько иную терапевтическую модель, отличающуюся большей интегрированностью сексотерапевтической практики и психоанализа. Она ставит перед собой следующие цели: 1) ослабление механизмов самоукрепления полового расстройства в результате проведения парной психотерапии, которая способствует устранению страхов сексуальной несостоятельности или стратегии уклонения; 2) ликвидация дефицита просвещенности в сексуальной сфере; 3) разъяснение значения сексуального расстройства в отношениях между партнерами и проработка лежащих в его основе конфликтов; 4) разъяснение и проработка первопричинных психодинамических конфликтов и страхов. К условиям успешной психотерапии G. Arentewicz und G. Schmidt (1986) относят многократные предварительные собеседования

с целью обследования партнеров вместе и по отдельности для установления вида сексуального расстройства и определения предварительных показаний к лечению; урегулирование вопросов контрацепции; выяснение жилищных условий и распределения свободного времени пар; их сексуального поведения в настоящее время; истории полового воспитания и отношения к сексу на данный момент. Все это позволяет разработать конкретную терапевтическую стратегию для пары и дать необходимые рекомендации относительно дальнейших совместных действий партнеров.

Следует отметить, что «в последние годы все большее число сексологов в США прибегают к эклектичным методам при лечении сексуальных расстройств, т. е. они используют самые разнообразные сочетания приемов терапии, учитывая особенности конкретного пациента настолько, насколько это возможно. Хотя они и могут заимствовать уже отработанные методы какой-либо известной научной школы, имеется понимание того, что необходимо проявлять гибкость и идти в ногу с меняющимися подходами и все возрастающим объемом научных знаний» (R. Rosen, S. Leiblum, 1995).

В России и других странах СНГ в работе с сексологическими пациентами наиболее широко используются традиционные для отечественных специалистов психотерапевтические методы и приемы: рациональная психотерапия (И. Е. Вольперт, 1972; Н. Д. Кибрик, 1999 и др.), аутогенная тренировка и самовнушение (В. В. Андрианов, 1968, 1993; Г. С. Кочарян, 1991 и др.), гипносуггестивная терапия (Д. Л. Буртянский, В. В. Кришталь, 1974; А. М. Свядощ, 1982); методики семейной и супружеской психотерапии (Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, 2002 и др.). В последние годы появились сообщения о применении в сексологической практике иных психотерапевтических подходов: гештальттерапии (Л. И. Козловская, 1996, 2001), психоанализа (Л.М. Щеглов, 1998; И. В. Белокрылов, 1999 и др.), нейролингвистического программирования (Г. С. Кочарян, 1994, 2002; В. А. Доморацкий, К. Ю. Королев, 1995), эриксоновского гипноза (В. А. Доморацкий, 1997).

В 1994 году в издательстве «Медицина» вышла в свет монография Г.С. Кочаряна, А.С. Кочаряна «Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов », в которой излагаются различные психотерапевтические методы,

применяемые в сексопатологии. В книге описаны приемы и техники рациональной, косвенной, гипносуггестивной, поведенческой, групповой и семейной психотерапии. Кратко рассмотрены аутогенная тренировка, наркопсихотерапия, секс-терапия и психоаналитический подход, некоторые техники нейролингвистического программирования. Касаясь вопросов методологии, при выборе конкретной психотерапевтической стратегии авторы предлагают ориентироваться на диагностику у пациента психологических системных механизмов (защитных процессов и стратегий совладания). Они указывают на необходимость срыва в ходе психотерапевтического воздействия психологической защиты, дезорганизующей сексуальное поведение пациента, при одновременном усилении (формировании) механизмов совладания за счет правильного подбора компенсаторных техник и достижения устойчивой разрядки эмоционального напряжения (Г.С. Кочарян, А.С. Кочарян, 1994).

В.В. Кришталь и Б.Л. Гульман (1997) разработали целостный подход к психотерапии нарушений сексуального здоровья, опирающийся на системно-структурный анализ сексуальной гармонии супружеской пары. В соответствии с трехкомпонентной структурой межличностного взаимодействия ими выделены три элемента системы психотерапевтической коррекции: 1) когнитивный (информационный); 2) аффективный (эмоциональный); 3) конативный (поведенческий). Цепь лечебных воздействий носит непрерывный, последовательный (этапный), комплексный и дифференцированный характер. В общем виде первый этап состоит в формировании у пациентов здоровых психологических установок с помощью цикла индивидуальных и групповых психотерапевтических бесед. Второй этап психотерапии служит преодолению невротических реакций больных на свою сексуальную несостоятельность и супружескую дисгармонию. Рекомендуется использовать рациональную и гипно-суггестивную психотерапию, аутогенную тренировку и самовнушение, наркопсихотерапию, групповую патогенетическую психотерапию, опосредованную и потенциирующую психотерапию. Третий этап имеет целью непосредственно восстановление и активизацию сексуальных функций пациентов, научение правильному поведению, в частности сексуальному. С этой целью проводятся парная, супружеская психотерапия, тренинг общения, сексуально-

эротический тренинг, а также сексуальная терапия. Отметим, что данная, по сути интегративно-эклектическая, психотерапевтическая модель, достаточно хорошо разработана, но в нее не вошел целый ряд современных методов психотерапии (эриксоновский гипноз, НЛП, ДПДГ и т. п.). Кроме того, ориентация на супружескую пару с обязательным привлечением партнера к обследованию и лечению, безусловно, логична (с учетом парного характера сексуального функционирования), но не всегда полезна и осуществима на практике. По мнению Ю.А. Решетняка (1974), вопрос об участии обоих партнеров в лечении следует решать дифференцированно с учетом мотивов брака и факторов, связывающих супругов в их совместной жизни. Психотерапевтическая работа не только с пациентом, но и его партнершей, при всех ее очевидных положительных моментах, невыполнима, например, у одиноких лиц либо при категорическом отказе супруги от сотрудничества в терапевтическом процессе. Поэтому ни коим образом не отрицая значения подходов, всецело сосредоточенных на межличностной и сексуально-поведенческой адаптации пары, современные психотехнологии существенно расширяют возможности для индивидуальной терапии лиц, испытывающими сексуальные затруднения, а при необходимости позволяют эффективно работать с обоими партнерами.

Таким образом, большой удельный вес психогенных механизмов в развитии половых расстройств требует совершенствования психотерапевтических подходов в лечении пациентов сексологического профиля. Анализ имеющейся литературы показывает, что существуют две основные тенденции применения психотерапии в сексологической практике. Большинство зарубежных психотерапевтов осуществляют лечение психогенных сексуальных дисфункций исключительно в рамках того психотерапевтического подхода, которого они придерживаются в своей работе. Напротив, сексологи ориентированные психотерапевтически, чаще используют интегрированные лечебные программы, в которых на Западе чаще сочетаются бихевиоральный и психодинамический подходы, а в странах СНГ наиболее широко применяется эклектичный набор приемов рациональной, поведенческой и гипносуггестивной психотерапии, реже - некоторые техники семейной и супружеской

терапии. Несмотря на предпринимаемые исследователями попытки выделить последовательные этапы психотерапии половых дисфункций, за исключением сексотерапевтических программ, большинство психотерапевтических моделей в сексопатологии отличают декларативность и недостаточная структурированность. При этом используется достаточно ограниченный арсенал методов психотерапевтического воздействия. Игнорируются возможности дифференцированного подхода к выбору наиболее адекватных психотерапевтических вмешательств у пациентов, страдающих половыми дисфункциями, с учетом особенностей психологических механизмов их сексуальной дезадаптации. Это существенно затрудняет воспроизводимость большинства из предлагаемых психотерапевтических моделей в реальной сексологической практике.

Все вышесказанное и побудило автора к поиску и систематизации наиболее адекватных в сексологической практике методов психотерапии, которые были интегрированы в единую систему и легли в основу оригинального психотерапевтического подхода, первоначально приме-ненного у мужчин, страдающих половыми дисфункциями, а в дальнейшем (с учетом ряда особенностей женской сексуальности) и при обращении за сексологической помощью женщин.

5.2. Основные принципы и составляющие интегративной психотерапии сексуальных дисфункций у мужчин

На основании проведенного анализа многочисленных данных литературы и результатов собственных исследований мы выделили ряд психологических факторов, способствующих возникновению и/или усугублению сексуальных затруднений у мужчин. С помощмо факторного анализа была проведена интегральная оценка их значимости в формировании половых дисфункций психогенного и смешанного генеза у 180 мужчин (В.А. Доморацкий, 2004). Ее результаты представлены в табл. 5.1.

300

Таблица 5.7

Интегральная оценка значимости различных психологических факторов в формировании сексуальных дисфункций у 180 мужчин

Факторный анализ	Факторные нагрузки (Варимакс нормализованный) Выделение: главные компоненты					
Переменные (x)	Фактор 1	Фактор 2	Фактор 3	Фактор 4	Фактор 5	Фактор 6
Задержки психосексуального развития	**,533380* (p<0,02)**	,1551264	,335526	,284911	-,089427	,311046
Полороленые нарушения	,045713	,116542	,204231	,-073241	,154322	,021763
Наличие тех или иных акцентуаций характера	,140089	,054091	,311046	-,010773	-,016701	-,009355
Воспитание в неполной семье	,170310	-,122836	,025066	-,030918	,052247	,133046
Негативный первый сексуальный опыт	,195595	,152048	-,002223	-,145415	,074433	,193082
Тревожное ожидание сексуальной неудачи и [illegible]	,448-171	**,877685* (p<0,001)**	,348433	,015855	,140889	,079056
Неадекватные убеждения и установки в отношении половой жизни	,025066	-0,18713	**,606698* (o<0,01)**	,132686	-,010733	,294925
Нарушение межличностных отношений в паре	0,01392	-,03371 6	,335526	-,055640	**,672579* (p<0,01)**	,063800
Интрапсихические конфликты, затрагивающие сексуальную сферу	-,130315	-,072982	,074466	**,546284* (p<0,05)**	-,030918	,083728
Отсутствие эротической любви к партнерше	-,429528	-,221348	,083728	-,099792	,124910	,273286
Дисгармоничное сексуальное взаимодействие партнеров	-,009355	,099792	,427830	-,097210	,196491	**,783766" (p<0,001)**
Тревожные переживания в связи с профессиональной деятельностью	-, 196082	,151264	-,063911	-,014332	,294925	,1511264

301

Примечание: * - *значимые факторные нагрузки (ФН). Ниже в скобках приведены соответствующие им значения p*

Выявлено, что значимые факторные нагрузки (ФН) приходятся на шесть психологических факторов: 1) задержки психосексуального развития (ФН = 0,53, p < 0,02); 2) тревожное ожидание сексуальной неудачи и коитофобия (ФН = 0,88, p < 0,001); 3) неадекватные убеждения и установки в отношении половой жизни (ФН = 0,61, p < 0,01); 4) интрапсихические конфликты, затрагивающие сексуальную сферу (ФН = 0,54, p < 0,05); 5) нарушения межличностных отношений в паре (ФН = 0,67, p < 0,01); 6) дисгармоничное сексуальное взаимодействие партнеров (ФН = 0,78, p < 0,001). Полученные данные подтвердили роль указанных факторов в развитии половых дисфункций у мужчин и необходимость акцентирования психотерапевтического воздействия на их нейтрализации (рис. 5.1).



Рис. 5.1. Значимые психологические факторы формирования мужских сексуальных дисфункций

*Примечание: В диаграмме приведены только значимые ФН, выявленные с помощью факторного анализа. * - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001*

С этой целью нами разработана оригинальная модель психотерапии сексологических пациентов (В. А. Доморацкий, 1999; 2002; 2004). Ее отличают универсальность и структурированность, активность и краткосрочность, широкие терапевтические возможности для эффективной коррекции наиболее значимых психологических механиз-

мов сексуальной дисфункции, основанные на гибком подборе оптимальных психотерапевтических методов. Она предполагает дифференцированное использование целого ряда сравнительно новых для отечественной сексопатологии приемов и техник психотерапии (вне зависимости от направлений и школ, в рамках которых были разработаны те или иные методики), интегрированных в единую терапевтическую систему, сфокусированную на устранении у пациентов основных психологических препятствий для полноценных интимных отношений.

Теоретическая основа предлагаемой модели - междисциплинарная (системная) концепция сексопатологии (Г.С. Васильченко); стратегический подход в психотерапии (M. Erikson, J. Haley); концепция технического эклектизма в психотерапии (A. Lasarus).

Технический (методологический) эклектизм - заимствование в клинической работе методов и процедур из разных психотерапевтических подходов, руководствуясь их практической полезностью для решения конкретных проблем конкретного пациента. Именно терапевтическим прагматизмом обусловлен выбор используемых нами технических приемов и методов психотерапии. Они относятся к различным психотерапевтическим школам и направлениям, включая эриксоновский гипноз, нейролингвистическое программирование (НЛП), десенсибилизацию и переработку движениями глаз (ДПДГ), когнитивно-бихевиоральную, семейную и супружескую терапию, а также элементы символдрамы, краткосрочной мультимодальной психотерапии и ряд других.

В зависимости от особенностей патогенеза сексуального расстройства психотерапия может выступать в качестве ведущего метода лечения, либо дополнять фармакотерапию и другие методы лечебного воздействия. Для коррекции идентифицированных негативных психологических факторов и порождаемых ими сексуальных проблем применяются наиболее адекватные им по направленности терапепевтического воздействия психотехнологии. Сосредоточение основного психотерапевтического воздействия на достижении позитивных результатов в сексуальном функционировании может показаться односторонней, искусственно ограничивающей возможности психотерапии

в решении широкого круга когнитивных, поведенческих и эмоциональных проблем, нередко сопутствующих половым дисфункциям. Однако в сексологической практике хорошо известно, что при успешном разрешении интимных затруднений пациентов, как правило, улучшается их психическое самочувствие и социальное функционирование, способствуя, в свою очередь, позитивным изменениям и в других сферах жизни. По-видимому, здесь приложим закон общей теории систем, гласящий, что изменения в одной области какой-либо системы способствуют перемещениям во всей системе и тем самым изменениям в ней. Это в полной мере относится и к сексуальности, которая не является изолированным фрагментом человеческого существования, а хотим мы того или нет, буквально пронизывает все стороны нашего бытия, будучи значимой частью индивида как сложной динамической, саморегулирующей системы. Согласно L. Bertalanffy (1968), система - набор взаимодействующих элементов в гипотетических границах, оставляющих большую или меньшую открытость для взаимодействия с окружающей средой. В психотерапевтической практике оно осуществляется через информационное влияние. Психотерапия оказывает неспецифическое и разноплановое воздействие на многих уровнях. Поэтому, даже будучи адресованная достаточно узкой сексологической проблематике, она, безусловно, приводит к более широким позитивным изменениям, что в конечном итоге и создает необходимые предпосылки для обретения психического комфорта и улучшения качества жизни лиц, обратившихся за помощью.

Структурированность психотерапии предполагает выделение последовательных этапов психотерапевтического процесса (В. А. Доморацкий, 2002):

1. *Создание устойчивых доброжелательных отношений с пациентом, как основы для эффективного психотерапевтического взаимодействия.*

С этой целью используется подстройка (присоединение) к пациенту через уподобление ему в позе, движениях, дыхании, особенностях речи. В частности, чтобы быть лучше понятым, врач употребляет в беседе наиболее часто используемые пациентом процессуальные слова (глаголы, прилагательные и наречия), отражающие предпочитаемую

сенсорную систему (визуальную, аудиальную либо кинестетическую), посредством которой он воспринимает, хранит и извлекает из памяти наибольшее количество информации. К приемам, облегчающим терапевтический контакт, относят употребление врачом ключевых слов, которыми больной описывает свои сексуальные затруднения, эмпатическое слушание, выражение искренней заинтересованности проблемами пациента и готовности помочь в их разрешении.

2. *Изложение пациентом жалоб и собственной точки зрения на существующие проблемы в половой жизни, включая его «субъективную теорию болезни».* Важно выявить личностную значимость сексуальной дисфункции и представления пациента о возможных причинах ее возникновения, мотивированность к психотерапевтическому лечению. Прояснению интимных проблем в ряде случаев может помочь предложение пациенту закончить три следующие фразы: а) «Я хочу избавиться от...»; б) «Я хочу получить (в результате лечения)...»; в) «Моя основная проблема заключается...» При этом мы получаем возможность для оценки соответствия жалоб пациента предъявляемой проблеме и получить кратко сформулированное им самим описание ее сути.

Дополнительную информацию о субъективной картине полового расстройства дает использование метафорического образа проблемы. Пациенту говорят: «Любая проблема похожа на стену. Если представить, что ваша проблема - это стена, то какая это была бы стена?» Важно получить детальное описание созданной воображением мужчины стены, которая символизирует актуальность и выраженность его затруднений в половой жизни. Далее пациенту предлагают подумать о том, как можно было бы преодолеть эту стену и оказаться по другую ее сторону. Очевидно, что образ монолитной, сделанной из очень прочного материала многометровой высоты и большой протяженности стены, которая представляется практически непреодолимым препятствием, в метафорической форме отражает представления пациента о всей серьезности и трудноразрешимости

проблемы, его переживания безысходности и неверия в свои силы, что необходимо учесть при планировании психотерапевтических мероприятий.

305

3. *Анализ возможных психологических причин сексуальных нарушений с учетом анамнеза жизни и полового расстройства, личностных особенностей и психосексуального развития индивида, предшествующего сексуального опыта, характера партнерских отношений либо отсутствие таковых.*

4. *Выявление ключевых психологических факторов сексуальной дезадаптации пациента («мишеней» для психотерапевтического воздействия) и планирование курса психотерапии.*

Как показано выше, к факторам, подлежащим психотерапевтической коррекции, относятся:

1) нарушения темпов и сроков психосексуального развития в виде его задержек (ретардаций психосексуального развития);

2) фобические факторы, проявляющиеся в форме тревожных опасений возможной сексуальной неудачи или коитофобии (являются наиболее частой непосредственной причиной сексуальных срывов у мужчины и закрепления дисфункционального стереотипа половой близости);

3) убеждения пациента (когнитивные конструкты), связанные со способом восприятия, неадекватными попытками решения и фиксацией сексуальных проблем, а также дисфункциональные схемы мышления;

4) интрапсихические конфликты, затрагивающие сексуальную сферу;

5) нарушения межличностных отношений с партнершей;

6) дисгармоничное сексуальное взаимодействие партнеров (несоответствие взаимных экспектаций и сексуальных сценариев).

Выделение указанных факторов, приводящих к развитию психогенных половых расстройств у мужчины либо способствующих нарастанию сексуальной дезадаптации при изначально непсихогенном характере половой дисфункции, является важнейшей предпосылкой для проведения психотерапии в рамках разработанной стратегии. Еще раз подчеркнем, что негативные психологические факторы являются основными точками

приложения, «мишенями» для прицельной, последовательной коррекции при помощи

306

специально отобранных, адаптированных и модифицированных нами психотерапевтических техник. Поскольку перечисленные факторы могут сочетаться друг с другом или с патологией других систем, обеспечивающих копулятивную сферу, необходим дифференцированный подход к выбору психотерапевтической стратегии в каждом конкретном случае.

На четвертом этапе важно сформулировать у пациента «лечебную перспективу» через разъяснение ему обратимого характера полового расстройства, функциональных механизмов, приводящих к неудачам в интимной жизни, конкретных путей восстановления собственных сексуальных возможностей.

5. *Осуществление последовательных психотерапевтических интервенций для устранения выявленных у пациента психологических механизмов сексуальной дезадаптации* (ликвидация тревожного ожидания неудачи при коитусе и страха перед половой близостью; коррекция когнитивных ошибок и неадекватных установок, внутренних противоречий, проблем в межличностном и сексуально-поведенческом взаимодействии партнеров). Это основной и наиболее трудоемкий этап психотерапии. Он заканчивается, когда пациент приобретает способность переносить результаты психотерапии и полученные навыки в реальную жизненную ситуацию, что проявляется устойчивым улучшением сексуального функционирования и партнерского взаимодействия.

6. *Завершение психотерапии.* Сфокусированность психотерапии на сексуальной проблематике и ее краткосрочный характер предполагают проведение ограниченного количества терапевтических сессий (от 2-3 до 12) с частотой 1-2 раза в неделю при средней продолжительности одного сеанса 45-60 минут. В отличие от завершения длительного курса глубинной (психодинамической) психотерапии проблемы, связанные с прекращением

терапевтических отношений, здесь не столь выражены. В значительной степени этому способствует изначальная договоренность о конкретных целях психотерапевтического лечения и устанавливаемый врачом и пациентом консенсус по поводу того, что считать позитивным результатом психотерапии. При устранении коммуникативных затруднений, достижении

пациентом приемлемого уровня психологического комфорта и восстановлении удовлетворяющих его параметров сексуальной активности, основные задачи психотерапии считаются выполненными.

На рис. 5.2 схематично представлены вышеизложенные этапы психотерапии сексологических пациентов.



Рис. 5.2. Этапы интегративной психотерапии сексуальных дисфункций у мужчин

Психотерапия является комплексным процессом с задействованием множества взаимосвязанных элементов, которые в совокупности и обеспечивают ее конечные результаты. Практически для всех направлений

психотерапии, включая интегративные подходы, можно выделить общие элементы, составляющие основу психотерапевтического процесса и в конечном счете обеспечивающие его эффективность J. Marmor, 1979, 1998; Yalom, 2000; J. Kottler, 2002 и др.). К ним относят:

1. *Позитивные экспектации пациента и психотерапевта*. Известно, что результативность психотерапевтического лечения нередко зависит от

ожидаемой клиентом степени его эффективности. Хотя эффективность психотерапии нельзя отнести только за счет ожидания благоприятных изменений считается, что почти треть успешных результатов психотерапии можно объяснить тем, что и целитель и пациент твердо верили в эффективность лечения

2. *Терапевтические отношения* (установление надежного терапевтического альянса). В основе продуктивных терапевтических отношений лежат уважение, доверие, рапорт, эмпатия, искренний интерес к обратившемуся за помощью и понимание его проблем. Психотерапия, по существу, является особой формой межличностных отношений.

3. *Хоторнский эффект* (особое внимание психотерапевта к пациенту ведет к улучшению состояния последнего). В классических Хоторнских исследованиях (1939), посвященных влиянию улучшения освещения на производительность труда на предприятии, впервые было замечено, что наблюдаемые улучшили свои показатели работы лишь потому, что являлись объектами изучения и получали особое внимание. Было обнаружено, что внимание к пациенту может приводить к улучшению независимо от того, дополняется ли это внимание какими-то иными психотерапевтическими воздействиями.

4. *Раскрепощение эмоций и снижение в ходе психотерапии эмоционального напряжения* (связаны с тем, что пациенту предоставляется возможность открыто обсуждать свою проблему с лицом, от которого он надеется получить помощь).

5. *Когнитивное научение* (объяснения и интерпретации терапевта ведут к повышению осознавания, т. е. дают пациенту понятную,

значимую и рациональную основу для понимания того, почему и как воз
никли его проблемы, каковы пути их разрешения и что для этого необходимо сделать).
6. *Оперантное обусловливание* - особый вид формирования условно-рефлекторных связей посредством явной или скрытой демонстрации врачом своего одобрения-неодобрения, поощрения-осуждения тех

или других форм поведения и эмоционального реагирования пациента. Другой вид оперантмого обусловливания - корректирующий эмоциональный опыт. Его сущность состоит в том, что врач, как правило, объективнее и реалистичнее, более эмпатически, чем окружение пациента, реагирует на его эмоциональные проявления и поведение. Все это дает пациенту новый эмоциональный опыт, позволяет по-иному взглянуть на существующие проблемы и отношения с окружающими людьми.
7. *Идентификация,* основанная на сознательном или бессознательном стремлении пациента видеть в психотерапевте модель для подражания, в силу чего он перенимает некоторые ценности и поведенческие особенности врача.
8. *Суггестия (явная и скрытая)* - терапевтический фактор, присутствующий во всех видах психотерапии (даже в тех школах, которые пытаются это отрицать). В одних случаях, например, при проведении гипнотерапии, прямые или косвенные внушения являются важнейшей составляющей психотерапевтических интервенций. В других - суггестивный акцент в психотерапии менее выражен. Но «всякий раз, когда врач представляет суть своего метода и подразумевает или открыто формулирует, что пациент почувствует себя лучше, если наследует этой терапевтической модели, - будь она динамической, гештальтистской или бихевиоральной, - он использует внушение» (J. Marmor, 1998). Кроме того, известно, что чем сильнее вера пациента во врача, чем выше его идеализация, тем больший круг

терапевтических действий обладает суггестивным потенциалом и тем мощнее воздействие внушений.
9. *Приобретение в ходе терапии и закрепление в реальной жизни новых, более адаптивных поведенческих паттернов.* При этом широко используются «репетиции» и повторения в форме домашних заданий. Фактически это процесс обучения путем конструирования в воображении и неоднократного проигрывания пациентом желательных

поведенческих паттернов в ситуациях психотерапевтического сеанса с последующей реализацией вновь приобретенных навыков в повседневной жизни.
10. *Возможность катарсиса.* Со времен выхода в свет в 1885 году трактата Брейера и Фрейда по лечению истерии многие психотерапевты пытались помочь пациентам избавиться от подавленного аффекта через катарктическое отреагирование, вслед за которым следовало уменьшение аффективного напряжения и чувство облегчения. Как указывает И. Ялом (2000), катарсис может играть важную роль в терапии, но одного лишь отреагирования часто бывает недостаточно. На протяжении жизни все мы испытываем порой очень сильные эмоциональные переживания, однако далеко не всякое переживание ведет к изменению.
11. *Десенсибилизация к психотравмирующим обстоятельствам.*
12. *Вызывающий доверие, способный вдохновлять, профессионально подготовленный специалист.* По мнению группы экспертов, наибольший вклад в результаты психотерапии вносят личностные качества пациента (в частности, его мотивация к изменению), на втором месте находятся личностные параметры психотерапевта и лишь на третьем - использование определенных психотерапевтических техник (Бейтман, 1989).

Использование психотерапевтических техник

В большинстве психотерапевтических подходов используются различные технические приемы (техники). Техника представляет собой систематическую процедуру, посредством которой решается та или иная комплексная или научная задача. Это тщательно разработанный план действий, основанный как на теории, так и на практических наблюдениях. Каждая техника имеет определенную цель и должна использоваться в подходящих для нее обстоятельствах (R. Sherman, N. Fredman, 1997). Применение той или

иной техники предполагает, что, выполняя ряд конкретных приемов, предписаний и предложений, которые исходят от врача, пациент совершит серию действий (в воображении или в реальности), в результате чего он сможет лучше понять свое поведение, изменить его в позитивную сторону или освободиться от тревожащих его симптомов. Создатели техник отталкиваются от представления, что если у человека имеется А (нежелательное поведение или симптом), вводится определенная последовательность событий или шагов В (техника), на выходе получаем С (желаемый результат). По словам А. Бека (1990), «коммуникация - это почва для эффективной психотерапии, но именно техники приводят к росту на этой почве того, в чем нуждается пациент, т. е. ведут к позитивным изменениям. Проблема состоит в том, чтобы адекватно применять соответствующие вмешательства к соответствующему пациенту и соответствующим нарушениям».

Все вышеперечисленные элементы (факторы) терапевтического влияния в той или иной степени задействованы при проведении психотерапии у сексологических пациентов. Предложенная стратегия психотерапевтической коррекции сексуальных дисфункций у мужчин может быть отнесена к инструментально-технической модели психотерапии интегративного типа (В.А. Ташлыков, 1992), где наряду с высокой активностью врача и структурированностью многофакторного психотерапевтического процесса особое значение придается технической стороне работы. Выбор конкретных приемов и методик воздействия определяется их терапевтическими возможностями, т. е. способностью наиболее эффективно корригировать выявленные у пациентов дезадаптивные психологические механизмы,

препятствующие полноценным сексуальным отношениям. Причем для каждой психотерапевтической «мишени» предложены альтернативные (взаимозаменяемые) методики с тем, чтобы практикующие специалисты имели возможность выбирать для работы наиболее приемлемые для них психотехники.

Рассмотрим подробнее «технический инструментарий» интегративной психотерапии сексуальных дисфункций у мужчин. Применяемые приемы и методы систематизированы нами в соответствии с основными точками

приложения психотерапевтического воздействия. В зависимости от степени участия тех или иных психологических механизмов в формировании полового расстройства у пациента психотерапия фокусируется на коррекции наруше-ний психосексуального развития, тревожного ожидания неудачи и коитофобии, внутриличностных проблем и дисфункциональных убеждений, неадекватного межличностного взаимодействия и сексуальной дисгармонии в паре. Следует отметить, что в одних случаях для полного восстановления сексуальной активности пациента требуется 1 - 2 сеанса психотерапии с использованием техник, позволяющих нейтрализовать страх перед коитусом, тогда как в других - необходим курс из 8 - 10 и более психотерапевтических сессий, направленный на параллельную коррекцию сразу нескольких негативных психологических факторов, приводящих к сексуальной дезадаптации мужчины.

В табл. 5.2 представлены систематизированные нами критерии выявления основных психологических факторов, дезадаптирующих сексуальную сферу мужчины, которые подлежат психотерапевтической коррекции.

Таблица 5.2

Критерии выявления ключевых психологических факторов сексуальной дезадаптации мужчины

Психологические факторы	Основные критерии
Задержки психосексуального развития	а) отставание в сроках становления сексуальности по данным сексологического анамнеза; б) трудности в установлении и поддержании коммуникаций с лицами противоположного пола; в) эротические и сексуальные фантазии при отсутствии устойчивых навыков их реализации; г) инфантильные взгляды на интимные отношения людей

313

Фобические факторы (тревожное ожидание сексуальной неудачи и коитофобия)	а) навязчиво возникающие опасения неудачи при коитусе или страх, заставляющий уклоняться от половых контактов; б) появление или усиление психических и соматических проявлений тревоги в интимных ситуациях либо при одних только мыслях о половой близости; в) повторяющиеся ситуации фиаско при отсутствии значимой органической патологии в системах, обеспечивающих сексуальную функцию мужчины
Неадекватные убеждения и установки в отношении половой жизни дисфункциональные схемы мышления	а) убежденность в собственной сексуальной несостоятельности и наличие системы алогичных аргументов, подтверждающих наиболее пессимистичные прогнозы мужчины; б) неадекватные и ригидные установки, ожидания, предубеждения пациента в отношении различных сторон интимной жизни, затрудняющие терапевтический процесс
Интрапсихические конфликты, затрагивающие сексуальную сферу	а) наличие внутренних противоречий между желанием половой близости и отношением к сексуальности, как к пугающей либо низменной стороне человеческого бытия; б) столкновение с экзистенциальными проблемами человеческого существования (болезненным осознанием конечности собственного бытия или угрозы одиночества) при возникновении сексуальных затруднений

Нарушения межличностных отношений в паре	а) трудности в общении и непродуктивное взаимодействие между партнерами; б) конфронтация с частыми конфликтами и предъявлением претензий; в) взаимное охлаждение и отсутствие с обеих сторон реальных шагов для изменения партнерской ситуации к лучшему; г) непонимание и/или игнорирование потребностей друг друга

314

Дисгармоничное сексуальное взаимодействие партнеров	а) выраженные различия в сексуальных предпочтениях партнеров; б) несоответствие в частоте, продолжительности и формах сексуальной стимуляции; в) неадекватное выражение одним или обоими партнерами своих чувств и переживаний по поводу половой близости (упреки, обвинения, угрозы, безразличие)

5.3. Принципы коррекции нарушений психосексуального развития

Наиболее частый вариант нарушений психосексуального развития - его задержки (ретардации), что подтвердило проведенное нами исследование.

Задержки психосексуального развития нередко приводят к нарушениям коммуникаций уже на платонической и эротической стадиях формирования либидо, что придает отношениям подростков с представительницами противоположного пола исключительно товарищеский характер. У них складывается весьма узкий и ригидный поведенческий репертуар, используемый при контактах со сверстницами. В дальнейшем у таких мужчин могут возникать затруднения при попытках познакомиться с понравившейся женщиной, ухаживать за ней, в приемлемой форме выразить свои чувства и желания, наконец вступить с ней в интимную связь. Психогенные сексуальные расстройства в начале половой жизни достаточно характерны для мужчин с задержками психосексуального развития. В этих случаях непосредственное устранение сексуальных дисфункций - лишь завершающий этап терапии. Неудачи, преследующие таких пациентов с первых в жизни половых актов, прежде всего связаны с трудностями коммуникации из-за отсутствия необходимых навыков общения с противоположным полом. Поэтому вначале такому мужчине нужно помочь сформировать адекватные представления об интимных отношениях и выборе потенциальной сексуальной партнерши. Необхо-

димо совместно с пациентом определить основные критерии наиболее подходящего объекта для поиска (с учетом индивидуальной привлекательности женщины, особенностей характера, а не ее сексуальной доступности), выработать оптимальную для него модель поведения на всех этапах сближения (от первого знакомства и платонического ухаживания до эротических ласк и полового акта). Далее пациенту, находящемуся в состоянии мышечной релаксации или легкого транса, предлагают проиграть в воображении разработанный сценарий, мысленно «примерить» новую, адаптивную поведенческую роль на себя. При этом врач может суггестивно усиливать возникающие у мужчины картины благоприятного развития событий и давать соответствующие постгипнотические внушения, направленные на последующую реализацию данного сценария с партнершей. Для закрепления моделируемых навыков пациент получает домашнее задание, которое выполняется несколько раз. Ему предлагают выделить для упражнения 10-15 минут, принять удобную позу и, находясь в спокойном и расслабленном состоянии, последовательно и ассоциирование (т. е. погрузившись в представляемое событие, как если бы оно происходило с ним на самом деле) проиграть в воображении возможные варианты все более

интимного общения с понравившейся женщиной. Положительный эффект конструирования зрительных образов и предвосхищения желаемых событий, их мысленных повторений находит объяснение в ряде нейрофизиологических исследований. Так, работы D. Bennet (1989) показали, что, когда человек создает воображаемый образ какого-либо события, в его мозге возникает электрическая активность строго определенной нейронной сети точно так же, как если бы он принимал реальное участие в этом событии (D. Bennet, 1989). Поэтому мысленные репетиции действий в каких-то трудных для индивида ситуациях создают постоянную нейронную цепочку, которая фиксирует желаемую поведенческую модель, постепенно превращая ее в привычный способ реагирования. Вероятно, сходные механизмы лежат в основе широко используемого приема эриксоновской терапии - формирования у пациента в трансовых состояниях «образа достижения», т. е. представлений и картин успешного разрешения жизненных

затруднений. Применительно к психотерапевтической работе с пациентами, у которых на фоне задержек психосексуального развития возникли неудачи при интимных контактах в дебюте половой жизни, это означает создание в воображении мужчины четкого представления самого себя в недалеком будущем как человека, располагающего широкими коммуникативными возможностями и способностями для гармоничного перехода от ухаживаний и поверхностных ласк к более глубокому эротическому контакту с женщиной и его логическому завершению - коитусу.

Практическая реализация модели интимного сближения, как правило, должна осуществляться такими пациентами постепенно, на протяжении ряда встреч с женщиной. С началом взаимных глубоких эротических ласк целесообразно предложить пациенту не стремиться к немедленному их завершению половым актом, а некоторое время (обычно в ходе нескольких интимных контактов) использовать для достижения сексуальной разрядки петтинг. В ходе петтинга мужчина сосредоточен не столько на качестве собственной эрекции (поскольку отсутствует тревожное ожидание наиболее «ответственного» для дебютанта, уже терпевшего ранее неудачи, момента

интроитуса), сколько на сладострастных ощущениях при взаимной стимуляции гениталий и чувственных переживаниях женщины. Все это создает у пациента предпосылки для возникновения сильного полового возбуждения, сопровождающегося эрекцией, и позволяет закрепить адекватные сексуальные реакции в процессе парного взаимодействия. Только при условии установления хорошего эмоционального и эротического контакта с постоянной партнершей возможен успешный переход к коитальной активности мужчины с задержкой психосексуального развития, который ранее не имел позитивного сексуального опыта. Причем крайне важно помочь пациенту создать весьма привлекательный для него, но вместе с тем реально-воспроизводимый образец коитального поведения, который вначале закрепляется в сфере воображения, лучше всего в гипнотическом состоянии, а в дальнейшем - на практике.

С целью глубинной коррекции задержек становления сексуального либидо и устранения малоосознавае-

мых страхов перед проявлениями сексуальности могут использоваться приемы символдрамы и, в частности, мотив «куст розы», предложенный X. Leuner (1980) для диагностики мужской сексуальности и коррекции психогенно обусловленных половых расстройств.

При неоднократных неудачных попытках в начале половой жизни для нейтрализации негативного сексуального опыта пациентов и устранения у них тревожных опасений нового фиаско применяются техники НЛП, эриксоновский гипноз, ДПДГ и другие методы психотерапевтической коррекции, изложенные далее.

Нарушения стереотипа полоролевого поведения у мужчин, как правило, не вызывают серьезных проблем с сексуальной адаптацией, что и подтвердили приведенные выше результаты интегральной оценки значимости психологических механизмов в нарушении сексуального функционирования пациентов, вошедших в исследование (см. табл. 3.1). Для полноты представленной психотерапевтической модели все же отметим, что своеобразие поведения мужчины с трансформацией половой роли, его мягкость, покладистость, а в сексуальной сфере - ожидание инициативы

сближения от женщины и пассивность в процессе полового акта могут приводить к сексуальным дисгармониям, поскольку вызывают недовольство и упреки со стороны партнерши, способствуя невротической фиксации пациентов на половой сфере. Это происходит в тех случаях, когда для женщины наиболее привлекательным и возбуждающим является энергичное, напористое поведение сексуального партнера, совершенно не свойственное таким мужчинам, которые порой даже не улавливают суть предъявляемых к ним претензий, полагая, что основная проблема состоит в неполной эрекции либо в недостаточной продолжительности коитуса.

Психотерапия пациентов с полоролевыми нарушениями направлена на исправление искажений соответствующего этапа психосексуального развития. В коррекции поведенческого стереотипа при интимной близости основной акцент сосредоточен на моделировании в воображении пациента все более активных сексуальных действий и побуждении его к следованию разработанному сценарию в ходе половых контактов.

5.4. Психотерапия тревожного ожидания сексуальной неудачи и коитофобии

Для успешной ликвидации тревожных опасений и страха мужчины перед коитусом необходимо: 1) устранить у него навязчивые воспоминания о предшествующих сексуальных срывах; 2) разрушить триггеры (устойчивые внутренние либо внешние стимулы), запускающие дисфункциональные сексуальные реакции; 3) создать условия для исчезновения у пациента тревожного гиперконтроля за собственными генитальными реакциями на всех этапах коитуса и обучить его ассоциированному восприятию половой близости.

Для нейтрализации негативного сексуального опыта пациентов применяется ряд альтернативных психотерапевтических методик. Одним из простых способов трансформации психотравмирующих воспоминаний и ослабления связанных с ними отрицательных эмоциональных реакций

пациента является использование *техники интеграции якорей*, разработанной в НЛП (L. Cameron-Bendler, R. Bandler, J. Grinder, 1997 и др.). Якорь - это специфичес-кий стимул, предъявление которого позволяет перенести прошлый опыт человека в настоящий момент и воссоздать связанные с ним состояние и переживания. В основе применения техник «якорения» лежат классические работы И.П. Павлова об условных рефлексах. Чтобы добавочный стимул стал якорем, повторное использование которого приводило бы к обретению человеком требуемого переживания, необходимо соблюсти следующие условия; 1) выбранный стимул, чаще всего кинестетический (сжатие плеча, надавливание на колено либо на пястные кости), вводят в момент максимальной погруженности пациента в воспоминание на высоте связанных с ним эмоциональных проявлений; 2) для быстрого возвращения в это воспоминание якорь должен быть воспроизведен предельно точно (локализация, интенсивность давления). В зависимости от характера переживаний, с которыми сформирована условно-рефлекторная связь, якоря могут быть положительными (ресурсными) или отрицательными (проблемными).

319

Мы проводим «интеграцию якорей» следующим образом. Вначале пациенту предлагается как можно ярче и ассоциирование оживить в памяти проблемную ситуацию (особенно запомнившуюся сексуальную неудачу). В момент возникновения наиболее дискомфортных представлений осуществляется постановка негативного якоря, например путем нажатия пальцами руки на левое колено пациента в течение 25 - 40 секунд. После короткого перерыва, уже на высоте приятных переживаний, связанных с удачным сексуальным опытом, на его правое колено аналогичным образом накладывается позитивный якорь. Если в прошлом у пациента не было сколько-нибудь успешных половых контактов, в качестве ресурсного можно использовать любое воспоминание, где он проявил себя как стеничный, уверенный в своих силах человек, успешно справившийся с той или иной задачей. Иногда для формирования более мощной положительной альтернативы один позитивный якорь последовательно соединяют сразу с несколькими ресурсными воспоминаниями. Далее производится собственно

интеграция якорей. Для этого вначале накладывается негативный якорь, предлагая пациенту вновь погрузиться в сцену сексуального фиаско, а при возникновении отчетливых невербальных признаков страха перед близостью (побледнение кожи лица и изменение мимики, учащение дыхания, мышечное напряжение и т. п.) вводится позитивный якорь, причем не менее 30 - 40 секунд оба якоря удерживаются одновременно, а затем еще столько же - один позитивный. Если в результате совмещения якорей отрицательное переживание ослабло, подверглось нейтрализации - это отражается в изменении внешних реакций пациента, а при расспросе он отмечает, что воспоминание о предшествующей сексуальной неудаче поблекло, воспринимается с меньшим драматизмом, порой отстранение. Для этой же цели мы используем более эффективный, модифицированный вариант методики - «замену двигательных якорей».

Замена двигательных якорей выполняется в три этапа. На первом пациенту, который стоит напротив врача на расстоянии вытянутой руки, предлагается представить себя в психотравмирующей ситуации сексуального срыва. При этом его просят почувствовать некий внутренний ритм своего тела, а затем постепенно начать раскачиваться на

прямых ногах в такт негативному воспоминанию, соединяя с ним темп, ритм и амплитуду раскачиваний. Врач суггестивно усиливает переживания пациента, способствуя большему погружению в образы, мысли, ощущения и, неоднократно подчеркивая, что они связываются, соединяются с движениями, которые совершает его тело. Затем пациента необходимо взять за плечи, чтобы точнее уловить «ритм негативного воспоминания» и, определив характер движений, можно даже несколько их усилить. Если образовалась устойчивая связь между определенным типом раскачиваний пациента (негативным якорем) и переживаниями сексуальной неудачи, то при увеличении амплитуды этих движений обычно усиливается яркость воспоминания и интенсивность эмоционального реагирования. На втором этапе пациент максимально отчетливо представляет себе ситуацию наиболее удачного сексуального контакта (возможно, даже с другой партнершей), которая, так же как и в первом случае, связывается с раскачиваниями тела (позитивным якорем). Чтобы движения пациента как можно больше отличались от первоначально установленного негативного якоря, ему предлагается найти тот их ритм, темп и амплитуду, которые символизируют качественный половой акт. Затем пациента следует взять за плечи и, определив характер раскачиваний, усилить их, чтобы убедиться в наличии связи между ними и ресурсным воспоминанием. При выполнении третьего этапа данной методики пациент вновь должен обратиться к негативной ситуации, причем, как правило, он спонтанно начинает воспроизводить связанные с ней движения тела. При появлении явных невербальных признаков оживления дискомфортного воспоминания врач берет пациента за плечи и начинает его раскачивать в ритме позитивного якоря. На фоне выполнения движений, соответствующих ресурсным переживаниям, пациенту предлагается еще некоторое время удерживать в воображении сцену фиаско, суггестируя, что «она постепенно начинает стираться, распадаться на отдельные фрагменты, превращаться в случайный эпизод, о котором прямо сейчас можно начать забывать вспоминать, одновременно припоминая самые приятные моменты интимного общения, ощущая в себе особую силу духа, твердость характера и удивительную легкость на подъем». Во время проведения

завершающего этапа процедуры у многих пациентов возникает легкий гипнотический транс. Используемые прямые и косвенные внушения существенно усиливают нейтрализующее воздействие введенного в негативное воспоминание позитивного якоря. Суггестии строятся с учетом характера сексуальных проблем конкретного мужчины, а их продолжительность может варьировать от 2-3 до 5-8 минут. Уже во время сеанса ряд пациентов отмечает замещение негативных представлений сценой успешного полового акта, а после его завершения меняется субъективное восприятие сексуальной неудачи, которая нередко предстает малозначительным жизненным эпизодом (В.А. Доморацкий, 2002).

Визуально-кинестетическая диссоциация (ВКД), используемая в НЛП, позволяет отделить в сознании картину негативных событий прошлого от связанных с ними чувств и таким образом существенно уменьшить аффективные реакции, возникающие у человека при оживлении их в памяти либо в сходных ситуациях (R. Bandler, J. Grinder, 1997). Техника основана на представлении о том, что если индивид зрительно вспоминает драматичное или, наоборот, очень приятное событие так, как будто в нем находится (ассоциирование), он начинает испытывать прежние сильные чувства. Но если человек увидит себя участником этого события со стороны (диссоциирование), интенсивность переживаний оказывается значительно меньшей. Если сцена сексуального фиаско длительно удерживается в памяти мужчины ассоциированно, то она легко всплывает в сознании при последующих интимных контактах, вызывая у него множество отрицательных чувств и эмоций, которые тормозят адекватные генитальные реакции. Применение БКД способно обеспечить эмоциональную отстраненность пациента от прежнего негативного опыта и существенно снизить у него интенсивность наиболее дискомфортных переживаний, связанных с предшествующими неудачами в интимной жизни. В свою очередь это способствует редукции тревожного ожидания новой неудачи и позволяет достичь большей вовлеченности в реальную близость.

Рассмотрим последовательность выполнения основных элементов модифицированного нами с учетом сексологической проблематики варианта техники ВКД (В.А. Доморацкий, 2002, 2003).

1. Формирование у пациента «базисного» состояния безопасности и уверенности в успехе лечения, которое строится на взаимном уважении и доверии между ним и врачом.
2. Перевод пациента в позитивное состояние. Для этого просят его вспомнить ситуацию, когда он чувствовал себя особенно спокойно и комфортно, испытывал положительные эмоции. Достигнутое состояние внутреннего комфорта ставится на якорь, что обеспечивает возможность легко возвратиться к нему в ходе дальнейшей работы.
3. Пациенту предлагают представить себя в уютном безлюдном кинозале, где он чувствует себя в полной безопасности. Перед ним экран, где сейчас будет демонстрироваться черно-белый фильм о досадном эпизоде в его интимной жизни. Экран освещается, и он видит себя там, в прошлом, рядом с женщиной, и еще ничто не предвещает возможное фиаско. На этой сцене делается стоп-кадр, превращали ее в слайд.
4. Далее пациент мысленно представляет себе, как он словно бы выходит из собственного тела и перемещается в задние ряды кинозала или в будку киномеханика. Фактически ему предлагается увидеть из третьего места себя в настоящем, сидящего в кинозале в ожидании предстоящего просмотра фильма о неприятном событии, произошедшем с ним в прошлом. После того как трехместная диссоциация осуществлена, она также ставится на якорь.
5. На следующем этапе работы пациент в своем воображении должен просмотреть этот фильм от начала (первый стоп-кадр) до самого конца, когда он потерпел очевидную неудачу и предстает на экране растерянным и подавленным, а женщина в той или иной форме проявляет свое недовольство (второй стоп-кадр). Принципиально важный технический момент - на протяжении всего фильма мужчина должен сохранять кинестетическую диссоциацию от травматического переживания. Он, как посторонний зритель, наблюдает за своими неудачными действиями, отделяя себя от тех чувств, которые

испытал когда-то. Для этого врач, удерживая якоря внутреннего комфорта и диссоциации, время от времени подчеркивает, что пациент, ощущая полную безопасность, сохраняя спокойствие, видит себя сидящим в кинозале, где на экране идет фильм о нем в прошлом. Иногда, чтобы усилить кинестетическую диссоциацию от просматриваемого эпизода, можно предложить понаблюдать за разворачивающимися на экране событиями, как если бы они демонстрировались в режиме ускоренного показа (в несколько раз быстрее, чем в реальности).

6. Когда эпизод полностью просмотрен уже без прежнего оживления негативных чувств и эмоций по поводу пережитой неудачи, пациента просят вернуться с третьего места на второе, т. е. мысленно воссоединиться с собой, сидящим в кинозале.

7. Затем пациенту предлагают мысленно подняться с кресла в кинозале, подойти к экрану, где демонстрируется заключительный эпизод черно-белого фильма о ситуации фиаско (второй стоп-кадр). Он должен войти в этот завершающий кадр фильма и очень быстро прокрутить весь фильм назад (за 1,5-3 секунды), сделав его цветным. Пациенту разъясняют, что это похоже на то, как; будто он заново оказался внутри сцены сексуальной неудачи, и время быстро побежало назад. Тогда все события и действия разворачиваются в противоположном направлении, и весь процесс происходит от конца к началу. Можно привести пример с видеомагнитофоном, в котором включена быстрая перемотка видеоленты назад с ее просмотром на экране. После быстрой прокрутки ситуации в обратном порядке (до первого стоп-кадра) пациент вновь возвращается в свое кресло.

8. Пациенту предлагается представить, что он «сам себе режиссер», поэтому у него имеется возможность переписать неудачный сценарий фильма так, чтобы все происходило по-другому, к обоюдному удовольствию участников вновь отснятого эпизода. Затем он мысленно встает из кресла и переносится в прошлое, где оказывается наедине с самим собой

незадолго до начала событий, закончившихся сексуальным срывом. Воображение мужчины должно нарисовать картину этой встречи, целью которой является предложение разыграть этот эпизод в соответствии с новым сценарием. В своих фантазиях пациент-режиссер может дать прямые инструкции не только самому себе как непосредственному участнику происходивших событий, но и партнерше, если ее поведение в реальной ситуации близости было не вполне адекватным.

9. Мысленно пациент вновь возвращается в свое кресло в кинозале и заново перепросматривает отрежессированный эпизод, где все заканчивается благополучно. В ходе этого просмотра врач использует якорь комфорта и безопасности, всячески поощряя мужчину к тщательному выполнению данного этапа работы, и подчеркивает, что из прошлых ошибок важно извлечь необходимый опыт, который позволит ему в самом недалеком будущем вести и чувствовать себя иначе.

10. Заключительный этап данного варианта техники - проекция в будущее. С этой целью, удерживая якорь безопасности и комфорта, пациента просят нарисовать возможную сцену интимной встречи с актуальной партнершей, где события с самого начала развиваются по наиболее благоприятному сценарию. Ему предлагают дать волю своим фантазиям и представить тот чрезвычайно притягательный вариант близости, одна мысль о котором заставляет чаще биться сердце, вызывает растущее желание реализовать его наяву.

Предложенная нами модификация методики ВКД позволяет пациенту не только дистанцироваться от весьма болезненного опыта сексуального срыва, но нередко прояснить для себя непосредственные причины неудачной попытки полового контакта, а также создать в воображении новый, более адекватный сценарий интимных отношений.

Техника взмаха, применяемая в НЛП, позволяет быстро и эффективно менять ригидный стереотип поведенческого реагирования человека на какие-то другие, более

его устраивающие (R. Bandler, J. Grinder, 1997). У мужчин с тревожной фиксацией на сексуальных неудачах мы выполняем «взмах» как самостоятельно, так и вслед за техникой ВКД, которая в этом случае проводится без последнего этапа (проекции в будущее).

В технике взмаха можно выделить три основных блока.

1. Определение триггера (негативного стимула), от которого начинается «взмах». У любого проблемного поведения есть свои собственные стимулы (триггеры), активизирующие нежелательные поведенческие стереотипы. При возникновении у мужчины дисфункциональных сексуальных реакций (например, резкого ослабления эрекции при попытке интроитуса) также выявляются некие внешние или внутренние стимулы, которые запускают процессы, блокирующие нарастание либо поддержание полового возбуждения, в частности его физиологические проявления.

Наша практика показывает, что такими тормозящими триггерами могут быть как буквально на несколько мгновений вспыхивающие в сознании мужчины сцены предшествующих неудач (внутренний негативный стимул), так и реальная картина какого-то момента сближения - образ возбужденной партнерши, не оставляющий сомнений в ее крайне негативной реакции в случае возможной неудачи, или вид обнаженных тел, свидетельствующий о том, что кульминация интимной встречи близка, и сейчас потребуется «настоящая» эрекция (внешний негативный стимул). Когда негативный стимул найден, следует определить, какие изменения в зрительном восприятии меняют реакцию человека на него. Обычно для большинства людей увеличение размера и яркости мысленного образа усиливают его воздействие, а их уменьшение - ослабляет.

2. Моделирование в воображении желаемого образа самого себя. Для этого пациенту предлагают подумать о том, как он хотел бы вести себя в ситуации половой близости. Просят его в воображении нарисовать оптимальный вариант сексуального контакта, когда все происходит так, как при наиболее запомнившихся ему интимных встречах и даже еще лучше. Если мужчина не имеет подобного позитивного сексуального опыта, врач помогает ему создать в своей фантазии некое представление о весьма удачном

половом акте. Важно, чтобы этот новый, ресурсный образ

326

обладал всеми желаемыми качествами и возможностями, буквально притягивал к себе, вызывал у мужчины сильное желание отождествиться с ним. Для усиления привлекательности сконструированной диссоциированной картины можно отрегулировать ее по размеру, цвету, яркости.

3. Быстрая повторная трансформация негативного стимула в желаемый образ. Пациенту говорят, чтобы он представил себе картинку негативного стимула. В углу этой картинки размещается маленький и темный желаемый (ресурсный) образ. Врач просит пациента приготовиться к тому, что, когда он скажет слово: «взмах», - большая негативная картинка (триггер) мгновенно начнет стираться, разрушаться, а маленький ресурсный образ взорвется всеми красками и быстро заместит ее, станет большим и ярким. Чем быстрее удается стереть негативный образ при одновременном росте позитивного, тем эффективнее техника взмаха. Процедуру смены негативной картинки (триггера) позитивной (ресурсной) повторяют от 5-6 до 10 раз. После каждого такого замещения пациент выходит из сферы воображения, как бы «очищает» внутренний экран, глядя по сторонам, затем вновь сосредотачивается на картинке негативного стимула и превращает ее в ресурсный образ.

В заключение осуществляется проверка, которая состоит в том, что пациента просят вновь представить себе негативный образ. Если «взмах» был эффективным, ему будет трудно это сделать, а если и удастся, то образ будет тусклым, размытым, удаленным и, главное, неприятным. Картинка будет стремиться исчезнуть и заместиться другим образом, желательным. При правильном выполнении техники взмаха визуальные триггеры, запускающие дезадаптивное поведение пациента, разрушаются, что позволяет ему в дальнейшем проявлять в интимных ситуациях более адекватные эмоциональные и физиологически реакции.

Если установлено, что в роли триггера выступает также определенный звук или ощущение, «взмах» может быть проведен в слуховой либо кинестетической (связанной с ощущениями) системе. Однако, как показывает практика, эффективность данной методики наиболее высока именно в визуальной системе.

Нередко удается выявить своего рода цепочку внутренних триггеров, принадлежащих к различным сенсорным

каналам, последовательное включение которых блокирует генитальные реакции пациента при половом возбуждении. Для разрушения этих внутренних пусковых стимулов (визуальных, аудиальных, кинестетических) нами применяется *комбинированное мулътимодалъное воздействие,* впервые предложенное А. Лазарусом (1976). Используя процедуру «отслеживания», пациент проигрывает в воображении ситуации фиаско и определяет, в какой последовательности у него возникают мысли, образы и чувства, непосредственно предшествующие торможению сексуальных реакций. Например, вначале возникает мысль: «Опять ничего не получится». Затем воображение рисует картину неудачи, а далее появляются дискомфортные ощущения в эпигастрии и чувство неприятного холодка в области промежности. Стратегия работы предполагает последовательное использование различных психотерапевтических приемов, воздействующих на модальности в том же порядке, в котором они включаются в реальной ситуации срыва, т. е. вначале проводится коррекция нежелательных мыслей, затем переключаются на сферу воображения (меняем картинку) и заканчивают трансформацией ощущений.

Автоматически возникающие мысли о возможной неудаче во многом влияют на дальнейший ход реального события, предопределяя его, и фактически становятся «самосбывающимися пророчествами». Их устранение мы осуществляем несколькими путями. Наиболее простой прием - *раскрутка мыслей.* Пациенту предлагают про себя проговаривать нежелательную фразу, начиная с очень медленной скорости (растягивая слова), затем медленно, средне, быстро и очень быстро. При этом он представляет себе, что мысль раскручивается как волчок, и когда достигает очень большой скорости, вылетает из головы, уносясь прочь. С короткими перерывами процедура повторяется 5 - 6 раз подряд, а для закрепления она рекомендуется в форме домашнего задания. Другой вариант работы - применение бихевиоральной *техники остановки мыслей.* В ходе сеанса пациента просят закрыть глаза и проговорить мысль, подлежащую контролю. Без промежуточной паузы врач резко и громко произносит слово «стоп!», которое должно прозвучать неожиданно и даже пугающе. Эта процедура повторяется несколько раз. Затем пациент

произносит негативную мысль про себя, каждый раз поднимая при этом палец. Врач реагирует немедленным восклицанием «стоп!». Процедура многократно повторяется. Далее пациент обучается выкрикивать слово «стоп!» при преднамеренном вызывании у себя негативной мысли. На заключительном этапе пациент мысленно говорит себе «стоп!» сначала при намеренном, а затем и в случае непроизвольного появления нежелательной мысли. Процедура повторяется до выработки у пациента полного автоматизма. Мы также использовали вариант, когда внутренняя команда «стоп!» сочеталась с легким болевым раздражителем (сдавливание мочки уха) для резкого прерывания нежелательных мыслей. Для закрепления и поддержания необходимого уровня автоматизма пациенту рекомендуется повторять упражнения самостоятельно 2-3 раза в день по 5 минут.

Может быть использована техника, предложенная Л. Сандерсом (США), которая специально предназначена для устранения навязчивых неприятных мыслей. Вначале субъект должен определить, какая мысль или образ заставляет его чувствовать себя плохо. Затем ему даются следующие инструкции: «Встаньте прямо. Правую (или, для людей с инвертированными глазными сигналами, левую) руку вытяните вперед, перпендикулярно туловищу, наподобие створки люка в полу, который открывается вниз, в черный провал». (Сам специалист при этом встает напротив субъекта и держит свою полусогнутую руку со сжатыми в кулак пальцами на уровне его глаз на расстоянии примерно полуметра.) «Теперь, - говорит он клиенту, - подумайте о том, что заставляет вас чувствовать себя плохо. Сделайте глубокий вдох, а затем с силой выдохните, "выдувая" все плохие чувства вниз, в черный провал. Одновременно *с* этим резко бросьте руку вниз, *сильно* ударив ей по передней части бедра. Сразу же после этого проследите глазами, как я поднимаю свой кулак вверх и вправо. Как только ваш взгляд поднимется, я разожму пальцы. По этому сигналу вы делаете глубокий вдох, а затем снова выдыхаете, на этот раз вперед, в направлении горизонта». Все должно быть проделано очень быстро, так, что едва клиент войдет в одно состояние, его немедленно выталкивают в следующее. Важно также, чтобы шлепок по бедру был достаточно сильным. Процесс по-

вторяют 4-5 раз, пока он уже не сможет снова получить от той мысли плохие чувства. Таким способом происходит своеобразная перенастройка нервной системы, результатом чего является разрыв причинной связи между определенной мыслью (чем-то, что субъект говорит себе или представляет) и тем чувством, которое она вызывает.

В качестве домашнего задания предлагается следующее упражнение. Пациент, устроившись удобно, сосредоточивается на своем дыхании и добивается, чтобы оно стало спокойным. Затем он делает 4-5 глубоких вдохов и выдохов, ощущая, как с каждой выдыхаемой порцией воздуха негативные мысли выбрасываются из головы. Если мысли возвращаются, предлагается понаблюдать за ними со стороны (диссоциированно), как будто это медленно плывущие облака или пролетающие птицы.

Для разрушения внутренних негативных образов мы чаще всего применяем вышеописанную технику взмаха либо сокращенный вариант метода ДПДГ, который изложен далее.

Устранение кинестетических триггеров также может быть осуществлено различными приемами. Наиболее результативно использование техник визуализации дискомфортных ощущений или болезненных симптомов. Они основаны на многочисленных наблюдениях, свидетельствующих о том, что если человек создает в своем воображении некий образ неприятного ощущения, который затем подвергаете трансформации вплоть до полного исчезновения, сцепленное с ним ощущение также ослабевает или полностью редуцирует. Одним из таких приемов визуализации является *техника «светового потока»* (S. Levine, 1991), а своем первоначальном варианте предложенная для помощи лицам, переживающим эмоциональные страдания, а также при острой и хронической боли.

Рассмотрим основные этапы данной техники, используемой нами с некоторыми изменениями:

1. Врач предлагает пациенту сосредоточиться на воспоминании о сексуальной неудаче и погрузиться в ощущения, которые предшествовали ослаблению либо изначальному отсутствию эрекции в ходе взаимных ласк. Когда неприятные ощущения возникают, пациента просят описать их локализацию. Его спрашивают: «Каким видится вам

это ощущение? Имеет оно форму? Каковы его размеры? Какого оно цвета? Какова его консистенция? Какая у него температура?» В абсолютном большинстве случаев, часто совершенно неожиданно для себя, пациенты начинают отвечать на эти вопросы, постепенно создавая некий метафорический образ ощущения.

2. У пациента спрашивают: «Какой из любимых вами цвет ассоциируется у вас с исцелением, избавлением от всего, что мешает вам чувствовать себя здоровым и уверенным в себе мужчиной?» Принимается любой ответ, даже если назван тот же цвет, который пациент избрал для описания ощущений в теле. В этом случае ему предлагают подумать и назвать еще один цвет.

3. Пациенту предлагают представить, что световой луч того цвета, который он выбрал, проникает в голову и постепенно начинает распространяться по всему телу. Источник этого света - космос, наполненный энергией, самое огромное из всего, что он может себе представить. Свет устремляется в тело, пронизывает его, вибрируя и переливаясь, заполняет голову, затем, струясь и перетекая, мягко, без усилия опускается через шею в плечи, руки до самых кончиков пальцев. Свет проникает в грудную клетку, живот, струясь, спускается в область таза, потом через ягодицы идет в ноги и дальше к ступням. Пациенту предлагают обратить особое внимание, как исцеляющая световая энергия направляется в то место, где локализовано дискомфортное ощущение, образ которого начинает изменяться. По ходу сеанса у него уточняют, что происходит с этим образом. Как меняются его форма, размеры и цвет? Необходимо продолжать внушение целебного воздействия светового потока, пока образ негативного ощущения не подвергнется существенным изменениям или полностью не растворится в исцеляющем свете. Параллельно меняются или исчезают сами ощущения. В ходе выполнения упражнения пациенты, как правило, достигают релаксации, которая может быть усилена внушениями чувства умиротворения и глубокого спокойствия, после чего следует возвратить их в обычное состояние. Если при выполнении техники не удается полностью убрать образ негативного ощущения, процедуру можно повторить на следующем сеансе.

Мы применяем и несколько иной вариант работы, когда мужчине, находящемуся в гипнотическом состоянии, предлагается совершить воображаемое путешествие внутрь себя и описать, что он видит в той области тела, где перед предстоящей близостью возникает дискомфорт. В ряде случаев пациенты приводят метафорические описания испытываемых ими неприятных ощущений: «они похожи на кусок льда голубоватого цвета и грушевидной формы », «это напоминает темно-коричневую пористую губку величиной с ладонь с изъеденными краями». Далее пациенту в трансе предлагают найти способ, который позволит избавить себя от этой визуализации либо превратить ее во что-то незначительное и малозаметное. Обычно пациенты легко представляют некие метафорические варианты решения поставленной задачи. Например, растопить кусок льда сфокусированным пучком солнечного света или растворить губку, локализованную в надлобковой области, а затем вывести ее наружу при мочеиспускании. Воображаемые сцены освобождения от образов негативных ощущений могут суггестивно усиливаться, а в конце сеанса, перед реориентацией и выведением из состояния гипноза, пациенту дается закамуфлированное постгипнотическое внушение о том, что «комфортные ощущения, испытываемые им в трансе, заменят те, другие ощущения, которые были у него ранее».

Последовательное разрушение всех выявленных негативных внутренних стимулов способствует восстановлению нарушенных в ситуациях интимного контакта с партнершей генитальных реакций пациента.

В 1987 году Ф. Шапиро (США) разработала оригинальный психотерапевтический метод *десенсибилизации и переработки движениями глаз (ДПДГ)*. С этого времени он с успехом применяется для лечения посттравматических стрессовых расстройств у участников боевых действий, жертв насилия, катастроф и стихийных бедствий, а также лиц, страдающих фобиями, паническими и диссоциативными расстройствами (F. Shapiro, 1994, 1998).

Метод основан на активизации с помощью повторных серий движений глаз процесса ускоренной переработки и нейтрализации травматических воспоминаний, а также любой другой негативной информации, заблокированной в нейронных структурах мозга. Предполагается, что дви-

жения глаз, используемые при ДПДГ, запускают процессы, аналогичные происходящим во сне, в фазе быстрого движения глазных яблок. В ходе процедуры ДПДГ происходит быстрая десенсибилизация и переработка травматического материала. Воспоминания, имеющие высокий отрицательный эмоциональный заряд, переходят в более нейтральную форму, а соответствующие им представления и убеждения пациентов приобретают адаптивный характер (F. Shapiro, 1994).

ДПДГ - психотерапия тревожного ожидания сексуальной неудачи и коитофобии у мужчин осуществляется нами в последовательности, предложенной автором метода, с некоторыми сокращениями и изменениями. Она включает следующие основные этапы (В.А. Доморацкий, 2000):

1. Подготовка. На этом этапе устанавливаются терапевтические отношения с пациентом, разъясняется сущность ДПДГ-психотерапии, обосновываются ее высокие возможности в избавлении от чувства не уверенности в своих силах и тревоги перед близостью, формируется «лечебная перспектива».
2. Определение предмета (цели) воздействия. Основная цель воздействия - хранящаяся в памяти информация о психотравмирующих событиях, связанных с половой жизнью индивида, которая подвергается последовательной переработке: а) наиболее запомнившиеся сексуальные неудачи; б) воспоминания о негативной оценке партнершей сексуальных качеств мужчины и навязчивые мысли о собственной неполноценности; в) неадекватная информация о сексуальности, приводящая к формированию ложных убеждений и искаженных установок в отношении половой жизни; г) любые события, ведущие к появлению тревоги и страха перед проявлениями сексуальности или самим половым актом.
3. Определение типа и выраженности негативного эмоционального реагирования и телесного дискомфорта, возникающих в травмирующих ситуациях. Чаще всего такими эмоциями являются тревожное беспокойство и страх перед предстоящей близостью, иногда - раздражение, растерянность. Выраженность

отрицательных эмоций определяют по шкале субъективного беспокойства (ШСБ), где 0 баллов - полное спокойствие, а 10 баллов - крайняя степень тревоги и панический страх. Беспокойство, как правило, связано у пациента с мышечным напряжением и неприятными ощущениями в различных участках тела, которые также следует выявить.

4. Определение негативного самопредставления - отрицательного убеждения, отражающего представление пациента о себе в момент сексуальных неудач, новых попыток и других тревожащих ситуациях. Это убеждение типа: «У меня ничего не получится», «Я не могу справиться с этим» и т. п.

5. Определение положительного самопредставления, т. е. того убеждения, которое пациент хотел бы иметь в отношении себя в интимных ситуациях: «У меня все получается», «Я могу испытывать радость от близости» и т. п. Затем по шкале соответствия представлений (ШСП) определяют, насколько истинным (на уровне чувств и интуиции) кажется пациенту желаемое представление о себе сейчас. По ШСП 1 балл - это полное несоответствие представления, а 7 баллов - полное соответствие (истинное убеждение).

6. Десенсибилизация и переработка. На этом этапе пациенту проводят серии движений глаз от одного края визуального поля до другого. Чаще всего используются серии из 24 движений глаз (туда и обратно - 1 движение). В разных сериях движения глаз могут изменяться: горизонтальные, вертикальные, круговые, в виде восьмерки. В качестве точки фокусировки взгляда пациента используются пальцы руки врача. Он перемещает их с максимальной скоростью, не вызывающей дискомфорта у больного. Пациент должен вначале сосредоточить внимание на мысленном образе психотравмирующей ситуации (особенно запомнившаяся сексуальная неудача и т. д.), отрицательном самопредставлении и ассоциативно связанных с воспоминанием негативных эмоциях и дискомфортных ощущениях.

Далее начинают серии стимулирующих движений глаз, после каждой из которых пациенту предлагают на время отбросить травматический образ и сообщить об ощущениях в теле, эмоциях и мыслях, которые приходят ему в голову. Врач повторяет серии стимуляций, периодически направляя внимание больного на наиболее тягостные ассоциации, спонтанно возникающие у него во время процедуры, а затем снова возвращаясь к основной цели - первоначальному негативному воспоминанию. Процедуру повторяют до тех пор, пока уровень беспокойства (тревоги, страха) при воображении исходной ситуации не снижается до 0-1 балла по ШСБ. Параллельно нивелируется образ травматического события и происходит дезактуализации первоначального негативного представления о себе.

7. Инсталляция. Пациенту предлагают снова обратиться к травматическому инциденту, но при этом использовать положительное самопредставление (позитивное убеждение в своих возможностях), повторяя его про себя на фоне очередных серий движений глаз. В результате степень соответствия положительного представления по ШСП постепенно достигает 6 - 7 баллов, т. е. пациент по-новому начинает оценивать предшествующий опыт, проникаясь убеждением, что он вполне способен справиться со своей проблемой. При этом у пациента нередко возникают спонтанные представления успешно проводимой половой близости.

8. Сканирование тела. На этом этапе предлагают пациенту закрыть глаза и, удерживая в сознании первоначальное воспоминание и положительное представление о себе, мысленно пройтись по всему телу. Любое
остаточное напряжение или телесный дискомфорт перерабатываются дополнительными сериями движений глаз до их устранения. Это своего рода проверка результатов переработки, поскольку при пол ной нейтрализации травматического воспоминания оно теряет не только отрицательный эмоциональный заряд, но и перестает вызывать связанные с ним дискомфортные ощущения.

9. Завершающий этап - присоединение к будущему. Пациенту предлагают представить ситуацию возможной половой близости в ближайшем будущем. При возникновении дисфункциональных эмоций, мыслей, образов и ощущений проводится их дополнительная переработка. Позитивные образы и представления, которые приходят им на смену, закрепляют несколькими сериями движений глаз.

Работа с будущим проводится на заключительной стадии психотерапии, когда переработке подверглись основные травмирующие воспоминания пациента, содержащие негативную информацию о его сексуальности и вызывающие внутренний дискомфорт.

Если в ходе сеанса ДПДГ дисфункциональный материал полностью не переработан, перед его окончанием пациента возвращают в состояние эмоционального равновесия и предлагают запомнить (записать) беспокоящие воспоминания, мысли и ситуации, которые могут возникнуть у него между психотерапевтическими сессиями. На следующем сеансе они могут быть также подвергнуты десенсибилизации и переработке. Продолжительность одного сеанса составляет около 1 часа. Частота сеансов - 1-2 раза в неделю, при общем количестве от 2 до 6.

Нами предложена и широко используется аппаратная модификация метода ДПДГ, где серии движений глаз пациента вызываются при помощи аппарата визуальной цветоимпульсной стимуляции «АСИР». Для этого пациенту надевают специальные очки со светофильтрами, цвета которых по возможности подбирают с учетом предпочтений индивида. (К аппарату прилагается набор из 24 светофильтров различных оттенков.) Обычно десенсибилизация и переработка негативного материала проводится с использованием успокаивающих цветов (голубого, зеленого), для работы с ресурсами и присоединения к будущему используется импульсное воздействие активирующего светового потока (оранжевого, красного). Диапазон периодов повторения световых импульсов - 1-2 секунды. Пациенту предлагают, удерживая дискомфортное воспоминание, одновременно следить за попеременно вспыхивающими то в правом, то в левом окуляре огоньками. При этом его глазные яблоки совершают быстрые горизонтальные движе-

ния, обеспечивающие переработку негативного материала. После выполнения всех необходимых этапов процедуры ДПДГ врач устанавливает седатирующие светофильтры (синий, темно-зеленый), а цветоимпульсная стимуляция в течение 5-7 минут проводится в режиме поочередного постепенного увеличения и уменьшения яркости светового потока с длительностью световых импульсов от 5 до 8 секунд и паузами между ними 1 - 1,5 секунды. Заключительный этап визуальной цветостимуляции, особенно при использовании дополнительных суггестии, обеспечивает снятие эмоционального напряжения и мышечную релаксацию даже в тех случаях, когда наиболее травмирующие переживания пациента не были до конца переработаны в ходе одного сеанса (В.А. Доморацкий, 2002).

В ряде случаев ДПДГ-психотерапия может быть вполне самостоятельным методом лечения психогенных сексуальных дисфункций у мужчин, поскольку позволяет эффективно нейтрализовать воспоминания о предшествующих сексуальных срывах; добиться существенной редукции тревожного ожидания новой неудачи при попытках коитуса; обеспечить когнитивное переструктурирование, следствием чего является трансформация убеждений пациента в своей сексуальной несостоятельности в растущее понимание того, что он сможет успешно разрешить проблемы в интимной жизни. Но чаще мы дополняем им иные психотерапевтические процедуры, целенаправленно используя на одном-двух сеансах метод ДПДГ для быстрой переработки наиболее болезненных переживаний мужчины, связанных с сексуальными неудачами в прошлом, а также с целью нейтрализации опасений по поводу возможных неудач в будущем и закреплении в воображении пациента оптимальной модели интимной близости.

Сокращенный вариант процедуры ДПДГ используется нами в рамках мультимодальной стратегии как один из возможных способов нейтрализующего воздействия на визуальные и кинестетические триггеры, провоцирующие у мужчины дезадаптивные сексуальные реакции. При его выполнении пациенту вначале предлагают сосредоточиться на приятном (ресурсном) воспоминании, которое закрепляется в ходе 1-2 серий движений глаз, описывающих горизонтально расположенную восьмерку. Затем мужчина

должен переключиться на ситуацию неудачной попытки коитуса и отчетливо вспомнить негативный образ или ощущение, предшествующие сексуальному срыву. Далее проводят повторные серии движений глаз (горизонтальных либо вертикальных), во время каждой из них пациент фиксируется на соответствующем визуальном или кинестетическом объекте воздействия. Обычно требуется от 4 до 8 серий движений глаз, чтобы произошло размывание (стирание) неприятной картинки или исчезновение дискомфортных ощущений. Позитивный эффект может быть усилен дополнительными внушениями, проводимыми на фоне движений глаз пациента. Процедура завершается возвращением в приятное воспоминание, которое подкрепляется серией движений глаз в виде восьмерки.

Следующая группа техник используется для устранения тревожного гиперконтроля пациентов за состоянием половой сферы в интимных ситуациях и выведения из привычного для них диссоциированного состояния наблюдателя, опасливо оценивающего свои сексуальные реакции и действия партнера при попытках совершить коитус. Для этой цели может быть применена парадоксальная тактика «мнимого запрета», позволяющая уменьшить у мужчин произвольный контроль эрекции путем временного запрещения коитуса и параллельного поощрения интимных ласк, включая петтинг. Фактически данный принцип во многом определяет успешное использование нами в этих же случаях сексуальной, терапии в виде ряда последовательных этапов: эротическое наслаждение без эрекции (на фоне ласк, исключающих непосредственную стимуляцию гениталий мужчины); эрекция без оргазма (при прямой стимуляции полового члена, но без попыток вызвать эякуляцию); экстравагинальный оргазм (при мануальной либо оральной стимуляции); интромиссия без оргазма (введение полового члена во влагалище и копулятивные фрикции при запрете завершать их эякуляцией); коитус (H. S. Kaplan, 1994).

Усилить вовлеченность мужчины в чувственные переживания коитуса помогает *техника ассоциирования в переживание* (L. Cameron-Bandler, 1994). Используется процесс обратный визуально-кинестетической диссоциации. Пациент создает яркую визуализацию самого себя в ситуации, где он совершенно очевидно наслаждается сексуальной

близостью. Мужчина отчетливо представляет себя реагирующим полной эрекцией на чувственные ласки женщины, потом создает картинку самого коитуса, в котором партнеры всецело захвачены упоительными ощущениями телесного контакта. Пациент улучшает воображаемую сцену до степени, когда он будет полностью доволен увиденным. Затем мужчина мысленно входит в этот нарисованный воображением образ самого себя, отождествляясь с ним. Таким образом, он ассоциируется в кинестетическую часть желательного визуального переживания половой близости, обретая соответствующие эмоции и ощущения. Данная техника помогает фиксировать мужчину на чувственном компоненте сексуального взаимодействия, повышая его способность к восприятию всей гаммы островозбуждающих тактильных ощущений при половом контакте.

В случаях выраженной диссоциации пациентов от чувственных переживаний половой близости у них возникает своеобразный кинестетический блок. При этом мужчины парадоксальным образом реагируют на попытки партнерши использовать мануальную или оральную стимуляцию для достижения качественной эрекции, которая еще больше ослабевает либо вообще не возникает. Пациенты указывают, что, наблюдая в этот момент за собственными генитальными реакциями, они практически не ощущают ласк женщины, а отсутствие должной эрекции, несмотря на все попытки партнерши вызвать ее, столь резко усиливают тревогу, чувство бессилия и стыда, что вынуждает их немедленно прекращать интимный контакт. Для коррекции нарушений такого рода нами предложена специальная техника, сочетающая процедуру локальной декомпрессии (ЛД) с визуализацией пациентом различных ситуаций половой близости (В.А. Доморацкий, 2002). Для проведения локальной декомпрессии используют вакуумные насосы различных образцов, создающие в прозрачной колбе, надетой на половой член мужчины, пониженное давление воздуха, которое приводит к возникновению принудительной эрекции за счет возрастающего притока крови к кавернозным телам. Врач, регулируя уровень декомпрессии в колбе, осуществляет своеобразный пневмомассаж полового члена пациента. По достижении выраженной эрекции мужчине предлагается 3 - 5 минут разглядывать свой максимально

напряженный половой член, одновременно отмечая все нюансы и оттенки испытываемых генитальных ощущений. Параллельно врач суггестирует усиление переживаемых пациентом сексуально окрашенных «форлюстических» ощущений. Затем пациент закрывает глаза и, сохраняя фиксацию на сенсорных импульсах, исходящих из эрегированного полового члена, последовательно представляет себе сцены интимного контакта, включая эпизоды непосредственной стимуляции гениталий партнершей, а также сам половой акт. Он мысленно соединяет эти картинки с образом только что увиденного в колбе полового члена в состоянии полной эрекции и собственными ощущениями. При этом происходит своеобразное «якорение» т. е. устанавливается ассоциативная связь между нарисованными в воображении сексуальными действиями, видом напряженного полового члена и ощущениями, испытываемыми пациентом в момент эрекции. Чтобы добиться большей ассоциированности пациента в чувственные переживания, связанные с половым возбуждением и наступившей эрекцией, процедуры ЛД с визуализацией сцен сексуального взаимодействия с партнершей проводят 2 - 3 раза в неделю. Средняя продолжительность одного сеанса 15 - 20 минут при общем их количестве от 3 до 8.

Использование гипнотических техник позволяет существенно повысить восприятие мужчиной специфических телесных ощущений, возникающих в ходе интимной близости, и одновременно высвободить связанные с ними генитальные реакции из-под жесткого сознательного контроля. Причем применение приемов и техник из арсенала эриксоновского гипноза существенно расширяет возможности гипнотерапии пациентов, испытывающих страх перед предстоящим коитусом.

В эриксоновском гипнозе используется модель наведения транса, основанная на взаимодействии и сотрудничестве между пациентом и гипнотерапевтом. Применяются гибкие, адаптивные стратегии достижения состояния измененного сознания: врач вначале следует за текущим поведением пациента (присоединяется к позе, дыханию, особенностям речи субъекта), а затем, незаметно, все больше начинает им руководить, постепенно вводя в гипнотический транс. На стадии индукции транса и в ходе терапев-

тической утилизации трансовых состоянии нами широко используются разнообразные косвенные суггестии: последовательность принятия, иллюзия выбора, сложные составные и негативные парадоксальные внушения, пресуб-позиции, трюизмы, аллюзии, контекстуальные внушения, метафоры и др. Эриксоновский подход существенно повышает восприимчивость пациентов к гипнозу, позволяет избежать или изящно обойти сопротивление, которое не-редко возникает у субъекта при использовании директивных, традиционно-однообразных методов гипнотизации, а также прямых императивных внушений, ориентированных на снятие симптомов или изменение поведения.

В работе с сексологическими пациентами мы используем трансовые состояния в качестве своеобразной стратегической рамки, внутри которой осуществляют различные терапевтические интервенции. Мы считаем, что наиболее универсальным способом работы в гипнозе с пациентами с выраженной невротической фиксацией на половой сфере (особенно в начале курса лечения) является *погружение в ресурсное воспоминание*. Данная техника способствует активизации внутренних ресурсов пациента за счет воссоздания в гипнотическом трансе ранее пережитого им состояния физического и душевного комфорта, удовлетворенности, радости, уверенности в себе. Она позволяет работать с сексологической проблематикой даже без непосредственного обращения пациента к его противоречивому опыту интимных отношений. Для «сопровождения в приятном воспоминании» пациента предварительно расспрашивают о различных деталях той комфортной ситуации, в которую он хотел бы перенестись в своем воображении. Последующие внушения направлены на то, чтобы помочь пациенту постепенно представить себе эту картину прошлого более отчетливо, во всех красках, погрузиться в нее, услышать ее звуки, заново пережить прежние ощущения и эмоции.

Например, если мужчина пожелал мысленно оказаться в ситуации отдыха на море, фрагмент суггестивного текста может выглядеть следующим образом: «...Берег моря. Пляж с золотистым песочком, нагретым солнечными лучами... И как приятно удобно расположиться на этом песке, ощутить его тепло... Ощутить, как струятся по всему телу

солнечные лучи, наполняют его энергией, силой, создают удивительное чувство внутреннего комфорта, легкости и свободы... Какое это удовольствие - нежиться под ласковыми лучами солнца, ощущая всей кожей дуновение свежего ветерка... И можно наблюдать за неумолимым, размеренным движением морских волн, которые то набегают на песчаную косу пляжа, то вновь откатываются назад... чтобы вобрать в себя всю мощь бескрайних морских просторов и снова решительно двинуться на побережье... А можно обернуться и окинуть взором горные вершины, горделиво возвышающиеся вдали, обратить внимание на высокие могучие деревья, произрастающие по их склонам... Или просто наслаждаться этим прекрасным "ничегонеделанием", когда можно просто смотреть, просто слушать и, главное, чувствовать всем телом... радость жизни, ее дыхание, вкус и аромат... соприкасаясь с самыми желанными ее моментами... И как важно, что все это можно сохранить и даже усилить внутри себя... на уровне чувств, которые способны оживать каждый раз, когда действительно захочется... окунуться в те другие... еще более прекрасные и удивительные ощущения, которые знает и любит тело... Потому что существует возможность испытывать их всякий раз, когда твердое желание обрести эти чувства... придает телу особенную способность... легко войти в них, пропитаться ими изнутри...» (В.А. Доморацкий, 2002).

Подобная трансовая индукция позволяет осуществить одновременное воздействие на многих уровнях. Через погружение в приятное воспоминание реализуется непосредственная цель гипнотического сеанса - достижение пациентом в трансе ресурсного состояния, связанного с позитивными эмоциями, спокойствием и уверенностью, физическим комфортом как мощного противовеса тревогам и волнениям повседневной жизни. Широкое использование контекстуальных внушений, т. е. интонационного подчеркивания определенных слов (ощутить, почувствовать, нежиться, наслаждаться и т. п.), способствует активизации у пациента чувственного канала восприятия. Постгипнотическая суггестия, осуществляемая в последних фразах, перекидывает своеобразный мостик между способностью мужчины концентрироваться на своих телесных ощущениях в трансе и его возможностью в дальнейшем полнее ассо-

циироваться с другими чувственными переживаниями. При этом пациенту не дается прямого указания на сексуальный характер последних, что само по себе является косвенным внушением через «отсутствие упоминания». Намеренное опущение того, что достаточно явственно подразумевается, выделяет недостающий фрагмент для бессознательного восприятия. К другим терапевтическим элементам приведенного текста относятся активизирующие внутренние ресурсы пациента, динамичные, наполненные энергией образы морских волн, а также фаллическая символика (горные вершины, высокие могучие деревья), затрагивающие наиболее глубокие уровни бессознательного.

Другая трансовая модель активизации внутренних ресурсов пациента - *сопровождение в приятном воспоминании* (J. Beccio, Ch. Jousselin, 1998). До начала гипнотической индукции пациент фокусируется на цели (на том, что можно считать решением беспокоящей его проблемы), фактически ориентируя всю последующую работу бессознательного на поиск оптимальных путей для достижения намеченной цели. По мере погружения в транс, через возрастную регрессию (ее стимулирует врач, используя пространственно-временное искажение при описании собственного приятного воспоминания), пациент отыскивает в памяти ресурсное событие и постепенно углубляется в него, последовательно обретая картину того места, звуки и наконец физические ощущения. Достигнутое в трансе состояние душевного и телесного комфорта является весьма благодатной почвой для «посева» различного рода косвенных суггестии, направленных на снижение беспокойства пациента по поводу возможных сексуальных неудач и обретение уверенности в своих силах. Ниже приведена стенограмма авторского сеанса, в которой отражены специфические особенности трансовой речи и основные терапевтические элементы данной гипнотической индукции.

«Начнем сеанс. Вы можете делать что хотите. Вы можете оставить глаза открытыми, а можете их закрыть. Вы абсолютно свободны. И сейчас мы попробуем приблизиться к цели или достичь той цели, которую вы зафиксировали в своем уме. Вы готовы? Начнем. Итак, начинайте делать

ничего не делать. Потому что ничего не делать - это уже делать что-то. Ничего не делать, это, например, слушать

343

звуки, которые нас окружают. Вот так. Просто слушайте их, не пытаясь как-то интерпретировать... Просто получать их, принимать как показатели того, что вокруг что-то происходит, и люди заняты своим делом, а вы заняты своим... Смотрите, как Вы это делаете не глядя... просто позволяя блуждать своему разуму и осознавать на несколько секунд положение своего тела, чувствовать, как ноги твердо стоят на полу и чувствовать контакт собственного тела со стулом. Просто чувствовать, не пытаясь расслабляться, потому что то, что мы делаем, отличается от расслабления... Но если во время сеанса расслабление приходит, мы принимаем его с радостью. Хотя это и не та цель, которую мы ищем... Цель, которую мы ищем, мы попытаемся достичь или просто приблизиться к ней через то, что можно было бы назвать приятным воспоминанием... И через несколько секунд Вы отправитесь на поиски этого приятного воспоминания. Приятное воспоминание - это может быть самый прекрасный день в Вашей жизни. Может быть это обычный день, час или два, утро или вечер, или поздняя ночь, в общем один из тех моментов, когда чувствуешь себя хорошо, когда все идет хорошо, и даже не можешь этого объяснить. Один из тех моментов, когда все просто замечательно... Есть такие моменты, и я, например, припоминаю, как впервые отдыхал на Черном море вместе с родителями... И этот восторг маленького мальчика, который наконец наяву увидел, как выглядит море. И те чувства и эмоции, которые я испытал, когда впервые окинул взглядом бескрайние морские просторы, когда услышал звуки чаек и шум прибоя, когда почувствовал дуновение ветерка, наполненного запахами моря и какой-то особой свежестью, и нагретый солнцем песок под босыми ногами... И вот через 20 лет случай еще раз привел меня на тот же берег моря. Это место не очень сильно изменилось. И я нашел странным оказаться почти в том же самом месте, которое практически не изменилось: то же море, солнце, голубое небо, теплый песок, крики чаек и шум прибоя, веселые голоса загорающих на пляже людей - все как прежде, а я изменился, повзрослев на 20 лет. В нашей жизни есть такие моменты, когда обретаешь ощущения, которые позволяют

приходить воспоминаниям об эмоциях... Эмоциях, связанных с приятными моментами, которые мы можем использовать... И через некоторое

344

время мы попросим Вашу память, или Ваше бессознательное (и я не знаю, кто из них ответит) отправиться на поиски и предоставить нам то, что является для вас приятным воспоминанием. И чтобы сообщить мне об этом Вам нет необходимости говорить вслух... Вы можете дать знать мне о том, что уже обрели приятное воспоминание очень просто, например движением указательного пальца правой руки... И я вижу по движению этого пальца, что Вы сейчас обрели это воспоминание... Представьте себе тот момент дня, когда разворачивается это воспоминание. Очень хорошо... Представьте себе ту обстановку, в которой разворачивается приятное воспоминание. Как если бы Вы были художником и, может быть, Вы немножко являетесь им... И Вы хотите нарисовать картину того места. Поэтому Вы изучаете его, окидывая взором все, что Вас окружает, глядя на разные объемы этого пространства, расположение различных элементов, составляющих его. Также Вы изучаете цвета, их нюансы и оттенки. И среди этих оттенков, многообразия этих цветов Вы можете развлекаться, выбирая тот цвет, который Вам подходит, который гармонирует с Вами неизвестно почему. И когда Вы выберете этот цвет, Ваш палец даст об этом знать... Очень хорошо. А теперь попытайтесь увидеть, обладает ли Ваша память способностью позволить Вам обрести то, что можно назвать музыкой воспоминания, т. е. звуки, шумы, которые Вы слышали в тот день. И если Вы обретете некоторые из этих звуков, то Вы уже прекрасно знаете, как можно дать знать мне об этом... Очень хорошо. Оставайтесь в контакте с этой музыкой. Слушайте ее как будто в первый раз... Ведь она позволяет Вам обрести физические ощущения, которые бы испытали в тот день. Обретаете положение Вашего тела в тот день. Располагайте временем, чтобы как следует обрести эти приятные ощущения. Используйте время, которое Вам необходимо... Потому что в то время как одна часть Вас самого ищет эти ощущения, другая часть осуществляет работу на другом уровне, приятную и полезную работу, которая обладает способностью мобилизовать все, что может быть в Вас мобилизовано... И пока Ваше тело комфортно расположено, в течение нескольких мгновений у

Вас будет время, чтобы иметь время для себя.., время, которое принадлежит только Вам... Возможно в Вашей жизни было не слишком

345

много времени, когда в течение нескольких мгновений, которые здесь будут несколькими секундами, а может быть станут несколькими минутами, которые Ваше воображение сможет превратить в несколько часов... Это будет Ваше собственное время, личное время, которое Ваше бессознательное сможет использовать с наибольшей пользой. А пока у Вас есть время, чтобы помечтать и позволить себе еще какое-то время побыть в этом удивительном ресурсном воспоминании, пропитываясь теми чувствами, эмоциями и физическими ощущениями, которые и сделали его столь приятными и радостными для Вас... Обретая энергию этого воспоминания, которая поможет Вам приблизиться к поставленной цеди, а быть может достичь ее... уже сейчас... или чуть позднее. Впрочем, это неважно. Сегодня Вы хорошо поработали на разных уровнях себя и вправе рассчитывать на успех. И энергия Ваших ресурсов может быть направлена в то место Вашего тела, а быть может Вашего духа, которые в наибольшей степени будут нуждаться в этом... Чтобы обрести особую силу духа, твердость характера и легкость на подъем... И сейчас, когда наша работа подошла к концу, Вы можете начать возвращение обратно в реальный мир. Туда, где время течет как обычно, и Ваш мышечный тонус становится обычным. Сделав это быстро или медленно, так как Вам было бы удобнее всего перенести эти комфортные ощущения, силу и уверенность в реальность сегодняшнего дня...»

Один из эффективных способов работы в гипнозе с симптомами, порождаемыми страхом перед сексуальными контактами, - риминение трансов с заданной фабулой, где пациенту предоставляется возможность в метафорической форме расстаться с беспокоящей его проблемой. Вариантом такой работы является гипнотическая техника *мост в прошлое.* Ниже дана сокращенная стенограмма авторского сеанса, в которой отражены его основные терапевтические элементы.

Вначале пациенту предлагают подумать и вместе с врачом четко сформулировать проблему или симптом, с которыми он готов работать на

сеансе. Например: «Я испытываю чувство сильной тревоги и неуверенность в себе каждый раз, когда оказываюсь наедине с женщиной». Далее следует наша трансовая индукция и работа в гипно-

346

тическом состоянии: «Хочу попросить Вас начать с очень обычной вещи... с достижения комфорта вашей позы и может быть поиска того положения в кресле, когда Вам будет по-настоящему удобно... И Вы можете обратить внимание на свое тело... попытаться почувствовать себя целиком... Почувствовать, как Вы дышите... по мере поиска удобства зашей позы... И можете еще раз подумать о проблеме, с которой Вам хотелось бы расстаться... И пусть она всплывет сама... просто оттого, что Вы можете позволить себе расслабиться и погрузиться внутрь себя... просто ощущая себя здесь в этой комнате, в этом кресле... И в то же время, обретая возможность уйти внутрь своего воображения... сделав это быстро или медленно... так, как Вам удобно... чтобы там, в глубине себя... выполнить достаточно необычную, но очень важную работу... Я хочу попросить Вас представить себе, что вы стоите где-то там, где перед Вами начинается мост... И пусть Ваше воображение нарисует сейчас, как выглядит этот мост... Потому что он может быть вполне реальным, пришедшим из Ваших воспоминаний... А может быть это мост, увиденный Вами однажды на картинке... И мне бы хотелось, чтобы Вы... прежде чем вступить на этот мост, который поведет Вас в прошлое... в то место и в то время, когда Вашей проблемы еще не было... прежде чем ступить на него... очень ясно представьте себе, с чем Вы готовы расстаться... с чем вы могли и хотели бы работать уже сейчас... И думая об этой волнующей проблеме, Вы можете даже усилить ее на уровне Ваших чувств... на уровне Ваших воспоминаний. Потому что Вы находитесь в полной безопасности... и Ваше тело остается здесь, в этой комнате... а Ваше воображение может отправиться на ту сторону, в то место и то время, когда этой проблемы еще не было у Вас... И Вы можете вступить на этот мост и идти по нему... возможно, оживляя в памяти свои воспоминания, картинки прошлого... И Вы можете делать это очень сознательно... но в то же время можно просто довериться своему бессознательному, в котором хранится так много

знаний... И пусть оно пошлет вам какие-то воспоминания о том пространстве... в котором Вы существовали когда-то, когда этой проблемы еще не было... И тогда, ступая на этот мост, идя по нему туда, где этой проблемы еще не было... Вы сможете почти реально ощутить, как Вы движетесь...

347

увидеть, из чего сделан этот мост и как он устроен... И продолжая идти, разрешите себе одновременно погружаться в свои воспоминания, в свои ощущения, образы или чувства... Потому что Вы очень свободны сейчас... И это время, и это пространство принадлежит только Вам... И в конце концов Вы сможете оказаться на той стороне, в том месте и в том времени, когда Вашей проблемы действительно не было... И пусть Ваше бессознательное вернет Вам картины именно того места и времени, которые Вы ищите там... внутри своей памяти... И у Вас есть время для этого... И как важно, что Вы можете использовать его... и побыть на той стороне... А может быть, даже увидеть себя со стороны... там на той стороне... И можно отчетливо вспомнить то, о чем? казалось, давно забыл... о своих возможностях жить иначе... чувствовать себя иначе: раскованно и свободно... И я хочу попросить Вас прежде, чем вернуться обратно... оставить эту проблему где-то там, в прошлом... когда она еще только начиналась, и Вы даже не подозревали об этом... Оставить ее на той стороне времени, на той стороне пространства... И есть очень много способов оставить ее... И важно найти свой собственный, наиболее подходящий способ расстаться с проблемой... И может быть, даже попрощаться с ней или уйти сразу, оставив ее там, где Вы хотели бы ее оставить, оставив ее так, как Вы хотели бы ее оставить... И тогда Вы можете вернуться обратно старым путем, снова пройдя по уже виденному вами мосту... А возможно, это будет совсем другой мост, который создает ваше воображение... И Вы сами выбираете, каким путем Вам было бы удобнее возвратиться в свой сегодняшний день из этой картинки... И тогда Вы можете идти быстро или медленно... так, как это будет комфортно для Вас. И по дороге обратно, возвращаясь в реальность сегодняшнего дня... Вы можете очень отчетливо представить себе, что изменится в Вашей жизни, когда этой проблемы не будет вовсе... И если у Вас есть некоторое ощущение незавершенности, а возможно, желание еще раз вернуться к работе над этой проблемой или над тем, что от нее осталось... Вам важно помнить о том... что

достаточно устроиться удобно и Вы снова сможете проделать этот путь... ступая на этот мост или совсем другой... Мост, который приведет Вас в прошлое, где Вы сможете сделать что-то еще... и в конце концов окончательно расстаться с

348

тем, что вам мешало... а затем вернуться обратно самым удобным и подходящим способом... так как Вы это сделали сейчас, обретая чувство реальности... И время снова будет течь, как обычно, и Ваш мышечный тонус станет обычным... но все то полезное и важное, что произошло в ходе этого путешествия, останется с Вами» (В.А. Доморацкий, 2002).

Применение данной гипнотической техники позволяет, максимально сконцентрировав пациента на сексуальной проблеме, затем осуществить диссоциацию сознательных и бессознательных процессов с последующей возрастной регрессией при прохождении моста (метафорического пути в прошлое), что позволяет ему отчетливо вспомнить себя, лишенного каких-либо сексуальных комплексов; ориентирует на нахождение метафорического способа расставания с беспокоящей проблемой, который ярко визуализируется, активизируя бессознательные возможности ее разрешения в реальной жизни; обеспечивает при возвращении обратно «присоединение к будущему», т. е. моделирование пациентом в воображении удовлетворяющего образа самого себя; в случае необходимости создает установку на продолжение начатой работы в аутогипнозе.

Наряду с использованием в гипнозе метафорических образов важная роль принадлежит суггестивному воздействию с помощью терапевтических метафор (J. K. Zeig, 1994; D. Gordon, 1998; М.Н. Гордеев, 2001 и др.). В широком смысле, метафора - иносказание вообще или перенос по сходству, а в более узком смысле - обозначение предметов или явлений одного ряда с помощью свойств, характерных для предметов или явлений другого ряда. Терапевтическая метафора представляет собой новеллистический способ презентации психологических затруднений пациента и способов их разрешения. Она является особым видом вербального косвенного внушения и действует на нескольких уровнях. Буквальное (явное) значение метафоры обращено к сознанию пациента, в то время как второе, скрытое значение

адресовано к его подсознанию, оказывая активирующее и реорганизующее влияние на бессознательные процессы (J. Beccio, Ch. Jousselin, 1998). Установлено, что обработка сообщений метафорического типа происходит в правом (недоминантном) полушарии, которое в наиболь-

шей степени связано с формированием невротических и психосоматических симптомов (J. Mills, R. Crowley, 1996). Поэтому метафора движется к терапевтической цели по прямой, приводя в действие правополушарные процессы, активизируя неосознаваемые ассоциативные способности и ответные реакции, в результате чего возникает конечный продукт, который даруется сознанию в виде нового знания или поведенческой реакции (M. Ericson, E. Rossi, Sh. Rossi, 1997).

Согласно Л. Камерон-Бэндлер (1996), в общем виде правила построения эффективной терапевтической метафоры таковы: она должна быть изоморфной (подобной) проблеме пациента; метафора должна предлагать замещающий опыт; в ней должны содержаться примеры таких способов разрешения проблемы, которые пациент может обобщить и спроецировать на себя (найти подсказку, как можно справиться с собственными трудностями). Такие, специально сконструированные терапевтические метафоры, можно предлагать пациентам как без формальной трансовой индукции в ходе беседы с ними, так и использовать на гипнотических сеансах.

В гипнотическом трансе терапевтическая метафора может быть особым образом встроена в текст. Этот прием встраивания получил название *тройной спирали.* Встроенная метафора состоит из трех ступеней. Она представляет собой историю-матрешку, когда один сюжет вкладывается в другой, а тот - в третий. Первым этапом тройной спирали может быть трансовое сопровождение в ресурсное воспоминание (например, пациента отправляют погулять в осенний лес, предоставляя ему возможность полюбоваться красотой увядающей природы, послушать шуршание опавших листьев под ногами, ощутить свежесть осеннего ветерка и запахи леса. Когда замечают признаки углубления транса, вводят метафору изменений (второй этап). Отметим, что к метафорам изменений

относятся описания любых динамических явлений, подразумевающих движение, возможность превращений, трансформации, например смена времен года, смена погоды, цикл развития бабочки, рост какого-либо растения и т. п. Предположим, психотерапевт обращает внимание субъекта на большое дерево с подернутой золотом листвой. Он может сказать о том, что произойдет, когда придут холода

и дерево полностью сбросит свой наряд из желтых листьев. Что будет зимой, когда деревья спят, а их стволы и ветви покрыты белым снегом. Белым снегом покрыта поляна, на которой стоит это дерево, тропинки в лесу, вся земля. Примерно на середине повествования (после описания дерева осенью и зимой) второй рассказ прерывают и вводят терапевтическую метафору, которую рассказывают целиком (третий этап). Она является основной и, разумеется, находится под двойным покровом защиты, который закрывает ее от сознания, что еще вернее отправляет встроенную метафору на рассмотрение бессознательной части психики пациента. Завершив ее, психотерапевт снова возвращается к зиме, которая продолжает царствовать до той поры, пока не приходит весна. Дается развернутое описание признаков весны, которая сменяется жарким летом. Описывают все изменения, которые происходят с деревом весенней порой, а затем летом (четвертый этап). Но лето тоже проходит и осень все больше вступает в свои права... И пациент снова оказывается в том месте и времени года, с которого начиналась метафора изменений. Он опять гуляет некоторое время по осеннему лесу (пятый этап), после чего возвращается в реальность. Такая последовательность работы позволяет обеспечить структурирование амнезии той части сеанса, где использовалась терапевтическая метафора. Ибо важно, чтобы метафора была усвоена на бессознательном уровне, которому она адресовалась, и амнезировалась на уровне сознания. Отметим, что при переходе от одного этапа к другому нередко происходит автоматическое углубление транса, поскольку внимание разделяется, создавая перегрузку сознательных процессов. Дополнительно в эти моменты можно дать еще и внушение на углубление транса. По завершении встроенной метафоры, несмотря на то, что сама идея тройной спирали предполагает амнезию, можно специально дать установку

на амнезию с целью облегчения передачи метафорического материала для обработки бессознательному.

Несмотря на отсутствие в настоящее время научно обоснованной концепции терапевтического воздействия метафорических сообщений, целесообразность применения метафор в психотерапии неоднократно подтверждалась эмпирически (M. Erikson, J. Haley, 2001; J. Mills, R. Crowley, 1996 и др.). Метафоры, равно как

и другие косвенные суггестии, позволяют успешно решать проблему сопротивления пациента психотерапевтическому воздействию. Метафорический рассказ о ком-то или о чем-то другом в принципе неспособен вызвать сопротивление. В то же время, если события метафоры чем-то напоминают личные проблемы человека, он подсознательно начинает «примерять» на себя рассказ, содержащий то или иное их решение. Если это решение подходит пациенту, он примет его как свое собственное, а не навязанное извне (J. Beccio, Ch. Jousselin, 1998).

Например, при нарушении эрекции по механизмам тревожного ожидания неудачи в сексуальной связи с новой партнершей в трансе пациенту (особенно, если он водитель со стажем) нами иногда предлагается следующая метафора: «Вы хорошо можете припомнить, как когда-то учились водить машину, как впервые сели за руль, постепенно обретая необходимые навыки и автоматизмы. С течением времени Вы очень хорошо освоили свой автомобиль, все особенности его управления, и тогда поездки на нем стали доставлять все большее удовольствие. Потому что Вы легко и свободно вели машину, наслаждаясь самим процессом езды не ней... Но в какой-то момент Ваш старый автомобиль перестал вас устраивать. Может быть, Вам слишком часто приходилось чинить его или расход топлива был слишком велик. И это неважно... Потому что в один прекрасный момент Вы решились купить другой автомобиль, более красивый, более мощный. Но когда Вы впервые сели на место водителя этой более современной машины, то почувствовали некоторую растерянность. Другая приборная доска, иное переключение скоростей и еще масса разных нюансов, которые призваны сделать поездку в этом автомобиле более комфортной… Но их надо изучить, к ним нужно привыкнуть и

приспособиться. И это несложно сделать, ведь каждый автомобилист знает, что навыки вождения сохраняются очень долго, даже если некоторое время вообще не водил машину. И важно просто сесть за руль, чтобы разобраться в некоторых отличиях в управлении данным автомобилем, а затем тронуться в путь, потому что тело очень хорошо сохраняет все автоматизмы, связанные с вождением... И важно просто поверить в себя и свои возможности сделать это. И тогда очень быстро езда на новом автомобиле станет чрезвычайно приятным занятием. Когда мож-

но прибавить газу или замедлить скорость, остановиться, чтобы затем снова двинуться в путь, наслаждаясь этим упоительным ощущением полного единения с этой прекрасной и очень надежной машиной...» Здесь врач в метафорической форме сообщает, а фактически косвенно суггестирует, что прежние навыки сексуального взаимодействия не исчезли в никуда, и пациенту нужно просто поверить в себя, а также адаптироваться к новой партнерше, чтобы обрести сексуальную гармонию в общении с ней (В.А. Доморацкий, 2002).

Следующая метафора адресована проблеме преждевременной эякуляции, обусловленной тревожным ее ожиданием и чрезмерным беспокойством мужчины по поводу качества полового акта, возможных упреков со стороны женщины: «Когда сильно проголодался, может возникнуть желание поесть в ресторане. И тогда, устроившись удобно за столиком, можно сделать заказ, выбрав из меню свои любимые блюда. И, находясь в предвкушении обильной и вкусной трапезы, волноваться, когда же наконец официант принесет заказ, или даже переживать и сомневаться, хватит ли денег на его оплату. Но когда стол накрыт, расставленные на нем блюда выглядят столь заманчиво, что вызывают желание буквально наброситься на пищу, быстро поглощая ее, чтобы мгновенно наполнить желудок и утолить чувство голода... Но при этом, напротив, лишить себя возможности насладиться едой по-настоящему, ощутить ее тонкий аромат и нежный вкус... Но лучше поступить иначе. Ведь даже если человек голоден, можно позволить себе есть не торопясь, тщательно пережевывая, смакуя каждый кусочек пищи, на все лады ощущая изумительные вкусовые качества любимого блюда... Как это здорово - вкушать пищу

спокойно и размеренно, время от времени приостанавливаясь, чтобы с еще большим удовольствием продолжать далее... до полного удовлетворения от этой неторопливой и очень приятной трапезы «Данная метафора проводит подсознательно улавливаемую параллель между неспешной едой, позволяющей в полной мере насладиться ее вкусом, и половой близостью, которая происходит без спешки и тревожной суеты. Для пациента в гипнотическом состоянии - это суггестивное обращение к его бессознательным возможностям прервать прежний, дисфункциональный поведенческий паттерн (В.А. Доморацкий, 2002).

Мы также используем многоуровневые метафорические сообщения, адресованные некоторым профессиональным навыкам пациентов. Например, мужчине с психогенным расстройством эрекции, архитектору по профессии, в гипнотическом трансе словесно изобразили высокое здание, которое имеет солидный фундамент. В описании особое внимание было уделено мощному основанию этого высотного, очень прочного и устойчивого здания цилиндрической формы, где в полной исправности водо-канализационная система и электрическая проводка. Таким образом, пациенту дается скрытое послание об отсутствии серьезных нарушений потенции, а также установка на восстановление мощной и устойчивой эрекции.

Практика показывает, что метафорические послания в гипнозе, равно как и другие варианты косвенных суггестии, особенно эффективны при сочетании трансовых техник и различных сексотерапевтических (бихевиоральных) приемов. Так, например, в случае преждевременной эякуляции психогенного генеза дополнительно нами применяется *техника сжатия*, которая позволяет мужчине усилить произвольный контроль над эякуляцией. Ее суть состоит в том, что в интимной ситуации партнерша пациента мануально стимулирует половой член, а при приближении эякуляции на 3-4 секунды сдавливает его головку. При этом женщина кладет свой большой палец на уздечку полового члена, а указательный и средний пальцы с противоположной стороны у венечной борозды (чуть ниже головки). Сдавление, произведенное своевременно и с достаточной интенсивностью, подавляет эякуляторный рефлекс, одновременно несколько снижая эрекцию. Через 20 - 30 секунд стимуляцию возобновляют до нового всплеска возбуждения, которое тормозится в

предоргастической фазе при помощи очередного сжатия головки. Процедура выполняется не менее 4 - 5 раз, после чего мужчина может эякулировать экстравагинально либо в ходе последующего коитуса (W. Masters, B. Jonson, R. Kolodny, 1998). При регулярном применении «техники сжатия» создаются условия для разрыва условно-рефлектор-ной связи между началом копулятивных фрикций и резко возникающим, неконтролируемым позывом к эякуляции.

354

С аналогичной целью мы рекомендуем пациентам использовать некоторые приемы, известные из древнеиндийских источников. Например, неоднократное сжатие мускулатуры анального сфинктера, сопровождающееся втягиванием заднего прохода, которое может сочетаться с одновременным выполнением нескольких круговых движений глазных яблок, совершаемых мужчиной во время фрикций при высоком уровне полового возбуждения либо энергичное надавливание пальца женщины ему на «особую точку» на промежности (посередине между гениталиями и анусом) при приближении эякуляции. Применение этих приемов, описанных в старинных тантрических текстах, также может способствовать пролонгации полового акта

В работе с пациентами, которые испытывают сильный страх потерпеть неудачу при половом акте, на наш взгляд, весьма перспективна гипнотическая идеомоторная *техника левитации руки.* Хотя ряд специалистов считает данную технику весьма сложной и трудоемкой для широкого практического использования (И.Е. Вольперт, 1972; В.Т. Кондратенко, Д.И. Донской, 1997 и др.), многолетняя преподавательская и практическая работа автора скорее говорит об обратном. Перечислим основные технические моменты для успешного выполнения данной техники: 1) зафиксировать внимание пациента на собственных телесных ощущениях, суггестируя постепенное усиление их комфортности; 2) перевести его внимание на руки и предложить максимально сосредоточиться на них; 3) усилить ощущения в руках за счет концентрации внимания пациента на том, как по-разному лежат они на бедрах, как чувствуют соприкосновение с тканью одежды, давление

ремешка от часов на запястье левой руки или обручального кольца на безымянном пальце правой руки; 4) связать движения грудной клетки пациента при дыхании с легкими, едва заметными движениями рук, которые на вдохе слегка приподнимаются, а на выдохе опускаются; 5) предоставить возможность для одной из рук ощутить это особенно отчетливо, связать ее с желанием почувствовать эту руку особенно свободно и легко, освободить ее от какого-либо сознательного контроля, предоставив возможность управлять рукой бессознательному (момент диссоциации сознательных

и бессознательных процессов); 6) усилить нарастающее ощущение легкости и невесомости в руке, вводя соответствующие образы ее движения (к запястью на тонкой ниточке привязаны воздушные шарики, наполненные гелием, которые, устремляясь вверх, подталкивают руку за собой, и т. п.); 7) отслеживать любые микродвижения, возникающие в пальцах, или малейшие движения кисти руки и предплечья вверх, комментируя их и усиливая с помощью суггестии «почувствовать в полной мере эту удивительную легкость, которая позволяет теряющей вес руке двигаться кверху»; 8) подтвердить, что бессознательное пациента действительно способно быстро или медленно поднимать руку на наиболее удобную высоту, одновременно погружая его на ту глубину, где он может проделать важную и нужную работу для себя, решить некую проблему; 9) осуществить собственно терапевтическое внушение, направленное на успешное разрешение сексуальных затруднений пациента, с последующей его реориентацией и выведением из транса по мере того, как рука снова постепенно опустится вниз.

Считается, что левитирующая рука - хороший индикатор той глубины трансового погружения, которая позволяет осуществить любые терапевтические интервенции. Причем собственно левитация руки является прекрасной телесной метафорой возникающей эрекции: «Как интересно узнавать, что рука может стать настолько свободной, что начинает двигаться вверх сама по себе, так легко и естественно... И может быть, это похоже на движение кверху другой части вашего тела, которая вновь обретает важную

способность каждый раз, когда возникает желание, сделать это... ощущая в себе силу и особенную легкость на подъем».

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что гипнотические индукции с использованием разнообразных косвенных внушений, включая терапевтические метафоры, приводят к редукции тревоги перед возможной неудачей, способствуют ассоциированному восприятию пациентом полового контакта и оптимизируют сексуальные реакции на всех его фазах.

У пациентов с высоким самоконтролем и скептиков с негативной установкой на проведение гипноза суггестивное воздействие, направленное на устранение страха перед

половой близостью, может быть осуществлено в состоянии измененного сознания, обусловленном вдыханием ими закиси азота. Мы существенно модифицировали *наркопсихотерапию с использованием закиси азота*, практически отказавшись от жестко-директивных форм ее проведения. На фоне действия закиси азота используются современные психотерапевтические стратегии, основанные на депотенциализации сознательных процессов, косвенной суггестии и визуализации (В.А. Доморацкий, 1999). При этом учитывается стадийность развития наркотического эффекта:

I - эйфория (сопровождается общим расслаблением, чувством легкости, эмоциональным подъемом, приятной эйфорией, облегчением способности к визуализации, ускорением ассоциативных процессов и повышением внушаемости);

II - сонливость (напоминает процесс засыпания и сопровождается чувством отрешенности и душевного покоя, спонтанным наплывом мыслей, образов, на которых трудно сосредоточиться, иногда возникают легкие парестезии, внушаемость повышена);

III - легкая анестезия (сопровождается дремотным состоянием, возможно искажение чувства собственного тела, снижены болевая чувствительность и самоконтроль, сохраняется повышенная внушаемость);

IV - оглушенность (сознание сужено, возможна дезориентировка, могут возникать галлюцинаторные переживания, поддержание раппорта затруднено или невозможно).

Во время сеанса подача газовой смеси и регуляция соотношения кислорода и закиси азота осуществляется с помощью наркозного аппарата любого типа. Концентрация закиси азота может варьировать в пределах 25-75 %, что зависит от индивидуальной чувствительности пациента и необходимости достижения той или иной наркотической стадии.

Большинство терапевтических интервенций, связанных с управляемой визуализацией, использованием метафор и других косвенных внушений, осуществляется на стадии эйфории с переходом в сонливость (I - II ст.). Средняя продолжительность процедуры составляет 10-15 минут. Общее количество сеансов от *1-2* до 6 - 8.

357

Перечислим некоторые из психотерапевтических методик, которые мы наиболее широко используем на фоне наркотического действия закиси азота. Это приемы, связанные с формированием у пациента «образа достижения» (ресурсного и весьма притягательного); создание в воображении метафорического визуального образа сексуальной проблемы или отдельных симптомов половой дисфункции с его последующей трансформацией (изменением цвета, формы и консистенции, уменьшением размеров, а затем полным исчезновением); использование различных косвенных внушений, терапевтических метафор, которые контекстуально соответствуют проблеме пациента и содержат скрытые указания на возможные пути ее успешного разрешения; диссоциация от ситуации фиаско с последующим моделированием в сфере воображения оптимальных вариантов собственного сексуального поведения и закрепления их в форме своеобразных постнаркотических суггестии.

В некоторых случаях при сохранении зафиксированных дисфункциональных сексуальных реакций (после тщательной проработки лежащих в их основе психологических проблем) нами используются короткие, прямые суггестии, направленные на ликвидацию симптома и формирование его позитивной альтернативы. Такие внушения осуществ-

ляются в III и даже в IV стадии развития наркотического эффекта, а после сеанса у пациента, как правило, возникает частичная амнезия.

Таким образом, наркопсихотерапия при адекватном и умелом использовании позволяет в ряде случаев облегчить и ускорить решение конкретных терапевтических задач, связанных с коррекцией дезадаптивного сексуального поведения мужчин и устранения у них страха перед половой близостью.

В качестве домашнего задания для пациентов с тревожным ожиданием сексуальной неудачи нами дополнительно применяется *методика мысленной тренировки* (А. Лазарус, 2001). Она заключается в том, что мужчина, находящийся в расслабленном состоянии, в воображении представляет себя участвующим в страстных сексуальных сценах, где он обнаруживает полноценную эрекцию и добивается успеха в половом акте. А. Лазарус считает, что мысленной тренировкой потенции мужчине необходимо заниматься при отсутствии у него сильного полового возбуждения, так как фанта-

зии, связанные с мастурбацией, не способствуют улучшению качества эрекции при реальном сексуальном контакте. Конечной целью таких неоднократных мысленных репетиций является способность пациента без малейшего внутреннего напряжения представлять себе благоприятный исход воображаемой интимной близости, что, в свою очередь, приводит к угасанию прежних страхов и облегчает восстановление нормальных генитальных реакций при коитусе.

5.5. Модификация неадекватных убеждений и установок в отношении половой жизни, коррекция дисфункциональных схем мышления

При коррекции половых дисфункций необходимо учитывать, что сфера сексуальности насыщена у человека когнитивными конструктами, которые в немалой степени влияют на его ожидания, убеждения и

установки в отношении интимной жизни. Нередко сексуальные проблемы возникают или приобретают остроту в результате недостаточной либо искаженной информации. Поэтому разъяснение и сообщение пациентам адекватных сведений о различных сторонах психологии и физиологии половой жизни, а нередко и технических нюансах интимного взаимодействия - важная составная часть психотерапевтического процесса. Кроме того, используются специальные приемы когнитивной терапии, направленные на выработку более реалистичных ожиданий и установок в сфере сексуальных отношений. Причем высокоинтеллектуальные пациенты - не самые подходящие кандидаты для когнитивной психотерапии, поскольку они оказывают самое сильное сопротивление попыткам изменить их привычные схемы мышления. А. Бек (1993) считает, что более открыты когнитивному подходу пациенты, которые мало размышляют о своих чувствах и поведении, а также в случае расстройств, затрагивающих лишь отдельные аспекты их жизни (неуверенность в определенных ситуациях, в частности, при интимных встречах, трудности общения и ограниченные фобии). Используемые в рамках интегративного подхода элементы когнитивной терапии позволяют

установить рациональные причинно-следственные связи и нейтрализовать дисфункциональные схемы мышления пациента, что способствует выработке у него более адаптивных образцов сексуального поведения. Для этой цели мы применяем следующие когнитивные техники: обнаружения автоматических мыслей, когнитивных ошибок и искажений, а также эмпирическая проверка реалистичности.

Автоматические мысли отличаются тем, что возникают очень быстро, не являясь плодом размышлений, и часто не замечаются пациентом. Они существуют в вербальной форме или в виде образов и картинок, а их появление предшествует возникновению негативных эмоций, неприятных ощущений или подавлению активности определенных функциональных систем организма человека (например, функциональной системы, обеспечивающей копуляцию). В когнитивной терапии *коррекция автоматических мыслей* осуществляется в четыре этапа. Применительно к сексуальной проблематике это выглядит следующим образом:

1. Распознавание автоматических мыслей, для чего пациенту предлагают представить сексуальную неудачу и вспомнить, какие мысли обычно приходят при этом.

2. Вербализация. Пациент должен произнести эти мысли вслух, от первого лица и, по возможности, в утрированно преувеличенной форме: «У меня опять ничего не получается с женщиной - пора уходить в монастырь».

3. Анализ. Вместе с пациентом анализируются причины возникновения и негативные последствия подобных установок. Соответствует ли констатация неудачи реальным фактам? Что конкретно утвердило пациента во мнении о своей сексуальной несостоятельности? Соответствует ли этот вывод действительности? Не является ли он односторонним и нелогичным? (Например, учитывая сохранные спонтанные утренние эрекции, эрекции при мастурбации и в обстановке, исключающей интимную близость.)

К каким возможным негативным последствиям ведут эти «самореализующиеся пророчества» новых сексуальных неудач? Что произойдет, если и в дальнейшем все останется по-прежнему?

4. Изменения. Уже первые три этапа создают предпосылки для более реалистичной оценки пациентом своих сексуальных проблем, могут вести к изменениям установки. Дополнительно врач указывает пациенту на те его качества, опыт, предшествующие события, которые несовместимы с его негативной установкой. Если в истории жизни пациента удается найти убедительные факты, которые говорят об обратном (случаи весьма успешной половой близости, полноценные эрекции при просмотре эротического фильма или взаимных поверхностных ласках с партнершей), то существующая установка в силу потребности в согласованности убеждений и личного опыта начинает осознаваться как неадекватная, подлежащая исправлению. Полезно продемонстрировать пациенту ошибочный характер автоматических мыслей, этих молниеносных негативных интерпретаций ситуации, прослеживая шаг за шагом все их возможные последствия, которые способны довести его личную жизнь до полного абсурда.

Обнаружение когнитивных ошибок строится на выявлении умозаключений пациента, которые основаны на предубеждениях и ложных выводах (A.T Beck, 1997; R. MacMullin, 2001). Исходя из нашего опыта, перечислим наиболее типичные когнитивные (логические) ошибки у сексологических пациентов:

1) сверхобобщение - использование единичных негативных фактов для построения общей пессимистичной картины развития событий в будущем: «Это уже вторая неудачная попытка полового акта, значит я становлюсь импотентом»;

2) дихотомическое мышление, осуществляемое по принципу «все или нечего», что проявляется тенденцией видеть мир «черно-белым», не замечая полутонов: «в сексе ты или победитель, или проигравший»;

3) долженствование - превращение «хочу» в «должен», «обязан», «надо»: «Я должен ежедневно проводить с ней половые акты»;

4) выборочное абстрагирование - фокусировка на деталях, вырванных из общего контекста: «Последние

две недели я потерял всякий интерес к половой жизни », - говорит мужчина, фирма которого более месяца подряд подвергалась интенсивным проверкам контролирующих органов;

5) произвольная интерпретация - процесс, в ходе которого делаются выводы, не подкрепленные фактами или противоречащие им: «Женщины избегают меня, потому что догадываются о моей половой слабости»;

6) утопические ожидания - нереалистичные представления о себе иди других: «Если бы я встретил идеальную женщину, то смог бы совершать с ней половые акты сколь угодно долго»;

7) персонализация - тенденция связывать внешние события, особенно негативные, с собой, даже когда для этого нет оснований: «Стоит уединиться с женщиной, обязательно кто-нибудь помешает»;

8) противопоставление недостатков достоинствам - тенденция в любом положительном переживании всегда находить отрицательные моменты. Это мышление по схеме: «Да, но…». Например: «Сегодня мне удалось совершить половой акт, но эрекция была не такой, как раньше»;

9) нормативное мышление - убежденность субъекта в том, что все происходящее должно строго соответствовать установленным нормам и правилам: «В моем возрасте следует вступать в половые контакты 2-3 раза в неделю»;
10) перфекционизм - подбор для себя высших из теоретически возможных стандартов и использование их в качестве критерия собственной ценности: «Если я - настоящий мужчина, то могу совершить половой акт в любой обстановке и в любом состоянии»;
11) увековечивание - превращение кратковременных явлений в долговременные: «Я никогда не буду счастлив в браке»;
12) конкуренция - суждение о собственной ценности исключительно путем сравнения себя с другими людьми: «Я слабак в сексе, потому что многие мои знакомые живут половой жизнью гораздо чаще»;

362

13) априорное мышление - выведение фактов из принципов (дедукция) вместо выведения принципов из фактов (индукция): «Если жена ласкова со мной, значит, она пытается что-то от меня получить»;
14) субъективная ошибка - вера человека в то, что он является основной причиной поведения и эмоций других людей: «Я делаю свою жену несчастной»;
15) сверхсоциализированное мышление - излишняя конформность и некритичность людей, бездумно принимающих основные убеждения и предрассудки, характерные для их культуры: «Место женщины - в доме».

Коррекция выявляемых когнитивных ошибок проводится через вопросы, обнажающие суть недостаточно продуманных, порой алогичных и умозрительных интеллектуальных построений индивида. Это способствует более адекватному восприятию себя и имеющихся проблем в интимной жизни, дает понятную рациональную основу для определения возможных путей их решения.

Еще один прием когнитивной терапии - *эмпирическая проверка реалистичности.* Его суть состоит в том, чтобы представить умозаключения пациента в виде проверяемых гипотез, что делает его мышление более объективным и реалистичным. Например, если одинокий пациент утверждает, что все женщины избегают знакомства с ним, совместно с врачом формулируется следующая гипотеза: «Если я попытаюсь подойти и заговорить с понравившейся женщиной, она обязательно проигнорирует меня ». Далее в форме домашнего задания мужчине предлагается в выходной день прогуляться по городу, чтобы на практике подтвердить гипотезу о полном отсутствии к нему интереса со стороны противоположного пола. Он должен заговорить не менее чем с пятью женщинами и попытаться познакомиться с ними. На следующем сеансе пациент обсуждает с врачом результаты проделанного задания. Как правило, реальность опровергает представления мужчины, основанные на единичном негативном опыте, А в ряде случаев, к его большому удивлению, женщины проявляют интерес к продолжению неожиданного знакомства. Это заставляет пациента серьезно усомниться в истинности его прежних убеждений и позволяет с более конструктивных позиций строить дальнейшие отношения с понравившейся женщиной.

363

Для модификации системы убеждений пациента могут также использоваться приемы из арсенала парадоксальной психотерапии (G. Weeks, L. L'Abate, 1986).

Переформулирование (рефрейминг) - изменение точки зрения на ситуацию за счет размещения ее в иной системе координат, в результате чего изменяется значение, изначально приписываемое этой ситуации пациентом. Так, преждевременная эякуляция у пациента может рассматриваться не как свидетельство половой слабости и неспособности удовлетворить женщину, а как проявление сильного сексуального темперамента мужчины, который охвачен столь пылким желанием, что не в состоянии сдерживать стремительно нарастающее возбуждение.

Смена ярлыка (релейбинг) - позволяет изменить феноменологическую перспективу. Новое название может внушать, что симптом имеет определенный смысл и является инструментом позитивных изменений: недружелюбие - продуманный подбор знакомых, черствость - защита себя от обид и разочарований, нерешительность - исследование всех возможностей, импульсивность - способность вести себя спонтанно. Все эти ярлыки несут в себе позитивные

аспекты и отчасти являются правдивыми. Их цель - открыть пациенту новые возможности путем введения противоречий, обладающих большой силой воздействия. Например, мужчина, за которым закрепилась репутация плейбоя, в первую брачную ночь потерпел фиаско. Новобрачная была страшно разочарована и чувствовала себя отвергнутой. М. Эриксон прикрепил импотенции ярлык комплимента. Согласно его интерпретации, красота и сексуальность молодой жены произвели на мужа столь сильное впечатление, что он начал опасаться, что не сможет справиться с ситуацией, что фактически и произошло. Таким образом, пациенту предлагается альтернативный взгляд на проблемную ситуацию, которая предстает в ином, более оптимистичном свете, что и создает предпосылки для улучшения сексуального взаимодействия в дальнейшем.

5.6. Проработка интрапсихических конфликтов

Далеко не все личностные особенности, искажающие восприятие пациентом окружающей реальности и себя са-

мого, могут быть успешно скорригированы на рациональном уровне. Наличие глубинных личностных проблем и интрапсихических конфликтов требуют их тщательного анализа и выяснения бессознательных мотивов сексуальных затруднений. Здесь могут использоваться психодинамические подходы и гипноанализ.

Выявление серьезных внутренних противоречий предполагает *работу с полярными частями личности* (в модели эриксоновского гипноза или НЛП). Ее основной задачей является интеграция конфликтующих частей личности. В частности, сексуальные проблемы, порождаемые тревожным ожиданием очередной неудачи, могут быть представлены таким образом, что становится возможным проработать их более глубинные, личностные аспекты в технике работы с полярностями. Для этого мы условно рассматриваем крайне дискомфортное для мужчины противоречие между страстным желанием близости с партнершей и сильными тревожными опасениями неудачи при коитусе с ней как внешнее проявление метафорического внутреннего конфликта различных частей личности. При работе с полярностями в технике эриксоновского гипноза пациенту предлагают как-то обозначить эти

полярные части личности, дать им название. Например, он выделяет опасающуюся часть, которая боится сексуального срыва, и желающую часть, которая стремится к половому контакту. Далее его просят представить, что эти части размещаются по разным рукам, причем надо дать возможность пациенту самому выбрать, какая рука будет представлять ту или иную часть, а фактически разнопропорциональный негативный и позитивный опыт интимных отношений. Пациент приподнимает перед собой согнутые в локтях и прижатые к туловищу руки, обращенные ладонями друг к другу, удерживая их на весу. Используются техники быстрой индукции транса, чтобы руки не устали раньше, чем войдут в каталепсию. В ходе трансового погружения пациента врач неоднократно подчеркивает: «Сейчас вы передаете рукам возможность узнать и понять что-то важное о себе и о тех частях, опасающейся и желающей, которые представлены на правой и на левой руке... И благодаря различиям в ощущениях или движениях рук вы можете начать осознавать, что означают эти различные части, посылающие столь противоречивые сигналы...

365

И можно даже обратиться к одной из них или обеим с каким-то важным вопросом и понять ответ по изменению характера ощущений в той руке, которая представляет эту часть, или тем движениям, которые она совершает. А возможно, он будет получен в виде образов или внезапно возникшей мысли... Какая-то подсказка, что можно изменить в отношениях этих частей, или даже позволить им договориться между собой... И когда руки двинутся навстречу друг другу, это может свидетельствовать о происходящем контакте частей, обмене информацией... И может быть благодаря этому вы обретаете новые знания, новое понимание имеющихся проблем... И если руки сойдутся, части скажут друг другу «да», и это может означать начало реальных изменений в вашей личной жизни». Каталептическое бессознательное схождение рук в символической форме обозначает некий консенсус, достигнутый между конфликтующими частями личности (В.А. Доморацкий, 2002).

В эриксоновском гипнозе возможен и иной, еще менее директивный вариант работы с полярностями, который не носит завершенного характера, а

скорее является разновидностью техник гипноанализа (А.Ф. Радченко, 2001). В этом случае врач, отслеживая малейшие движения рук, комментирует их через вопросы, активизирующие подсознательные процессы: «И что означает там, на уровне бессознательного, когда ваша рука так осторожно движется, и то направление, которое она выбирает?.. О чем говорит ваша правая рука, которая медленно, как бы нехотя, опускается на бедро?..» Или «разрешите рукам говорить, используя свой особый язык, понятный бессознательному... И потому, что руки обретают сейчас возможность говорить от имени представленных на них частей, вы можете почувствовать, понять истоки своих проблем, а может быть, искать и находить, сейчас или потом, оптимальные пути их решения ». При этом врач избегает каких-либо собственных интерпретаций движений рук пациента, лишь констатируя сам факт таковых, и серией достаточно неопределенных вопросов побуждает его к интенсивной внутренней работе, направленной на поиск новых знаний и новых возможностей решения своих сексуальных проблем. Этой же цели служит широко известная гештальт-терапевтическая техника *двух стульев*, позволяющая получить доступы к тем

частям своего Я, которые ранее не были интегрированы в целостную индивидуальность.

При обращении к внутренним трудностям и интрапсихическим конфликтам пациентов нами также используются элементы глубинно-психологи-ческой символики. Динамика развития имагинативных процессов при представлении образов по технике символдрамы отражает не только глубинные особенности личности, но и соответствует основным стадиям развития либидо, описанным Г.С. Васильченко. С.А. Мартыненко и Я.Л. Обухов (2001) показали, что метод символдрамы, позволяющий через образы-символы получить доступ к неосознаваемому или недостаточно осознаваемому содержанию психики, может использоваться как в целях изучения особенностей формирования либидо у мужчин, так и для психотерапевтической коррекции имеющихся у них глубинных страхов перед проявлениями сексуальности, способствующих возникновению половых дисфункций. Особенно эффективен метод символдрамы у лиц с выраженным образным мышлением. Он также дает возможность работать с пациентами,

испытывающими трудности в выражении своих эмоций и переживаний на вербальном уровне, которым сложно выразить свое внутреннее отношение к женщинам. Чаще всего нами используется мотив «куст розы», предложенный H. Leuner (1980). Мужчину, предварительно погруженного в легкий транс, просят представить куст розы на краю луга, а затем сорвать с него один цветок. Примерно 5 минут пациент исследует образ луга и дает его общую характеристику (размеры луга, характер растительности, погода, время года и время суток). Сценарий луга отражает более или менее осознанное настроение пациента и часто представляет собой плоскость проекций актуальных конфликтов. После этого ему предлагают оглядеться по сторонам и найти куст розы, который обычно представляется на краю луга, а затем дать его развернутое описание. Пациента просят выбрать наиболее понравившийся ему цветок и детально описать, как он выглядит, а также сообщить о причинах своего выбора именно этого цветка. Трудности в выборе конкретного цветка могут быть вызваны недоразвитием платонического компонента либидо. Цвет розы говорит о сексуальной зрелости. Красный, желтый и оранжевый цвета считаются

наиболее сексуальными. Розовые цветы могут символизировать инфантильность, а желтые - ревность. Белый цвет говорит о стремлении к платоническим, духовным отношениям и идеализации женщины, а оранжевый - символ сильной личности, склонной подавлять окружающих. Листья на стебле символизируют витальную силу мужчины, стебель без листьев - ее отсутствие. Сам стебель является символом фаллического начала, опоры, а шипы на нем говорят об опасности, сопровождающей страсть. Если шипов слишком много, то такой человек находится во власти страха и преувеличивает возможную опасность. Если шипов очень мало либо вообще нет, то мужчина излишне легкомысленен и пренебрегает возможными опасностями, связанными с сексуальными отношениями. Далее пациенту предлагается попытаться в воображении дотронуться пальцем до стебля, провести по нему, коснуться шипов, листьев, лепестков розы, вдохнуть ее аромат, а затем рассказать о своих чувствах и ощущениях (таким образом, исследуется эротический компонент либидо). Потом его просят сорвать или

срезать понравившуюся розу, что символизирует сексуальное либидо. Нерешительность пациента, его страх уколоться отражают различные опасения перед половыми контактами. Пациентам, не достигшим стадии зрелой сексуальности, по Г.С. Васильченко, особенно трудно сорвать цветок. Если пациент жалеет розу, которой будет больно, это может говорить о фиксации на платонически-эротической стадии либидо, когда сам коитус рассматривается как нечто постыдное, а партнерша идеализируется. На последнем этапе пациенту предлагается отнести розу в дом и разместить ее там. Мужчина ставит розу в воду и любуется ею. Если он захочет что-то сделать с цветком (подрезать стебель, обжечь его на огне, добавить в воду глюкозу, чтобы роза лучше стояла), это символически характеризует развитие зрелой сексуальности.

Психотерапевтическое воздействие метода символдрамы обусловлено эмоциональным прорабатыванием внутренних бессознательных конфликтов и проблем. Поскольку работа ведется с наиболее глубокими и подлинными переживаниями образов, даже возникающие у пациента негативные эмоции оказывают терапевтический эффект. Поэтому в ряде случаев «символдрама дает возможность

глубоко пережить, проработать и принять то, что при использовании вербально-когнитивных техник психотерапии оставалось бы на поверхностно-понятийном уровне» (С.А. Мартыненко, Я.Л. Обухов, 2001).

Ряд экзистенциально-ориентированных авторов указывают на то, что столкновение человека с экзистенциальными данностями своего существования (смерть, свобода, одиночество, бессмысленность) вызывает сильную тревогу, которая может смещаться и символизироваться проблемами сексуальности (R. May, 1998, I. Yalom, 1999 и др.). Наш опыт также свидетельствует, что в ряде случаев осознание пациентом некоторых очевидных фактов собственного бытия и глубинных страхов способствует смягчению его тревоги перед возможной сексуальной несостоятельностью, что позволяет гораздо успешнее работать с симптомами сексуальной дисфункции и непосредственно связанной с ними, более поверхностной психологической проблематикой. Глубинный страх смерти,

актуализирующийся при столкновении индивида с фактом смерти близких людей или знакомых, нередко приводит к попыткам смягчить его путем активизации половой жизни, гипертрофированного отношения к ней. Сексуальная активность позволяет выстроить мощный бастион отрицающей защиты неизбежной старости и угасания витальных функций (I. Yalom, 1999). Секс - символ жизнеутверждающего начала, потенциально он позволяет продлить себя в своем потомстве. Одновременно сексуальный контакт - проявление максимальной жизненной активности индивида. Поэтому за фасадом конкретного страха перед импотенцией у мужчин нередко можно обнаружить глубинную тревогу перед конечностью бытия.

Сексуальная поглощенность и компульсивность некоторых людей может быть понята через призму экзистенциальной тревоги смерти, от которой они защищаются чередой беспорядочных сексуальных контактов. Психотерапевтическая работа над осознанием смерти может катализировать процесс личностных изменений и помогает легче достичь изменений на поведенческом уровне, в том числе и в сфере сексуального функционирования. Для этой цели используются различные упражнения с последующим обсуждением. Например, пациенту предлагают начертить

отрезок, один конец которого - его рождение, а другой - смерть. Просят поставить крестик, где он находится сейчас, и поразмышлять над этим в течение пяти минут. Или проводят «шоковую терапию», по сути, десенсибилизируя пациента к факту собственной смерти. Ему предоставляется возможность написать на себя некролог. Затем представить свою смерть и последующие похороны с подробным описанием своих фантазий. В некоторых случаях конфронтация со смертью приводит к переопределению жизненных приоритетов, что сопровождается всплеском подавленного сексуального влечения и активизицией половых контактов.

Осознание ответственности (свободы) для многих людей также является источником тревоги. По словам Ж.П. Сартра, «быть ответственным означает быть автором своего жизненного замысла». Избегание ответственности происходит через создание субъективного мира, в котором нет переживания свободы, а есть лишь существование под властью некой

«неодолимой силы». Индивид, охваченный непреодолимой, завораживающей силой сексуального желания, часто снимает с себя ответственность за возможные негативные последствия его реализации как для себя, так и для других людей. «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо», - этой фразой конкретная личная ответственность за свои поступки иногда подменяется их абстрактной биологической детерминированностью. С другой стороны, избегание ответственности в глубинном, экзистенциальном смысле может привести к ее гипертрофии на локальном, поведенческом уровне и, в частности, чрезмерно ответственному и оттого пропитанному тревогой перед возможной неудачей отношению к выполнению определенных сексуальных действий, которые утрачивают свою спонтанность и естественность, нередко вызывая дезавтоматизацию генитальных реакций мужчины. Кроме того, принятие на себя роли «исполнителя супружеского долга» позволяет без излишних хлопот и тревог следовать привычным жизненным путем, избегая столкновения с проблемой личного выбора и необходимостью принимать ответственные решения по радикальному изменению отношений в браке, которые во многих аспектах совершенно не удовлетворяют, но приносят иллюзию устойчивой стабильности и предсказуемости. Поскольку пациенты обычно более или менее осознанно

сопротивляются принятию реальной ответственности свои жизненные затруднения (в том числе и сексуальные), пытаются переложить их на других людей, важно заставить их осознать, каким образом они сами создают проблемы в межличностных отношениях. Наиболее подходящий прием для этого - концентрация на «здесь и теперь». Пациенты склонны воспроизводить в терапевтической ситуации (особенно в ходе групповой психотерапии) те же поведенческие паттерны, что и в реальной жизни. Поэтому концентрация на том, что происходит непосредственно во время психотерапевтической сессии, позволяет врачу прямо указать на неадекватные способы реагирования на других людей, а также помочь пациенту найти им более конструктивную замену.

Столкновение человека с экзистенциальной изоляцией (одиночеством, обусловленным непреодолимым разрывом между субъектом и другими

людьми) вызывает тревогу, которую он пытается рассеять через межличностные контакты. Сексуальные отношения в браке или стабильном партнерстве, создавая иллюзию слияния с близким человеком, в наибольшей степени позволяют избежать пугающего осознания одиночества в этом мире. При этом могут возникать невротические отношения созависимости, когда любое отдаление партнера вызывает сильную тревогу одиночества. В этом случае даже незначительные проблемы в интимной жизни актуализируют страхи индивида оказаться покинутым, никому не нужным, абсолютно одиноким, что в свою очередь влечет за собой нарастание у него сексуальных затруднений.

Другим способом преодолеть чувство изоляции являются беспорядочные половые связи, в которых люди используют друг друга как средство борьбы со своим одиночеством. Бесконечная череда сексуальных контактов служит для них лучшим подтверждением, что в этой жизни они не одиноки. Психотерапевтическая работа с экзистенциальной изоляцией заключается в развенчивании попыток иллюзорных решений пациентом этой до конца неразрешимой проблемы, а также в повышении его способности к продуктивным отношениям с другими людьми.

Отсутствие самоочевидного смысла жизни - еще одна экзистенциальная проблема, с которой так или иначе сталкивается любой человек. Для многих людей вполне удовлетворяющим объяснением их жизненной позиции является

стремление к удовольствию как самоцель. Такой гедонистический подход легко может быть реализован через поглощенность сексуальными отношениями, поскольку они позволяют регулярно испытывать чувственное наслаждение. Некоторые мужчины заполняют все свободное время фантазиями на тему секса и поисками все новых сексуальных объектов. Однако в полном согласии с В. Франклом (1990), «чем больше человек намеренно ищет удовлетворение, тем больше оно ускользает от него». Так, нарушается эрекция у мужчины, который стремится возбудиться как можно быстрее, пытаясь сознательно усиливать непроизвольные механизмы, обеспечивающие его генитальные реакции.

По мнению И. Ялома (1999), «человек ищет смысл и уверенность в мире, не имеющем ни того, ни другого... Эффективный психотерапевт должен помочь пациенту отвернуться от вопроса: "Зачем я живу?". Ибо поиск смысла, как и поиск счастья, возможен только косвенным путем... Нужно переориентировать человека на вовлеченность в жизнь... Вовлеченность - самое эффективное терапевтическое средство: обрести дом, заботиться о других, искать, творить, любить - все это обогащает и является мощным противовесом дисфории бессмысленности».

Очевидно, что в рамках рассматриваемой стратегии интегративной психотерапии фокусировка на экзистенциальных проблемах пациента осуществляется лишь по мере необходимости, а психотерапевтическая проработка ограничивается отдельными их аспектами. Вместе с тем даже краткое, на протяжении нескольких сессий, обращение к базисным проблемам человеческого существования может уменьшить у пациентов проявления глубинной тревоги, способствуя более адекватному отношению к собственной сексуальности и создавая предпосылки для эффективной терапии половых дисфункций.

5.7. Психотерапия нарушений межличностных отношений в паре

Половая функция человека адекватно реализуется в процессе тесного взаимодействия с другим человеком.

372

Поэтому любые нарушения партнерских отношений могут негативно влиять на сексуальное функционирование индивида. По мнению J. Gottman (1994), существуют четыре всадника супружеского апокалипсиса: критика, пренебрежительное отношение, блокирование и защиты.

Исследования подтверждают, что люди, которые несчастливы в браке, намеренно посылают партнерам много враждебных и болезненных сообщений. Они оскорбляют своих супругов, демонстрируют свое презрение с помощью языка тела, едких критических замечаний, высмеивания и

враждебного юмора. Вместо того чтобы говорить о том, что их беспокоит, эти люди переходят к глобальному оцениванию и обвиняют супруга за любые проблемы, возникающие в их отношениях. Ответная реакция на критику и пренебрежение может проявляться в форме ухода или защиты. В первом случае уязвленные партнеры учатся отгораживаться, т. е. они притворяются что супруга не существует (механизм блокирования). Это может принимать крайние формы, когда супруги не реагируют на прямые вопросы или предложения и действуют так, как если бы просьбы вообще не высказывались. Они как бы стирают из своего сознания индивидуальность партнера. Во втором случае используются защитные механизмы: а) отрицание ответственности за свою роль в конфликте (гораздо легче обвинить партнера); б) взаимные обвинения (всякий раз, когда один супруг жалуется, другой выступает с контробвинениями, игнорируя исходную жалобу); в) многократные высказывания одних и тех же идей, выражение согласия с партнером только в форме «да, но...», что нивелирует реальные чувства партнера и вопросы, которые его беспокоят. Оба супруга могут использовать все эти защитные стратегии, либо, например, муж прибегает к защитам (обвиняет, злится, снимает с себя ответственность за супружеские проблемы и т. п.), а жена в ответ замыкается в себе и отгораживается, т. е. использует стратегию блокирования.

О нарастающих проблемах в супружеских взаимоотношениях также свидетельствуют пять следующих диагностических признаков (J. Gottman, 1994):

1. *Переполнение (флудинг).* Формируется такое восприятие партнера, когда его негативные эмоции оказываются совершенно неожиданными, ничем не спровоцированными (кажется, что они возникают из ниоткуда), они подавляют и дезорганизуют, побуждают к прекращению взаимодействия (например, избеганию общения). Женщины в отличие от мужчин более склонны испытывать флудинг.
2. *Ощущаемая серьезность.* Является верным индикатором глубины супружеских проблем.

3. *Дистанцирование*. Если хотя бы один из супругов предпочитает разобраться с существующими проблемами самостоятельно и отказывается принимать участие в терапевтическом процессе, улучшение
взаимоотношений в данной паре прогнозировать достаточно сложно.
4. *Параллельные жизни.* Партнеры сосуществуют параллельно вместо того, чтобы быть интегрированными в единую супружескую систему. У них разные друзья, они принимают пищу по отдельности и не делятся своими каждодневными занятиями друг с другом.
5. *Ощущаемая изоляция*. Партнеры чувствуют себя одиноко даже если находятся в доме вместе («одиночество вдвоем»).

Для улучшения межличностного взаимодействия с партнером используются приемы и техники семейной и супружеской психотерапии. Фокус применения данных психотехник направлен на улучшение взаимной адаптации супружеской пары. Для выполнения этой задачи важно определить основные поведенческие паттерны, приводящие к усилению негативных тенденций в отношениях между супругами и помочь им выработать и закрепить на практике более продуктивные формы общения друг с другом; повысить уровень коммуникации партнеров, что способствует их переходу от конфронтации к сотрудничеству, а также росту взаимопонимания и доверия, открытости в выражении собственных чувств и желаний по отношению друг к другу. Осуществляемая параллельно с индивидуальной психотерапией мужчины, страдающего половой дисфункцией, работа с парой создает очевидные предпосылки для более гармоничного сексуального взаимодействия партнеров.

Если супруги находятся в конфликте, они мало и непродуктивно общаются друг с другом. Видоизменить характер коммуникаций в паре помогает техника *незаконченные*

предложения в модификации А. В. Черникова (1998, 2001). Супругов просят расположиться напротив друг друга и поочередно заканчивать следующий ряд незавершенных предложений: 1. Мне нравится, что ты... 2. Я

расстраиваюсь, когда... 3. Я злюсь, когда... 4. Я благодарен тебе за то... 5. Мы могли бы по-другому...

Эмпирическим путем было выявлено, что оптимальным в такой работе является завершение пяти предложений. Оба супруга должны пройтись по этому списку 3-4 раза, что занимает 15-20 минут и, как правило, не встречает сильного сопротивления. Они получают возможность наглядно убедиться, как легко проявлять негативные чувства по отношению друг к другу и как непросто начать открыто признавать достоинства партнера по браку. Техника стимулирует диалог между супругами, структурируя их общение и делая его более безопасным (формулировки в виде Я-высказываний, сбалансированность в выражении негативных и позитивных чувств, обозначение направления желаемых изменений). Озвучивание позитивных характеристик особенно важно в ситуации супружеского конфликта, когда партнеры обмениваются в основном негативными подкреплениями, провоцируя нарастание ссоры. Прием позволяет обеспечить равный вклад в разговор, сдерживая многословного и поощряя молчаливого супруга. Помимо изменения процессуальных характеристик общения данная техника позволяет исследовать основное содержание взаимных претензий.

Bach and Wyden (1968) предложили для работы с конфликтующими супружескими парами специальный прием - *создание границ при обсуждении конфликта.* Супругам предлагают заранее договориться о времени, когда они смогут обсудить все то, что их беспокоит. Они оба должны перед этим хорошо отдохнуть, поэтому лучше всего подходят вторая половина субботнего или начало воскресного дня. Обсуждение проводится по следующим правилам: 1) затрагивайте только один вопрос и придерживайтесь его; 2) четко объясните проблему (жалобу); 3) покажите, что вы понимаете партнера, как только увидите, что он понимает вас; 4) постарайтесь найти альтернативные способы осуществить желательные изменения; 5) получите обратную связь от партнера; 6) продолжайте

рассматривать альтернативы и получать обратную связь до тех пор, пока не будет найден компромисс.

Хорошие отношения между партнерами во многом зависят от того, насколько точно они воспринимают информацию, передаваемую друг другу. Многочисленные недоразумения нередко возникают из-за того, что люди не-внимательны к высказываниям собеседника. Вместо того чтобы постараться максимально точно понять суть сказанного, супруги предпочитают домысливать слова собеседника, нередко приходя к ошибочным умозаключениям, которые принимаются ими за истину. Поэтому паре, в качестве домашнего задания, мы предлагаем регулярно тренировать важнейший коммуникативный навык - «полноценное, слушанье», которое, по В. Сатир (1983), предполагает соблюдение следующих условий: 1) слушающий полностью сосредоточен на говорящем; 2) слушающий отказывается от любых предубеждений в отношении говорящего; 3) слушающий никогда не пользуется чужими и предвзятыми оценками; 4) слушающий абсолютно свободен от какого бы то ни было смущения и может задавать любые вопросы; 5) слушающий показывает говорящему, что тот услышан и смысл сказанного понят. Пару инструктируют, что в тех случаях, когда соблюдение вышеперечисленных условий по каким-либо причинам невозможно, правильнее перестать притворяться и честно сказать: «Извини, но мне сейчас не до тебя. Я не могу сосредоточиться на том, что ты мне говоришь. Давай вернемся к этому разговору чуть позже» (V. Satir, 1983).

Чтобы обучить партнеров подлинному слушанью вместо домысливания сказанного собеседником дополнительно используется специальная техника *трех положительных ответов* (V. Satir, 1983). Паре предлагается сесть лицом к лицу. Один из партнеров произносит какое-то утверждение, которое представляется ему верным. Например: «Мне кажется, что в комнате жарко», «Я чувствую себя одиноко», «Ты мне не доверяешь» и т. п. Тот, кто слушает должен выразить свою реакцию на высказывание партнера фразой, начинающейся словами: «Ты имеешь в виду, что...», и дальше в вопросительной форме передать как он понял содержание данного утверждения. Цель слушающего - трижды добиться положительного ответа. Это будет означать, что в конце концов он правильно уловил смысл высказывания

говорящего. Если задающий вопросы, неверно интерпретируя фразу, произнесенную партнером, так и не сможет получить три утвердительных ответа, говорящий должен объяснить ему, какой именно смысл он вложил в те или иные слова. Партнеры несколько раз поочередно меняются ролями, стараясь через уточняющие вопросы, как можно лучше понять друг друга. При повторных выполнениях данного задания в паре постепенно растет понимание того, что люди могут вкладывать в одни и те же слова совершенно разный смысл. Осознание этих разных смыслов и означает, что собеседники начинают понимать друг друга. В свою очередь, улучшение коммуникации между партнерами способствует возрастанию доверия и взаимной симпатии.

Известно, что в конфликтных ситуациях партнеры склонны злоупотреблять оценочными суждениями, «навешивая ярлыки» друг на друга. Обоюдонегативные оценки лишь усиливают конфронтацию в паре. Напротив, если партнеры избегают оценок и ограничиваются только описанием своих чувств - они общаются открыто, напрямую. Поначалу им может не понравиться то, что они услышат, но в конечном итоге они гораздо лучше поймут друг друга. Перейти от языка оценок к языку описаний помогает техника *высказывания трех истин* (V. Satir, 1983). Партнеров просят поочередно высказать три истины о другом и три истины о самом себе. Предполагается, что эти истины справедливы только на данный момент. Возможно, в будущем они станут неверными. Чтобы лучше сосредоточиться на собственных чувствах, необходимо начинать каждую реплику со слов: «Мне кажется, что сейчас о тебе можно сказать, что ты…». Если суждение носит негативный характер, следует найти подходящие слова, которые позволят высказаться откровенно и вместе с тем доброжелательно, оставаясь в рамках описания и избегая оценок. Каждый из партнеров сообщает о тех чувствах, которые возникли у него в связи с высказываниями другого. Умение проговаривать не только положительные, но и отрицательные суждения способствует более доверительным и стабильным партнерским отношениям. Паре рекомендуют выполнять данное упражнение не реже одного раза в неделю. Кроме всего прочего, оно вносит в супружеские отношения очень важные представления о гармоничном

общении. Когда один человек откровенно делится своими внутренними переживаниями с другим человеком, в их отношения вносится элемент доверия, и пара переходит от непонимания к близости.

Близость между людьми во многом определяется тем, как они воспринимают прикосновения друг друга. В проблемных супружеских парах существует своего рода запрет на тактильные контакты, возникший на основе предшествующего опыта блеклых, дисгармоничных сексуальных отношений. В этих случаях может быть использовано упражнение В. Сатир (1983) - *техника общения руками.* Вначале партнерам предлагают в течение одной минуты рассматривать друг друга. Затем они должны закрыть глаза, протянуть друг другу руки, максимально сосредоточиться на своих ощущениях и постараться понять, что это означает - чувствовать руки другого человека и одновременно позволять ему ощущать собственные руки. После двух минут такого исследования партнеры открывают глаза и продолжают «встречу руками». Далее им нужно снова закрыть глаза и отметить малейшие изменения в ощущениях. Следующий этап - не открывая глаз, только при помощи тактильного контакта рук партнеры поочередно передают друг другу различные чувства: удовольствие, тревогу, озабоченность, спокойствие, нежность, страсть и т. п. Принимающая сторона по возможности должна идентифицировать сигналы, исходящие от рук партнера, к сообщить, что именно они выражают. Затем руки медленно убирают, оба партнера открывают глаза и обмениваются своими впечатлениями. Выполняя это упражнение, люди начинают осознавать, что их ощущения и переживания очень субъективны и могут быть по-разному интерпретированы. Важно чтобы они поделились тем, что каждый из них испытывал при прикосновениях. Например: «Если я хотел передать любовь и нежность, а ты почувствовала в этом прикосновении грубость и резкость - мне очень важно узнать об этом». Все это способствует лучшему пониманию и принятию друг друга на невербальном уровне. Повысить способность к восприятию тонких тактильных ощущений при эротической стимуляции помогают специальные сексотерапевтические при-ёмы «чувственного фо-кусирования», изложенные далее.

В ситуации острого семейного кризиса, когда супруги испытывают сильные и противоречивые чувства по отношению друг к другу, весьма эффективна техника *прояснения коммуникаций* (А.С. Спиваковская, 1988). Она позволяет организовать конструктивное выражение эмоций, постепенно углубить диалог между супругами, выводя его на уровень Я - высказываний и проговаривания реальных страхов и опасений. По сути, техника прояснения коммуникаций является развитием психодраматической техники дублирования. Хотя в идеале ее использование требует работы двух психотерапевтов, при определенной тренировке техника может осуществляться и одним специалистом. Паре предлагают обсудить любую тему, представляющую обоюдный интерес. Перед началом обсуждения врач говорит: «В ходе беседы я буду периодически прерывать говорящего и кое-что за него формулировать. Если та или иная формулировка не подходит - вы можете меня поправлять...». По мере того как диалог между супругами становится все более и более эмоционально насыщенным, создаются условия для перехода к прояснению коммуникаций. При этом специалист поочередно старается подключиться к эмоциональному состоянию каждого из супругов, озвучить их непроговоренные переживания от первого лица и помочь выразить себя более полно, не прибегая к защитным маневрам. Если такой «перевод» удается, сообщения партнеров становятся более ясными, проявляются скрытые ранее страхи, и супруги постепенно переходят к реальному живому диалогу, все глубже продвигаясь в понимании себя и друг друга. Одновременно происходит их обучение более открытому общению. Врач трансформирует критическое Ты - высказывание супругов («Ты плохой», «Ты меня не любишь») в Я-высказывание («Я испытываю обиду на тебя», «Я чувствую, что ты меня не уважаешь», «Я боюсь, что недостаточно хорош для тебя»). Это позволяет управлять переговорным процессом, сдерживать поток обвинений и взаимных нападок, побуждая пару к все более продуктивному контакту, который способствует росту взаимопонимания и доверия между супругами. Данная техника показана в первую очередь в случаях, когда супруги, конфликтуя, продолжают испытывать сильные взаимные чувства, но избегают открытого обсуждения тех своих

сомнений и опасений, которые реально стоят за чередой бесконечных ссор и обид.

Техника инсценировки позволяет вначале пронаблюдать особенности спонтанного дисфункционального взаимодействия между партнерами непосредственно в ходе приема. Затем, исходя из увиденного, врач создает свой собственный сценарий, который он предлагает разыграть в его присутствии привычным (проблемным для пары) способом. При этом врач может активно вмешиваться в этот процесс, повышая его интенсивность, продлевая время взаимодействия супругов, подсказывая паре возможные альтернативные способы общения друг с другом, позволяющие прийти к конструктивному разрешению ситуации. Фактически пара разыгрывает свою реальность в терапевтическом контексте и при помощи специалиста обучается более продуктивной модели взаимодействия (S. Minuchin, Ch. Fishman, 1998).

Аналитический метод Юрга Уилли (1993) позволяет помочь супругам осознать и с пониманием отнестись к сложным факторам, оказывающим влияние на каждого из них. Вместо того чтобы фокусировать свое внимание на взаимодействиях между супругами, метод сосредоточен на работе с каждым из партнеров отдельно, но в присутствии другого. Ставятся задачи вербализировать и понять конструкции, которыми человек руководствуется в своем поведении, выявить ригидный или амбивалентный характер этих конструкций, побудить каждого из супругов к созданию новых способов мышления и представлению проблем пары на концептуальном уровне. Необходимо выявить и разобрать как диспозиционные факторы (неизменные личностные особенности, влияющие на поведение человека), так и важные ситуационные факторы (объясняющие причины определенного поведения с позиций внешнего стресса и кратковременных состояний человека).

Процесс начинается с того, что терапевт говорит: «Сегодня я хочу, чтобы мы разобрали некое событие последних нескольких дней. Было ли в том, что вы недавно пережили, что-то такое, что обеспокоило или затронуло бы вас обоих?» После выявления конфликта терапевт пытается получить конкретные факты этого инцидента и восстановить последовательность событий. Затем терапевт начинает

анализировать то, о чем думал каждый человек на каждом этапе этого инцидента.

Пациенты поначалу обычно рассказывают врачу, что они чувствовали, а не то, что думали. Тогда их можно спросить: «Если бы эти чувства могли говорить, что бы они сказали?» Важно подтолкнуть супругов к тому, чтобы расширить свои внутренние голоса и темы. Затем следует задать вопросы, подтверждающие противоположные мысли, которые возникают у супругов в одно и то же время. Например, мужчина может заметить, что когда его жена собирается в гости, у него возникают мысли о том, что на самом деле она могла бы и лучше выглядеть и что ее внешний вид свидетельствует о том, что ей совершенно наплевать на него. Она относится к такому типу людей, которые во всем проявляют небрежность. Затем терапевт может спросить этого мужчину, не говорила ли какая-то другая его часть совершенно противоположное. Например, что его супруга на самом деле хочет выглядеть привлекательно, но что-то мешает ей; она хотела бы сделать своему мужу приятное, но чувствует себя неуверенно и напряженно, потому что он постоянно делает акцент на ее внешности.

Врач поощряет клиента облекать в слова все разнообразные и противоречивые мысли об этом сценарии, а не только ту первую мысль, которую выбрал клиент, чтобы поделиться ею с терапевтом. Таким образом, многие клиенты легко подходят к осознанию сложных и амбивалентных мыслей, которые у них возникают.

Некоторые люди одномерны в своем мышлении. У них нет детально разработанных концепций, даже когда их побуждают к этому. Тогда человека можно подтолкнуть к тому, чтобы он пробовал мыслить иначе, попросив его ответить на вопрос: «Если бы вы чувствовали совершенно противоположное тому, что вы ощущали в действительности, то какие мысли могли бы у вас возникнуть после того, как ваша жена вышла за дверь?»

Цель этих сессий состоит в выявлении альтернативных реалий и реалий, которые определяются многими факторами. Когда темы повторяются и расширяются, когда меняется формулировка этих тем, то направляющие философские принципы экстернализуются для того, чтобы все могли руководствоваться ими и/или высказывать о них свои суж-

дения. Благодаря этому методу каждый супруг слышит то, что переживает его партнер, без ограничений во времени и препятствий. Каждый начинает понимать точку зрения другого, что бывает невозможно сделать, потому что обычно этому препятствуют враждебные остроумные ответы, прерывания или физические уходы. Анализируя индивидуально созданные системы, партнеры начинают признавать свои собственные разногласия, и у них начинает возникать большее взаимное уважение.

Самое важное, что партнеры достаточно много времени затрачивают на обдумывание того, что они прибегают к ситуационной атрибуции в беседе со своими супругами. Диспозиционные атрибуции уже не возникают; напротив, они представляют собой одну из многих составляющих, объясняющих причины того, почему партнер действовал именно так. Подобным образом ситуационные атрибуции того, кто говорит, украшаются через какое-то время некоторыми диспозиционными атрибуциями. Таким образом, пара на уровне игры развивает общее поле, которое позволяет им понять и разрешить конфликтные ситуации.

Для выявления ценностей, влияющих на супружеские отношения, применяется прием *сравнение ценностей* (H. H. Ployd, 1982). Техника основана на системном подходе, который исходит из того, что любые отношения в супружеской паре могут быть рассмотрены целостно. С ее помощью выявляются ценности и социальные роли каждого из супругов, влияющие на отношения между ними, а также предоставляется возможность получить доступ к проблемам, сходствам, различиям и взаимодополняющим позициям, существующим в данной паре.

Супругам предлагают поразмыслить о том, что является наиболее значимым в их жизни. Каждый должен дома приготовить два списка личностных ценностей. Один список - собственные ценности, другой - ценности партнера. Ценности размещают в порядке их важности, причем не существует никаких ограничений по содержанию ценностей и их количеству. До новой встречи с врачом пару просят не обсуждать составленные списки. На следующей сессии партнерам предлагают прочитать их вслух, а затем для удобства сравнения списки мужа и жены заносят на один лист бумаги. Пока пара сравнивает представленные

списки, врач может подумать над следующими вопросами: возможный источник ценностей каждого, противоречия между списками и внутри каждого списка, различия и сходства в их содержании, правильно ли супруги воспринимают ценности друг друга и т. д. Затем пару просят рассказать о своих впечатлениях от знакомства со списками. При этом актуализируется целый ряд обоюдоважных проблем, подлежащих обсуждению. Например, может оказаться, что важность семьи для мужа не замечается женой или что ни один из супругов не отдает себе отчет в том, насколько важны интимные отношения для другого. Анализируются общие интересы и увлечения, причины невнимания к тому, что представляется наиболее значимым для другого, связь восприятия ценностей партнера с собственными ценностями.

Техника позволяет помочь супругам в эффективном общении друг с другом, прояснить подозрения по поводу того, что кто-то кого-то не ценит, кто-то кем-то манипулирует. Она дает информацию о внутрисемейных взаимоотношениях, особенностях межличностного восприятия и степени сбалансированности супружеской системы.

Если пара «погрязла» во взаимных претензиях и представляет проблему неудовлетворительных взаимоотношений таким образом, что один или другой партнер делает что-то не так, либо, наоборот, не делает то, что необходимо, весьма эффективная стратегия работы - использование модификации техники *вечеринка частей* (V. Satir, 1983). Супругам разъясняют, что у каждого человека имеется множество различных граней личности, которые так или иначе проявляются при взаимодействии с другими людьми. Затем партнеров просят взять по четыре чистые бумажные карточки, на которых следует указать название ролей (черт характера), наиболее часто проявляющихся у каждого из них при взаимном общении. Например, сексуальность, требовательность, отзывчивость и т. п. Рядом с подписью рисуется некий символ, характеризующий эту роль или черту характера. Затем происходит сличение и выяснение того, какие грани (роли, качества) совместимы, какие конфликтны, а какие дополнительны. По ходу обсуждения врач задает уточняющие вопросы: «А что это за роль? Когда она проявляется наиболее отчетливо? Что этому способствует?» Как правило, человек охотно предъявляет свои по-

зитивные роли или черты характера, а попытки партнера заострить внимание на его негативных качествах вызывает сопротивление, проявляющееся отрицанием таковых и выражением крайнего недовольства по поводу «беспочвенных» претензий. В такой ситуации задачей врача является немедленное переопределение этой роли позитивно. Такая переоценка позволяет представить определенные аспекты проблемного поведения в другом, более выигрышном свете. Целью положительного переопределения не является отрицание проблемы или ее минимизирование. Специалист просто помогает обнаружить, а иногда и прямо указывает на те или иные аспекты роли или качеств характера одного из супругов, которые были ранее заслонены негативными эмоциями и предубежденностью другого. Например, одна из характеристик, которые дает жена своему мужу: «чурбан бесчувственный». Врач должен подвести пару к позитивному переопределению этой роли. Это разговор на тему о том, что мы всегда делаем что-то полезное для себя. Жену можно спросить: «А в каких ситуациях это качество помогает вашему мужу?» Ответ: «Твердость характера и отсутствие сентиментальности помогает ему преодолевать жизненные трудности, защищаться, успешно заниматься своим делом». Далее на карточке под «чурбаном бесчувственным» полезно подписать его переопределение. Затем партнера просят «навесить свой ярлык» на то, что женщина назвала «чурбаном бесчувственным». При таком подходе возможно привести партнеров к согласию даже по поводу тех их качеств, которые изначально они в себе полностью отвергали. В заключение проводится обсуждение того, что сближает супругов друг с другом, а что, наоборот, отталкивает, какие качества им следует держать под контролем при совместном общении. Причем каждый из них выдвигает свою версию, а врач помогает паре прийти к общему знаменателю и тем самым обеспечить определенный баланс в супружеских взаимоотношениях.

В приеме *создание аналогичных ситуаций* используются метафоры для того, чтобы эффективно войти в партнерскую систему и в игровой форме «отщепить» от нее стойкие дисфункциональные паттерны (A.Y. Napier, C.A. Witaker, 1987), Получив ясное представление о трудностях супружеской пары, врач выбирает для беседы си-

туации или виды деятельности, отражающие проблемы партнеров, но в то же время не вызывающие излишнюю тревогу. Так, если жена высказывает претензии, что муж не обращает должного внимания на ее сексуальные потребности, игнорирует их, паре может быть предложена история, где супруги заняты совместным приятным времяпровождением, в той или иной мере напоминающим сексуальное взаимодействие, но более легким для открытого обсуждения. В подобных случаях М. Эриксон подолгу говорил с супругами о принятии пищи, когда за накрытым столом сидят только они вдвоем. Он касался вопроса о большом разнообразии в привычках и поведении людей во время еды. Одни долго раскачиваются, начиная с закусок и засиживаясь перед тарелкой с супом, тогда как другие сразу же съедают первое, а затем немедленно приступают к мясу с картофелем. Эриксон мог сказать о том, «как гармонично некоторые мужья могут дополнять своих жен за обеденным столом». Если супруги начинали связывать «обеденную тему» с сексуальными отношениями, он переводил их внимание на что-либо другое, а затем вновь возвращался к этой аналогии. Преследуемая цель - бессознательное связывание конфликтов в отношениях между супругами и кулинарной темы. Затем Эриксон давал им домашнее задание пообедать вместе так, чтобы каждый из супругов получил от еды максимум удовольствия и стимулировал аппетит другого. При этом сформулированная ассоциативная связь способствует получению парой большего удовлетворения не только от обеда, но и от сексуальных отношений. Использование подобных метафорических сообщений (аналогий) в супружеской терапии побуждает пару искать новые формы общения с партнером по браку. Недирективность данной техники минимизирует вероятность сопротивления или восприятия ее супругами в качестве угрозы их личным интересам.

Нами применяется еще одна метафорическая техника - *супружеская хореография*, направленная на фокусировку супругов на ведущей проблеме в отношениях между собой (P. Papp, 1998). Партнеров просят обратиться к своей фантазии и мысленно представить друг друга в некой символической форме (растением, животным, сказочным героем и т. п.). Затем им предлагают точно так же представить са-

мих себя в виде некой символической фигуры или образа. Следующий шаг - нарисовать в воображении возможное взаимодействие между этими образами. Далее по очереди партнеры излагают свои фантазии вслух и, привлекая другого, создают «скульптурную композицию», в символической форме отражающую их видение особенностей взаимоотношений в паре. Врач через вопросы, обращенные к автору «скульптуры», проясняет ее глубинный смысл, пытается найти тупик, в который зашли партнеры в своих попытках решить проблему, а также переопределяет ее, придавая проблемному поведению супругов иное значение. Как и любой терапевтический прием, построенный на метафорах, данная техника позволяет эффективно обойти сопротивление и через символические образы получить важную информацию о реальной супружеской ситуации, наметить возможные пути к ее изменению в позитивную сторону.

Бихевиоральные техники супружеской терапии при наличии в паре хотя бы минимальной установки на восстановление нарушенных взаимоотношений довольно быстро приводят к позитивным изменениям. Они построены на выполнении супругами определенных, заранее оговоренных взаимных обязательств.

Одна из наиболее популярных и эффективных методик поведенческой супружеской психотерапии - *конструктивный спор* (St. Kratochvil , 1991). Его суть заключается в том, что супругам предоставляется возможность открыто и, не травмируя друг друга, обмениваться информацией об имеющихся трудностях во взаимоотношениях, осознаваемых и подавляемых чувствах и желаниях, противоречиях в исполнении супружеских функций. Правила конструктивного спора: 1) для его проведения необходима отдельная комната и отсутствие эмоционально заинтересованных свидетелей; 2) спор должен начинаться как можно ближе ко времени возникновения конфликтной ситуации; 3) инициатор спора должен сообщить партнеру, о чем пойдет речь и о своем намерении спорить; 4) спор должен быть конкретным, имеющим цель совместными усилиями решить проблему, а не наказать партнера. Основные характеристики конструктивного спора: а) реализм; б) конкретность; в) открытость; г) честность; д) ответственность; е) юмор;

ж) акцент внимания участников на обратную связь. Участники соблюдают правила «честной игры»: высказывания их отражают чувства в ситуации «здесь и теперь»; они воздерживаются от обобщений типа «ты всегда не слушаешь», от актуализации прошлых обид и злости, аргументов, направленных на «слабое» место партнера (вес тела, внешность, дефекты речи и др.), от критики родственников («ты такая же глупая, как и твоя мать...»); пользуются безоценочным языком.

Выделяют три фазы спора: вводную (А), среднюю (В), финальную (С), а также ряд правил для проведения каждой фазы. Правило фразы А: «Дай знать, что хочешь спорить, и назови предмет спора»; фазы В: «Скажи, что думаешь о поведении партнера, отреагируй и критикуй»; фазы С: «Признай свои ошибки и найди положительное в партнере». Продолжительность спора не превышает 10 - 15 минут. На финальную фазу отводится 1,5-2 минуты. Партнеры завершают спор пожатием рук. Вначале супружескую пару обучают приемам конструктивного спора во время психотерапевтической сессии. Причем врач проводит оценку стиля спора по четырем параметрам (конкретность, вовлеченность, коммуникация, «честная игра»), а также его результатов (информативность, отреагирование, сближение, улучшение). По каждой из восьми указанных позиций супругам начисляют 4-1; 0 или - 1 балл, в результате чего наивысший показатель для пары + 8, а наименьший - 8. Набранная сумма баллов позволяет участникам спора узнать особенности стиля своего спора и его результативность, являясь фактором подкрепления позитивных образцов супружеского взаимодействия.

Достаточно простая, но весьма эффективная процедура - техника *семи основных правил*, которая заключается в обсуждении с супругами каждого из следующих пунктов (A. Lasarus, 2000):

1. Никогда не критикуйте; предлагайте конкретные изменения в поведении супруга.

2. Никогда не занимайтесь измышлениями (т. е. не говорите за другого человека, что он думает или чувствует).

3. Остерегайтесь говорить: «Ты всегда...» или «Ты никогда...». Говорите о конкретном случае.

4. Избегайте категорий правильно/неправильно, плохой/хороший. Когда возникают разногласия, ищите компромиссное решение.

5. Используйте сообщения «Я чувствую...» вместо сообщений «Ты...». Например, скажите: «Я чувствую обиду, когда ты меня игнорируешь!», а не говорите: «Ты эгоист и совсем меня не замечаешь».

6. Будьте откровенны и честны. Говорите, что думаете, и думайте, что говорите.

7. Я в порядке, ты в порядке. Я имею значение, ты имеешь значение.

Затем супругам дают копии этих правил с тем, чтобы они почаще в них заглядывали и строили свои отношения, руководствуясь ими.

Специалисты по бихевиоральной терапии определяют супружеские конфликты как проблему несбалансированного или редкого подкрепления. Когда супруги посылают друг другу очень мало положительных сигналов и пытаются манипулировать друг другом с помощью отрицательных приемов взаимодействия, их отношения будут совершенно неудовлетворительными. Причем большинство таких пар склонны обвинять друг друга в сложившейся ситуации, демонстрируя свою беспомощность в достижении какого-либо прогресса во взаимоотношениях. Поэтому целью использования бихевиоральных техник в супружеской терапии является изменение дисфункциональных поведенческих паттернов супругов, обучение их конструктивному сотрудничеству и практике позитивного поведения. В основе последнего лежат позитивные обмены, которые представляют собой активную деятельность, направленную на поддержку и принятие партнерами друг друга, ведущую в конечном итоге к взаимному удовлетворению (N. Jacobson, G. Margolin, 1977).

J. Gottman (1994) на основе обширного исследования супружеских пар обнаружил так называемое «магическое соотношение 5:1». Он выявил, что пока во взаимоотношениях мужа и жены в пять раз больше положительных чувств и взаимодействий чем негативных, брак, вероятно, будет стабильным. Таким образом, в идеале на каждый коварный взгляд или замечание должно приходиться пять улыбок, шуток, комплиментов, поглаживаний. Готтман пришел к выводу, что это соотношение оказывается верным для трех

различных стилей коммуникации. На одном полюсе существуют «переменчивые пары», брак которых отличается прочностью и стабильностью, даже несмотря на то, что их стиль общения характеризуется очень высокими уровнями позитивного и негативного влияния. В таких карах супруги отпускают в адрес друг друга много критических замечаний, равно как и много комплиментов на вербальном и невербальном уровнях. Это очень экспрессивные пары, общение в которых (включая любые замечания и попытки убеждения) проходит живо, громко, с открытым выражением чувств, юмором и любовью. В переменчивых парах супруги ценят свою индивидуальность, и им необходимо иметь свое собственное пространство, причем как физическое, так и психологическое. Иногда создается впечатление, что они буквально погрязли в конфликтах, но при этом не теряют ореола романтики и по-прежнему полны страсти. Таких супругов отличает эгалитарность и андрогинность (Fitzpatrick, 1988). На другом полюсе мы имеем «неконтактные пары», браки которых также очень стабильны, даже несмотря на то, что их стиль отношений характеризуется очень низкими уровнями позитивного и негативного влияния. В неконтактных парах представлены люди, которые при обсуждении конфликтных ситуаций всегда стараются найти что-то общее и минимизировать важность открытого выражения различий. Они считают, что время примирит их, и что проблемы имеют обыкновение разрешаться сами собой, и нет необходимости их обсуждать.

Промежуточное место между ними занимают «валидаторы». Они выражают непосредственные уровни позитивного и негативного влияния. Многие их обсуждения характеризуются легким и спокойным взаимодействием, но при обсуждении важных вопросов может возникнуть конфликт. Обычно один супруг подтверждает то, как другой описывает проблему: он кивает, обращает на что-то внимание, задает вежливые и интересные вопросы. Иногда человек проявляет эмпатию и дает партнеру знать, что он может понять его видение конфликта. Это оценивание имеет место даже тогда, когда супруг не соглашается со словами своего партнера. Обычная для них атмосфера - это совместная работа над решением общей проблемы. Валидаторы делают больший акцент на «мы», чем на индивидуальные цели.

389

Они разделяют физическое и психологическое пространство, равно как и свои ежедневные обязанности. Работа Готтмана разрушает миф о том, что стабильные браки могут быть только у «валидаторов». Он показал, что переменчивые и неконтактные браки так же стабильны, если супругам удается удерживать соотношение 5:1 (пропорция позитива и негатива). Этой информацией полезно поделиться с супружеской парой с последующим обсуждением реальной ситуации в их семье. Необходимо побуждать пару к действиям, направленным на достижение «магического соотношения». J. Gottman (1994) для улучшения брака рекомендует использовать четыре важных стратегии. Кратко они могут быть представлены следующим образом:

1. *Успокоиться* - это означает, что проблема не будет решена эффективно, когда человек расстроен.
2. *Говорить не прибегая к защитам.* Защитный стиль проявляется тем, что человек высказывает бесконечные претензии, цепляется к другому, злится на него и т. д.).
3. *Подтверждать ценность своего супруга,* т. е. говорить, слушать и показывать партнеру, что вы понимаете его слова. Акцент делается на том, как человек реагирует на эмоциональное состояние своего партнера. Это может выражаться в извинениях, комплиментах, признании его чувств и принятии на себя ответственности за то, что другого человека что-то беспокоит или расстраивает.
4. *Постоянное обучение* - эта стратегия включает в себя регулярную работу по улучшению брака и попытки найти новые способы коммуникаций и оптимального взаимодействия, когда после каждой конфликтной ситуации партнеры стараются не прибегать к защитам и подтверждать ценность друг друга.

Одна из самых серьезных причин, связанных с коммуникативными проблемами а браке, состоит в том, что в настоящее время пары имеют слишком мало времени для общения, хотя у них возникает множество важных и интимных вопросов, требующих совместного обсуждения. На

сегодняшний день к наиболее интимным и эмоционально связывающим типам бесед, происходящих с любой ча-

390

стотой, относят *дебрифинг.* В ходе такой беседы каждый партнер рассказывает о том, что произошло за день. Было установлено, что партнеры, которые имели обыкновение вести друг с другом подобные беседы, имели более высокую удовлетворенность браком (Vangelisti, Banski, 1993). Поэтому одним из эффективных приемов изменения характера общения между супругами является предложение выделить время на то, чтобы вспомнить и обсудить друг с другом испытания, неудачи и радости, которые были в течение дня. Проведение дебрифингов является одним из самых простых путей для того, чтобы супруги могли каждый день подтверждать друг другу, что они обеспокоены и заинтересованы тем, что происходит в жизни каждого из них. Общение в подобной форме служит прекрасным переходом от роли работника и коллеги к роли любовника и друга. Продолжительность дебрифинга в зависимости от ситуации может варьировать от 1-2 минут до часа и более, но чаще такой разговор занимает от 15 до 30 минут.

Для повышения удовлетворенности браком широко применяют специальный поведенческий прием - *двойственный договор.* Договор представляет собой письменное соглашение между супругами, направленное на подкрепление положительного поведения. Основной упор в этом соглашении делается на укрепление положительного поведения (практике позитивных обменов), а не на устранение отрицательного. Такая расстановка акцентов связана с тем, что трудно заметить и подкрепить отсутствие каких-то поступков. На принципе взаимных договорных обязательств основан целый ряд бихевиоральных техник супружеской терапии. Если супруги погрязли в рутине семейных отношений, мало и неэффективно взаимодействуют друг с другом, мы используем один из вариантов «двойственного договора» - технику *тройного увеличения* (A. A. Lasarus, 2000). Каждого из супругов просят составить список из трех видов поведения, которые он или она хотели бы, чтобы их партнер делал чаще. При этом им объясняют, что просьба изменений в позитивных терминах (увеличения, а не снижения) - более конструктивна. Вместо фразы: «Я бы хотел, чтобы ты прекратила грызть свои ногти, потому что твои руки выглядят просто отвратительно», лучше сказать: «Я бы очень

хотел, чтобы ты отрастила ногти, так твои руки будут выглядеть более красивыми».

391

Составляя свои списки, большинство людей выражает свои пожелания слишком обобщенно. «Я бы хотела, чтобы он стал внимательнее и заботливее». Супругам предлагают заменять такие неопределенные предложения на более конкретные. Затем обсуждается каждый пункт, чтобы выяснить насколько он приемлем для другого партнера. Если нет - пункт изменяется. Когда супруги соглашаются с обоснованностью каждой просьбы, фокус перемещается на их практическую реализацию. Уточняется как часто готовы он и она идти навстречу пожеланиям друг друга. После завершения переговоров каждый из партнеров расписывается в своем листе обещаний, обязуясь скрупулезно выполнять пункты договора. Основное достоинство этого метода состоит в том, что он учит шести важным видам поведения, которые входят в супружеский сценарий, повышая общий уровень удовлетворенности браком.

Лучшему пониманию потребностей и желаний друг друга в супружестве способствует техника *прояснения взаимных ожиданий,* также построенная на бихевиоральных принципах «двойственного договора» (S. Wolen, R. DiGusepp, R. Wessler, 1997). Супругам предлагают подумать о том, каких изменений в отношениях они бы хотели, а затем составить собственные списки ожиданий и предложений. Каждый из них делит лист бумаги на две части: справа указываются свои ожидания от партнера, а слева - то, что ему можно предложить взамен. В ходе выполнения этой техники врач выступает как регулятор ситуации. Иногда, перебивая партнеров, он может вскрывать их манипуляции, стимулируя пару к ясному и прямому изложению взаимных ожиданий. Достигнутая договоренность фиксируется на бумаге, причем вначале каждый из супругов пишет свой текст, а затем они обмениваются этими проектами «супружеского соглашения». После обсуждения и уточнения некоторых пунктов взятых на себя обязательств супруги составляют совместное соглашение, которое остается у врача. Если заключенный контракт выполняется, у супругов, измотанных

взаимными упреками и обидами, появляется реальный шанс изменить свое поведение, начать делать пусть маленькие, но конкретные шаги навстречу друг другу. Если обязательства не выполняются, это подлежит совместному обсуждению с парой во время очередной психотерапевтической сессии. Врач вы-

ясняет возможные причины несоблюдения контракта, в него вносятся уточнения, после чего супругам предлагают прийти к новому, более конструктивному соглашению.

В случае выраженного сопротивления изменениям в семейной системе нами используются парадоксальные интервенции (G. Weeks, L. L'Abate, 1986). Применяя стратегии, базирующиеся на сопротивлении, врач предполагает что пациент и его супруга взбунтуются против парадоксальной директивы. Специалист, желая чтобы задание не было выполнено, сообщает о неизбежности возникновения проблемной ситуации, тем самым побуждая пару оказать врачу противодействие, что и помогает предотвратить нежелательное событие. Например, супруги, которые часто ссорятся, получают указание делать это еще чаще. Им предлагают следующее обоснование: 1) даже если они очень постараются, то все равно не смогут избежать ссор; 2) они слишком любят ссориться, чтобы отказаться от этого; 3) они признанные мастера в искусстве ссор и не должны «зарывать» свой талант; 4) ссоры являются для них выражением любви, окрашенной в садомазохистские тона и т. д. Следует выбрать такое обоснование, которое просто невозможно принять, что служит для пациентов мотивацией к протесту и фактическому отказу от дезадаптивных форм поведения. Другая стратегия этого типа - рекомендация очень медленного темпа изменений в супружеских отношениях. Например, когда врач информирует партнеров о том, что они пока еще не готовы полностью отказаться от ссор и поэтому в течение будущей недели им следует «организовать» по крайней мере, три ссоры. Общая цель интервенций, базирующихся на сопротивлении, - спровоцировать пациента и его супругу на борьбу с врачом, а не друг с другом, что само по себе сплачивает их и влечет за собой позитивные перемены во взаимоотношениях.

В супружеской терапии также могут использоваться процедуры когнитивной терапии. А. Бек перечисляет девять стадий процесса консультирования супружеской пары; некоторые из них могут проходить параллельно (Беек, 1989).

1. Идентифицировать негативные эмоциональные реакции, определить ситуации, вызывающие их, и подойти к признанию того, что автоматические мысли связывают эмоции с ситуацией.

2. Представить себе сцену, в которой данные реакции имеют место, идентифицировать автоматические мысли и записать их.
3. Практиковать идентификацию автоматических мыслей, например, таких как: «Ему на меня наплевать», «Я ничего не могу сделать по-человечески» или «Она постоянно предъявляет ко мне претензии».
4. Воскресить в своем воображении неприятное событие и идентифицировать свою автоматическую мысль.
5. Спросить себя, насколько оправданной является данная мысль, есть ли подтверждающие её фактические свидетельства, существуют ли факты, свидетельствующие об обратном, и возможны ли альтернативные объяснения произошедшего.
6. Поискать рациональное объяснение имевшего место поведения, которым можно заменить автоматическое объяснение. Так, например, «Ему на меня наплевать» может превратиться в иное: «Он не обращает на меня особого внимания, когда ему нужно отдохнуть, но в другое время он проявляет обо мне заботу».
7. Проверить данное объяснение. Например, муж считает, что жена к нему безразлична, потому что она его больше не любит. На рациональном уровне он может спросить себя (стадия 6): «А не вызвана ли ее реакция тем, что я недостаточно внимателен к ней; возможно, она не видит проявления достаточного интереса к ней с моей стороны».
Он может проверить это предположение, поинтересовавшись у жены, что ее волнует, и предложив ей свое участие.
8. Реструктурировать ситуацию: реинтерпретировать как положительную характеристику то, что воспринималось в негативном свете. Например, то, что жена воспринимала как критику

со стороны мужа, может быть реинтерпретировано как конструктивные предложения.

9. Пытаться классифицировать свои искажения на поляризацию (все или ничего), сверхобобщения (вы-

воды на основании лишь отдельных наблюдений), туннельное видение (выхватывание отдельных деталей из многопланового события), персонализацию (тенденция считать себя причиной негативного поведения, я то время как за него ответственны другие факторы), навешивание негативных ярлыков (приписывание негативных характеристик человеку, а не совершенному им действию). Такая классификация помогает человеку опознать свои неверные интерпретации и преувеличения, касающиеся поведения супруга.

5.8. Коррекция дисгармоничного сексуального взаимодействия в паре

Неадекватное сексуальное поведение одного или обоих партнеров может быть устранено путем повышения их информированности о психофизиологических и технических нюансах сексуальных отношений. В необходимых случаях специалист должен разъяснить паре, что гармоничные интимные отношения определяются умением понимать желания партнера и адекватно выражать собственные сексуальные потребности в общении с ним. Гармония в половой жизни зависит от хорошей психологической совместимости и возникает при взаимной сексуальной адаптации партнеров, часто требующей обоюдной гибкости и своеобразной «притирки», ибо далеко не всегда то, что очень нравится одному, изначально вызывает такой же восторг у другого. Вместе с тем если пара стремится к взаимоудовлетворяющим сексуальным отношениям, партнеры могут

попеременно «солировать»: быть то дающей, то принимающей ласки стороной. Кроме того, при регулярном позитивном подкреплении те эротические ласки или позиции коитуса, которые поначалу казались малопривлекательными, со временем нередко начинают вызывать все больший чувственный отклик. Таким образом, при наличии в паре взаимных претензий к техническим нюансам половых контактов очень важно прояснить индивидуальные сексуальные предпочтения партнеров, обсудить с ними о бою до приемлемые варианты интимных от-

ношений и выработать наиболее подходящую в данном случае модель сексуального взаимодействия.

Важную роль в повышении сексуальной адаптации пары играет *библиотерапия*. Партнерам предлагается специально подобранная литература, откуда они могут почерпнуть недостающие сведения, получить более полные и адекватные представления о человеческой сексуальности, найти для себя наиболее приемлемую модель поведения в ситуациях интимной близости. Следует подчеркнуть, что среди имеющихся в настоящее время на книжном рынке многочисленных популярных изданий, посвященных различным аспектам сексуальных отношений, далеко не все формируют у читателя реалистичную картину половой жизни людей, навязывая подчас весьма субъективные и искаженные представления об оптимальном интимном взаимодействии. Обычно мы рекомендуем пациентам следующие книги: К. Имелинский «Психогигиена половой жизни» (1972); М. Яффе, Э. Фенвик «Секс в жизни мужчины» и «Секс в жизни женщины» (1990); У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Колодны «Мастерс и Джонсон о любви и сексе» в двух частях (1991); А. Комфорт «Радости секса» (1992); С. Квиллиам «Секс в вашей жизни» (1998). Специальные *обучающие видеофильмы* также позволяют супругам расширить репертуар интимного взаимодействия. В частности, паре можно порекомендовать совместный просмотр видеопрограммы, разработанной сексологами Х. Ликинс и М. Пэри «Секс - удовольствие на всю жизнь» в двух частях (1998). Данная программа предлагает ряд технических приемов и упражнений, которые способствуют повышению взаимной удовлетворенности партнеров половой близостью.

Совместное выполнение *сексотерапевтических упражнений* является важным фактором развития у пары способности открыто говорить о своих сексуальных желаниях и реализовывать их в интимном контакте (J. Bancroft, 1985; K. Hawton, 1993). Для улучшения сексуальной адаптации супружеской пары применяются приемы поведенческой терапии, объединенные в единую программу, которая состоит из ряда последовательных ступеней (C. Kelly, 2000):

1. Научение тому, как при несексуальных прикосновениях и массаже получать наслаждение от тела партнера и расслабляться.

2. Легкая генитальная стимуляция, которая должна быть для партнера приятной, но не вызывать у него сильного полового возбуждения и оргазма.
3. Обучение тому, как объяснить друг другу, какие формы стимуляции являются для каждого из партнеров наиболее эффективными и выработка умения физически помогать при их осуществлении.
4. Использование специальных упражнений, направленных на устранение дисфункциональных привычек и выработку модели сексуального взаимодействия, которая приятна обоим партнерам и удовлетворяет их.

Для осуществления первых трех из перечисленных выше задач паре рекомендуются различные виды упражнений, нацеленные на то, чтобы партнеры научились доставлять друг Другу физическое удовольствие. Это - приемы *чувственного фокусирования*, которые позволяют парам выработать с помощью партнера и оценить ощущения, привносящие в интимные отношения чувство физического наслаждения (H. S. Kaplan, 1987). Первая фаза чувственного фокусирования включает негенитальные прикосновения в виде массажа и поглаживаний, которые поочередно совершают партнеры. Иногда это дает возможность паре впервые по-настоящему насладиться физической близостью, не испытывая напряжения, возникавшего ранее при сексуальных контактах. Во второй фазе допускается легкая генитальная стимуляция и ласки, не переходящие в прелюдию полового акта. Партнеры

должны просто получать наслаждение, а в случае возникновения сексуального возбуждения дать ему возможность незаметно исчезнуть. Заключительная фаза обычно состоит из каких-то направляющих действий, при помощи которых один партнер показывает другому, какой вид стимуляции является для него оптимальным. Партнеры принимают обоюдоудобную позу, и один из них помещает свою руку поверх руки другого, мягко направляя ее во время генитальной стимуляции.

Длительность прохождения парами различных фаз чувственного фокусирования зависит от того, насколько успешно и быстро они продвигаются вперед. Следует своевременно выявлять потенциальные помехи или иные трудности в процессе терапии и стремится к тому, чтобы

на каждой ступени были достигнуты позитивные результаты прежде чем упражнения перейдут в следующую фазу. Важно, чтобы пара выработала модель позитивного сексуального опыта, преодолев неудачи, которые были вызваны непонимание» потребностей друг друга или половым расстройством. Поэтому на ранних этапах лечения пациентам предлагается избегать коитуса или иных видов сексуальных контактов, которые были отягощены проблемами. Постепенно, по мере того как будут вновь обретаться уверенность и способность расслабляться на каждой последовательной ступени, пара может снова начать практиковать половые сношения.

Основанный на предположении, что большинство гетеросексуальных пар используют (и, вероятно, предпочитают) в ходе коитуса позицию, когда мужчина находится сверху, а женщина снизу, типовой сексотерапевтический подход рекомендует поэтапный переход к привычному варианту интимной близости. Вначале женщине предлагается занимать во время полового акта верхнее положение, что дает ей больше возможностей регулировать протекание коитуса, а мужчине позволяет легче расслабиться. Промежуточным шагом, помогающим сформировать у мужчины чувство уверенности при сношениях, является боковая позиция «лицом к лицу», которая обеспечивает партнерам наибольшую физическую релаксацию. Никому из них не приходится выдерживать вес другого. Когда партнеры лежат на боку, они оба принимают участие в контроле фрикционных движений, а их руки остаются свободными для взаимных прикосновений и

ласк. Считается, что эта позиция доставляет многим парам такое наслаждение, что они начинают практиковать ее при половых актах чаще, чем позицию, когда мужчина находится сверху. Заключительный терапевтический шаг, при условии, что он является для партнеров желанной целью, - достижение успеха в их привычной позиции, когда все сексуальные действия происходят так, как хочется им обоим, и партнеры испытывают обоюдное удовольствие от полового акта.

В табл. 5.3 в систематизированном порядке (с учетом основных точек приложения) представлены психотерапевтические приемы и методы, используемыемые нами для коррекции сексуальных дисфункций у мужчин.

Таблица 5.3

Тактика психотерапевтической коррекции ключевых психологических факторов сексуальной дезадаптации мужчины

Психологические факторы	Тактика психотерапевтического воздействия и используемые методы психотерапии
1	**2**
Задержки психосексуального развития	1. Формирование у пациента адекватных представлений о выборе сексуального партнера и гармоничных интимных отношениях. 2. Использование гипнотических техник для выработки новых установок и поведенческой роли с закреплением последней в воображении в ходе выполнения «домашних заданий». 3. Поэтапная практическая реализация модели интимного сближения с постоянной партнершей (от первого знакомства и платонического ухаживания до эротических ласк, петтинга и коитуса)

Фобические факторы: тревожное ожидание сексуальной неудачи и конто фобия	1. Нейтрализация негативного сексуального опыта мужчины с использованием техник НЛП (различные варианты интеграции якорей, БКД, взмах); ДПДГ; возрастная регрессия в гипнотическом трансе с последующей нейтрализацией травматического опыта. 2. Разрушение триггеров (мыслей, образов и ощущений), запускающих дисфункциональные сексуальные реакции. С помощью «процедуры отслеживания» определяют последовательность включения различных модальностей триггеров, а затем воздействуют на них в том же порядке: а) на мысли - «раскрутка негативных мыслей» или бихевиоральная техника «остановки мыслей», техника Сандерса; б) на образы - взмах, сокращенная версия ДПДГ; в) на ощущения - техника светового потока, визуализация дискомфортных ощущений в трансе с последующей трансформацией полученного пациентом образа.

1	2
	3. Устранение гиперконтроля коитуса и обучение пациента ассоциированному восприятию половой близости: тактика мнимого запрета; сексотерапия в виде 5 последовательных этапов (эротическое наслаждение без эрекции, эрекция без оргазма, экстравагинальный оргазм, интроитус без оргазма, коитус); техника «ассоциирование в переживание»; ЛД с визуализацией пациентом ситуации коитуса; гипнотические техники (погружение в ресурсное воспоминание, метафорические трансы с заданной фабулой, левитация руки); наркопсихотерапия с использованием закиси азота; мысленная тренировка по Лазарусу. 4. Активизация внутренних ресурсов пациента через обращение в гипнотическом трансе к позитивному опыту прошлого (как сексуальному, так и иному опыту, связанному с уверенностью и спокойствием)

Неадекватные убеждения и установки в отношении половой жизни, дисфункциональные схемы мышления	Применяются техники когнитивной терапии: коррекция автоматических мыслей; обнаружение и последовательная коррекция когнитивных ошибок, опровержение иррациональных убеждений, эмпирическая проверка реалистичности. Когнитивное переструктурирование с помощью ДПДГ. Работа с неадекватными убеждениями в модели НЛП. Лингвистический рефрейминт (переопределение). Смена ярлыка (релейбинг)
Интрапсихические конфликты, затрагивающие сексуальную сферу	1. Устранение внутренних противоречий, глубинных страхов перед проявлениями сексуальности и чувства вины: работа с полярными частями личности в эриксоновском гипнозе; использование стратегий гипноанализа, а также приемов символдрамы (мотивы «луг», «куст розы»); техника 2-х стульев. 2. Работа с глубинной тревогой в экзистенциальной модели (исследование проблем конечности бытия, свободы, одиночества и бессмысленности существования)

400

Нарушения межличностных отно-шений в паре	Используются техники семейной и супружеской терапии для решения следующих задач: 1) прояснение и видоизменение характера коммуникаций между супругами (техники «незаконченные предложения », «полноцен-ное слушание», «три положительных ответа», «прояснение коммуникаций», «инсценировка»); 2) исследование и сопоставление взаимных ожиданий и разногласий в паре (техники «сравнение ценностей», «прояснение взаимных ожиданий», «конструктивный спор»; 3) сосредоточение супругов на наиболее значимых проблемах в отношениях и возможных путях их решения (техники «супружеская хореография», «вечеринка частей», «создание аналогичных ситуаций); 4) изменение стиля поведения, т. е. обучение партнеров более эффективному взаимодействию (дебрифинг, техники «тройного увеличения», «семи основных правил», «дни заботы», парадоксальные интервенции)
Дисгармоничное сексуальное взаимодействие партнеров	Выяснение индивидуальных сексуальных предпочтений партнеров, совместное обсуждение, планирование и последующая реализация оптимальных для них вариантов сексуального взаимодействия. Библиотерапия и использование обучающих видеофильмов. Сексотерапевтические приемы (по У. Мастерсу и В. Джонсон, Х. Каплан), направленные на повышение физического удовольствия от сексуальных контактов

В психотерапии сексуальных расстройств мы выделяем три уровня, на которых может осуществляться основная работа. Первый уровень - феноменологический (симптоматический), предполагающий целенаправленное устранение симптомов половой дисфункции. Используются прямые суггестии в гипнотическом трансе, аутогенная тренировка, рациональная психотерапия, Сексотерапевтические программы и т. п. При отсутствии серьезных личностных и партнерских проблем психотерапия на этом уровне может

401

быть вполне эффективной. Второй уровень - проблемообразующий. Работа на этом уровне требует выявления и коррекции психологических механизмов, лежащих в основе дисфункциональных сексуальных реакций индивида. Все психотерапевтические интервенции на данном уровне осуществляются с учетом конкретной психологической проблематики пациента, непосредственным результатом которой и является возникновение и углубление первично-психогенных половых расстройств, присоединение нарушений в сексуальной сфере к имеющимся психопатологическим расстройствам либо невротическое реагирование с усилением симптомов сексуальных дисфункций у пациентов с органической патологией. Поэтому максимально индивидуализированное применение психотерапевтической стратегии, ориентированной на разрешение психологических проблем пациентов, не только создает условия для восстановления их сексуальной активности, но и оказывает коррегирующее воздействие на имеющуюся психопатологическую симптоматику. Третий уровень - сущностный (экзистенциальный), связанный с внутренним динамическим конфликтом, порождаемым конфронтацией индивида с конечными данностями существования. В практике психотерапевта-сексолога необходимость в работе на этом уровне возникает не столь уж часто.

Как следует из вышеизложенного, психотерапевтическая работа врамках предложенной стратегии осуществляется преимущественно на «проблемообразующем» уровне, поэтому данная модель является проблемно-ориентирован-ной. Вместе с тем в необходимых случаях она позволяет исполь-зовать симптоматические методы психотерапии, а также обращаться к некоторым экзистенциальным аспектам человеческого бытия.

Итак, практическое использование разработанной нами стратегии интегративной психотерапии сексологических пациентов предполагает определение ключевых психологических факторов сексуальной дезадаптации мужчины с последующей их прицельной коррекцией при помощи наиболее адекватных для этого методов психотерапии. Так, если пациент страдает психогенно обусловленной эрекционной дисфункцией (F52.2), в основе которой лежат тревожное ожидание неудачи при коитусе, неадекватные

убеждения и установки, создающие у мужчины искаженные представления о нормальной половой жизни, а также нарушения взаимоотношений с партнершей, психотерапевтическая стратегия строится с учетом всех выявленных психологических механизмов полового расстройства. На первых индивидуальных сессиях могут применяться техники когнитивной терапии для коррекции у пациента дисфункциональных схем мышления и когнитивных ошибок. Параллельно, для нейтрализации навязчивых воспоминаний о предшествующих срывах и устранения страха перед новыми неудачами при половой близости, используется метод ДПДГ либо приемы из арсенала НЛП (трехместная ВКД с последующим выполнением техники взмаха). В дальнейшем индивидуальные сессии с применением техник для последовательного разрущения триггеров, тормозящих генитальные реакции мужчины в ситуациях интимной близости, чередуются с работой с парой, в ходе которой осуществляется супружеская психотерапия, направленная на повышение уровня коммуникации партнеров и улучшение взаимоотношений между ними.

При наличии органической, в частности сосудистой патологии, приводящей к нарушению гемодинамических механизмов эрекции, мужчина также может испытывать тревогу и неуверенность в своих силах, а супружеские отношения нередко все больше ухудшаются. В этом случае лечебные мероприятия, направленные на улучшение генитального кровотока (вазоактивные препараты общего и локального действия, процедуры ЛД), сочетаются с психотерапией, которая фокусируется на тревожном ожидании сексуальной неудачи пациента и проблемах неадекватного супружеского взаимодействия.

Таким образом, разработанная нами интегративная модель психотерапевтической коррекции сексуальных дисфункций у мужчин исходит из прагматического эклектизма, обращаясь для решения конкретных сексологических проблем к различным методам психотерапии, и использует многочисленные приемы и техники, объединенные общей идеей восстановления сексуальной активности пациентов и улучшения их качества жизни. Объем и последовательность психотерапевтического воздействия определяются строго индивидуально, а предложенные методики легко

могут быть дополнены другими, адекватными основной задаче психотерапии - прицельной коррекции всех выявленных у пациента психологических механизмов сексуальной дисфункции. В силу полисиндромности и полиэтиоло-гичности большинства половых дисфункций у мужчин их лечение, как правило, является комплексным. При этом психотерапевтические мероприятия сочетаются с иными способами лечебного воздействия, в частности с фармакотерапией. Подчеркнем, что основные принципы и техники предложенной модели могут использоваться при психотерапевтической коррекции половых дисфункций у женщин, безусловно, с поправкой на особенности женской сексуальности.

Заключение

Помощь лицам, испытывающим серьезные проблемы и трудности в интимной жизни, представляет собой сложную и многоплановую задачу. Эффективное лечение сексуальных дисфункций невозможно осуществить исключительно пошаговым, механистическим путем, следуя стандартным терапевтическим схемам и шаблонам. Методы лечебного воздействия, включая конкретные формы психотерапии, фармакотерапии и другие способы коррекции половых расстройств, должны подбираться и комбинироваться между собой на основе индивидуального подхода к каждому пациенту, обратившемуся за сексологической помощью. При определении лечебной тактики следует принимать во внимание личностные особенности пациентов, характер партнерских отношений или причины отсутствия таковых, выраженность нарушений половой сферы и степень участия в их развитии как органической патологии, так и психологических механизмов. По мнению R. Rosen и S. Leiblum (1995), терапия половых расстройств - «это своего рода искусство, которое требует как профессиональных навыков, так и творческого подхода».

Огромный диапазон индивидуальных различий в человеческой сексуальности предполагает такое же многообразие возможных подходов к оказанию помощи людям, испытывающим затруднения в интимной жизни. В данной книге приведены лишь некоторые важные, на наш взгляд, стратегии оказания помощи пациентам сексологического профиля. Автор выражает надежду, что они окажутся полезными для практикующих специалистов-

Приложение 1. Опросники

Сексуальная формула женская (СФЖ)

Специальный вопросник, применяемый в практической работе врачей-сексологов для предварительной оценки сексуальных проявлений женщины. Вопросник состоит из 8 основных разделов (обозначены римскими цифрами), 9 раздел указывает на длительность полового расстройства. Ответы пациентки обозначаются цифрами от 0 до 4. После прочтения вопросника женщина подчеркивает цифру, которая стоит против утверждения, наиболее отвечающего ее состоянию на момент обращения за помощью.

I. Менструация:

0 - кровянистых выделений из половых путей никогда не было;

1 - нерегулярные кровянистые выделения из половых путей или регулярные из других мест (например, носовые);

2 - менструации стали нерегулярными или полностью прекратились в течение последних лет;

3 - менструации утрачивали свою регулярность только под влиянием неблагоприятных условий, при нервно-психических состояниях, в летний период или при смене места жительства;

4 - менструации всегда сохраняли свою периодичность, даже в самых неблагоприятных условиях.

II. Отношение к половой активности:

0 - половой акт всегда вызывал непреодолимое отвращение (или боль);

1 - половой акт с некоторых пор вызывает отвращение, что заставляет искать предлог, чтобы от него уклониться;

2 - половой акт безразличен и участие в нем проходит без внутреннего побуждения (из чувства долга или чтобы избежать конфликта);

3 - половой акт доставляет удовольствие, но степень наслаждения находится в явной зависимости от фазы менструального цикла;

4 - половой акт вызывает глубокое наслаждение всегда, вне зависимости от фазы менструального цикла.

III. Выделение влагалищной слизи к началу полового акта:

0 - никогда не было;

1 - происходит не всегда и находится в зависимости от фазы менструального цикла (в «неблагоприятные» периоды не происходит даже при
длительных предварительных ласках;

2 - происходит со значительным постоянством (вне зависимости от фазы менструального цикла), но при условии достаточной длительности предварительных ласк;

3 - происходит во всех случаях при условии, что половой акт совершается по внутреннему побуждению;

4 - происходит всегда и очень быстро, даже при самых поверхностных ласках (поверхностные беглые объятия и поцелуи), а иногда и просто при разговоре, принимающем интимный характер.

IV. Наступление глубокой острой нервной разрядки (оргазма):

0 - никогда ни при каких обстоятельствах не испытывала оргазма;

1 - испытывала оргазм только при сновидениях эротического содержания;

2 - испытывала единичные случаи оргазма при исключительных обстоятельствах (сексуальные «игры», особые формы полового воздействия при общении с изощренным мужчиной) или при самораздражении;

3 - оргазм наступает примерно в 50 % всех половых актов;

4 - оргазм наступает более чем в 80 % всех половых актов; бывают повторные оргастические разрядки при однократном половом акте.

V. Физическое самочувствие после половых актов;

0 - боль или ощущение тяжести в половых органах;

1 - полное физическое безразличие;

2 - ощущение неотреагированного полового возбуждения, долго не исчезающее;

3 - ощущение разрядки полового возбуждения, наступающее сразу по окончании полового акта или в процессе заключительных ласк;

4 - удовлетворенность и приятная усталость.

VI. Настроение после сношения:

0 - отвращение или (и) чувство униженности;

1 - чувство избавления от досадной обязанности;

2 - чувство полного безразличия;

3 - удовлетворение от сознания выполненного долга (или удовольствие от сознания доставленной мужчине радости);

4 - чувство благодарности мужчине за испытанное удовольствие, радость обоюдно разделяемого взаимного сближения.

VII. Уровень половой активности. Половые акты осуществляются со следующей периодичностью:

0 - никогда

407

не было; 0,5 - с интервалами не менее года;

1 - несколько раз в год, но не чаще раза в месяц;

2 - несколько раз в месяц, но не чаще раза в неделю;

3 - раза два или несколько чаще в неделю;

4 - ежесуточно один или несколько раз.

VIII. Длительность сношения. Семяизвержение у партнера наступает:

0 - еще до введения члена или в момент введения;

0 - не наступает ни при каких обстоятельствах; 0,5 - через несколько секунд после введения; 1 - не при каждом подовом акте, сношение носит затяжной, подчас изнурительный характер;

2 - примерно в пределах 15 - 20 движений;

3-4 - через 1-2 минуты или дольше (указать примерную длительность).

IX. Длительность полового расстройства:

0 - с начала половой жизни;

1 - более полугода;

2 - менее полугода;

3 - в настоящее время нет никаких расстройств, но они случались в прошлом;

4 - не знаю, что значит иметь затруднения в половой жизни.

Показатель I отражает состояние гормонального фона женщины, индикатором которого является устойчивость менструального цикла. Показатель II указывает на отношение к половой активности, которое определяется состоянием психической сферы и эндокринным статусом женщины. Показатель III отражает степень возбуждения на стадии предварительных ласк, свидетельствующую о готовности женщины к половому акту. Показатель IV - характеризует способность женщины к достижению оргазма. Показатели V и VI отражают соответственно физическую и психологическую реакцию женщины после полового акта. Показатели VII и VIII указывают на косвенные предпосылки для нормальных сексуальных реакций женщины, которые в решающей степени обеспечиваются партнером: соответственно уровень половой активности и продолжительность коитуса.

Цифры 0, 1, 2 в каждом показателе отражают различные степени снижения половой функции пациентки, 3 - среднестатистическую норму, 4 - сильную половую конституцию женщины.

При проведении анализа полученных данных цифры, соответствующие ответам обследуемой, записывают в виде числового ряда, разделенного

наклонными линиями на 4 диады, отдельно проставляется показатель длительности полового расстройства (IX), а затем подсчитывается сум-

408

марный (прогностический) показатель. Полученная мула отражает состояние сексуальной сферы женщины, поскольку показатели СФЖ зависят от ее конституционных особенностей, наличия или отсутствия половой дисфункции, характера взаимоотношений с партнером, его половой активности и длительности полового акта. Среднестатистический (нормативный) образец СФЖ приближается к следующему: 3, 3/3, 3/3, 3/3, 3/3 = 6 / 6 / 6 / 6 / 3 = 27. Реальные показатели могут отличаться как в большую, так и в меньшую стороны, что имеет диагностическое значение при сексологическом обследовании. Клиническая оценка СФЖ важна для экспресс-диагностики сексуальных дисфункций и сравнительного анализа результатов, достигнутых в ходе сексологического лечения.

Сексуальная формула мужская (СФМ)

Специальный вопросник, применяемый в сексологической практике для предварительной оценки состояния половой сферы мужчины. Вопросник состоит из 10 разделов (обозначены римскими цифрами), в каждом из разделов ответы пациента обозначаются цифрами от 0 до 4. Пациенту до начала обследования предлагается заполнить вопросник, подчеркнув в каждом разделе то утверждение, которое в наибольшей степени соответствует его состоянию на момент обращения к врачу. Использование вопросника СФМ позволяет сексологу получить важную предварительную информацию о половой функции мужчины.

I. Потребность в половых сношениях. Как часто возникает настоятельное желание иметь половой акт (вне зависимости от напряжения полового члена):

0 - вообще никогда или не чаще раза в год;

1 - несколько раз в год, но не чаще раза в месяц;

2 - 2-4 раза в месяц;

3 - раза два или несколько чаще в неделю;

4 - ежесуточно один или несколько раз.

(При заполнении этого раздела мужчины часто неправильно отождествляют желание половой близости с наличием эрекции, достаточной для проведения коитуса. Однако при ряде эректильных дисфункций желание иметь половой акт возникает довольно часто, но его реализация затруднена из-за слабой эрекции.)

II. Настроение перед сношением:

0 - сильный страх неудачи, поэтому попыток никогда не предпринимал;

1 - выраженная неуверенность, заставляющая искать предлог, чтобы уклониться от попытки;

2 - некоторая неуверенность, но от попытки не уклоняюсь (или провожу коитус в угоду партнерше без внутреннего побуждения; или провожу сношение, чтобы испытать себя);

3 - главным образом желание наслаждения, овладения женщиной, к сношению приступаю без опасений;

4 - всегда только жажда наслаждения женщиной, никогда не испытываю ни малейших сомнений.

III. Половая предприимчивость. Провожу действия, направленные к непосредственному осуществлению полового акта:

0 - вообще не провожу или провожу с интервалом не менее года;

1 - несколько раз в год, но не чаще 1 раза в месяц;

2 - несколько раз в месяц, но не чаще 1 раза в неделю;

3 - 2-3 раза (или несколько чаще) в неделю;

4 - ежесуточно один или несколько раз. (В этом разделе при заполнении вопросника довольно частая ошибка - указание количества удавшихся половых актов, хотя речь идет о сексуальных действиях, направленных на осуществление полового сношения, то есть попытках вступить в интимную близость, которые могут и не совпадать с числом успешно завершенных половых актов. Таким образом, в этом разделе учитывается общее количество попыток совершить коитус [как удачных, так и неудачных].)

IV. Частота осуществления полового акта. Мне удается провести половое сношение (хотя бы и не совсем полноценное по форме, то есть кратковременное или при неполном напряжении полового члена): 0 - вообще никогда не удавалось; 1 - очень редко; 2 - в большинстве случаев; 3 - в обычных условиях - всегда; 4 - в любых условиях и всегда, даже если обстоятельства этому не благоприятствуют.

V. Напряжение полового члена (эрекция):

0 - эрекция не наступает ни при каких обстоятельствах;

1 - вне обстановки полового акта эрекция достаточная, однако к момен ту сношения ослабевает и введение члена не удается;

2 - приходится применять усилия или местные манипуляции, чтобы вызвать достаточную для введения эрекцию (или же эрекция ослабевает после введения, но до семяизвержения);

3 - эрекция неполная, но введение удается без труда;

4 - эрекция наступает в любых условиях, даже самых неблагоприятных.

VI. Длительность сношения. Семяизвержение наступает: 0 - не наступает ни при каких обстоятельствах; 0,5 - наступает не при каждом половом акте, сношение носит затяжной, подчас изнурительный характер; 1 - еще до введения члена или в момент введения; 2 - через несколько секунд после введения; 2,5 - примерно в пределах 15-20 движений; 3-4 - через 1-2 минуты или дольше (указать примерную длительность).

VII. Частота половых отправлений. Семяизвержение происходит при сношениях (или ночных поллюциях, онанизме и др.) в среднем: 0 - вообще не происходит или происходит не чаще раза в год; 1 - несколько раз в год, но не чаще раза в месяц; 2 - несколько раз в месяц, но не чаще раза в неделю; 3 - 2 раза или несколько чаще в неделю; 4 - ежесуточно один или несколько раз. (При заполнении этого раздела пациенты иногда указывают только семяизвержения при половых сношениях. Здесь, однако, следует отметить все эякуляции, происходящие у мужчин при мастурбаторных актах, ночных поллюциях, половых актах, так как именно общая частота половых отправлений [количество семяизвержений] является важным объективным показателем мужской сексуальности.)

VIII. Настроение после сношения (или неудавшейся попытки): 0 - крайняя подавленность, ощущение катастрофы (либо отвращение к партнерше); 1 - разочарование, досада; 2 - безразличие (или некоторый осадок от сознания, что женщина чувствует себя неудовлетворенной); 3 - удовлетворенность и приятная усталость; 4 - полная удовлетворенность, душевный подъем.

IX. Оценка успешности половой жизни: 0 - женщина не хочет иметь со мной близость; 1 - женщина высказывает упреки; 2 - половая жизнь происходит с переменным успехом; 3 - половая жизнь происходит в общем успешно; 4 - способен в любых условиях удовлетворить женщину.

X. Длительность полового расстройства: 0 - с начала половой жизни; 1 - более полугода; 2 - менее полугода; 3 - в настоящее время нет никаких расстройств, но они случались в прошлом (в особенности в начале половой жизни); 4 - не знаю, что значит иметь затруднения в половой жизни.

Если какие-то индивидуальные проявления сексуальности мужчины варьируют очень широко (например, про-

должительность половых актов), то ему предлагается самому обозначить крайние пределы колебаний. В каждом из разделов вопросника СФМ стандартные ответы нумеруются цифрами от 0 до 4. Цифры 0, 1, 2 в каждом из десяти показателей отражают различную степень снижения половых функций, 3 - среднестатистическую норму для мужчины средних лет, 4 - сильную половую конституцию либо период юношеской гиперсексуальности.

Структурные показатели отражают: I - состояние предварительной готовности, связанной с нейроэндокринным обеспечением либидо; II - состояние психической сферы, выражающееся в настроении перед коитусом; III - сексуальную активность. Показатели IV, V и VI - отражают объективные параметры реализации половой активности: соответственно частота коитусов, качество эрекции и длительность сношения. Показатель VII объективно характеризует сексуальные возможности мужчины (частота эякуляций). Показатели VIII и IX отражают субъективную оценку полового акта мужчиной и его партнершей.

При анализе СФМ учитывается каждый из полученных ответов, затем их цифровые выражения объединяются в 3 триады, которые суммируются с показателем X (длительность полового расстройства), после чего подсчитывается общий (прогностический) показатель. Так, в случае среднестатистичеслой нормы СФМ выглядит так: 3, 3, 3 / 3, 3, 3 / 3, 3, 3 / 3 = 9 / 9 / 9 / 3 = 30. У пациентов с сексуальной патологией и при мнимых половых расстройствах показатели СФМ отличаются от среднестатистических в меньшую сторону, а у молодого мужчины, например, в медовый месяц, как правило, их превышают. Числовой ряд СФМ имеет свои особенности, при различных половых нарушениях у мужчин, которые рассматриваются в руководствах по сексопатологии.

Опросник сексуальной удовлетворенности (по Берг-Кросс, с изменениями и дополнениями)

Каждый из супругов должен ответить на вопросы, далее следует совместное обсуждение.

412

1. Удовлетворены ли вы частотой свих сексуальных отношений?

2. Удовлетворены ли вы продолжительностью предшествующих половому акту прелюдий (предварительных ласк)?

3. Удовлетворяют ли вас эти прелюдии?

4. Удовлетворены ли вы различными типами поведения (собственного и партнера) в ходе сексуального контакта?

5. Удовлетворены ли вы частотой и интенсивностью ваших оргазмов?

6. Удовлетворены ли вы длительностью полового акта?

7. Удовлетворены ли вы тем, что происходит после завершения полового акта?

8. Удовлетворены ли вы продолжительностью контакта после сексуального акта?

9. Удовлетворяет ли вас то, насколько часто у вас возникает желание заниматься сексом?

10. Удовлетворяет ли вас то, насколько часто у вашего партнера возникает желание заниматься сексом?

11. Удовлетворяет ли вас то, насколько уверенно вы себя чувствуете в в сексуальной сфере?

12. Удовлетворяет ли вас то, насколько уверенно чувствует себя ваш партнер в сексуальной сфере?

13. Удовлетворяет ли вас то, насколько свободно вы чувствуете себя в сексуальных отношениях с партнером?

14. Удовлетворяет ли вас то, насколько свободно чувствует себя ваш партнер в сексуальных отношениях?

15. Удовлетворены ли вы степенью самораскрытия между вами и вашим супругом?

16. Удовлетворены ли вы тем, насколько ваш партнер способен понимать ваши сексуальные потребности и его готовностью удовлетворить их?

17. Удовлетворены ли вы тем, насколько ваш партнер готов чем-то пожертвовать в ваших отношениях?

18. Удовлетворяют ли вас проявления любви (несексуального характера), которые имеют место между вами и вашим партнером?

19. Удовлетворяет ли вас то, насколько хорошо вы и ваш партнер функционируете как «пара» в различных ситуациях, с друзьями, родственниками, детьми?

413

20. Удовлетворяет ли вас та частота, с которой вы обсуждаете значимые вопросы (включая интимные) с вашим партнером?

21. Удовлетворяют ли вас те цели, которые вы поставили перед собой вместе со своим супругом?

Супруги должны обменяться друг с другом своими ответами. Прежде всего необходимо обсудить все области совместной неудовлетворенности. Затем можно перейти к рассмотрению моментов, вызывающих беспокойство у каждого из них по отдельности. Данный тест не предполагает подсчета суммы баллов. Здесь не ставится задача выявлять пары с сексуальными дисфункцями. Тест направлен на то, чтобы люди могли проанализировать уровень удовлетворенности в различных областях их сексуальных отношений.

Индекс сексуальной возбудимости (D. Hulbert, 1988)

Инструкции. Воспользуйтесь следующей шкалой, чтобы оценить каждый вопрос:

Все время - 0

Большую часть времени - 1

Иногда - 2

Редко - 3

Никогда - 4

1. Во время прелюдии я быстро возбуждаюсь. (R)
2. Занятия сексом с моим партнером очень возбуждают меня. (R)
3. Когда я занимаюсь сексом со своим партнером, я испытываю оргазм. (R)
4. У меня возникают трудности с сексуальным возбуждением.
5. Во время полового акта я, кажется, теряю исходный уровень сексуального возбуждения.
6. Для того чтобы испытать сексуальное возбуждение, мне требуется слишком много времени.
7. Мне трудно сохранять сексуальное возбуждение.
8. Секс наводит на меня скуку.

9. Я быстро возбуждаюсь, когда мой партнер занимается со мной оральным сексом. (R)

10. Мысли о сексе действуют на меня возбуждающе. (R)

11. Я нахожу анальный секс очень приятным. (R)

12. Когда я занимаюсь сексом со своим партнером, меня легко возбудить прикосновениями. (R)

13. Я нахожу мастурбацию сексуально стимулирующей. (R)

14. Я очень быстро теряю сексуальное возбуждение.

15. Меня очень возбуждают поцелуи. (R)

16. Даже когда я нахожусь в соответствующем настроении, у меня возникают трудности с сексуальным возбуждением. (R)

17. Меня возбуждают предварительные игры. (R)

18. Когда я занимаюсь сексом, требуется слишком много времени чтобы меня возбудить.

19. Когда я доставляю удовольствие своему партнеру, меня это сексуально возбуждает. (R)

20. У меня возникают трудности с сохранением сексуального возбуждения.

21. Я нахожу сексуальные отношения очень возбуждающими. (R)

22. Я считаю, что к началу полового контакта мой уровень сексуального возбуждения низкий.

23. Даже когда я хочу заняться сексом, у меня возникают трудности с сексуальным возбуждением.

24. Когда я занимаюсь со своим партнером оральным сексом, при этом я возбуждаюсь. (R)

25. В общем, сексуальные отношения удовлетворяют меня. (R)

Пункты, отмеченные злаком R, оцениваются противоположно, то есть 0 считается как 4;1 считается как 3;2 считается как 2;3 считается как 1 и 4 считается как 0. После того, как это действие выполнено, следует сложить все баллы, чтобы получился показатель сексуальной возбудимости. Низкий показатель (25 баллов и менее из 100 возможных) свидетельствует о наличии у индивида значительных затруднений в половом возбуждении, показатель 26 -50 баллов - о невысокой возбудимости, 51- 75 баллов - о средней, выше 75 баллов - о высокой сексуальной возбудимости. Тест используется в клинической практике свыше 15 лет. Он имеет коэффициент

валидности повторного тестирования (.87) свыше семи дней, а также альфа-коэффициент Кронбаха (.83), что указывает на хорошую внутреннюю последовательность.

Показатели шкалы отражают разную степень возбудимости у партнеров и могут использоваться для последующего обсуждения, как повысить сексуальное возбуждение одного или обоих партнеров до желаемого уровня.

Методика диагностики кроссполовых акцентуаций полоролевого поведения (Б. Е. Алексеев, 2006)

Вариант методики для женского пола

Дайте ответ на следующие утверждения: нет (1), да (2)

	до 7 лет	7-13 лет	13- 18 лет	сейчас
Предпочитали общество девочек (женщин)				
Предпочитали общество мальчиков (мужчин)				
Общество девочек (женщин) было неинтересным				
Играли в куклы, в «дочки-матери » и т. п.			-	-
Играли в машинки, в «войну» и т. п.			-	-
Оценивались как сорванец, а позже как человек решительный				
Нравились подвижные игры, спортивные занятия				
Нравилось шить, готовить				
Были уверены в себе, могли защитить себя, вступались за товарищей (подруг)				

В поведении проявлялись повышенная чувствительность и неуверенность в себе				
Избегали пользоваться косметикой				
Предпочитали одежду типа «унисекс»				

Вариант методики для мужского пола

Дайте ответ на следующие утверждения: нет (1), да (2)

	до 7 лет	7- 13 лет	13-18 лет	Сейчас
Предпочитали общество мальчиков (мужчин)				
Предпочитали общество девочек (женщин)				
Общество мальчиков (мужчин) было затруднительным, неинтересным				
Играли а куклы, в «дочки-матери» и т. п.			-	-
Играли в машинки, в «войну» и т. п.			-	-
Оценивались как мягкий, ласковый, привязанный к дому				
Нравились подвижные игры, спортивные занятия				
Нравилось шигь, готовить				
Испытывали неприятие мальчишеской возни, драк; силовые решения проблем были чужды				
В поведении проявлялись повышенная чувствительность и				

неуве-ренность в себе				

417

Случалось пользоваться косметикой				
Доводилось надевать женскую одежду и украшения				

Обследование по этой методике происходит в два этапа. На первом этапе она используется как опросник. Человек отвечает на поставленные вопросы по принципу «да» иди «нет». На втором этапе перечень тех же вопросов служит для структурированного интервью, в результате которого ранее полученные ответы уточняются и кодируются.

Оба варианта опросника состоят из 12 пунктов, каждый из которых предполагает четыре ответа по принципу да/нет, отражающих четыре возрастных периода (до 7 лет, от 7 лет до 12-13 лет, от 13 до 18 лет и «сейчас»). Исключение составляют пункты, касающиеся предпочитаемых игрушек и игр, - они оценивались в первых двух возрастных периодах. Показатели для возрастного периода до 7 лет являются одновременно маркерами маскулинного-фемининного (М - Ф) измерения. Для квантифицированной оценки поведения характеристикам, отражающим поведение, более свойственное противоположному полу, приписывается 2 балла, а характеристикам, подтверждающим поведение своего пола - 1 балл.

Сумма баллов по каждому возрастному периоду позволяет оценивать выраженность кроссполового поведения. Сопоставление уровня кроссполового поведения по возрастным периодам дает возможность изучать возрастную динамику данного поведения. С этой целью введен *индекс кроссполового поведения (ИКП)*, который равен частному, где делимое равно разности шкальной оценки и минимально возможной суммы баллов по шкале, а делитель - размаху шкалы (разность между максимальным и минимальным значением шкалы, равная *двенадцати* для первых двух возрастных периодов и равная *десяти* для двух вторых). Значение индекса кросспо-

418

лового поведения лежит в пределах от 0 до 1. Таким образом, обработка данных структурированного интервью, характеризующего М-Ф измерение и полоролевое поведение, предполагает получение четырех оценок индекса кросс-полового поведения соответственно возрастным периодам: до 7 лет; от 8 до 12-13 лет; от 13 лет до 18 лет; «сейчас».

Ключ к методике

Вариант методики для женского пола

Ответы, соответствующие фемининному поведению: 1 - да; 2 - нет; 3 - нет; 4 - да; 5 - нет; 6 - нет; 7 - нет; 8 - да; 9 - нет; 10 - да; 11 - нет; 12 - нет.

Ответы, соответствующие маскулинному поведению: 1 - нет; 2 - да; 3 - да; 4 - нет; 5 - да; 6 - да; 7 - да; 8 - нет; 9 - да; 10 - нет; 11 - да; 12 - да.

Вариант методики для мужского пола

Ответы, соответствующие маскулинному поведению: 1 - да; 2 - нет; 3 - нет; 4 - нет; 5 - да; 6 - нет; 7 - да; 8 - нет; 9 - нет; 10 - нет; 11 - нет; 12 - нет.

Ответы, соответствующие фемининному поведению: 1 - нет; 2 - да; 3 - да; 4 - да; 5 - нет; 6 - да; 7 - нет; 8 - да; 9 - да; 10 - да; 11 - да; 12 - да.

Методика валидизирована и может использоваться в практической деятельности врача и психолога при решении широкого круга задач, начиная с анализа генеза психосоматических расстройств, сексуальных дисфункций, семейных дисгармоний, проблем адаптации в широком плане, в том числе при различных заболеваниях, а также в научных исследованиях для диагностики кроссполовой акцентуации М-Ф измерения и полоролевого поведения у мужчин и женщин.

419

Опросник супружеской удовлетворенности (А. Лазарус, 1997)

Имя:

Дата:

Инструкция

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Неприятно			Отчасти приятно				Очень приятно		

В первой графе после каждого пункта, пожалуйста, поставьте цифру, которая наиболее точно и правдиво отражает Ваши нынешние чувства относительно брака / отношений или супруга / партнера. В следующей графе укажите, как, по вашему мнению, ваш супруг (а) / партнер ответит на этот пункт, если бы он / она заполнял (а) этот опросник. Работайте как можно быстрее, попытайтесь не тратить слишком много времени на каждый пункт.

Я: Он (Она)

1. Доволен тем, сколько мы разговариваем друг с другом.
2. Доволен качеством нашего общения (например, оно приятно и конструктивно, а не безразлично или враждебно и т. д.).
3. Удовлетворен нашими сексуальными отношениями.
4. Удовлетворен тем, как мы тратим деньги и вообще обращаемся с деньгами.
5. Удовлетворен количеством времени, которое мы проводим вместе.
6. Счастлив нашей общественной жизнью и общими друзьями.
7. Удовлетворен тем, каким родителем является мой партнер (если у Вас нет детей, оцените свой уровень удовлетворения по поводу этого факта).

8. Полагаю, что мой супруг/партнер в «моей команде».

9. Удовлетворен тем, как мы проводим свободное время вместе (например, склонности, спорт, загородные прогулки и т. д.).

10. В основном я согласен со взглядами моего супруга/ партнера на жизнь (например, ценности, религия, убеждения и т. д.).

11. Доволен степенью теплоты, которую даю и получаю.

12. Могу доверять тому, что говорит и делает мой супруг/партнер.

13. Доволен тем, сколько мой партнер курит, пьет и другими его/ее привычками.

14. Удовлетворен моими отношениями с членами семьи моего супруга/партнера (например, его или ее родителями, братьями, сестрами).

15. Доволен тем, как мой супруг/партнер общается с членами моей семьи (то есть с моими родителями, братьями, сестрами и т. д.).

16. Доволен внешностью своего партнера.

Интерпретация

Общий балл имеет меньшее значение, чем баллы по отдельным пунктам. Так как общее количество оценок колеблется от 16 до 160, то показатель ниже 80 свидетельствует о значительной неудовлетворенности супружескими отношениями. Тем не менее наиболее продуктивным является обсуждение отдельных баллов, уточнение, почему определенные пункты оценены на 9 или 10 баллов, тогда как другие оценены только на 3 или 4. Также имеет смысл проанализировать различия в оценках, поставленных за партнера.

Опросник навыков общения (L. Navran, 1967)

Инструкции: ниже перечислены навыки общения. Оцените каждый из этих навыков и определите, насколько они характерны для ваших отношений. Отметьте пять навыков, которые вы хотели бы усовершенствовать в течение

нескольких следующих месяцев. Обсудите с супругом, как можно усовершенствовать эти навыки.

1	*2*	*3*	*4*	*5*
Никогда	*Редко*	*Иногда*	*Часто*	*Очень часто*

1. Как часто вы обсуждаете со своим супругом приятные события, произошедшие за день?
2. Как часто вы обсуждаете со своим супругом неприятные события, произошедшие за день?
3. Обсуждаете ли вы со своим супругом вопросы, по которым у вас возникают разногласия или трудности?
4. Обсуждаете ли вы со своим супругом вопросы, интересующие вас обоих?
5. Принимает ли ваш супруг во внимание ваше состояние в данный момент, а именно: что он говорит и как это говорится?
6. Когда вы начинаете задавать вопрос, знает ли ваш супруг о том, что вы хотите спросить?
7. Узнаете ли вы о том, что чувствует ваш супруг, по выражению его лица и жестам?
8. Избегаете ли вы в разговоре с супругом обсуждения определенных вопросов?
9. Объясняет ли ваш супруг или выражает свои чувства взглядом или жестами?
10. Обсуждаете ли вы со своим супругом какие-то моменты, прежде чем принять важное решение?
11. Может ли ваш супруг сказать, насколько удался у вас день, не спрашивая об этом?
12. Ваш супруг хочет посетить близких друзей или родственников, но вам не очень нравится находиться в их обществе. Скажете ли ему (ей) об этом?
13. Обсуждает ли с вами ваш супруг вопросы, относящиеся к сексуальной сфере?
14. Используете ли вы со свои супругом слова, имеющие специальное значение, не совсем понятное другим?
15. Как часто ваш супруг бывает в дурном настроении или «дуется»?

16. Можете ли вы со своим супругом обсуждать свои самые сокровенные мысли, не теряя при этом само обладания или не испытывая смущения?

422

17. Предпочитаете ли вы не рассказывать своему супругу то, что может представить вас в невыгодном свете?

18. Вы и ваш супруг отправляетесь в гости к друзьям. Друзья говорят нечто такое, что заставляет вас переглянуться друг с другом. Вы поймете друг друга?

19. Как часто тон голоса вашего супруга может сказать вам столько же, что и сама информация, которую он вам сообщает?

20. Как часто вы обсуждаете со своим супругом свои личные проблемы?

21. Чувствуете ли вы, что ваш супруг часто знает заранее то, что вы пытаетесь сказать?

22. Вы скорее будете обсуждать свои интимные вопросы со своим супругом, чем с кем-то другим?

23.Можете ли вы по выражению лица своего супруга сказать о том, что он чувствует?

24. Если вы со своим супругом отправляетесь к друзьям или родственникам и один из вас начинает что-то говорить, может ли другой вмешаться так, чтобы не возникло ощущения, что разговор прерван?

25. Обсуждаете ли вы совместно со своим супругом самые разные вопросы?

Ключ к шкале опросника навыков общения

1. По всем пунктам (за исключением 8, 15 и 17) следует подсчитать сумму баллов, отмеченных клиентом. На пример, цифра 5 (очень часто) соответствует 5 баллам и т. д.

2. По пунктам 8,15 и 17 подсчет баллов обратный. Здесь предлагается оценить негативное или неэффективное поведение. Например, цифра 5 (очень часто) соответствует 1 баллу, который прибавляется к общему результату, а цифра 1 (никогда) - 5 баллам.

3. По пунктам 5, 6, 7, 9,11, 13,15, 21 и 24 баллы берутся из опросника супруга. Подобное смещение обусловлено тем, что сюда включаются оценки супруга. В итоге учитываются собственные описания и оценки супруга. Таким образом, общая сумма баллов может быть точно подсчитана только тогда, когда оба супруга принимают участие в опросе.

423

4. Чтобы получить общую сумму баллов по невербальной коммуникации, подсчитайте баллы по пунктам 6, 7, 9, 11, 15, 18 и 23. Путем вычитания этой суммы из общего результата можно получить отдельную сумму баллов по вербальной коммуникации.

Нормативные данные опроса	Общий итог	Невербальная коммуникация	N
Мужья, которые счастливы в браке	X= 105,1	29,3	24
Жены, которые счастливы в браке	X=105,4	28,9	24
Мужья, имеющие нарушения	X=81,6	23,2	24
Жены, имеющие нарушения	X=81,1	23,2	24

Опросник для исследования уровня социально-педагогической и сексуально-поведенческой адаптации супружеской пары (Д. Л. Буртянский, В. В. Кришталь, 1982)

1. *К супруге(у) я испытываю чувство:*
1. Неприязни.
2. Привычки и безразличия.
3 Любви и уважения.

2. *Черты характера супруга (и) соответствуют моим желаниям:*
1. Не соответствуют.
2. Частично.
3. Полностью.

424

3. *Наличие соответствия мировоззрении, убеждений, морально-этических и эстетических установок:*

1. Несоответствие.
2. Частичное.
3. Полное.

4. *Внешность супруга(и) соответствует моему идеалу:*

1. Не соответствует.
2. Частично.
3. Полностью.

5. *Что является ведущим в Вашей деятельности?*

1. Потребность свободного творчества.
2. Моральное удовлетворение работой.
3. Материально-бытовые потребности.

6. *В какой степени деятельность супруга(и) соответствует Вашим желаниям?*

1. Не соответствует.
2. Частично.
3. Полностью.

7. *Цифрами от 1 до 5 укажите порядок, отражающий значимость указанных ниже факторов:*

1. Работа и вопросы, связанные с трудовой деятельностью.
2. Материально-бытовая обеспеченность жизни.
3. Культурные интересы.
4. Половая жизнь.
5. Хобби (индивидуальные увлечения).

8. *В какой степени указанные выше факторы в представлении Вашей супруги соответствуют Вашим собственным?*

1. Не соответствуют.
2. Частично.
3. Полностью.

9. *Интеллект супруга(и) соответствует Вашему:*

1. Не соответствует.
2. Частично.
3. Полностью.

425

10. *Имеется ли соответствие в характере проведения свободного времени у Вас и Вашей супруги(а)?*

1. Несоответствие.
2. Частично.
3. Полностью.

11. *Обозначьте знаком «+» или «-» соответственное случаях положительного или отрицательного отношения к качествам. Вашего супруга(и) как:*

- отца (матери), семьянина (хозяйки);
- работника (работницы), гражданина (гражданки).

В случаях отрицательного отношения степень несоответствия следует обозначить цифрой после знака «-», при частичном - 2, при полном несоответствии - 3.

12. *Соответствует ли материально-бытовое состояние семьи Вашим запросам?*

1. Не соответствует.
2. Частично.
3. Полностью.

13. *Соответствует ли сексуальное поведение супруга(и) в непосредственной подготовке к половому акту тому, что Вы хотели бы?*

1. Не соответствует.
2. Частично.
3. Полностью.

14. *Соответствует ли сексуальное поведение супруга (и) во время полового сношения Вашим потребностям (желаниям)?*

1. Не соответствует.
2. Частично.
3. Полностью.

15. *Соответствует ли сексуальное поведение супруга (и) непосредственно после сношения Вашим желаниям?*

1. Не соответствует.
2. Частично.
3. Полностью.

426

16. *Как влияет психологическая несовместимость (если таковая имеется) между Вами и супругом(ой) на половую жизнь?*
1. Делает ее невозможной.
2. Частично.
3. Не влияет.

17. *Влияет ли сексуальное поведение Вашего супруга (и) на степень Вашей половой удовлетворенности?*
1. Приводит к неудовлетворению.
2. Несколько снижает ее.
3. Не влияет.

При использовании данной методики обследуемому предлагается подчеркнуть один из трех приведенных в анкете вариантов ответа на 16 вопросов. Каждый из них предусматривает получение характеристики одной из сторон социально-психологической и сексуально-поведенческой адаптации или дезадаптации. Для более полной и точной характеристики значимости каждого из вошедших в опросник факторов они могут оцениваться по пятибалльной симметричной шкале от + 2 до -2 . Оценка «+2» означает весьма значимое положительное влияние фактора на психологическую адаптацию и сексуальную гармонию, «+1» - на небольшую положительную значимость данного фактора, «0» - отсутствие практической значимости фактора для психологической адаптации и сексуальной гармонии, «-1» - небольшую отрицательную значимость, «-2» - выраженное отрицательное влияние фактора на психологическую адаптацию и сексуальную гармонию. Анализ полученных данных дает возможность уточнить факторы, приведшие к развитию сексуальной дисгармонии супружеской пары, что является ценным подспорьем для выбора наиболее рациональных методов ее коррекции. Сопоставление данных, полученных у обоих супругов, дает наглядное представление о наличии и выраженности несоответствий в характере и тенденциях супругов, которые приводят к развитию супружеской дезадаптации.

427

Международный индекс эректильной дисфункции (МИЭФ) - International index of erectile function (IIEF) (R. C. Rosen et al., 1997)

Выберете и отметьте только один вариант при ответе на каждый вопрос:

1. *В течение последних 4 недель, как часто Вы мог ли достигать эрекции при сексуальной активности?*

[0] Не было сексуальной активности.
[1] Почти никогда или никогда.
[2] Несколько раз (гораздо меньше, чем в половине случаев).
[3] Иногда (около половины).
[4] В большинстве случаев (гораздо больше, чем в половине случаев).
[5] Почти всегда иди всегда.

2. *В течение последних 4 недель, когда Вы достигали эрекции при сексуальной стимуляции, как часто Ваша эрекция была достаточной для введения полового члена во влагалище?*

[0] Не было сексуальной активности.
[1] Почти никогда или никогда.
[2] Несколько раз (гораздо меньше, чем в половине случаев).
[3] Иногда (около половины).
[4] В большинстве случаев (гораздо больше, чем в половине случаев).
[5] Почти всегда или всегда.

3. *В течение последних 4 недель, когда Вы предпринимали попытки проведения полового акта, как часто Вы были в состоянии ввести половой член (войти) во влагалище партнерши?*

[0] Не было попыток проведения полового акта.
[1] Почти никогда или никогда.

[2] Некоторое время (гораздо меньше, чем в половине случаев).
[3] Иногда (около половины).
[4] В большинстве случаев (гораздо больше, чем в половине случаев).
[5] Почти всегда или всегда.

4. *В течение последних 4 недель, когда Вы предпринимали попытки проведения полового акта, как часто Вы были в состоянии сохранить эрекцию после введения полового члена во влагалище партнерши?*

[0] Не было попыток проведения полового акта.
[1] Почти никогда или никогда.
[2] Некоторое время (гораздо меньше, чем в половине случаев).
[3] Иногда (около половины).
[4] В большинстве случаев (гораздо больше, чем в половине случаев).
[5] Почти всегда или всегда.

5. *В течение последних 4 недель, когда Вы предпринимали попытки проведения полового акта, как трудно Вам было сохранить эрекцию до конца полового акта?*

[0] Не было попыток проведения полового акта.
[1] Исключительно трудно.
[2] Очень трудно.
[3] Трудно.
[4] Не очень трудно.
[5] Совсем не трудно.

6. В *течение последних 4 недель, сколько раз Вы предпринимали попытку проведения полового акта?*
[0] Не было попыток.
[1] Одну - две попытки.
[2] Три - четыре попытки.
[3] Пять-шесть попыток.
[4] Семь - десять попыток.
[5] Одиннадцать или более.

429

7. *В течение последних 4 недель, когда Вы предпринимали попытку проведения полового акта, как часто Вы были удовлетворены?*

[0] Не было попыток проведения полового акта.

[1] Почти никогда или никогда.

[2] Несколько раз (гораздо меньше, чем половину).

[3] Иногда (около половины).

[4] В большинстве случаев (гораздо больше, чем в половине).

[5] Почти всегда или всегда.

8. *В течение последних 4 недель, насколько Вы были удовлетворены половым актом?*

[0] Не было попыток проведения полового акта.

[1] Не получил удовлетворения.

[2] Не очень большое удовлетворение,

[3] Достаточное удовлетворение.

[4] Большое удовлетворение.

[5] Очень сильное удовлетворение.

9. *В течение последних 4 недель, при проведении сексуальной стимуляции или половом акте, как часто у Вас происходила эякуляция?*

[0] Не было попыток проведения сексуальной стимуляции или полового акта.

[1] Почти никогда или никогда.

[2] Несколько раз (гораздо меньше, чем в половине случаев).

[3] Иногда (около половины).

[4] В большинстве случаев (гораздо больше, чем в половине).

[5] Почти всегда или всегда.

10. *В течение последних 4 недель, при проведении сексуальной стимуляции или половом акте, как часто Вы испытывали оргазм (с или без эякуляции)?*

[0] Не было попыток проведения сексуальной стимуляции или полового акта.

[1] Почти никогда или никогда.

[2] Несколько раз (гораздо меньше, чем в половине случаев).

[3] Иногда (около половины).
[4] В большинстве случаев (гораздо больше, чем в половине).
[5] Почти всегда или всегда.

11. *В течение последних 4 недель, как часто Вы испытывали сексуальное желание?*
[1] Почти никогда или никогда.
[2] Несколько раз (гораздо меньше, чем в половине случаев).
[3] Иногда (около половины).
[4] В большинстве случаев (гораздо больше, чем в половине).
[5] Почти всегда или всегда.

12. *В течение последних 4 недель, какова Ваша оценка уровня Вашего сексуального желания?*
[1] Очень низкий или совсем отсутствует.
[2] Низкая.
[3] Средняя.
[4] Высокая.
[5] Очень высокая.

13. В *течение последних 4 недель, насколько Вы в целом удовлетворены сексуальной жизнью?*
[1] Очень неудовлетворен.
[2] Неудовлетворен.
[3] В равной степени удовлетворен и неудовлетворен.
[4] Достаточно удовлетворен,
[5] Полностью удовлетворен.

14. В *течение последних 4 недель, насколько Вы удовлетворены сексуальными отношения» с партнершей?*
[1] Очень неудовлетворен,
[2] Неудовлетворен.
[3] В равной степени удовлетворен и неудовлетворен.
[4] Достаточно удовлетворен.
[5] Полностью удовлетворен.

431

15. *В течение последних 4 недель, как Вы оцениваете свою уверенность в возможности достигать и сохранять эрекцию?*

[1] Очень низко.
[2] Низко.
[3] Средне.
[4] Высоко.
[5] Очень высоко.

Оценка результатов анкетирования

Домен	Эректильная дисфункция	Удовлетворенность половым актом	Оргазмическая функция	Либидо	Общая удовлетворенность
Вопросы	1, 2, 3, 4, 5, 15	6,7,8	9,10	11,12	13, 14
Сумма баллов	(1-30)	(0-15)	(0-10)	(2-10)	(2-10)

Сумма баллов, полученных при ответе на 1 - 5 и 15 вопрос характеризует *эректильную функцию* мужчины, если она составляет менее 26 баллов, диагностируют ее дисфункцию.

T.F. Lue et al. (2004) разработали специальную анкету для оценки женской сексуальной функции (FSFI), представленную ниже.

Индекс женской сексуальной функции (ИЖСФ) - Female sexual function index (FSFI)

Эти вопросы направлены на выявление особенностей Вашей сексуальности в течение предшествующих 4 недель.

Пожалуйста, ответьте на эти вопросы честно и ясно насколько возможно.

Ваши ответы будут сохраняться полностью конфиденциальными. В опроснике применяются следующие определения.

Половая активность может включать ласки, мастурбацию и половой акт.

Половой акт определен как включающий проникновение полового члена во влагалище. Половое влечение (желание) или интерес - чувство, которое включает желание иметь половой опыт, чувство восприимчивости к сексуальному интересу со стороны партнера, к сексуальным размышлениям или фантазиям.

Половое возбуждение - чувства или ощущения, которые включают физические и психические аспекты полового возбуждения. Оно может включать чувства теплоты или других ощущений в гениталиях (половых органах), появление выделений (смазки) и/или сокращения мышц промежности.

Половое возбуждение включает его достижение как в процессе общения в общении с партнером, так и в процессе самоудовлетворения (мастурбации), и/или сексуальных фантазий.

1. *Как часто Вы испытывали половое влечение или интерес 6 последние 4 недели?*

[5] Почти всегда или всегда.

[4] В большинстве случаев (больше, чем в половине случаев).

[3] Иногда (приблизительно в половине случаев).

[2] Несколько раз (меньше, чем в половине случаев).

[1] Почти никогда или никогда.

2. *Как Вы оценили бы ваш уровень (степень) полового влечения (желания) или интереса в последние 4 недели?*

[5] Очень высокий.

[4] Высокий.

[3] Умеренный.

[2] Низкий.

[1] Очень низкий или его не было.

433

3. *Как часто Вы чувствуете себя активно сексуально «включенными» в течение полового контакта или общения 6 последние 4 недели?*

[0] Общения и контактов не было.

[5] Почти всегда или всегда.

[4] Часто (больше, чем в половине случаев).

[3] Иногда (приблизительно в половине случаев).

[2] Несколько раз (меньше, чем в половине случаев).

[1] Почти никогда или никогда.

4. *Как бы Вы оценили уровень полового возбуждения в течение полового контакта в последние 4 недели?*

[0] Общения и контактов не было.

[5] Очень высокий.

[4] Высокий.

[3] Умеренный.

[2] Низкий.

[1] Очень низкий или отсутствовал вообще.

5. *Пробуждалась ли Ваша сексуальность 6 течение полового контакта в последние 4 недели?*

[0] Общения и контактов не было.

[5] Почти всегда или всегда.

[4] Больше, чем в половине случаев.

[3] Иногда (приблизительно в половине случаев).

[2] Несколько раз (меньше, чем в половине случаев).

[1] Почти никогда или никогда.

6. *Как часто Вы были удовлетворены вашим возбуждением (волнением) в течение полового акта или общения в последние 4 недели?*

[0] Общения и контактов не было.

[5] Почти всегда или всегда.

[4] Больше, чем в половине случаев.

[3] Иногда (приблизительно в половине случаев).

[2] Несколько раз (меньше, чем в половине случаев).
[1] Почти никогда или никогда.

434

7. *Как часто появлялось увлажнение половых органов (влагалища) в процессе полового акта, за последние 4 недели?*
[0] Общения и контактов не было. Никаких половых действий.
[5] Почти всегда или всегда.
[4] Больше, чем в половине случаев.
[3] Иногда (приблизительно в половине случаев).
[2] Несколько раз (меньше, чем в половине случаев).
[1] Почти никогда или никогда.

8. *Насколько трудным было достижение увлажнения половых органов (влагалища) в начале полового акта в последние 4 недели?*
[0] Общения и контактов не было.
[1] Чрезвычайно трудным или невозможным.
[2] Очень трудным.
[3] Трудным.
[4] Относительно трудным.
[5] Нетрудным.

9. *Как часто появлялась необходимость в поддержании увлажнения половых органов (влагалища) до завершения полового акта в последние 4 недели?*
[0] Общения и контактов не было.
[5] Почти всегда или всегда.
[4] Больше, чем в половине случаев.
[3] Иногда (приблизительно в половине случаев).
[2] Несколько раз (меньше, чем половине случаев).
[1] Почти никогда или никогда.

10. *Насколько трудно было сохранить увлажнение половых органов до завершения полового акта в последние 4 недели?*
[0] Общения и контактов не было.
[1] Чрезвычайно трудно или невозможно.
[2] Очень трудно.

[3] Трудно.
[4] Относительно трудно.
[5] Нетрудно.

435

11. *Как часто Вы достигали оргазма при половом возбуждении за последние 4 недели?*
[0] Общения и контактов не было.
[5] Почти всегда или всегда.
[4] Больше, чем в половине случаев.
[3] Иногда (приблизительно в половине случаев).
[2] Несколько раз (меньше, чем в половине случаев).
[1] Почти никогда или никогда.

12. *Насколько трудным для Вас было достижение оргазма при половом контакте прошлые 4 недели?*
[0] Общения и контактов не было.
[1] Чрезвычайно трудным или невозможным,
[2] Очень трудным.
[3] Трудным.
[4] Относительно трудным.
[5] Нетрудным.

13. *Насколько Вас удовлетворяли приемы и усилия, необходимые для достижения оргазма, за последние 4 недели?*
[0] Общения и контактов не было.
[5] Очень удовлетворена.
[4] Удовлетворена.
[3] Относительно одинаково удовлетворена.
[2] Неудовлетворена.
[1] Очень неудовлетворена.

14. *Вы были удовлетворены эмоциональной близостью между Вами и вашим партнером в процессе полового акта в последние 4 недели?*
[0] Общения и контактов не было.
[5] Очень удовлетворена.
[4] Удовлетворена.
[3] Относительно удовлетворена.

[2] Неудовлетворена.
[1] Очень неудовлетворена.

15. *Удовлетворены ли Вы были сексуальными отношениями с вашим партнером в течение последних 4 недель?*

436

[5] Очень удовлетворена.
[4] Удовлетворена.
[3] Относительно удовлетворена.
[2] Неудовлетворена.
[1] Очень неудовлетворена.

16. *Насколько удовлетворены Вы были сексуальной жизнью в целом в течение прошедших 4 недель?*
[5] Очень удовлетворена.
[4] Удовлетворена.
[3] Относительно удовлетворена.
[2] Неудовлетворена.
[1] Совсем неудовлетворена.

17. *Как часто Вы испытывали дискомфорт или боль в процессе проникновения полового члена во влагалище за последние 4 недели?*
[0] Не было попыток общения.
[1] Почти всегда или всегда.
[2] Часто (больше, чем половине случаев).
[3] Иногда (приблизительно в половине случаев).
[4] Несколько раз (меньше, чем в половине случаев).
[5] Почти никогда или никогда.

18. *Как часто Вы испытывали дискомфорт или боль в процессе и /или после полового акта за последние 4 недели?*
[0] Не было попыток общения.
[1] Почти всегда или всегда.
[2] Часто (больше, чем половине случаев).
[3] Иногда (приблизительно в половине случаев).
[4] Несколько раз (меньше, чем половине случаев).
[5] Почти никогда или никогда.

19. *Как бы Вы оценили величину (степень) дискомфорта или боли в процессе и/или после полового акта за прошедшие 4 недели?*

[0] Не было попыток общения.

[1] Очень высокая.

[2] Высокая.

437

[3] Умеренная.

[4] Низкая.

[5] Очень низкая или вообще отсутствовала.

Спасибо за завершение этого анкетного опроса.

Индекс позволяет оценить состояние сексуальной функции женщин с учетом ее шести основных составляющих: *половое влечение, чувствительность и возбудимость, любрикация (увлажнение влагалища), оргастиче-ность, удовлетворенность половой жизнью, коитальный и/или посткоиталъный дискомфорт/боль.* Количественная оценка результатов теста не предусмотрена, оптимальным считается максимально позитивное количество баллов при ответе на каждый вопрос анкеты.

438

Приложение 2. Клинические иллюстрации

Клиническое наблюдение № 2

Больной С., КСО-628С, 33 года, ИО-15
Экономист-менеджер
СФМ 3,2,2/1; 1; 2,5/1,1,1/1-7/4,5/3/1-15,5

Предъявляет жалобы на слабость эрекции, малую продолжительность коитуса, раздражительность, беспокойство, пониженное настроение, рассеянность внимания, периодические головные боли, временами плохой сон.

Впервые обратил внимание на ухудшение потенции примерно 7 месяцев назад. Незадолго до этого на работе возник трудовой конфликт, в результате которого пациент был обвинен в денежных махинациях. На протяжении нескольких недель на предприятии шла финансовая проверка, выявившая перерасход средств, в связи с чем пациент подвергся серьезным штрафным санкциям. Был крайне удручен происходящим, но жене о своих проблемах почти ничего не сообщал. В указанный период дважды попытался вступить с ней в интимные отношения, но достаточной для коитуса эрекции не возникло даже после продолжительного периода ласк, включая прямую мануальную стимуляцию гениталий, проводимую супругой. Жена расценила это как свидетельство полного к ней равнодушия. Чтобы как-то реабилитироваться в ее глазах начал специально настраиваться на близость, но вопреки ожиданиям проигрывание сцен предстоящего полового акта лишь усиливало навязчивые мысли о возможном срыве и последующих упреках в сексуальной несостоятельности. Если половые акты и происходили, то при неполной эрекции или слишком быстро. Тревожные опасения новых неудач

привели пациента к снижению сексуальной активности. На протяжении 4 месяцев пытался совершать половые акты с частотой примерно 1 раз в 7-10 дней. Более чем в половине случа-

ев попытки вообще не удавались из-за изначально слабой эрекции либо ее резкого ослабления при интроитусе. Почувствовал, что отношение жены к нему изменилось: она стала вести себя подчеркнуто холодно и пренебрежительно, все чаще упрекала в половой слабости и неспособности удовлетворить ее. Тяжело переживал сексуальные неудачи, постоянно об этом думал. Примерно 2 месяца назад начали беспокоить сердцебиение, чувство нехватки воздуха, усилились раздражительность и внутреннее беспокойство, снизилось настроение, подолгу не мог уснуть, появились неприятные ощущения в промежности. Тогда же впервые обратился к сексопатологу, который расценил сексуальные нарушения пациента как проявления выраженного астено-невротического синдрома и обострения хронического простатита. Прошел 10 сеансов ЛД и курс массажа простаты, получал мезапам, тентекс-форте, спеман-форте, абактал. В начале лечения наблюдалось кратковременное усиление эрекций и уменьшение числа неудачных попыток. Однако уже через три недели еще на фоне проводимой терапии адекватные эрекции вновь ухудшились, что было расценено больным как свидетельство тяжести расстройства. Из-за постоянных навязчивых мыслей о неудачах при интимной близости и ухудшения общего состояния снизилась работоспособность. На протяжении последнего месяца, несмотря на наличие полового влечения, не предпринял ни одной попытки совершить коитус, поскольку был уверен, что ничего не получится. Появились мысли о разводе. Будучи настроенный весьма пессимистично все же обратился за консультацией в Минский городской сексологический центр.

Из анамнеза. Родился первым из 2-х детей в семье служащих. Наследственность психопатологически не отягощена. Раннее развитие без особенностей. В школу пошел в 8 лет. Окончил 10 классов, затем институт народного хозяйства. В 1991-1992 годах служил в армии. После демобилизации работал по специальности. Женат. Жена старше на 2 года, работает преподавателем ВУЗа. Имеет 2 детей. Из перенесенных заболеваний отмечает пневмонию, бронхит, ангины. В 1993-1996 годах

трижды амбулаторно лечился у уролога по поводу хронического простатита. При обострениях заболевания отмечал неприятные ощущения и боли в промежности,

440

яичках, некоторое укорочение продолжительности коитуса. Курит с 17 лет по 15-20 сигарет в день. Алкоголь употребляет 3 - 4 раза в месяц, преимущественно вина и пиво.

Либидо с 14 лет, с того же времени и ночные поллюции. Мастурбация с 14 до 16 лет: прекратил, поскольку родители напугали его неблагоприятными последствиями для здоровья. Поллюции происходили с частотой 3 - 4 раза в месяц. С 16 до 19 лет периодические сексуальные фрустрации. Половая жизнь с 19 лет, нерегулярная. До брака имел 4 сексуальных партнерш. Женат с 24 лет. Максимальный сексуальный эксцесс - 3 (в медовый месяц). УФР с 29 лет. Установившаяся длительность половых актов составляла 2 - 4 минуты. Диапазон приемлемости достаточно широкий. Прелюдия всегда была короткой (до 5 минут), и только около полугода в связи с неустойчивой эрекцией предварительные ласки удлинились до 15 - 20 минут. Ранее супруга испытывала оргазм в 70 - 80 % половых актов, последние 5 - 6 месяцев не чаще, чем в 10 % случаев. До возникновения нарушений половая жизнь с частотой 2-3 раза в неделю.

Объективные данные. Рост 179 см, масса тела 78 кг. Правильного телосложения. Трохантерный индекс 1,97. Оволосение лобка по мужскому типу с тенденцией к горизонтальному. АД 130/80 мм рт. ст. Пульс лежа 74 уд. в мин, стоя - 86 уд. в мин. Тоны сердца слегка приглушены.

Нервная система. Черепно-мозговая иннервация в норме. Сухожильно-периостальные рефлексы равномерно оживлены, брюшные рефлексы не вызываются. Патологических стопных рефлексов нет. Ладони влажные, теплые. Дермографизм ярко красный, появляется через 8 секунд, держится 10 минут. Генитальные рефлексы сохранены.

Мочеполовая система. Половой член длиной 9,5 см, окружность - 9 см; яички - 4,6 см по длинной оси, плотно-эластичной консистенции. При пальпации тыльных артерий пениса пульсация определяется неотчетливо. Предстательная железа величиной с каштан, плотно-эластичной

консистенции, поверхность бугристая, четко определяются ее границы, междолевая бороздка сглажена. После непродолжительного массажа выделилось много секрета. Микроскопическое исследование сока простаты: лейкоциты 5-6 в поле зрения, умеренное количества лецитиновых зерен.

441

Данные ультразвуковой допплерографии: объемный кровоток по тыльным и глубоким пенильным артериям незначительно снижен. После интракавернозной фармакологической нагрузки (5мкг каверджекта) через 7 минут после инъекции отмечается полная ригидность полового члена. При этом регистрируется почти 4-кратное возрастание кровотока справа и 3,5-кратное его увеличение слева, что свидетельствует об отсутствии патологических изменений сосудистого русла гениталий.

Показатели половой конституции: Кг = 4,25; Ка = 3,33; Ка/Кг = 0,78 (ослабленный вариант средней половой конституции).

Психический статус. Больной во время беседы держится напряженно. Проявляет признаки беспокойства: суетливо потирает руки, постукивает ими по столу, несколько раз пересаживается на стуле. При ответах на вопросы врача многоречив. Детализирует свои жалобы и в первую очередь затруднения в сексуальной сфере. Неодобрительно отзывается о жене, которая упрекает его в половой слабости. Опасается, что жена подаст на развод, поскольку в возможность его излечения верит слабо. Очень переживает по поводу сложившейся в семье ситуации. Утверждает, что последние месяцы не может продуктивно работать из-за того, что постоянно думает о своих сексуальных проблемах. Замечает, что заметно изменился по характеру: стал беспокойным, раздражительным, обидчивым, замкнутым. Последние месяцы ничего в жизни не радует, и даже плаванье на яхте, которое он обычно совершает с друзьями в отпуске, не принесло прежних положительных эмоций и ощущения хорошего отдыха. Нарушился сон, поэтому днем чувствует себя уставшим и разбитым. На работе очень трудно заставить себя на чем-то сосредоточиться. Настроение почти постоянно снижено, его суточных колебаний не отмечает. Весьма пессимистичен в оценках своего состояния и перспектив на выздоровление. Говорит, что просто боится предпринимать какие-то попытки

к сближению с супругой, поскольку все это бесполезно и, кроме огорчений, ничего больше не дает.

Диагностическое заключение: адаптационное расстройство (обусловленное коитофобией и семейно-сексуальной дисгармонией), смешанная тревожная и депрессивная реакция.

442

Анализ наблюдения. В приведенном случае первые затруднения в половой жизни у больного возникли на фоне сильных эмоциональных переживаний в связи с неблагоприятной ситуацией на работе. На фоне упреков супруги произошла невротическая фиксация на сексуальной сфере с ослаблением адекватных эрекций и укорочением продолжительности коитуса. Попытки изменить ситуацию к лучшему не принесли ожидаемого результат а. По степени о нарушения эрекции прогрессировали, половые акты урежались и уменьшалась их продолжительность. Все больше попыток совершить коитус заканчивались неудачей из-за отсутствия или резкого ослабления эрекции. Тревожные опасения по поводу возможных неудач при половом акте значительно увеличивали вероятность срывов даже при активизации предварительных ласк или использовании для коитуса спонтанных утренних эрекций. Страх потерпеть фиаско, усиливающийся после каждой неудачной попытки, к моменту обращения за помощью заставил больного практически отказаться от интимной близости с супругой, несмотря на наличие полового влечения и периодически возникающих эрекций. К особенностям данного клинического случая следует отнести генерализацию невротической симптоматики с присоединением к поначалу относительно изолированным тревожным опасениям сексуальной неудачи тревожно-депрессивных проявлений, сопровождающихся вегетативными нарушениями и инсомнией. Учитывая отчетливую временную связь между нарастающей семейно-сексуальной дисгармонией и возникновением около 2 месяцев назад смешанной тревожной и депрессивной симптоматики, следует рассматривать возникшие психопатологические нарушения как проявления адаптационного расстройства, обусловленного стрессовым фактором, в качестве которого для пациента выступали нарастающие проблемы семейно-сек-суального характера.

Лечение данного больного проводилось с учетом всех психогенных механизмов, участвующих в формировании у него психической и сексуальной патологии. С целью коррекции тревожно-депрессивных проявлений на протяжении 1 месяца получал тианептин (коаксил) по 1 таблетке 3 раза в день. Психотерапевтическое лечение было акцентировано на устранение страха перед неудачей при коитусе, а также улучшение межличностных отношений и гармонизации сек-

суального взаимодействия с супругой. Проведено 5 сеансов гипнотерапии, причем первые 3 были посвящены работе с внутренними ресурсами и были направлены на восстановление состояния душевного равновесия пациента и обучение его способам достижения спокойного, комфортного состояния, а 2 последующих сеанса имели целью устранение страха перед близостью и обретение прежних чувственных переживаний. Нейтрализация наиболее травматичных воспоминаний о сексуальных срывах осуществлена с помощью ВКД с последующим выполнением техники взмаха для разрушения внутренних негативных образов, блокирующих сексуальные реакции пациента при интимном сближении. Параллельно с индивидуальной психотерапией проведены 4 сессии супружеской терапии, которые были посвящены изменению характера коммуникаций между супругами, прояснению их разногласий и взаимных ожиданий, выработке более адекватного стиля взаимодействия в различных житейских ситуациях, а также при сексуальных контактах. Через 10 дней после начала курса лечения больной отметил усиление спонтанных и адекватных (вне ситуации интимной близости) эрекций. Почувствовал себя гораздо спокойнее и увереннее, улучшилось настроение. На фоне супружеской терапии прекратились бесплодные выяснения отношений с женой, которая повела себя с больным более адекватно. Через 2,5 недели после начала терапевтического курса совершил первый удачный коитус и далее стал проводить половые акты с супругой *2* раза в неделю при возросшей до 3 - 4 минут длительности полового акта.

СФМ (после окончания курса лечения): 3, 3, 3/3; 3; 4/3, 4, 3/ 3-9/ 10/10/ 3-32.

Катамнез 2 года. Все это время сохраняются установившиеся в ходе лечения ритм половой активности и продолжительность коитуса. Явных

сексуальных неудач не отмечает. Взаимоотношения с женой расценивает как стабильные и вполне удовлетворен ими.

Клиническое наблюдение № 2

Больной Н., КСО-127Н, 48 лет, работает старшим мастером на Минском автомобильном заводе

СФМ: 3; 1; 1/1; 1,5; 2/1; 1; 0/1-5/4,5/2/1-12,5

Предъявляет жалобы на слабость эрекции при редких попытках совершить половой акт, ускоренное семяизвержение, снижение настроения, раздражительность, чувство неуверенности во время интимной близости, навязчивые мысли о сексуальной неполноценности и возможном разрыве супружеских отношений.

Впервые мысли о наличии сексуального расстройства возникли у больного примерно 9 месяцев назад, когда супруга начала открыто выражать ему свое недовольство короткими, редкими половыми актами и ослаблением эрекции при интимных контактах. Был весьма уязвлен упреками жены, поскольку считал, что некоторое ослабление потенции в течение последнего года вызвано переутомлением, связанным со строительством дачи и напряженной работой на производстве. Больной решил чаще отдыхать и больше внимания уделять интимной жизни. Однако попытки восстановить прежнюю сексуальную активность и совершать половые акты не менее трех раз в неделю привели к тому, что, несмотря на активизацию и удлинение прекоитальных ласк, примерно в половине случаев эрекции вообще не возникало либо она ослабевала без эякуляции через 20-30 секунд после начала фрикций. Учащение неудачных половых актов вызвало еще большее раздражение у супруги больного, которая стала упрекать его в сексуальной несостоятельности. Тяжело переживал ухудшение интимных отношений с женой. Перед близостью подолгу настраивался, мысленно контролировал качество сексуальных реакций. Но чем больше усилий прилагал для улучшения адекватных эрекций, тем хуже они становились. Обратился к экстрасенсу, который пообещал за 4 сеанса избавить его от всех сексуальных нарушений. Однако ожидаемого улучшения не последовало, что убедило

больного в тяжести полового расстройства. Забросил дачное строительство, принялся изучать медицинскую литературу, чтобы получше разобраться в своем заболевании. Постепенно снизилось настроение, усилился страх потерпеть неудачу при половой близости в связи с чем начал избегать сексуальных контактов. Отношения с супругой весьма напряженные, периодически возникают ссоры по бытовым вопросам. Несмотря на сохранное либидо и наличие кратковременных спонтанных эрекций, за последние 3,5 месяца предпринял лишь три по-

пытки совершить половой акт. Из них удалась одна, причем эрекция во время коитуса была неполной и эякуляция произошла примерно через полминуты после начала фрикций. В двух других случаях, несмотря на весьма формальные попытки супруги мануально стимулировать половой член, устойчивая эрекция у пациента так и не возникла, что сопровождалось нелицеприятными комментариями о его мужских достоинствах. В связи с указанными проблемами обратился в Минский городской сексологический центр.

Из анамнеза. Родился вторым ребенком в семье рабочих. Наследственность психопатологически не отягощена. Раннее развитие без особенностей. В школу пошел с 7 лет, окончил 8 классов и индустриальный техникум. Два года служил в армии. Работал слесарем, мастером, последние 4 года - старшим мастером на производстве. Работой вполне доволен. Всегда был подвижным, энергичным. Однако еще в школьные годы отмечал появление в характере мнительности, неуверенности в себе. Женат с 29 лет. Жена на 5 лет моложе. Имеет двух детей. Семья проживает в отдельной квартире. Курит около 30 лет, в последние годы не более 10 - 15 сигарет в день. Алкоголь употребляет 1 - 2 раза в месяц по 200 - 300 г водки, в последние 2 - 2,5 года прием даже небольших доз спиртного подавляет эрекцию. Из перенесенных заболеваний отмечает болезнь Боткина, страдает хроническим гастритом. Поллюции с 13 лет, либидо с 14 лет. С того же времени мастурбация с частотой 4-5 раз в неделю до 20 лет.

Первый коитус со случайной партнершей в состоянии алкогольного опьянения в 20,5 лет (как протекал точно не помнит). С 21 до 23 лет имел

постоянную половую партнершу, с которой встречался по выходным дням, поскольку она жила в другом городе. За два дня обычно совершал 4-5 коитусов. Затем познакомился с будущей женой, до брака половых актов с ней не было. Женат с 24 лет. Жена на 4 года моложе. Первый год после вступления в брак ритм половой жизни 8 - 10 раз в неделю. Максимальный эксцесс 4, в 26 лет. УФР с 36 лет. Средняя продолжительность коитуса (при регулярной половой жизни) 5 - 6 минут. Сексуальная активность в последний год до начала заболевания 2 - 3 раза в неделю. Внебрачные связи в последние 10 лет отрицает. Отношения с женой прежде были доброжела-

тельные. Ее сексуальность пробудилась через три года после вступления в брак. Оргастичность около 60 %, сексуальная притязательность средняя. На фоне сексуальной дисфункции у мужа оргастичность снизилась до 10 %. Период предварительных ласк до последнего времени был редуцирован. В связи с торпидностью эрекции при половой близости последний год жена больного иногда прибегает к мануальной стимуляции его гениталий, предварительные ласки удлинились до 20 - 25 минут.

Объективные данные: рост 172 см, масса тела 74 кг, ширина таза 36 см, плеч 46 см. Трохантерный индекс 1,98. Оволосение лобка по мужскому типу. Кг = 5,2; Ка = 5; Ка/ Кг = 0,96 (средняя половая конституция). АД 130/75 мм рт. ст. Пульс 78 в 1 мин. Со стороны внутренних органов патологии не отмечено.

Неврологически: черепно-мозговая инервация в пределах нормы. Сухожильно-периостальные рефлексы симметричные, живые, патологические рефлексы не вызываются. Легкая гипостезия головки полового члена. Бульбо-кавернозный и кремастерный рефлексы не нарушены.

Мочеполовая система: половой член - длина 10 см, окружность 9,5 см правое яичко 5 см по длинной оси, левое - 4,6 см предстательная железа величиной с крупный каштан, эластичной консистенции, безболезненная при пальпации. Междолевая бороздка хорошо выражена. При массаже удалось получить небольшое количества секрета. Микроскопическая картина секрета

простаты без отклонений от нормы. Заключение нейроофтальмолога: калибр сосудов глазного дна не изменен.

По данным реоэнцефалографии, удовлетворительное кровенаполнение всех сосудистых зон мозга.

Фармакологический тест: при интракавернозном введении 5 мкг каверджекта через 9 минут возникла неполная эрекция, которая продолжалась около 25 минут (угол эрекции = 60°). При повторном (через три дня) введении в кавернозное тело 10 мкг каверджекта через 8 минут зарегистрирована практически полная эрекция продолжительностью 45 минут (угол эрекции = 80°). Ультразвуковая допплерография: выявлена асимметрия кровотока в тыльных артериях пениса, после фармакологической нагрузки кровоток по левым тыльной и глубокой артериям не достигает

условной нормы. Там же регистрируется допплерографический сигнал стенотического типа.

Психический статус. В начале беседы больной несколько скован, внимательно следит за врачом. Постепенно успокаивается, все более охотно отвечает на вопросы. Склонен драматизировать отношения с супругой, считает, что, если он не поправится, жена его не просто бросит, но еще и опозорит. Высказывает ряд гипотез по поводу собственного сексуального расстройства, приводит сведения из научно-популярной и медицинской литературы. Считает, что у него тяжелая форма мужского климакса, которая привела «почти к полной импотенции». Говорит, что готов на любые лечебные манипуляции ради сохранения семьи. Активно интересуется возможностями лечения, заявляет, что при необходимости готов даже на хирургическую операцию. Обнаруживает выраженную эмоциональную лабильность с преобладанием пониженного фона настроения. К сексологическому обследованию и предложенному лечению отношение настороженное, скептическое.

Диагностическое заключение*:* недостаточность генитальной реакции (эрекционная дисфункция преимущественно психогенного генеза, обусловленная коитофобией и нарастанием дисгармонии в супружеских отношениях на фоне легкого снижения генитального кровотока атеросклеротического генеза).

Анализ наблюдения. Приведенное наблюдение представляет интерес тем, что у больного около года отмечались начальные признаки снижения генитального кровотока: некоторое ослабление и замедленное возникновение адекватных эрекций, отнюдь не исключающие возможность проведения коитуса. Пока пациент не обращал особого внимания на состояние сексуальной сферы у него возникали лишь незначительные затруднения из-за торпидности эрекции в прекоитальной фазе. Нетактичные замечания супруги по поводу снижения потенции оказали на пациента сильное психотравмирующее воздействие. Он начал анализировать свои сексуальные реакции и действительно отметил некоторое ослабление эрекций и снижение половой активности, которые являлись начальными признаками нарушения кровоснабжения гениталий. Указанные симптомы подверглись невротической фикса-

ции, к чему предрасполагали тревожно-мнительные черты в характере больного. Дальнейшее нарастание половой дисфункции в решающей степени было связано с невротическими расстройствами, присоединившимися к первоначальному ухудшению качества эрекций сосудистого генеза. Попытки пациента поддерживать прежний уровень половой активности без учета реальных возможностей привели к учащению неудачных половых актов и супружеским конфликтам. Усиление на этом фоне тревожного ожидания новых срывов с фиксацией внимания на малейших изменениях потенции, в свою очередь, еще больше усугубило половую дисфункцию. В конечном итоге пациент стал всячески уклоняться от интимной близости из-за сильного страха в очередной раз обнаружить сексуальную несостоятельность, что свидетельствовало о формировании у него коитофобии. При объективном обследовании обнаружена диссоциация между наличием жалоб на серьезные затруднения при попытках совершить коитус и легким (компенсированным) снижением кровоснабжения кавернозных тел, выявленным при УЗДГ, которым нельзя было объяснить имеющиеся у больного сексуальные проблемы.

Лечение данной сексуальной дисфункции было комбинированным и включало курс психотерапии наряду с использованием методов активизации генитального кровотока. Для усиления кровоснабжения кавернозных тел на

протяжении полутора месяцев пациент получал комбинацию вазоактивных препаратов: ницерголина (сермиона) 0,03 г в сутки и пентоксифиллина (трентала) 0,3 г в сутки внутрь. Дополнительно проведено 14 процедур локальной декомпрессии (с интервалами между процедурами в 1-2 дня). Параллельно осуществлялась психотерапевтическая коррекция коитофобии и нарушенных партнерских отношений (как проблем межличностного общения, так и сексуального взаимодействия). Пациенту было проведено 3 сеанса ДПДГ для переработки наиболее запомнившихся сексуальных неудач, нейтрализации страха, возникающего при демонстрации супругой своего желания близости, а также присоединения к будущему свободному от тревожного ожидания нового срыва. С целью усиления вовлеченности в чувственные переживания интимной близости

и обретения уверенности в своих силах пациент прошел 3 сеанса эриксоновской гипнотерапии. В гипнотических трансах применялись приемы, позволяющие получить доступ к ресурсным воспоминаниям и метафорическая техника «мост», моделировался оптимальный паттерн поведения в ходе коитуса. Индивидуальные сеансы чередовались с 5 сессиями супружеской психотерапии. Работа с парой была направлена на выявление поведенческих паттернов, которые привели к нарастанию негативных тенденций во взаимоотношениях, выработку и закрепление на практике более продуктивных форм общения друг с другом, способствовавших переходу супругов от конфронтации к сотрудничеству и росту взаимопонимания и доверия между ними. С этой целью использовались техника инсценировки, техника прояснения коммуникаций, прием сравнения ценностей, один из вариантов «двойственного договора» - техника тройного увеличения и некоторые другие. Для выработки более адекватных представлений о человеческой сексуальности и проблемах в половой жизни супругам для прочтения были предложены книги М. Яффе, Э. Фенвик «Секс в жизни мужчины» и «Секс в жизни женщины». При работе с супружеской парой были уточнены индивидуальные сексуальные предпочтения каждого из партнеров, взаимные претензии и пожелания, обсуждены

обоюдоприемлемые варианты интимной близости (с учетом торпидности генитальных реакций мужа из-за некоторого снижения регионального кровотока). В результате была выработана наиболее подходящая для пары модель сексуального взаимодействия. В ходе 1,5-месячного курса лечения удалось добиться улучшения качества адекватных эрекций и восстановления прежнего ритма половой жизни (до 2 раз в неделю) при длительности коитуса около 3 - 4 минут.

СФМ (после лечения): 3; 3; 3/3; 3; 3,5/3; 3; 3/3-9/9, 5/9/3-30,5.

Катамнез 1,5 года. Спонтанные эрекции сохранены, адекватные чаще возникают после дополнительной мануальной стимуляции. Ритм половой жизни 1 - 2 раза в неделю, эрекция во время фрикций удовлетворительная (в единичных случаях ослабевает через 1,5 - 2 минуты без эякуляции). Длительность полового акта в пределах 2-4 минут. Взаимоотношения с супругой ровные, с пониманием стала относиться к его проблемам.

Около полугода назад повторно обратился в связи с некоторым ослаблением эрекции. При ультразвуковой допплерографии было выявлено снижение кровотока по левым тыльной и глубокой пенильным артериям. Прошел двухмесячный курс лечения экстрактом листьев гинкго билоба (танаканом) по 120 мг в сутки в сочетании с приемом 5-10 мг йохимбина за 1,5-2 часа до возможного коитуса. Первые 3 недели дополнительно получал милдронат по 1 г в сутки. С интервалами в 2-3 дня проведено 10 сеансов локальной декомпрессии. Достигнутое улучшение сохраняется на момент катамнестического обследования.

Клиническое наблюдение № 3

Больной С., КСО-618С, 40 лет, ИО-15
Автослесарь таксопарка

СФМ 3,2,2/1; 1,5; 2,5/1,1,1/1-7/5/3/1-16

Предъявляет жалобы на слабость эрекции, малую продолжительность коитуса, снижение остроты оргазма. Наряду с сексологическими жалобами отмечает чрезмерную раздражительность, внутреннее беспокойство, головные боли, временами головокружение, сердцебиение. Пациента много лет преследуют навязчивые воспоминания о бое с «душманами», когда у него на глазах погиб друг, а сам он был ранен в руку. Испытывает трудности при засыпании, периодически беспокоят повторяющиеся ночные кошмары, в которых фигурируют события Афганской войны.

Примерно через год после ранения и последующего лечения в госпитале пациент стал испытывать смутную беспричинную тревогу, ухудшилось настроение, раздражался по малейшему поводу, беспокоили кошмарные сновидения, сердцебиение, головокружение, колебания артериального давления. Военные врачи расценили состояние пациента, как проявление нейроциркуляторной дистонии. Получал лечение, но названия препаратов не запомнил. Отмечает, что еще несколько раз с интервалами в 1 - 2 года возникали похожие нарушения, по поводу которых он обращался к невропатологам, терапевтам и психоневрологам. Получал белласпон, корданум, реланиум, тазепам, феназепам, сонапакс, триптизол и другие препараты. Впервые сексуальные

проблемы возникли около 3 лет назад, когда на фоне очередного ухудшения состояния со снижением настроения, усилением тревоги и навязчивых мыслей, связанных с травматическими воспоминаниями, резко сократилась продолжительность полового акта, периодически наблюдалось ослабление эрекции при попытках интимной близости. В этот же период лечился амбулаторно в Минском ГПНД: принимал алпразолам, пропранолол, амитриптилин. По мере редукции тревожно-депрессивной симптоматики и улучшения сна у пациента восстановилась прежняя длительность коитуса и усилилась эрекция, поэтому за сексологической помощью не обращался. Более года назад после серьезного производственного конфликта снова почувствовал себя хуже. Усилились внутреннее беспокойство, раздражительность, эмоциональные колебания с преобладанием депрессивного аффекта, симптомы вегетативной дисфункции, навязчивые мысли о том, что он неудачник и не имеет жизненных перспектив, которые перемежались тягостными воспоминаниями об афганских событиях, обвинениями себя в гибели друга. В течение нескольких месяцев

злоупотреблял алкоголем, «чтобы хоть немного расслабиться и забыться». За неоднократные нарушения трудовой дисциплины пациента вначале понизили в должности, а затем и уволили с работы. В этот период «все было как в тумане, ничего не хотелось». Половая жизнь была весьма нерегулярной, вновь стали отмечаться срывы, а если коитус и удавался, то протекал слишком быстро, вызывая нарекания супруги. В семье стали возникать конфликты, которые поначалу больше были связаны с пьянством пациента и потерей им работы. На протяжении последнего года пытался совершать половые акты с частотой примерно 2 - 3 раза в месяц. Нередко попытки вообще не удавались из-за слабой эрекции. Примерно в половине случаев коитус происходил при неполной эрекции, а через 10 - 20 фрикций возникала эякуляция. После того как жена подала на развод, пациенту удалось уменьшить потребление алкоголя и устроиться на работу автомехаником. В связи с сохраняющимся внутренним дискомфортом и нарушениями сна по собственной инициативе стал принимать ксанакс и радедорм на ночь. Однако, несмотря на ослабление тревоги и навязчивых мыслей и даже некоторое улучшение взаимо

отношений с супругой, интимная жизнь «продолжала давать сбои». По-прежнему испытывал чувство неуверенности в собственных силах и сомнения в своих способностях удовлетворить жену при половой близости. Тяжело переживал сексуальные неудачи, постоянно об этом думал. Почувствовал себя «еще более никчемным и никому не нужным». Расценил все происходящее с ним как «наказание за то, что не смог уберечь друга от смерти». Снова усилились раздражительность и беспокойство, снизилось настроение, подолгу не мог уснуть, временами просыпался от ночных кошмаров. Часто конфликтовал с женой, обвиняя ее в отсутствии чуткости и уважения к нему, а также пассивности при интимной близости. Будучи ветераном войны в Афганистане получил направление на стационарное обследование в БНИИЭТИНе, где состояние пациента впервые было квалифицировано как посттравматическое стрессовое расстройство с отставленным началом и хроническим типом течения. Говорит, что лишь в

ходе обследования, заполняя опросник СФМ, он «впервые подумал всерьез, что в 40 лет стоит попытаться нормализовать сексуальные отношения с женой хотя бы для того, чтобы сохранить семью».

Из анамнеза. Родился первым из 2 детей в семье военнослужащего. Наследственность психопатологически не отягощена. Раннее развитие без особенностей. В школу пошел в 7 лет. Окончил 10 классов, высшее военное училище бронетанковых войск. С 1983 года служил офицером в СА. В 1988 году участвовал в боевых действиях на территории Афганистана. После ранения проходил службу в Казахстане, где демобилизовался в 1992 году по причине расформирования воинской части. Женат с 22 лет. Жена моложе на 3 года, работает учителем английского языка в школе. Имеет одну дочь. С 1993 года вместе с семьей живет в Беларуси. Работал инженером, начальником автоколонны, последний год - автомехаником в таксопарке. Из перенесенных заболеваний отмечает болезнь Боткина, пневмонию. Имеет осколочное ранение в правое плечо. Курит с 16 лет по 20 сигарет в день. С 1992 года неоднократно отмечались эпизоды злоупотребления алкоголем. На наркологическом учете не состоит. Последний год алкоголь употребляет 3-4 раза в месяц, преимущественно пиво (1,5-2 литра). Либидо

с 13 лет, с того же времени и ночные поллюции. Мастурбация с 14 до 22 лет. Половая жизнь с 18 лет, нерегулярная. Всего имел сексуальные связи с 6 партнершами. Первый год после женитьбы жили с женой в разных городах, поэтому половые акты были достаточно редкими. Максимальный сексуальный эксцесс - 4, в возрасте 22 лет. УФР с 36 лет. Установившаяся продолжительность половых актов составляла около 4 - 5 минут. Диапазон приемлемости широкий. Прелюдия обычно 5 - 10 минут. Ранее супруга испытывала оргазм не менее чем в 80 % половых актов, последний год не чаще 10 %. До возникновения сексуальных нарушений совершал половые акты с частотой 2 - 3 раза в неделю.

Объективные данные. Рост 179 см, масса тела.78 кг. Правильного телосложения. Трохантерный индекс 1,97. Оволосение лобка по мужскому

типу с тенденцией к горизонтальному. АД 140/90 мм рт. ст. Пульс лежа 72 уд. в мин, стоя - 86 уд. в мин. Тоны сердца несколько приглушены.

Нервная система. Сглажена левая носогубная складка. Сухожильно-периостальные рефлексы равномерно оживлены, брюшные рефлексы вялые. Ладони влажные, прохладные. Дермографизм ярко-красный, появляется через 7 секунд, держится 9 минут. Генитальные рефлексы сохранены. Легкая гиперестезия головки полового члена в области уздечки.

Мочеполовая система. Половой член длиной 8,5 см, окружность - 9 см; яички - 4,3 см по длинной оси, плотно-эластичной консистенции. Предстательная железа величиной с каштан, плотная, эластичная, поверхность гладкая, четко определяются ее границы, междолевая бороздка сглажена. После непродолжительного массажа выделилось большое количество секрета. Микроскопическое исследование сока простаты: лейкоциты 3-4 в поле зрения, умеренное количества лецитиновых зерен. По данным УЗДГ, кровоток по тыльным и глубоким пенильным артериям в пределах нормы. Данных за патологию кровоснабжения гениталий нет.

Показатели половой конституции: Кг=4,65; Ка=3,53; Ка/Кг=0,76 (средняя половая конституция).

Психическим статус. Больной держится настороженно. Сидит на стуле, скрестив руки и ноги, временами слегка вздрагивает, подергивает плечами. Смотрит на врача ис-

подлобья. На вопросы о сексуальных проблемах поначалу отвечает весьма формально. Говорит, что затруднения в сексуальной сфере выбивают у него почву из-под ног. Утверждает, что отношение супруги к нему изменилось в худшую сторону: «она стала игнорировать меня и под любым предлогом уклоняться от секса, ясно давая понять, что я как мужчина ни на что не годен». Считает несправедливыми упреки жены в равнодушии к ней и пренебрежения интересами семьи. Испытывает опасения, что жена вновь подаст на развод, «теперь уже из-за моей половой слабости». Очень переживает по поводу сложившейся в семье ситуации. Пациент отмечает, что заметно изменился по характеру: стал раздражительным, замкнутым, обидчивым. Говорит, что последнее время ничто в жизни не доставляет удовольствия. Почти постоянно ощущает внутреннее напряжение. Из-за

проблем с засыпанием и нередких кошмарных сновидений с пробуждениями днем чувствует себя уставшим и разбитым. Очень трудно на чем-то сконцентрировать свое внимание. Преобладает пониженный фон настроения без отчетливых суточных колебаний. Пессимистичен в оценках своего будущего и перспектив на выздоровление, хотя и «готов попробовать полечиться».

Диагностическое заключение: недостаточность генитальной реакции и преждевременная эякуляция, обусловленные хроническим ПТСР с отсроченным началом в стадии декомпенсации, тревожным ожиданием сексуальной неудачи и нарастающей супружеской дисгармонией.

Анализ наблюдения. Приведенное наблюдение достаточно показательно по нескольким причинам. Во-первых, правильный диагноз у пациента был впервые установлен примерно через 10 лет после начала заболевания, хотя за это время больной неоднократно обращался за медицинской помощью к раз-личным специалистам. Для ветеранов Афганистана это весьма типично, поскольку диагностические критерии ПТСР стали использоваться в нашей стране только в последние годы. Проблема адекватной диагностики боевого ПТСР безусловно осложняется отсутствием в МКБ-10 столь же четкого, как в DSM-IV, выделения типа расстройства. С учетом характерной клинической симптоматики, анамнестических сведений об отставленном (до 1 года) начале расстройства и его затяжном (около

10 лет), волнообразном течении, руководствуясь более детализированными критериями DSM-IV, у данного больного правомерно говорить о посттравматическом стрессовом расстройстве с отсроченным началом и хроническим течением. Во-вторых, половая дисфункция впервые возникла у пациента 3 года назад на фоне усиления психопатологической симптоматики при очередном обострении ПТСР, что свидетельствовало о вовлечении сексуальной сферы в его клиническую картину. На это указывало и спонтанное улучшение половой функции пациента по мере редукции симптоматики расстройства. В-третьих, сексуальные проблемы пациента в течение последнего года поначалу были обусловлены сложным переплетением патогенных факторов: стрессы, связанные с конфликтом на

работе и последующим увольнением, которые спровоцировали новое усиление симптоматики ПТСР, злоупотребление алкоголем, ухудшение супружеских отношений и упреки жены в безразличии к ней и ее желаниям в сексе. Попытки больного на столь неблагоприятном фоне «не ударить в грязь лицом хотя бы в постели «привели к обратному результату в связи с возникновением тревожного ожидания потерпеть очередную неудачу. Поэтому даже после некоторой стабилизации жизненной ситуации (пациент существенно ограничил употребление алкоголя, устроился на работу, супруга забрала свое заявление о разводе) интимные проблемы продолжали сохраняться. Тревожные опасения по поводу возможных сексуальных неудач при наличии психопатологических нарушений в рамках ПТСР существенно увеличивали вероятность новых срывов, которые только подтверждали пессимизм больного и привели к новому обострению отношений с супругой. Сохраняющиеся редкие половые контакты приобрели проверочный характер: «смогу или нет». Неудачные попытки крайне болезненно били по самолюбию пациента, приводя к усилению тревожно-депрессивной симптоматики и других проявлений ПТСР.

Коррекция сексуальной дисфункции у данного пациента проводилась как составная часть лечебно-реабилитационных мероприятий при ПТСР. В начале терапии, учитывая характер психопатологических нарушений, а также сексологическую симптоматику (наличие преждевременной эякуляции), пациенту был назначен сертралин с постепенным

повышением дозы до 75 мг/сутки (курс 2 месяца). Параллельно в первые 2,5 недели получал алпразолам-ретард 1 мг/сутки и пропранолол 60 мг/сутки. В этот же период прошел 5 сеансов гипнотерапии в групповом формате и был обучен приемам самопомощи по ослаблению тревоги (использование «самоякорения» ресурсных состояний и их визуализации, релаксационных упражнений и самостоятельного движения глаз для снятия стресса). После прекращения приема алпразолам-ретарда проведено 3 сеанса ДПДГ с целью переработки травматических воспоминаний, связанных с боевыми действиями, и кошмарных сновидений. (Считается, что на фоне приема транквилизаторов бензодиазепинового ряда эффект ДПДГ может снижаться.)

Анализ причин возникновения сексуальных нарушений у пациента выявил патогенную роль сразу нескольких факторов: обострения симптомов хронического ПТСР; тревожного ожидания неудачи при коитусе; неадекватных убеждений и установок, создающих у пациента искаженное представление о сексуальной норме; нарушений взаимоотношений с партнершей. Психопатологическая симптоматика коррегировалась вышеуказанными способами. Стратегия психотерапевтического лечения половой дисфункции строилась с учетом всех психологических факторов, способствующих сексуальной дезадаптации. На двух сессиях применялись техники когнитивной терапии для коррекции у пациента дисфункциональных схем мышления и когнитивных ошибок, приводящих к неадекватному восприятию собственных сексуальных затруднений. Проведены две сессии с применением техник для последовательного разрушения триггеров, тормозящих генитальные реакции мужчины в ситуациях интимной близости. Затем - один сеанс ДПДГ с целью нейтрализации двух наиболее травматичных воспоминаний о неудачных попытках совершить коитус и устранения страха перед возможным фиаско в будущем. Индивидуальные сессии чередовались с 4 сессиями супружеской психотерапии, направленными на повышение уровня коммуникаций партнеров и улучшение взаимоотношений между ними. В результате 2,5-месячного курса комплексного лечения существенно улучшилось психическое состояние и физическое самочувствие. В сексологическом плане было достигнуто улучшение качества адек-

ватных эрекций, восстановление прежнего ритма половой жизни (2-3 раза в неделю), а средняя продолжительность коитуса увеличилась до 8 - 10 минут. Несмотря на периодически возникающие конфликты, пациент и его супруга отметили значительное потепление в их отношениях.

СФМ (после лечения): 3; 3; 3/3; 3; 4/3; 3; 3/3-9/10/9/3-31,0.

Катамнез 2 года. За этот период сексологических жалоб не зарегистрировано. Супружеские отношения сохраняются на обоюдоприемлемом уровне. Эпизодически испытывает чувство беспокойства

и внутреннего дискомфорта, которые самостоятельно купирует, используя движения глаз и техники релаксации.

458

Литература

Алексеев Б.Е. Полоролевое поведение и его акцентуации. СПб.: Речь, 2006. - 144 с.

Андреас С., Фолкнер Ч. НЛП. Новые технологии успеха: Пер. с англ. М.: Гелиос, 2001. - 448 с.

Беккио Ж., Жюслен Ш. Новый гипноз: Практическое руководство: Пер. с фр. М.: Класс, 1998. - 160 с.

Берг-Кросс Л. Терапия супружеских пар: Пер. с англ. М.: Изд-во Института психотерапии, 2004. - 528 с.

Блазер А., Хайм Э., Томмен М. Проблемно-ориентированная психотерапия. Интегративный подход: Пер. с нем. М.: Класс, 1998. - 272с.

Вагнер Г., Грин Р. Импотенция / физиология, психология, хирургия, диагностика и лечение: Пер. с англ. М.: Медицина, 1985. - 240 с.

Варга А.Я. Системная семейная психотерапия: Краткий лекционный курс. СПб.: Речь, 2001. - 144 с.

Володин В.С. Основы медицинской сексологии (курс лекций): Учебное пособие. М.: Логос, 2003. - 240 с.

Гиллшен С. Терапевтические трансы: Руководство по эриксоновской гипнотерапии: Пер. с англ. М.: Класс, 1997. - 416 с.

Гипнотерапия / Под ред. М. Хипа, У. Драйдена. СПб.: Питер, 2001.- 352 с.

Голдстейн И. Импотенция: Пер. с англ./ Ред. Р.Б. Тейлор // Трудный диагноз: В 2 т. М.: Медицина, 1988. Т. 2. С. 7-24.

Гордеев М.Н. Классический и эриксоновский гипноз: Практическое руководство. М. Изд-во Института психотерапии. 2001. - 240 с.

Доморацкий В.А. Сексуальные расстройства и методы их коррекции у мужчин: Учебное пособие. - Минск: БГУ, 2002. - 192 с.

459

Доморацкий В.А. Сексуальные нарушения и их коррекция: Краткое практическое пособие по диагностике и лечению психогенных сексуальных дисфункций. Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 288 с.

Доморацкий В.А. Интегративная психотерапия в системе комплексного лечения сексуальных дисфункций у мужчин (клинико-терапевтическое исследование). Дисс. докт. мед. наук.// Белорусская медицинская академия последипломного образования. Минск, 2004. - 248 с.

Зейг Д. Мастер гипноза. Психотерапевтические манипуляции Милтона Эриксона: Пер. с англ. Минск: Издатель В.П.Ильин, 1998. - 190 с.

Имелинский К. Сексология и сексопатология: Пер. с польск. М.: Медицина, 1986. - 423 с.

Камерон-Бендлер А. С тех пор они жили счастливо: простая и эффективная психотерапия сексуальных проблем и трудностей во взаимоотношениях: Пер. с англ. Воронеж: МОДЕК, 1996. - 256 с.

Каплан Х. Сексуальная терапия. Иллюстрированное руководство: Пер. с англ. М.: Класс, 1994. - 160 с.

Каплан Г., Сэдок Б. Клиническая психиатрия: В 2 т.: Пер. с англ. М.: Медицина, 1994. Т. 1. - 672 с.; Т. 2. - 528 с.

Каплан Г., Сэдок Б. Клиническая психиатрия: Пер. с англ. / Гл. ред. Т.Б. Дмитриева. М.: ГЭОТАР Медицина, 1998. - 505 с.

Карвасарский Б.Д. Неврозы. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина, 1990. - 576 с.

Карвасарский Б.Д. (общая редакция). Психотерапевтическая энциклопедия. СПб.: ПитерКом, 1999. - 752 с.

Кочарян Г.С., Кочарян А.С. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов. М.: Медицина. 1994. - 224 с.

Кротовский Г.С. Лечение сосудистой импотенции. М.; СПб.: БИНОМ - Невский диалект, 1998. - 160 с.

Келли Г. Основы современной сексологии: Пер. с англ. СПб.: Питер, 2000. - 896 с.

Кемпер И. Практика сексуальной психотерапии: В 2 т.: Пер. с нем. М.: Прогресс - Культура, 1994. Т. 1.288 с.; Т. 2.192с.

Кинг М., Цитренбаум И. Экзистенциальная гипнотерапия: Пер. с англ. М.: Класс, 1998. - 176 с.

460

Кондратенко В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия: Учебное пособие. 2-е изд., доп. и перераб. Минск: Выш. шк., 1997. - 464с.

Кон И.С. Сексология: Учебное пособие для студентов высших учеб, заведений. М.: Академия, 2004. - 384 с.

Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний: Пер. с чешек. М.: Медицина, 1991. - 336 с.

Кришталь В.В., Гулъман Б.А., Григорян С.Р. Сексология: В 5 т. Харьков: Академия сексологических исследований, 1997. Т. 1. - 352 с.; Т. 2. - 272 с.; Т. 3. - 192 с.; Т. 4. - 176 с.; Т. 5.-152 с.

Кон И.С. Введение в сексологию. М.: Медицина, 1988. - 319с.

Лазарус А. Краткосрочная мультимодальная психотерапия: Пер. с англ. СПб.: Речь, 2001. - 256 с.

Лазарус А. Мысленным взором: образы как средство психотерапии: Пер. с англ. М.: Класс, 2000. - 144с.

Либих С.С., Фридкин В.И. Сексуальные дисгармонии. - Ташкент: Медицина, 1990. - 142 с.

Лоуэн А. Любовь и оргазм: Пер. с англ. М.: Ин-т обще-гуманитарных исследований, 1997. - 405 с.

Маданес К. Стратегическая семейная терапия: Пер. с англ. М.: Класс, 1999. - 272 с.

Макаров В.В. Избранные лекции по психотерапии. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая Книга, 2000. - 432 с.

Макаров В.В. Психотерапия нового века: М.: Академический Проект, ППЛ, 2001, - 496 с.

Макаров В.В. Прогулки в Фрейдом. М.: PerSe, 2007. - 462 с.

МакМаллин Р. Практикум по когнитивной терапии: Пер. с англ. СПб.: Речь, 2001. - 560 с.

Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Мастерс и Джонсом о любви и сексе: В 2 ч.: Пер. с англ. СПб.: Ретур, 1991. Ч. 1. - 264 с.; Ч. 2. - 296 с.

Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. М.г Мир, 1998. - 692 с.

Методы современной психотерапии: Учебное пособие / Сост.: Л. М. Кроль, Е.А. Пуртова. М.: Класс, 2001. - 480 с.

Миллс Д., Кроули Р. Терапевтические метафоры для детей и «внутреннего» ребенка: Пер. с англ. М.: Класс, 1996. - 144с.

461

Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии: Пер. с англ. М.: Класс, 1998. - 304 с.

О'Коннор Д., Сеймор Д. Введение в нейролингвистическое программирование: Пер. с англ. Челябинск: Версия, 1997. - 256 с.

Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. М.: Экспертное бюро - М, 1997. - 496 с.

Психические расстройства и расстройства поведения: (F00-F99). (Класс V МКБ-10, адаптированный для использования в Российской Федерации). М.: МЗ РФ, 1998. С. 286-292; С. 297-299; С. 320-331.

Пушкарев А.А., Доморацкий В.А., Гордеева Е.Г. Посттравматическое стрессовое расстройство: диагностика, психофармакотерапия, психотерапия. М.: Изд-во ин-та психотерапии, 2000. - 128 с.

Руководство по сексологии / Под ред. С.С. Либиха. СПб.: Питер, 2001. - 480 с.

Символдрама. Сб. науч. тр./ Под ред. Обухова и Поликарпова. Минск: Европейский гуманитарный университет, 2001. - 416 с.

Свядощ А.М. Женская сексопатология. 3-е изд. М.: Медицина, 1988. - 175с.

Сексопатология: Справочник /Под ред. Г.С. Васильченко. М.: Медицина, 1990. - 576 с.

Современная сексология: Энциклопедия / Под общ. ред. В.А. Доморацкого. Минск: Беларус. Энцыклапедыа імя П. Броукі, 2008 - 384 с.

Старович З. Судебная сексология: Пер. с польск. М.: Юрид. лит., 1991. - 336 с.

Стукалова Л.А., Виш И.М., Литарт Н.К. и др. Неврозы и сексуальные расстройства. Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1985. - 158 с.

Старшенбаум В.Г. Сексуальная и семейная психотерапия. М.: Изд-во Высшей школы психологии, 2003. - 300 с.

Ткаченко А.А., Введенский Г.Е., Дворянчиков Н.В. Судебная сексологическая экспертиза. М.: ГНЦ СиСП им. В.П. Сербского, 1998. Т. 1. - 360 с.

Ткаченко А.А. Сексуальные извращения - парафилии. М.: Триада-Х, 1999. - 461 с.

Уолен С.Д. Гуссен Р., Уэсслер Р. Рационально-эмотивная психотерапия: Пер. с англ. М.: Ин-т. Гуманитарных знаний, 1997. - 257с.

462

Федорова А.И. Диспарейния: патогенез, диагностика, лечение. Автореф. дисс. ... докт. мед. наук // Санкт-Петербургская Медицинская академия последипломного образования. СПб., 2007. - 50 с.

Хейли Д. Терапия испытанием: Необычные способы менять поведение: Пер. с англ. М.: Класс, 1998. - 212с.

Хейли Д. Что такое психотерапия: Пер. с англ. СПб.: Питер, 2002. - 224 с.

Частная сексопатология: В 2 т./ Под ред. Г.С. Васильченко. М.: Медицина, 1983. Т. 1. - 304 с.; Т. 2. - 352 с.

Черников А.В. Введение в семейную психотерапию. Интегративная модель диагностики: Тематическое приложение к журналу «Семейная психология и семейная терапия » за 1998 год. М„ 1998. - 152 с.

Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии. М.: Триада-Х, 1999. - 232 с.

Шапиро Ф. Психотерапия эмоциональных травм с помощью движений глаз: Основные принципы, протоколы и процедуры: Пер. с англ. М.: Класс, 1998. - 496 с.

Шерман Р., Фредман Н. Структурированные техники семейной и супружеской терапии: Руководство: Пер. с англ. М.: Класс, 1997. - 336 с.

Штарке К., Фридрих В. Любовь и сексуальность до 30 лет.: Пер. с нем. М.: Высш. шк., 1991. - 383 с.

Щеглов А.М. Сексология и сексопатология// Врачу и пациенту. СПб.: Культ-информ-пресс, 1998. - 416 с.

Эволюция психотерапии: В 4 т. Пер. с англ. /Под ред. Д. Зейга. М.: Класс, 1998. Т. 1. - 304 с., Т. 2. - 416 с., Т. 3. - 304 с., Т. 4. - 320 с.

Эриксон М. Мой голос останется с вами: обучающие истории Милтона Эриксона: Пер с англ. СПб.: Петербург - XXI век, 1995. - 256с.

Эриксон М. Стратегии психотерапии: Избр. работы: Пер. с англ. СПб.: Летний сад, 1999. - 512 с.

Эриксон М., Росси Э. Гипнотические реальности: Наведение клинического гипноза и формы косвенного внушения: Пер. с англ. М.: Класс, 1999. - 352 с.

Ялом И. Экзистенциальная психотерапия: Пер. с англ. М.: Класс, 1999. – 576 с.

Ялом. И. Теория и практика групповой психотерапии: Пер. с англ. СПб.: Питер, 2000. - 640 с.

Kaplan H. S., Disorders of sexual desire and other new concepts and techniques in sex therapy. N.Y.: Brunner/Mazel, 1987.

Kaplan H. S., The sexual desire disorders: Dysfunctional regulation of sexual motivation. N.Y.: Brunner/Mazel, 1995.

Laumann E., Gagon J., Michels B., Michels S. The social organization of sexuality. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1994.

Rosen R., Leiblum S., Case studies in sex therapy. N.Y.: Guilford Press, 1995.

Wespes E., Impuissance organique masculine. Paris: D/o. Ornament, 1989.

Содержание

Введение.....3

Глава 1. Сексуальность человека.....5
Половой диморфизм.....5
Формирование либидо.....9
Сексуальные реакции и копулятивный цикл.....12
Сексуальное поведение.....18
Гендер.....21
Половая конституция.....22
Сексуальная норма.....30
Сексуальность в современном обществе.....35
Особенности мужской и женской сексуальности.....39
1.10 Сексология и сексопатология.....47
Глава 2. Сексуальные дисгармонии и дисфункции.....52
2.1 Сексуальные дисгармонии.....52
Социально-психологические дисгармонии……..……...55
Поведенческие (технические) дисгармонии.……..……58
Физиологические дисгармонии.....59
Дисгармонии, связанные с патологией…..…….……62
2.2. Мнимые сексуальные расстройства.....66
2.3. Эпидемиология и систематика расстройств сексуальной функции.68
2.4. Принципы классификации сексуальных дисфункций в МКБ-10….74
Психогенные половые дисфункции (сексуальные неврозы)……76
2.5. Механизмы психологической адаптации к сексуальным дисфункциям..79
2.6. Обследование пациентов с сексуальными расстройствами……84
2.7. Современные подходы к лечению сексуальных дисфункций…….91

465

Физиотерапевтические методы влечении половых дисфункций 94
2.8. Клинические варианты сексуальных дисфункций и их терапия. 98
F52.0. Отсутствие или потеря полового влечения.....100
F52.1. Сексуальное отвращение и отсутствие полового удовлетворения.....111
F52.10. Сексуальное отвращение.....111
F52.11. Отсутствие сексуального удовлетворения.....115
F52.2. Недостаточность генитальной реакции.....117
F52.3. Оргазмическая дисфункция. 132
F52.4. Преждевременная эякуляция.....154
F52.41. Абсолютное ускорение семяизвержения.....154
F52.42. Относительное ускорение семяизвержения.....154
F52.49. Ускорение семяизвержения неуточненное.....155
F52.5. Вагинизм неорганического происхождения.....161
F52.6 Диспареуния неорганического происхождения.....164
F52.7. Повышенное половое влечение.....172
F52.8. Другая сексуальная дисфункция, не обусловленная органическим нарушением или болезнью.....176
F52.9. Сексуальная дисфункция, не обусловленная органическими нарушениями или болезнью, неуточненная.....177

2.9. Зависимость от алкоголя (F10...) и сексуальные дисфункции.....177

Глава 3. Нарушения психосексуального развития.....182
3.1. Психосексуальное развитие человека.....182
3.2. Нарушения темпов и сроков психосексуального развития…….192
3.3. Нарушение стереотипа полоролевого поведения…….195

3.4. Феномен гомосексуальности.....204
3.5. Сексуальные девиации.....214
3.6. Сексуальные перверсии.....219
3.7. Расстройства половой идентификации (F64).....225
F64.0. Транссексуализм.....225
F64.1. Трансвестизм двойной роли 228
F64.2. Расстройства половой идентификации в детском возрасте. 230
F64.21. Расстройство половой идентификации в детском возрасте транссексуального типа.....232
F64.22. Расстройство половой идентификации в детском возрасте трансролевого типа.....232
F64.29. Расстройство половой идентификации в детском возрасте неуточненное.....232
F64.8. Другое расстройство половой идентификации. 232
F64.9. Расстройство половой идентификации неуточненное 232
3.8. Расстройства сексуального предпочтения (F65.....233
F65.0. Фетишизм.....233
F65.1. Фетишистский трансвестизм.....234
F65.2. Эксгибиционизм. 234
F65.21. Эксгибиционизм, садистический тип.....235
F65.22. Эксгибиционизм, мазохистический тип 235
F65.29. Эксгибиционизм неуточненный. 235
F65.3. Вуайеризм. 235
F65.4. Педофилия 235
F65.5. Садомазохизм. 236
F65.6. Множественные расстройства сексуального предпочтения. 236
F65.8. Другие расстройства сексуального предпочтения. 237
F65.9. Расстройство сексуального предпочтения неуточненное. 237

467

3.9. Психологические и поведенческие расстройства, связанные
с половым (психосексуальным) развитием и ориентацией по полу (F66) 241
F66.0. Расстройство психосексуального созревания (развития).....242
F66.1. Эгодистоническая ориентация по полу.....242
F66.2. Расстройство сексуальных отношений.....243
F66.8. Другие расстройства психосексуального развития.....244
F66.9. Расстройство психосексуального развития неуточненное.....244

Глава 4. Фармакотерапия сексуальных расстройств.....245
4.1. Адаптогены и сходные с ними стимулирующие вещества.....245
А. Средства растительного происхождения
и продукты пчеловодства.....245
Б. Средства животного происхождения.....249
В. Комбинированные средства (животно-растительного
происхождения).....249
4.2. Витамины и поливитаминные комплексы, содержащие макро- и микроэлементы и биоактивные вещества. 250
4.3. Половые гормоны и средства, влияющие на гормональное обеспечение половой сферы 251
А. Андрогены и их синтетические аналоги.....251
Б. Анаболические стероиды.....255
В. Гонадотропины.....256
Г. Ингибиторы секреции пролактина.....257
Д. Антиандрогены... 259
Е. Эстрогены..... 260
Ж. Гестагены. 261
4.4. Вазоактивные препараты..... 261
А. Общего действия.....261
Б. Вазоактивные препараты селективного действия.....264
4.5. Препараты, стимулирующие центральную и периферическую нервную систему.....271

4.6. Метаболиты и ферменты, регулирующие обмен веществ.....274
4.7. Психотропные препараты. 275
А. Транквилизаторы.....275
Б. Нейролептики. 277
В. Антидепрессанты.....278
Г. Психостимуляторы.....283
Д. Ноотропы. 283
4.8. Гепатопротекторы. 284
4.9. Препараты, действующие в области периферических нервных окончаний.....285
А. Местноанестезирующие средства.....285
Б. Местнораздражающие мази.....286
4.10. Препараты, улучшающие функцию простаты.....286
4.11. Другие методы коррекции эректильных дисфункций у мужчин.....287
1. Использование эректоров.....287
2. Вакуумная терапия эректильных дисфункций.....287
3. Хирургическое лечение.....289

Глава 5. Психотерапия сексуальных дисфункций.....291
5.1. Место психотерапии в сексологическом лечении.....291
5.2. Основные принципы и составляющие интегративной психотерапии сексуальных дисфункций у мужчин.....300
5.3. Принципы коррекции нарушений психосексуального развития.....315
5.4. Психотерапия тревожного ожидания сексуальной неудачи и коитофобии. 319
5.5. Модификация неадекватных убеждений и установок в отношении половой жизни, коррекция дисфункциональных схем мышления.....359
5.6. Проработка интрапсихических конфликтов.....364
5.7. Психотерапия нарушений межличностных отношений в паре.....372
5.8. Коррекция дисгармоничного сексуального взаимодействия в паре. 395

469

Заключение.....**405**
Приложение 1.....**406**
Приложение 2.....**439**
Литература.....**459**

470

Научное издание

Доморацкий В.А.

Медицинская сексология
и психотерапия сексуальных
расстройств

Компьютерная верстка И. Самсонов
Корректор
М. Яковлева

ООО «Академический Проект»
Изд. лиц. N0 04050 от 20.02.01.
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3.
Санитарно - эпидемиологическое заключение
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
№ 77.99.60.953.Д.003959.04.08 от 22.04.08.
Издательство «Культура» 105215, Москва, ул. Парковая 13-я, д. 27, оф. 2
По вопросам приобретения книги просим обращаться в ООО «Трикста»:
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3.

Тел.: (495) 305 5702; 305 6092; факс: 305 6088
E-mail: info@aprogect.ru
www.aprogect.ru

Подписано в печать с готовых диапозитивов 24.10.08.
Формат 84 x 108/32. Гарнитура Mysl. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,2. Тираж 1500 экз.
Заказ № 3385.
Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО «Дом печати - ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122